

心理咨询与治疗系列

Interviewing Strategies for Helpers:
Fundamental Skills and Cognitive Behavioral Interventions

心理咨询师的问诊策略

【美】S. Cornier, B. Cornier 著 / 张建新 等译

（下册）



 中国轻工业出版社

*Interviewing Strategies For Helpers: Fundamental Skills and
Cognitive Behavioral Interventions* (《心理咨询师的问诊策略》)

Copyright © 1998, by Brooks/Cole Publishing Company, A Division of
International Thomson Publishing Inc.

All Rights Reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in
any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying,
recording or any information storage and retrieval system, without permission,
in writing, from the Publisher.

心理学丛书——心理咨询与治疗系列

Interviewing Strategies For Helpers: Fundamental Skills
and Cognitive Behavioral Interventions

心理咨询师的问诊策略

【美】Sherry Cormier, Bill Cormier 著

张建新 等译

(下 册)



中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

心理咨询师的问诊策略 / (美)科米尔(Cormier, S.), (美)科米尔(Cormier, B.)著; 张建新等译. —北京: 中国轻工业出版社, 2000.6
(心理学丛书·心理咨询与治疗系列)

书名原文: Interviewing Strategies For Helpers:

Fundamental Skills and Cognitive Behavioral Interventions

ISBN 7-5019-2715-4

I. 心… II. ①科… ②科… ③张… III. ①心理诊断
②心理卫生 IV. R395.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 17995 号

丛书策划: 石 铁

责任编辑: 朱 玲 张乃东 责任终审: 杨西京

版式设计: 刘智颖 责任监印: 吴维斌

*

出 版 人: 赵济清 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

E-mail: wqtw@public3.bta.net.cn

电 话: (010) 652884

印 刷: 北京天竺颖华印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 850 × 1168 1/32 印张: 35.625

字 数: 750 千字 定价: 68.00 元 (上、下册)

书 号: ISBN 7-5019-2715-4/G · 151

著作权合同登记 图字: 01-1999-0443 号

· 如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换 ·

版权所有 · 翻印必究

心理学丛书——心理咨询与治疗系列

Interviewing Strategies For Helpers: Fundamental Skills
and Cognitive Behavioral Interventions

心理咨询师的问诊策略

【美】Sherry Cormier, Bill Cormier 著

张建新	黄秀琴	林石楠	董欣川	
杨东林	朱耀华	冯 洁	丁仁峰	译
童永胜	陈 波	王 黎	高文斌	
	周迅溢	吕建红		
	(下	册)		



中国轻工业出版社

丛 书 序

中国心理卫生协会理事长 蔡燦基

随着工业化、都市化程度的日益提高，随着生活节奏的不断加快，人们逐渐认识到，心理和社会因素对现代人的健康所起的作用越来越大。这些因素与许多心理障碍、心理-生理疾病（心身疾病）和不良行为密切相关。而心理咨询与心理治疗恰恰针对这些因素，积极、有效地帮助人们维护和提高身心健康。因此，心理咨询与心理治疗得以在全球范围内蓬勃发展。

心理咨询与治疗在西方大多数国家已经相当普及，而在我国自 20 世纪 80 年代以后才开始受到重视。总的来说，我们开展工作的时间不长，面临的问题和困难很多，其中比较紧迫的是缺乏一支训练有素的专业队伍。

对任何一门处于创建初期的学科而言，专业书籍的引进与编写都起着相当重要的作用。近年来，国内虽然也陆续引进或自行编写了一些专业书籍，但总体上仍显得品种单调，选择的书籍也缺乏代表性，不敷国内众多读者的需求。

正是基于上述认识，本人对中国轻工业出版社即将推出的“心理咨询与心理治疗丛书”寄予了很高的期望，并认为很值得向广大读者推荐。

大致说来，这套丛书有如下特点：

一、入选书籍比较权威

这套丛书的作品大多为经典之作，比如《团体咨询：策略与方法》就是一本在美国被广为采用、颇受推崇的专业书籍，有评论认为它是“同类图书中的不可多得者”。同样，《危机干预策略》、《行为矫正原理与步骤》等书也都具有较大的影响。

特别值得一提的是《理智胜过情感》一书。该书由两位资深的临床心理学家合作完成，不仅是培训教材，更有许多人将其作为自助读物，按照书中提供的步骤和方法，改变思维模式，排除情绪障碍。

二、内容具有较高的可操作性

对于许多愿意从事心理咨询与心理治疗的初学者而言，好的读物不应写得高深莫测，而应让他们看了就知道如何做。“心理咨询与心理治疗丛书”所选择的书籍正具备这样的特点。比如，其中的《夫妻心理治疗与辅导指南》、《心理咨询师的问诊策略》、《心理咨询与心理治疗》、《危机干预策略》、《行为矫正原理与步骤》、《团体咨询：策略与方法》等，在全面介绍理论的同时，更强调内容的可操作性。

三、填补了国内空白

由于我国开展心理咨询与治疗的时间不长，学科门类还不齐

全，诸如婚姻心理咨询与治疗、家庭心理咨询与治疗、集体心理咨询与治疗等领域的基础还极为薄弱，而它们又确实是需要大力加强的专业。因此，这套丛书的出版，相信会对本行业的发展起到促进作用。

四、由专业人员翻译，保证了译文的质量

本人虽不从事心理咨询与治疗，但从一些翻译书籍来看，其中往往存在因非专业人员翻译而带来的各种问题，比如虽然文通句顺却不得要领，甚至令人不知所云。此外，有些翻译书籍中的术语缺乏规范和统一。

反观本套丛书，在这方面胜过了许多同类书籍。承担本套丛书翻译工作的译者多具有较高的英语水平，曾在发达国家从事过科研工作，是相关领域的专家或学有所成的中青年学者。如《理智胜过情感》的译者张忆家博士，在美国获心理学博士学位，且是有执照的心理学家，开业多年。同样，胡佩诚、肖水源、张建新、石林、汤宜朗等名字对许多读者也不陌生。

需要说明的是，心理咨询与心理治疗同文化的关系相当密切。有证据表明，在西方国家相当有效的一些治疗体系，应用到其他国家却效果不彰。对此读者应有所注意。本人相信，随着我们工作的不断深入，基于我国本土文化、适合我国人民需求的心理咨询与治疗体系终将出现在中华大地上。

译者的话

心理咨询与治疗事业在中国已经越来越多地引起人们的关注，应该说这是一种历史的必然，表明中国文化开始真正的“人文关怀”，开始对个人竞争采取开放与宽容的态度。传统的大一统文化更多的是限制、约束人的个性发展，抹杀人的个性：或者你与我保持一致，成为模范的“君、臣、父、子”；或者离经叛道，“非疯即傻”。在那样的文化中，心理问题是并不存在的，它或者被上纲上线、被等同于“思想道德”问题；或者转而求其次，把心理健康问题当做身体疾患来对待。如研究表明，当中国人说自己“体虚”、“肾虚”或“神经衰弱”，而“药物大补”效果甚微时，通常意味着他们的情绪出现了慢性偏离，他们对自己、对他人、对周围小环境和大气候有着不能说清，或者不易说清的不满足、不愉快的情感。因而心理咨询与治疗在传统文化中是没有生长土壤的。

中国文化博大精深，尽管在世界范围内，它目前还不是强势文化，但它已经敞开了心胸，表现出了很强的自信。市场经济的建立和完善，必将导致社会成员之间竞争的存在，必将鼓励社会成员个性的张扬；而竞争就一定会有挫折和失败，张扬就一定会“标新立异”；随之而来的，就是身心的疲惫、焦虑和失落。因而心理咨询和治疗业的出现就是必然的，其兴旺也只是时间问题了。

那么什么是心理健康的标准呢？概括来说，心理健康的人能够愉悦地接纳自己，能够与周围环境和谐相处，“宜人宜己”。反过来说，“损人不利己”的人一定是心理不健康的。有人说心理健康完全是一种个人的主观感受，只要自己感觉愉快了，就是心理健康了。这是相当片面的理解，如果一个人整天“趾高气扬”，只顾自己愉快，而不顾他人的幸福，这样的人不是心理健康的人。特

别是在中国文化中，“损人利己”之人始终受到众人的唾弃和蔑视。心理健康的定义脱离不了文化的制约，在从西方引进心理咨询与治疗的理论和方法时，也一定要融入中国文化的内涵。

那么心理咨询与治疗又是什么呢？通常心理咨询是一个由至少两个人组成的人际互动过程。互动的一方是咨询者，另一方是求助者。咨询者在与求助者的心理沟通过程中，帮助求助者认识自己的心理问题，找出解决问题的个人化的方法，并督促求助者实施问题解决措施。与医生和患者的关系不同，咨询者与求助者是完全平等的。咨询者在帮助求助者解决其面临的问题时，不一定比求助者更高明。咨询者的角色在于利用专业知识为求助者提供一个敞开自己心理世界，认识自己内心，并调整、改变自己心理运作方式的场所和氛围。心理咨询与治疗一定要个性化，要针对每个求助者的具体情况设定特别的目标和干预措施。由于心理问题的复杂性，心理咨询与治疗不存在一成不变、统一普适的模式，而且它需要比打针吃药更长些的时间，才能达到咨询与治疗的目标。

当然，要使中国人完全接受心理咨询与治疗，可能还需要一段很长的时间，“人文关怀”文化的建立不是一蹴而就的。很多中国人仍将心理问题等同于精神疾病，羞于启齿；或者用身体疾患来掩盖或否认心理健康问题；或者还不太习惯于向一个陌生人公开自己的隐私世界；或者要求心理咨询与治疗能够像“打针吃药”那样即刻见效。最根本的是要建立一种人人平等竞争、相互关爱、自尊且互尊的社会环境。

心理咨询与治疗是西方文化的产物，在中国进行心理咨询与治疗之初，要采取“拿来主义”。近些年在中国大陆陆续出现了一些介绍心理咨询与治疗的译著。中国轻工业出版社利用自身的优势，引进、出版了一系列国外心理咨询与治疗的最新著作，在推广、宣传、普及心理咨询与治疗知识的过程中，留下了重重的一笔。

《心理咨询师的问诊策略》是这个系列丛书中的一种。它的作者，一对夫妻，是美国心理咨询与治疗业的资深从业者，有着丰富的临床咨询经验。作者在书中第二章提出了成为有效咨询者的基本条件，其中包括诚恳、开放。在翻译全书的过程中，译者能够充分领略作者诚恳与开放的态度，受益良多。

本书共二十章。第一章勾画全书各章的基本结构；第二章告诫读者，在决心成为咨询者之前，先要了解自己；第三章至第十一章详细描述心理咨询中的各项基本技能；以后各章则着重讲述了心理咨询与治疗中的几种重要方法。全书重点不在于诠释咨询理论，而在于如何学习、掌握咨询技能，并能在不同的情境下加以运用。虽然本书将那些有志于从事心理咨询与治疗的人作为读者对象，但其潜在读者群远远不止于此，凡从事与人打交道职业者都能从中获益。

参与本书翻译的有黄秀琴（第二、三章）、林石楠（第六章）、董欣川（第十、十一、十二章）、杨东林（第十三章）、朱耀华（第十四、十五、十六章）、冯洁（第十七章）、丁仁峰（第十八章），以及童永胜（第四、五章）、陈波（第七、九章）、王黎（第八章）、高文斌（第十、十一章）、周迅溢（第十八章）、吕建红（第十九、二十章），本人翻译第一章，并负责全书统稿。其中前七人是参加中国科学院心理研究所第七期心理咨询与治疗培训班的学员，其余则为心理研究所博士、硕士研究生。感谢他们的参与，特别要感谢陈波博士不辞百忙，加入我们的行列。

张建新

2000年4月

本书作者简介

本书两位作者是一对夫妻。本书内容涉猎广泛、深入，与夫妻两人的默契合作是分不开的。书中还列举了作者夫妻一起在实际生活中运用咨询干预方法的实例，可见作者不仅诲人不倦，而且亲身实践。

妻子谢里·科米尔 (Sherry Cormier) 现在是西弗吉尼亚大学康复和心理咨询学系的教授，并在西弗吉尼亚大学医学院家庭医学系任兼职教授，同时也是西弗吉尼亚州的注册心理医师。她近来的研究兴趣主要放在探讨训练咨询者的问题和模式方面，而临床实践主要是为年轻女性和妇女进行咨询。在咨询中她主要遵循认知—行为学派、物质—关系学说、身体意识论、荣格心理学等理论。她有两个十几岁的女儿，还有一只金色毛发的猎狗。

丈夫比尔·科米尔 (Bill Cormier) 在过去26年中做过教师、临床医生、咨询师以及研究学者。曾任西弗吉尼亚大学医疗中心临床心理学博士学位课程临床训练部的教授、主任。他是西弗吉尼亚和马里兰两个州的注册心理医生。1991到1996年间，他从事私人行医，专长为行为医学。目前他对东西方心理治疗方法和心/身技术感兴趣，曾接受过冥想法、呼吸法、太极功、瑜珈功的深度训练，并获得瑜珈功指导教练证书。他的业余兴趣有划船、山地自行车，并写作小说。

目 录

第一章	导 言	1
	本书的目的	2
	咨询概述	5
	本书的结构	8
	最后一点想法	16
第二章	作为咨询者，你要了解自己	17
	本章目标	17
	有效咨询者的特点:	17
	自我意识、人际关系觉察和依恋理论	17
	影响咨询者的三个问题:	30
	价值观、文化多样性和道德观	30
	本章总结	53
	参考文献	56
第三章	建立有效咨询关系的促进因素	63
	本章目标	63
	促进条件	64
	情感的客观性: 移情和反移情	94
	治疗同盟	96
	本章总结	101
	参考文献	105

第四章	强化治疗关系的人际影响因素	109
	本章目标	109
	Strong 的人际交互影响咨询模型	110
	影响过程的相互性	111
	咨询者特征或治疗关系的强化因素: 专业技能、 吸引力和值得信任	113
	本章总结	147
	参考文献	153
第五章	非言语行为	155
	本章目标	157
	求助者的非言语行为	157
	如何处理求助者的非言语行为	173
	咨询者的非言语行为	178
	本章总结	182
	参考文献	185
第六章	聆听反应	191
	本章目标	192
	聆听求助者的故事	193
	聆听反应对咨询者的要求	194
	四种聆听反应	195
	聆听中的各种妨碍因素	228
	本章总结	231
	参考文献	238

第七章	行动反应	241
	本章目标.....	241
	实施行动反应的时机	242
	行动反应对咨询者的要求	242
	四类行动反应	243
	本章总结	291
	各种技巧的综合	291
	参考文献	301
第八章	求助者问题的概念化与理解	305
	本章目标.....	305
	什么是评估?	305
	对求助者的问题进行概念化与理解的方法	306
	关于评估和认知行为疗法的理论假设	315
	行为的 ABC 模式	323
	对求助者问题的诊断分类	330
	诊断的局限性: 标签和性别及文化偏见	334
	运用 ABC 模式进行个案分析	339
	本章总结	347
	参考文献	353
第九章	界定求助者问题的会谈评估法	361
	本章目标.....	361
	直接评估会谈	362
	会谈和病史采集	362
	精神状况检查	367
	评估求助者问题的十一项内容	370

会谈评估中的性别及文化因素	397
问题评估中引导语的局限性	399
问题评估的会谈示范: Joan 的个案	399
档案和记录保存	414
求助者自我监测评估	422
评估怎样才算“足够”了?	427
本章总结	428
参考文献	443
第十章 识别、界定和评价治疗结果目标	449
本章目标	449
治疗目标及其在咨询中的意义	450
咨询目标中的文化问题	452
结果目标代表什么	454
识别目标的会谈引导	459
治疗范例对话: Joan 的个案	468
界定目标的会谈引导	476
结果目标的评价	493
结果反应的维度: 测量什么	494
选择结果量度: 如何测定结果	497
示范例子: Joan 的个案	508
对话范例: Joan 的个案	509
本章总结	521
参考文献	533
第十一章 治疗计划与治疗策略选择	539
本章目标	539
影响治疗策略选择的因素	540

计划治疗类型、疗程和模式的决策原则	552
治疗计划和选择中的性别和多元文化问题	566
本章总结, 并介绍以下各章治疗策略的内容	584
参考文献	587
第十二章 符号模型与参与者模型	595
本章目标	597
符号示范学习法	597
参与示范学习法	601
社会示范学习法的多元文化应用	607
多元文化使用示范法的原则	608
参与示范学习法的对话范例	608
本章总结	615
参考文献	620
第十三章 引导想像法和内隐模仿法	625
本章目标	625
求助者的想像: 评估与训练	626
想像法的多元文化应用	628
引导想像法	628
治疗原理	630
引导想像法示范	635
内隐模仿法	636
内隐模仿法的范例对话	647
本章总结	659
参考文献	669

第十四章 认知示范和问题解决	673
本章目标	673
认知示范和认知自我指导训练法	674
示范对话：认知示范和认知自我指导训练	680
问题解决疗法	689
问题解决的跨文化应用	690
问题解决的六个阶段	694
问题解决治疗法示范	703
本章总结	705
参考文献	720
第十五章 认知治疗和认知重建	725
本章目标	725
认知治疗的发展	725
认知重建法的应用	727
认知治疗和认知重建法的跨文化应用	727
认知重建的六个组成部分	729
认知重建法示范对话	745
本章总结	751
参考文献	758
第十六章 再构和应激预防	761
本章目标	761
再构法的过程	761
再构法的跨文化应用	768
再构法个案示范	769
应激预防法	773

应激预防的七个组成部分	773
应激预防法示范对话	790
本章总结	794
参考文献	804
第十七章 冥想与肌肉放松	809
本章目标	810
冥想的过程与应用	810
对不同文化群体求助者应用冥想和放松法	813
基本冥想	813
沉思冥想的步骤	814
放松反应冥想的步骤	819
仁爱冥想的步骤	822
冥想的禁忌症和副作用	826
沉思冥想个案范例	827
肌肉放松的过程与应用	831
肌肉放松的步骤	833
肌肉放松的禁忌症和副作用	841
肌肉放松法的变式	843
肌肉放松训练的对话范例	848
本章总结	852
参考文献	868
第十八章 呼吸练习和HATHA 瑜伽	875
本章目标	877
呼吸练习的过程与用途	878
呼吸和应激的生理学	878
呼吸练习的步骤	881

膈式呼吸的禁忌症和副反应	895
膈式呼吸范例:	896
交替鼻孔呼吸示范	897
Hatha 瑜伽功的过程与益处	900
瑜伽与你	903
身体的七个能量中心	903
Hatha 瑜伽的步骤	910
Hatha 瑜伽范例	923
本章总结	927
参考文献	933

第十九章 系统脱敏 937

本章目标	938
使用脱敏疗法的各种报告	939
系统脱敏疗法的跨文化应用	941
脱敏疗法的解释	942
脱敏疗法的组成部分	944
示范对话: 脱敏疗法的原理	945
示范对话: 识别引起情绪反应的情境	947
示范对话: 使用 SUD 量表建构刺激等级	955
示范对话: 条件反射反应的选择和训练	961
示范对话: 想像评估	964
示范对话: 场景呈现	969
示范对话: 家庭作业和复诊	973
脱敏疗法过程中的问题	974
系统脱敏疗法的变式:	
现场脱敏、眼动脱敏和再加工法	975
本章总结	981

参考文献	996
第二十章 自我管理策略：自我监测，刺激控制，自我奖赏，自我偶像和自我效能	1003
本章目标	1005
自我管理策略的临床应用	1005
自我管理在跨文化咨询中的应用	1006
有效自我管理策略的特征	1009
为求助者设计自我管理方案的步骤	1012
自我监测的目的、使用 and 过程	1014
自我监测的步骤	1017
自我监测方法的范例	1030
刺激控制	1034
刺激控制治疗法范例	1040
自我奖赏的过程和应用	1040
自我奖赏疗法的组成	1042
选择适当的奖赏物	1044
自我奖赏策略范例	1050
自我偶像法	1052
自我偶像法范例	1057
自我效能	1063
自我效能感在跨文化治疗中的应用	1068
自我效能的范例	1071
本章总结	1074
全书最后的提示	1075
参考文献	1077

第十一章 治疗计划与治疗策略选择

制定治疗计划在治疗过程中显得越来越重要。治疗计划包括对所用方法、疗程、模式的选定。在明确求助者的问题、治疗目的以及确定评估方法后，才能开始制定治疗计划。治疗计划要说明运用哪些咨询干预措施（治疗方法），帮助求助者达到他们的预期目标和治疗过程所需要的时间（疗程时间），以及干预措施实施的具体方式或方法（治疗模式）。

治疗计划不是在某个时刻间断的活动，它是一个连续的过程，无论何时出现了新的信息，或求助者与咨询者遇到了“困扰”，原来的计划就要重新调整。治疗计划一直是咨询过程中的重要组成部分。在最近的几年里，其重要性更加突出，因为在许多已实施的保健体系的第三者保险赔偿中，都要求提供治疗计划这部分内容。除此以外，我们倡导使用治疗计划还基于以下理由：首先，求助者参与共同制定治疗计划，通常会使其在咨询过程中增加情感投入；第二，治疗计划有助于对求助者使用最佳的干预策略组合，并且达到最终目标；第三，治疗计划有助于咨询过程始终围绕主题，即保证做到尽可能地面对和考虑求助者的需要。

本章目标

1. 对于给出的个案和相应的治疗计划，要能识别出：
 - a. 咨询者选择的治疗干预方法与求助者的价值观和世界观相冲突的地方。
 - b. 作为一个咨询者，你将建议使用什么样的治疗策略、疗程和模式。
2. 针对给定个案，使用简单的治疗计划表格，并逐步明确治

疗策略、疗程和模式。

影响治疗策略选择的因素

治疗计划建立在许多重要因素之上。根据 Beutler 和 Clarkin 的看法,“有效的治疗是一个系列精选决策过程的结果”,这些决策要将许多治疗因素联系在一起,并“协同地”引起求助者的改变。这些治疗因素中包括:求助者的特征和偏好,咨询者的偏好和灵活性,有关文献资料和实践指南。

求助者的特征和偏好

“求助者在治疗中的特征是对最终治疗结果最有力的影响源”。例如, Banken 和 Wilson 在针对抑郁症使用了几种不同治疗方法后发现,对疗效有更大影响的不是特定的治疗内容,而是非特定的求助者各种特征,如求助者的准备程度、他们的动机、信仰体系、各种可用资源、自我效能感等。求助者对改变的动机影响着他们实施治疗计划。求助者对改变的准备程度可由下面几个方面来判断:有没有口头承诺,是否意识到改变将带来的积极结果,在两次会谈之间是否进行过一些内省行为或思考,等等。有时,求助者的准备程度也可通过他们部分行为的改变体现出来。例如:求助者会变得更加坦诚,或在谈话中更多地暴露自己。还有一些求助者会坚持准时来咨询,这也表示出他们的准备程度。

在第十章曾描述过一个最近发展出来的、对求助者准备程度进行评估的体系,称做改变的超越理论模式。许多关于该模式的研究结果显示,改变过程中的某些特殊阶段与求助者对改变的准备程度有关。Smith、Subich 和 Kalodner 的最新研究结果发现,那些过早终止治疗的求助者,大多处于该模式的考虑前阶段(第一阶段),而不是处在考虑阶段或行动阶段。Prochaska 和 DiClemente 的改变模式还包括了 10 种帮助求助者积极改变的过

程，它们综合了各种理论方法，见表 11-1 中所列的 10 种过程以及相应的干预策略。另外，Smith 等人(1995)的研究还表明，可以通过这些过程将过早结束咨询的人和其他求助者区别开来。继续治疗的求助者比过早终止治疗的求助者更多、更经常地使用表中所列的这些引起改变的方法。

表 11-1 超越理论治疗模式：10 种改变过程和相应干预方法举例

过 程	定义：干预法例子
自我再评价法	评估个人问题如何影响生理环境：共情训练，分析既往资料
意识提高观察法	增加对自我和对问题的信息：质询法，解释法，读书疗法
戏剧减轻紧张法	体验并表达关于解决问题方法的情感：心理戏剧法，角色扮演法
环境再评价法	评估个人问题如何影响生理环境：共情训练，资料记录和分析
自我暴露和信任法（支持关系）	坦诚并信任关心自己的人：治疗联盟，社会支持，自助团体
增强／强化作用	发生改变后奖励自己，或从他人那里得到奖励：外显和内隐式奖励，自我奖励
去条件反射作用	对存在的问题行为进行替代：放松，脱敏，自我肯定，积极的自我内部对话
刺激控制	回避引发问题行为的刺激：重新构造周围环境（例如禁酒、不吃高脂肪的食品），避免高危诱因，减少欲望
自我和社会解脱（社会政治的）	增加非问题行为在社会上被认可的机会和范围：为受压迫者伸张，政治干预措施

Caspar 认为，除了评估求助者的准备情况外，咨询者还需要在对求助者的动机有一个很好的了解后，再制定有效的治疗步骤。我们应记住，求助者的动机不仅仅是内部的动态机制，而且也反映了他们的价值观。例如：一个经常受父母忽视的求助者，可能

会害怕再被咨询者拒绝，因而就倾向于接受咨询者的治疗计划；而另一求助者接受咨询者的治疗计划，则完全是为了另外一个原因，他们怕被拒绝是为了保护家庭和文化群体的面子。

咨询者应认识到，求助者经常会有相互对抗的动机，必须与之周旋。例如一个在十岁时丧父的大学二年级女生，她是个独生女。她认为母亲太过保护主义，老想安排她的生活。她说生活中惟一能真正支配的就是自己的运动锻炼活动，于是便强迫性地进行锻炼。她还感觉到无缘无故的“沮丧”。在对她了解的过程中，你就可能会注意到，她不断地询问你的意见和建议，看来很想依赖你的意见。可见，她在依赖和控制之间存在着对抗动机。咨询者必须尊重两种动机。同样，对于具有二元文化背景的求助者，他们在两种（或更多）文化背景之间有对抗性动机也是很常见的。例如，一个青年亚裔美国女生，她在一所由白人占主导地位的高中学习。她出生并成长在美国，但是她的父母都是越南人。她感觉自己的情感总是指向两个方向。比如，她想像她的同学一样，坚持自己的自由和独立，并且自己做决定；然而她又害怕这样做，会使她在父母和亲戚面前失去尊严并蒙羞。她觉得自己被抓在两种文化之间，一种是学校和朋友中的主流文化——强调独立自主和个人自由；另一种是她的家庭和亲戚中的亚洲文化——强调集体归属感的价值观和理念，并以此为荣。这里需要再次指出，咨询者必须认可这些不同的动机和理念。

学习练习活动 35 / 求助者的特征和治疗计划

这个学习练习活动将帮助你了解某些求助者的特征对治疗计划的影响。你可以和同学或小组一起进行这项活动。答案见学习活动反馈 35。

任务 1 求助者 A 很希望通过治疗去掉口吃的毛病。作为咨询者，

你有一个补充计划帮助他达到此目标。在计划中,你必须掌握在什么情况下求助者会口吃,而这种情况对求助者又有什么主观的含义。请为收集资料计划具体的行动,列出可能的情境。然后对求助者口吃行为和具体情形的关系进行假设,但假设要合理。在5~10分钟内完成可行性提纲,可以的话,在小组里讨论这个计划,也可以自己试着评估一下方案。

任务2 求助者M极不愿意承认其弱点,这与他理想中做个坚强、适应良好的人不相符合。他来咨询这一举动反映出他无法坚持不承认自己的弱点。在谈话中,他尽了很大努力,以表现得像咨询者一样坚强。请尽可能详细地列出咨询者应该采取怎样的行为,以避免与求助者发生冲突。

注意到求助者所处的情况(他们坚信的价值观和信仰)非常重要,因为这将影响到求助者支持或反对使用某种方法,如果咨询者不能敏锐地察觉,并在触到求助者的观念之前,就巧妙地化解这一问题,求助者就有可能抵制进程或不能完全投入到治疗中去。偶尔,求助者会公开拒绝一个计划好的治疗方案:“那样对我来说很傻!”“那究竟有什么用呢?”或“我根本不想试。”其他求助者更微妙,通常是非言语地表示“是”或“否”。比如,一些求助者不愿接受某项方案,他们可以通过改变脸色、眼或嘴的移动或呼吸类型表现出来。

如Caspar(1995)所注意到的,治疗计划应和求助者对其生活总的看法,特别是和其自主水平相符合。假如计划能增强求助者的自主性,那么它就好比约束求助者自主性的计划更可行和有效。有效的治疗计划同样要建立在求助者力所能及和正常状态的基础上,还要考虑到社会和周围环境的支持力度。

咨询者的偏好和灵活性

Beutler 和 Clarkin 发现,在治疗方法的选择上,咨询者处理不同求助者的需要时所表现出的灵活性和适应能力,要比咨询者和求助者之间的简单配合更为有用。如 Caspar 所述,咨询者可选择的方法越多,那么他在最低代价下获得最大收益的可能性就越大。

这种灵活性要求咨询者对自己、对求助者及两人之间的相互作用方式具有高度的意识水平。这些意识有的来自于直觉或本能,但有的就需要分析、计划,并向其他咨询者或指导者请教。

咨询者对于某些治疗理论和干预方法的偏爱,在治疗方法的选择中同样起着很重要的作用。咨询者对策略的选择通常是基于他们所受过的训练,他们运用这些策略感觉顺手,并有能力进行驾驭。有时,也要鼓励咨询者“变通执行”他们的计划和干预方法。从道德的观点上看,在你的能力和经验水平内进行工作是很重要的。若你只受过认知转变方法的训练,而没有接受过其他的训练和实践,你就不太可能实施完形(Gestalt)疗法。但是,治疗计划的确定常常是基于咨询者最喜好的治疗理论(见表1-1的概述),而不是考虑求助者的问题和结果目标,这就是为什么一个咨询者常会使用相同的治疗导向来应付所有的求助者了。在制定有效的治疗计划中,具备多种治疗观点的重要性再清楚不过了。就像打高尔夫球,如果你的球袋里只有一支球棍去应付各种情况,在比赛中你就会受到很多限制。若你觉得自己的能力和经验有限,你可以介绍需要其他治疗方法的求助者转诊;或者扩展你自身的训练和经验,以掌握更多的方法。

无论你受过多少训练,有多少经验,在治疗计划的选择中,咨询者的偏爱都不应是惟一或首要的考虑因素。除了咨询者的偏好、训练以及求助者的特征、偏好外,在文献中寻找对特殊求助者使用的特殊干预方法也是很重要的。

学习活动反馈 35/ 求助者的特征和治疗计划

现假设求助者A和M是同一个人！首先，检查一下你是否已为任务1做好计划，且不和任务2的描述相冲突。然后试着同时为两个任务制定附加计划。

文献资料和实践指南

不同的咨询程序都有大量的资料可供参考，这些资料可以帮助咨询者计划治疗方案，并成功地使用不同方法去处理求助者不同的问题。在本书中出现的所有治疗策略都有一定的实践经验支持。

治疗干预的文献资料越来越多地被包括在新出现的“实践指南”中。实践指南是指执行某种治疗程序的方法。实践指南被定义为“在特定的临床环境下，帮助咨询者和求助者决定采取相应的健康措施的系统化说明”。当前已经有针对躁狂症、控制自杀和抑郁症治疗的实践指南；制定实践指南的工作在其他许多问题领域也取得了进展，包括焦虑和恐惧、婚姻治疗、饮食障碍、儿童行为问题、疼痛控制和戒烟等。AHCPR指南是由多个学科方法发展而来的，它建立在经验数据结果之上，并受到各方面咨询者的评论，而且每18个月到36个月修订一次。最近关于抑郁、躁狂、焦虑和恐惧的实践指南概述已经面世。

根据美国精神病治疗协会（APA）的意见，当前的研究结果是否能够保证治疗的实行，是一个与临床息息相关的问题。职业咨询者不断根据研究文献提出临床治疗建议，因而实践指南也随着咨询及相应管理组织的发展壮大而扩展。

尽管这些指南存在着某些内在的不足（后文有叙），但一些咨询者相信，不重视心理治疗的文献资料，就有可能导致第三方

保险付款人排斥所有的心理治疗方法。最糟的结果（这还没有被全部心理健康工作者所意识到）是公众认为，对于情感问题惟一的补偿选择只有药物治疗了。Hollon 指出，尽管药物治疗在减轻许多严重失调症状上，“有替代心理治疗的趋势”，但心理治疗能够取得单独使用药物治疗所不能达到的效果。

最佳的个案情境应是这样的：针对某类群体求助者所出现的特殊情绪 / 心理问题，咨询者使用了最恰当的治疗方案，并使求助者的心理健康质量得到了改善和提高。例如，美国心理学会第 12 组（临床心理学组）最近建立了一个权威机构，来审定被经验证明有效的各种心理治疗方法，培训咨询者和第三方付款者，并让公众了解这些干预措施。1993 年该机构的一份报告显示，根据病情的性质，一些干预方法优于其他的方法。例如：对恐慌症进行放松疗法（第十八章将讲述）就不如认知疗法（第十五章讲述）有效。通过分析收集的资料，该机构已发表两类治疗干预措施表：（1）业已成熟的疗法（表 11-2）；（2）可能有效的疗法（表 11-3）。报告的意图不在于说明哪一种治疗理论普遍有效，而是要指出针对特定问题有效的特殊治疗方法。

对于许多成人心理疾病（如抑郁、焦虑、饮食障碍、酗酒、夫妻不和，人格障碍临界状态等），另外还有一个很好的治疗计划草案来源，即《心理障碍临床手册》。表 11-2 和表 11-3 的内容来自 1993 年 APA 评估报告，现在（APA）又成立了一个新的小组，用以评估 Barlow 书中提到的新治疗方法。

APA 评估报告中所引用的研究被称为“功效”研究，是在严格控制的实验条件下，对两种治疗法进行的比较研究。Seligman 亦在一本书中对这类研究做了总结，他指出认知疗法和人际关系疗法对于单向抑郁症有效，认知疗法对痛觉失调有效，系统脱敏疗法可以减轻某些恐怖症，沉思及呼吸训练缓解了焦虑，认知疗法对食欲过盛也有用。正如 Seligman 说到，“因为功效研究中的

表 11-2 APA 第 12 组评估中心确定的疗法报告

业已确立的治疗方法	引证
抑郁症 Beck 认知疗法	Dobson (1989)
个体发育障碍的行为 药物治疗	Scotti, Evans, Meyer, & Walker (1991)
大小便失禁症的行为 矫治	Kupfersmid (1989); Wright & Walker (1978)
头疼及过敏性内脏综 合征的行为治疗	Blanchard, Schwartz, & Radnitz (1987); Blanchard, Andrasik, Ahles, Teders, & O'Keefe (1980)
女性高潮缺失和男性 勃起障碍的行为治疗	LoPiccolo & Stock (1986); Auerback & Kilmann (1977)
婚姻行为治疗	Azzin et al. (1980); Jacobson & Follette (1985)
慢性疼痛的认知行为 疗法	Keefe, Dunsmore, & Burnett (1992)
伴有或不伴有广场恐 怖症的恐慌症的认 知行为疗法	Barlow, Craske, Cerny, & Klosko (1989); Clark et al. (1994)
弥散性焦虑症的认知 行为疗法	Butler, Fennell, Robson, & Gelder (1991); Borkovec et al. (1987); Chambless & Gillis (1993)
恐惧症和应激失常的 暴露疗法 (广场恐 怖症、社会恐惧症、 简单恐怖症)	Mattick, Andrews, Hachzi-Pavlovic, & Christensen (1990); Trull et al. (1988); Foa, Rothbaum, Riggs, & Murdock (1991)
强迫症暴露和反应疗法	Marks & O'Sullivan (1988); Steketee, Foa, & Grayson (1982)
精神分裂症的家庭教育	Hogarty et al. (1986); Falloon et al. (1985)
社交恐惧症的团体认知 行为治疗	Heimberg, Dodge, Hope, Kennedy, & Zollo (1990); Mattick & Peters (1988)
食欲过盛症的人际疗法	Fairburn, Jones, Peveler, Hope, & O'Conner (1993); Wiltley et al. (1993)
抑郁症的 Kerman 和 Weissman 人际疗法	DiMascio et al. (1979); Elkin et al. (1989)
针对儿童反抗行为的 父母训练	Wells & Egan (1988); Walter & Gilmore (1973)
单纯性恐惧症的系统 脱敏疗法	Kazdin & Wilcoxon (1976)
记数经济治疗手段	Liberman (1972)

对于经验确定的治疗方法的标准：业已成熟的疗法

I. 至少有两个设计良好的团体研究，它们是由不同的研究者分别进行的，并以下列方式显示出治疗方法的功效：

A. 它的疗效比药品、心理安慰剂或另外一种疗法更优越；

B. 它的疗效相当于业已成熟的疗法，并达到统计显著性水平（每组的30人：引自 Kazdin & Bass, 1989）。

或者

II. 许许多多的单样本设计研究都显示出功效，并具有下列特征：

A. 采用良好的实验设计；

B. 同其他的治疗方法进行过对照比较，做法同IA。

对于I和II的进一步标准

III. 研究必须使用标准化的治疗手册作为治疗指导方案。

IV. 求助者样本的特征必须清楚地加以说明。

表 11-3 APA 第 12 组评估中心报告的可能有效疗法

可能有效的疗法	引证
应用放松疗法治疗恐慌症	Ost (1988); Ost & Westling (1991)
简便心理动力学疗法	Piper, Azim, McCallum, & Joyce (1990); Sheffer & Dasberg (1989); Thompson, Gallagher, & Breckenridge (1987); Winston et al. (1991); Woody, Luborsky, McLellan, & O'Brien (1990)
性犯罪的行为矫治	Marshall, Jones, Ward, Johnston, & Barbaree (1991)
边缘性人格障碍的辨证 行为疗法	Linehan et al. (1991)
情感集中的配偶疗法	Johnson & Greenberg (1985)
习惯矫正和控制技术	Azrin, Nunn, & Frantz (1980); Azrin, Nunn, & Frantz-Renshaw (1980)
对于抑郁症 Lewinsohn 的 心理教育疗法	Lewinsohn, Hoberman, & Clarke (1989)

对于实践可行的治疗方法的标准：可能有效的疗法

I. 至少有两个研究显示该疗法比其他疗法更有效。

或者

II. 至少有两个研究达到已成熟疗法的标准I、III和IV；但它们是由同一个研究者进行的，或只有一个设计良好的研究表明其有效性达到了同样的标准。

或者

III. 至少有两个研究显示出疗效良好，但研究中的求助者样本不同质。

或者

IV. 有少量单样本设计研究达到了成熟疗法的标准II、III和IV。

注：可能有效的疗法被视为试验性疗法。未在此列出的疗法也不应被忽略，因为评估中心可能已看过这些疗法，但因为缺乏充足依据而未列出。

治疗是在严格控制的条件下进行的，并针对仔细挑选出来的求助者，所以具有最大的敏感度。对于某类病症，要肯定一种疗法是否比另一种疗法更好，进行这种研究很有帮助”。

另外，还要注意到由实践指南衍生出了很多治疗手册。治疗手册用来规范化某类治疗程序，即那些在实证研究中采用的干预方法。Wilson和Agras推测这种“小型革新”将继续发展。Wilson报告了在实际工作中应用和误用治疗手册的各种情况。

针对功效研究在婚姻及家庭治疗方面的应用，Pinsof和Wynne进行过总结评论。他们发现，对于许多病症进行MFT治疗比不进行任何治疗有效得多；对于某些病症，它比个体治疗更有临床意义，但比较费力；而对于某些严重障碍，MFT是必要而非充分的治疗方法。表11-4列出了他们的总结。他们对精神治疗计划评论的一点重要启示是：“病症越是严重、扩散和混乱，就越需要有多种有效的治疗方法。”

除了功效研究和一些探索性研究外，疗效研究对于明确疗法的效果同样有用。疗效研究是对求助者进行大规模的实地调查，

**表 11-4 婚姻治疗(MT)和家庭治疗(FT)与不进行治疗
或个体治疗的结果对比**

婚姻治疗 (MT) 或家庭治疗 (FT) 比不进行治疗有效的病症
成人精神分裂症 (FT)
处于痛苦婚姻中的抑郁女性求助者 (MT)
婚姻痛苦和冲突 (MT)
成人酗酒和药物滥用 (FT, MT)
成人高血压 (MT)
老年性痴呆 (FT)
成人肥胖症 (MT)
成人心血管系统危险因素 (FT)
青春期行为障碍 (FT)
青春期少女厌食症 (FT)
青春期药物滥用 (FT)
儿童行为障碍 (FT)
多动症儿童的攻击和反抗行为 (FT)
儿童慢性躯体疾病 (如哮喘、糖尿病等) (FT)
儿童肥胖症 (FT)
儿童心血管系统危险因素 (FT)
婚姻和家庭治疗 (MFT) 比个体治疗有效的病症
成人精神分裂症
痛苦婚姻中的抑郁女性求助者
婚姻痛苦
成人酗酒和药物滥用
青春期行为障碍
青春期药物滥用
青春期少女厌食症
儿童孤独症
成人和儿童的多种慢性躯体疾病
另外, 在成人酗酒者治疗上, 家人参与比单独成人治疗更有效

并分析求助者报告的结果。Seligman认为,疗效研究是评价治疗起作用机理的一个好方法,因为它涉及许多功效研究不能测量的关键变量。一则由《Consumer Report》报道的大规模疗效研究发现:(1)求助者在治疗中受益很大;(2)没有哪种疗法更优于其他疗法;(3)长期治疗效果强于短期治疗;(4)当疗程和疗法的选择受到医疗保险等因素限制时,其疗效较差。消费者报告的研究结论引起了热烈反响。Seligman总结道,最终的治疗方案应该综合有效率,且有效果的多种治疗技术。

在考虑实践指南、经验证明有效疗法和标准化疗法手册时,重要的是要了解,所有这些文献都处于发展早期阶段,特别是在涉及到求助者人口变量,如少数民族求助者时更是不成熟。幸运的是,现在已经有很多关于种族文化方面的资料来源。例如,Marsella、Friedman、Gerrity和Scarsfield已出版了一本关于种族文化与创伤后应激综合征关系的书。然而,在实践指南中对种族因素的重视程度仍然相对不足。

早些时候,我们曾注意到一篇关于双向抑郁症患者的心理治疗和药物治疗的综述报道。这些研究者指出,种族和性别问题在几乎所有的研究中都“被强烈地疏忽掉”了。因为所用的典型样本90%是白种人,所以很难说明有色人种的情况。同样,抑郁症的研究中65%到85%的样本是女性,其结果如何应用于男性就不清楚了。从治疗的角度看,几乎75%的抗抑郁症药方都是为女性开的,这一观察结果导致了这样几个问题:第一,在寻找导致抑郁的社会、政治因素之前,就已经为抑郁妇女开药方了;第二,妇女面临着不恰当地服用处方药的危险,因为她们可能比男性更容易出现各种副作用。

Brown建议,当评估各种实用研究的结果和建议时,应该考虑以下问题:

研究者关于常模标准、价值观和恰当行为的假设是什么?

研究者所测量的存在状态是某种文化中的常态现象，还是根据研究者自己的文化进行的？

评价一个人的行为是以他的文化背景为前提，还是从偏见出发？

当研究者属于主流文化时，上述这些问题就变得非常重要了。

计划治疗类型、疗程和模式的决策原则

早在1976年，Shaffer就建议使用诊断线索和模式或“决策规则”，来制定求助者的治疗计划。决策规则是咨询者在咨询会谈时不断向自己提出的系列问题，以使治疗策略能与求助者及其问题相配合。一些研究者最近对这种咨询者-求助者关系做了详细的描述。

Meyer和Deitsch模式已在DSM-IV中得到反映。它描述了许多诊断类型，并将这些诊断与特定的评估和标准化测验建立了联系，然后针对每个诊断类型建议出各种治疗方法。比如在表11-5中便列出了他们对失眠症建议的可选择疗法。

Santiago-Rivera的模式综合了许多文化维度，如文化适应水平、治疗的文化敏感性以及文化相关资源的可利用性（见图11-1）。这种模式特别适用于关注文化因素的治疗情境。

Hackney和Cormier的模式在五类领域（情感、认知、行为、系统和文化）中，将问题类型与相应的干预类型和理论模式建立了联系。详见表11-6。

Beutler和Clarkin模型综合考虑了求助者特征、求助者问题性质和治疗目标，但它没有详尽地考虑文化因素。表11-7对他们的模型作了概述。（如要了解细节，建议看他们的原文）。

治疗类型

按照Beutler和Clarkin的模式，求助者的问题可分为两类：

表 11-5 失眠症可选择的疗法举例(DSM-IV 分类法)

许多失眠者都有严重的焦虑、抑郁、强迫性特征，这些症状和其他机能方面的问题都进一步导致了失眠。假如这些症状都存在，读者可以参考本章推荐的相关疗法

化学药物经常用于失眠症，有的时候还非常被看重。实际上，任何有关睡眠的药物都应小心管理；它们对打破失眠循环很有用（假如服药不超过一周），但如果药方时间太长，将会失效，并有带来药物依赖性和/或成瘾的危险，而且可能复发，甚至引发更厉害的失眠。血液中的褪黑素（由松果体自然生成的激素）与不同的睡眠类型有关。在睡觉前1-2小时控制使用2-3毫克褪黑素，在一周内可恢复睡眠觉醒循环，对于老年人特别有效。

许多行为疗法都是有效的，但最有效的可能是认知疗法、放松训练和重点在于放松肌肉的生物反馈疗法。辅助的方法包括：（1）养成剧烈运动的习惯，理论上当然最好避免在深夜进行此锻炼，可以在睡觉前3-4小时做有氧运动；（2）避免吃得过多或太晚进餐，相反也不该空腹睡觉——一个高血糖水平是有益的；（3）避免打盹，特别是日间长时间或较晚的睡眠，把小睡的时间控制在45分钟之内；（4）困倦时再上床，并且根据需要控制睡眠时间，通常不超过七小时，这能做到一个真正的、有效的睡眠，并且不会在床上辗转反侧；（5）停止使用咖啡因，不要多抽烟或喝酒，特别是在深夜；（6）停止考虑睡眠的类型——在睡觉前给自己一些“安静时间”，理想的是1-2小时，并且告诉自己你准备睡觉，而且会睡个好觉；（7）尽可能保持卧室安静、黑暗和舒适，室温65度是最适宜的，如果有可能就使用“白噪音”发生器或者磁带来产生掩蔽或放松的声音；并且（8）重新制定一个更合适的睡眠习惯：<a> 感到困倦再上床， 每天早晨在同一时间醒来，<c> 避免在卧室里做与睡觉无关的事（在可能的前提下），并且<d> 假如20-30分钟内睡不着就起来，做些如读书之类的事，直到想睡时再回去。

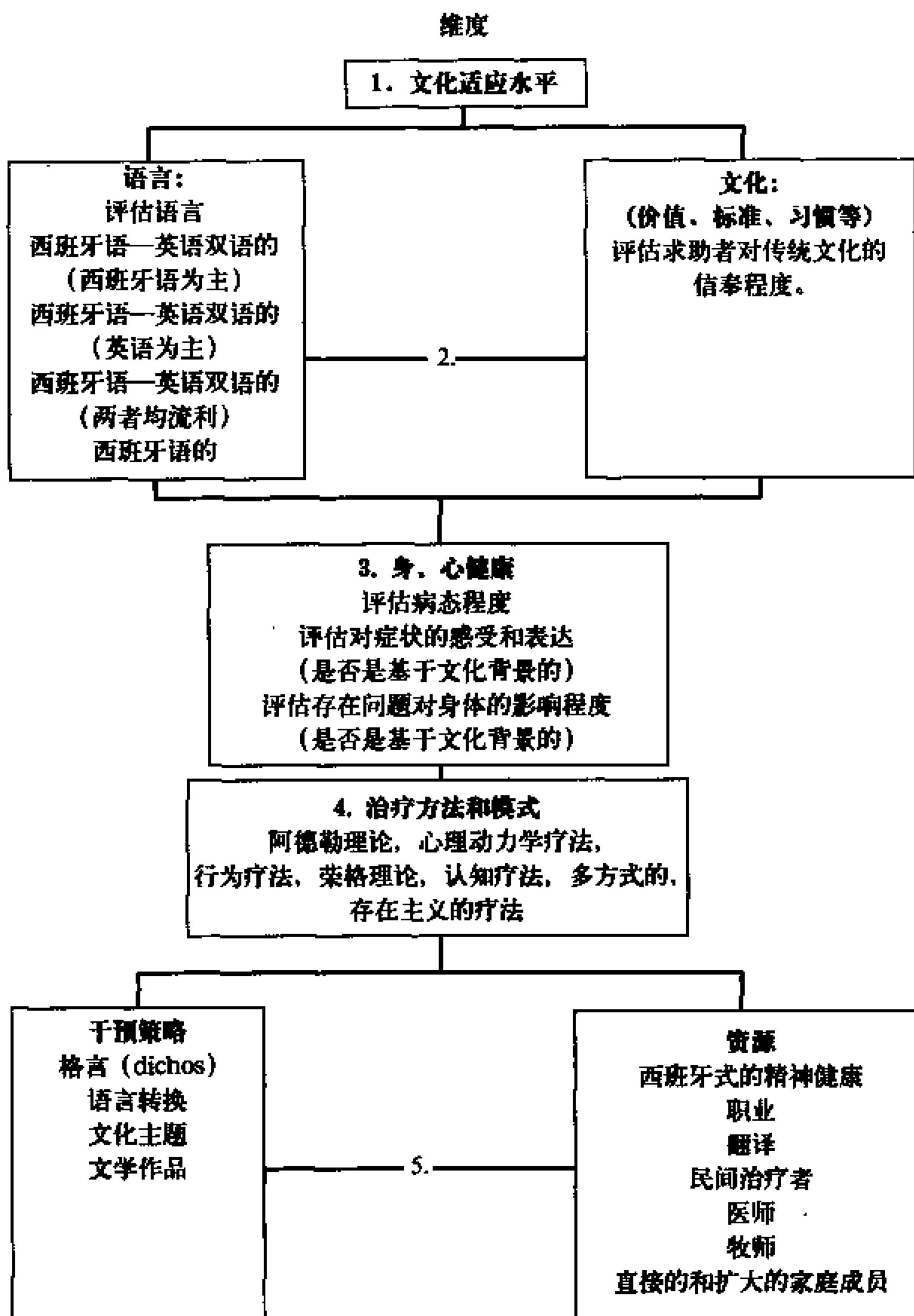


图 11-1 Santiago-Rivera 的文化敏感疗法选择模式

表 11-6 治疗策略和相应的求助者问题表现

情感的	认知的	行为的	系统的	文化的
个人中心疗法;	理性情感疗法;	Skinner 操作性	结构疗法;	多元文化咨询;
完形疗法;	Beck 认知疗法;	条件反射;	策略的家庭疗法;	跨文化咨询;
身体知觉疗法;	相互作用分析;	Wolpe 去条件反射;	代际沟通疗法;	
精神动力疗法;	现实疗法;	Bandura 的社会学习;		
经验疗法;		Lazarus 多通道疗法;		
积极聆听;	A-B-C-D-E 分析;	引导想像法;	子系统分化	元理论,
共情; 积极奖励;	布置家庭作业;	角色扮演;	指导;	基于文化的多模式,
真诚;	去条件反射;	自我管理;	卷入和分化;	干预技巧;
意识提高技术;	读书疗法;	生理指标记录;	强调三角关系、	世界观、
空椅; 幻想;	媒体磁带;	行为立约;	同盟关系	文化取向
做梦; 生物能;	头脑风暴;	决断训练;	和联合关系;	和文化身份;
生物反馈;	多重选择法;	社会技巧训练;	角色重建;	解放和宽容的
核心能量;	再构法;	系统脱敏;	澄清相互作用;	眼界;
计数疗法;	本我分析;	偶然事件立约;	再建法;	文化敏感

(待续)

表 11-6(续表) 治疗策略和相应的求助者问题表现

情感的	认知的	行为的	系统的	文化的
自由联想; 感情转移分析; 解梦; 集中技巧。	笔迹分析; 问题界定; 澄清相互作用顺序; 定义人际界限; 转换三角模型; 指出矛盾问题。	行动计划; 去条件反射。	指出矛盾问题; 改变作用顺序; 定义人际界限; 转换三角模型。	语言、暗喻、 仪式、实践、 资源、合作、 网络、意识提 高等。
问题表现 感情表现和 冲动; 感情的 不稳定性; 解决和决定 问题时感情 用事; 对自 己和他人的 敏感性; 对 于别人情感 的接纳性。	问题表现 智能化; 逻辑、 理智、系统行为; 推论; 计算机式 问题解决和决策; 对于逻辑、 思想、理论、概 念、分析和综合 的接纳性。	问题表现 参与活动; 强烈的 目标定向; 不断做 某事的需求; 对于 活力、活动、既成 事实的接纳性; 可 能要别人付出代价。	问题表现 卷入或脱离关 系; 严格的关 系界限和规则; 相互关系失调。	问题表现 文化适应水平; 世界观类型, 文化同一性的 水平; 双语或 三语; 目前的 问题在某种程度 上说, 是与文化 有关的。

表 11-7 Beutler 和 Clarkin 的系统治疗选择模式

问题的本质	改变的目标	相关的治疗
痛苦症状	行为 (第一改变顺序)	1. 社会技巧训练 2. 内在或外显暴露法 3. 阶段训练 4. 强化
	认知 (第一改变顺序)	1. 认知错误的确定 2. 估计歪曲的程度或危险性 3. 探询失常的假设和信念 4. 自我监督 5. 自我引导 6. 训练选择性思维 7. 验证新假设
象征性冲突	情感 (第二改变顺序)	1. 关注情感状态 2. 情感的反射 3. 情感“分裂”的双重工作 4. 和未完成事宜相关的单、双重工作 5. 构造意象法 6. 完形释梦法 7. 隐藏自我的镜像反射 8. 扮演对立情感 9. 自由联想 10. 身体表达和放松训练
	无意识冲突 (第二改变顺序)	1. 自由联想 2. 解梦 3. 鼓励转换投射 4. 解释阻抗和防卫 5. 通过评估常见错误或过失分析隐藏动机 6. 自由幻想的探索 7. 早期记忆的讨论 8. 关于内心“分裂”的双重工作

有痛苦症状的问题和有象征性冲突的问题。区别这两类问题的最简单办法是回答这个问题：“问题是由环境造成的习惯呢，还是那些内部冲突体验的象征性表现？”如果问题与情境有关，并有清楚的先前事件和后继事件，那么它就是症状问题。例如，一个十几岁的女孩被她的父母带到咨询者那里，因为她的父母确信在最近几个月里，女孩与他们变得“生疏和孤癖”了，尤其自从她与一个比她大的男孩来往后。

另一方面，如果症状反复出现，似乎并不与特定环境中的先前事件和后继事件有任何联系，而且再次发生的环境与最初的引发环境没有相似性，这时的问题则可能表示着内部冲突。例如，另一个十几岁的女孩被父母带来见你，她的父母认为女儿不仅同他们，而且同她的弟弟也变得“生疏和孤癖”起来。然而，他们说这一行为不是刚出现的，自从她2岁和她弟弟一同被收养时就开始了。在她2岁之前，她被生母遗弃在一所废弃的房子里好几天。她把自己描述为孤独的人，并且没有任何真正的朋友。

对于以症状为主的求助者问题，改变的目标是那些可观察到的过度行为、缺失行为，或认知障碍。对于以矛盾冲突为主的求助者，改变的目标是那些被症状所掩盖着的情感，以及内心深处的无意识矛盾冲突。表11-8提供了两个问题例子——抑郁和广场恐怖症——及其改变目标。

对于以症状为主的问题，应考虑改变求助者的行为和认知；建议的治疗手段应包括行为和认知干预策略，如示范法、逐步练习法、认知重建法、自我监测法等（见表11-7），这取决于症状是外显的，还是内隐的。外显的症状对于行为干预方法更具反应性，而内隐的症状对于认知疗法则反应性较好。对于那些把自己的痛苦原因进行外部归因的求助者，行为和认知疗法也能取得较好的效果。

对于以矛盾冲突为主的问题，应改变求助者的情感。建议的

表 11-8 两类求助者问题的改变目标

抑郁:
观察到的症状 (例如: 抑郁)
与当前问题有关的社会技巧缺乏 (例如: 缺乏沟通技巧)
与症状直接相关的认知 (例如: 消极的自我归因)
被症状所掩盖的情感和情绪 (例如: 对某重要人物的愤怒情感)
无意识冲突 (例如: 为失去母子关系而悲恸)
广场恐怖症:
观察到的症状 (例如: 不敢走进一座拥挤的建筑)
缺乏应对技巧 (例如: 不能控制唤醒水平)
与症状直接相关的认知 (例如: 对于死亡的预期)
被症状所掩盖的情感和情绪 (例如: 害怕失去身边重要的他人)
无意识冲突 (例如: 谋求依赖时的冲突)

治疗方法包括情绪和感觉结果增强干预策略, 如情感反射法、Gestalt 双椅及梦幻工作法、表象法、身体表现及相关活动法 (见表 11-7)。解决无意识冲突的建议疗法包括探寻无意识经历、强调人际关系模式以及隐藏动机的干预策略, 如解释法、对抗法、早期经历回忆法和双椅工作法等 (见表 11-7)。这类强调无意识动机和情感的治疗方法对于那些将痛苦进行内化归因的求助者似乎更为有效。

治疗持续时间

治疗类型的选择有一个层次表, 治疗开始时的关注点应当是简洁的, 换句话说, 应当指向症状而不是内部冲突。Beutler 和 Clarkin 总结道: “初始的假设应当是, 任何问题都是单纯习惯问题, 或是简单的适应问题。只有当有相当可信的证据表明, 症状

以一种重复和衰减的模式代表着深层联系，治疗的关注点才可以放到象征性内部冲突上，而并非只关注症状”。

Beutler 和 Clarkin 主张，治疗计划开始于症状的治疗是有益的，因为没有证据显示，使用有限的疗法对付复杂问题会产生负面影响，但是使用大范围的疗法来对付一个简单的问题则有些太过分了。他们承认，尽管“使用有局限性的疗法对付复杂的问题时，症状可能会反复，……交替使用不同宽度的混合疗法的确可能减少症状的反复”。他们指出，随着改变目标的增加和求助者体力及资源的减少，较长时间的治疗就变得重要起来。一项证据显示：求助者接受治疗的总量越多，持续的时间越长，受益就越大。然而，一些机构和保健管理部门都有限制治疗时间的政策，时间长短要取决于对求助者的诊断。出现单纯情境问题的求助者最适于使用危机干预方法，但我们不能假设所有来咨询的求助者，都适合于简单、用时很短的治疗。简单治疗对于那些有可能较早地放弃治疗的求助者似乎比较有效，如那些处于改变模式中考虑前阶段的求助者，和那些只有单一症状或冲突问题的求助者。短期治疗还可能符合一些少数民族求助者的要求和信仰。表11-9总结了主要的指标，用以决定何时进行针对症状和内部冲突的简短治疗方法。

治疗模式

治疗模式是指对求助者进行干预的特定方式，包括：

1. 个体治疗
2. 配偶和 / 或家庭治疗
3. 群体治疗
4. 药物治疗

这些模式都各有某些优点。个体单独治疗比其他模式涉及更多的隐私、自我流露、情感分享和更为专注、与咨询者有更多的认同

表 11-9 使用简短疗法的指标

针对内部冲突的简短疗法

指标：

1. 内心冲突的焦点是分离、恋母情结、自恋伤害或应激反应综合征。
2. 目标是某重点领域的特征改变。

有助于治疗的因素：

1. 求助者在童年时期至少有一个重要的人际关系。
2. 求助者对咨询者反应迅速、灵活、坦诚。
3. 求助者在评定时能集中在中心冲突上。
4. 求助者愿意检验自己的情感和行为。
5. 求助者有相对较强的自我能力,这可以通过教育、工作和性行为找出证据。
6. 求助者有改变行为 and 了解自我的动机。
7. 求助者智能良好,能用语言交流思想、情感和幻想。

针对症状的简短疗法

指标：

1. 焦虑症、广场恐怖症、恐慌症、广泛性焦虑、过度换气、考试焦虑、人际焦虑。
2. 轻度到中度的抑郁。
3. 社交技巧不足。
4. 性功能障碍。
5. 强迫的仪式性动作。

有助于治疗的因素：

1. 对一些有色人种的求助者,有时间限制的治疗可能更合适。
-

感等。配偶治疗可以直接观察配偶之间的相互作用,如双方的冲突和共同利益,并且可以为双方发展出相互支持、相互交流和解决冲突的办法。父母和孩子都参与的家庭治疗也具有这些优点。群体模

式允许从他人那里得到深度示范、支持和反馈。夫妻、群体和家庭干预对于提供教育和技巧训练都是很好的背景。个体、夫妻/家庭和群体模式治疗没有典型的副作用。药物治疗手段包括使用精神药物,以帮助治疗或减轻精神疾病,很明显这会造成生化失衡。通常用药物治疗的病症包括严重精神病、内因性或严重的抑郁症,以及双向情感紊乱。若有必要使用药物治疗手段,求助者同样还需要医生的评估和复查。用药物治疗,求助者很少能学到解决问题的新方法,所以还需要一些心理治疗方法。另外,用药物治疗比用其他模式治疗,会给求助者引起更大的风险和各种副作用。

治疗的模式通常由求助者问题的性质来决定。正如 Beutler 和 Clarkin 观察到:“一般来说,假如冲突的症状反映了一个短期或不复杂的模式,此模式又在求助者个人控制之中,并且没有给当前的家庭环境带来什么麻烦,那么就可以使用个体或群体治疗。若症状或冲突给当前的婚姻/家庭的人际环境带来了严重困扰,那么家庭/婚姻治疗模式将是选择对象。同样地,若症状或冲突具有人际性质,且延伸到家庭环境以外,团体治疗将是选择的形式”。

表11-10明确描述了适合于各种治疗模式的求助者和求助者问题。尽管这个表没有包括所有治疗模式的条件,但其优点是提醒某些咨询者不要只根据自己的训练背景,而不根据求助者的问题来确定计划和选择干预方法。单一的视野导致单一的治疗方案。例如,一个受过配偶和家庭咨询方法训练的咨询者,可能会把所有问题和相应干预措施都引向家庭咨询;然而只受过个人咨询方法训练的咨询者,则可能错过或忽略求助者问题中与家庭、群体和系统有关的重要部分。使用多维治疗观点的重要性怎么强调都不过分!求助者的问题越严重,涉及的方面越多,多种治疗模式的使用就越关键。

选择治疗模式要考虑的另一因素是成本效益。我们在以下部

表 11-10 求助者问题和治疗模式之间的关系

治疗模式	求助者特征和存在问题
个人	1. 求助者的症状或人际关系问题是基于内部冲突和应付生活方式，它们导致求助者出现了固定化的生活方式，而不去理睬当前人际关系的特殊性。 2. 求助者是一个努力在家庭中获得自主权的青少年。 3. 问题或困难是非常令人难堪的，因此要求个人治疗以使求助者感到安全。
配偶	1. 配偶双方互相认可，或者表现出的症状或冲突几乎只在夫妻间发生。 2. 一方单独有症状——例如广场恐怖症或抑郁症，这种情况由于配偶的作用而保持或加重。 3. 对一方进行一段有效治疗后，另一方也有参与的必要（例如，一方得了厌食、肥胖或恐惧症，需要配偶帮助其进行行为治疗，以促进合作，并提供一般支持）。 4. 夫妻关系暗示他们之间的角色很僵化。
家庭	1. 家庭问题出现于没有被任何一个家庭成员看做是特殊的求助者，问题主要体现在他们的关系模式上。 2. 家庭出现了当前内部关系的结构性困难，每个成员都共同或公开地对相互影响负有责任。 3. 家庭中的青少年可表现出发泄行为。 4. 一个家庭成员的进步能导致其他成员的退步。 5. 一个家庭成员有慢性精神病（例如：精神分裂症），这需要全家人来应付这种情况。
群体	A. 混合群体（群体中的求助者各有不同的问题） 1. 求助者最有压力的问题出现在人际关系上，例如： 1) 求助者孤独，希望与他人亲近，有社会和工作阻碍，过分腼腆； 2) 求助者不能和他人分享，表现出自私和爱炫耀，需要受到格外的敬重，很难接受对别人的需求和做出反应； 3) 求助者喜欢争论，反对权威，显示出消极—积极的特性；

（待续）

表 11-10(续表) 求助者问题和治疗模式之间的关系

治疗模式	求助者特征和存在问题
	(4) 求助者具有过度依赖性, 相对地不能独立、缺乏主见; (5) 求助者在人际关系中具有外部归因应对风格, 倾向于感情用事。 2. 求助者可能没有显著的人际问题, 但可能有其他原因与混合群体有关, 如: (1) 变得和私人治疗师关系紧密, 并且不能坚持自我观察。 (2) 极端理智, 如有人对他表示质询, 则可能有益于他的改变。 B. 同类群体 (群体内的求助者有明确共同问题) 1. 明确的冲动问题, 例如肥胖、酗酒、吸毒、赌博、暴力。 2. 问题属于急性环境刺激, 例如心脏病、离婚、髋骨吻合术、晚期疾病。 3. 与特定的人生发展阶段相关联的问题, 例如儿童养育、衰老。 4. 明确的症候群, 例如恐惧症、精神分裂症、双向紊乱。

分将详细讨论这个问题, 个体模式需要求助者和咨询者花费最多的时间, 群体模式最少, 夫妻和家庭治疗则居于二者之间。夫妻治疗和家庭治疗对于住院求助者最具成本效益, 治疗对象包括: 精神分裂症, 违法犯罪, 严重的青春期失常, 以及青年和成人的药物依赖和成瘾。

治疗的成本效益

如前面提到的, 在选择治疗类型、疗程和治疗模式时, 要考虑到成本效益。Herron、Javier、Primavera 和 Schultz 指出, 目前资助政策趋向于采取这样的观点, 保险支付范围内的心理治疗, 只要能够恢复或保持求助者精神健康的“必需水平”, 这就足够了。必需水平意味着“只要不存在影响个人完成生活中必要任务的症状”就可以了。从花费的观点上, 这种所谓的“保健标准”暗

示着,没有必要进一步考虑预防与改进的问题。Herron 等人说,“当功能水平处于可接受的标准以下时需要进行心理治疗,这被认为是合理的;但是追求高水平的心理健康则被认为是不必要的”,至少精神保健管理部门一些人的观点是这样。

提到治疗的支出和收益, Herron 等人认为有两个方面需要加以考虑。一个是经常被使用的错误假设,即把有效性和功效等同起来。许多保健组织把每年的精神保健次数限制在20次以内,并且假设此数字为有高需求的人也提供了一个“安全港”。然而,如 Herron 和他的同事(1994)指出的,目前的资料驳斥了这个假设。一个非常全面的研究表明,对于大部分求助者来说,每年进行52次咨询可以获得最大的收益。美国心理协会支持这种说法,并认为这样作,临床成本效益是好的。显然,肯定有一些需要更多治疗的求助者,他们自身没有能力支付或不能借助于保险进行所需的治疗。贫穷的求助者和一些少数民族求助者更可能无路求医。实际上,很难给所有求助者找出一个通用的有效疗程标准,因此要为每个求助者单独制定治疗计划。

第二个方面,费用应和保健质量保持很好的平衡。保健管理部门一直依靠效用回顾法来限制治疗次数和治疗者数目。结果,一些收费较高或使用较长疗程的咨询治疗者被取消资格,更糟的是,一些求助者因此而过早就被停止治疗。

Eckert 注意到,“恰当的临床保健途径被堵塞,不仅导致了求助者心理上的痛苦,而且增加了与管理、诉讼及治疗建议有关的所有费用”。一些有保健管理的公司现在认识到,效用回顾法所花费的费用比所节约的还要多,于是它们改用一种称为“服务者剖析图”的方法。服务者剖析图收集了最具成本效益的咨询者资料,并将他们列为参照榜样。所有咨询者都要根据下面的指标进行“评分”,诸如求助者满意度、临床效果,以及达到这些效果的时间和花费报告等。

评估治疗的成本效益应处理以下问题:

1. 对于一个具有确定问题和目标的求助者, 疗法 A 比疗法 B 更具成本效益吗?
2. 这一疗法的收益是否超过投入?
3. 我怎样才能最短的时间内使这个求助者获得可能的最好结果?

对于典型的咨询者, 成本效益意味着:

1. 针对每个求助者的目标, 描述可供选择的治疗干预方法或治疗方式。
2. 给每种治疗方式列出成本和收益表。

成本包括: 咨询者或诊所运转费; 求助者引致的费用, 如误工费等; 以及与咨询者的工作和设备有关的正常开支。成本还包括使用疗法 A 和 / 或 B 所需的治疗次数的费用估算。

收益包括: 求助者在功能整体上的改变程度; 症状减轻的幅度; 以及求助者生活质量的提高。受益还包括治疗给求助者生活的其他方面带来的影响, 如求助者的生活和他的家庭、学校、工作等等。显然, 花在一种治疗方法上的时间比其他方法短, 但能得到相同的结果, 这也是一种收益。

3. 选择那些最有成本效益且临床上最有效的治疗方式, 它帮助求助者达到目标的可能性是最大的。

治疗计划和选择中的性别和多元文化问题

咨询者一开始就应认识到心理治疗策略和干预方法的起源, 以及这些起源对于制定治疗计划的含义, 特别当治疗对象是那些感觉自己“处于社会边缘”或在社会主流外的求助者。本书后半部分讲述的大部分治疗策略都是由创始人在其治疗过程中建构出来的, 其中被广泛使用的治疗策略, 都反映了主流文化的价值观,

主流文化被认为是由“白种人、中产阶级、年轻人、健全者、异性恋者和男人”所决定的。不具这些特征的求助者多半会感到处于边缘状态。另一个重要之点是要认识到,一些在欧美求助者身上取得成功的传统心理治疗技术,对于那些主流范围以外的求助者来说,则可能是他们文化上的禁忌对象。传统的治疗计划和选择并未考虑种族、性别和社会阶层——尤其是贫穷及文化视角方面的问题。在所有治疗计划中,有两个重要问题需要咨询者考虑:

1. 常规或推荐疗法会对求助者产生更大压力吗?
2. 当治疗“被压迫”的求助者时,治疗应是怎样的,能提供什么?

假如这些问题未解决,那么咨询者在治疗计划中就很可能反映出欧美中心主义和大男子主义。

看待这个问题的另一个方法是,要从求助者的世界观考虑求助者对心理治疗和具体干预策略的接受程度。“世界观”是我们对世界的基本知觉和理解。Sue 和 Sue 认为有两种主要世界观维度影响着治疗计划,一个是控制点,另一个是责任点。控制点可以是内控的,也可以是外控的。倾向于内控的人们相信通过信仰和行动,他们可以改变自己的命运。倾向于外控的人们相信,自己的命运是由运气或造化,以及他们控制力以外的力量所左右的。起源于归因理论的责任点概念,同样也可分为内部的和外部的两种。有内部责任感的人们感觉,他们对自己的成功和失败负有责任,而外部责任感高的人觉得,是社会主宰着他们的问题和成功与失败。

Essandoh 提供了一个跨文化例子,以说明归因风格在少数民族求助者中是如何变化的。他提到,某些文化看重相互依靠、谦让和集体主义,而不是独立、自私、个人主义,这种文化的求助者常将成功归因于外部因素的作用(如上帝、祖宗、显要人物、咨询者等),将失败也归因于外部因素(如鬼神、坏运气、上帝

的意愿等)。他指出这一归因风格通常反映了谦让的愿望,而并不意味着抑郁、低自尊或决断有问题。他总结说,当问题被外部化时,咨询者“应对这种不同的世界观(如将“问题”特别归因于鬼神)表示尊重,并提供一种不同的世界观和解决问题的可能建议”。

图 11-2 展示了 Sue 和 Sue 对控制点和责任点组成的四个象限的分析。前面提到的主流求助者(白人,中产阶级,青年人,健全者,异性恋者和男人)最有可能属于左上象限(I) IC-IR,这反映了美国主流文化的“极端个人主义”。认知疗法和问题解决之类的疗法是以个人为中心的疗法,反映了个体的中心性和理性主义,它们也属于这个象限。这些疗法对那些既看重内在控制,也看重内在责任的求助者最有可能奏效。

内控 - 内部责任 (IC-IR)	内控 - 外部责任 (IC-ER)
I.	III.
我很好,能控制自己。	我很好,也有控制力,但需要机遇。
社会是正常的,我在这个系统中能够工作。	社会不好,但我知道问题所在,并试图去改变它
外控 - 内部责任 (EC-IR)	外控 - 外部责任 (EC-ER)
II.	IV.
我很好,但只有当我按主体文化的定义来约束自己时,我的控制力才达到最好。	我不好,也没多少控制力;我或许该认输或求助于他人。
社会看样子并不错,这全看我的了。	社会不好,使我陷于困境;糟糕的制度真该死。

图 11-2 Sue 和 Sue 的文化同一性矩阵

位于其他三个象限的求助者更可能是处于社会“边缘”的人群，他们在与主流社会成员相处时会遇到许多问题。Lum针对于这三个象限描述的求助者，提出了五种特别的干预治疗方案，分列如下：

1. 释放（相对于压迫）。当改变发生时，求助者从受压抑的障碍和控制中释放或解脱出来的体验。在一定程度上，它伴随着个人的成长，求助者决心永不向压力屈服。从另一方面讲，释放又是在环境变化的影响下出现的，例如，一种就业培训计划的引进，或是一位少数民族市长的当选，他制定了有利于有色人种的政策、法规和纲领等。
2. 赋能（相对于无能感）。帮助那些受歧视社会人群求助者，使他们发展和增加人际影响力方面的技能。它强调人在社会中资源和福利的权利。赋能的第一步是获得关于资源和能力的信息，然后选择适当的行动途径，求助者担任有一定利益的职位。锻炼能力，赋予能力的具体方法有参加当地的投票选举、影响政策或发起提案。
3. 平等（相对于剥削）。涉及一种平等的观念。对于有色人种来说，平等意味着在社会上与别人有同等的权力、价值、地位，并受到同等的待遇。它的核心就是公平和赋予一定权利。平等体现在保障最低生活水准的财力方面，如社会安全保障、医疗保障、最低收入保障和医疗保险等。
4. 文化保护（相对于文化同化）。维护一个民族的思想、风俗、技艺、艺术和语言的重要地位。通过追溯一个民族的历史，咨询者和求助者能鉴别出这个民族生存和成功所经历的转折点和挑战。应用这样的历史课来鼓励求助者克服障碍，并成为提供给求助者力量的源泉。文化的保护，保全了求助者作为一个民族成员的身份。
5. 独特个性（相对于偏见和定势）。是一种超越偏见和定势

的干预策略。个体功能咨询强调在咨询关系中每个人都是独特的，每个个体都独特之处。当有色人种为摆脱社会偏见追求自由时，他们就是争取自己的个性，并显示自己的人性。

在图 11-2 的左下象限（II. EC-IR）中，求助者一方面反映了美国主流文化对自我责任的定义（IR），但另一方面又在生活中感到很少有控制能力（EC）。这些求助者很可能觉得在主流文化体系和影响自己命运的本族文化的联系中左右为难，如妇女、有精神或身体问题的人、老年人、穷人、同性恋者、双性恋者和非欧裔美国人。虽然他们具有两种或更多种文化的特征，但这些个体更适应主流文化，而不是本族文化。他们很可能在支配—从属权力结构中居于从属地位，然而他们或者是没有认识到这一点，或者认为从属地位是他们自己造成的。受丈夫或男友虐待的妇女和那些过去有过严重创伤史的求助者都是这方面的例子。带着这种世界观的非欧裔求助者时常宁愿要找一个欧裔美国咨询者的帮助，因为他们拒绝自己的种族和文化。

对持有这种世界观的求助者，直觉和主观的疗法要比理性和客观的疗法更有可能奏效。要帮助他们认识对主流文化适应的结果，认识支配—从属社会层次的影响；帮助他们提高自身的力量和智能，表现出自己的能力和成就，表达出自己的需求和愿望，以及增强自己的个人权威感和自我价值感。当求助者持有 EC-IR 世界观时，临床咨询者必须建立一个相互协作、相互尊重的工作关系，而且必须抑着一种中立的立场。对于这些求助者，Lum 模式中的文化保护和释放方法特别有效。

将求助者的问题重构为社会情境问题，并帮助求助者把个人身份与问题区分开来，同样有作用。Sue 和 Sue（1990）指出：“一个文化上封闭的白人咨询者，如果不了解与求助者息息相关的社会政治动力学的话，可能会在不知不觉中让冲突存在下去。”第二

章到第六章中讲到的咨询关系和沟通技巧,对于EC-IR求助者尤其有效,特别是当有意识地运用移情和聆听反应来证实求助者的愿望和体验时。Young-Eisendrath指出,“双方相互的验证是人类心智健全的基础,我们通过它知道自己经验的真实性,并通过它充实自尊感”。从另一方面说,如果给了求助者发言权,但咨询者却不去聆听或不能理解一个EC-IR型的求助者所要阐明的新观点,那对问题的解决还是没有帮助的。

在图 11-2 的右上象限(III. IC-ER),求助者的世界观正好相反。在某种意义上,他们相信如果有好的机遇,他们能够通过个人能力改善生活。他们认为由于“制度”的压迫、剥削和偏见、墨守陈规,限制了他们的机遇。与EC-IR型的求助者相反,IC-ER的求助者特别能融入他们自己的种族、性别或性身份(像我们在第二章中提到的),现在却要求恢复他们自己的文化渊源和性别特点。Sue和Sue预言,那些偏离非主流文化的求助者会日益意识到自己的文化特性,会有越来越多的求助者持有IC-ER型的世界观。研究者认为,主流文化中具有IC-IR观点的欧美咨询者最不信任持这种世界观的求助者,认为他们是最棘手的求助者,这些求助者很可能在治疗计划阶段形成之前就停止咨询,因为他们对咨询者感到不满,或认为咨询进行的方式不“适合”自己。这些求助者面对持有IC-IR观点的咨询者时,常常不愿开口讲出真情。

持IC-ER观点的求助者很可能将问题归因于外部原因,他们不能同持IR观点的咨询者形成治疗同盟,因为这些咨询者把问题看成是求助者内部原因造成的。这种求助者可能期望得到并利用直接的、行动化的及社会系统指向的治疗法。正如Sue和Sue所指出的:IC-ER型“求助者强烈要求咨询者采取外在行动……但我们大多数咨询者的训练都教导我们不要进行外在干涉”。对于IC-ER求助者来说,我们在第七章中提到的行动反应技巧和行为

干涉法都相当有效。使用Lum模式中平等、独特个性和释放等方法对这种求助者也都特别有效。

第四限即右下象限(IV, EC-ER)的求助者持有EC-ER型的世界观。这种求助者最有可能觉得绝望、泄气和无能,因为他们受到高度的外在控制,同时又百般谴责现存制度,他们认为自己无力克服造成困难的外部障碍,比如歧视和剥削。他们高度的EC反应可能表明,他们已真正产生了Seligman所指的“习得无助”(那些经历了漫长而无法驾驭自己的生活的人们,对以后的境遇形成了无助念头)。高度的EC反应还表明,这些求助者只知道解决这种无助状态的最佳方式就是与当权者进行和解。习得无助与和解行为都代表了这些人的自下而上的策略,他们认为直接表达愤怒或健康的直率太过危险,因为可能导致从环境中得到惩罚性后果。奴隶制还存在时,如果非洲美国人不对他们的白人“主人”举止恭敬,他们就要受到严厉的处罚。不幸的是,这种贬低身份的社会现象“后遗症”至今仍然可以被感受到,它存在于许多欧裔美国人与非欧裔美国人的交往中。在一定程度上我们也都不断受到对种族、人种、性角色、性倾向等无意识偏见的影响。妇女也学会认识到在一个主要由男人掌权的社会中直接表达愤怒的风险。正像Young-Eisendrath指出的那样,“任何社会背景下的妇女,如果她坚持己见、表示愤怒或争取权力,通常就会被认为是过会支配、咄咄逼人或管过头了,几乎很少有人简单地将其理解为愤怒和具有权威”。EC-ER的求助者面对咨询者时,可能表现得过度礼貌和恭敬,他们不像IC-ER求助者,不能挑战或直面咨询者的偏见,因为他们察觉到这种行为要么太冒险,要么一文不值。他们不可能对你表现出直接和公开的生气,即使是你做的或说的已经在某种程度上冒犯了他们。他们也可能表现得如同相信你的观点,但是一旦出了诊所,他们可能马上就将你的那些在他们生存空间不起作用或站不住脚的观点

丢弃。针对EC-ER求助者的治疗计划在实施前,咨询者首先必须认清他们的生存价值观,这样才不会认为这些求助者“缺乏勇气和自我力量”;另外,教会这些求助者使用新的为人处世策略,也是非常有帮助的。在Lum的模式中,赋能、授权的干预措施对这些求助者特别有用。

将这种模式应用于治疗计划时,要记住Sue和Sue(1990)提出的一些警告。首先,任何一种世界观都有一些有用和积极的东西。例如,“第一象限群体的个人责任感和成就欲望,第二象限群体的二元文化和文化灵活性,第三象限群体的妥协能力和对生活条件的适应性,第四象限群体中的集体行动和对社会的关心,这些都应该互取所长”。咨询者的任务是制定这样的治疗方法,它们能够帮助求助者综合各种世界观,以增强自己的效力和幸福。第二,对这种模式的科学研究还处在发展阶段,我们所做的观察还只是试验性的。第三,这四种象限的描述只存在于理论上,而实际上大多数人都是混合的,并不符合纯粹的分类标准。因此,咨询者要面对具有主要和次要控制点和责任点的求助者,并要能向他们提供治疗计划。

大体上,我们为多元文化治疗计划提出下列几种指导原则:

1. 确定治疗计划要在文化和临床上敏感、相关的。文化不敏感的治疗计划有如让亚洲的父母以美国的养育方式训练自己的孩子。而“对亚洲家庭来说,被家庭赶出家门是个人所能承受的最坏的一种处罚,轰出家门相当少见。所以当孩子做错事时,他们被家里人威胁要赶他们出去或被告知出去。当然,孩子们不得不抗争留在家里。一旦留下,他们就不再离去。儿子们还带来了妻子,并且期待父母帮忙照顾孙辈”。换句话说,要确保治疗计划反映求助者文化所特有的价值观和世界观,而不是咨询者自己的世界观。

2. 确信治疗计划表达了求助者所处社会系统以及求助者本人的需要和影响（如社会压迫状况）。例如，你正在为一个吸毒的土著美国青年咨询。虽然可使用认知-行为干预策略，但还远远不够，除非你还对求助者的文化因素进行探索，并了解社会压迫在多大程度造成了他的吸毒行为。Freire在他的一本经典著作《受压迫者的教育学》中阐述了一个重要的咨询目的，培养关键意识——即对自己在社会体系中地位的意识。
3. 确信治疗计划涉及了本土化的治疗方法，并得到了求助者的支持。换句话说，确认你的计划包括了求助者生活中的重要支持系统和资源，如他们的家庭和外部的支持系统。大量研究表明，咨询者与当地的社会支持系统进行合作，会促进咨询者的治疗计划，并更具文化共鸣性。
4. 确信治疗计划强调了求助者对健康、康复和问题解决等的观点。求助者的精神在这方面可发挥极大的作用。民间信仰、神话和超自然的力量等都可能是重要因素。
5. 在治疗计划中要考虑和评估求助者的文化适应程度、优势语言和语言偏好。在总体治疗计划中，使用相关的文化主题、手稿、民间故事、谚语、比喻等，以作为文化特殊性的治疗方法。
6. 确信你所计划的疗程能在时间上满足求助者的需要。据Rosado和Elias所述，求助者在他们在茁壮成长前，必须先能够生存。实用策略，具体的应对技术，短期的治疗可能被一些求助者喜欢。Rosado和Elias建议，将治疗计划按求助者的生态需要进行剪裁，“要是让求助者能在一年中抽几次时间来处理问题，这远比他们不再回来更为重要”。

学习练习活动 36

在这个练习活动中，你会遇到一个低收入美国农村妇女的案例。你的任务是仔细阅读这个案例，并应运我们讨论过的 6 项指导原则，指出为这个妇女进行咨询时可能存在的多元文化因素。然后，同其他同学一起针对上面找出的各种因素，制定出相应的治疗计划。要根据求助者的问题和结果目标，确定治疗的类型、模式和时间。

Jane 的案例：

Jane Wiggins 是一位 34 岁欧洲后裔妇女，生活在偏僻的山区农村。一次被强奸后，她被附近的精神健康中心推荐来进行心理咨询。

她对咨询者十分怀疑，因为咨询者是个高加索男人。她不愿讲话，也不抬头。渐渐地她才说，她已经结婚，但没有孩子；自己没有工作，而丈夫因身体很差，也只靠社会残疾救助金生活。三十多年来，她一直生活在农村。过去一年里，她发现生活在同一个村子的白人男人，一直在注意着自己。她知道这个名字，但很少碰面。他还写了大量的信，不断打电话，说下流话。她和丈夫到警察局去过几次投诉，但没有人干预此事，因为这个男人与副警长有亲戚关系。几个星期前，她丈夫到山那边的邻居家做客，没有告诉她，也没有锁门。那个男人显然当时就在附近，看到她丈夫离开后，就进到屋里，强奸了她。此事她只对邻居和丈夫讲了，而没有对其他人说，她感到十分羞辱。她十分信仰宗教，但她没有勇气去向牧师忏悔，因为她怕其它人的议论。出于同样的顾虑，她也没有告诉住在附近的母亲和姐姐。她觉得报告警察局也没用，因为他们多次不理睬她的报告。她有很强的罪恶感，因为她相信自己本可以防止这件事发生的。这以后，她做了大量的

祷告。

几个疗程过去后，Jane 开始变得爱说起来；并表示她愿意来此做咨询，以使自己变得愉快起来，不再被罪感所缠绕。最后，她表明更愿意向另一个女性咨询者谈论此事，因为这个问题实际上是“女人问题”。

我们在第九章和下面（见图 11-3），为读者提供了一个门诊病人治疗表格样例。类似的表格在各种咨询服务机构中都可以见到。评估部分（部分 A）综合了第八章和第九章所讲述的各种评估信息。治疗计划部分（部分 B）汇集了本章和第十章涉及到的结果目标和治疗计划信息。部分 C 包括最近三次治疗报告，涉及结果目标的进展情况，如目标的评价，行为改变的评价，以及阻碍因素和继续治疗的要求。部分 D（结束报告）指出治疗在多大程度上达到了结果目标。我们相信，如果治疗者能够在评估、制定目标、评价和治疗过程中（如同图 11-3 所示那样），积极、主动利用这类治疗计划表格，那么他们的治疗就会是有效的。让求助者参与完成这个表格，并在表格中为求助者留出评论的地方，就可以确保求助者是积极地参与了整个治疗过程。

门诊求助者治疗报告

报告人：_____

求助者姓名：_____ 出生日期：_____ 年龄：_____ 性别：_____

A. 评估

1. 当前问题：_____

2. 咨询的原由：_____

3. 相关的医疗史（药物、毒品、疾病、伤残、手术等）：_____

4. 以前的精神及心理状况和治疗：_____

5. 其他相关史（职业／学校、人际关系／性关系，社会／法律等）：_____

6. 简明的精神状况（在项目上画勾）：

外表／衣饰	智力	判断力	幻觉／幻想	思维混乱	近期记忆	远期记忆
—适当	—高	—良好	—没有	—没有	—完整	—完整
—不适当	—中	—缺失	—有	—有	—缺失	—缺失
—没有评估	—低	—没有评估	—没有评估	—没有评估	—没有评估	—没有评估

7. 情绪／情感（描述）：_____

8. 自杀评估（危险、计划）：_____

他杀评估（受害者、暴力、计划）：_____

9. 临床诊断：_____

B. 治疗计划

1. 目标行为和可测量目标（强调当前的问题）：

2. 治疗类型：认知／行为疗法 人际关系／顿悟／情感疗法 意识疗法 其他：_____

3. 治疗时间长短：

4. 状态：

	问题	目标	成功的标准	干预措施
1.	_____	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____	_____

治疗者签名：_____时间：_____

电话: _____ 执照号: _____

求助者评语: _____

治疗报告一(评估后第一次)

目标 (见前页)	是否获得进步			评语
	是	有些	没有	
1. _____	_____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____	_____

治疗者签字: _____ 时间: _____

治疗报告二

目标 (见前页)	是否获得进步			评语
	是	有些	没有	
1. _____	_____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____	_____

治疗者签字: _____ 时间: _____

治疗报告三

目标 (见前页)	是否获得进步			评语
	是	有些	没有	
1. _____	_____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____	_____

治疗者签字: _____ 时间: _____

治疗结束报告

最后治疗日期: _____ 全部治疗次数: _____

目标（见前页）	是否获得进步			评语	达到目标
	是	有些	没有		
1. _____	_____	_____	_____	_____	无效
2. _____	_____	_____	_____	_____	求助者转诊
3. _____	_____	_____	_____	_____	不合宜
					求助者退出

治疗者签字和电话: _____ 时间: _____

图 11-3 治疗计划表样例

治疗范例对话：Joan 的个案

在下面的对话中，咨询者帮助 Joan 计划治疗策略，以达到 Joan 的第一个结果目标（见第十章中所列 Joan 的目标图）。这个对话是前两章对话的继续。在此，Joan 和咨询者讨论了如何帮助 Joan 减少上数学课和对父母拒绝态度的焦虑。注意这里所建议的三种策略都是针对 Joan 特殊的局部性焦虑，而不是广泛性焦虑。

在开始会谈后，咨询者总结前次会谈内容，并给 Joan 介绍探索治疗方法的思路：

1. 咨询者：Joan，上周我们谈到，你愿意在咨询完成后看到的一些结果。其中对你十分重要的一点是，你想要能够变得更积极、主动一些，如回答问题、主动提出问题、表明自己的观点和感受。我们发现你现在无法做到上述事情的原因，在于你在某种情形下感到焦虑，比如与父母在一起或上数学课时。我们有好多种方法可以解除你的忧虑。今天我们就谈一下所要采取的步骤。你觉得怎样？

求助者：好。如果我们能找到一条出路，我也许不再那么紧张，会感到舒服些。

在对话 2 中，咨询者尝试向 Joan 解释治疗计划的内容，以及

Joan 参与的重要性。

2. 咨询者：是的。但是要知道没有现成的答案，而且出路也不是只有一条。我们今天探讨的方法，都是些可以在特定情境下帮助人们缓解焦虑的手段。重要的是要找出你认为最适合于你自己的方法。在决定前，我将介绍一下这些方法。

求助者：好的。

对话3和4中，咨询者提供了一些策略让Joan考虑，也解释了这些手段与她的关系以及怎样帮她达到目的。

3. 咨询者：就我的经验而言，我想有这样几条途径可以帮助你克服不安和焦虑。首先，当你焦虑时，就会紧张。有时，你紧张时，就会感到不舒服，好像病了，自己无法控制。我们可以教你一些放松的方法（见第十七章）。放松将有助于你了解什么时候你会开始感到焦虑和紧张，使你能在它变得十分强烈之前加以控制，这样你就不至于逃课或者不愿开口发言了。有道理吗？

求助者：是的。我真是在自己焦虑时，就不想说任何话。有时候我强迫自己说，但我仍然紧张，我不喜欢这样。

4. 咨询者：很好。你没有精力或愿望去做你担心的事情。有时候对于某些人来说，懂得放松和控制自己的紧张就足够了。你可以先试一下放松，如果这可以帮助你发言时放松下来的话，这个方法就是有用的。当然我们还有其他一些事情要做，我也想让你了解这些行动计划。

求助者：是什么样的呢？

咨询者在对话5中提出增加一种干预策略的建议，并指出这个策略能帮助Joan减少焦虑。要向她讲清楚这种方法是如何与她的问题和目标相关联的。

5. 咨询者：其中一个过程有一个很有意思的名字，叫做“应

激预防”(见第十六章)。你知道,你曾“接种过牛痘”,这种预防针可保护你不得小儿麻痹症。同样,“应激预防”过程也会帮助你在应激场合中(如上数学课或与父母在一起时)不会那样焦虑。

求助者:这会不会像打针那样疼?

咨询者介绍了应激预防的一些内容,包括时间、利益和风险。这些可以帮助 Joan 考虑她的选择。

6. 咨询者:不,不是这样,当然你自己要做些工作。除了学习刚才提到的放松法之外,你还应学会如何应付应激场合:放松身体,去想一些帮你应付这些困难和竞争场合的想法。当你在我这里能够成功地做到这些时,你就可以开始在数学课上和家里去做。一旦你学会放松后,我们将会用几个疗程学会其他方法。应激预防的好处就在于,它帮你学习如何应付而不是躲避应激场合。当然了,它要求你自己不断练习放松术和应付的理念,这需要每天都花些时间来做。如果不进行日常练习,它就没那么有用了。

求助者:这听起来很有趣,你是不是用了很多次呢?

咨询者指出了这个方法的一些信息和好处,这些都来自亲身经历和他人使用的结果。

7. 咨询者:只要我认为求助者能从应激预防法中受益,而不是让应激场合控制他们,我就愿意使用它,或它的一部分。我知道其他咨询者也曾使用过,并知道不同的求助者都能从中受益。如果你处在很强的焦虑中,并学会怎样处理所受的压力,它将发挥很大的潜力。这种过程的另一样好处就是它相当全面,它可以对付一种焦虑反应的不同方面,如手心流汗或者胃里难受,你的想法(即认为女孩子对数学迟钝或不要说太多的话等),以及想躲避的想法等。这就像去购物,一下买了很多东西——牛仔裤、衬衫和鞋

——而不是只买了衬衫。

求助者：好的，这听起来还不错，我喜欢你提到的放松疗法。

在对话8中，咨询者继续描述另一种可能的治疗方法，并解释了这种方法的内容，以及用它怎样帮助Joan克服焦虑。

8. 咨询者：还有另一种方法叫做“脱敏”，它对帮助消除人们对情境的焦虑非常适合（见第十九章）。这也是一种帮你减少对数学课焦虑的方法。

求助者：这种方法是怎样起作用的，如何减少对某些事物的敏感性？

咨询者解释了这种方法如何帮助Joan消除焦虑，并说明了这种方法的一些要点、好处和危险。

9. 咨询者：其中的原理是你不能在放松的同时又紧张焦虑。你学会如何放松后，你就想像你上数学课和在亲属面前的情况。只有放松时才想像那些情境。练习一段时间后，你在课堂上或与父母在一起时就可以讲话了，而不会像现在这样焦虑。换句话说，你摆脱了情境敏感性。这个方法主要是我们在治疗过程中一起来做，它的好处就是不需要你做大量的家庭作业。

求助者：这要花很多时间吗？

咨询者对Joan谈了一些关于时间、疗程和模式的问题。

10. 咨询者：这个过程比其他两个方法要长一点。它们已经帮很多人减少了他们对特殊场合的焦虑，如参加测验或飞行表演。当然要记住，任何变化都需要花些时间。

求助者：这听起来似乎有帮助。

咨询者将谈到关于时间因素的更多问题。

11. 咨询者：我们将一起就这个方法进行几个月的咨询工作。

求助者：这段时间我正好有自修课，反正我通常都只和我

的朋友在一起。

在对话12中，咨询者指出自己的特长，并讲到了一些文献资料的情况。

12. 咨询者：我们来一起做出决定。对于上述三种方法我是很得心应手的。而且，这三种方法被许多人证明在对付不同的恐惧焦虑症状时是非常有效的。事实上，三种方法都有一些指导手册，你可以照着它们来练习。

求助者：我想知道怎样才能决定下一步做什么。

在第13、14对话中，咨询者指出了有关求助者偏好的一些信息。

13. 咨询者：对了，如果我们回顾一下我们上面提到的这些计划，你也许就会明白，哪一个可能会最适合于你。怎么样？

求助者：好，有这么多内容，我不知道是不是还记得你提到的那些事。

14. 咨询者：我们首先谈到你可以在这里学到的放松法，然后靠你自己用放松法来控制情感和身体上的焦虑感觉。后来我们又说到了应激预防法，它包括许多不同的技巧，可以帮助你应付紧张的情况，如上数学课。第三个是脱敏法，先放松，然后想像上数学课和与父母在一起的情境。有的我们将一起进行，有的需要你自已练习，如放松法。你认为哪种方法最有用？

求助者：我认为，放松可能有帮助，既然我可以自己练习。它好象也最简单的，并不要求那么多时间。

最后，咨询者进一步解释Joan所选择的方法，也就更明确了求助者的选择。

15. 咨询者：很好，以上提到的三种方法中，放松训练可能是最简单，也最容易学会并加以使用的方法。在我们谈话之前，你就提到这种方法一两次，好像你已经仔细考虑过好

一阵了。这种方法对你似乎有吸引力，也能有帮助。如果是这样，我想可以从今天起就开始进行。

本章总结，并介绍以下各章治疗策略的内容

大多数求助者都带着各种各样的目的，并提出形形色色的复杂问题。咨询者需要有各种干预方法或治疗策略的组合，以针对求助者功能失调中的主要问题进行咨询治疗。咨询者和求助者都应积极参与制定治疗计划，并共同挑选符合求助者问题与愿望的治疗策略。整个治疗计划应该反应出求助者的性别特点和文化特征，要能充分地解决求助者的中心问题，还要尽可能考虑到所界定问题的反应性。选择好了治疗策略后，咨询者和求助者就要一起施行这些干预措施。

在以下各章中（第十二章到第二十章），我们将介绍一些认知-行为治疗方法。主要介绍这些疗法是因为我们同意Beuler和Clarkin的观点，即选择的最初治疗方法通常要以求助者的症状为主，而不是针对其内部冲突；而且也是因为这些策略已被经验证明是有效的和有作用的。但需要指出的是，认知-行为疗法，总的来说，只是在最近才考虑文化和性别等的影响，才开始注意求助者的不同身份。在以下各章中，我们都将用一部分内容来阐述，该干预策略应用于不同人群的情况。然而，Hays认为这部分内容还十分薄弱，因为“缺乏认知-行为疗法在少数民族群体中的研究”。Lum在1996年也得出结论说，直到现在，社会文化多元化的咨询实践太少了。

Brown在1994年提出对那些主流文化之外的求助者进行治疗计划的问题，其他人则对认知-行为疗法在多元文化方面的应用进行了批评。Kantrowitz和Ballou指出，认知-行为治疗方法本身并不存在对性别、角色和社会阶层等变量的敏感性。同样，Hays也指出，“认知-行为治疗法并没有排除对社会文化因素的

考虑，但因为它没有明确提到种族主义和其他形式的压迫情境，因而那些属于主流文化群体的咨询者们就很容易忽视这些因素的影响”。例如，人们常常不太注意认知-行为治疗中的文化差异。我们尽力把这些考虑都结合到第八章和第九章所提出的模式中，使读者能够在治疗过程的各阶段上始终清醒地考虑这些因素（从建立治疗同盟开始，到评估、选择和评价治疗目标、制定治疗计划、实施治疗措施，一直到测评治疗情况）。

认知-行为方法受到批评，还因为它们至少含混地维护和保护了主流社会的价值观和标准，诸如决断力、独立性、口头表达能力和个体差异（即IC-IR型世界观）。这些价值观和标准可能会反映在治疗目的、治疗方法，以及认知风格、相互作用模式和咨询者所流露的世界观中。由此产生了一些问题：第一，当求助者的问题实际上是由不公正的社会环境造成的时候，使用认知-行为疗法，会使求助者觉得受到谴责。Kantrowitz和Ballou提供了一个例子，一个女性求助者在工作的地方受到性骚扰，她的认知-行为咨询者（女）推荐她进行增强自我肯定性的训练。这些研究者指出：“虽然提高自我肯定性的技巧没有什么错误，但是只重视技巧的培养和认知结构的改变是远远不够的，因为无论是外部因素（性攻击行为和个人界限遭到破坏），还是主导的社会模式（认为妇女应该有义务自己保护自己），在这种技巧训练中都没有得到阐释和质疑”。

另外，自我肯定的性质和它连带的价值观反映了一种欧美中心论的观点。正如Hays指出的那样，“然而有些民族，如美洲土著人、拉丁美洲人、亚洲人以及阿拉伯人，都高度重视对他人的尊重，而不是自我肯定。如果这些人群的求助者在人际交往中缺乏尊重他人的品质，咨询者就应开展‘尊重训练’”。而且，让一个来自非主流文化群体的求助者更加自我肯定，会给那个人带来很大的危险。因为太有主见会与某些求助者的文化信仰不相协调。

当然，认知-行为疗法在多元文化的求助者身上仍旧很有潜力。可以使用这些方法更强调个体独特性，强调人际交往的主动性，强调对医患合作关系的投入，强调意识（而不是无意识），强调过程和具体（而不是抽象）等方面。我们同意Hays的观点，总之“多元文化认知-行为疗法应用的关键在于，要明确意识到那些久被忽略的文化因素和少数民族人群”。

学习评判

第一部分

这里我们描述了David Chan的病历和治疗计划，仔细阅读后，请找出：（1）咨询者选择的干预手段在哪些方面与求助者的价值观、世界观相冲突了；（2）咨询者建议使用的治疗类型、疗程和模式。（答案见学习评判反馈）

David Chan是一名21岁的电子工程专业学生。他第一次来咨询是因为学习问题增多，并得知自己被留级。学业上的困难在大学四年级的前三个月开始明显出现，并伴有头痛、消化不良和失眠。由于他以往是名优秀学生，所以David把学业的退步归咎于疾病。但是，医学检查表明没有器质上的病变。

咨询一开始，David看起来很沮丧和焦虑，他的回答很简短，有礼貌，很少主动谈到自己。他回避所有涉及他情感的话题，并且把问题只看做是教育问题。尽管没有直接表露，但David好像很怀疑咨询的价值，在谈话中需要对自己的问题做多次肯定和反馈。

几次咨询以后，咨询者辨别出了一个主要问题：David不喜欢电子工程，他感到是父母迫使他学习这个专业的。然而，没有父母的同意，他不敢改变专业。他感觉自己依赖于父母，还特别想能给他们争光，但又不敢向他们表达愤怒。使用格式塔的空椅

技术，咨询者与 David 设想他的父母就坐在对面的空椅子上，并鼓励他表达出自己的真实想法。一开始，David 觉得很困难。在咨询者的不断鼓励下，他开始讲出一些真实想法了。不幸的是，后来发现这种方法是无效的，而且 David 好像比以前更加畏缩和有负罪感了。

问题：

1. 咨询者使用的干预方法（格式塔空椅子技术）是如何与求助者的传统东方文化相冲突的？
2. 假如你是 David 的咨询者，你将会使用什么治疗类型、疗程和模式？

第二部分

本章第二个目标要求你用治疗计划样表（图11-3）给一个求助者建立一份治疗计划，要专门说明治疗的类型、疗程和模式。如果你现在有求助者，我们建议你为一个真正的求助者填写计划表。在完成后，与你的指导老师或同事再仔细讨论一下。如果你还是个学生，没有实际求助者，我们建议你使用在第八章中描述的 Joan 的个案。根据第九章中的示范对话，填写表 A ——评估部分；根据第十章中的示范对话信息，填写表 B ——治疗计划部分。完成 B 表时，只针对 Joan 的第一个问题、目标、可测量的结果和干预措施（见第十章列举的 Joan 的目标图）。答案见学习评判反馈。

参考文献

- American Psychiatric Association. (1993). Practice guidelines for major depressive disorder in adults. *American Journal of Psychiatry*, 150, 1-26.
- Antonuccio, D. O., Danton, W. G., & Denelsky, G. Y. (1995). Psychotherapy versus medication for depression: Chal-

- lenging the conventional wisdom with data. *Professional Psychology*, 26, 574–585.
- Axelson, J. A. (1993). *Counseling and development in a multicultural society*, (2nd ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
- Barlow, D. H. (Ed.). (1994). *Clinical handbook of psychological disorders* (2nd ed.). New York: Guilford.
- Beutler, L., & Clarkin, J. (1990). *Systematic treatment selection*. New York: Brunner/Mazel.
- Brown, L. S. (1994). *Subversive dialogues: Theory in feminist therapy*. New York: Basic Books.
- Caspar, F. (1995). *Plan analysis: Toward optimizing psychotherapy*. Seattle, WA: Hogrefe & Huber.
- Chambless, D. (1993). *Division 12 of APA Task Force on Promotion and Dissemination of Psychological Procedures*. Unpublished report, American University, Washington, DC.
- Clinton, J., McCormick, K., & Besteman, J. (1994). Enhancing clinical practice: The role of practice guidelines. *American Psychologist*, 49, 30–33.
- Elkin, I., Shea, M., Watkins, J., Imber, S., Stosky, S., Collins, J., Glass, D., Pilkonis, P., Leber, W., Docherty, J., Fiester, S., & Parloff, M. (1989). National Institute of Mental Health Treatment of Depression Collaborative Research Program. *Archives of General Psychiatry*, 46, 971–982.
- Field, M. J., & Lohr, K. N. (Eds.). (1992). *Guidelines for clinical practice: From development to use*. Washington, DC: National Academy Press.
- Hackney, H., & Cormier, L. S. (1996). *The professional counselor* (3rd ed.). Boston: Allyn & Bacon.
- Hanna, F. J., & Ritchie, M. H. (1995). Seeking the active ingredients of psychotherapeutic change: Within and outside the context of therapy. *Professional Psychology*, 26, 176–183.

- Hays, P. A. (1995). Multicultural applications of cognitive-behavior therapy. *Professional Psychology: Research and Practice*, 26, 309–315.
- Hollon, S. (1996). The efficacy and effectiveness of psychotherapy relative to medications. *American Psychologist*, 51, 1025–1030.
- Inglehart, A. P., & Becerra, R. M. (1995). *Social services and the ethnic community*. Needham Hts, MA: Allyn & Bacon.
- Kantrowitz, R. E., & Ballou, M. (1992). A feminist critique of cognitive-behavioral therapy. In L. S. Brown & M. Ballou (Eds.), *Personality and psychopathology: Feminist reappraisals*. (pp. 70–87). New York: Guilford.
- Lazarus, A. A. (1989). *The practice of multimodal therapy*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Logan, M. L., Freeman, E. M., & McRoy, R. G. (1990). *Social work practice with Black families*. New York: Longman.
- Meyer, R. G. & Deitsch, S. (1996). *The clinicians handbook: Integrated diagnostics, assessment, and intervention in adult and adolescent psychopathology*. (4th ed.). Boston, MA: Allyn/Bacon.
- Miller, N., & Magruder, K. (Eds.). (in press). *The cost-effectiveness of psychotherapy: A guide for practitioners, researchers, and policy-makers*. New York: Wiley.
- Miranda, J. (Ed.). (1993). Understanding diversity: Special edition, *The Behavior Therapist*, 16 (9), 226–241.
- Pinsof, W., & Wynne, L. (Eds.). (1995). Family therapy effectiveness: Current research and theory. Special issue, *Journal of Marital and Family Therapy*, 21 (4).
- Reid, W. H. (1995). *Treatment of the DSM-IV psychiatric disorders*. New York: Brunner/Mazel.
- Rosado, J. W., & Elias, M. J. (1993). Ecological and psychocultural mediators in the delivery of service for

- urban, culturally diverse Hispanic clients. *Professional Psychology*, 23, 450–459.
- Sanderson, W. C., & Woody, S. (Eds.). (1995). *Manuals for empirically validated treatments: A project of the Division 12 APA's psychological interventions*. Unpublished manuscript, Albert Einstein College of Medicine, New York.
- Santiago-Rivera, A. (1995). Developing a culturally sensitive treatment modality for bilingual Spanish-speaking clients. *Journal of Counseling and Development*, 74, 12–17.
- Seligman, M. (1994). *What you can change and what you can't*. New York: Knopf.
- Seligman, M. (1995). The effectiveness of psychotherapy: The Consumer Reports study. *American Psychologist*, 50, 965–974.
- Smith, K. J., Subich, L. M., & Kalodner, C. (1995). The transtheoretical model's stages and processes of change and their relation to premature termination. *Journal of Counseling Psychology*, 45, 34–39.
- Sobell, L., Toneatto, T., & Sobell, M. (1994). Behavioral assessment and treatment planning for alcohol, tobacco, and other drug problems. *Behavior Therapy*, 25, 533–580.
- Steenbarger, B. (1993). A multicultural model of counseling: Bridging brevity and diversity. *Journal of Counseling and Development*, 72, 8–15.
- Steketee, G. (1994). Behavioral assessment and treatment planning with obsessive-compulsive disorder. *Behavior Therapy*, 25, 613–634.
- Thompson, C. L., & Rudolph, L. B. (1996). *Counseling children* (4th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
- Treviño, J. G. (1996). Worldview and change in cross-cultural counseling. *The Counseling Psychologist*, 24, 198–215.

VandenBos, G. R. (Ed.). (1996). Outcome assessment of psychotherapy (Special issue.). *American Psychologist*, 51 (10).

学习评判反馈

第一部分

1. 医生使用一种格式塔空椅子技术来治疗。这种方法鼓励 David 对父母表达自己的感受；而东方的传统价值观要求尊敬长者（父母），即使当你不同意他们的观点时，也要控制自己不和他们争吵。这种方法与文化价值观相抵触。
2. 作为 David 的咨询者，首先要弄清楚 David 对咨询的期望，这是非常重要的，因为这可能和你的想法不一样。David 可能看重那些直接而含有具体建议的治疗方法。选择一种珍视或尊重传统亚洲文化价值观的治疗类型也很重要，因为这种价值观包括控制感情、不要与陌生人公开讨论问题、崇尚集体/家庭责任感。只看重认知-行为方法，而不重视情感的干预方法，面对 David 的文化信仰咨询者将会遇到更大的阻力。如果注意到这一点，疗程有可能缩短。对他进行个体自我肯定和表露情感的干预方法也不怎么有用，因为这和他的世界观产生了冲突。尊重和承认二元文化的矛盾也很重要，David 正在考虑是按照他父母的意愿当一名工程师，还是实现他自己的价值观和爱好。由于矛盾的性质和东方价值观中家庭的重要性，家庭咨询作为一种治疗模式，也许要比个体咨询效果好。然而，在同格式塔一家的接触过程中，一定不要强迫自我流露，要尊重家庭等级，尽量找到一种双方都能接受的解决办法。

第二部分

假如你使用 Joan 的个案，根据下列表格核对一下你的回答。

心理健康档案：门诊求助者治疗报告 报告人：_____（你的姓名）

求助者姓名： Joan 出生日期：_____ 年龄： 16 性别： 男 ☐ 女 ☒

A. 评估

1. 当前问题（求助者方面）：不喜欢上学，尤其数学，对竞争感到焦虑，害怕社会，留级、选课，感到来自父母要求好成绩和上大学的压力，不敢说话，认为自己缺乏主见。

2. 咨询的原由（为什么现在请求帮助？）：学校表现很差，尤其数学方面，开始疏远父母。

3. 相关的医疗史（用药史、成瘾史、疾病史、外伤史、手术史等）：无。

4. 以前的精神及心理状况和治疗：无。

5. 其他（职业／学校，人际关系／性关系，社会／法律等）：这个学期以前学业表现尚可，独生女，父母替她做决定，有不少朋友。

6. 简明的精神状况（画勾）：

外表／衣饰	智力	判断力	幻觉／幻想	思维混乱	近期记忆	远期记忆
☒ 适当	☒ 高	☒ 良好	☐ 没有	☐ 没有	☐ 完整	☐ 完整
☐ 不适当	☐ 中	☐ 缺失	☐ 有	☐ 有	☐ 缺失	☐ 缺失
☐ 没有评估	☐ 低	☐ 没有评估	☒ 没有评估	☒ 没有评估	☒ 没有评估	☒ 没有评估

7. 情绪／情感（描述）：焦虑，有点强迫表现。

8. 自杀评估（危险、前期、计划）：_____

他杀估计（受害者、暴力、计划）：_____

9. 临床诊断（症状，包括力量／来源、治疗的困难／隐藏的情况）

请简要说明：最近的问题给她一个机会来对她父母表现得更坚决，并借助她自己的身体和能力解决“危机”。

10. 代号 DSM-IV Axis II: V71.09 诊断印象：DSM-IV Axis I: V62.3

313.82

B. 治疗计划

1. 集中的、有的放矢的行为和可测量的目标（优先的），特别要说明目前的问题（分行写明）。

2. 治疗类型：认知 / 行为疗法

3. 疗程：开始治疗的日期：1997.2.21

预期治疗次数：13 次

预计治疗结束时间：1997.6.8

4. 治疗模式 个体 配偶 家庭 个体或家庭 药物 群体 其他（ ）
 （结合） （如果有条件）

问 题	预期目标	测量标准	干预措施
1. 没有主见的焦虑	每周至少 4 次主动应对	1. 在 5 级目标获得 尺度上至少得 1 分	放松 应激预防 系统脱敏
2. _____		2. 百分制 SUDS 量表 表中焦虑由 20 分 减到 50 分	
3. _____			

咨询者签名和电话：_____ 执照号码：_____ 日期：_____

求助者评语：

第十二章 符号模型与参与者模型

想像下面的系列事件：一个女孩被问到长大后想干什么，她回答说，“像妈妈一样，当个医生”；一个男孩看完电视中的警匪片后，用玩具枪指着说，“砰，砰，你死了”；人们在看完杂志上的“户外、休闲或运动装”的广告后，一下涌向商店去购买。设想有这样一条电视新闻：在大约30秒钟内，几个青年打碎玻璃窗，闯进商店，盗走他们可以搬走的一切。这件事在电视上报道几天后，类似的青少年抢劫案却呈上升的趋势。假设一个人小时候父母表现出不良行为，他长大后也表现出类似的不良行为。所有这些事件都是模仿、重复、效颦、替代学习、认同、观察、示范学习过程的例子。Rosenthal 和 Steffek 将示范学习定义为“一种过程，在这种过程中信息（通常没有言语信息的传递）引导着观察者，将其行为由随机的尝试与错误转向有目的的反应。有目的的行为是指，许多学习练习活动是在头脑中产生的，通过信息加工、决策和评价等内部活动，才导致外显的行为”。

示范学习有几种方式：可以通过活的榜样，也可以通过符号的示范，来学会新的行为。示范可以帮助一个人以更适当的方式或更合乎需要的次数表现出已掌握的行为。示范也可以祛除求助者的恐惧感。示范学习方法有多种用途，它可以帮助人们学会做父母，来照看孩子改正不良行为；帮助人们降低恐惧、焦虑和应激反应；还可以用于减少体重、戒烟，以及改变自我观念等等。示范学习方法也被用于健康保健系统，进行预防和行为医学治疗。

Matson 将示范学习、模仿和观察学习进行了区分。示范学习包括了其他两种学习。模仿是先观察，然后做出行为或反应；观察学习则是观察别人，但并不一定要做出行为和反应。而示范者

的作用在于为观察者的思想、信念、情感和行动提供了刺激。

Rosenthal和Steffek提出：“为实现所期望的结果，只掌握某种技能是不够的。人们必须获得足够的自我效能感（信心），相信自己在面对压力、危险和疑虑时能够做出需要的行为，遇到困难时也能坚持做下去”（见第二十章对自我效能的讨论）。他们还强调，要用积极的应对自语来替换、重构脆弱和消极的想法（见第十五章），并用其他的认知策略来坚持做必要的行为。逐步、分级地掌握目标行为，能够增强信心，从而获得自我效能感。同时，自我效能的增强反过来会引导和加强行为的改变。

本章主要介绍符号示范和参与示范学习模型，第十三章将谈到内隐模仿法，第十四章则描述认知示范法（见表12-1）。表12-2则列举了一些关于符号示范和参与示范学习模型的最新研究领域。符号示范法已运用于艾滋病预防、利他主义行为、愤怒和进攻行为、性别定势的矫正及外科手术等方面。而参与示范法也被应用于焦虑、恐惧、吸毒、儿童性虐待、口吃、外科手术、言语攻击行为及女子防身术等方面。

表 12-1 模型的类型

观察类型

符号示范法	电影、录音带、著作或动画片中提到的模仿行为
内隐示范法	人们想像别人或自己而进行的行为模仿（第十三章）
认知示范法	大声或自言自语模仿自己需求的想法（第十四章）

参与者模型

活泼地模仿已知的行为和通过一系列行为表演引导求助者。

表 12-2 象征性和参与者模型研究领域举例

符号示范学习法	
艾滋病预防	性别定势矫正
利他主义行为	伙伴咨询训练
愤怒和攻击行为	外科手术
参与示范学习法	
焦虑	儿童性虐待
担心	口吃
恐惧	外科手术
自我注射吸毒	言语攻击行为
	妇女防身术

本章目标

1. 编写出一份能用于真实案例的符号示范法的剧本。并利用本章结尾的符号示范法检测清单评估这个剧本。
2. 针对模拟案例，描述如何应用参与者模型的四个组成部分。
3. 至少演示出 17 步参与者模型中的 14 个步骤。

符号示范学习法

在符号示范学习中，示范是通过书面材料、音像磁带、电影或幻灯片等形式呈现的。符号示范学习可用于个体，也可用于群体。可用卡通人物将决策技能教给孩子，这些人物可以编在教材或录影带中。建立标准化示范学习的成本效益更好，因为它可用于更多的求助者。例如，学校咨询者为了训练学生掌握寻找信息的技能，可制作一个磁带供这些学生使用。

我们现在提供一些编制自我引导符号示范学习过程的方法。

自我引导学习过程包括目标行为的展示、求助者进行练习的机会,以及反馈信息。咨询者在编制过程中必须考虑以下因素:求助者的特征,示范的目标行为,使用的媒体,故事的内容,对示范作用的现场试验。在本章结尾处的符号示范法检测清单总结了以上五个步骤。

求助者的特征

编制符号示范学习教材时首先要考虑求助者的特征,如年龄、性别、文化、民族,以及问题行为的性质。例如,为了确定问题,Sarason和Sarason采用会谈法来评估成就感低的高中生需要什么样的社会技能。他们会见了老师、学校咨询者、在校生、退学生及退学生目前的雇佣者等。

示范人物的特性应类似于求助者的特征。咨询者应考虑到示范者与求助者特征上可能的差异程度。设置多个示范人物会使示范学习过程适合于更多的求助者。例如,在Sarason和Sarason的中学生示范人物中,包括了多个民族的代表。

在一些场合下,参与过咨询的求助者也可在录音和录像带中充当示范人物。Reeder和Kunce(1976)雇佣了一个已经戒毒的护士和一个在戒毒治疗过程中取得不错效果的住院求助者作为示范人物,编进了他们6集的故事剧本中。在每集故事中示范人物都要表现出明确的应对态度,同时展现出为达到戒毒目的而需要掌握的各种技能。例如下面的情节:

示范人物开始很悲观,面对问题无能为力。然后他开始思考这个问题,并同伙伴或者咨询者进行讨论。之后,示范人物尝试新的问题解决方法。随着情节的发展,示范人物逐步地能够独立解决问题,而很少依赖他人的劝告了。

示范的目标行为

目标行为应当很具体。咨询者可编制一系列示范学习活动,针对不同的具体行为,或者将复杂的行为模式分解为较为简单的技能。比如,Reeder和Kunce为以下六个具体问题领域编制了录影故事:接受他人的帮助,在街上行走的技能,应聘面试,主雇关系,自由时间支配,新生活的适应方式。Craigie和Ross为了实施治疗前培训计划,雇用了演员表现适当和不适当的目标行为,以便鼓励酒精中毒求助者前来进行自我治疗。Webster-Stratton用录像带介绍母亲的养育行为,示范母亲表现出的适当的养育行为(关怀、愉悦),以及不适当的养育行为(刻板、抑制)。Sarason和Sarason使用示范法在下列社会情境中展现社会和认知技能:应聘面试,抵制同伴压力,在学校里求助,课堂提问,和上司相处,应付工作挫折,逃课,在工作中求助,与父母亲相处。

是编制一个示范故事还是系列故事取决于下面的三个问题:要取得什么样的目标行为?这些行为或活动是否应当分解为系列动作或简单技能?怎样安排系列动作和技能?

媒 体

我们在本书中采用了书面示范法(如对话示范、学习练习活动、学习反馈等),以帮助读者学习咨询技能。这些示范都可以拍成电影、录像或通过幻灯进行介绍。媒体的选择依赖于在何处、对何人及怎样使用示范学习法。符号示范法可用于单个求助者,也可用于学校、组织机构或家中。录音磁带是最经济、使用范围最广的媒体。但在一些场合,录音带不是最有效的,因为它们不够形象。书面形式的示范学习就像是一种读书治疗法,通过描述相似的人物和情境来帮助求助者。然而,自我引导的书面示范学习有别于传统的读书治疗,它还增加了自我指导练习和反馈

等内容。换言之，没有咨询者，求助者也可以实施自我引导示范学习。

故事的内容

不论使用什么类型的媒体，咨询者都要编写故事剧本来反映示范表演的内容。剧本应包括五个部分：指导语，示范表演，练习，反馈和总结。

指导语 每个行为和动作都要有指导语。表演前的简短、清楚的指导语会使求助者了解示范人物表演的主要内容。它还要介绍示范学习法的原理，并指出需要特别注意的线索。它还可以描述示范人物的特点，如指出“你将要看到或听到的那个示范者与你很相似”。

示范 剧本的下一个内容是具体行为和活动，以及示范人物在做目标行为时可能进行的对话。按照计划的顺序，这部分可以展示出复杂的行为模式。

练习 如果在示范演示后求助者有机会加以练习，那么示范学习的效果会更大。符号示范学习应为求助者提供机会，让他们能够练习刚刚读到、看到、听到的示范人物行为。

反馈 求助者练习足够的时间以后，应为他们提供反馈。反馈应以描述行为或活动的方式进行。若反馈指出不足之处，应给求助者提供重复练习的机会。

总结 结束某个情节或整个学习时，应进行一下总结，包括演示的目标行为以及它对求助者学习这些行为的重要性。

现场试验

当你编写完剧本之后，最好是先做一下试验。可以让同事或目标人群中的一些人当场考察这个剧本。应检查剧本的语言、顺序、人物的示范、训练时间和结果反馈。如果可能，还要在最初

的示范学习中进行试验。可以用试验结果数据来对剧本进行必要的修改。

参与示范学习法

参与示范学习法包括示范表演、有指导的练习和体验成功三个部分。它假定，求助者成功地完成某种任务是促进其行为改变的有效手段。通过成功地完成原来觉得很困难和惧怕的行为，求助者就能维持该行为的长久改变。参与示范学习法可用来减少逃避行为、恐惧行为及其相关的情感。例如，患有恐高症的户外油漆工通过参与示范学习，直接应对在高处的焦虑情绪，从而可以逐渐地爬上“令人恐怖”的高度。

它还可以应用于有行为缺陷的人，或训练社交技能、自信心、管教孩子及健美锻炼等。在学校或社会机构中，这些技能可作为预防措施来进行训练。例如，通过参与示范学习，家长可以练习各种与孩子打交道的有效教育技能。

参与示范学习法有四个组成部分：基本原理，示范表演，指导参与和成功体验。不论是用于减少恐惧的回避行为，还是提高某种行为技能，这些组成部分实质上都是一样的。你可以从本章结尾处的会谈检测清单中看到，每一个组成部分还可分为若干个小部分。在描述每个组成部分时，都提供了假设的咨询者与求助者的对话，以解释如何进行参与示范学习法，并附有学习练习活动。

学习练习活动 37 / 符号示范学习法

求助者是一个青年女性。她母亲是菲律宾人，父亲是墨西哥人，双亲都移居美国。她正申请在当地一家儿童照顾中心工作，因而对学习如何照顾孩子的技能颇感兴趣。她是独生女，没有兄弟

姐妹，也没有照顾婴儿的经验。

1. 描述你要选择的示范人物类型，要考虑到年龄、性别、种族、应对或控制技能等。
 2. 编写一份用于录音磁带示范的故事剧本，要包括：使用指导语，示范人物的说明，进行练习的简单范例，练习的反馈，以及情节总结等。
-

治疗的基本原理

下面是咨询者讲述参与示范学习法基本原理的例子：

这个方法已帮助许多人克服了恐惧或者获得了新的行为（基本原理）。在这个方法中，我们要做三件事：首先，你将会看到示范者在进行表演……（某种行为）；其次，你要在我的帮助下进行该行为的练习；然后我会安排你在咨询以外的情境中练习该行为。这些练习会帮助你完成现在觉得难以完成的事情（概述）。你愿意现在尝试一下这个方法吗？（询问求助者）

示范表演

参与示范学习法包括五个示范部分：

1. 可将目标行为（若复杂的话）分为一系列次任务或次技能；
2. 将次技能排列成等级；
3. 选择示范人物；
4. 示范表演前向求助者进行指示说明；
5. 示范人物表演每一个次任务，并在需要的情况下多次反复表演该项次任务。

学习活动反馈 37 / 符号示范学习法

1. 要记住这个求助者带有双种族、双文化特性。你应当选择年轻女性作为示范人物，最理想的是菲律宾人，或至少是亚裔美国妇女或墨西哥妇女。示范的应对技能应与求助者的实际需求相关联，即儿童照顾技能。使用的示范人物应具有儿童养育经验。

分解目标行为 在咨询者或其他人示范目标行为之前，要首先判断该行为是否应划分为次行为。复杂行为要分为次技能或次任务，并按小步骤原则将它们排列成次任务等级。按难易顺序排列的次任务等级，应保证使求助者能够进行最容易的次任务。这一点是参与者模型策略中的一个重要步骤，因为咨询者要让求助者在进行目标行为中不断体验到成功。所以，开始的任务一定要是求助者能够做到的事情。

例如，对于患恐高症的房屋油漆工来说，最终要达到的目标行为是，能够在离地面30英尺的高度从事房屋油漆工作。这一行为可分成在不同高度进行油漆的次任务，每一次任务可使高度升高几英尺。

排列次技能(任务)等级 次任务等级中的第一个任务是难度最小或危险性最低的，其他等级任务的复杂性和危险性不断增加。通常，要从等级中的第一个任务开始工作。要让求助者成功地完成每一个低等级任务后，才可练习其他等级的次任务。对于一个不自信的求助者，练习下面的任务等级可能更有帮助：先让他练习目光的直接对视，再练习在言语交流中发现错误，然后练习发现潜在反应，最后再同时完成上述所有行为。

在恐惧症病历中，每部分的内容及安排可以是一系列恐惧活

动或引起恐怖的物体。首先从最小威胁或最小恐惧的情况开始工作。针对患恐高症的房屋油漆工，我们应从最小高度的高空作业开始练习，然后逐渐提高高度。

选择示范人物 在进行示范表演前，应选择适当的示范人物。有时，治疗者本身就是最有效的示范人物。但正如本章前面所说的，采用多个与求助者接近的示范人物会取得更好的治疗效果。例如，某些恐惧症治疗诊所使用参与示范学习法时，通过起用几个以前患有恐惧症的求助者作为示范人物，已成功地消除了求助者的恐惧。

示范表演前向求助者进行指示说明 在示范表演进行之前，为了把求助者的注意集中在示范人物身上，咨询者应向求助者说明示范的内容。要指导他们注意，示范人物在进行某种行为时，并没有体验任何负面的后果。对于那个不自信的求助者，咨询者可以说：“注意，当示范人物拒绝为你打印文件时，他直接瞧着你的方式。”而对那个房屋油漆工，咨询者可以说：“要去观察示范者如何在五尺高的脚手架上自由自在地进行活动。”

示范表演 在参与者模型中，示范人物要一次表演一个次任务。通常反复示范同一个任务是必要的，可以安排一个示范人物进行多次重复，也可让多个示范人物依次表演同一个任务。例如，一个示范人物表演在脚手架上来回走动，而不会掉下来；或者多个示范人物在脚手架上做同样的活动。当有多个示范人物可利用时，就要这样去利用，因为多个示范人物的表演可增加完成任务的多样性和可信性。对于双种族或双文化的求助者来说，采用多个示范人物显得特别重要。

指导参与

示范行为和活动之后，要给求助者机会让他们在必要的指导下进行目标行为。指导参与是最重要的一环，它可以帮助求助者

学会应付，减少恐惧，获得新行为。求助者必须在进行目标行为时有成功感。在咨询过程中求助者的参与应没有任何危险。

指导参与过程包括下列五个步骤：

1. 在咨询者的帮助下，求助者进行练习；
2. 咨询者提供反馈；
3. 使用各种引导手段帮助最初的练习活动；
4. 引导手段逐渐撤除；
5. 求助者自我引导练习。

求助者进行练习 要求求助者练习刚才示范的行为，练习活动应按照先后顺序进行。在完全熟练和自信地掌握了第一级的反应之后，求助者才可以练习下一个反应。对某些求助者来说，可能需要将行为或活动进一步分解。在这种情况下，只需对整体行为的练习进行指导就足够了，无须对每个分解动作都进行指导。

咨询者提供反馈 在每一次练习后，咨询者要向求助者提出关于练习活动的口头反馈。反馈有两部分：（1）赞成或鼓励成功；（2）修改调整错误。如对油漆工，咨询者可以说：“在这一高度，你看起来很自在，你能从容地上下梯子。甚至往下看对你来说都没有任何麻烦，那真是太好了。”

使用引导手段 引导手段是咨询者用来帮助求助者进行恐惧和困难行为的辅助方法。许多人把成功的表演当做是减少焦虑的一种好方法。但直接让他们参加某项恐惧的活动，大部分人会干脆不来参加。例如，你会害怕像捉蛇、驾驶飞机、开船、登山等活动吗？如果是的话，假如现在就让你去做，你会非常不愿意的。但假设你看着我们拿着蛇；然后我们拿着蛇，你摸摸它；然后我们攥住蛇的头和尾，你拿它的中间部分；再后，我们攥头，你攥尾，等等，你可能就愿意做了。条件是要有一些支持人员在场。

咨询中可以使用引导手段，在一些接近自然情境的练习场景中也可以运用引导手段。可能的话，咨询者或示范人物可陪同求

助者进入“现场”，并观看进一步的示范表演。咨询者还可以引导求助者进行内隐式的练习，而不仅仅是外显行为练习。总之，咨询者要做好为求助者提供帮助和支持的准备。

撤消引导手段 要逐步撤消引导手段。对那些不自信的求助者，若开始时的辅助手段有四种，那就要逐步减为三种、两种、一种。这是从咨询者指导练习到求助者自我引导练习的过渡阶段。

求助者自我引导练习 不需要任何指导和辅助手段的求助者，就可以进行自我引导练习。自我引导练习可强化求助者的信心和自我评价，从而改善行为的功能。理想的情况是，求助者要在咨询中和自然环境中都进行过自我引导练习。它比咨询者指导下的练习效果要好。

除了参与示范学习法外，帮助求助者将训练中获得的行为迁移到实际生活中亦是整个咨询的任务。目标行为的泛化可通过成功感和强化体验来达到。

成功体验或强化体验

参与示范学习法的最后一个部分是成功（或强化）体验。求助者必须对所学习的行为体验到成功感。Bandura指出，“除非行为改变在日常生活中被证明是有效的，否则它们就难以持续”。要针对每个求助者的情况安排成功的体验。应先将新学会的技能安排在容易成功的条件下进行练习，然后再逐步扩大范围，直到原先令人恐惧、困惑的自然情境。

训练迁移过程有如下几个步骤：

1. 咨询者和求助者首先找出一些情境，以便让求助者在其中练习目标行为；
2. 将这些情境排序，从简单、安全、容易成功的情境排到最具风险的情境；
3. 咨询者陪同求助者进入这些情境，进行示范表演和指导练

习，然后逐步撤消指导；

4. 让求助者以自我引导的方式练习各种任务行为。

Bandura 结论说，参与示范学习法的一个优点是“大量健康人”（如同伴、康复的求助者等）都能成为咨询治疗的示范者，它能够帮助求助者在一种“真实生活条件”下学会新的行为反应，从而使学习的迁移问题变得容易了。

社会示范学习法的多元文化应用

示范学习法在多元文化中的应用，主要是在药物滥用和预防等领域（见表 12-3）。Botvin、Baker、Botvin 和 Dusenbury 在一项纵向研究（以 233 名黑人高中学生为研究对象）中，考察了抽烟行为的发生和持续现象。他们发现，社会示范作用（朋友的吸烟行为）是导致吸烟行为产生的最重要的早期因素，而吸烟行为的社会常模和吸烟者本身的素质，则在维持吸烟行为上有重要作用。

使用的示范人物如果在文化上与求助者相似，那么它们的作用就具有更大价值。在对化学物质依赖的男女同性恋者进行群体治疗和艾滋病预防教育中，上述结论都得到了证实在对一组非裔美国妇女进行咨询时使用了文化相似的示范者，结果增加了她们对乳房进行自行检查的信心和意愿。

表 12-3 社会示范学习法的多元文化研究领域举例

无烟烟草使用习惯	药物滥用的预防
艾滋病及化学物质依赖	家长示范作用
儿童亲社会行为	儿童技能训练
家庭暴力	儿童安全
焦虑降低	疼痛
乳房自我检查	

家长的示范作用在许多方面都是重要的。Hurd、Moore 和 Rogers 在一篇考察 53 位非裔美国家长的作用时发现, 家长的正面示范作用和家长的投入与支持, 对于将价值观和行为传递给自己的子女起着重要的作用。当然, Reyes、Routh、Jean-Gilles 和 Sanfilippo 也注意到家长的示范作用在不同的种族之间存在着差异, 故而他们提醒咨询者, 在使用示范学习法时, 要关注不同种族的历史和文化发展趋势。

多元文化使用示范法的原则

对不同民族的求助者使用社会示范学习法时, 要注意下列原则:

1. 确认治疗中所使用的真人示范者或符号的示范人物要与求助者的文化背景相适应。
2. 确认示范行为的内容要与求助者的文化相关联, 而不只是反映出咨询者欧美中心主义的价值观。
3. 要记住, 人们在对示范人物的关注点、从他们那里学习的结果, 以及利用示范作用等方面都存在着文化差异。

Malgady 等人在对波多黎哥儿童和青少年使用文化敏感的示范人物时, 发现其治疗效果存在着复杂模式。求助者的认知反应和他们的家庭结构对治疗效果都有影响。

参与示范学习法的对话范例

我们仍以 Joan 为治疗对象。咨询者用参与示范学习法帮助 Joan 掌握她曾极力避免数学课的行为。

第一次会谈

在对话 1 中, 咨询者为 Joan 讲述这种策略的基本原理, 并简单描述其过程。

1. 咨询者: 这个治疗过程对那些在课堂参与上有困难的人是有帮助的。我们将逐一解决你在数学课上的问题, 我本人或者你的同学会表演在课上的行为, 然后你再进行练习。首先我们在这里进行练习, 然后你再在其他课上练习, 最后才是数学课。你认为如何?

求助者: 可以。这就是要我做本来可以做到, 但因为紧张而无法去做的事情。

咨询者将重提Joan过去的反应, 并用它进一步解释参与示范学习法的基本原理。

2. 咨询者: 紧张会妨碍你想做的事。这个方法将帮助你用小步骤学会如何去做。当你完成每一个步骤后, 你就会增强信心, 减少紧张。

求助者: 我想那肯定会有帮助。只是有时我不相信自己。

在对话3中, 咨询者开始示范, 并回顾Joan想要在数学课上掌握的主动发言技能。

3. 咨询者: 你知道, 上周我们找到一些行为方式可以帮助改进你在数学课上的参与行为, 并将它们进行了排序, 从你认为最简单的行为到最困难的行为。你还能记得这个顺序吗?

求助者: 当然。我想是这样安排的: 回答问题, 到黑板前解题, 自愿回答问题, 然后是主动发表意见。

咨询者问求助者是否需要增加活动或是否需要重新安排等级顺序。

4. 咨询者: 经过一周的考虑, 你有没有想出其他的参与方式, 或者你希望将行为方式的顺序重新安排?

求助者: 有一件事。在我向老师请求帮助后, 我愿意自己独立解决这个问题。但通常他都会替我解答这个问题。

在对话5中, 咨询者将为Joan编制一个可能的模型, 并希望

她提出想法。

5. 咨询者：好，我们现在必须做的一件事就是，考虑由谁来做示范，并帮助进行这些课堂行为。我可以做示范，但你可以找个在数学课上做的不错的同学来做。以后他可以在数学课上帮助你。你认为如何？

求助者：有必要让某人陪我上数学课吗？

咨询者抓住Joan对自己出现在数学课上的不安，建议用另一个同学做示范人物。

6. 咨询者：我想如果进行示范的人是你的同学而不是我，你会感到舒服些的。如果你能选一个积极参与数学课的人，我想和他谈谈，以便让他／她在我们下次会面时来帮助你。因此，好好考虑一个你喜欢、尊重并感到愉快的同学。

求助者：选Debbie吧。她是我的朋友。她对回答老师的问题或到黑板上答题没有任何犹豫。我可以请她，她乐于帮助我。她也能独立思考数学问题。

咨询者进一步讲解选用Joan的朋友做示范人物的原理，以使Joan了解她的同学将怎样参与咨询过程。注意Joan对此的反应有些犹豫；如果Joan对此感到不自在，就要选择别人。

7. 咨询者：可以叫她，若她同意，请她到我办公室来一下。如果不行的话，我们会考虑其他人选。若Debbie想做，我会培训她表演一些数学课上的行为。在我们下次见面时，她就可以进行示范了。你觉得怎样？

求助者：可以，那可能很有趣。以前我在英语作文上帮助过她，所以她可能会帮助我。

在接下来的对话中，咨询者鼓励求助者与这个朋友进行相互帮助。

8. 咨询者：那是个好主意。好朋友应互相帮助。在你和Debbie交谈以后，让我知道结果。

第一次会谈后，Joan 顺便来访，证实了 Debbie 很愿意与他们合作。咨询者与 Debbie 见了面，向她说明了她的角色。特别要求 Debbie 表演 Joan 想掌握的四种数学课参与行为。同时，咨询者还告诉 Debbie 在指导参与阶段如何帮助 Joan。Debbie 进行了练习，并在练习中尝试使用多种引导辅助手段，如联合练习、口头指导、逐步扩大时间间隔和增加任务难度等。还让 Debbie 了解自我引导练习的过程，以及如何让 Joan 体验成功。当 Debbie 对自己在治疗过程中的角色感到自在时，咨询者就可以安排与 Joan 的下一会谈了。

学习练习活动 38 / 参与示范学习法

这个活动是为你自己设计的，用来完成你想改变的某种行为。你需要一个伙伴来共同完成这一练习活动。

1. 选择想获得的一种技能。
2. 通过描述你做什么、想什么，以及有什么不同的感受，来界定这个技能；判断此技能是否太宽泛，是否需要划分成一系列次技能。若能，按难易程度将它们逐一安排。
3. 请你的伙伴示范这个技能（你也可以观察其他人）。
4. 在伙伴的帮助下，准备最初的练习或等级中的第一个技能。伙伴要使用至少一两种引导手段（如联合练习、口头练习）来帮助你最初的练习。随着练习尝试成功，这些引导手段将逐渐撤消。你的伙伴要在每次训练后提供反馈意见。

第二次会谈

在第一次会谈中，咨询者向 Joan 说明了在模仿表演期间应该注意哪些东西，咨询者也指出在示范情境中没有负面的结果。

1. 咨询者: Joan, 很高兴见到你。我一直在和 Debbie 合作, 她今天来这里给你做些示范。我们首先要做的是你上周提及的一件事, 即向老师求助, 但希望自己独立解决问题。Debbie 首先表演这一点。我来扮演老师的角色。Debbie 向我走来, 请求帮助。注意她告诉我她所需要进行的解释, 然后坚定地告诉我(老师), 她想要试着自己完成问题。注意 Debbie 很容易就做到了, 老师并没有不高兴。你有什么疑问吗?

求助者: 没有。我准备开始。

Debbie (示范者): 老师, 我想请您解释这个问题。我需要您再解释一遍, 以便于我能自己解答。

咨询者(老师): 可以, 嗯。答案是……

Debbie (打断): 我想自己找到答案。但我想请您解释一下这个公式。

咨询者: 行, 你要这样做……

Debbie: 这很有帮助。多谢。(走回座位)

示范后, 咨询者问 Joan 对所看到的有什么感受。

2. 咨询者: Joan, 你对刚才的示范感觉如何?

求助者: 看起来相当容易, 我想如果我真的请他帮助时, 总有一种让他帮到底的倾向。我无法肯定地告诉他, 我想自己解决问题。

咨询者抓住了 Joan 问题中的关键, 开始第二次示范。

3. 咨询者: 这是示范中重要的组成部分, 要首先能够请求帮助, 然后要能够让他知道, 你自己运用他提供的信息, 回到座位上, 自己尝试解决问题。现在让 Debbie 再做一遍, 看她如何给出信息, 使老师不必进一步提供答案。

求助者: 可以。

在对话 4 中, 咨询者问 Joan 是否可以练习。

4. 咨询者：你现在准备得怎样？

求助者：准备好了。

在第一次训练前，咨询者将引入一种辅助手段——Debbie的口头指导。

5. 咨询者：那好，现在我们让 Debbie 做你的辅助老师。例如，如果你遇到困难开始退却时，Debbie 会给你指点或提示。你看怎样？

求助者：行，那会使事情更容易些。

第一次练习开始。

6. 咨询者：我们开始吧。现在我是老师，你带着问题从座位上走过来。

求助者：老师，我不太懂这个问题。

咨询者（老师）：嗯，我把答案给你，那你做起来就没有什么问题了。

求助者：我需要的不是答案。

咨询者：那你的意思是什么呢？

Debbie（打断，进行提示）：Joan，你要说出你想自己解出答案，但你需要再解释一下这个公式。

求助者：我想自己找到答案，但需要再给我解释一次。

咨询者：行，是这样的……

求助者：好，谢谢。

Debbie：现在你完成了对话，请返回座位。

咨询者对 Joan 的练习进行评估。

7. 咨询者：你觉得练习做得怎样，Joan？

求助者：非常好。有 Debbie 在这里帮忙很好。

在下一个对话中，咨询者向 Debbie 和 Joan 做出反馈，开始另一个练习。

8. 咨询者：我想她确实帮了忙。你看起来能很好地进行对话。

在向我解释你的想法时，你的确需要帮助。一旦Debbie给你指点，你就能继续进行对话了。或许你需要再试一下这部分。

(第二次练习，Debbie提示的内容减少了。)

咨询者解释自我指导练习的原理。

9. 咨询者：看起来很顺利。我想你准备再试一下，没有任何帮助，你看怎么样？

求助者：可以。

咨询者看到Joan的肯定反应后，叫Debbie离开房间，因为Debbie的出现会使Joan有一种心理依赖。所以Debbie离开后，才能进行真正的自我引导练习。

10. 咨询者：我打算叫Debbie离开房间，以便你能完全独立地进行练习。

(自我引导练习开始)。

接下来咨询者暗示Joan对自我指导练习进行自我反馈。

11. 咨询者：Joan，你觉得这次练习怎么样？

求助者：我认识到自己有点依赖Debbie，因此我想独立完成练习。

咨询者注意到自我引导练习已经和自信建立了关联，因而开始进行成功体验练习。

12. 咨询者：对。首先，有人在那里能对你有所帮助，它帮助你树立了信心能够独自完成。从现在开始，我认为我们应该讨论你在数学课上应当怎样做了。你看怎样？

求助者：行。有点害怕，不过还好。

咨询者讲述了自己的想法，先让Debbie帮助Joan在课外进行练习。

13. 咨询者：开始觉得有些担心是很自然的。但我们可以帮助你的一件事就是再请Debbie辅导你。

求助者：好的。但怎样工作呢？

在对话 14 中，咨询者梳理了以下 Joan 在数学课上问题行为难易程度的次序。请 Debbie 在 Joan 第一次练习每一个目标行为时都提供帮助，以确保 Joan 获得成功感。

14. 咨询者：很明显，数学课是你惟一遇到困难的科目。所以，我们想要你在数学课上成功地使用这个方法。既然 Debbie 和你一起上课，开始时你可以和 Debbie 一起找老师，而不要独自去。第一次她可以向老师请求帮助。下一次你们俩一起去，你要提出请求，她可以进行提示。逐渐地你将独自实现目标。但每一次我们只采取一个步骤。

求助者：那肯定会有帮助。如果她在的话，我会感觉好很多。

15. 咨询者：对。在做任何新的事情时，开始时都要慢些，做好每一步。现在 Debbie 可以进来，我们一起计划第一个步骤。

Debbie 将做出示范，并指导 Joan 在数学课上进行目标行为。对于其他的目标行为，整个过程都要重新开始。

本章总结

本章介绍了两种示范学习策略，可用于帮助求助者获得新技能，并消除恐惧。这些示范策略通过向求助者演示目标行为来促进学习。在不同的示范策略过程中，示范人物的呈现方式略有不同，符号示范法利用各种媒体展示目标行为，而参与示范法则要进行现场表演。作为一种干预策略，示范作用不一定在所有的文化群体或亚群体中都是突出的。当示范学习适合于某个文化群体时，示范人物应当与求助者相似，其表演的内容应与求助者的文化相关联。

学习评判

第一部分

本章目标一要求你编写一个符号示范学习的故事剧本，应包括以下几个部分：

1. 示范对话实例
2. 提供练习机会
3. 反馈
4. 总结

使用后面的符号示范法检测清单作为指导。

第二部分

目标二要求你描述如何在假设的案例中应用参与模型的四个组成部分，描述如何使用这四个部分（基本原理、示范表演、指导参与、成功体验）来帮助求助者获得言语和非言语的技能。这些技能是求助者与社会接触所必须的。

第三部分

目标三要求你在角色扮演中表现出参与模型17个步骤中的14个步骤。扮演求助者的人要装做害怕的样子。你可以用下面的参与示范法会谈检测清单来进行自我评价。

符号示范法检测清单

指导语：判断你在进行符号示范学习时是否用到了下列准则。如果用到了，在相应的地方画勾。

—— 1. 确定求助者所要使用的符号模型的过程，并辨认他们的特征：

- 年龄；
- 性别；
- 种族、文化；
- 应对或控制技能。

- ____ 2. 列举所示范的目标行为。
- ____ 3. 选择媒介物（如书面剧本、录音磁带、电影、幻灯片等）。
- ____ 4. 剧本应包括下列部分：指导语、示范对话、练习、反馈和总结。
- ____ 5. 现场检验书面剧本。

参与示范法会谈检测清单

指导语：确定咨询者是否在会谈中使用了下列引导语。如果用了，在相应的地方画勾。

项目	引导语举例
I. 基本原理	
____ 1. 咨询者解释参与模型策略的基本原理。	“这个过程曾用于与你有同样问题的其他求助者。它会帮助你克服……的恐惧，或帮助你掌握这些技能。”
____ 2. 咨询者简单描述参与模型的组成部分。	“它包括三件事：我示范你要做的，你在我的帮助下练习，然后你在认为相当容易的情况下自己尝试。因此你可以成功。”
____ 3. 咨询者要求助者自愿使用策略。	“现在你愿意试一下吗？”
II. 示范表演	
____ 4. 咨询者和求助者决定是否要把目标行为划分为一系列次任务/技能。	“嗯，咱们看一看……现在你几乎走不出这房子，你说你甚至不能走到院子里。看看有没有别的不同的活动可以使你逐渐地远离房子，如走到前门，从走廊上出去，等等。”
____ 5. 假如划分目标行为（第4步），咨询者和求助者将按难易顺序分级排列这	“也许我们可以拿出清单，按顺序排列，现在从最简单的活动开始，如向门走去。逐渐增加难度安排每一活动。”

些次技能。

——6. 咨询者和求助者决定和选择适宜的示范人物。

“我可以指导你做，也可以选择你认识的或与你相似的某个人来帮助你完成任务。你更喜欢哪一种？”

——7. 咨询者要在求助者实际观察之前，告诉他应注意哪些方面。

“注意当门铃响时，我镇定地迅速向门走去，毫不犹豫的打开。同时注意，我开门后，没有发生任何事情。”

——8. 示范要至少表演一次目标反应，若需要的话，可重复更多次的示范。

“好，让我再一次演示给你看。”

“下面我向你演示走出走廊，然后我们把这两个场景结合起来。”

III. 指导参与练习

——9. 要求助者练习目标反应。如果使用分级训练，首先练习个级中的第一技能，然后再成功地练习第二、第三技能等等。

“这次门铃响时，你试着走向门。你需要帮助时，我会帮助你的。”

——10. 每次练习后示范者或咨询者要提供肯定反馈和纠正错误反馈。

“很顺利，你能迅速走向门，当你到达时，你仍然有点犹豫。当你看见有人在那儿时就试着打开门。”

——11. 求助者每次进行技能练习时可提供一些引导手段，例如：

“在头几次练习中，我将帮助你。”

——a. 和咨询者联合练习；

“咱们一起模仿吧，我和你一起向门走去。”

——b. 咨询者给予言语或动作指

“让我给你提个建议，当你打开门时，向那个人打招呼，看他想要什么。”

导;

——c. 重复练习一种任务,直到求助者能进行下个任务;

“咱们继续试验几次,直到你感到的确很自在。”

——d. 把练习时间分成长、短等;

“这次我们增加你走向门的距离,咱们从厨房开始吧。”

——e. 为练习安排保护措施,以减少可能出现的恐惧等情况;

“我们肯定有人一起和你在房子里。”

——f. 将严重性或情况复杂性分级。

“好,我们练习打开门。此时有一个好朋友在门边。这次咱们假定站在门外的是一个你熟悉的人,但不是朋友,如送邮件的人。”

——12. 在后面的练习中,引导手段的数量逐渐减少。

“我相信你可以做到,我不用再给你那么多的指导了。”

——13. 随着训练的继续,求助者可按所有要求进行自我指导练习。

“这次我将离开。我想让你独自试试。”

IV. 成功体验(作业)

——14. 咨询者和求助者熟悉练习场景,在这种环境中,求助者要表演目标行为。

“咱们列一下练习的次数和你想做这件事的地点。”

——15. 从风险最小至风险最大分等级安排场景。

“我们可按顺序排列这些场景。首先是最简单的,然后是比较难或说威胁更大的。”

- 16. 从最简单的、风险最小的场景开始，咨询者（示范者）和求助者一起在实际生活环境中使用现场或符号示范法，直到求助者能够不依赖别人的帮助。 “从第一个场景开始。我将先帮助你，然后你要独立完成训练。”
- 17. 以自我指导方式让求助者实施一系列相关的任务。 “现在不用我的帮助，你准备进行练习。你已向我们表明你能独立完成。”
-

参考文献

- Anderson, E. A. (1987). Preoperative preparation for cardiac surgery facilitates recovery, reduces psychological distress, and reduces the incidence of acute postoperative hypertension. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 55, 513–550.
- Arnow, B. A., Taylor, C. B., Agras, W. S., & Telch, M. J. (1985). Enhancing agoraphobia treatment outcome by changing couple communication pattern. *Behavior Therapy*, 16, 452–467.
- Bhargava, S. C. (1988). Participant modeling in stuttering. *Indian Journal of Psychiatry*, 30, 91–93.
- Botvin, G., Baker, E., Botvin, E., & Dusenbury, W. (1993). Factors promoting cigarette smoking among Black youth: A causal modeling approach. *Addictive Behaviors*, 30, 397–405.
- Erasmus, U. (1992). Behavioral treatment of needle phobia. *Tijdschrift voor Psychotherapie*, 18, 335–347.
- Faust, J., Olson, R., & Rodriguez, H. (1991). Same-day surgery preparation: Reduction of pediatric patient

- arousal and distress through participating modeling. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 59, 475–478.
- Feindler, E. L., Ecton, R. B., Kingsley, D., & Dubey, D. R. (1986). Group anger-control training for institutionalized psychiatric male adolescents. *Behavior Therapy*, 17, 109–123.
- Hughes, D. (1990). Participant modeling as a classroom activity. *Teaching of Psychology*, 17, 238–240.
- Katz, P. A., & Walsh, P. V. (1991). Modification of children's gender-stereotyped behavior. *Child Development*, 62, 338–351.
- Larson, J. D. (1992). Anger and aggression management techniques through the Think First curriculum. *Journal of Offender Rehabilitation*, 18, 101–117.
- Maibach, E., & Flora, J. A. (1993). Symbolic modeling and cognitive rehearsal: Using video to promote AIDS prevention self-efficacy. Special Issue: The role of communication in health promotion. *Communication Research*, 20, 517–545.
- Mail, P. (1995). Early modeling of drinking behavior by Native American elementary school children playing drunk. *International Journal of Addictions*, 30, 1187–1197.
- Matson, J. (1985). Modeling. In A. S. Bellack & M. Hersen (Eds.), *Dictionary of behavior therapy techniques*, (pp. 150–151). New York: Pergamon Press.
- Mattick, R. P., Peters, L., & Clarke, J. C. (1989). Exposure and cognitive restructuring for social phobia. *Behavior Therapy*, 29, 3–23.
- Ozer, E. M., & Bandura, A. (1990). Mechanisms governing empowerment effects: A self-efficacy analysis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58, 472–486.
- Reyes, M., Routh, D., Jean-Gilles, M., & Sanfilippo, M.

- (1991). Ethnic differences in parenting children in fearful situations. *Journal of Pediatric Psychology*, 16, 717–726.
- Romi, S., & Teichman, M. (1995). Participant and symbolic modelling training programmes. *British Journal of Guidance and Counseling*, 23, 83–94.
- Rosenthal, T. L., & Steffek, B. D. (1991). Modeling methods. In F. H. Kanfer & A. P. Goldstein (Eds.), *Helping people change* (4th ed., pp. 70–121). New York: Pergamon Press.
- Samson, D., & Rachman, S. (1989). The effect of induced mood on fear reduction. *British Journal of Clinical Psychology*, 28, 227–238.
- Sanders, M. R., & Jones, L. (1990). Behavioural treatment of injection, dental and medical phobias in adolescents: A case study. *Behavioural Psychotherapy*, 18, 311–316.
- Vaccaro, F. J. (1990). Application of social skills training in a group of institutionalized aggressive elderly subjects. *Psychology and Aging*, 5, 369–378.
- Wurtele, S. K., Marrs, S. R., & Miller-Perrin, C. L. (1987). Practice makes perfect? The role of participant modeling in sexual abuse prevention programs. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 55, 599–602.
- Yoshimi, Y., Yonezawa, S., Sugiyama, K., & Matsui, H. (1989). The effects of the viewpoints and observers' traits on the observational learning of altruistic behavior. *Japanese Journal of Psychology*, 60, 98–104.
- Zaragoza, R. E., & Navarro-Humanes, J. F. (1988). Behavioral treatment of blood phobia: Participant modeling vs. gradual "in vivo" exposure. *Analisis y Modificacion de Conducta*, 14, 119–134.

学习评判反馈

第一部分

用符号示范法检测清单检查你自己编写的故事剧本。

第二部分

你可用下面的参与示范法来帮助求助者。

基本原理

首先，向求助者说明这个过程能帮助他获得自己所需的各种技能，促进他与其他人的社会交往。你也可以告诉他，整个过程包括示范、指导参与和成功体验。要强调这个咨询过程是基于这样一种观点，即当以小步骤来学习技能时，每成功一步就进行强化，这样学习就会产生效果。

示范表演

你和求助者一起探索他与人交往时需要的言语和非言语行为。例如：这些技能可能表现在言语请求被毫不犹豫地表达出来，语调坚定等。在描述几个组成部分后，你和求助者要将目标行为按难度顺序分级排列，并逐一进行练习。

要选择与求助者文化背景相应的示范者，并先向求助者示范目标行为等级中的第一个练习（然后是其他练习内容），也许有必要重复其中的某一个练习。

指导参与

在一种练习示范后，你请求助者进行表演。前几次可以借助于各种引导手段，如你的口头指导。每次练习后，要向他做出反馈，务必要鼓励他，肯定他的表演，并建议如何逐渐提高。一般来讲，求助者多次练习一种活动后，要逐渐减少引导手段的数目。在继续练习下一个不同的活动前，求助者要在没有你支持的情况下，以自我引导方式练习那些技能。

成功体验

你和求助者要一起熟悉他的环境。在这种环境中，他将使用学到的技能。这种情况大部分是社交场合，有一些风险；要将风险从大到小进行安排。求助者从风险最小的场合开始进行训练，直到他能自如地、成功地表演。最理想的是，咨询者和求助者一起参与。如果示范者是求助者的同事，也可以进行练习。如果不是同事，求助者可请求重新安排示范者，以便得到帮助和鼓励。

第三部分

参与者会谈检测清单来评价你的表演，或让其他人来评价你自己的表演。

第十三章 引导想像法和内隐模仿法

咨询者有时会发现，对某些求助者使用实物或符号模仿方法是不现实的，让求助者公开练习目标行为也不可能。在这些情况下，利用求助者的想像进行模仿和练习的策略或许更为可行。本章描述了两个主要依靠求助者想像的治疗方法，即引导想像法和内隐模仿法。使用这两个策略时，求助者运用视觉场景和想像进行练习。应用这两个程序需要首先假设求助者能够产生强烈的、栩栩如生的表象。但我们目前还不清楚，求助者的想像要达到什么强度，才能产生治疗效果。

情感想像、视觉想像或引导想像这些术语经常被人们混用。Merriam-Webster 大学字典（第十版）将视觉想像定义为“心理表象的形式，以视觉形象或可见形式进行解释的心理行为或过程”。心理表象或场景视觉可以是自发的，也可以被引导出来。所有的想像或表象都与情感、情绪和精神相联系。我们通过感官感受事件、人或事物，感觉又影响我们的情绪系统和知觉。一些人在开始时产生强烈而生动的表象有困难，而在治疗者的帮助下，大多数求助者都能够唤起生动的表象，能够引发出自己的想像潜力。

本章目标

1. 在所列 7 个咨询者的引导语例子中，指出引导想像法的五个步骤。要至少准确地辨别出其中的 6 个例子。
2. 演示 13 步引导想像法中的 10 个步骤，并利用本章末会谈检查清单评估自己的成绩。
3. 针对模拟求助者案例，描述你如何应用内隐模仿法的五个组成部分。

4. 至少演示出 28 步内隐模仿法中的 22 个步骤，并利用本章末的会谈检查清单评估自己的成绩。

求助者的想像：评估与训练

使用引导想像法和内隐模仿法时，重要的是先对求助者的想像或幻想潜能进行评估。在某种程度上，这两个策略的成功依赖于求助者产生生动形象的能力。一些求助者可能被想像程序搞得失去咨询的兴趣，而另一些人则很难在内心产生生动的场景。

这里介绍一个评估求助者想像强度和清晰程度的方法。首先，在应用引导想像法或内隐模仿法之前，让求助者回忆他们感兴趣的或感到轻松、高兴的新近发生的事件。告诉他们闭上眼睛，做两次深呼吸，放松一下，然后描述出愉快的事件。求助者描述完事件后，让他们自己评价事件的清晰性。用 4 表示十分清晰，3 表示中等清晰，2 表示一般清晰，1 表示不清晰，0 则表示无法分辨。然后用表 13-1 中的评定量表评估求助者想像的清晰度。60 分以上说明求助者很容易产生生动的表象。总分低于 30 分说明他们需要很多训练才会产生生动鲜明的表象。清晰度量表可以自测，也可以由咨询者宣读指导语和量表题目，然后再获取每个项目的得分。后一种评估方法很少引起干扰，因为宣读代替了求助者自己阅读，他们就不必自己去看指导语和量表条目了。

为了训练求助者产生生动的形象或心理场景，咨询者和求助者可以建立一些练习场景以帮助产生想像。例如，咨询者可以指导求助者“想像一个让你感到放松、愉快的事件，同时放松身心，并注意想像过程中所有的感觉”。让求助者注意与想像事件相关联的感觉是很有用的引导手段。咨询者可以通过下述问题为求助者提供感觉线索：“想像场景中有什么物体？”“你看到什么颜色？”“光线怎样，是明还是暗？”“温度有多高？”“嗅到什么气味？”“听到什么声音？”“口中是什么味道？”“身体感觉如何？”求助

表 13-1 想像生动性量表

想像生动

让我们进行一个简单的测试,要求你想像某个画面。如果你的想像十分清晰,评4分;如果中等清晰,评3分;有点清晰,评2分;不清晰想像评1分。如果是“十分不清楚”或“不可辨认”,则评0分。读完下述每个条目后,闭上眼睛,在心中尽可能清晰地想像它的内容,然后记下你的得分。

把所有得分加起来。如果分数是60分或更多,你就能相当容易和生动地形成想像。如果分数是30分或更少,在应用引导想像干预法之前,你要在想像方面进行更多的训练。

想一个十分亲近的亲戚或朋友

	评分
1. 看到他(她)站在你面前。	()
2. 想像她(他)笑。	()
3. 描画她(他)的眼睛。	()
4. 想像一碗水果。	()
5. 想像在一个干燥、尘土飞扬的道路上开车。	()
6. 看到你自己掷球。	()
7. 描画你童年的家。	()
8. 看到一个白色、布满沙子的海滩。	()
9. 想像正在往商店橱窗里看。	()
10. 看着空白电视屏幕。	()
11. 想像狗叫的声音。	()
12. 想像爆竹爆炸的声音。	()
13. 感到热水浴的温暖。	()
14. 感觉到粗砂纸的纹理。	()
15. 想像你自己正在提起重物。	()
16. 想像你自己走在一个陡峭的山路。	()
17. 想像柠檬汁的味道。	()
18. 想像吃冰淇淋。	()
19. 想像烧白菜的味道。	()
20. 想像你自己正在嗅一朵玫瑰花。	()

如果求助者在想像个别细节方面有困难,咨询者可训练他们进行更加细致的想像练习。如果这样做看起来太费事,求助者不愿意使用想像力或者对使用想像力不感兴趣,那么就应当改换策略,选择一种不需要想像的策略。如果求助者对想像感受良好,并能够适应想像练习,这时咨询者和求助者就要根据求助者的问题和目标行为,来决定是使用引导想像法还是内隐模仿法。

者在想像练习时得到上面的帮助后,就可以使想像过程变得自信起来。当咨询者评估求助者想像的能力或训练他们产生生动表象时,应当选择那些令人高兴、愉快的场景或事件。体验愉快的事情时,我们会更加注意自己的感觉。表13-2解释了感觉的维度以及一些感觉体验的例子。

想像法的多元文化应用

到目前为止,想像法对其他群体的应用还是相当有限的。Herring 和 Meggert曾把想像法作为咨询策略应用于美国土著儿童。Andrada 和 Korte 使用听觉、触觉、言语、视觉和味觉刺激等想像场景,来增强居住于疗养院的西班牙裔老年人的怀旧情绪。Brigham 描述了特别的想像场景,用于那些艾滋病带菌者。

对不同文化的求助者使用想像法有几条原则需要考虑。首先,不同文化的想像模式很可能是不同的。Gaines 和 Price-Williams 和 Brigham 指出,欧美人的想像模式是个人主义式的,而某些其他文化的想像模式则具有集体性。

想像场景的形式和内容与求助者的哲学和文化背景相关联,因此必须在求助者个人观和文化观的框架中去理解他的想像。例如:土著美国人可能想像以“强硬的盾牌”去驱赶坏心情并达到与自然的和谐。其他的求助者则可能选择把他们自己想像成“和平斗士”。

引导想像法

使用引导想像法时,要训练求助者在想像不愉快或引起焦虑的活动和情境的同时,把自己的注意力集中于积极的想法和表象上。注意力集中于积极、愉快的表象能够“阻断”那些让人痛苦、恐惧和焦虑的场景。可以认为情感想像法中的“阻断”是这样一个过程,它利用了人们很难同时将注意力既集中于愉快的想法,

表 13-2 增强想像生动性的各种感觉

感觉	维度	体验
视觉	颜色, 光亮, 黑暗, 场地的深度	接近, 距离, 活动, 安静, 物体, 事件, 动物, 人和自然
听觉	噪声, 声音, 方向, 频率、响度	声音的知觉: 悦耳、不愉快, 音乐, 物体、自然、人声
嗅觉	物质分子——气味, 气息、香气	吸入鼻子中的空气分子, 动物, 人, 物体, 自然, 交通, 烹调, 烟雾、潮气、污染、花的芳香, 空气
味觉	酸, 苦, 甜, 咸	使人讨厌的场景在我嘴里留下怪味, 或海风带给人高兴的味道, 嗅觉和味觉提供了风味体验
触觉	压力, 疼痛, 温度	触觉的知觉: 潮湿, 冷和热的感觉, 皮肤感觉
头和躯体的运动位置	运动, 身体在空间中的位置	一端在上, 不同的活动提供了身体位置的反馈信息

又想像着焦虑、痛苦和紧张。因为两种情感是难以相互协调的。

自发引导的想像能够用于多种不同形式的咨询中。表13-3列出了对引导想像法多用途的研究实例。引导想像法的应用范围很广，如：帮助个人控制过敏反应，对付失落感和悲痛，增强免疫力，减少偏头痛，提高解决问题的能力，等等。近些年来，引导想像法已经成为运动心理学一个重要的部分。像其他的咨询策略一样，引导想像法也被用来补充各种治疗方案，如肌肉放松、脱敏、眼动脱敏和再加工、目标设置以及问题解决等。想像在肌肉放松训练中所产生的生理反应可以达到和真正收缩和放松肌肉完全一样的效果。

许多人以表象或心理图画的方式体验各种想法和情感。Judith Beck 使用这一技术让求助者去接近那些令他们烦忧的表象，以了解自己的问题。她可能会问求助者：“当你产生这个想法或情感时，你的脑海里出现了什么表象或图画？”。如果咨询者和求助者能够找到令人烦恼的表象，他们就可以创造一个新的表象，用于重建与先前表象相联系的想法和情感。引导想像法作为补充策略在医学领域里也十分流行。Jeanne Achterberg 在她的《治疗中的想像》一书中列举了想像在医学中的许多应用。另外，市场上也有许多录影带教授进行有效想像训练的各种方法。

引导想像法包括五个步骤：基本原理，对求助者想像潜力进行评估，想像场景的建立，场景练习，家庭作业。本章结尾处的引导想像法检查清单中提供了一些关于五个步骤的样例。

治疗原理

下面介绍的引导想像法原理可用于对看病感到焦虑的人：

引导想像法是这样进行的。通常人们在去医院之前对医疗过程有很多焦虑情绪，这是正常和自然的。一般来说，克服这种信念是困难的。这种信念引起了焦虑，而如果治疗有

表 13-3 引导想像法研究领域

过敏	乳腺癌
癌症	化学药物依赖
儿童游戏	象法的辅助作用
文化认识	情绪释放的记忆
悲伤	溶血病
艾滋病	免疫功能
习得无助感	偏头痛
音乐治疗	疼痛
惊恐发作	个人生活意义
躯体挑战	问题解决
精神分析治疗	呼吸问题
戒烟	运动心理学
肌肉拉伤	减少应激
考试焦虑	呕吐

令人不舒服的感觉，结果会使人更紧张焦虑。

因为紧张夸大了医疗的效果，你越紧张，你就越会体验到疼痛。可以说焦虑体验提高或加剧了痛苦，这就是所谓的恶性循环。应用引导想像法的技术可以帮助你逆转焦虑—疼痛的循环。它是这样起作用的：当治疗程序进行时，你去想像一个让你高兴、放松的场景或事件。你不能同时感到想像场景中带给你的宁静、安全、放松，而同时又感到治疗带给你的焦虑。两种不同的情感是不能相互协调的。

这样你选择一种能够让你感到放松、镇静和快乐的场景，当治疗进行时，你就想像你所选定的表象或场景。这种想像会阻断不舒服感和焦虑。采用过引导想像法的人报告说，想

像并保持愉快的场景会使他们的疼痛阈限升高。所以引导想像法不仅消除了与焦虑相联的不舒适感,而且模糊了可能体验到的痛觉。

求助者想像潜力评估

引导想像法成功取决于求助者从想像一个特殊场景中得到放松和积极感情的数量,因此咨询者了解求助者想像的潜力十分重要。咨询者可以用本章开始时谈到的自我报告问卷法、求助者叙述练习场景或咨询者对想像细节探索等方法,来评估求助者想像的潜力。

想像场景的建立

如果决定继续使用引导想像法,求助者和咨询者就要建立想像场景。虽然一种场景对某些求助者已经足够,但应至少建立两种想像场景。确切的场景数目和类型取决于不同的求助者以及他们的问题。

选择和建立场景包括两个基本成分。首先这个场景应当增进求助者内心的平和、安定和愉快。如在美丽的山坡上滑雪、在森林小径上穿行、在阳光灿烂的湖上划船、在安静的沙滩上散步、欣赏交响乐团演奏喜爱的乐曲、观看体育比赛等。在这些场景里,求助者可作为积极的参与者,也可作为参观者或旁观者。对于某些求助者来说,他们在这些场景里越活跃,其参与程度也越大。

场景的第二个成分应该尽可能有细腻的感觉,如:声音、颜色,温度,味道,触觉和运动等。感觉的程度和数量与求助者在想像场景中体验的高兴、愉悦程度存在很高的正面影响关系。咨询者和求助者应该决定在引导想像中使用哪一个想像场景。记住要选择那些与求助者文化背景相关的场景。

下面的想像场景例子可用于对医疗程序感到不舒服的求助者。

请注意该场景说明中所描述的各种感觉。

闭上眼睛，坐稳，做几个深呼吸（停会儿），放松。想像你正在一个美丽的沙滩上。你看到蓬松的云彩在蓝蓝的天空中飘散着，蓝绿色的海水泛着白色的泡沫，在海滩上打着回旋。你自己穿着泳装，感觉好极了，温暖的阳光照在你的身上。你做了个深呼吸，感受新鲜、干净的空气。听着海浪拍打岸边、退下去又一次卷水重来的声音。嗅着咸味和空气的湿气。温柔的海风轻轻地抚摩你的身躯。你躺在展开的一条沙滩浴巾上，感觉到布料的纹理。你脚上粘有沙子。沙滩温暖，使你放松和平和。想像你现在正走向大海，你站在没脚深的海水里，感受到海水的潮湿、温暖和舒适。你单独一个人，海浪升到你的腰，又升到你的胸部。你听到海浪声，看到阳光在蓝色的海水上闪闪发亮。你钻入海浪尝到海水的咸味，钻出海浪时又感受到海水的温暖。你脚下的海水上下运动着。海水和阳光感受起来多么温暖。在海水里逗留多么让人感到放松。你缓缓地在海面上游着。随着海浪飘向岸边，又随着海浪飘了回去。现在你慢慢地走出海水，走向自己的浴巾。温暖的阳光，适合的温度。你再次在浴巾上躺下来。沙滩上没有别人。阳光照在你的身上。你身上的每一块肌肉都完全放松下来。抬头望着天空，一块巨大的云团翻滚着飘然而去。

学习练习活动 39 / 引导想像法

这个学习活动帮助你学习想像引导的过程。有个同伴做起来会更容易些，尽管也可单独一人做。你可以先和搭档一起做，然后再单独做。

两人活动的指导语

1. 一个人扮演咨询者，另一人扮演求助者。完成一遍后而交换角色。
2. 咨询者提供想像引导过程的解释。
3. 咨询者确定求助者想像的能力：让求助者想像几个愉快场景，然后探询具体细节。
4. 二人共同形成两幅想像场景，让求助者进行生动的想像。每幅想像场景应产生愉快、积极的情感，而且要与求助者的文化相一致。
5. 求助者进行想像时，要尽可能的生动。
6. 求助者进行想像时，咨询者要在一旁模拟问题情境（如产生焦虑的情境），或捏一下求助者的手臂来产生疼痛的感觉。

独自活动的指导语

1. 想像两幅场景，要想像得非常生动。这些场景应产生积极、愉快的情感，并且与自己的文化背景相一致。尽可能想像一些细节。
 2. 尽可能全神贯注地进行想像。
 3. 在模拟问题情境过程中进行上述想像，例如，手里拿着一块冰或把手放进冷水里，此时应非常集中精力地进行想像。
 4. 在接下来的三天中，每天进行两次练习。看看你对冷水的忍受性会增加多少。
-

想像场景练习

建立起想像场景后，要指导求助者进行相应的练习。有两种练习方法，第一种是让求助者集中精力于一个场景，持续约30秒

的时间，要尽可能想出每个细节和感觉体验。求助者完成想像后，咨询者就能获得对求助者想像体验（即场景细节的感受和感觉）的印象。如果还建立了其他场景，则还可以继续同样的练习。进行练习时可以变化想像保持的时间长度。

第二种练习方法是让求助者在模拟的焦虑、紧张、恐怖和疼痛情形之中应用想像场景。这种练习可以帮助咨询者和求助者了解，所建立的想像场景对于阻断不舒适感、降低焦虑和恐惧方面的效果。模拟情境可通过生动地描绘焦虑、烦恼的细节而产生。例如咨询者在描绘一个愉快场景的同时插入一些令人不快的情境；再如当求助者想像某个场景时，咨询者拧一下求助者的胳膊而模拟痛苦状态；或者当女性求助者想像愉快的场景时，咨询者让她想一下生孩子时宫缩的情境。另一种模拟技巧是让求助者把手放在冰水里持续一段时间。模拟练习有助于求助者将想像场景应用于实际问题中。模拟练习后，咨询者应该对求助者运用场景的情况和他在模拟中的不适或焦虑感做出评估。

家庭作业和复诊

要让求助者在实际情境（即担心、疼痛、紧张或焦虑状态）中进行引导想像练习。求助者可用家庭日志来记录应用想像场景的日期、时间和情形。求助者还可以用5分制记录自己在应用想像场景前、后的反应。1分代表最轻的不适感，而5分则代表最严重的不适感。求助者要在下次就诊时带上家庭日志。

引导想像法示范

在下面这个引导想像法的典型例子中，我们将不象过去那样使用假设的案例进行解说，而是直接叙述我们夫妇俩在生产两个孩子时，是怎样应用引导想像方法的。

1. 原理：首先我们讨论了生孩子过程中要用到的引导想像法

和产前教育中所学到的有关呼吸和放松的技术(见第十七章)。我们决定在分娩过程中使用引导想像法作为呼吸法的补充。我们还商定用打手势的方式相互交流何时应当继续或停止场景想像。

2. 评估想像的潜力：我们分析了Sherry(女方)能否在分娩过程中集中注意力进行有效想像。我们是这样进行测试的：让Bill(男方)描述想像刺激，而让Sherry对此进行想像并运用所有感官将场景想像得尽可能生动逼真。
3. 建立想像场景：我们选择了两个练习场景，一个是在一个阳光普照、温暖和煦的日子里，我们在和风中乘着小船疾速前进。我们选择这个场景是因为它带来欢乐，并包括了许多感官体验。第二场景是：我们的船在轻柔的晚风中停泊下来。这两个场景都是真实的经历，我们认为这较之纯粹的想像作用会更好些。
4. 想像场景练习：我们知道分娩中运用引导想像是否成功取决于分娩前我们的训练。我们应用两种方式进行练习。首先，Sherry自己进行想像，有时与自我引导呼吸和放松训练一起做，还有时是在令人烦恼的状况下进行。第二，当Sherry努力唤起想像场景时，Bill则通过挤压她的上臂来模拟分娩收缩情境。
5. 家庭作业：实际上我们是在宫缩开始后练习想像场景。现在回顾起来，引导想像法对于分娩中的呼吸与放松法的确是有益的补充。

内隐模仿法

内隐模仿法是求助者在咨询者的引导下想像一个示范人物进行目标行为的过程。示范人物并不真的出现，而是要求助者去想像他正在做着目标行为。内隐模仿法曾被用于训练运动员获得希

望掌握的动作。Bill Cormier 用内隐模仿法帮助求助者和学生学习瑜伽的姿势和位置。Uhlemann 和 Koehn 运用内隐法和示范法进行人物移情反应训练。Lindh 在芬兰曾用该法帮助3到9年级有学习困难的学生。

内隐模仿法有许多优点：这一过程不需要复杂的治疗和诱导帮助；想像场景可以用于解决许多问题；可以非常具有针对性；求助者可独自进行练习；求助者可将想像场景用于实际问题中进行自我控制；当咨询中不能用实际的或影象的示范人物，或者进行实际的练习有困难时，内隐模仿法也许是很好的选择。

当然这种方法中还有一些问题未能解决，如示范人物的身份、强化物的作用、最适宜的想像场景类型和持续时间等。内隐模仿法包括五个主要组成部分：基本原理，练习场景，建立治疗场景，应用治疗场景，家庭作业。每一组成部分中又分成几个步骤。如果你愿意浏览整个过程的话，请参看本章结尾处的内隐模仿法会谈检查清单。

治疗原理

咨询者和求助者在共同找出问题行为和目标行为后，咨询者就要解释内隐模仿法的基本原理。下面的例子是 Bill 运用内隐模仿法教授瑜伽功时所做的介绍说明：

在家里自行练功时，想像出每个姿势的形态对于你们练习不同的瑜伽动作很有帮助。它会有助于你们的日常练习。在想像中看到你做的每个姿势可增强自信心，并对实际练习行为大有益处。

下面是 Bill 向瑜伽学生或求助者介绍内隐模仿法原理的另一个例子：

练习完每种姿势后，我要求你们闭上眼睛去尽可能清晰地想像，你正在观察自己所做的第一个姿势。然后我引导你

们去想像其他八个姿势。在想像中要利用自己的感觉。我将引导你们集中注意力和体验做每个姿势时的感受。当完成最后一个姿势后，我会问你们进行想像过程中的感受和想像的清晰程度。

练习场景

把原理告知求助者后，咨询者就可以利用几种练习场景进行内隐模仿法训练了。对多数求助者来说想像训练是新的经验，或是稀奇的事情。Kazdin指出，练习场景可帮助求助者熟悉想像过程，并使他们对想像中的细节变得敏感起来。场景练习还可以帮助咨询者评估求助者在想像中执行命令的能力。

练习场景通常是一些与目标行为无关的简单明了的情形。例如，你准备用内隐模仿法帮助某求助者获得面试技巧，这时使用的练习场景可能与求职并无关系，如下面的一些场景：

1. 想像在一个怡人的日子里，你正在美丽的高尔夫球场第十八洞附近，观看别人打高尔夫球。
2. 想像某个人爬到山顶，饱览山下全景。
3. 想像在一个喜剧俱乐部观赏喜剧演员的演出。
4. 想像某人在一个风和日丽的天气里散步。

咨询者通常采取六个步骤让求助者应用这些练习场景。

1. 引导求助者闭上眼睛，坐好，并放松，当完全放松下来后告知咨询者。如果求助者不能放松下来，咨询者应考虑是否要进行放松指导（第十七章）。
2. 咨询者描述一个练习场景，然后引导求助者想像该练习场景。当想像变得非常生动时，求助者伸出食指示意。练习场景与前述四个例子相似。
3. 当求助者示意其想像非常生动后，咨询者让求助者睁开眼睛，描述该场景并叙述想像中的事件。

4. 咨询者要询问求助者想像中的每个细节,如示范人物的衣服和体形特点、背景场面,光亮度、家俱的颜色、装饰品的特征、噪音以及味道等。这些询问可鼓励求助者注意到想像中的细节。
5. 在随后的练习中,咨询者可建议求助者注意更多想像的细节。首先进行场景练习有助于建立用于实际治疗的想像。
6. 通常每个练习场景都要进行数次。练习次数取决于几个因素。如果在数次练习后,求助者对想像场景的细节非常熟悉,并产生了舒适感,这时咨询者就应把它作为停止进行练习的线索,这也是开始建立治疗场景的良好时机。如果求助者放松有困难,那么就要进行放松训练。而当在练习中不能产生想像时,咨询者就要考虑用其他模式方法取代内隐模仿法。

建立治疗场景

内隐模仿法中的治疗场景是咨询者与求助者一起建立的,与实现求助者的愿望和目标相符合。场景中包括各种求助者目标行为的真实生活情境。如,求助者想获得有效的求职面试技巧,则治疗场景的建立就会紧紧围绕应聘的情形。

建立治疗场景应考虑五个方面的问题:示范人物特征,建立个性的、还是标准化的场景,使用模糊、还是具体的场景,场景的各种因素,场景的数目。求助者参与治疗场景的建立非常重要,因为他们可以提供情境中的非常具体的细节。

示范人物特征 示范人物与求助者之间的相似性有助于求助者的改变,如同样的性别和年龄等。而且,求助者想像多个示范人物比只想像一个人物会有更大的变化。求助者更容易从有相同性别、种族和道德观的人物那里学到东西。

最有趣的问题是示范人物的身份:有些求助者以自己本人作

为想像人物，而另一些求助者则想像他人。我们相信，对大多数人来说想像自己会更有作用。然而，没有足够的资料表明内隐模仿法中将谁作为示范人物更好。我们认为答案随求助者的不同而不同，因此我们建议要让求助者来决定是将自己还是他人作为示范人物。对于混血求助者，这就意味要他们回答自己对哪部分文化更认同。最重要的是要让求助者能对示范人物的身份进行轻松而愉快的想像。当求助者开始以自己作为想像人物有困难时，最好是先让他以别人作为想像人物，然后再过渡到自己。当找不到一个具有相同文化背景的人物时，不妨让求助者以自己作为想像中的示范人物。

个性化或标准化场景 治疗场景可以是标准化的，也可以是针对求助者个人的。标准场景包括日常生活中的不同情形，可提供给一组具有同样目标行为的求助者使用。例如，咨询者可以采用一系列标准化场景来描述应聘的情形。个性化场景则代表求助者提供的特定情形。例如，一个不自信的求助者需要一个与陌生人见面的场景；另一个缺乏自信的求助者则需要与亲密朋友见面的场景。一般来说，由于标准化场景可能与特定的求助者无关，因此对于那些有特殊问题或单独进行咨询的求助者而言，其治疗场景应是个性化的。

场景的具体化 建立治疗场景的另一个考虑因素是引导语的具体程度。有的求助者可以从具体详细的引导想像中获益，而有的求助者则从笼统的治疗场景中获益，因为他们自己可以为场景增添具体内容。当然，不对求助者进行细节引导具有一种风险，即有时求助者所添加的内容与目标行为或期望结果没有关系，甚至偏离。我们建议具体化的程度应考虑求助者的偏好。

下面是一个非常笼统的治疗场景引导语：一个假释出狱的犯人求职的场景。

想像你自己正在应聘。老板问你为什么没能完成高中学

业。你告诉他你遇到了麻烦。他问什么麻烦。你虽有些紧张，但还是告诉他你曾入过狱。老板问为什么入狱、呆了多长时间。然后他接着问你怎么能肯定不再遇到麻烦，假释期间你一直在做什么。想像你自己对老板说，以级假释期间一直在尝试找一份工作，并思考着自己如何去生活，能做些什么。

在这个例子中，治疗场景的笼统性在于它假定求助者知道如何进行应答，以及知道为这个场景增添什么样的细节。

一个更加具体化的治疗场景将包括许多实际应答的细节。例如：

想像你自己正在应聘，并进行了下面的对话。老板说：“我了解到你只上了3年中学，你不想毕业吗？”想像你自己这样回答(有点焦虑)：“不，我想一边工作，一边上职业学校。”老板问：“发生了什么事情？你怎么落下这么多课程？”你自己回答说：“我暂时离开了学校，因为我遇到了麻烦。”现在想像老板有些警惕地问道：“什么麻烦？”想像中你决定面对现实并问答说：“我入过狱。”老板问道：“为什么？”想像你自己有点紧张，但还是保持镇静地回答：“我猜想当时我太不成熟，我和一些朋友与毒品沾了边。我正在假释出狱期间。我已远离毒品，现在正努力找一份工作。我真的渴望能找到工作”。

记住，场景的具体程度主要取决于求助者和他们的问题及咨询的目的。

场景的组成成份 治疗场景由三个成份构成：目标行为发生的背景描述；进行目标行为的示范人物描述，目标行为所带来的积极结果描述。

情境：想像你在一个晴朗的日子里打网球。你正在比赛，对手将球打到你的正手，你打了回去；对手打回来时，球很低，落在你的反手。

目标行为：你想像着自己用双手握住球拍，收回胳膊准备击低球。你击中了球，球越过网，落在对方界内。注意体验一下将球击过网时身体的感觉。

下面是为一个想戒烟的成人建立的、有良好结果的治疗场景例子：

想像你在预约晚餐之前正和几位朋友坐在餐馆喝酒。所有的朋友都在抽烟，烟味熏得你也想抽支烟。你和他们大约喝了十分钟，其中一位朋友递给你一支烟。在过去，如果你没有带烟，你就会接受他的烟。想像你很想抽这支烟，但又拒绝了，并且专注于朋友们所讨论的问题上。

研究表明，如果求助者看到示范人物的行为得到了奖赏，或者感觉到其行为有不错的结果，那么求助者则很可能按照示范人物的行为去做。并且，设定想像中出现有利的结果可以防止求助者不经意地想像出不利的结果。想像中示范人物得到奖励的治疗场景，比起那些没有积极结果的想像场景，能帮助求助者更快地学会目标行为。

我们认为场景中的有利结果，应以求助者自己主动行为的形式出现，或者以内隐的自我强化和自我表扬形式出现。例如：在戒烟场景中出现有利结果应是求助者自己主动拒绝抽烟导致的。想像场景中这种导致有利结果的行为最好是由求助者本人或示范人物做出的，而不是其他人做出的。因为在现实情况下，求助者依靠别人的行为带来有利结果是相当危险的，通常很难保证求助者总是能从别人那里得到有利的行为反应。

将有利结果融入治疗场景的另一种方式，是将求助者（或示范人物）的自我激励、自我赞扬包括在场景中。例如，想像人物可能自我祝贺地说：“太好了，我能对旅馆店员说出那样的话，我感到自豪。”想像人物的自我赞扬都是他们自己努力获得的。同样，在现实生活中，求助者学会自我奖励比期待不一定会出现的

外界奖赏要好得多。

得到奖励结果的人应是想像中的示范人物。如果求助者将自己作为想像人物,那么在想像中就是求助者自己得到了这些奖励。对于内隐模仿法的强化作用还很少有实际的证据。治疗场景有利结果的强化效果取决于示范人物的身份,以及这种结果对于求助者的特定价值;而所有这些又都随求助者性别、年龄和文化的变化而有所不同。

想像场景的数目 咨询者和求助者可以建立不同的想像场景,用以描绘求助者体验到的困难情境,或者希望进行目标行为的情境。治疗想像场景的数目取决于求助者和他们的问题。尽管没有固定的数目,但多几种场景总要比只有一两种场景好得多。

应用治疗场景

建立完治疗场景后,咨询者就可以使用这些场景,让求助者对每一个场景进行想像。应用治疗场景的基本步骤如下:

1. 将这些场景按等级进行排列
2. 在场景呈现之前对求助者给予引导
3. 在场景等级中每次使用一个场景
4. 按规定的时间呈现每个场景
5. 获得求助者对于想像场景的反应
6. 引导求助者对治疗场景进行言语概括
7. 在咨询者或录音磁带的帮助下,每个场景至少呈现两次
8. 在求助者的自我引导下,每个场景都至少要想像两次
9. 从场景等级中随机选择并呈现治疗场景

场景等级 咨询者和求助者建立的场景在应用时应按一定等级排列。等级的顺序如下:从求助者最容易想像、产生最小应激的场景开始,直到压力和应激最大的场景。

引导语 如果想像场景在相隔较长时间后才练习,就有必要

向求助者重复有关想像的引导语。如咨询者可以这样说:

闭上眼睛,做几次深呼吸,全身放松。我希望你尽可能生动、清晰地想像你正在做着瑜伽功。调整并利用你所有的感觉。例如,努力听到我对每种姿势的引导语声音,看到你所穿衣服的颜色,看到你自己正在做每个姿势。你嗅到什么气味?身体有什么样的感觉?做每一姿势时,你身体特定的肌肉群有何感觉?你嘴里有何味道?我在几分钟后会问你们有关场景的感受以及想像的清晰程度。

如果想像人物不是求助者本人而是别人,就要引导求助者将该示范人物想像成与自己的年龄、性别和文化相仿。要告诉求助者这个想像人物将被用于所有的治疗场景。还要让求助者一旦场景想像非常清楚时,便伸出食指示意;而且要一直保持想像,直到咨询者发出停止信号。

场景呈现顺序 应将等级中的第一个场景首先呈现给求助者。每次呈现一个场景。当一个场景被充分想像后,再呈现下一个场景,直到所有场景都呈现完。

场景想像的持续时间 在求助者伸手示意之前,想像过程应持续多长时间并没有一个统一的规定。对于某些求助者,较长时间的场景想像可能会更好;而对另一些求助者,短时间的想像可能更有益。我们认为时间长短的选择取决于咨询者的意愿和经验、求助者问题的性质、咨询中要取得的目标行为等。呈现一两个场景后,咨询者应向求助者询问场景的持续时间是否合适。一般来说,场景的持续时间应足够长,以便求助者能对场景中的三个成份进行生动地想像,而不会要草率。

求助者对场景的反应 求助者想像完特定的场景后,咨询者要询问场景想像的清晰度。让求助者描述一下想像场景某一部分时的感受。还要询问求助者场景描述得是否太快,场景持续的时间是否足够长。这些问题能使咨询者和求助者在第二次应用该

场景前，对场景的某些部分进行修改。求助者对场景的修订意见很有帮助。如果场景的某些部分引起了求助者强烈的焦虑和紧张，那么这部分内容以及呈现方式就应加以修改，也许场景级别的顺序也需要重新排列。

解决求助者想像中产生不愉快和不适感的另一种方法是对其进行讨论。如果示范人物（或其自身）在想像场景中参与某个行为活动时令求助者感到紧张，咨询者就要与求助者一同考察是哪个情节产生了不适感，要分析、检查障碍是什么。但分析要集中在想像场景中的那些适应性行为，而不要针对焦虑或不适感本身。

每一个场景呈现后，咨询者都应当评估场景描述速度、想像的清晰度、场景所引起的不愉快程度。如果在建立和修改想像场景时，求助者给予了很多意见的话，不适感就会降到最低的水平。另外，场景想像的清晰度也可通过言语的概括或场景的个性化而得到加强。

言语概括编码和个性化 言语概括编码是指求助者用自己的言语对目标行为和行为发生的情境的简短描述。语言编码可以帮助求助者在治疗中和治疗结束后获得并保持目标行为，因为语言使他们在记忆工作中能够对所期望的反应进行编码。场景言语化（或言语概括编码）是引导想像法和内隐模仿法的变通方式。治疗者可引导求助者用自己的语言描述行为及情境。我们建议求助者对练习场景进行言语概括编码，并从治疗者那里获得编码反馈。这种训练应在想像治疗场景之前进行，然后呈现治疗场景，并让求助者用自己的语言对治疗场景进行言语概括编码。第一次呈现治疗场景时，不要求求助者进行言语概括编码，第二次呈现时，则引导求助者准确大声地说出想像的场景中有什么。

治疗场景的个性化是增强内隐模仿法效果的另一项技术。呈现场景后，告诉求助者可以对治疗场景以任何自己的方式进行修改，惟一的要求是想像中示范人物的目标行为要保持不变。如

同言语概括编码一样，要让求助者将练习场景进行个性化，并从咨询者那里得到反馈。咨询者应鼓励求助者在练习场景所提供的情形下，进行个性化的修改。当治疗场景第二次呈现后，要让求助者尽量做出详细阐述和发挥。这可使求助者更加投入，因为这时的场景已经很个性化了。

记住求助者第一次进行场景想像时，不要引导他使用言语概括编码，或者对场景进行个性化的修改。第二次呈现治疗场景时，再引导求助者应用两种技术之一。为了证实求助者是否遵循了咨询者的引导语，可令其大声说出言语概括编码，或者解释在那些方面做出了详细补充、修改和发挥。

咨询者引导下的场景重复 第一次呈现场景并做了必要修改后，咨询者可将此场景进行多次重复。场景重复的次数取决于求助者想像场景时所体验到舒适感的程度，以及想像中行为活动的复杂性。例如，复杂的运动技能需要重复多次；在某种情况下，求助者也需要重复多次才能感到舒适。再一次强调，重复次数有赖于求助者的意见，要经常询问求助者的意见。如果要使用言语概括编码或者场景个性化方法，要记住告诉求助者不要在第一次呈现场景时就应用这些技术。

求助者自我引导下的场景重复 除了咨询者引导场景想像训练外，求助者还可以进行自我引导训练。场景的重复次数有随意性，但至少重复两次。一般来说，求助者可独自重复进行想像，直到做这些事情时感觉很舒服。求助者既可以使用不出声的言语概括编码，也可以运用场景个性化技术。公开想像治疗场景有利于求助者获得并保持目标行为。应当在每个场景第二次或第三次呈现后，要求求助者与治疗者一起公开复述想像场景。

随机呈现场景 场景等级中的所有场景呈现完之后，咨询者要检查求助者是否做好准备进行自我引导家庭练习。检查方法是随机呈现某些场景。随机呈现可以防止场景等级安排中的“顺序”

效应。

家庭作业和复诊

自我引导的家庭作业练习也许是最重要的治疗组成部分。如果一个人能够在咨询环境外应用和练习想像过程，那么他在实际情境中采用“新”行为的可能性就会大大增加。家庭作业包括在日常生活中分辨出不同的情形，以便做出相应的适当反应。

安排家庭作业任务时，咨询者要和求助者一起确定做练习的频率、持续时间，以及在什么时间、什么地方进行练习。还应指导求助者用日志记录每日进行想像练习的情况。咨询者还应核实求助者是否真正理解了家庭作业，并预约复诊时间以便检查家庭作业的完成情况。

内隐模仿法的范例对话

下面是一个内隐模仿法的对话范例，其中我们将帮助Joan提高她在数学课上的主动技能（并参见学习练习活动40）。

在对话1中，咨询者简略描述了治疗策略的原理和概况。

1. 咨询者：Joan，我们要帮助你改善你在数学课上的主动学习技能，但你要先做一些练习。在练习中，你将利用你的想像力。我先向你描述一种情形，然后你去想像你自己或他人正置身于这个情形中。清楚吗？

求助者：是，你的意思是让我像做白日梦那样想像吗？

对话2中，咨询者进一步描述了治疗策略的概要。

2. 咨询者：有些相似之处。只是在想像中不要让你的思想漫游，而是要想像那些能够帮助你提高数学参与能力的技巧。

求助者：好，我很好做白日梦，如果两者相似的话，我会掌握它的。

对话3中, 咨询者将利用练习场景评估Joan的想像水平和风格。

3. 咨询者: 好。让我们做一次试试, 看看实际进行想像对你来说是困难还是容易, 看看你的感觉如何?

求助者: 好。会发生什么?

对话4中, 咨询者指导Joan在进行想像练习之前坐下来并放松自己。

4. 咨询者: 首先, 你先坐舒服了, 闭上眼, 放松自己(给Joan 5分钟时间去放松)。你看起来相当舒服。感觉怎样?

求助者: 很舒服, 放松对我而言不是很难。

对话5中, 咨询者要Joan生动地想像练习场景, 当想像生动时用食指示意。

5. 咨询者: 好。Joan, 现在我将给你描述一个场景。希望你尽可能生动地想像这个情境。当你觉得你想像的场景十分鲜明时, 就举起你的食指。懂了吗?

求助者: 懂了。

接下来咨询者描述了一个场景。这个练习场景很简单, 也很实际。只要求Joan去想像另一个人。

6. 咨询者: 想像某个准备给你一份暑期工作的人。在你心理描画一下这个人(给Joan足够的时间想像, 直到Joan举起了手)。

对话7中, 咨询者请Joan描述她的想像如何。

7. 咨询者: 好。现在睁开眼睛。你能告诉我你刚才想像的内容吗?

求助者: 我想像我正在与一位中年男子谈话。他问我暑期里是否想做救生员的工作。自然我说愿意。

Joan的想像报告的行为与对话是清楚的, 但她没有描述那个男人。咨询者进一步询问细节。

8. 咨询者：好。你对那个男人还想到了什么？你提到了他的年龄，但他穿什么？有什么特征？

求助者：他差不多35岁。穿着短袖高尔夫衫。我们是在游泳池旁进行谈话。就是这样。

Joan 够描述谈话场景和男人的衣着，但没有提到他的特征。咨询者建议 Joan 在下一次的练习中将特征加进去。

9. 咨询者：你讲到 he 穿着什么和你们谈话的场景。我想让你再做一次练习。想像同样的场景，只是这次要尽力想像那个男人外表的细节（咨询者呈现同一个练习场景，直到 Joan 举起她的手）

对话10中，咨询者仍询问 Joan 想像的细节。

10. 咨询者：这次你是怎样想像那个男人和当时的情形的？

求助者：他穿着白色短裤和绿衬衫。高个子，晒得很黑。黑头发，蓝眼睛，带着太阳镜，光着脚。我们正站在水池边。水是蓝色的。太阳高高的，很热。

对话11中，咨询者要判断 Joan 对想像内容是否感到舒服，是否需要进一步进行进一步的练习。

11. 咨询者：非常好。你能够想像颜色和温度了。你对想像练习感觉舒服吗？

求助者：噢，我喜欢去想。第二次想像更容易些，我加进很多东西。我愿意这样去想像。

对话12中，咨询者决定让 Joan 前进一步，开始进入到治疗场景部分。

12. 咨询者：好，我相信我们能继续进行。下一步的场景将与你上数学课的情形有关。

求助者：我是否以同样的方式进行想像？

咨询者首先要建立治疗场景以便获得所有必要的信息。对话13 的重点在于使 Joan 参与到这一过程中。

13. 咨询者：非常对。象刚才你想像时那样进行下面的想像。现在我们要一起讨论一些事情，使建立的场景更容易去想像。我将问一些问题，你的意见对我们双方都是非常有价值的。

求助者：好，开始吧。

对话14中，咨询者问Joan，她愿意将自己还是他人作为场景中的示范人物去想像。

14. 咨询者：首先，在刚才的练习中，我请你想像另外一个人。你做到了，并且也把自己包括在想像的场景中了。那么在下面有关数学课的场景中，你愿意想像自己还是想像他人？哪一种方式对你来说更容易且更不容易激动？（给Joan一段时间去思考）。

求助者（停一会）好，很难说。我想还是想像自己更容易些，如果想像他人则可能更不容易激动……（停一会）还是想像我自己吧。

在对话15中，咨询者肯定了Joan的选择，同时也指出改变示范人物的灵活性。

15. 咨询者：很好。但是你要知道，事情都是可以变的。如果你感觉不好，那么就在场景中想像其他人好啦。

求助者：好吧。

对话16中，咨询者介绍了建立应付行为的方法。

16. 咨询者：一开始就能想像出自己的行为很圆满是非常困难的。所以进行想像时，我将描述这样的情境，你遇到了点麻烦，但不是很大。这样可能更真实些。你认为怎样？

求助者：看起来是很合理。我知道你的意思，就像学开车一样，每次学一个动作。

对话17中，咨询者让求助者做出选择，或者建立个性化的场景，或者建立标准化的场景。

17. 咨询者：你已经明白了。现在让我们做另一种场景选择。场景可以是专门为你的问题度身建立的；或者我们可以使用磁带中录制的标准化场景，它已经在许多学生中使用过以提高课堂参与技能。你觉得哪种选择更好？

求助者：我真的不知道。它们真的不同吗？

许多求助者都不知道如何做出选择。在对话18中，咨询者指出较好的选择，并与求助者商量。

18. 咨询者：Joan，现在你不知道如何选择，以后会知道的。我更愿意使用个性化的那种选择。如果你自己练的时候，你可以在家继续使用磁带录音上的标准化场景。你觉得怎么样？

求助者：可以，这样我们两个方式都可以用。

在对话19和20中，咨询者让Joan找出她希望能加强参与技能的情境来。这就是第十章中描述过的美好（有利）行为。

19. 咨询者：是的。现在让我们专心设计场景细节。首先来看看数学课上的情境。

求助者：好吧。我们以前好象谈过那些事情，比如被老师叫到、到黑板前回答问题等。

下一步咨询者要探询Joan是喜欢非常笼统的描述，还是非常具体的描述。有时这种选择会对求助者的想像有不同的影响。

20. 咨询者：Joan，当我描述场景时，你希望描述的详细程度如何，是粗略点呢——这样你可以填补、发挥自己的想像——还是希望我非常完整地描述你要想像的内容？

求助者：在二者之间吧。我可以填补许多细节，但我需要知道填充些什么。

对话21中，咨询者将指出Joan的一些在数学课上遇到麻烦的具体情境。

21. 求助者：好，让我们填补以下我的描述。我们要谈的是你

在数学课上的情形。我记得在四种情形下你希望得到更多的应对技能：当老师叫到你时，你想回答得更多一些；要更主动地回答问题；到黑板上回答问题；要告诉老师你希望自己解决问题。还有吗，Joan？

求助者：我想不出其他的情境。

从对话22到27，咨询者请Joan找出在这四种情境中的目标行为。其中大部分还与第十章中对结果的识别有关。

22. 咨询者：好，所以我们可以进行四种不同情境。在每种情境下你愿意做些什么呢——比如老师叫到你时？

求助者：我愿意讲出答案，而不是闭口不语或者回答说“不知道”。

23. 咨询者：很好。如果你做了回答，而且确实知道答案，你会有怎样的感受？

求助者：会不错，感到轻松一些。

24. 咨询者：那么主动回答问题的情境怎样呢？

求助者：老师通常问谁知道答案，然后叫举手的同学回答。我通常不爱举手，即使我知道答案。所以我需要举手，他叫到我，我就会主动回答问题。我还需要发言清楚一些，有时我的声音太低。

25. 咨询者：你怎样能够告诉老师，你想自己解决问题呢？

求助者：自习时，我可以走到他面前，告诉他我在哪些数学题上遇到问题，并请他帮我解释。

26. 咨询者：所以你需要从他那里得到解释，并让他知道你想自己做出此题来。

求助者：是这样。

27. 咨询者：那么去黑板前回答问题呢？

求助者：我走上去，但我总感到自己像傻瓜，觉得全班同学都看着我，以致解不出问题。这时老师会让我回到座位

上去，即使我还没完成。我需要更加全神贯注，这样才能解出黑板上的全部问题。

建立完四个场景内容后，咨询者请 Joan 将四个场景排序。

28. 咨询者：现在我们已经有了四个有关数学课的场景。下面让我们为它们排个顺序。你能选择出一个最容易、最少应激的场景，并将其他三个场景按照难度和应激程度由小到大排列吗？

求助者：让我想一下。最容易做的事情是我告诉老师我想自己解决问题，再难一点便是老师叫我回答问题，然后是到黑板前做习题。问题最多也是最难的要数我自己主动举手回答问题了。

咨询者强调顺序是可以改变的，并告诉 Joan 怎样用这些场景进行下面的练习。

29. 咨询者：但这种顺序是可以改变的，任何时候当你感到它不对，我们就可重新排序。我们将从最容易的场景开始进行想像。所以第一个场景是你告诉老师你要自己解决习题。

求助者：就像我们开始做的那样？

咨询者开始对 Joan 具体描述场景。

30. 咨询者：是的。请坐好，闭上眼睛，放松自己（给 Joan 几分钟）。记住，当我描述这些场景时，你想像你自己正在情形之中。尽量用所有的感觉去想像，换句话说，真心投入进去。想像非常生动时，举手示意。我没说停止之前，继续保持想像。可以了吗？

求助者：可以了。

咨询者开始描述第一个场景，期间要有许多停顿时间以便 Joan 进行想像。

31. 咨询者：Joan，想像你正在上数学课……老师刚刚解释完了怎样求解 x 和 y ……他布置了习题，让你们开始练习……

你发现公式中有一些不明白的地方。你着作业纸，起身走到老师讲台前。你正在告诉老师你在哪些地方不太明白，你对他说，你并不是想让他帮助解题，而只需要解释一下公式。现在你感到很满意，终于可以站起来，走到老师面前请求解释了。（咨询者等了约10秒钟，Joan举起了手。）

咨询者示意Joan停下来。从对话32到对话35，咨询者进一步巩固Joan的想像。

32. 咨询者：好，Joan，现在睁开眼。你想像到什么呢？

求助者：想像相当容易。我站起来走到老师那里，告诉他我需要解释，但是我要自己找到答案。

33. 咨询者：你能想像出生动的场景吗？

求助者：是的，正是这样。

34. 咨询者：想像期间你感觉怎么样，特别是当你想像自己的时候？

求助者：我相当平静，没有心烦。

35. 咨询者想像自己并不会压力太大。我留给你的时间足够吗？

求助者：可能吧。但我认为我可以持续更长一段时间。

在Joan对第一个场景时间长度反应的基础上，咨询者在下次呈现场景时对时间做了调整。

36. 咨询者好，我下次会给你稍多一些时间。

在第二次呈现治疗场景以前，咨询者询问求助者愿意使用言语概括还是个性化的治疗场景。

37. 咨询者：Joan，这里有两种技巧可以帮助你数学课的想像。一种方法是简要地描述一下你想要做的事和数学课上的情境。你要用自己的语言进行描述，它可以帮助你记住你要做的行为。另一个技巧是，你可以对场景进行改变和发挥，只要你在想像中仍在进行你自己要做的事。你对此有什么问题吗？

求助者：你认为这两个技巧有助于更好地想像吗？

38. 咨询者：是的。你认为哪一个可能对你更有用？

求助者：我认为用自己的话描述场景的方法对我更适合。

39. 咨询者：那么对于第一个场景，你会用什么话来简要概括一下？

求助者：好。在老师讲完如何解 x 和 y 的问题后，我会发现有些东西我不太明白。我离开座位，走向老师，并告诉他我需要更多的解释，但我希望自己解出答案。

40. 咨询者：非常好，Joan！

咨询者再次呈现了同样的场景。通常每个场景需要至少呈现两次。如果求助者选择了一个或两个场景想像的促进技巧，那么每个场景都要使用这个技术。

41. 咨询者：我们再进行一次。同样的场景，但我会给你多一些想像时间。（再次呈现同样的场景，并查看 Joan 在第二次呈现中的反应。）

呈现场景后，咨询者让 Joan 自己引导进行场景想像练习。每个场景的自我想像练习也应至少进行两次。

42. 咨询者：看起来你已经习惯这个场景的想像了。这一次我不给你描述这个场景了，而是要你自己进行想像，没有我的帮助。

求助者：好吧。（自己练习想像了几分钟。）

43. 咨询者：感觉怎么样？

求助者：没有你的引导语，好象也很简单。我明白了我实际上应怎样向老师要求解释了。

其他场景的呈现也以相同的方式进行。

44. 咨询者：很好。现在我们可以用同样的方式进行其他三个场景了。每个场景的练习都要做到你在想像中能很轻松地进行目标行为。（逐一进行其他三组场景练习。）

45. 咨询者：当我们做完所有场景练习后，你的感觉如何？

求助者：非常好。我从来没有想到想像能够对我的数学课有帮助。

完成所有的场景后，咨询者随机选择其中的场景让求助者进行练习。这是一种检查方法，看看求助者在不按顺序呈现场景时是否能够轻松地进行想像。

46. 咨询者：是这样的。有时在想像中做某些事会帮助你在实际情境中的学习和掌握。现在我要随机选一个场景描述给你，请你进行想像。（随机选择一个场景并进行描述。）

求助者：这也很容易。

咨询者开始为 Joan 布置家庭作业。

47. 咨询者：刚才做得不错。我相信你现在已经能够自己独立完成想像练习了。

求助者：是否该用磁带录音了？

咨询者向 Joan 解释家庭作业。

48. 咨询者：是的。磁带录有一套语文课的场景练习。录音会为你描述各种场景。我希望你每天都练习，因为这样才能使你更快地学会。

求助者：我练习的方式与我们今天所做的一样，是吗？

咨询者指导 Joan 怎样完成她的家庭作业。

49. 咨询者：每次进行一个场景练习，每个场景大约练习四次。尽可能地使想像生动些。每次练习时都要做记录，记下练习的时间和地点，以及每次练习的时间长度。而且每一次练习后，要评估一下想像的生动程度，评估量表为5级分数：1代表不生动，5代表非常生动。概括一下家庭作业怎么样？

求助者：可以。照今天的方式进行想像练习，记下每个场景做了几次练习，并用一个数字代表我想像场景的生动程

度。

在结束之前，咨询者要告诉求助者下一次见面时要检查家庭作业。

50. 咨询者：对。下次我们见面时将记录纸带来，我们检查一下，好吗？今天的治疗过程进行得很好，你很努力。我们下星期二再见。

学习练习活动 40/ 内隐模仿法

回忆一下第十章中介绍的 Weare 女士案例，她的一个亚目标是与 Freddie 的老师安排一次会面。Weare 女士想要通过这样的会面，来解释她处理 Freddie 问题的策略，并获得学校的帮助与合作。Weare 女士认为，凡事（让 Freddie 迟到一次）有第一次，就会有第二次、第三次。但 Weare 女士因为不敢肯定在会面时谈些什么，她又有些犹豫。请说明一下，你将如何使用内隐模仿法来帮助 Weare 女士达到这个亚目标。着重描述你如何使用：(1)基本原理；(2)练习场景；(3)治疗场景；(4)治疗场景的应用；(5)帮助 Weare 女士达到目的的家庭作业。反馈信息见学习评判反馈 40。

学习活动反馈 40/ 内隐模仿法

1. 基本原理

首先，你将向 Weare 女士解释这种内隐模仿法能够帮助她，使她发现表达自己的方式，且能在实际会面之前帮她练习表达自己。第二，你可简单描述一下这个治疗方法，要强调她可在使用这时方法中运用想像力，练习在与老师会面中她如何做出反应。

2. 练习场景

要解释想像训练对她是有帮助的。先选择几个无关的场景,例如:想像某人来到她家,想像她的老朋友喊她,或想像一台新电视中正在上演一个女警察的故事。对每个场景,你指导她闭上眼睛,集中精力去想像这个场景;当她在脑海中有有一个鲜明形象后就举手示意;这时,可让她睁开眼睛,描述她想像中的细节。你可以帮助她加上一些额外细节,然后再一次让她想像同样的场景,或想像另一不同场景。当 Weare 女士能够得心应手地运用其想像力时,就可以前进一步,去对付实际场景。

3. 建立治疗场景

要让 Weare 女士对治疗场景提供细节。特别是,要决定场景中的示范人物是谁,用个性化的场景还是用标准化的场景。我们更愿意使用具体、个性化的场景,并让 Weare 女士将自己当做场景中的示范人物。下一步,要明确这个场景中的三个成份:①行为发生的情形;②将要展示的行为;③一个积极的行为结果。例如,场景可以是:Weare 女士打电话给老师,确定会面的时间;开始会面;在会面中解释自己教育孩子的策略;结束会面。积极的结果可以是:内部赞扬自己,感到紧张和焦虑情绪的宣泄。

4. 应用治疗场景

当所有的治疗场景建立后,可以让 Weare 女士将它们按难易程度排列成场景等级,然后从等级中的第一个场景开始。再次让 Weare 女士去想像。经过第一次场景之后,你要询问 Weare 女士想像的清楚程度、持续时间等。要根据她的反应对场景进行修改后,然后再次呈现给 Weare 女士,还要鼓励她用言语总结自己的想像。在你的引导下进行若干次想像,然后再进行若干次自我引导想像。当她完成场景等级中的所

有练习后，Weare 女士就准备好做家庭作业了。

5. 家庭作业

你可以指导 Weare 女士继续在家里练习此场景，并安排好下次复诊的时间。应当确认 Weare 女士明白要练习多少次，以及如何用日志记录练习情况。练习中如有任何问题，可以打电话过来。

本章总结

当影象演示和实际演示不可能进行时，就可使用引导想像法和内隐模仿法治疗程序。使用这两种策略不需要治疗助手，也不需要昂贵的仪器。两种策略都是利用人们的想像，从而使得求助者很容易进行自我引导练习。求助者的想像能力对于引导想像法和内隐模仿法取得疗效很重要，因此在使用两种策略前，要对求助者的想像力进行评估。假定求助者能够产生丰富的想像，咨询者就可以使用引导想像法处理求助者的恐惧和不适感，使用内隐模仿法促进学习目标行为。虽然想像法对于不同文化求助者的应用范例还不多，但如果它能够与求助者的文化建立起联系并适应不同的文化，它就会成为有用的干预治疗方法。

学习评判

第一部分

根据目标一，你应能够在下述咨询者的引导语中，从引导想像步骤的7个例子中确认出6个步骤。对每个咨询者的引导语，请写出他在执行引导想像法中的哪部分内容。引导想像中的五个主要部分如下：

1. 基本原理
2. 判断求助者运用想像的能力

3. 建立想像场景
4. 想像场景练习
5. 家庭作业和复诊

下面是咨询者使用的想像引导语例子:

1. “你能想像出若干情境, 它们使你产生平静和积极的情绪吗? 尽可能想像出它们的细节。以后你会使用这些场景来替代焦虑感。”
2. “练习这种想像是非常重要的。每天都要练习若干次。”
3. “这个方法可以帮助你控制自己的焦虑。通过想像愉快场景便能使你阻断恐惧情绪。”
4. “让我们看看你是否觉得想像很容易。闭眼静坐, 想像任何可以使你放松的事情。”
5. “现在选择一种你刚才练习的场景。尽力去进行想像。我将在你的手臂上施压, 但你要精力集中继续进行想像。”
6. “如果你觉得想像很容易, 我们就可以建立一些练习场景。想像时尽量放松。”
7. “现在你来练习我们刚刚建立的场景。每次练习一个场景, 静坐放松, 每次持续约 30 秒。时间到了我会告诉你。”

第二部分

第二个目标是在角色扮演中演示出引导想像13个步骤中的10个步骤。你自己或另一个观察者根据后面的引导想像法检测清单来评估你的表现。

第三部分

第三个目标要求你利用第八章所介绍的黄先生案例, 描述内隐模仿法的五个组成部分(即基本原理、练习场景、建立治疗场景、应用治疗场景、布置家庭作业), 并以此来帮助黄先生降低自己对退休的担心和焦虑。

第四部分

目标四要求你在角色扮演中演示内隐模仿法28个步骤中的22个步骤。利用后面的内隐模仿法检测清单评估你的表现。

引导想像法会谈检测清单

指导语：在角色扮演会谈中，确定咨询者表现出了下面所列引导语中的哪些引导语，在所表现出的引导语旁边画勾。清单的右侧栏中列举了一些引导语例子。

项目	引导语举例
I. 基本原理	
_____ 1. 咨询述者描引导想像的目的。	“这个过程之所以被称做引导想像法，是因为你可以在能引起恐惧、痛苦、紧张、焦虑的情境中，激起愉快的思想和表象。它帮助你减少不舒服或焦虑感。技巧主要在于每当不舒服出现时，就集中想像愉快场景，使自己放松下来。通常在一个场景中感到高兴、平静、快乐、安全的同时又感到焦虑、紧张、害怕、压抑，这是极其困难的。”
_____ 2. 咨询者介绍治疗程序概况。	“我们首先要查看你的想像场景细节的能力，然后我们再决定是否采用引导想像法。如果用这种方法，我们就建立想像场景，它们会使你感到平静、舒适，并会使你产生积极情感。然后将在模拟的场景中进行想像练习。之后，再在实际生活场景中练习应用想像法。对我的解释你还

—— 3. 咨询者评估求助者的意愿。

有疑问吗?”

“你愿意尝试这个治疗程序吗?”

II. 求助者想像潜力的评估

—— 4. 咨询者指导求助者进行那些引发出的好的感觉和平静的想像活动。

“闭上眼睛, 放松坐下; 想像能使你感到轻松或高兴的风景或一件事。选择一些你真正感到高兴的事情, 尽量体会到这一场景中的感觉。”

—— 5. 在30秒至1分钟之后, 咨询者探查求助者想像场景的生动性(颜色、声音、运动、温度、气味)、以及助者对想像场景的情感(对想像过程的好感觉)。

“把场景描述给我。”

“当描述场景时你体会到什么感觉? 体验到什么温度、颜色、声音、气味、姿势?”

“你对想像的感受如何?”

—— 6. 咨询者和求助者讨论是继续下去, 还是选择其他干预方法。

“你似乎能很生动地进行想像。我们现在可以一起建立一些适合你自己的场景。”

“因为你很难进入想像的情境中, 看来那些不需要进行想像的治疗策略可能更适合于你。”

III. 建立想像场景

—— 7. 咨询者和求助者一起建立两种引发积极情感的场景, 并适合求助者的文化背景。

“现在我打算为你建立能引发平静、安宁和高兴的场景。这个场景要尽可能提供细节, 以使你能体验颜色、气味、温度、声音、姿势等, 之后我们将利用这些场景去替代焦虑。”

IV. 练习想像场景

—— 8. 咨询者指导求助者专心集

“选择一种场景, 闭上眼睛、坐下放

集中于场景大约 30 秒。

松；想像约 30 秒钟，要尽可能地想像出细节；当时间结束时，我会告诉你。”

—— 9. 经过紧张的训练之后，咨询者评价求助者的反应。

“让我们模拟某种问题情境，如当我拧你的手臂使你感觉到疼痛时，你要全力想像愉快场景。”

—— 10. 对于模拟的问题刺激，咨询者评价求助者的反应。

“感觉怎么样？”

“我给你的疼痛刺激对你的放松状态有什么影响？”

“你集中于想像场景而不受其他刺激影响的能力怎么样？”

V. 家庭作业和复诊

—— 11. 咨询者指导求助者在实际生活中应用想像法。

“做家庭作业时，要将想像场景应用于实际问题情境中。当你正体验情境时，要尽可能集中精力想像愉快的场景。”

—— 12. 咨询者指导求助者在工作记录簿上记录下想像的用法及不舒服或焦虑的水平(程度)。

“每一次做完想像作业后，要在日志簿上记录练习情况。并用 5 点量表，评估情境焦虑程度。”

—— 13. 咨询者安排定期复查。

“让我们两周以后再见面，我会检查你练习的情况。”

求助者评语：

内隐模仿法会谈检测清单

指导语：在角色扮演会谈中，确定咨询者表现出了下面所列引导语中的哪些引导语，在所表现出的引导语旁边画勾。清单中的右侧栏中列举了一些引导语样例。

项目	引导语举例
I. 基本原理	
_____ 1. 咨询者描述被指导想像的目的。	“在想像中能够应对了，在实际生活中的应对也就容易了。”
_____ 2. 咨询者介绍治疗程序概况。	“我们先要检查一下你的想像能力。”
_____ 3. 咨询者评估求助者的意愿。	“你觉得这个治疗程序怎么样？”
II. 练习场景	
_____ 4. 要求助者坐好、闭上眼睛、放松，准备进行场景想像。	“放松坐好，闭上双眼。”
_____ 5. 向求助者描述一个与目标无关的场景；当想像生动时，求助者要举手示意。	“尽可能集中精力和生动地进行想像。”
_____ 6. 让他睁开眼睛，描述想像中的情境。	“尽可能多地告诉我你的想像情况。”
_____ 7. 探询想像情境中的细节。	“想像中的颜色、气味怎样？你的感受怎样？”
_____ 8. 向求助者建议如何进一步注意细节。	“再来想像一次，这次不仅要注意颜色、气味，而且还要注意其他方面，如声音、味道等。”
_____ 9. 引入新的场景让求助者进行想像练习。	“让我们进行另一场景，我们将这样做一会儿直到你感到很舒服为止。”

—— 10. 场景练习后, 咨询者可做:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| —— a. 确定建立治疗场景; | “现在想像场景对你来说已经很容易了, 我们继续下一步吧。” |
| —— b. 确定是否需要进一步放松和场景练习; | “继续做之前, 先来做几次放松练习。” |
| —— c. 确定结束内隐想像法, 因为这个方法不适于该求助者。 | “从这个练习来看, 我们应当采用其他的治疗方法。” |

III. 建立治疗场景

—— 11. 确定治疗场景中的示范人物的特征:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| —— a. 其身份 (求助者自己或他人); | “你愿意想像自己还是其他人?” |
| —— b. 应对或控制模式; | “更容易想像那些做得不十分完满的人。” |
| —— c. 单个或多个示范人物; | “可以想像一个人, 也可以是多个人。” |
| —— d. 使示范人物在最大程度上与求助者相似。 | “想像中的人物要与你自己相似。” |

—— 12. 确定使用:

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| —— a. 个性化的场景; | “有两种选择, 一个是专门为你建立治疗场景, 或者使用标准化的场景。” |
| —— b. 标准化的场景。 | |

—— 13. 确定使用:

- | | |
|-----------------|---|
| —— a. 场景的一般性描述; | “有两种呈现方式。或者我做一般性描述, 你在想像中添加细节; 或者我给你描述得非常详细。” |
| —— b. 场景具体、细节的 | |

描述。

—— 14. 确定场景中的具体成份、
如:

—— a. 行为发生的情境;

—— b. 示范的行为和应对
技能;

—— c. 行为的积极结果,
如:

—— ① 有利于求助者
进行该行为;

—— ② 有利于求助者
自我强化。

—— 15. 建立多种治疗场景。

IV. 应用治疗场景

—— 16. 将多种治疗场景排序, 根
据:

—— a. 求助者感觉不舒服
的程度;

—— b. 情境的难度和复杂
性。

—— 17. 呈现场景前, 要指示求助
者:

“我们来决定每个场景将出现那些事情。”

“在你求职会谈场景中, 仔细考虑以下你要申请的工作类型, 以及什么样的雇主很难对付。”

“现在, 你在这个情境中要做事情, 是与雇主平静地谈论你的既往史, 解释所发生的事情, 并要强调你的既往史是不会干扰将来的工作表现的。”

“想像结束时, 你应该学会目标行为。”

“要表扬自己学会了目标行为。”

“现在我们针对其他治疗目标建立更多的治疗场景。”

“现在我希望你能运用我的已经建立好的六种场景, 并按程序把它们安排好, 从你感到最舒服的情况下开始, 这样对你而言更容易讨论, 到使你感到最困难并给你最不舒服或焦虑的场景结束。”

“我将要告诉你当向你描述情境的时候需要做的事情。”

- _____ a. 坐好、放松、闭上眼睛； “首先坐下来，闭上眼睛放松自己。”
- _____ b. 想像的对象； “现在想像一下你在想像情境中将要遇到的人。”
- _____ c. 用多种感官全力进行想像； “当我描述场景的时候，尽可能逼真地想像这种情境，运用你的所有感官——视觉、嗅觉、触觉等。”
- _____ d. 想像生动后，举手示意； “当你想像到这种逼真的情境时，可以竖起食指示意。”
- _____ e. 保持想像，直到咨询者示意停止。 “尽量去保持想像的情境，直到我告诉你可以停止为止。”
- _____ 18. 每次呈现一个场景（口头或录音机）。 “以下是第一个情境，当雇主询问你为什么在学校名次这么靠后时，想像你正在用平静的声音向他做出解释。”
- _____ 19. 场景呈现的时间长短要根据求助者的情况来确定，通常要使示范人物完成目标行为（20 - 30 秒）。 “你应尽可能在想向中解释你的成绩，直到我示意你停止。”
- _____ 20. 完成一个场景后，要让求助者评估：
 - _____ a. 场景的呈现时间和呈现频率是否合适； “你想像的情境能持续多长时间。”
 - _____ b. 想像的清晰度和生动程度； “你想像的情境有多强烈，你是如何想像的呢？”
 - _____ c. 场景的愉快程度。 “当你想像情境的时候有什么感觉？”

—— 21. 根据求助者的评估, 咨询者要做:

- a. 再次呈现该场景;
- b. 修改场景或改变呈现方式;
- c. 改变场景等级顺序;
- d. 先进行放松场景的呈现。

“我将把这个情境再次复述给你。”

“根据你已经说的, 让我们变换一下雇主, 并且给你更多的时间去想像情境。”

“或许我们需要改变一下想像中情境的顺序, 换一个开头。”

“让我们来讨论一下关于您的紧张不适。”

—— 22. 增进场景想象的技术

- a. 用自己的言语总结;
- b. 根据个人情况补充治疗场景。

“你可以采用自己的语言描述情境, 这可以帮助你记住在想像中需要做的事情。”

“你可以采用任何方式来改变情节或使情节更加丰富, 只要能够想像到你应当做到的角色。”

—— 23. 每个场景至少呈现两次。

“好, 下面我将把情境再给你描述一次或两次。”

—— 24. 求助者要以自我引导的方式至少练习两次。

“这次我希望你在想像情境的时候自己描述给自己, 而不要受我的影响。”

—— 25. 完成场景等级的呈现后, 咨询者还要随机呈现其中的某些场景。

“现在我将随意挑选一个情节, 在你想像的同时描述给你听”

V. 家庭作业

—— 26. 指导求助者在日常生活情境中进行练习, 并解释日

“在这个星期里, 我希望你能够拿起那些我们已经写下的曾经训练过的

常练习的目的。

情境,自己训练自己展开想像,这将帮助你更加迅速而且容易地掌握这种方法。”

____ 27. 家庭作业包括:

_____ a. 做什么;

“回顾一下情境——尽可能清晰真实地展开想像。”

_____ b. 做的频率;

“每天回顾这些情境 5 次。”

_____ c. 何时、何地去做;

“每天在家安排情境想像 2 次,在学校安排 3 次。”

_____ d. 家庭作业的自我观察法。

“每次回顾情境后,在记事本上做个标记,并且在每次正规训练结束后,自己在刻度上写下想像情境的强烈程度。”

____ 28. 安排复诊时间。

“下周拿着那些记录来,我们可以讨论一下你的训练情况,并且可以看到下一步我们需要做的事情。”

求助者评语:

参考文献

- Achterberg, J. (1985). *Imagery in healing: Shamanism and modern medicine*. Boston: Shambhala.
- Andrada, P., & Korte, A. (1993). *En aquellas tiempos: A reminiscing group with Hispanic elderly*. *Journal of Gerontological Social Work*, 20, 25-42.
- Baider, L., Uziely, B., & Kaplan-DeNour, A. (1994). Progres-

- sive muscle relaxation and guided imagery in cancer patients. *General Hospital Psychiatry*, 16, 340–347.
- Beck, J. S. (1995). *Cognitive therapy: Basics and beyond*. New York: Guilford.
- Brigham, D. (1994). *Imagery for getting well*. New York: Norton.
- Brown, J. C. (1990). Loss and grief: An overview and guided imagery intervention model. *Journal of Mental Health Counseling*, 12, 434–445.
- Cohen, R. E., Creticso, P. S., & Norman, P. S. (1993–1994). The effects of guided imagery (GI) on allergic subjects' responses to ragweed-pollen nasal challenge: An exploratory investigation. *Imagination, Cognition and Personality*, 13, 259–269.
- Fernandez, D., & Allen, G. J. (1989). Test anxiety, emotional responding under guided imagery, and self-talk during an academic examination. *Anxiety Research*, 2, 15–26.
- Fezler, W. (1989). *Creative imagery: How to visualize in all five senses*. New York: Simon & Schuster.
- Iacqua, G. E. (1994). Migraine headaches: Coping efficacy of guided imagery training. *Headache*, 34, 99–102.
- Lazarus, A. (1984). *In the mind's eye: The power of imagery for personal enrichment*. New York: Guilford.
- Lindh, R. (1987). Suggestive covert modeling as a method with disturbed pupils. *Jyvaskyla Studies in Education, Psychology and Social Research*, 60, 1–194.
- Myrick, R. D., & Myrick, L. S. (1993). Guided imagery: From mystical to practical. Special Issue: Counseling and children's play. *Elementary School Guidance and Counseling*, 28, 62–70.
- Overholser, J. C. (1991). The use of guided imagery in psychotherapy: Modules for use with passive relaxation training. *Journal of Contemporary Psychotherapy*, 21, 159–172.

- Rosenthal, T. (1993). To soothe the savage beast. *Behaviour Research and Therapy*, 31, 439–462.
- Sheikh, A. A. (Ed.). (1986). *Anthology of imagery techniques*. Milwaukee, WI: American Imagery Institute.
- Simonton, O. C., & Hensen, R. (1992). *The healing journey*. New York: Bantam.
- Suinn, R. (1986). *Seven steps to peak performance: The mental training manual for athletes*. Lewiston, NY: Huber.
- Uhlemann, M. R., & Koehn, C. V. (1989). Effects of covert and overt modeling on the communication of empathy. *Canadian Journal of Counselling*, 23, 372–381.
- Wynd, C. A. (1992). Personal power imagery and relaxation techniques used in smoking cessation programs. *American Journal of Health Promotion*, 6, 184–189, 196.

学习评判反馈

第一部分

1. 建议求助者建立想像情境，用以阻断那些不愉快的情感。
2. 家庭作业的一部分——在实际生活中进行想像。
3. 基本原理——让求助者了解使用引导想像法的理由。
4. 评估求助者进行想像的潜力。
5. 想像场景练习——与一个问题情境同时进行。
6. 基本原理——让求助者了解整个治疗过程。
7. 想像情境练习——求助者练习情境想像，然后再在模拟的情境中使用这些场景。

第二部分

用引导想像法检测清单评估自己的表现。

第三部分

基本原理

首先你给黄先生解释内隐模仿法和它的主要过程。

练习场景

然后再给他呈现几个无关的场景，进行练习。

建立治疗场景

和黄先生一起讨论治疗场景中的几项内容。要包括行为发生的情境、目标行为和应对技能，以及行为的积极结果。

应用治疗场景

将治疗场景排列成场景等级，逐一练习。最后要随机选取其中的几个进行想像练习。

家庭作业

你要建议黄先生每天坚持情境想像练习，并安排好复诊的时间。

第四部分

根据内隐模仿法检测清单，评估自己的咨询会谈。

第十四章 认知示范和问题解决

大部分认知治疗体系都强调，改变外显行为与改变认知、情感等内隐行为同样重要。近些年来，人们努力去建构各种调整求助者思维、心境、情绪、态度和信念的治疗和评估程序。所有这些程序都被归纳为认知治疗法或认知行为矫正法。认知矫正法有两种基本假设：一是人们的思想和信念对他们的适应不良行为有作用；二是通过改变人的信念、态度或思维，便能改变他们的适应不良行为。很多时候，求助者不切实际的自我标准和自我否定思想会降低治疗的作用。了解求助者对咨询的信念和期望对于成功的治疗相当重要。

本章提出两种认知改变程序：认知示范和自我指导训练法、问题解决法。第十五章将描述认知重建法，第十六章提出应激预防和再构法，而第十七章讲述的冥想法则是调整认知的另一种程序。所有这些治疗程序都被用来消除所谓的“认知污染”。

本章目标

1. 针对模拟案例，描述你怎样应用认知示范和自我指导训练法的七个组成部分。
2. 用角色扮演法，演示 21 步认知自我引导示范法中的 16 个步骤，并使用本章后面的认知示范会谈检测清单评估自己的表现。
3. 在列出的咨询者 10 种反应中，辨别出其中所包含的问题解决策略，要至少准确地识别出其中的 8 种。
4. 在角色扮演会谈中，演示 19 步问题解决程序中的 16 个步骤，并使用问题解决会谈检测清单评估自己的表现。

认知示范和认知自我指导训练法

认知示范法是这样一种程序，咨询者一边执行一项任务，一边向求助者显示他们怎样与自己进行对话。认知示范和自我指导训练法被应用于各种求助者。表14-1列出了有关认知示范和自我指导训练法的一些研究，其应用范围包括：注意力缺失或多动症儿童；进行心脏导管手术过程中，控制求助者的恐惧和敌意；学校咨询中，帮助学习困难学生；促进问题解决能力；提高自我效能感；减少老师的焦虑，并增加其控制知觉；减低九年级女生的考试焦虑和紧张；进行训练和管理等。其中只有一例与认知治疗的跨文化应用有关，即 Hains 使用自我指导认知示范法，教授黑人、白人和西班牙男性少年犯掌握控制愤怒的技巧。训练后，有75%的参加者在面对激惹事件和人际关系的矛盾时，能够使用自我指导和向前思考的方式进行自我控制。

表 14-1 认知示范及自我引导训练法研究领域举例

注意力缺失，多动症	愤怒，敌意
学校咨询	学习困难
问题解决	自我效能
教学	考试焦虑
训练及指导	

使用自我指导训练策略的认知示范包括五个步骤：

1. 咨询者首先进行示范（或使用符号性示范）：执行任务的同时大声地与自己交谈。
2. 求助者按照示范执行同样的任务，咨询者要在一旁大声地指导求助者。

3. 让求助者再次执行同样的任务，同时大声地指导自己。
4. 求助者执行任务时低声地进行自我指导。
5. 最后，求助者执行任务时不出声地指导自己。

上述第一步主要是进行认知示范，而第二步到第五步则主要是求助者在执行任务时练习自我指导语。求助者的自我指导语要逐渐减弱，从大声到不出声。

我们建议使用下述七个指导步骤，来补充认知示范和自我指导训练：

1. 关于训练的基本原理。
 2. 执行任务和自我指导的认知示范。
- 求助者的练习从下面开始。

3. 出声的外部指导。
4. 出声的自我指导。
5. 声音明显减弱的自我指导。
6. 不出声的自我指导。
7. 家庭作业和复诊。

我们将进一步解释这些步骤，另外在本章末的认知示范会谈检测清单中亦列出了详细解释。

认知示范治疗基本原理

下面即是一个咨询者解释认知示范法基本原理的例子：

人们发现，有些人在执行某种特殊任务时会感到非常困难。通常困难的出现并不是因为他们不具备能力，而是在于他们执行任务时自我语言或内心思想的干扰。换句话说，一个人的“自语”能阻碍或干扰行动。例如，当你进行演讲时，你想到“我是多么笨拙”，这种思想就会影响你的讲演。而认知示范法则可通过检查和提出某些有帮助的计划或自我指导语，帮助你在执行任务时按照恰当的方式做事（基本原理）。

我将先演示一下在执行任务时我对自己说什么，然后我会让你在的指导下完成同样的任务。再后，你将大声地指导自己重复做这项工作。最后，你要做到在完成任务的同时进行自我思考和计划（综述基本原理）。你明白了吗？（征询求助者意愿）。

讲述基本原理、并阐明一些问题后，咨询者就可以开始进行认知示范。

任务示范和自我指导

首先要让求助者注意，咨询者在执行某项任务时对自己说了些什么；然后，咨询者开始示范，并在执行任务的同时大声地对自己说话。

咨询者示范要回答的问题：

1. 必须做什么？
2. 用计划表的形式回答必须做什么。
3. 自我指导和集中注意力。
4. 自我强化。
5. 用错误纠正选项应对自我评价陈述。

咨询者自我指导语：

1. “我必须做什么？”
2. “你想让我用不同的线条复制这幅画。”
3. “我必须慢慢地做。向下画线，向下，好；然后往右边，现在下面还有一些，到左边。”
4. “好，即使有错误，我仍可以继续慢慢地仔细做。好，现在我必须做下去。”
“完成了，我做完了。”
5. “现在，再做些加工。不，我想应朝下。很好，现在仔细擦去这些线条。”

这个例子显示,咨询者示范和自我言语指导都应包括五部分。示范的第一部分是对所要完成的任务性质和要求用言语提出问题。提出问题的目的是补充、完善对任务的理解,并且提出完成任务的一般方向,以及建立一个认知定势。示范的第二部分是用言语回答上面的提问。答案要能够显示完成任务的认知计划过程,以使求助者的注意力集中在任务要求上。在执行任务时的自我指导是示范中的第三部分。自我指导的目的在于促进注意力,并抑制任何可能存在的外显或内隐分心或干扰。自我强化是示范过程的第四部分,用于坚持完成任务和促进成功。自我言语指导的最后一个部分包括应对错误和挫折的自我陈述语句。换句话说,在示范过程中执行任务时出现错误,咨询者马上纠正它,并没有停止示范。试试看你能否在学习练习活动41中辨别出自我指导示范法的这五个组成部分。

学习练习活动 41 / 自我指导示范法

下面是咨询者用言语表达的认知示范,来为一个学习使用轮椅的残疾人进行康复练习。在他的讲话中识别出下面五个部分: 1) “做什么”的问题; 2) 用计划形式回答这个问题; 3) 自我指导; 4) 应对自我评价陈述; 5) 自我强化。答案见学习活动反馈41。

“从停车场经过人行道,再进入大楼,我都必须做什么? 我必须将轮椅转到路边,推上马路沿儿,然后再在人行道上推行一段,最后进入大楼入口。将轮椅推到路边没有问题。现在我必须小心,我处在马路沿儿边。我必须先抬高前轮,它们上去了。现在我必须用力使我的后轮也上去。哟,不行。但没什么,我将再次用力。很好,现在我将轮椅推上了人行道。我做到了。”

出声的外部指导

在咨询者作了示范之后，要教会求助者如何执行任务（象咨询者示范的那样），同时给予辅导。咨询者在求助者执行任务过程中的指导语要用人称代词“你”来代替“我”（例如，‘那…对你意味着什么？你必须转动你的椅子…，你需要仔细’）。咨询者要确信指导语中包括了自我指导法的五个部分：问题、计划、集中注意、应对自我评价、和自我强化。有时在现实生活情境中，求助者执行任务时可能有另外的人观看——就好象求助者坐在轮椅中出现在公众面前。如果他人的存在干扰了求助者，咨询者可以对他说：“这些人可能令你分心，但不要理会他们，只须注意你自己正在做的事情。”为了使这个步骤与求助者实际遭遇的情境相似，咨询者在进行出声的外部指导时，应包括这类应对陈述语。

出声的自我指导

咨询者下一步要教会求助者在执行任务的同时大声地指导自己。这个步骤的目的是让求助者练习自我交谈，以便加强对任务要求的专注，使分心减到最小。咨询者要仔细注意求助者自语的内容。同前面的两个步骤一样，自语步骤也应当包括五个组成部分。还要鼓励求助者使用自己的语言。如果求助者的自我指导不完整或卡住了，咨询者可以插话进行辅导。必要的话，咨询者可返回到前面的步骤——或者再次进行示范，或者给予出声的外部指导。当求助者完成这个步骤之后，咨询者要提供反馈，告诉求助者哪些部分完成得很好，哪些部分还有错误或遗漏。在转到下一步骤（低声的自我指导）之前，也许有必要再进行一遍出声的自我指导练习。

低声的自我指导

求助者在这一步骤只低声进行自我指导（只见嘴唇活动）。这是一个中间步骤，介于求助者大声自语和默默自语之间。换句话说，低声自我指导是求助者接近最后成功（即执行任务时默想自我指导语）的一种途径。经验表明，咨询者需要对那些因低声自语而犹豫不决的求助者做进一步解释。若求助者认为低声自语步骤无关紧要或令人讨厌，则可以在重复若干次出声的自我指导后，直接转到内隐自我指导步骤。若求助者完成这个步骤有困难或遗漏了部分内容，则需要在转到下一步之前再次进行练习。

学习活动反馈 41 / 自我指导示范法

问题：“从停车场经过人行道，再进入大楼，我都必须做什么？”
用计划回答问题：“我必须将轮椅转到路边，推上马路沿儿，然后再在人行道上推行一段，最后进入大楼入口。”

自我指导和集中注意力：“将轮椅推到路边没有问题。现在我必须小心，我处在马路沿儿边。我必须先抬高前轮，它们上去了。现在我必须用力使我的后轮也上去。”

应对自我评价和错误纠正：“哟，不行。但没什么，我将再次用力。”

自我强化：“好，很好，现在我使轮椅上了人行道。我做到了。”

不出声的自我指导

在最后一个步骤，求助者要在执行任务的同时内隐地或“在自己的头脑中”进行自我指导。求助者进行内隐指导练习很重要。练习之后，咨询者要让求助者描述出内隐自我指导的内容。如果发现其中有分心或抑制自我交谈的情况，咨询者要提出更恰当的

指导语，然后再一次进行练习。如果求助者这个步骤的练习完成得很好，就表明他已经可以在家里自己练习了。

家庭作业和复诊

家庭作业非常重要，它对于求助者将在咨询会谈中所学会的技巧扩展到现实环境中很有益处。治疗者应当指导求助者如何在没有咨询者辅导情况下，使用内隐自我指导策略独自完成目标行为。家庭作业应详细说明求助者将做什么、做多少、何时做等。咨询者还应提供某种方法促使求助者监督和奖励自己完成家庭作业。检查家庭作业完成情况的复诊预约也应事先计划好。

在下面的对话中，我们将用求助者 Joan 的个案，具体演示认知示范法的七个组成部分。个案中使用认知示范策略的目的在于帮助 Joan 更积极地参与数学课讨论。

示范对话：认知示范和认知自我指导训练

在对话 1 中，咨询者首先介绍认知示范方法帮助 Joan 在数学课上学会讨论技巧的可能性。咨询者正在讲解认知示范策略的基本原理：

1. 咨询者：我们的目标之一是帮助你提高在数学课上的参与水平。治疗方法之一是，我先演示你要做的各种事，同时演示在完成这些任务时如何进行自我思考、自我谈话。这种程序将会帮助你制定一个如何完成任务及如何培养参与技巧的计划。你觉得怎么样？

求助者：这很难吗？

在对话 2 中，咨询者讲述有关治疗程序的概况，这也是基本原理的一个部分。

2. 咨询者：不，并不很难。我会在你做之前进行演示，并且在你练习时一直在旁边指导。这个过程包括：我演示参与

数学课的方法，同时我会大声地对自己讲话，以指导自己的参与行为。然后，你来进行练习。我们会逐步进行同样的参与练习，直到你能独立地靠自我思考来完成任务。我们一次只进行一个步骤，你清楚了吗？

求助者：好，明白了，尽管我从来没有这样做过。

在对话3中，咨询者考察并确定Joan进行治疗程序的意愿。

3. 咨询者：你愿意试一下吗？

求助者：当然，我愿意。

在对话4、5中，咨询者设置任务和相伴随的自我指导语，并告诉求助者在该步骤中咨询者将做些什么，以及她需要注意哪些方面。

4. 咨询者：我们提到过，你至少可以做四件事来增加你参与的技巧：只请求老师给予解释；回答老师更多的问题；走到黑板前解题；主动回答问题。让我们从中挑选一个。你喜欢从哪件事开始？

求助者：走到黑板前做代数题。如果我做错了，所有的同学都能看到。

5. 咨询者：当你走向黑板时，可能有点紧张。治疗过程将帮助你把更多的注意力集中在解题，而不是自己身上。作为第一步，我现在假装正在走向黑板。当我离开座位向黑板走时，我将说出我正想什么，这会帮助我解决问题。请仔细看和听，因为我将要求你做同样的事，有什么问题吗？

求助者：没有，我正等着看你将怎样演示。我会像老师一样看着你，他的眼镜总是架在鼻尖上，他直直地盯着你，使你失去勇气。

在对话6、7中，咨询者开始演示怎样在执行任务的同时进行言语自我指导。在对话7中，要注意自我指导过程的五个组成部分，还要注意举例时所选择一个简单的算术问题。

6. 咨询者：好，你就扮演老师，它使你有真实感。现在就叫我的名字，让我走到黑板前吧。

求助者（作为教师）：Joan，现在到黑板前做这个题。

7. 咨询者（离开座位，走到想像的黑板前，拿起粉笔，大声地说出）：我需要做什么呢？老师想让我求 Y 。好，我要慢慢地、仔细做，不要着急。问题是 $4X + Y = 10$ ， $X = 2.8$ 。好，我可以用 X 求出 Y （咨询者问有关任务的问题）。好，到目前为止，我做得很好。记住，要慢慢做。 $Y = 10 - 4X$ ，如果 X 是 2.8，那么 Y 就等于 $10 - 4 \times 2.8$ （咨询者使用集中注意力及自我指导）。让我看， $4 \times 2.8 = 10.2$ ，哎哟，对吗？我听到一些人在笑。继续做，让我重新计算一遍。不，结果应是 11.2。擦去 10.2，并填入 $Y = 10 - 11.2$ 。好，很好，如果我继续慢慢做，我能找到任何错误，并进行纠正（咨询者使用应对自我评价及纠正错误）。现在问题很容易， $10 - 11.2 = -1.2$ ， $Y = -1.2$ 。好，我完成了，现在我可以返回座位了（咨询者使用自我强化）。

在对话 8、9 中，咨询者开始进行出声的外部指导：求助者执行任务时，咨询者持续用语言大声地做自我指导，不过指导语中的代词要用“你”代替“我”。

8. 咨询者：对，就是这样。现在，让我们转换一下角色。这次是你离开座位，走到黑板前回答问题。而我将辅导你在完成任务过程中怎样做出计划，好吗？

求助者：我要说些什么吗？

9. 咨询者：这次不需要。你只需集中注意力以完成任务。换句话说，第一次我将告诉你怎样去做。

求助者：好的，我明白了。

在对话 10 中，在求助者解题的同时，咨询者用语言进行指导。

10. 咨询者：好，我扮演老师，我要你走到黑板前，然后，我

将开始辅导你（作为教师）。Joan, 现在你走到黑板前, 解出这个题目: 如果 $2X + Y = 8$, $X = 2$, Y 等于多少? (Joan 从座位上站起来, 走到想像的黑板前, 拿起粉笔, 像咨询者一样)。好, 首先你在黑板上写出题目, $2X + Y = 8$, $X = 2$, 现在问自己“我将怎样做这个题目? ”。好, 现在给自己答案（提问）。

你需要去求 Y 的值（回答问题）。好, 慢慢做, 要仔细, 将注意力集中于你正在做的。你知道, $X = 2$, 因此你能用 X 来求出 Y 。你的第一步是做减法: $8 - 2X$ 。你完成得很好, 一继续慢慢地做（集中注意力和使用自我指导）。

你知道 $8 - 2 \times 2 = 8 - 4$, 有人正在笑你。但你做得很好, 继续思考你正在做的, $8 - 4 = 4$, 因此 $Y = 4$ （应对自我评价）。

现在你求出了 Y , 很顺利。你完成了, 现在你可以回到你的座位上（自我强化）。

在对话 11 中, 在做下一步之前, 咨询者要对求助者的反应进行评价。

11. 咨询者: 好, 我们暂停一下。你对这些有什么想法?

求助者: 不错, 它对我是一件新鲜事。我明白它能怎样帮助我。通常当我走到黑板前, 我不是思考问题, 而是常想着自己的紧张表情, 或想着老师及其他同学正看着我。

在对话 12 中, 咨询者重申认知示范程序的基本原理。

12. 咨询者: 是的, 这种思想分散了你解数学题的注意力。这就是为什么这种治疗程序能帮助你, 它使你有机会将注意力集中于你想做的事。

求助者: 我明白。

在对话 13 和 14 中, 咨询者告诉求助者, 在执行任务的同时大声地对自己讲话（出声的自我指导）。

13. 咨询者: 这次我想让你完成我们刚才所做的, 但只靠你自

己。换句话说，你将从座位上起来，走到黑板前，做数学题。像你正在做的那样，计划你将做什么和怎样去做它。告诉你自己，不要着急，集中注意力于你正在做的事情。当你完成任务后，轻轻敲自己一下。你明白了吗？

求助者：好，我将说一些与你上次所讲的相似的话，是吗？

14. 咨询者：是的，但你不必使用相同的话。只要试着计划你将做什么。如果你卡住了，我会提示你。记住，开始时你一定要问自己在这个情境中想做什么，并给出回答。这次的题目是： $5X+Y=10$ ， $X=2.5$ ，求 Y 。

求助者（离开座位，走到黑板前，写下问题）：我需要做什么？我需求 Y ，我知道 $X=2.5$ 。只考虑这个题目。第一步是做减法 $10-5X$ 。而 $5 \times 2.5=12.5$ ，因此我将做减法 $10-12.5$ 。（咨询者笑，Joan 回转身）做错了吗？

咨询者：自己检查，但要保持注意力于这个题目上，不要理睬我的笑。

求助者：好， $10-12.5$ 是 -2.5 ， $Y=-2.5$ ，让我看，如果它是正确的，那么 $5 \times 2.5-2.5=12.5-2.5=10$ ，我做完了。

在对话 15 中，咨询者对 Joan 的练习给予反馈。

15. 咨询者：相当好，你只错了一次——当我发笑时。我之所以笑，是想知道你当时注意力是否集中。但后来，你又回到自己的工作，并解出了这个题目。对你来说做这个题目似乎相当容易。你感觉这样？

求助者：它确实比我想的容易。当你笑时，我很吃惊。但后来，像你所说的，我试着继续做下去。

在对话 16、17 中，咨询者指导 Joan 怎样在执行任务的同时，对自己进行低声自语（低声的自我指导）。

16. 咨询者：这次我们将做另一个练习。整个过程与上次相同，只有一个改变。即你在做计划时，不要大声地说出来，而

是低声地对自己讲。也许你可能不习惯对自己耳语，所以开始时可能有点笨拙。

求助者（笑）：对自己耳语？确实有点滑稽。

17. 咨询者：我知道。但它只是帮助你的一步骤，通过这些练习，你将变得更加自然和放松地做事。

求助者：好，我想我明白了。

18. 咨询者：那么我们来试试吧。这次我们解决一个长一些的小数题，因为你已经能够解决小数题了。它似乎难一些，但不要着急，慢慢地思考。问题是： $10.5X + Y = 25$ ， $X = 5.5$ ，求 Y 。

求助者（离开座位，走到黑板前，写下问题，耳语）：好，我需要做什么？我需求 Y ，这次有许多小数，因此我需要更加仔细。让我来看看，我要先做 $25 - 10.5X$ 。 10.5×5.5 ，我想它的得数是 52.75。（咨询者笑）我想我只需考虑我正在做的事情。让我重做一遍。不，得数应是 57.75。对吗？我最好再检查一次，对了。继续做， $25 - 57.75 = -32.75$ 。因此 $Y = -32.75$ 。我可以再检查一遍。是的，我做对了！

咨询者在对话 19 中给 Joan 的反馈：

19. 咨询者：很好，Joan —— 非常顺利。我笑时，你只是重做了一次，而不是转过身来，让你的思想离开问题。

求助者：好像每做一次都变得更容易了。事实上，这也是学习数学的一个好办法。

在对话 20、21 中，咨询者指导 Joan 在解数学题时如何同时不出声地指导自己（内隐自我指导）。

20. 咨询者：是的。不仅现在做是这样，当你做数学作业时也是这样。现在，让我们完成进一步的练习。你确实做得相当好。这次我想让你做相同的事，只是这次你要默想着完成这个题目。换句话说，你不要说出指导语，而只是在

头脑里想它们。你清楚了吗？

求助者：你让我只想着对自己说什么？

21. 咨询者：是，只在你的头脑中指导自己。让我们做下面这个题目： $12X - Y = 36$ ， $X = 4$ ，求 Y 。（Joan 离开，走到黑板前，花了几分钟做完这个题目。）

在对话22中，咨询者要求求助者描述出在内隐自我指导练习中所发生的事。

22. 咨询者：你能告诉我当你做题时想到了些什么吗？

求助者：好，我想到我必须做的事情，然后我第一步应做什么，然后经过解决问题的每一步之后，又检查了一遍。最后，我想我是对的。

学习练习活动 42 / 认知示范和认知自我指导训练

回想 Weare 女士和 Freddie 的个案（见第八章）。Weare 女士希望停止每天早晨给 Freddie 的各种帮助。她关心的事是找到一个指导 Freddie 养成新习惯的方法，使她不用再帮助 Freddie 穿衣服，不用再提醒他汽车只有几分钟就要开来了等。但 Weare 女士担心，当她让 Freddie 这样做之后，Freddie 会生气或反驳她；她担心自己将不能把计划坚持到底，或不能严格执行这些规矩。

(a) 描述你将怎样使用认知示范和自我指导训练法的七个主要组成部分来帮助 Weare 女士达到上述目的。

(b) 写出一个 Weare 女士可以用来完成任务的认知示范对话例子，确信对话中包含了自我指导程序的五个主要部分：提问，回答，集中注意，自我评价，自我强化。答案见学习活动反馈 42。

在对话23中，咨询者要进行检查，看看是否需要重复做练习，或者可以转到去做家庭作业。

23. 咨询者：它似乎相当容易。这就是我想让你在课堂上做的——当你在黑板前做题目时，要像这次这样，在头脑中暗暗地指导自己。你愿意在这里多做一次这样的练习，还是本周内你自己在家里独立完成？

求助者：我想我自己现在可以进行独立练习。

在对话 24 中，咨询者布置了 Joan 下一周的家庭作业。

24. 咨询者：好，我想如果你本周内自己做做这类练习是会有帮助的——一边做数学题，一边指导自己。

求助者：你指的是我的数学家庭作业？

在对话 25 中，咨询者要指导 Joan 怎样做家庭作业，包括做什么？在哪里做？做多少？等等。

25. 咨询者：好，从数学家庭作业开始，这很好。你每天做七道题。每做一道题，都要在头脑中进行这些自我指导练习（在家做）。清楚了吗？

求助者：是的，每天我将用今天的练习方法完成七道数学题。

在对话 26 中，咨询者指导 Joan 观察她自己的家庭作业完成情况，并记在日记本上。

26. 咨询者：好，还有一件事。在日记本上记录每天完成数学题时，你进行这种练习的次数。这将帮助你了解自己练习的连续性。下周我们见面时，把你的日记本带来，我们一起检查你的家庭作业。

学习活动反馈 42 / 认知示范和认知自我指导训练

A. 七个组成部分的描述

1. 基本原理：首先向 Weare 女士解释认知示范法会帮助她管教 Freddie，以及这个程序都包括了哪些内容。

2. 任务示范和自我指导：你将为 Weare 女士示范一种教育 Freddie 的方法。你要确信对话内容与 Weare 女士生活有关，并能为她所接受。示范将包括任务和自我指导程序的五个部分。
3. 出声的外部指导：Weare 女士练习给 Freddie 的指导，同时你在自我指导过程中辅导她。
4. 出声的自我指导：Weare 女士在完成这些指导同时，用语言大声表达出自我指导程序的五个部分。如果她卡住或遗漏了五个部分中的任何一个，你可以提示她。重复练习几次。
5. 声音减弱的自我指导：假定 Weare 女士愿意完成这个步骤，她将以低声自语的方式完成给 Freddie 的指导。
6. 内隐式自我指导：Weare 女士练习给 Freddie 的指导，同时不出声地指导自己。当她能轻松地完成这个练习时，你就可以给她布置家庭作业。
7. 家庭作业：家庭作业要求 Weare 女士每日练习这些内隐自我指导，同时安排完成作业后的复诊。

B. 示范对话的例子

“我在这个情境中要做什么（提问）？我想告诉 Freddie，他要靠自己起床、穿衣服，即使公共汽车要来时，我也不再去帮他（回答）。好，要记住做一个深呼吸，看着 Freddie，坚定地、慢慢地说：‘Freddie，我将不会在早上帮助你，我有自己的事要做，如果你想准时到学校，你必须下定决心准备自己做事情’（集中注意力和自我指导）。现在如果他向我发火，我要保持冷静和坚定，我不能回头（应对的自我评价）。一切都会是好的，我能处理它（自我强化）。”

问题解决疗法

问题解决疗法或问题解决训练出现于 20 世纪 60 年代后期和 70 年代初期,是为提高人们在某些特殊情境下的竞争力而采取的干预和预防策略。D'Zurilla 把问题解决定义为一种“认知—情感—行为过程,个体(或群体)通过这一过程来尝试识别、发现或创造应付、处理日常生活中各种问题的有效手段”。Rose 和 LeCroy 把问题解决描述为一种策略,“求助者通过这种策略学会如何系统地、一步步地完成分析问题、发现新方法以及评估这些方法的步骤,并掌握在现实生活中运用这些方法的策略”、问题解决治疗或训练可以作为一种治疗策略,一种疗效维持策略,或一种预防策略,它已经应用于儿童、青少年和成人。问题解决可以单独使用,也可以结合本书讲述的其他治疗策略一同使用。

表 14-2 显示,问题解决治疗法能够有效地应用于广泛的领域。它对住院病人、有攻击行为的男青年、癌症求助者、问题家庭、有学习和行为问题的儿童,以及单身父母都有帮助作用。它

表 14-2 问题解决的有关研究

研究领域	
青少年	攻击性男孩
行为问题	癌症
儿童各种问题解决	交际、沟通行为
决策冲突解决	抑郁
节食自控	家庭
健康	人际依赖
学习与行为问题	婚姻治疗
智力落后	父母方式
单亲父母行为	解决方法的有效性
应激控制	药物滥用
担心	

还成功地提高了求助者在人际交流、饮食控制、冲突解决、应激应付等方面的技巧，并增强了这些技巧的应用效果。通过问题解决治疗，求助者能够降低抑郁，减少对健康的抱怨和过高期望，不再过分依赖他人，停止药物滥用和焦虑。

Heppner建构了一个解决问题测问卷，它包括这样几个量表：解决问题自信度（即在从事问题解决活动时的自我肯定度）；问题解决的倾向（趋向或回避）性；以及在解决问题时相信能够控制自己行为和情绪的程度。D'urilla和Nezu也建构了一个着重于解决社会问题的测量表。

对于问题解决的知觉和态度既可以起促进作用，也可以起破坏作用。当感觉和态度促进问题解决时，求助者有动机去学习和进行问题解决行为。而那些没有动机或回避解决问题的求助者，他们对问题解决的知觉和态度妨碍他们学习问题解决的策略。对于这些人，治疗者首先要帮助他们调整自己的知觉和态度，治疗者还可以帮助他们参与一些能够促进问题解决的有效应对活动或行为。调整知觉、态度和情绪的活动表明，问题解决训练或治疗远远不只是一种智力练习活动。

许多求助者宁愿忽视或回避问题，因为他们相信问题可能自己会消失。尽管一些问题可能会消失，但另外一些问题则不会消失，即使你忽视或回避它们。事实上，如果求助者没有解决最初的困难，问题可能会变得更糟或带来更多的問題。治疗者的作用就是要通过改变求助者对于这些问题的态度和知觉，来帮助求助者承担起解决问题的责任，并投入时间和精力来解决这些问题。

问题解决的跨文化应用

本书中我们描述的所有干预策略中，问题解决是被广泛地应用于不同的文化群体的策略之一。我们猜想其中部分原因在于，

它是一种关注于直接行动及其可观察结果的策略。问题解决主要在下面几个领域被应用于各种文化群体，如取得学习成绩和学术成就的技巧、应付技巧和冲突控制技巧的培养；另外，作为各种预防计划的组成部分，问题解决也被用于预防艾滋病、吸烟、和暴力（参阅表 14-3）。

表 14-3 问题解决的跨文化研究

研究领域	
培养学习能力	培养应对技能
促进内部冲突控制能力	
艾滋病预防	预防吸烟
预防暴力	

Armour-Thomas、Bruno 和 Allen 在一项研究高中学生（其中有 77 名美国黑人和 30 名美国拉丁人）的研究中，考察了学生解决学业问题情境中的高元思维特点。他们发现，这些学生在解决学业（特别数学）问题时，做计划和进行监督是问题解决中的主要组成部分。Pollard 的一项研究显示，在学校中学习成绩好的黑人学生比那些不太好的同学更多地使用有效的问题解决策略。

下面的两项研究特别考察了与文化相关的问题解决过程。Bell、Brown 和 Bryant 的研究比较了 195 名非裔美国大学生在讲演时问题解决的表现。有些学生参与传统、分析式的口头介绍工作，另外一些学生则参与文化相关、整体式的口头介绍工作。结果显示，后者的工作表现要优于前者。研究者认为这表明了文化因素对问题解决过程的影响，他们强调对于美国黑人学生来讲，重要的是使他们受到非洲式而不仅是欧洲式的教育。

在第二个研究中，Mehan、Hubbard 和 Villaneuva 描述了一个在美国圣地亚哥地区高中学校进行的计划。该计划主要面对准

备上大学的学生,被称为“通过个人决心取得进步”计划(AVID)。计划为大学预备班的非洲裔和拉美裔学生提供了一个特殊选修课——重点强调互相指导、写作和问题解决。完成AVID计划的学生进入四年制的大学时,他们所达到的水平比全国平均线平要高。AVID计划的一个有趣的结果是,计划中的这些学生报告说,他们在学校中能够获得好成绩,而无须回避自己的民族身份。当然他们能够取得这一点,主要是他们采取了相互支持的方式,而对老师和咨询者带有的种族主义偏见则不予理睬。以白人为主的主流学校中多数有色人种学生都经常这样做。实际上,他们并不指望从学校获得自身的自我价值感。

另外一些研究探索了非学习领域中的问题解决方式。Rao和Kramer访问了患细胞贫血症婴儿的非裔美国母亲,以便探索母亲在照料她们自己的孩子中使用的应对技巧。她们都经常地使用社会支持、积极地重新评价和有计划地解决问题等策略,来应付照料这些孩子时所遇到的各种应激。

Yang和Clum研究了生活在美国的88名亚洲学生(年龄18~40岁),对问题解决模式和社会支持模式与紧张、忧郁、无望感和自杀观念等的关系进行了探索。他们发现问题解决模式与紧张、忧郁、无望感和自杀观念有关,特别是那些忧郁和无望的学生在问题解决技巧方面有许多缺陷。这一发现暗示,为留学生提供问题解决技巧训练,可以帮助他们应对紧张和忧郁。

Watson、Bell和Chavez以墨西哥裔和非西班牙裔白人高中学生及退学者为样本所进行的一项研究,比较了他们在解决人际冲突方面的技巧。白人学生一般使用竞争式问题解决方法进行矛盾控制,而墨西哥裔美国学生和退学者则更多地使用合作式问题解决方法。这些研究者建议,学校要为所有民族、种族的学生提供以合作方式解决问题的机会。

在艾滋病预防中对各种求助者进行问题解决训练,是另一个

研究领域。Bracho-de-Carpio、Carpio-Cedraro和Anderson发表的报告,讲述了在西班牙家庭中推广一个基于问题解决的HIV预防教育计划的情况。Kelly和St. Lawrence则报告了问题解决训练可用于男性同性恋者。Schinke、Botvin、Orlandi和Schilling发展出一种文化敏感的HIV预防计划,计划中既包括了与艾滋病事实也与各种文化的令人骄傲之处相关联。计划是为非裔和西班牙裔美国青少年设计的,既能在学校,也能在非学校的环境中实施。在此基础上,他们又编制出一个人与计算机交互作用式的电脑训练方法。

在HIV预防计划的一个出色研究中,246名非裔美国青少年(28%男性和72%女性)被分成两组,一组只进行教育训练,另一组还要进行行为技巧训练,包括避孕套的正确使用、性的自信、拒绝和接受信息的传递、自我控制、危险识别,以及问题解决等内容。举例来说,参加者或者找出他们过去曾遇到的问题情境,或者想像他们将来可能要遇到的问题情境,然后练习各种实用的问题解决技巧来处理这些问题情境。训练在减低参与者感染艾滋病病毒危险方面的效果,是通过训练后及一年后的随访中多项测量方法来评价的。结果表明,第二组比第一组只进行通常教育的受训者从训练中得到的益处更加显著,尽管男、女受训者出现了性别上的差异。这些研究者的结论是,感染艾滋病的危险行为受到各种“认知、人际交往和情境因素的影响,因此各个层面的干预措施”都是需要的。而且为使这类训练对于各种文化群体的人都能达到最佳效果,训练方法必须是“适应个人发展水平的,同时要与相应的文化内容相联系”。

Moncher和Schinke为土著美国青年制定了一个预防吸烟的群体干预方法,包括提供主流文化与土著文化中生存能力的信息、训练应付技巧和问题解决技巧等。Hammond和Yung特别针对黑人青少年制定了一个叫做PACT(青少年正确选择训练)的暴力

预防计划。在PACT计划的先行研究中，参与者的交际、问题解决和磋商技巧都得到了提高。

对不同文化群体求助者使用问题解决方法的指导方针

证据显示，虽然表现方式不同，但问题解决是帮助不同文化群体求助者的一种有效干预策略。在实施过程中要遵照一些共同的指导原则，以利于提高它的有效性。首先，问题解决技巧的特殊性质是随求助者的性别、民族和种族身份而变化的，不同文化群体的人使用着同样方式解决问题是不明智的。传统上欧洲中心和男权主义式的问题解决模式是一种个人主义的模式，它在男性和白人中得到广泛认可；而多数女性和有色人种则更倾向于采用协作或合作的问题解决模式。所以，采用问题解决训练策略的各种干预及预防计划，必须根据求助者的年龄、性别、民族和种族身份进行调整，以使问题解决既适应个人发展状况，又与文化相关联。

第二，只有当训练是用一种文化敏感方式进行时，问题解决训练才能够对来自不同文化的求助者产生效果。所谓文化敏感方式是指，要尊重不同文化传统和文化仪式，增进相应的文化认同感（如性别、民族的认同、民族自豪感等），帮助这些求助者获得问题解决技巧，而且不以主流文化的标准要求他们。

问题解决的六个阶段

我们将D'Zurilla列举的六个阶段列于下面：

1. 治疗基本原理：向求助者讲解问题解决策略的目的和概要说明。
2. 问题引导：评估求助者问题解决的应对风格；告诉他们哪些应付技巧对于问题解决有阻碍作用，哪些有促进作用；确定求助者问题解决过程中的认知及情绪障碍，然后训练

他们克服这些障碍；从多种角度揭露问题，并评估克服困难所需的时间、精力和投入程度。

3. 确定和形成问题：帮助求助者搜集有关的真实资料，了解问题，将与问题相关和与情绪相关的成份区别出来，并为每一个问题成份分别指定相应的问题解决目标。
4. 列出多种问题解决方法：引导求助者考虑以不同的方法来处理每一个问题目标，并利用延迟判断、数量化和多样化等的原则。
5. 做出决定：指导求助者在各种可供选择的解决方法中进行筛选，并针对每个问题目标，评价（判断和比较）各种解决方案的可能结果，最后选择问题解决计划。
6. 解决方法的实施和证实：鼓励求助者同时实施几种可供选择的解决方法；让他们进行自我监督、实施评价和强化解决方案；如果某种解决方法无效，要帮助求助者找到障碍所在，并开始新一轮问题解决策略的过程。

下面将分别描述每一步骤，在本章末的问题解决会谈检测清单中列有六个组成部分的详述。

治疗基本原理及概述

问题解决治疗中所应用的基本原理是试图加强求助者这样一种信念，即问题解决是有效执行各种功能的重要应对技巧。下面提供一个问题解决治疗基本原理的例子。

我们每个人都要面对或小或大的各种问题。有些问题是经常遇到的，如决定吃什么或看什么电影；另一些则压力较大，如处理别扭的人际关系。提高我们的责任感和自我控制力的一个途径，就是要学会一些解决问题的技巧。问题出现后立即投入必要的时间、精力加以解决和处理，会减轻其他问题将来可能引起的挫折和痛苦。

下面提供一个治疗程序概述的例子。

你将学习如何意识到自己解决问题的方式，并且还将了解自己对解决问题时应投入多少控制力、时间和努力的想法。我们一起收集信息以便了解和定义所出现的问题，还要了解什么东西在妨碍你解决问题。探索各种解决问题的方法非常重要，而面对若干解决方法，你要决定哪一种最合理。最后，你要实施该解决方案。（停一会儿）我想知道你对我所讲的有什么想法和感觉，有什么问题吗？

治疗的基本原理和概述必须与求助者的文化相关联。

问题引导

介绍基本原理和概述之后，咨询者要让求助者描述，他（她）自己解决问题的典型方法是怎样的，从而帮助咨询者判断，求助者的问题解决风格是阻碍式的还是促进式的。咨询者要帮助求助者学会区分这两种应对风格：具有阻碍式应对风格的人常因问题而责备自己或他人，他们相信自己存在着毛病，因而感到自己不正常、毫无希望、悲观抑郁、愚蠢或不幸。他们还常常低估问题解决所带来的益处，并夸大没能成功解决问题所能带来的损失。缺乏问题解决技巧的人们通常感到问题无法解决，从而回避面对问题。而且，他们常感到自己不适应和无能为力，他们宁愿让别人帮助解决问题。有些解决问题很困难的人或者是因为他们从来没有学习过怎样去解决问题，或者是他们感到困难太大了无法克服。

咨询者的角色是帮助那些具有阻碍式应对风格的求助者，使他们改变自己对于问题解决的知觉。然而，咨询者必须用一种文化敏感的方式来做，因为问题解决风格存在着性别、年龄、民族或宗教信仰的差异。重要的是不能把阻碍式的问题解决方式与非欧美中心的世界观相等同。要帮助他们认识到，问题的出现不是

一种威胁，也不是个人无能的表现，相反它给我们提供了一个进一步成长和自我提高的机会。求助者或许觉得不直接面对问题更容易些，可以等待事情自己变得好起来。咨询者要使他们知道，如果问题得不到很好的解决，以后还会经常出现；要使他们相信问题是能够解决的，而且他们有能力 and 自我控制力去独立且成功地找到解决问题的方法。对成功解决问题的预期会产生解决问题的能力。

问题解决要花时间和精力。当人们的情感比理智影响更大时，人们更容易回避问题解决，此时人们常常冲动地对问题做出反应，而不花时间和精力去思考各种有效的解决方法。问题解决需要时间、精力和投入——一种延迟的满足。咨询者需要评估求助者花费时间、精力、身心投入和延迟满足的意愿，并且要鼓励求助者对解决问题进行必要的投入。

问题引导中的另一部分是讨论，求助者的认知和情感是怎样影响其解决问题的。求助者可能没有解决问题的动机，如，他们可能会自言自语道，“这是他们的过错”、“它反正会过去的”，或“我不能处理它”，这种认识会抑制解决问题的动机。治疗的目的是指导和训练求助者，使他们用一种积极的应对方式，有意识地去克服问题解决过程中的认知及情感障碍。诸如认知重建、再构、压力转移、冥想、肌肉放松或系统脱敏、呼吸练习和瑜珈等策略（参阅第十五、十六、十七、十八和十九章），都可以用来帮助求助者克服问题解决中的认知、情绪障碍。一旦抵抗问题解决的阻力减少，求助者就可以准备进入下一阶段的问题解决治疗。

确定和形成问题

在问题解决的这一阶段，咨询者要帮助求助者收集尽可能多的、围绕问题的客观信息。如果求助者对问题有歪曲的认知或知觉，咨询者则要应用认知重建或理性-情绪疗法（参阅第十五章）。

咨询者将问题解决策略解释为一种技巧和实用的方法，人们通过它可以去识别、探索或创造出有效应对日常生活问题的途径。可以将问题解释为是由两种情境差异所引起的，一个是人们正在体验到的情境，而另一个则是人们认为应当（能够）体验到而实际没有体验到的情境。求助者要获得有关问题的信息，就要识别出那些引起上述情境差异，或者妨碍减少这种差异行动的障碍。同样重要的是要考察造成目前问题的原因以及尚未解决的问题。在问题确认这一步骤中，咨询者可以利用第九章中提供的技术。

一些治疗者在以问题为焦点和以情绪为焦点的问题定义之间做了明确区分。问题焦点的定义围绕着问题解决的目标，重点在于改变问题产生的情境；而情绪焦点的定义则专注于改变求助者对问题的个人主观反应。D' Zurilla (1988) 建议，如果问题情境被评价为是能够改变的，那么在治疗中要强调问题焦点的定义；如果问题情境无法改变，咨询者则要帮助求助者关注自己对问题的反应。在一些个案中，求助者的问题先被评估为问题焦点类，但随后咨询者和求助者发现问题情境是无法改变的，从而治疗的重点又转为改变求助者个人的主观反应。我们的经验是，在定义求助者的问题时，最好要包括以问题为焦点和以情绪为焦点两种定义。另外还要注意，这两种定义及其相应的治疗目标在一定程度上是与求助者的性别和文化相关的。

在识别和定义了问题之后（参阅第九章），咨询者和求助者就要确立切合实际的、以情绪为焦点（或以问题为焦点）的目标（参阅第十章）。目标即是求助者经过解决问题的努力之后希望看到的结果。目标应当是现实的、能够达到的，应能较详细地指出行为的类型和强度，以及能够促进解决问题的条件。咨询者应帮助求助者识别出那些可能干扰问题解决的障碍。最后，咨询者要让求助者认识到，问题情境的复杂性要求人们必须从不同的角度去解决问题。确立问题解决目标将帮助求助者进入下一步治疗：列出

各种变通的问题解决方法。

列出多种问题解决方法

问题解决这一阶段的目标在于让求助者想出尽可能多的变通解决方法。咨询者不仅要指导求助者对自己想做什么、处理问题的方式进行思考,还要指导求助者不必担心怎样开始制定工作计划,或者怎样使解决方法更为有效。要鼓励求助者的想像,想出各种各样新颖而独特的解决方法,哪怕这些解决方法似乎很可笑也没关系。D'Zurilla 的研究表明,求助者想出的解决方法越多,他所能选择的解决方法质量也越好。同样,如果求助者去评判和批评自己设想出的解决方法,他就有可能想出更高质量的解决方法。

想出各种解决问题的方法之后,求助者还要识别出这些方法可分为几种不同的策略。如果策略种类太少,求助者就要想出更多的方法策略,或针对某种特殊策略想出更多的解决方法。采用这种类似“脑筋急转弯”过程的目的,是要在求助者的想像中排除掉头脑中的僵化、过于实际和实用性的倾向。如果解决问题有若干目标,咨询者就要鼓励求助者为每一个问题目标设想出几种可供选择的解决方法。其主要的理由就在于,大多数问题都十分复杂,单一的方法通常是解决不了问题的。

做出决定

这一步骤的目的是帮助求助者通过判断或比较决定出最佳的解决问题方法。首先要求求助者筛选出那些可用的方法,并剔除那些具有危险、不可行的解决方法。最佳的解决方法应是那些能为求助者个人带来最大的短期和长期利益,并使代价最小的方法。要求求助者预期每一种方法的结果,然后按照下列四个标准评价每一种解决方法:(1)问题是否能够得到解决?(2)求助者的情

绪状态将会怎样？（3）解决问题需要花费多少时间和精力？（4）结果会对求助者总体的个人和社会利益有什么样的影响？注意，在与不同文化的求助者打交道时，切不可将咨询者自己的价值观和文化观加入上述判断过程中。

D'Zurilla 建议，在求助者选择和评价了所有解决方法之后，应要求求助者回答下面三个问题：（1）问题能够被解决吗？（2）在解决方法被执行之前还需要更多的信息吗？（3）应使用什么解决方法或解决方法组合来解决问题？如果问题不能被现有的方法解决，咨询者就必须帮助求助者重新定义问题，收集更多的有关信息。假若上面的三个问题得到了满意的回答，而且所选择的方法与解决问题的目标一致，那么求助者就可以开始实施解决问题的方法。

在问题解决策略的前五个阶段中，咨询者起引导的作用，以确保下面几个步骤能完整地得到执行：问题引导，问题定义，列出变通的方法，做出决定。当求助者进入最后阶段——解决方法实施阶段后，咨询者的引导作用应当减弱。问题解决治疗策略的最后阶段目标是让求助者变得更负责任。

问题解决方法的实施和证实

这一阶段的目的是根据问题解决目标来检验所选择的解决方法，并证实这些方法是否解决了问题。求助者同时实施尽可能多：

第一，实施所选的解决方法。如果实施解决方法有障碍（如行为缺陷、情绪问题认知缺失等），求助者可以先学习行为技巧，缓解情绪问题，或重建认知，以便除掉这些障碍。

第二，求助者可使用自我监测技术（参阅第二十章）来评估解决方法的效果。咨询者指导求助者如何记日记，以记录下实施所选择方法时的自我对白和情绪反应，然后按11级量表对日记中记录的我白或陈述做出评定（“5”代表极端消极，“0”为无

所谓,“-5”为极端积极)。另外,情绪状态也可记录下来,如可爱的、忧郁的、挫折的、内疚的、高兴的或中性的(中性状态可增加情绪敏感性)。

第三,求助者评估所选择的方法是否达到了解决问题的目标。这个自我评价过程依照下列几个方面来评判:(1)问题是否解决;(2)情绪良好状态;(3)所花费的时间和精力;(4)所获利益与代价的比率。

最后,如果所选择的解决方法满足了所有的标准,求助者就会从成功地解决问题中获得自我奖励(参阅第二十章)。但是,如果所选择的解决方法不能解决问题,咨询者和求助者就要分析麻烦的出处,并重新进行问题解决的所有步骤。一些带有共性的原因是:对问题的情绪反应,对问题定义不适当,出现先前未曾解决的问题,用以问题为焦点的定义代替了以情绪为焦点的定义,以及选择了不令人满意的解决方法,等等。

D'Zurilla 提出三个有关问题解决策略的警告。警告一是,当存在另外更适当的治疗策略时,咨询者却使用了问题解决策略。当求助者有严重的心理或行为问题时,咨询者要使用其他的治疗策略。例如,对于患有抑郁症的求助者,在考虑进行问题解决疗法之前,可能先要进行强化认知重建治疗(参阅第十五章)。第二个警告是,咨询者常把问题解决治疗作为一种“理性的”、“智力的”或“大脑旅行训练”方法,而不是将其看做一种包括了行为、认知和情感三个部分的应对策略。问题解决策略应当被看做是治疗中的一个整体、综合的体系,它必然要涉及到人的情绪、行为和认知等状态,而且同样也与人们的文化相联系。第三个警告是,治疗者没有认识到,应该与求助者建立融洽的关系或积极的治疗联系,这是成功治疗的一个必要条件。建立有效的治疗关系(参阅第三章)和增强治疗关系的变量(参阅第四章),对成功实施任何治疗策略都是重要的,当然问题解决策略也不例外。有时问题

解决对于那些不习惯于思考长期效果的求助者是困难的,如许多青少年和一些有外伤史的求助者,他们不愿让自己想得更远。Bly讲到,许多生活在美国的欧洲美国人在问题解决方面是短视的,缺乏历史观,而美国土著人则有为解决某个问题而要向前追溯几代人的习惯。

最后,Nezu、Nezu和Perri提出一些实施问题解决策略的指导方针。

1. 问题解决训练不能用机械的方式进行。
2. 治疗者应尝试使策略个性化,使之与求助者关心的具体问题相关联。
3. 家庭作业和现场练习是问题解决策略中的重要组成部分。
4. 治疗者对求助者所关心的事情和感觉要表现出关注和敏感。
5. 治疗者正确、恰当地使用幽默,可以增强治疗的效果。
6. 治疗者要不断地确保在治疗过程中准确地评估问题。
7. 治疗者应鼓励求助者在治疗中实施尽可能多的解决方法。
8. 治疗者必须详尽评估求助者实施解决方法的能力和局限,评估还应包括求助者对问题情境的控制程度。
9. 治疗者必须确定,求助者的问题是以问题为焦点还是以情绪为焦点,又或者二者都有。

在问题解决的整个过程中,治疗者的角色是教会求助者问题解决的策略,并引导他们通过问题解决的所有步骤。我们在前面提过,咨询者在问题解决的最后阶段应减少指导,以便帮助求助者更为独立和负责地运用问题解决方法,并验证所选择解决方法的有效性。咨询者要帮助求助者保持问题解决的技巧,并将它们推广至其他的问题情境中去。咨询者还可以帮助求助者预期解决策略的障碍,并懂得如何应付它们。如果求助者肯花时间去客观地检查自己对问题的定义,设想出各种各样的解决方法,并根据

问题解决目标选出哪些解决方法是可取的等，他们应能够很好地解决自己的问题。如果问题解决程序的前四个阶段能够被完整、客观地完成，实施解决方法的阶段就会变得很容易（参阅学习练习活动 43）。

问题解决治疗法示范

在这个示范中，我们将示范如何使用问题解决疗法帮助一个 49 岁的男性求助者。Yoshi，一个空中交通管制员，他想降低工作中的紧张情绪。他相信减少紧张对他的溃疡有好处，还能帮助他更好地工作。除了紧张的躯体症状（失眠症）之外，Yoshi 还说他不断地担心会在工作中出错。他想早点退休，这样会使他从紧张和担心中解脱出来。

基本原理

首先，我们向 Yoshi 解释说，我们每个人都要面对问题。有时我们会感到困惑不安，因为我们不知道怎样处理问题。我们告诉 Yoshi 解决问题能避免将来的不适，并向他概述了问题解决疗法。其中，我们需要知道他怎样看待问题，以及在解决问题时存在着什么障碍；然后我们需要给问题定义，设想出解决问题的各种不同的方法，再选择执行其中的几个解决方法，并考察这些方法是否解决了问题。我们强调问题解决是一种协同、合作的过程。最后，我们确认了 Yoshi 愿意使用问题解决疗法，并回答了他对疗法提出的问题。

问题引导

首先要确定 Yoshi 解决问题的典型方式是怎样的：我们要他讲述一个过去的例子，他遇到什么问题，又是怎样解决的。然后我们向 Yoshi 描述了阻碍式问题解决和促进式问题解决之间的不

同，并向他解释大多数人天生具有解决问题的能力，但有些东西妨碍了这些能力的使用。问题解决疗法就是要去除这些阻碍或障碍，以便人们能更好地解决问题。健全的问题解决是一种视问题为机会的能力。如果 Yoshi 在尝试问题解决时遇到认知或情绪障碍，我们会介绍适当的策略来帮助他去除。最后，我们评估 Yoshi 为解决问题所花费的时间、精力和投入。

确定和形成问题

我们为 Yoshi 简略地描述了问题解决策略，向他解释我们需要收集一些有关他自己问题的信息，如：他对问题的认识和情感，存在哪些未解决的问题，问题的严重性，为解决问题已经做了些什么，问题在何时、何处发生等。我们问 Yoshi 确认其问题还需要其他什么信息。如果他对问题有扭曲的观点和知觉，我们会帮助他再构他对问题的知觉。我们还要确定 Yoshi 的问题是以问题为焦点，还是以情绪为焦点，或者两者都有。对 Yoshi 的个案来说，我们也许能改变他对工作情境的情绪和认知反应，从而帮助他减少紧张；但是他无法改变工作要求，除非他离开这个工作或者退休。我们帮助 Yoshi 建立问题解决的目标。对于 Yoshi 来说，最实际和最易达到的目标就是减少工作紧张。

列出各种解决方法

Yoshi 被要求设想出尽可能多的问题解决方法。我们告诉他，不要担心如何着手进行各种工作以及如何有效地解决问题；并且告诉他，不要马上就对自己的想法或解决方法的效果及可行性进行判断，要尽可能多的想像出各种各样的方法（数量产生质量），要富于创造性，想像出那些非传统而不保守的解决方法。

做出决定

我们指导 Yoshi 列出各种解决方法, 并使用下列标准评估每一种解决方法: 用这个解决方法能解决问题吗? Yoshi 的情绪状态将会怎样? 这种解决方法将花费多少时间和精力? 每一种方法对 Yoshi 的个人或社会利益的整体影响是什么? 要提醒 Yoshi 使用这四个标准来评价每种解决方法。最后, 他选择出了最好的解决方法——既配合问题解决的目标, 又最恰当地反映了他自己的文化价值观。

解决方法的实施和证实

我们让 Yoshi 尝试他所选择的方法来解决问题, 并指导他对问题解决方法的有效性进行自我监督。假定他选择使用冥想作为一种减轻工作场所压力的方法。我们告诉 Yoshi, 自我监督的方法就是在日记上依照下列标准记录冥想的有效性: 冥想在减少工作压力上如何有效? 对冥想体验的情绪感觉怎样? 日常进行冥想所花费的时间和精力是否值得? 使用冥想的益处是否比代价更大? 他的思想、情感和行为与冥想方法有何种联系? 要求他每天上床之前完成自我监督日记。我们还要求 Yoshi 用 5 级量表来评价每一个标准问题。我们告诉他在成功解决这个问题(减轻压力)后, 要选择带有奖励性的东西和行动来鼓励自己, 并且选择获得奖赏或活动的最佳时机。如果冥想不能对解决问题有帮助作用, 我们则指导 Yoshi 分析哪些是解决问题的可能障碍, 如他对问题的情绪反应和定义, 或者也许还有一些未被解决的问题等。

本章总结

认知示范法是一种帮助人们学会运用自我对白, 以增进技能的治疗程序。在这个策略中, 不仅外显反应而且内隐反应也被用

下进行示范。问题解决治疗或训练法提供了一种形式化系统，使求助者能建设性地考虑问题。作为一种治疗策略，问题解决可以单独使用，也可以结合本书讲述的其他治疗策略一起使用。问题解决已被用于不同文化群体的求助者，问题解决风格的差异在求助者的年龄、性别、民族、种族等的变量上是明显的。文化敏感问题解决训练还包括民族自尊和多种文化能力等素质。

下一章我们将会看到，如何让求助者学会用应对思想和技巧来替换自己的自我否定思想。第十五章介绍的认知重建策略，即是这样一种用来替代或重塑自我否定思想的策略。

学习练习活动 43/ 问题解决

这个学习活动提供了一个学习问题解决法的机会。想出一个要加以解决的问题，把问题解决的步骤运用到解决这个问题上。在一个不会被干扰的安静地方进行练习。

1. 确认你将怎样解决问题。你的性别和文化会如何影响你的问题解决方法？
 2. 评估自己的问题解决风格。它反映出了什么样的世界观？
 3. 你有哪些认知或情感障碍会妨碍你对问题的解决？
 4. 你能将多少时间、精力投入到问题解决中？
 5. 界定自己的问题，并确定它是以问题为焦点，还是以情绪为焦点，或者两者都有。
 6. 列出解决问题的各种方法。一定要使这些方法与自己的文化相适应。
 7. 使用问题解决会谈检测清单中第 13 条的标准，选择最佳的解决方法。
 8. 实施解决方法，或至少考虑怎样去实施，并考虑一个评价解决方法有效性的途径。
-

学习评判

第一部分

描述你将如何使用认知示范和自我指导训练的七个组成部分来帮助黄先生（见第八章），使他主动与老板进行社会活动（目标一）。下面是七个组成部分：

1. 基本原理
2. 任务示范和自我指导
3. 出声的外部指导
4. 出声的自我指导
5. 声音逐步减弱的自我指导
6. 内隐自我指导
7. 家庭作业和复诊

答案见学习评判反馈。

第二部分

本章目标二要求在角色扮演中演示21步认知自我指导示范程序中的至少16个步骤。你可以录音或让观察者评估你的表现，评估可根据认知示范会谈检测清单进行。

第三部分

目标三要求你在10个会谈例子中，至少对8个例子中反映的问题解决步骤能够准确地识别出来。问题解决的六个主要步骤是：

1. 问题解决的基本原理
2. 问题引导
3. 问题界定和形成
4. 列出可供选择的解决方法
5. 做出决定
6. 解决方法的实施和证实

答案见学习评判反馈。

1. “自我监督包括使用日记或日志，来记录你的思想、感觉和行为。”
2. “为帮助自己评估每一个解决方法，你可以提出关于解决问题方法有效性的若干问题。”
3. “要发挥创造力，自由想像，记下进入头脑中的所有方法。”
4. “你要为自己的情绪设立什么目标？”
5. “请给我提供你解决问题的一个例子，你通常解决这个问题的方法是什么？”
6. “问题解决可以起到预防它再次发生的作用。”
7. “多数人有能力解决问题，但他们不常使用它们，从而无法解决复杂问题。”
8. “哪些没有解决的事情造成了目前的问题？问题是何时发生的？在什么地方发生的？”
9. “看看你的问题解决方法清单，它们的差别大吗？能想出新的方法吗？”
10. “当你完成这个步骤后，要想一想如何奖励自己。”

第四部分

目标四要求你通过角色扮演演示 19 个问题解决步骤中的 16 个步骤。你可录音或让观察者评估它，评估根据问题解决会谈清单进行。

认知示范会谈清单

指导语：确认咨询者在会谈中是否使用了下面的引导语，如果使用了，在相应的位置上画勾。在清单的右栏，列举了一些咨询者引导语，当然，它们都只是建议。

项目	引导语举例
I. 基本原理	
—— 1. 解释基本原理。	“这个策略将帮助你完成任务，并安

- 排你怎样做。计划会帮助你完成得更好，更容易。”
- “我们将循序渐进地学习。首先，我将演示怎样做，我将在做的同时大声地与自己交谈，以使你能听到我的计划。然后你也这样做。逐渐地，你将能在考虑计划的同时完成任务。”
- “现在愿意继续下去吗？”
- Ⅱ. 任务示范和自我指导
- “在我做的时候，我将在口头上告诉你我的计划，你要仔细听我所说的话。”
- “好，我现在开始。（咨询者）我正准备会见招工者，等待着他示意我坐下来（坐下来）。”
- “在这个情境中，我将做什么？”
- “我只需要按提示坐下来、回答问题。”
- “记住做一个深呼吸，放松，集中注意力于会谈。记住讨论我的资格和经验，试着完整地、直接地回答问题。”
- “如果我变得紧张，只要做一个深呼吸，保持注意力集中于会谈，如果我不能很好地回答一个问题，我可以
- _____ 2. 介绍概况。
- _____ 3. 争得求助者同意。
- _____ 4. 指导求助者听和看哪些方面。
- _____ 5. 大声地示范任务。
- _____ 6. 包括
- _____ a. 对问题要求的提问；
- _____ b. 用计划来回答；
- _____ c. 集中注意力于任务本身，进行自我指导；
- _____ d. 应对自我评价，纠正错误；

_____ e. 完成后自我强化。

III. 出声的外部指导

_____ 7. 在一旁指导求助者练习。

_____ 8. 用言语指导求助者, 包括:

_____ a. 提问;

_____ b. 回答;

_____ c. 注意任务、自我指导;

_____ d. 应对自评, 纠正错误;

_____ e. 自我强化。

IV. 外部自我指导

_____ 9. 让求助者练习。

_____ 10. 求助者大声地自我指导自

重新回答。”

“好, 做得很好, 事情做得很顺利。”

“这次你自己来进行会谈, 我将在做什么及你的计划上辅导你。”

“现在只要记住你将进入会谈, 当会谈开始时, 我会辅导你该怎样做。”

“好, 你正进入会谈室, 现在问自己将做什么?”

“你正迎接会谈者(求助者照着做), 现在他暗示你坐下来(求助者坐下)。”

“只要注意想怎样处理这个情境。他正问你有关背景, 你正在直接和完整地回答。”

“当你被提问时, 如果你感到有点紧张, 只要做一个深呼吸, 如果你不能完整地回答问题, 你就尝试用另一种方法回答。现在试试。”

“很好。记住, 现在你要表达的意思就是: 你应当受到要雇佣。[求助者按照指示做了]非常好, 做得很好。”

“这次我想让你自己做, 你在会谈中用我们前面做过的方式进行自我指导。记住, 你的计划有五个部分, 如果你卡住了, 我会帮助你。”

己的练习:

- _____ a. 提问; “现在我需要做什么?”
 - _____ b. 回答; “我将迎接会谈者, 等待坐下来的暗示。然后直接地和尽可能详细地回答问题。”
 - _____ c. 注意任务, 自我指导; “只要集中注意力于我正在处理的这个情境, 我将叙述我为什么被选择。”
 - _____ d. 应对自评, 纠正错误; “如果变得紧张, 只要做一个深呼吸, 如果某个问题有困难, 可以返回去重新做。”
 - _____ e. 自我强化。 “好, 事情很顺利, 我完成了。”
 - _____ 11. 若自我指导不完整, 咨询者要:
 - _____ a. 提供线索; “让我们停一会儿, 你似乎有麻烦, 让我们再试试……”
 - _____ b. 重新进行步骤 10。 “似乎相当困难。因此让我们再试一次, 这次我将辅导你通过会谈。”
 - _____ 12. 为求助者提供反馈意见。 “这对你似乎相当容易, 你能通过会谈辅导自己。在中间的一个地方, 你描述自己有困难, 似乎有点儿卡住了。但最后, 你还是处理得很好。你想到了什么?”
- V. 声音逐步减弱的自我指导
- _____ 13. 让求助者低声进行练习。 “这次我想让你对自己进行耳语指导, 就像你单独在练习。耳语对你是一件新的事, 但我相信它将帮助你学会完成任务。”

—— 14. 求助者低声地练习

“现在我将进入房间，等待会谈者迎接我，坐下来，我将尽可能完整地回答问题，现在，我将谈我的背景。”

—— 15. 检查求助者完成的如何：

—— a. 若步骤进行不完整，要重新进行

“你对……有一些困难，让我们再试试这类练习。”

—— b. 若进行得顺利，则继续下一步。

“似乎你做这个很容易、很自然，下一步是……”

VI. 内隐自我指导

—— 16. 告诉求助者如何内隐地进行练习。

“这次当你练习时，只想着这些指令，不要说出来。换句话说，在自己的头脑中指导自己。”

—— 17. 求助者不出声地练习。

“在这时，只看得见你的行为。”

—— 18. 让求助者描述不出声的自我指导语。

“你能告诉我，当你做这个时想的是什么呢？”

—— 19. 基于求助者的信息，确定：

—— a. 重新进行步骤 17、18；

“有时在脑海中预演指令有些困难，让我们再试一次，你能感到更自然。”

—— b. 开始布置家庭作业。

“好，你做它似乎很容易，如果在本周你能应用这个程序做同样的事，我相信它会有帮助，例如……”

VII. 家庭作业和复诊

—— 20. 告诉求助者如何进行家庭练习，包括：

—— a. 做什么；

“这个星期我希望你做的是靠你自己完成这类练习。”

—— b. 做的次数；

“我相信如果你每天做两次，它将是

	有帮助的。”
_____ c. 何时、何地进 行练习;	“首先在家练习, 然后在学校 (或工 作场所) 练习, 我相信它将有帮助。”
_____ d. 进行自我检测。	“每次做时, 要在日记本上做记录, 写下自我指导的五个部分。”
_____ 21. 安排复诊时间。	“下周带你的日记本来, 或在周末给 我一个电话, 我们将检查你的家庭 作业。”

观察者评语: _____

问题解决会谈检测清单

指导语: 确认咨询者在会谈中是否使用了下面的引导语, 如果使用了, 在相应的位置上画勾。在清单的右栏, 列举了一些咨询者引导语, 当然, 它们都只是建议。

项目	引导语举例
I. 问题解决的基本原理	
_____ 1. 以与求助者文化相一致的方式解释问题解决的目的	“我们都要面对大小问题, 有时我们感到被难住, 因为我们不知道怎样处理问题。这个治疗程序能帮助你识别和确认问题, 并检查解决问题的方法。使你能够控制问题, 而不是被问题控制。当问题发生时, 解决这

—— 2. 介绍概况

个问题，以便预防将来的不适。”

“这个程序包括五个步骤。大多数问题是复杂的，我们需要从许多不同的方面解决问题。首先，我们需要了解你怎样看待这个问题，是阻碍还是促进的问题解决技巧。另外一部分是探索如何克服解决问题的思想和情感障碍。第二，我们将收集有关的信息。第三，我们想知道，为解决问题我们能提出多少不同的解决方法。下一步，我们将比较这些方法，并决定使用哪一个。最后，你将尝试所选择的解决方法，并评估它们的效果如何。（暂停）对我讲的你有什么想法？有什么问题吗？”

II. 问题引导

—— 3. 确定求助者如何解决问题

“请就你的问题给我一个例子，并描述你解决它的典型方法。”

—— 4. 区分阻碍式和促进式的问题解决方法，性别、年龄、文化的影响

“大多数人都具有解决问题的能力，但通常他们不利用它。问题解决疗法能帮助去除障碍，把重要的问题带入焦点，并从不同方面考虑问题。不能解决问题的人认为自己无法解决问题，通常这些人会回避问题或想让别人解决它。人们有时感到不去解决这些问题是容易的，事情会变得更好。大部分时间，问题解决无能者感到无望、抑郁或不愉快。你能解

决问题，它们只是日常生活中的一部分。通常每个问题都有一系列的解决方法，你有能力找到解决方法。把问题看做一个机遇来考虑是会有帮助的。”

—— 5. 确定求助者解决问题中的
认知、情感障碍。

“当你思考你的问题时，你对这个问题有什么想法？通常在这个问题中你会想什么？你有任何有关这个问题的‘应该如何’的信念吗？当考虑这个问题时，你体验到什么感觉？在你过去的生活事件中，有任何仍然影响这个问题的事件吗？你的思想和情感怎样影响这个问题和你解决问题的能力？”

（如果存在某种障碍，就要用各种方法加以调整，去除这些障碍，如认知再检、重构、冥想、音乐放松等。）

—— 6. 评估问题解决的时间、投入程度等。

“任何问题都要花费时间、精力、投入来解决。知道怎样要求自己来解决问题是重要的（等待回答）。解决一个问题要花时间，你觉得你有足够时间来解决这个问题吗？（暂停，等待回答）思考和致力于解决问题要花大量精力，你觉得应怎样进行？（暂停，等待回答）”

III. 问题界定和形成

—— 7. 描述问题解决策略

“人们都有问题，一些问题是轻微的，而一些是重大的。问题解决策略

是一种技巧和实用方法，人们使用问题解决来识别、探索、或产生有效地处理每个问题的方法。”

—— 8. 帮助求助者收集有关问题的信息。

“我们想尽我们收集更多与问题有关的信息，它是哪类问题？当问题发生时你有什么想法？对这个问题你体验到什么情感？这个问题通常怎样发生或怎样发展？谁卷入了问题？在什么时候发生问题？什么地点发生？这个问题将持续多久？这个问题有多紧张？解决这个问题需要做什么？你能认识到什么障碍阻碍解决问题？告诉我，你怎样看待这个问题？定义这个问题时我们需要另外的信息吗？你对这个问题的定义是什么？”

—— 9. 确定求助者的问题是以问题为焦点，还是以情绪为焦点，或者两者都有。

“这个问题怎样被改变？这个问题的什么方面能够被改变？对这个问题你有什么情绪反应？你愿意改变对问题的个人情绪反应吗？对于这个问题，有些东西不能改变，一些问题情境是无法改变的，如果问题的某些方面是能改变的，我们将致力于那些能改变的事，你对问题的情绪或个人的反应就是能够被改变的。”

—— 10. 帮助求助者确定问题解决的目标。

“现在我们识别和确认了问题，我们需要建立一些目标。一个目标是你愿意做什么，以使这个问题被解决，

这个目标将是你能做到的、可接受的和现实的事。”

“有多少障碍阻止你建立问题解决目标？怎样能去除这些障碍？你想改变什么行为？改变的程度是多少？在什么情况或形势下行为改变将发生？对于在问题情境中要被改变的东西，你设立了什么目标？你想为自己设立什么行为目标？这些目标将在问题解决的下一步骤帮助我们。”

IV. 列出可供选择的解决方法

—— 11. 指导求助者列出各种解决方案：

—— a. 各种选择方案；

—— b. 延迟做出判断；

—— c. 数量要大；

—— d. 种类要多；

“我们想为解决问题列出尽可能多的可供选择的解决方法。因为问题通常是复杂的，一个简单的解决方法通常是不适当的，我们需要为每一个问题目标列出几种可供选择的解决方法。”

“想想你将处理问题的哪些方面？不用担心怎样完成你的计划，或怎样使这个解决方法有效。”

“推迟判断各种解决方法，要放开思想。”

“数量产生质量，可供选择的方法和想法越多，就越好，你将发现质量更好的解决方法。”

“要有创造力，启动想像力。无论什么进入你的脑海都把它记下来。要

允许自己想出各种无用的或非传统的解决方法。检查你列出的解决方法，看有多少种。如果你列出的种类较少，要想出更多新的和独特的解决方法。”

V. 做出决定

—— 12. 指导求助者筛选方案。

“现在你需要筛选和检查你列出的可供选择的解决方法，你要找出最好的解决方法。最好的解决方法是对你个人、社会，以及直接和长期的利益花费最小而收获最大的方法。”

—— 13. 提供评价解决方案的方法。

“为帮助你评价每个解决方法，你要回答下列四个问题：

- (1)用这个解决方法能解决问题吗？
- (2)通过使用这个解决方法，我的情绪会感觉很好吗？
- (3)如果我使用这个解决方法，需要花费多少时间和精力来解决问题？
- (4)如果使用这个解决方法，会对我个人的利益有帮助吗？

记住通过回答这四个问题来评价每个解决方法是重要的。”

—— 14. 针对目标，选择出最佳的解决方案。

“选择尽可能多的解决方法，并回答下列问题：

- (1)用这些解决方法，这个问题能被解决得相当好吗？
- (2)这些解决方法在被选择和实施前，是否需要更多的信息？

描述解决方法是否适于问题解决目标。”

VI. 解决方法的实施和证实

____ 15. 求助者实施解决方案。

“在问题解决的最后阶段，尝试实施被选择的解决方法，如果试用解决方法有障碍，我们将返回重做。同时，你可以使用几种或尽可能多的解决方法。”

____ 16. 告诉求助者进行自我监测。

“你要运用自我监测方法，包括在日记上记录思想、情感和行为。我们将要讨论你的记录”

____ 17. 用下述标准评估是否达到目标：

“你需要确认解决方法是否解决了问题，并问自己下列问题：

____ a. 是否解决了问题；

解决问题了吗？

____ b. 情绪状态良好；

情绪良好？

____ c. 投入了时间和精力；

花费了多少时间和精力？

____ d. 收益与支出的比例。

效果是否值得？”

____ 18. 告诉求助者进行自我奖励。

“你需要考虑在成功解决问题之后奖励自己，奖励自己什么东西或活动？何时得到一些东西或进行一个奖励活动？”

____ 19. 如果没有解决问题，下一步应当怎样做

“当解决方法不能解决问题时，我们需要查看解决问题的障碍和麻烦，以及你对问题的情绪反应。或许是因为你对这个问题没有准确定义，或者还有以前未解决的矛盾影响着目前的问题。”

参考文献

- D'Zurilla, T. J. (1986). *Problem-solving therapy: A social competence approach to clinical intervention*. New York: Springer.
- D'Zurilla, T. J. (1988). Problem-solving therapies. In K. S. Dobson (Ed.), *Handbook of cognitive-behavioral therapies* (pp. 85–135). New York: Guilford.
- D'Zurilla, T. J., & Nezu, A. M. (1990). Development and preliminary evaluation of the Social Problem-Solving Inventory (SPSI). *Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 2, 156–163.
- Gorrell, J. (1993). Cognitive modeling and implicit rules: Effects on problem-solving performance. *American Journal of Psychology*, 106, 51–65.
- Gutkin, T. B. (1993). Cognitive modeling: A means for achieving prevention in school-based consultation. *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 4, 179–183.
- Nezu, A. M., & Nezu, C. M. (Eds.). (1989). *Clinical decision making in behavior therapy: A problem-solving perspective*. Champaign, IL: Research Press.
- Nezu, A. M., Nezu, C. M., & Perri, M. B. (1989). *Problem-solving therapy for depression: Theory, research and clinical guidelines*. New York: Wiley.
- Paye, B. D., & Manning, B. H. (1990). The effect of cognitive self-instructions on preservice teachers' anxiety about teaching. *Contemporary Educational Psychology*, 15, 261–267.
- Rose, S. D., & LeCroy, C. W. (1991). Group methods. In F. H. Kanfer & A. P. Goldstein (Eds.), *Helping people change* (pp. 422–453). New York: Pergamon Press.
- Schinke, S., Botvin, G., Orlandi, M., & Schilling, R. (1990).

- African American and Hispanic American adolescents, HIV infection, and prevention intervention. *AIDS Education and Prevention*, 2, 305–312.
- St. Lawrence, J., Brasfield, T., Jefferson, K., Alleyne, E., O'Bannon, R., & Shirley, A. (1995). Cognitive-behavioral interventions to reduce African American adolescents' risk for HIV infection. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 63, 221–237.
- Watson, D., Bell, P., & Chavez, E. (1994). Conflict handling skills used by Mexican American and White non-Hispanic students in the educational system. *High School Journal*, 78, 35–39.
- Yang, B., & Clum, G. (1994). Life stress, social support, and problem-solving skills predictive of depression symptoms, hopelessness, and suicide ideation in an Asian student population: A test of a model. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 24, 127–139.

学习评判反馈

第一部分

1. 基本原理

首先，你将向黄先生解释认知示范和自我指导训练的目的和步骤。

2. 任务示范和自我指导

向黄先生示范一种能与他的老板打交道的方法，指导过程分为五个部分：

- ① “需要做什么”的问题。
- ② 用计划的方式回答这个问题。
- ③ 集中注意力于任务，指导自己完成它。

④评价自己，纠正错误。

⑤完成后强化自己。

在示范中最重要的是使用与黄先生有关的语言。

3. 外部指导

辅导黄先生完成自我指导的五个部分。

4. 出声的自我指导

Huang先生练习，同时大声地自我指导。如果他卡住了，你可以提醒他，也可以让他重复这个步骤或返回到第3个步骤。

5. 声音逐步减弱的自我指导

黄先生进行耳语自我指导程序。

6. 内隐自我指导

黄先生进行内隐自我指导程序。你要求他描述发生了什么，必要时用内隐自我指导进行另外的练习或返回到第4、5个步骤。

7. 家庭作业

在黄先生实际进行社会交往前，指导他练习日常的自我指导程序。

第二部分

利用认知示范会谈检测清单，评价你的会谈录音，或者让一个观察者评估你的会谈表现。

第三部分

1. 解决方法的实施和证实
2. 作出决定
3. 列出可供选择的解决方法
4. 问题界定
5. 问题引导
6. 问题解决的基本原理
7. 问题引导
8. 问题界定

9. 列出可供选择的解决方法

10. 解决方法的实施和证实

第四部分

利用问题解决会谈检测清单评价你的会谈录音，或让观察者评价你的会谈表现。

第十五章 认知治疗和认知重建

在过去的二十年时间里，认知治疗的概念和实践都发生了很大的变化。认知治疗包括各种治疗技术与理论，它们都基于这样一种预设，即求助者的情绪与行为问题源自于他们的知觉和解决事件的方式。有三种认知水平对产生情感和行为困境有着重要作用：1) 自动思维；2) 图式或认知假设；3) 认知歪曲。临床疗效有赖于认知三个水平的改变，即认知重建。

本章目标

1. 在给出的个案中，能够识别和描述出认知重建法的六个组成部分。
2. 在角色扮演会谈中，向另一个人讲授或展示认知重建法的六个组成部分。

认知治疗的发展

Mahoney提出，在过去三十年中认知心理治疗领域中主要概念的进展表现在：1) 理性主义者与建构主义者在认知概念上分野；2) 认识到社会、生物及具体因素的作用；3) 重新评价无意识过程；4) 更加关注自我和社会体系；5) 重新评价情感和经验过程；6) 认知心理治疗对心理治疗整合运动的贡献。表15-1列出了对这些进展做出主要贡献的人物名单，也是对认知治疗发展的历史回顾。

Albert Ellis创立了一种控制求助者不合理信念的心理治疗方法。Homme对内隐条件反射的研究和Cautela对内隐敏感化过程的研究，也为认知行为改变方法的临床应用奠定了基础。他们的

表 15-1 认知疗法的发展

治疗方法	
理性-情感治疗	内隐条件反射
内隐敏感化	自我引导训练
认知治疗	焦虑情绪管理训练
问题解决疗法	自我控制法
应激预防法	社会学习法

工作后来被发展成第十三章所讲述的引导想像法和第十九章的系统脱敏法。Meichenbaum 和 Goodman 的自我引导训练法在言语自我引导法与行为矫正法之间建立了联系。Beck 在 1967 年发表了他的著名论文,明确提出情感障碍是人们对生活事件的歪曲思维和不现实认知评价的结果。本章描述的一种认知重建法与 A.T. Beck 和 J. Beck 提出的观点十分相似。Suinn 和 Richardson 的焦虑情绪管理训练法是在循环抑制概念基础上发展出来的,其中求助者要使用放松法(冥想和肌肉放松)控制自己的焦虑情感。第十四章介绍的问题解决治疗是一种自我控制的认知方式,求助者在面对问题情境时要探索各种各样的反应方式。Spivack、Platt 和 Shure 发展了一种人际认知问题解决治疗方法,它是由 D'zurilla 和 Goldfried 确立的同一种技巧发展而来的。Mohoney 和 Thoresen 对于将自我控制用于认知疗法,特别是自我管理法(第二十章)做出了贡献。最后,Bandura 的社会学习理论为第十二章描述的符号示范法和参与示范法,以及第二十章描述的自我效能法提供了理论基础。本章将描述的认知重建法,被认为在认知行为治疗发展过程中具有划时代的意义。近来有人提出了认知替代概念,它与认知重建一样,都是指将旧的心理图像和规则转变成新的图像和规则。

认知重建法的应用

认知重建法来源于消除歪曲和无效的推理,抵制不合理思维和信念,和促进规则支配的行为等理论。在许多方面,认知重建都被认为是几乎所有认知行为治疗中最重要的部分。表15-2列举了认知重建的若干研究,显示认知重建可以在许多问题领域得到应用。

认知治疗和认知重建法的跨文化应用

近些年,大家都开始注意到认知治疗在各种文化人群中的应用,虽然 Hays 注意到这类应用还是太少了。Hays 认为,认知治

表 15-2 认知重建的研究领域举例

愤怒	关节炎
焦虑	体育竞赛
食欲过盛	癌症
犯罪	儿童酗酒
文化差异	抑郁
癫痫症	赌博
头疼	失眠症
生活转型期	婚姻治疗
记忆	强迫症
疼痛	惊恐
父母训练	完美主义行为
恐惧症	心理问题躯体化
酗酒行为复发	自尊
吸烟	应激
担心	书写

疗背后的价值观为主流文化的现状所支持。例如，对自我控制的强调正好适应了欧美个人自主的价值观，它可能会帮助一些求助者，但也“暗示着对某些求助者的指责，虽然他们的问题是由不公平的社会环境造成的”。

认知治疗和认知重建也受到女权主义治疗者的批评。在争取女权运动的早期，认知-行为治疗因其指导妇女进行一种新的行为方式而被人称赞。但是现在的女权主义、跨文化和生态治疗者们都不赞同这样的主张，即如果你转变了受压迫者的思维方式，现存的社会问题就会自动得到解决。而且像Kantrowitz和Ballou指出的那样，认知治疗和认知重建中的“理性思维”倾向于强化欧美中心和男权主义的认知过程和世界观；而其他的认知过程和世界观轻则被忽视，重则被贬低，妇女和少数民族的认知风格因而被否定。而且，认知治疗和认知重建挑战了人们的信念和思想，但这种挑战可能并不适合某些文化和性别的社会化模式。例如，亚洲人“在他们文化的常模中强调情感和谐，避免冲突”。

Hays认为，只有对认知心理治疗法进行适应各种文化的修正，它才能用于不同文化的求助者。实际上，修正后的认知重建法对不同求助者群体的治疗还是有效果的，表15-3列出了一些研究实例。

表 15-3 认知治疗的不同文化群体应用实例

非裔美国妇女	亚裔美国人
信仰基督教的人	有躯体残疾的人
老年人	男性同性恋者
拉丁美洲人	女性同性恋者
低收入者	美国土著人

跨文化使用认知重建法的指导原则

正如 Hays 所指出的，认知治疗和认知重建适用于各种求助者群体，但这要取决于进行治疗所采用的方式，以及“咨询者对各种文化世界观的敏感性”。我们建议使用如下的应用原则。

首先，当你描述求助者的认知时，要十分谨慎自己使用的语言。我们不提倡对求助者使用“合理”或“不合理”等术语，而且我们认为这些词汇（甚至包括其他词汇，如适应不良，或功能失调等）特别不适合于那些处于社会主流边缘的人，如同性恋者、少数民族等。因为这些词汇会进一步降低这些人的自我效能感，并使他们觉得自己是边缘人群。

第二，出于教育而不是治疗的目的为某些文化的求助者讲解认知重建的基本原理，会帮助他们消除对精神健康治疗的误解。指定具体家庭作业的教学方法是有用的。

第三，要使认知重建中使用的语言接近求助者的母语习惯，并适合求助者的年龄、受教育程度，以及他们的听、看、阅读的能力。考虑到步骤的合理性，要一步一步地进行，而不要几个步骤同时进行。要提供适用于多种文化的应对技能和思想的具体例子。

第四，要雇用本族的双语助手来帮助你处理心理社会应激源及种族歧视问题。要记住，对于那些处于社会边缘的求助者，强调上述因素与强调个人内部认知问题同等重要。还要考虑到，以群体方式进行认知重建可能比个体方式更有效。

认知重建的六个组成部分

我们将从六个主要方面来介绍认知重建法。并在本章结尾的认知重建会谈检测清单中对这六个组成部分进行了详细描述。

1. 基本原理：目的和概要

2. 在问题情境中识别求助者的扭曲思想
3. 引入和练习应对思想
4. 用应对思想替代自我否定思想
5. 引入练习积极的、自我强化的自我对话
6. 布置家庭作业及复诊

治疗基本原理

认知重建的基本原理在于，它尝试加强求助者有关“自我对话”能影响行为的信念，特别是关于自我否定思想或消极自语能引起情绪烦恼并干扰行为的信念。解释原理时所使用的例子要与求助者的性别和文化相关联。

基本原理 下面是一个用于治疗一般行为焦虑的原理解释例子。

我们的目标之一是要让你意识到自己的思想或对自己所说的话，正是这些内部思想活动使你焦虑。当我们找出这些习惯性的思维后，我们就有办法替代或改变它们。这些思想的产生可能与某种情境有关，也可能与这种情境引发出的情感有关。无论这种习惯性思想是如何产生的，它们都会引起你身体中的某种生理反应。生理反应，加上思想和情感，一起影响和干扰了你的行为。如果我们能意识到这些自动思维，我们就可以改变它们。

概况介绍 下面是一个介绍治疗概况的例子。

我们怎样对付你的自动思维呢？首先要意识到这种思想何时出现，以及这些自我对话的内容是什么。认识自我否定思想是改变和减少焦虑的第一步。每当意识到自我否定思想出现时，它们就应像亮起了红灯或响起了警铃，这时我们就要用自我肯定的思想来替代自我否定。转到自我肯定的内部对话后，你的生理反应和情绪反应也会变得积极和自我肯定

起来，从而使你行为中的焦虑减少。我们将学习在行动中或行动前、后，怎样使思想由自我否定转变为自我肯定。

自我否定和自我肯定思想的对比 认知重建法除了要向求助者讲述基本原理以外，还要将自我肯定或合理思维与自我否定或不合理思维进行对比，这样才能使求助者在治疗过程中知道如何区分这两种对立的思想。许多能从认知重建治疗法中获益的求助者，就是因为他们以前对自己的自我否定思想意识太强烈，而对自我肯定的思想没有意识或不能产生自我肯定的想法。提供两种想法的对比就能帮助他们明白如何培养更切合实际的思维模式。

进行两种思想对比的一个方法是，示范一些积极肯定的自我陈述或消极否定的自我陈述的例子，这些例子既可以是咨询者自己的个人体验，也可以与求助者的问题情境有关。另外，例子内容要与求助者的文化相关联。例子可以发生在问题情境出现之前、之中或之后。例如你告诉求助者说，有时要与某人第一次见面时自己会感到紧张，这时就会有許多非常消极的想法出现，如：

会见前：

“如果我们见面不愉快怎么办？”

“如果这个人不喜欢我怎么办？”

“我肯定会弄糟这次建立良好关系的机会。”

会见中：

“我没有给这个人留下好印象。”

“这个人可能希望我们的会面早点结束。”

“我只想早点结束，离开这儿。”

“我肯定这个人不想再见到我。”

会见后：

“啊，会面糟透了。”

“我从来不能与陌生人进行很好的交谈。”

“我也许再也不能进行这样的会面了。”

“我的话听起来多么愚蠢。”

与之相反，你可以提供一些在同样情境下的积极的、自我肯定的例子。

会见前：

“我会通过见面了解、认识这个人。”

“与他会谈时，我会表现我自己。”

“我会找一些我喜欢的话题来谈。”

“这只是初次会面，我们还会有更多见面的机会。”

会见中：

“我要从这次会面中学会些东西。”

“谈话的内容我了解一些。”

“这次会面给我一个机会来谈论_____。”

“需要一些时间来了解这个人，对方也会是这样。”

会见后：

“会面还可以，它肯定不是一次失败的会面。”

“我知道会谈中我能很容易地讨论主题。”

“每次与陌生人会谈，都会使我有机会认识更多的人，了解更多的事。”

“我能很好地展现我自己。”

自我否定思想对行为的影响 讲述基本原理的最后一部分，是明确地向求助者指出，自我否定或消极的自我对话没有任何积极作用，相反会影响人的情绪和行为。人们通常会相信自己所说的话，并照此行动。但是在很多情境下，人们往往不需要将一些事情用语言明确告诉自己，因为人们的思想已经习惯化，能够自动地反映出自己的认知图式。因此，求助者要在咨询以外的时间不断地提醒自己检测和记录实际情境发生的过程。

介绍认知重建法的基本原理非常重要，怎么强调都不过分。如果原理没有解释清楚，也没有得到求助者的同意，就很快进行

治疗程序，结果很可能事与愿违。防止出现这种情况的一个办法是提高求助者的自我效能感，这就需要让求助者有足够的时间反复练习，直到他能够没有困难地进行思想转换。通过反复练习，求助者能获得足够体验，使自我肯定思想也变成习惯化的内部活动。练习会使求助者不再坚持自我否定思想，能更现实地阐述体验。而且，反复练习还能提高求助者对治疗过程的自我效能感。只有当求助者认为可以实施治疗措施后，咨询者才能开始着手治疗工作。

识别求助者在问题情境中的思想

下一步是要分析求助者处在焦虑或痛苦情境中的思想，要考察情境的范围和求助者在该情境中的思想内容。

对问题情境中思想的描述 在会谈中，咨询者要仔细询问求助者的苦恼情境，以及求助者在该情境出现前、后和情境中的各种思想。如，咨询者对求助者说：“坐下来，考虑一下那些真的令你烦恼的情境，它们是怎样的？”然后继续问：“你能确切地说出在你进入之前，你正在想些什么或是对自己说些什么吗？在该情境中，你都想些什么？情境之后，你又想些什么呢？”

在识别消极或自我否定思想时，咨询者要为求助者提供一些描述线索。咨询者可以指出消极思想有“担心特征”（如“我害怕……”），或者“自我指向特征”（如“我做不好”）。消极思想还可有“杞人忧天”式的内容（如“如果我失败，那将是非常可怕的”），以及夸张的内容（如“我从来都做不好”、“我肯定会搞砸”）。求助者通过问自己下述问题，来确定导致情境焦虑的自我否定思想的范围，“我1）对自己提出不合理的要求了吗？2）感觉到别人在注意自己的行动了吗？3）忘记了这仅仅是我生活中小小的一部分了吗？”

生活事件和情绪之间连接演示 如果求助者难以辨认消极思

想, Guidano 建议使用电影放映法的技术, 帮助求助者在自己的头脑中演示情境过程。“就像求助者正在剪接室里编辑电影, 向前向后地慢动作放映画面, 然后停在某幅画面, 并注意其中的某个细节”。咨询者要指出, 思想是情境与情绪之间的连接物, 求助者要特别注意连接物的情况。如果求助者仍然不能辨别出消极思想, 咨询者就要演示这种连接, 或者用求助者自己的问题情境, 或者以咨询者本人的生活为例。如下例:

这是个发生在我身上的例子。我在大学主修音乐, 一年中我要进行几次钢琴演奏会, 由系里的老师评分, 老师、朋友和陌生人都可以参加。每一次临近演奏会时, 我都变得紧张不安, 常担心失败。当时我并没有意识到演奏会这个事件与我感到紧张不安之间的联系, 但我现在仍能记得我当时的一些想法, 如“我走上舞台脑子一片空白怎么办?”“我的手臂变得僵硬, 无法演奏怎么办?”“如果别人看到我的膝盖发抖怎么办?”等等。那么现在你能回想出, 当你对……感到心烦时的那些特殊思想吗?

识别出求助者的歪曲思想 认知治疗的新发展是强调求助者认知图式在问题情境中的作用, Goldfried 将图式定义为“人对某种情境或某人过去经验的认知表述”。图式为我们提供了了解求助者扭曲思想的途径。例如, 如果求助者具有一种自卑或被抛弃的图式, 那么他所注意的都是些与失败、孤独、拒绝等有关的信息, 而不会注意到那些与成功、人际交往、被人认可等有关的信息。一般来讲, 关于自我和他人的图式产生于童年早期的认知表述, 特别是早期的依恋类型。

儿童期的社会政治环境也能影响图式的发展(见第十一章所述的各种世界观)。例如, 一个遭受或目击创伤事件、歧视和迫害场景的儿童, 他所发展出的图式与没有受到这些场景影响的儿童图式就会有所不同。Nolen-Hoeksema、Girgus 和 Seligman

的纵向研究表明，应激生活事件能导致儿童的消极认知风格，从而又会导致成人以后出现忧郁情绪。

Leahy 注意到，虽然动摇求助者建立在儿童时期的图式很困难，因为儿童前操作期的认知加工“带有明显的自我中心、奇妙的思想和是非分明的特点”。但是他相信，探索 and 了解求助者歪曲思想背后的特殊图式是很有帮助的。探索过程的问题如下：

你的父母（兄弟，同龄人，老师）怎样教你，你是_____（填入最能描述求助者图式的一个词）。当你学习这种图式时你才 5 岁，你认为用一种 5 岁时的思想指导你现在的的生活是明智的吗？

你有什么根据认为你不是_____或者你是_____（填入最能描述求助者图式的一个词），你对自己的要求是什么？你将永远是无能、失败、依赖别人或被人否定的吗？

现在你是一个成年人，如果他们描述你像_____（填入一个最能描述求助者图式的词），你将怎样与你的父母争论？

求助者演示自己的思想 咨询者可以让求助者在咨询会谈之外以家庭作业的形式，监测和记录实际生活情境和思想，以辨别问题情境和其中的思维。家庭作业最初是让求助者每天观察和记录在紧张情境下的三个自我否定语句，连续记录一个星期。可以记日记或日志，如图 15-1。

日期_____	星期_____	
情境	情绪	自我否定思想
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.

图 15-1 日记表

咨询者和求助者共同分析记录,辨别出哪些是自我肯定而有效的思想,哪些是自我否定而无效的思想。求助者自己要学会进行辨别,并了解为什么自我否定思想和无效的思想相联系。这样做可以达到几个目的。第一,它能确定求助者的心理资源中是有积极和消极两种成份呢,还是只有消极思想。第二,这些资料也能表明求助者在某种实际情境中苦恼的程度。如果原本就有一些积极的思想,求助者就应意识到自己的思想风格中存在着可用来替代消极思想的东西;而如果原本只有消极的思想,这就暗示着对这个领域要特别加以注意。

引入和练习应对思想

在这一步,咨询过程应将注意从求助者的自我否定思想转到与之不相容的积极思想上。这种不相容的思想被称做应对思想、应对自我陈述或自我应对指令。每个求助者的应对思想都是不同的,不存在所有求助者都能接受的共同的合理信念,这与理性-情绪治疗法的通常做法是不一样的。

就我们知道的而言,引入和练习应对自我陈述是认知重建法取得成功的关键。实际上,只是进行应对自我陈述的练习也可以取得疗效,其效果甚至不低于找出消极思想并用积极思想替代之的过程。

应对思想的解释和举例 要向求助者解释清楚引入应对思想的目的,要使求助者了解到思考失败体验的同时又要想以自己最大的努力做成一件事,这是很难做到的。咨询者可以这样来解释引入和使用应对思想的目的:

到目前为止,我们找出了你在_____情境中曾产生的一些自我否定思想。只要你想到这些思想,你就会感到焦虑。但当你用应对思想替代它们时,应对思想就会占主导地位。这是因为,思想既集中在对失败的担心上,又尝试应对思想,这

几乎是不可能的。应对思想会帮助你处理情境中的各种问题。

咨询者还应示范一些应对思想的例子，使求助者能确切地区分自我否定思想和应对思想。如下面几个做某事之前的应对思想例子：

“我以前做过这件事，结果并没有我想像得那样糟糕。”

“做事之前要保持冷静。”

“尽最大可能去做。不要担心别人的看法。”

“这是一个富有挑战性的情境。”

“还不太坏，只有少数人去那儿。”

“集中注意力于工作。”

下面是几个做事之中的应对思想例子：

“注意力集中在工作上。”

“只去想我要做什么或说什么。”

“放松些，我能够专注于情境。”

“停一下，做一个深呼吸。”

“慢慢来，还有时间，不要着急。”

“好吧，不要失去控制，这是需要应对的信号。”

如果你重复阅读上述句子，你可以发现它们之中存在着一些细微的不同，它们可以分为四种应对自我陈述：（1）情境指向应对自我陈述，它可以帮助求助者减少对情境威胁或严重情况的预期水平，如“它还不太坏”，或“只有少数人在看着我”；（2）与求助者计划、步骤和行为有关的应对自我陈述，如“只想着任务”、“只去想我要做什么或说什么”、“我要完成什么任务？”，这类自陈被称为任务指向应对自我陈述；（3）应对惊慌失措的自我陈述，如“保持冷静”、“保持镇静”、“放松，做一个深呼吸”；（4）第四类被称为积极自我陈述，用于让求助者对自己的应对行为进行强化和鼓励，包括自我指导，如“真棒，我做到了”、“我设法通过了”，积极自我陈述可在一个压力很大的情境中使用，特别是在应

对情境过后使用。

在解释和示范应对思想时，咨询者要指明应对思想与控制思想的差异。应对思想可以帮助求助者适当地处理或应对情境、事件或人，而控制思想则是一种旨在帮助人用几乎是无缺点的方式“征服”或控制某一情境。对于某些求助者来说，控制思想近乎完美的标准，在现实中是很难达到的，控制思想只能使他们感到更大的压力，而不是减轻压力。因此，我们建议咨询者避免使用控制性自我陈述的示范，也要警惕求助者在随后的认知重建的练习期间，自发地使用控制性自我陈述。

求助者自我应对思想的例子 在提供了一些例子之后，咨询者要让求助者考虑另外的应对陈述。求助者可以提出他们在另外情境中使用的自我肯定或积极的自我陈述。要鼓励求助者选用自然出现的应对思想。

求助者进行实践 选择好应对陈述语后，要让求助者大声地用语言练习应对陈述语。这是非常重要的，因为大多数求助者还不习惯于使用应对陈述。这样的练习可减少求助者最初的不适感，并加强他们产生积极自我陈述的信心。另外，受过“正规”系统训练的求助者，能够产生更多的积极应对陈述，也可以产生一些特殊的应对思想，并且在现实中能够前后一致地使用应对思想。

起初，求助者可以用语言练习单个的应对陈述。当求助者逐渐习惯练习这些应对思想后，就要按照它们在真实场景中的顺序进行练习。首先，练习某个情境出现之前应进行情境准备的应对自我陈述，然后练习在情境之中的应对思想——将注意力集中于任务，并应付惊慌失措感。

让求助者积极参与这些练习相当重要，咨询者应确保求助者不只是简单、机械地练习应对思想；相反，要在练习过程中不断内化应对自我陈述的意义。促使求助者积极参与的方法之一是告诉求助者，他们要装做正在为很多听众演讲，演讲要有说服力，使

别人能明了自己的观点。

用应对思想替代自我否定思想

在求助者辨别出消极思想，并练习了各种应对思想后，就可以开始让求助者进行在某种压力情境中使用应对思想来替代自我否定思想的练习。这种替代练习可以帮助求助者把自我否定思想作为线索，一旦出现，就要立即转变为应对思想。

咨询者演示思想替代 在要求求助者尝试之前，咨询者要首先进行示范，使求助者准确地了解怎样进行这种替代练习。下面是咨询者向一个高年级学生进行示范的例子，这个学生常在竞赛情境中变得“僵硬”。

现在我坐在这里，等待着轮到我去进行啦啦队队长的选拔竞赛。哦，我能感到自己变得非常紧张（焦虑感）。现在，我为什么会这样紧张？我想我可能演砸（自我否定思想）。唉，这没有用（应对开始的线索）。竞赛不过只需几分钟，很快就会过去的。此外，只有老师在观看，而不是整个学校。（情境指向应对思想）。

排在我前面的那个人差不多做完了。哦，他们正在叫我的名字。我感到很紧张（焦虑感）如果我完不成跳跃怎么办呢（自我否定思想）？好了，不要去想我不会做的事情。出发，轮到我了。只去想我的工作（任务指向应对思想）。

求助者进行替代练习 在咨询者进行了演示之后，求助者接着进行辨别、停止自我否定思想，并用应对思想替代之的练习。咨询者应监督求助者的练习过程，必要时进行辅导。替代练习包括四步。

1. 求助者想像压力情境，或在角色扮演情境中扮演自己。
2. 要求求助者辨认出自我否定思想的出现，并举手示意。
3. 告诉求助者停止消极的思想，或重构这些思想。

4. 要立刻用应对思想替代消极的思想。要给求助者一定的时间,去注意应对思想。最初求助者可用语言说出应对思想,以后则可不出声地练习这个过程。

当求助者能识别、停止和替代自我否定思想后,咨询者可以逐步减少帮助的次数。布置家庭作业之前,求助者要能够在会谈中全部以自我引导的方式完成整个替代过程。

引入并练习积极的、自我强化的自我对话

认知重建法的最后一部分是要教会求助者如何对应对行为进行自我强化,它包括咨询者示范和求助者练习。许多求助者只有自我否定的思想,而没有或很少有积极、有益的自我评价。另一些求助者可以用任务指向的应对思想来替代自我否定思想,但他们对自己的进步不感到满意。认知重建法中的积极自我(强化)陈述的目的,就是帮助求助者学会赞扬或祝贺自己的进步。尽管咨询者能在会谈中提供社会强化,但求助者不能在面对压力情境时,总依赖于从别人那里得到鼓励和支持。

积极自我陈述的目的和例子 咨询者要向求助者解释强化自我陈述的目的,并提供一些具体例子,如:

Joan,你知道在处理这些情境时,你做得真是很好;你已经学会停止自我否定思想,并用一些应对思想替代它们。现在是表扬自己进展的时候了。我将帮助你学会如何用自我强化思想鼓励自己。以后只要你成功地应对了某种情境且没有惊慌失措时,你就要给自己鼓励。这种自我鼓励的方法将帮助你注意到自己的进步,从而避免变得灰心。

然后,咨询者提供一些强化自我陈述的例子。

“呀,我做到了。”

“嗨,我很好地应付了。”

“我没有让焦虑的情绪战胜自己。”

“我取得了一些进步，感觉很好。”

“看，不是进行得很好吗。”

选择积极自我陈述 提供例子后，咨询者将要求求助者找出另外的积极陈述语。求助者应选择他自己觉得合适的陈述语，这很重要，因为陈述语强化作用的大小完全取决于求助者个人。

咨询者演示积极自我陈述 咨询者要向求助者演示，在应付某一情境之后如何运用积极自我陈述。在下面的例子中，咨询者为一个被教养的少年示范如何进行与父母面对面的会谈。

我能感到他们给我的压力。他们想让我谈，可我不想谈。我只想离开这儿。（自我否定思想）。慢着，等一会儿。不要给自己压力，保持冷静。（应对惊慌失措感）好，很好。（积极自我陈述）。

好，结束了。不是太坏，我坚持到结束了。这是一个进步。[积极自我陈述]

积极自我陈述的练习 求助者练习在某一压力情境中以及结束后使用积极自我陈述，进行自我鼓励。练习开始是在咨询会谈中进行，此后逐步增加在会谈之外现实场景中的练习。

家庭作业和复诊

家庭作业是认知重建法的组成部分，求助者最终要能够在任何实际情境中使用认知重建法。求助者应能在实际生活场景中使用认知重建，但不要期望自己能很快成功，求助者可以用几个星期的时间监督和记录使用认知重建法的情况。

咨询者可以提供类似图15-2的家庭作业记录日志表，来帮助求助者做记录。在下次的咨询会谈中，咨询者要与求助者一起总结日记资料，以确定求助者使用认知重建法的次数和所取得的进步。咨询者还要鼓励求助者在将来可能出现的压力情境中运用这个程序。

日期/时间	情境	习惯性思想	情绪	应对反应	结果
	1.引起不愉快情感的 的真实发生的事 件、思想、空想、或 回忆 2.有什么样的躯体 紧张感觉吗?	1.有什么样的思想 和表象在头脑中产 生? 2.你每次对每种习 惯性思想的相信程 度有多大(0到 100%)?	1.你所体验的到怎 样的情绪(悲伤/ 焦虑/愤怒等)? 2.情绪强烈程度如 何(0到100%)?	1.有怎样的认知歪 曲? 2.使用表格下面的 问题对习惯性思想 做出反应 3.你對自己做出的 反应的相信程度有 多大(0到100%)?	1.你对习惯性思想 的相信程度多大? 2.你现在体验的情 绪如何?其强度如 何(0到100%)? 3.你打算做什么 (或已经做了什 么)?
星期五(2 /23) 10am	与 Danna 通电话	她不再会喜欢我; 有90%的可能性	悲伤; 80%		
星期二(2 /27) 12am	考试复习功课	我肯定学不会; 100%	悲伤; 80%		
星期四(2 /29) 5pm	考虑明天的经济学 课程	我也许会被老师问 到,我不能很好地 回答; 80%的可能 性。	焦虑; 80%		
	注意到心脏跳得快 起来; 注意力难以 集中	我怎么啦?	焦虑; 80%		

帮助产生应对反应的问题: (1) 有没有证据表明习惯性思想是真实的? (2) 有没有其他的解释? (3) 最坏的可能结果是什么? 我能扛过去吗? 最好的可能结果是什么? 最现实的结果是什么? (4) 我相信习惯性思想的后果是什么? 如果我改变这样的思想, 其结果会是什么? (5) 我应当做些什么呢? (6) 如果——(朋友的名字)处于我的情境中, 并有同样想法, 那么我应当告诉些什么?

图 15-2 家庭作业日志表举例

有时，求助者在反复进行自我否定思想的认知重建练习后，其苦恼水平并未有所减轻。对某些求助者来说，消极自我陈述并不都是先于或导致强烈感情。某些情绪的出现是由于条件反射，因此用去条件化程序可能更为适合，如系统脱敏法（见第十九章）。当然，即使出现条件反射式的恐惧，认识重建过程也可以在保持或减轻害怕方面起到一定作用。

当认知重建不能减轻求助者的烦恼、忧郁和焦虑水平时，咨询者和求助者就需要重新考虑问题和目标。治疗的焦点可能要更多地针对外部的社会心理压力，而不是内在事件。治疗者应考虑他所做的问题评估可能不准确，实际上可能并不存在与求助者的特殊问题在功能上相连的内部言语。应记住，对问题的最初评估并不总是确切的。

假定最初的评估是准确的，那么也许需要对认知重建程序进行部分修改。下面是一些可能的修正：

1. 求助者用来进行思想替代和想像积极应对思想的时间应当增加。
2. 求助者所选择的应对陈述语可能没有效果，要帮助求助者改变应对陈述的类型。
3. 认知重建法需要辅助性的应对技巧，如深呼吸、放松、技能训练等。

认知重建失败的另一个可能原因是，求助者的问题行为是由认知编码错误而非推理错误造成的。在下一章，我们将描述另一种治疗策略（再构法），用以改变编码或知觉错误。

学习练习活动 44/ 认知重建法

I. 请仔细阅读下列8个陈述句，确定哪一种自我否定的，哪一种自我肯定的。记住自我否定思想是消极的、无益的，自

我肯定对一种情境或自我的解释是现实的、有价值的。答案见学习活动反馈 44。

1. “现在有了这个意外，我再也不能做任何事了。”
2. “当我不知道我想说什么时，我怎么能进行一个好的演讲？”
3. “使用轮椅不像看上去那样困难，我能到我想去的任何地方。”
4. “我不得不离开儿子到这个国家来。现在他也来了，但我知道他不想与我发生任何关系。”
5. “我需要考虑的是我想说什么，而不是我应该说什么。”
6. “如果不得糖尿病，我可能会有很多机会。”
7. “反正她可能不想和我出去约会，为什么还要去邀请她呢？”
8. “我当然愿意我女儿同一个男人结婚，但如果她选择单身或是与另一个女人生活，我也会同意。我爱她，这也是她自己的生活。”

II. 这个学习活动可以帮助你进行个性化的认知重建。

1. 识别你的一个问题情境——你不想做任何事，不是因为你不会做，而是由于你的消极、自我否定思想，下面是一些例子：
 - a. 为了提升、晋级或调换岗位，你必须接近你的老板。你知道要说什么，但你又没有这样做，因为你不相信这会有什么效果。你不确信老板会有怎样的反应。
 - b. 你具有成为一个有效咨询者的技能，但你总认为自己缺乏这样的技能。
 - c. 虽然他人对你处理某种情境的评价是积极的，但你总是想着不能很好地应付它。
2. 在一周中，每当这种情境发生时，就要检测你在情境前、

情境中和情境后的所有想法,并在日记中记下来。在周末,你可以:

- a. 识别哪种思想是自我否定的。
 - b. 识别哪种思想是自我肯定的。
 - c. 确定自我否定思想主要发生在情境前、情境中还是情境后。
3. 记录你在这—情境前、情境中和情境后使用自我肯定思想的情况,特别注意你几乎都是自我否定想法的时期是否也包括日记中的某些积极或自我奖励的思想。
 4. 想像这个情境,停止任何自我否定思想,并用应对或自我奖励的思想替代它们。你甚至可以用角色扮演法来练习,直到你感到能控制你的应对或自我奖励思想。
 5. 为你自己设想一个家庭作业,鼓励自己当出现自我否定思想时,就使用认知重建法。
-

认知重建法示范对话

本次与Joan进行会谈的主要目的是帮助她用应对思想替代自我否定思想。这是认知重建法基本和主要的特点。

1. 咨询者:很高兴再次见到你,过去一周好吗?

求助者:很好,我做了大量练习,并尝试在数学课上也进行练习,它有些帮助,但我还是感到紧张。这是我的日记。

在对话2中,咨询者讲述了认知重建的基本原理,向Joan解释了应对思想的目的,并介绍了该治疗方法的概况。

2. 咨询者:今天我们要学习使用一些更具建设性的思想,我把它们称为应对思想。你可以用应对思想替代消极思想。当你想到数学课时、在你上数学课时、进行数学测验或到黑板前演算时,应对思想会帮助你。对这些你有什么问题吗?

求助者：我不太明白你讲的应对思想是什么意思。

咨询者在对话3中解释了应对思想，并给出了例子。

3. 咨询者：好，让我来解释一下，并给你一些例子。然后你要考虑一些自己的例子。首先，有许多时候你需要使用应对思想，如想到要上数学课时，你不要去担心它，而是要准备去应对它。你可以使用这样的应对思想，“不需要这样紧张，只想怎样做对”，或“你能对付这种情境”，或“不要这样烦恼，你有能力做好”。然后，在数学课上，你也能使用应对思想使自己集中于正在做的事情，如“做好心理准备完成它”，或“将数学课看成挑战，而不是威胁”，或“保持冷静，你能控制自己的焦虑”。如果在某些时候特别困难，如进行考试或走到黑板前演算等，你可以使用下面的应对思想进行应对，如“冷静地想一想”，或“放松，做一个深呼吸”、“尽量使自己放松，很快就过去了”。上完数学课后，或应付了某个困难情况之后，你可以用积极的想法来鼓励自己，如“我做到了”、“我能控制自己的消极思想”、“你正在进步”等。你明白这种思想了吗？

求助者：是的，我想我明白了。

下一步，在对话4到7中，咨询者将指导Joan选择应对思想，并进行练习。

4. 咨询者：Joan，我们每次只做一件事情。你在上数学课之前想什么？你能想出在上数学课前的一些应对思想吗？

求助者：好。（暂停）我考虑到只去想解题，而不要担心自己。

5. 咨询者：很好。现在尝试去找到那种感觉，并练习使用它们。想像你将要上数学课，将你的应对思想大声地说出来。

求助者：我正在想，把数学课当做一种挑战。我要只想着我怎样去解题。当专注于自己的数学问题时，我通常会找

到答案。

6. 咨询者：很好。说出来的感觉怎样？

求助者：不错。我明白这种方法会怎样帮助我了。但是我通常都不会这样去想。

7. 咨询者：我知道。我们以后会实际练习如何使用这些思想，使你能够做到把焦虑当做进行应对思想的信号。一出现这个信号，就停止自我否定思想，并练习使用替代用的应对思想。

在对话8、9和10中，咨询者让Joan选择和练习用语言表示出应对思想。

8. 咨询者：Joan，现在你在上数学课前已经有几种应对思想了。那你在上数学课时，能使用哪些应对思想呢？

求助者：我可以对自己说，别的不要去想，只去想所要解决的数学问题。一次只尝试解决一个问题。我知道，只要我相信自己能上好数学课，我就一定会学好数学。

9. 咨询者：好像你已经准备好了几种在数学课上运用的应对思想了。现在就可以假装你正在上数学课，想着刚才的应对思想，并把它们大声地说出来。

求助者：好。我正坐在座位上，在桌子上放着我的作业。现在我需要做哪一步呢？我应该一次只想一个问题。不必同时想着所有的问题。如果我慢慢做，我就能做好。

10. 咨询者：这似乎对你来说很容易。现在多做几次练习，以便使这些应对思想更加熟练和自然。练习时，要同时认真思考你对自己讲话的意义。（进行更多的练习）

下一步，Joan选择和练习那些帮助她应付数学课上出现的特别紧张情境的应对思想（对话11、12和13）。

11. 咨询者：现在让我们想出一些特别的应对自我陈述，以使你能够在数学课上应付那些令你特别焦虑的情境，如数学

测验、到黑板前进行演算，或被老师叫起来回答问题。每当这样的时刻，你都想到什么来压制紧张呢？

求助者：我要想我应该做什么。也许，象你刚才说的那样，做一个深呼吸，想着保持冷静，不要让我的焦虑战胜我自己。

12. 咨询者：非常好。现在你来大声地说出这些思想，就好象你正在进行考试，或者被叫起来回答问题。

求助者：好吧。我正站在黑板前，我在考虑着如何解决这个问题。如果我开始感到紧张，我就要做一个深呼吸，并集中注意力，使自己保持镇定。

13. 咨询者：让我们再练习几次。这次你可以使用第一种紧张场合，如被老师点名。（继续练习）

接下来，咨询者指出 Joan 在课后出现的失望和惩罚性思想（对话 14、15）。要求 Joan 选择和练习那些自我鼓励、自我奖励的思想（对话 16、17、18）。

14. 咨询者：Joan，在数学课后，你通常想什么？

求助者：我感到如释重负，很高兴数学课结束了。有时我会想着我没做好的情况。

15. 咨询者：这样的想法会使你泄气。我想你应该学会使用应对思想进行自我鼓励，它会对你有所帮助的。换句话说，不要去注意做得不好的情况，要想着自己在应对焦虑上的进步。在课上或课后都可以这样做。那么你能找出一些鼓励自己的积极想法吗？

求助者：比如，我做得并不像我所想像的那样糟？

16. 咨询者：是的，类似这样的一些想法。

求助者：课上完了，还不太坏。事实上我应付得很好。如果我相信自己能做，我就能做好，并能看到自己的进步。

17. 咨询者：好。现在让我们假定你正从黑板前回到座位上。

大声说出你在这种情境中用于鼓励自己的想法。

求助者：我坐下来会这样想，在黑板前我演算得很快，我专心做题，这很好。

18. 咨询者：现在假定下课了。这时你会对自己说哪些积极和自我鼓励的话呢？

求助者：好，我正走出教室。我想，课上得不坏，我学到了东西。如果我有心去做，我是能做到的。（进行多次这样的积极自我陈述练习）

在对话19中，咨询者指导Joan练习认知重建的整个过程，即在上课前、上课时和下课后如何停止自我否定思想，并用应对思想来替代。通常求助者用情境想像来练习。

19. 咨询者：到目前为止，我们练习了在各种情况下使用应对思想的方法，你现在可能已经习惯这样想了。现在让我们按照实际的发生次序进行练习：上课前和上课时遇到焦虑情境使用应对思想，下课后用应对思想来鼓励自己。你可想像各种情境，只要出现自我否定思想，就停止去想它们，并立即转到应对思想。集中注意力于应对思想，你明白了吗？

求助者：我想，我明白你的意思。（但看上去有点茫然）

有时，指导语过长会令人困惑，进行示范可能更好。在对话20和21中，咨询者演示Joan如何在实际情境中运用应对思想。

20. 咨询者：刚才我说了很多，现在我来给你做些演示。首先，我想像正在上英语课。快要下课了，下节课就是数学课。我真希望能够不去上数学课，它使我不安。且慢！这是个信号，要我使用应对思想！我要把上数学课当做一种挑战。如果我努力，我就能做好。（暂停）Joan，你知道怎么去做了吗？

求助者：是的，我会了。

21. 咨询者：我继续想像我正在上数学课。老师让我们用30分钟完成一项作业，这真是没劲。等等，我应该想，我能完成这个作业，但我需要慢慢做，集中注意力于作业上，而不要考虑自己。要每次解决一个问题。现在老师让我们给出答案。如果他叫到我的名字怎么办？我能感觉到心跳。但我想，如果我被叫到，我只需做一个深呼吸，并进行回答。如果答错了，这也不是什么了不起的大事。铃响下课了，我正在走出教室。我感到很高兴课终于上完了。等等，我应该想，课上得还不太坏。实际上我应付得相当不错。（Joan多次按这样的顺序进行练习。开始时有咨询者的帮助，逐渐地完全自我指导）

在这次咨询会谈结束前，咨询者为Joan布置了每天的家庭作业。

22. 咨询者：我希望你能利用一周的时间每天练习几次。把你的练习记在日志表上。你认为需要的时候，就可以进行练习，如数学课前、课后等。要把练习时间也记录下来。下周我们再来检查。

学习活动反馈 44

- I. 1. 自我否定
2. 自我否定
3. 自我肯定
4. 自我否定
5. 自我肯定
6. 自我否定
7. 自我否定
8. 自我肯定
-

本章总结

在咨询和心理治疗过程中，咨询者越来越经常地使用各种认知改变方法，如认知示范法、问题解决法、再构法、应激预防法及认知重建法等。求助者对某种特殊情境的构建就像一幅照片，个人的影响或偏见会使这张照片模糊或者歪曲。本章所讲述的认知重建或替代法，就好像为求助者提供了同一情境的另一幅照片。认知结构的改变不仅仅是调整歪曲情境知觉的认知习惯、规则、公式、假设等，它也能使情绪得到释放。向任何其他的干预方法一样，认知重建法也要根据求助者的性别和文化进行修订和调整。例如，某些求助者会在群体方式下进行认知重建，并获得最好的疗效。使用认知重建法的咨询者要对求助者文化的多样性保持敏感。下一章我们将介绍其他两种认知改变治疗法——再构和应激预防。

学习评判

第一部分

本章目标一要求你能够识别和描述认知重建法的六个主要组成部分。利用下面描述的案例，简要解释你如何对这个求助者使用认知重建法。可以用下列六个问题来描述治疗过程。答案见学习评判反馈。

求助者案例：Doreen 是大学三年级学生，主修教育，并且成绩很好。她说自己社交活跃，有一些亲密的女性及男性朋友。她常感到生活无价值、无意义。她对自己的标准似乎定得太高，尽管她功课几乎都得 A，她仍责怪自己没有得到全部的 A。尽管她有吸引力，并有活跃的社交生活，但她认为自己应该更有魅力，更有才干。在初次会面结束时，她补充说作为一名黑人妇女，她似乎总是想证明自己与普通人不一样。

1. 你将怎样向这个求助者解释认知重建的基本原理？

2. 给出一个例子，说明自我否定思想和自我肯定思想的不同，尝试将你的例子建立在求助者的案例描述上。
3. 怎样让求助者识别她自己的思想——关于她的成绩、外貌、社会生活等。
4. 这个求助者可以应用哪些应对思想。
5. 在治疗中，怎样帮助求助者用应对思想替代自我否定思想。
6. 你将指定什么家庭作业来帮助求助者增加应对思想的使用？

第二部分

目标二要求你将认知重建法的六个步骤教给另一个人。用角色扮演法演示进行教授，并利用下列认知重建会谈检测清单作为教授和评估的指南。

认知重建会谈检测清单

给观察者的指导语：确定咨询者是否演示了列在清单中的提示，参照例句检查咨询者使用的提示：

项目	引导语举例
I. 基本原理	
—— 1. 解释这种治疗方法的目的。	“你提到，在与评估你工作的人的会谈期间和会谈后，你自己变得焦虑和忧郁。这个程序能帮助你识别在这个情境中无益的想法。你将会学习用更实际的方法考虑这个情境，它能帮助你进行应对。”
—— 2. 介绍概况。	“使用这个程序时，你要做三件事。首先，它帮助你识别在这个情境的前、中、后出现的各种自我否定思

- 想；第二，用应对思想替代否定思想；第三，帮助你树立改变这些自我否定思想的信心。”
- 3. 区分自我否定和自我肯定思想。
- “自我否定思想是解释情境的一种方法，但它通常是消极和无效的，如认为别人没有重视你或你所说的话。相反，自我肯定思想在解释情境时，更具有建设性、现实性，如认为你的谈话对自己是有价值的。”
- 4. 解释自我否定思想对情感和行为的影响。
- “当你担心情境中要发生什么时，它会影响你的情绪和行为。对情境的担心会使你感到焦虑、烦躁。集中注意力于情境本身，而不要担心它的结果，能使你放松，能帮助你更容易地处理情境。”
- 5. 询问求助者的意愿。
- “你准备试试吗？”
- II. 在问题情境中识别求助者的扭曲思维
- 6. 让求助者描述问题情境，找出所体验到的自我否定和自我肯定思想。
- “想想上次处在这个情境中的情况，描述你在谈话前想什么？在谈话中通常想什么？谈话结束后充斥你头脑的是什么思想？现在让我们看看哪些思想是这个情境的建设性方法；哪一种是无效的、自我否定的。”
- 7. 若求助者无法完成步骤6，咨询者就要进行示范。
- “想想会谈这件事与后来你所感到的烦躁、抑郁之间的关系，其中间环节是什么？例如，它可能是某些事，如‘我从来没有得到过好的评价’、‘我

_____ 8. 让求助者检测和记录情境之前、之间和之后的想法。

_____ 9. 根据记录，找出求助者的自我否定思想。

III. 引入和练习应对思想

_____ 10. 解释应对思想的目的和作用，举例说明：

_____ a. 情境之前，用于做好准备；

_____ b. 情境期间，用于：

_____ ①. 集中注意力于任务；

_____ ②. 避免出现惊慌的情况。

将失去这个职位’，或者‘我总是使谈话告吹，从未留下一个好印象’。你回想一下，曾有这样的思想吗？”

“一个帮助你的方法是，记录这些情境发生时你的思想。这星期我希望能每天记日记，每天试着至少识别和记录在这种情境下出现的三个特殊思想。”

“让我们看看你的日记，并仔细检查各种消极思想在哪些情境中似乎是占主导地位，探索这些思想怎样影响你在这些情境中的感觉和行动，这些思想是否有证据或根据。”

“到目前为止，我们讨论了你在这些情境中产生的消极思想，以及这些消极思想使你感觉不舒服、焦虑和抑郁。现在我们尝试以不同的角度，用建设性、积极的思想，来看待这个情境。这些思想会使你对情境的出现有所准备，能够应付情境，并应付情境中的不安、焦虑情绪。只要你能应用这些应对思想，你就可以不努力，就可以避免让自我否定思想重新支配你。下面是一些应对思想的例子。”

“试着想出一些你自己的应对思想。也许你还记得，你曾在其它情境中

____ 11. 让求助者想出更多的应对思想。

成功地利用过这些应对想法；这些想法会很适合你现在的情况。”

“现在我们将来看在这些情境中，是否可选择出更具建设性的应对思想，这些思想能帮助你为这些情境做准备、应对这个情境、对付在这个情境中感到的烦躁和惊慌。这儿是应对思想的一些例子。试着想想你自己的应对思想。”

____ 12. 让求助者口头练习应对思想：

“刚开始使用应对思想时，你会觉得有点笨拙。帮助你习惯这些方法是大声地练习这些陈述。”

____ a. 分阶段练习应对思想；

“开始时是分开练习每一个应对陈述，当你习惯了大声说这些之后，练习你在这次会谈之前使用的应对思想。好，现在练习你与你的评估者在会谈中使用的应对思想。”

____ b. 按情境顺序练习应对思想

“现在让我们一起来做，想像你是在会见前1小时，练习你能使用的应对陈述。我们用角色扮演法去演示会谈。当你感到有些惊慌这时要练习应对思想。”

____ c. 指导求助者积极参与，并将应对思想内化。

“把你自己真正融入练习中，并试着想这些思想的真正意义是什么。”

IV. 用应对思想替代自我否定思想

____ 13. 咨询者示范如何察觉到自我否定思想，并用应对思

“让我演示今天我们将怎样练习。首先，我是在会谈中，每件事都很好，

想替代它们。

—— 14. 让求助者练习转变过程

—— a. 用角色扮演像问题情境;

—— b. 察觉自我否定思想的出现;

—— c. 停止自我否定思想;

—— d. 用应对思想替代。

—— 15. 帮助求助者进行练习,直到在情境中感到的焦虑情绪降低;而且求助者可以进行自我引导练习。

V. 引入和练习积极、自我强化的自我对话

—— 16. 解释积极自我对话的目的,并举例。

—— 17. 要让求助者想出各种积极的自我对话。

突然我感觉到自己开始紧张,我知道我开始对会谈感到惊慌失措了。现在我只需集中注意力并保持冷静,做一个深呼吸,只想着我要说什么。”

“现在我们一起来练习。你要想像这个情境,出现自我否定思想时就停止它,然后大声地用语言表达,告诉你自己停止;然后适当地用语言表达应对思想,继续想这个情境。”

“让我们在这个情境中练习,直到你对它感到相当愉快,能在没有我帮助的情况下将自我否定思想转换为应对思想。”

“你在学习应对自我对话上确实有许多进步。”

“现在,是给你自己奖励的时候了。在你应对了一个情境之后,你可以为你自己骄傲,想像‘我做到了’或‘我确实应对得很好’之类积极的自我奖励思想。”

“当你感到某些事很好或当你觉得完成了一些事时,你能想像这样的一些思想吗?试试其中适合你的思想。”

—— 18. 咨询者示范将这些积极自我对话用做自我强化。

“好，这是鼓励你自己的一种方法，你已经认出了自我否定思想。现在在这个情境中应用应对思想，你正在想着‘做个深呼吸’或‘只把注意力集中在任务上’。现在，会谈完成了，你可以使用应对思想‘是的，我完成了’或‘我确实能对付它’来奖励自己。”

—— 19. 指导求助者按照情境之前、之中和之后的顺序，练习替代和自我强化。

“好，让我们试试，你正在想像这次会谈。你正用言语表达应对思想……现在，想像情境结束了，为你的顺利通过祝贺，用语言表达几种自我鼓励的思想。”

VI. 布置家庭作业及复诊

—— 20. 布置作业，在实际生活中应用认知重建法。

“现在你已经准备好将这个方法应用到实际生活中，因为在上面的练习中了，你认出并停止了自我否定思想，在情境之前用应对思想进行准备，在情境中用应对思想帮助你注意任务并对付惊慌感，在情境结束后用积极自我陈述来鼓励你的努力。”

—— 21. 告诉求助者检测和记录练习情况。

“我希望你用日记来记录你练习的次数，并简单记录使用它的情境。每次使用5级量表来评估你的紧张水平。”

—— 22. 安排复诊时间

“两周后，我们一起进行下一步的治疗。”

观察者评语：

参考文献

- Arean, P. (1993). Cognitive behavioral therapy with older adults. *The Behavior Therapist*, 16, 236-239.
- Beck, J. S. (1995). *Cognitive therapy*. New York: Guilford.
- Bedrosian, R. C., & Bozicas, G. D. (1994). *Treating family of origin problems: A cognitive approach*. New York: Guilford.
- Deffenbacher, J. L., Oetting, E. R., Huff, M. E., & Thwaites, G. A. (1995). Fifteen-month follow-up of social skills and cognitive-relaxation approaches to anger reduction. *Journal of Counseling Psychology*, 42, 400-405.
- Foa, E. B., Rothbaum, B. O., Riggs, D. S., & Murdock, T. B. (1991). Treatment of posttraumatic stress disorder in rape victims: A comparison between cognitive-behavioral approaches and counseling. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 59, 715-723.
- Freeman, A., & Dattillio, F. (Eds.). (1992). *Comprehensive casebook of cognitive therapy*. NY: Plenum.
- Grant, L. D., & Haverkamp, B. E. (1995). A cognitive-behavioral approach to chronic pain management. *Journal of Counseling and Development*, 74, 25-31.
- Greenberger, D., & Padesky, C. (1995). *Mind over mood: A cognitive therapy treatment manual for clients*. New York: Guilford.
- Hays, P. (1995). Multicultural applications of cognitive behavior therapy. *Professional Psychology*, 26, 309-315.
- Horan, J. (1996). Effects of computer-based cognitive restructuring on rationally mediated self-esteem. *Journal of Counseling Psychology*, 43, 371-375.
- Johnson, W. B., & Ridley, C. R. (1992). Brief Christian and non-Christian rational-emotive therapy with depressed Christian clients: An exploratory study. *Counseling and*

Values, 36, 220–229.

Leahy, R. (1996). *Cognitive therapy: Basic principles and implications*. Northvale, NJ: Aronson.

Mahoney, M. J. (Ed.). (1995). *Cognitive and constructive psychotherapies*. NY: Springer.

Nedate, Y., & Tagami, F. (1994). Effects of instruction through writing on subjective well-being modification: When adopting a cognitive restructuring approach. *Japanese Journal of Counseling Science*, 27, 21–26.

Sookman, D., Pinard, G. B., & Beauchemin, N. (1994). Multidimensional schematic restructuring treatment for obsessions: Theory and practice. *Journal of Cognitive Psychotherapy*, 8, 175–194.

Thompson, L. W. (1996). Cognitive-behavioral therapy and treatment for late-life depression. *Journal of Clinical Psychiatry*, 57, 29–32.

学习评判反馈

第一部分

1. 整体的目的是使 Doreen 感到自控，对她自己是个黑人妇女感到较少压力。
2. Doreen 要挑战的核心问题是关于她的种族和性的偏见系统——作为一个黑人妇女她必须不断证明她自己是一个有价值的人。只想着自己还不够好就是自我否定思想，她对自己的肯定或积极的思想是：好的成绩，亲密的朋友，活跃的社交生活等；承认自己是聪明、有吸引力的人。
3. 要求求助者描述不同的情境和当时的想法，她也可以在这一星期中进行观察，你可以示范一些她可能会产生的思想。

4. 她有许多可以应用的应对思想，如：“嗨，做得相当好”，“不要对自己如此严厉。我不是一个完美的人”，“无价值感是一个应对的信号——承认自己的吸引力”，“不要让一个B打倒，那不是世界末日”，“我是一个黑人妇女，我没有必要向别人证明我的价值”。
5. 参阅认知重建会谈检测清单的第13-16项。
6. 指定一些有帮助的家庭作业，如下例：
 - a. Doreen 每次使用应对思想都记录在日记上。
 - b. 通过在卡片上记录和阅读卡片，提醒自己使用应对思想。
 - c. 她可以要求好朋友帮助，如果他们注意到 Doreen 开始“贬低自己”，就要打断她，这时 Doreen 可以使用应对自我对话。

第二部分

使用认知重建会谈检测清单来评估你对这个程序的设计和角色演示。

第十六章 再构和应激预防

再构法和应激预防法都认为，一个人的核心信念、图式（第十五章）及其知觉和认知对于失调的情绪和思维起着影响和中介作用。两个程序都包含着认知重建和应对技能，它们能帮助求助者了解和确定知觉、认知、情绪和行为之间的关系；鉴别自己是如何对情境和经验进行解释的；并促使求助者重新结构解释框架。

本章目标

1. 在角色扮演会谈中，至少演示出11步再构法中的8个步骤。
2. 针对模拟案例，描述如何将应激预防法的五个组成部分应用于求助者。
3. 在角色扮演会谈中，至少演示出21步应激预防法中的17个步骤。

再构法的过程

在混乱无序、受虐待、被拒绝、毫无依赖可言的环境中成长起来的人，普遍表现出扭曲的归因方式。这些人常常认为自己的问题是没办法加以化解的。例如，一个曾遭到父母拒绝的男孩，成年后会说：“我没有人际交往的技能。”从他的解释框架出发，他会认为“缺乏人际交往技能”是无法改变的，因而会体验到与人进行接触的无助感。这就是他对自己人际交往技能的一种虚构信念和参照框架。这种习惯的认知图式会导致他在与人交往时自我限制性的情感、思维和行为模式。如果这个男人反复这种自我限制的循环而不能自拔，他就会体验到绝望感，并变得退缩，不愿意进行任何社会交往。他会陷入自己的认知图式中，这个认知图

式是他在对家庭状态的记忆、学习和行为体验中逐步形成的。他对社会交往的认识和情绪使他在自己的认知图式中迷失，不能知觉、认识并选择其他的行为方式。再构法正是这样一种干预方法，它可以帮助这个男人修正他的知觉方式，从而调整他的人际交往技能。

再构的意思是，首先探索个人对某事或某种情境是如何知觉的，然后再针对这个情境提供出另外一种观点或结构。再构法帮助求助者改变情绪、意义和选择；并能改变求助者日常的意识定势和对自己局限性的知觉。但正如 Gendlin 所指出的，再构“有时起作用，有时不起作用”。确定再构是否有效，你必须感觉到它所带来的躯体上的变化，必须感觉到再构在你体内实际产生的反应。一个真正的改变不仅是一种新的思考方法，它也是一种具体的躯体变化。治疗者要通过询问求助者在进行再构法时躯体的反应和感觉是什么，来评价再构法的疗效。使求助者意识到自己身体的一种技术是躯体扫描法（见第十七章）。有效的再构治疗会产生“一种可直接察觉到的躯体感觉，有一种身体释放感和补充了新能量的感觉，求助者感到可以做以前似乎是不可能的事”。有时再构最初的效果很小，在这种情况下，咨询者要鼓励求助者坚持更长的一段时间，这样它的效果就会充分地体现出来。

再构（有时又被称为重新标记）是一种修正或重新构造求助者对问题或行为知觉或观点的方法。再构经常被用于家庭治疗，它使问题得以重新定义，将治疗的注意力从“有问题的家庭成员”或“替罪羊”身上转移到整个家庭。以这样的方式，再构过程就改变了家庭对问题和冲突进行编码的方式。

对于单个求助者，再构也有若干种用途。首先，通过改变或重新构造求助者的编码和知觉方式，从而减少自我防御，并动员出求助者进行改变的自身资源和力量。第二，再构能改变求助者对自身问题的关注点，从对行为进行过分简单的归因推理（如求

助者说“我很懒”或“我不很自信”等)转变为分析行为的情境因素和线索。最后,再构也是一种帮助求助者建立自我效能感的有用策略(见第二十章)。

再构法的应用

表16-1列出了目前关于再构的一些研究。从中可以看出,使用再构法有这样几种目的:改变有关艾滋病的信息,减少社会和考试焦虑,照顾困难儿童,影响认知改变,帮助求助者应付忧郁、疾病、痛苦和惊恐。

表 16-1 再构法研究领域举例

艾滋病预防	焦虑
儿童与青少年	认知调整
决策	抑郁
再构失败	家庭治疗
疾病	狼疮
精神健康	老人
疼痛	惊慌
父母行为	抗拒
吸烟行为	咨询指导
不治之症	创伤

意义再构

当咨询者要求或鼓励求助者从不同的角度看待自己的问题时,他使用的就是再构。本章将介绍一个系统再构方法。最广泛使用的再构方法要对问题情境和问题行为的意义进行再构。咨询者进行意义再构时,就是挑战求助者为自己问题行为赋予的意义。通

常一个特殊的意义（标签）与求助者行为联系的时间越长，这个行为在求助者整体功能中的作用也越强。随着时间的延长，求助者有可能将某种功能固定化，即是说他只用一种方式或一种角度看待事物，并顽固地认为某种情境或特性就是问题本身。再构的作用就是为求助者提供新的视角去看待自己的行为，而不是直接针对行为本身；此外就是扩展求助者的知觉框架，从而为其他治疗方法奠定基础。当一个人对行为或情境意义的认识发生改变时，他对特定情境和行为的反应也会随之而变化。意义再构的本质是给某种情境和行为一个具有不同意义的新标记和新名称。新的意义要具有不同内涵，而且通常是积极的内涵。例如，求助者的“顽固”可以再构为“独立”，“贪欲”可以再构为“雄心”。

再构法包括六个步骤：

1. 基本原理：治疗的目的和概况
2. 识别求助者问题情境的知觉和情感
3. 仔细选择问题情境的知觉特征
4. 提出他的知觉关注点
5. 调整问题情境知觉
6. 家庭作业和复诊

治疗原理

使用再构法要强调的是，求助者对问题情境的知觉和归因是其情绪痛苦的原因。下面是一个介绍再构使用原理的例子：

当我们想到或处于问题情境时，我们会自动有选择地注意其中的某些特征。逐渐的我们倾向于将注意力固定在这些情境特征上，而忽略情境的其他方面。这就有可能导致某些烦恼的情绪，就像你现在的感觉一样。在这个治疗程序中，我将帮助你辨别出在问题情境中，你通常会注意到哪些方面。然后，我们将努力增加你对那些不曾给以关注的特征的意识。

注意的内容改变后，你会发现你对问题的情感和反应也会开始发生变化。你有什么问题吗？

识别求助者的知觉和情感

假定求助者懂得了咨询者讲述的原理，下一步就是帮助他意识到自己会自动注意到问题情境的哪些方面。求助者通常不能意识到问题情境的特征和细节，不能意识到编码的情境信息。例如，怕水的求助者可能只注意水的深度，因为他们不看到水的底部，并将知觉编码为“我可能会被淹死。”有考试焦虑的求助者可能只注意房间大小和其他人答题的速度，这些情境特征被编码后导致求助者惊慌焦虑，并使自己缺乏自信，而这些感觉又将导致成绩不理想，甚至逃避考试。

治疗者在会谈中要帮助求助者发现他们在问题情境中注意的特征是什么。可以使用想像法和角色扮演法来让求助者重现问题情境，并找出他们的关注点。在求助者进行想像或角色扮演时，治疗者可以通过下列问题来帮助求助者意识到自己的典型编码模式：

“现在你注意到什么？”

“现在你意识到什么？”

“在这个情境中你观察到什么？”

下面的问题是探询求助者情感和知觉的关系，例如：

“现在你的感觉是什么？”

“你的身体有什么感觉？”

咨询者可能需要帮助求助者进行多次角色扮演或想像，使他们能够重建情境，并意识到被编码的突出特征。为了将求助者的自动知觉提升到意识层次，治疗者还要启发、暗示求助者有可能感觉到或体验到什么。还要帮助他们意识到那些“边缘印象”，如短暂的表象、声音、情感和感觉。

仔细选择问题情境的知觉特征

在求助者意识到自己的自动关注点后，要让他们重现问题情境，并且有意识地关注那些曾经自动处理的情境特征。例如，恐水症求助者想像或假装接近水池的情境，有意地注意下列突出特征，如水的深度和见不到的池底等。有意识地注意到这些被编码的特征后，求助者便能使这些自动加工过程进入意识中，并处于直接控制之下。这一“戏剧化”过程使求助者的意识能更集中于现在的知觉上。随着这些知觉被意识到、被揭示出来，求助者就很难再去维持原有的错误知觉。在治疗中可多次重复这个步骤，也可布置为家庭作业。

提出其他的知觉关注点

咨询者可以通过改变求助者的关注点，使他注意那些曾被忽略的其他情境特征。例如，可以让恐水症求助者将自己注意的焦点，从水的深度转到去注意水的清澈和干净程度。对于只注意房间大小的考试焦虑求助者，咨询者要重新引导求助者的注意力，使他转而注意考试场所多么宽敞，或座位摆放多么舒适。求助者和咨询者可以提出其他具有积极性（或至少是中性内涵）的问题情境特征，如那些使求助者感到轻松的特征。

要使再构法产生效果，所选择的知觉特征必须能够被求助者接受。它们应能使求助者准确、有效地看待事物；应根据求助者的价值、风格和社会文化环境进行选择 and 剪裁；并配合求助者个人的经历和世界观。当然，再构的知觉特征也必须符合情境的外部现实，使它们看起来合情合理。例如，丈夫因为妻子的婚外情对她非常愤怒，这时如果以“太爱她了”来再构他的愤怒，并不足以代表这个求助者的客观现实。更为合理的再构可能是，“因不能控制妻子的行为而感到挫折”，或“因不能保护婚姻关系而感到

挫折”。

呈现再构的方式也很重要。当向求助者建议其他的知觉选择时，咨询者的非言语行为应与语调和再构内容相一致。要通过强调关键词和短语来加强呈现再构的语气。

调整问题情境知觉

咨询者可以用角色扮演和想像法帮助求助者调整自己的知觉。让求助者在想像或扮演过程中注意问题情境的其他方面或特征。这个步骤需要重复多次。重复的目的在于使求助者的知觉反应更为具体，逐渐体验到轻松的感觉。

家庭作业和复诊

治疗者要建议求助者在现实的情境中按照咨询会谈中的方式进行重构治疗。要更加清楚地意识到应激情境中被编码的突出特征，将这些知觉与不适感觉联系起来，有意识地进行练习活动，尝试在应激情境中将知觉转换到以前被忽略的情境特征上。

当求助者熟悉这个程序后，治疗者要特别注意并指出那些知觉上的细微改变。通常求助者不善于察觉这些编码的变化。帮助求助者区别出对问题情境的新、旧编码（知觉）方式，对于实现再构策略的整体目标（减轻和修正编码知觉错误、偏见）是非常有效的。

情境再构

除了上面提到的意义再构以外，另一种再构的方法是对问题行为发生情境的再构。情境再构可以帮助求助者探索和确定某个问题行为在何时、何地、对何人是有益或适当的。情境再构基于这样的预设，即任何一种行为都只在某些情境，而不是所有情境有效。因此，当求助者说“我太懒散”时，情境再构就是要回答

“在什么样的情境中，懒散的行为是有用甚至有益的”。求助者可能会说，每当她要与孩子们一起玩的时候，懒散就是有用的行为。这时咨询者就可以帮助求助者了解问题行为出现的情境，使他们看到何时、何地他们需要这种行为，而在其他的时间和地点则不需要这个行为。情境再构法对那些“过份概括化”（如“我从来都不自信”、“我总是迟到”等）的求助者最有效。

再构法的跨文化应用

我们在前面提到过，有效的再构对求助者来说必须是合理、可接受的。在跨文化应用再构疗法时，注意到不同求助者的年龄、性别、民族等因素是非常重要的。Oppenheimer 提供了一个很好的例子。求助者是一个严重忧郁的67岁的拉美裔妇女，其咨询者也是一个拉美裔妇女。咨询者在使用再构时不仅没有把拉美有关超自然信念（如“不安的幽灵或鬼影”）当做是病态的，反而用它来再构求助者的抑郁症状。只进行过几次再构治疗，求助者就大大改善了抑郁症状。

跨文化使用再构法的另一个较好的例子，是女权主义运动有关抗拒的概念。他们将抗拒再构为“拒绝与主流文化模式融合，而专注于自己的语言和完整性”，而不是求助者有意或无意地试图“回避或逃避改变”。这样抗拒不由某些病态的标签转为健康的标签。Smith 讲到这样一个黑人女孩，她在成长过程中被培养成了一个“抗拒者”，但她坦率、独立、勇于维护自己的权利。她的生活没有不切实际的幻想，如期待有“白马王子”来解救她。最近Taylor、Gilligan和Sullivan的研究证实，许多黑人少女都有强烈但健康的抗拒情绪。Robinson和Ward区别出了生存抗拒策略的概念。生存抗拒策略用于危机时期，是一种短期的方式，包括自我降低人格和不顾文化常模的过分自做主张，如早孕、计划外怀孕、药物滥用、学习成绩差或中途退学等；而解放抗拒策略

则承认社会存在着压迫问题，并有进行改变的需求。

再构法个案示范

下面的例子阐明了再构干预法的过程。治疗者为一位母亲和她的儿子再构了他们各自的角色，以及她们间的相互关系。请注意再构是如何与家庭文化价值发生联系的。咨询者充分考虑到亚洲文化家庭的关系模式，因此对Kim夫人作为母亲的责任和她儿子作为儿子的义务进行了再构。

Kim 一家

几个月前，地区里的一家医院要求本书作者帮助一位即将出院的韩国老太太。她看起来非常可爱，她喜欢被所有工作人员溺爱，因为她看起来要长期呆在医院里。她一般不愿在周末回家，而宁愿呆在医院，就好像她要永远呆在那儿。她开始依赖工作人员，并要求得到比她实际需要多得多的药物和护理。

这位67岁的Kim夫人曾试图自杀（用刀割自己的咽喉）。她已住院一个月，她的伤口愈合得很好，但医护人员和她之间的良好关系变得不愉快起来。由于情况没有改善，医护人员请来作者，并说这似乎是由于“家庭问题”造成的。

医护人员一直鼓励Kim夫人要更独立些，不要只靠儿子，而应该依靠丈夫。令他们很惊讶的是，她的丈夫很少探访她，但大儿子尽管工作很忙，而且是抚养两个孩子的单身父亲，但仍每天来看她。他们曾与母亲和她的儿子交谈过，但没有用。

调解和协商比直接面对面的争论对亚洲美国人来说更有作用。作者认为对这个家庭的治疗任务有两个：找到一种体面的方法来帮助Kim夫人回到丈夫身边；帮助她的儿子找到一种方法，既可以做一个有责任感的父亲，又能成为孝顺的

儿子。

作者分别与母亲和她的儿子进行了单独会谈。了解到下述内容：这个儿子是三个儿子中最大的，十二年前来到美国，取到大学学位并获得一份重要的工作，从而为家庭争取了荣誉。他爱上了一个美国姑娘，结了婚，并有了两个儿子。为了供养家庭，他不得不退学。但是最近他恢复了半工半读的生活，婚姻以离婚而告终，他拥有孩子的监护权。为了显示他对家庭的责任心，他设法把父母和他的两个弟弟都带到美国。然而，他们的生活是不幸和困难的。但因为无法忍受面对失败的耻辱，Kim一家没有人回到韩国。

当两三年前他父母首次来到这个国家时，他们与儿子和孙子生活在一起。孙子对他们的祖父母并不尊重。他们吵闹、随意地表达他们的意见，没有正确理解传统文化的遗产和风俗，偶尔还粗鲁地谈论祖父母的旧观念。他们向父母高声抱怨祖父母的“不切实际”的期望、陌生的食物和奇怪的行为方式。为了所有的人，大儿子安排父母搬到老年公寓去住。

为了尊重Kim夫人，作者以医院顾问的名义首次单独会见了她。作者对她说，她有一个孝顺的儿子，她培养了一个聪明而又有责任感的儿子。作者和Kim夫人谈到她的家庭在离开家乡这么远的陌生土地上经受的痛苦。咨询者对Kim夫人的想法表示了同情，她认为现在的年轻人，特别是在美国出生、长大的孩子，都是自私的等。这些都是为进行再构所做的铺设，咨询者将她的自杀企图再构为无私的牺牲。为了达到再构的目的，作者站在Kim夫人的观点上看待目前的情境。

Kim夫人开始不愿意交谈，但她逐渐活跃起来。第二次到医院拜访她时，她更乐意谈论自己的感受，一个母亲的失败和被孙子们推出家门的耻辱。咨询者抓住她愿意谈有关境

遇的机会，将她大儿子的行为再构为对他自己儿子们的善意责任感。作者向 Kim 夫人指出，没有母亲愿意看到儿子不能成为好父亲，因为这也意味着做母亲的失败。另外，如果她真的自杀成功了，那么在孙子们的眼里，他们的父亲，她的儿子，就永远地失败了。另一方面，咨询者告诉她，她对儿子的关心胜过其他一切，在这方面，Kim 夫人认真对待母亲的责任（甚至想到结束自己的生命），令人印象深刻。

咨询者提醒她（她自己已经知道），年轻人不仅对自己的父母亲有责任，说也有责任保护和鼓励自己的孩子走向成功。而且还补充道，这个责任中还包括老夫老妻愉快相处，以免除孩子对父母的挂念。给孩子们机会让他们成功，这是做父母的责任。Kim 夫人同意这种观点，并感谢我的再次来访。

Kim 夫人的观点被再构为是对本族文化准则的实践。她回到丈夫身边对她儿子来说是重要和必须的，因为她儿子抚养自己的孩子也是为整个家庭增加荣誉的事。

与儿子交谈时，作者称赞他是一个孝顺的儿子，为他父母和弟弟做了如此多的事；也暗示他母亲对他的培养教育很好，他不仅对父母和弟弟忠诚，也是一个有责任感的父亲。如果他不能很好地照顾自己的孩子，这对他的父母来说是不光彩的事，因此他要努力工作，使自己的孩子们也能成功地生活。

Kim 夫人不久就出院回到丈夫那里。一年后的随访表明她生活得很好，没有复发抑郁。

这两次对母亲和对儿子的干预措施相互关联，强调了亚裔美国人紧密的家庭纽带。与文化背景有关的再构技术要充分尊重每个求助者的世界观。

学习练习活动 45/ 再构法

这个活动有助于你使用再构治疗法。

1. 识别产生不适或痛苦的情境，例如：
 - A. 你正准备建立与某个人的新关系。
 - B. 你正在大批观众前做演讲。
 2. 尝试意识到你在这个情境中自动地注意到什么特征。与别人进行角色扮演，或假设你正坐在电影院里，并在银幕上投射这些情境，问自己：
“我现在意识到什么？”
“我现在注意到什么？”
要注意到其中的任何短暂声音、情绪、意象和感觉。
 3. 建立情境特征和感受之间的联系。当你再演出这个情境时，问自己“在这个时刻我感到了什么？”“现在体验到什么？”
 4. 当你意识到情境的突出特征后，用角色扮演和想像法再次演出这个情境。要有意识地去注意这些特征。重复这个过程，直到你感到能在情境中有意识和控制你的知觉过程。
 5. 选择情境中你能注意到的其他（以前忽略的）特征，它们将使你用不同的方式考虑和处理该情境和其中的意象、声音和感觉，以及人和事物。问自己诸如“在这个同样的情境中，哪些方面我以前没注意到，而又会给我提供考虑问题的不同方法”之类的问题。你还可以向他人寻求帮助。当你识别出了这些新的特征后，用角色扮演或想像法演出这个情境——如果有必要，重复数次——以中断旧的模式。
 6. 练习家庭作业，要像在实际情境中一样，鼓励自己运用再构法。
-

应激预防法

应激预防法是教会求助者进行躯体和认知两方面应对技能的方法。Meichenbaum指出, 应激预防训练能够“帮助求助者获得足够的知识、自我领悟和应对技巧, 来应对预期到的应激场景。它结合了各种元素, 如苏格拉底式的说教、求助者自我检测、认知重建、问题解决、自我引导放松训练、行为和想像练习、环境改变等”。Eliot和Eisdorfer, 以及Meichenbaum将应激事件分成下面几类:

1. 时间相对短暂的和慢性的事件, 如内科活组织检查、外科手术、牙科检查、口试等。
2. 触发一系列应激反应的事件, 如失业、离婚、配偶死亡、自然或人为的灾难、性侵犯。
3. 慢性而间断的事件, 如音乐演出、体育比赛、战争、周期性头痛。
4. 慢性而持续的事件, 如慢性内科或精神科疾病、婚姻矛盾、慢性躯体—情绪或精神刺激、某些职业——护士、老师和警察等。

表 16-2 列出了使用应激预防法的研究例子, 包括学业成绩、愤怒控制、儿童哮喘、体育比赛、护理工作中的疲劳、牙科治疗、高血压、失业等。

应激预防的七个组成部分

应激预防有七个主要的组成部分:

1. 基本原理
2. 提供信息
3. 直接行动应对技巧的获得和练习
4. 认知应对技巧的获得和练习

表 16-2 应激预防研究领域举例

学习成绩	愤怒
焦虑	哮喘
体育比赛	护士中的疲劳
癌症	青少年
牙科治疗	灾难救治
练习	头痛
高血压	老年人
疼痛	父母养育方式
预防	强奸受害者
精神病人护理者	安全
再婚者	老师应激
失业	

5. 在问题情境中应用所有的应对技能
6. 在潜在的问题情境中应用所有的应对技能
7. 家庭作业和复诊

本章末的应激预防会谈检测清单详细描述了与这个七个部分有关的步骤。

治疗原理

下面是咨询者在使用应激预防法时介绍原理的例子。

目的 对怀有敌意的求助者解释应激预防的目的:

你发现自己正面对一个使你失去控制情绪的情境。你无法控制愤怒,特别是当你感到被挑衅时。这个治疗程序能帮助你学习应对具有挑衅性的情境,帮助你在这些情境中控制

强烈的愤怒。

概况介绍 咨询者可以简略说明这个程序。

首先，我们试图帮助你了解情感的本质，以及为什么某种情境可以激怒你，使你的愤怒转变成敌意。然后你将学习一些方法来控制情绪，来应对这些激惹情境。在你学会了应对技巧后，我们将设计一些情境让你练习使用这些应对技能，以帮助你控制自己的愤怒。

提供信息

在学习和运用各种应对策略之前，应向求助者提供一些有关应激反应本质以及应对策略的信息。提供应激预防法的信息将帮助求助者认识应激反应，并为以后的治疗建立起基础。信息应包括三方面的内容：情绪反应的概念结构，应激反应的阶段，以及各类应对技能和策略的例子。

求助者情绪反应的概念结构 在建立概念结构时，咨询者首先要解释求助者应激情境反应的本质。尽管了解应激反应还不足以改变它，但建立起相应的概念结构可以为改变进程打下基础。要向求助者解释，各种应激（焦虑、敌意、疼痛）反应都有两个组成部分：一是生理唤起，二是引起焦虑、敌意、疼痛的自我对话或内隐思想。这个解释能帮助求助者认识到，应对策略应当针对唤起行为以及认知过程的两个方面。例如，可以向难以控制脾气的求助者这样描述应激反应概念结构：

你要考虑一下，当你变得非常愤怒时会发生哪些变化。你可能会注意到你的身体变得紧张起来，脸发烫，呼吸急促而且心跳加重。这是愤怒的身体反应。然而，当你非常愤怒时，你的思想也会发生变化。你可能会想“他没权利攻击我，我将对他报复，我要让他明白谁厉害，我要让他闭上嘴巴”，等等。这些思想只会加强你的愤怒。所以你对激惹情境的内

部解释方式也会引起你的敌意情感。

(注意在上例及有关例子中,我们对适当、合理的愤怒和导致辱骂或破坏行为的敌意做出区分。)

应激反应阶段 在解释情绪唤起的概念结构之后,咨询者还要描述唤起水平升高的时间阶段性。通常,恐怖症患者把自己的焦虑看成为“严重的惊恐反应”。同样,处于愤怒、抑郁或痛苦中的求助者,也把他们的情感解释成是一种严重而持续的反应。但用这种方式解释自己反应的求助者会认为这种应激反应很难加以改变和控制,因为它们太强烈了,难以阻挡。

要帮助求助者看到这些反应是可以对付的,其方法是把应激反应分成不同的阶段。Meichenbaum将反应分为四种阶段,来帮助求助者认识情绪反应。(1)为应激(痛苦或激惹等)情境出现进行准备的阶段;(2)应对应激情境的阶段;(3)在这些情境中,应对关键时刻(或应对恐慌及激动的情感)阶段;(4)由于在前三个阶段中使用了应对技巧,而奖励自己的阶段。阶段性的解释会帮助求助者理解学习应对策略的顺序。解释例子如下:

当你想到愤怒反应时,你可能会认为愤怒将持续好长一段时期。然而,愤怒反应并不总是处于高涨水平,它时而上扬高涨,时而平静低落。当你预期应激情境即将出现时,你开始变得愤怒起来。这是第一个关键期。这时你要学会用控制自我的方法来对付这个阶段。下一个关键期是当你处在应激情境中且变得非常愤怒。这时你要学习怎样用建设性的方法面对令人愤怒的情境。你的愤怒可能会有几次变得非常强烈,你会感到它开始控制了你,或者你自己失去控制。这时你要学习怎样应付强烈的情绪冲动感。最后当这个应激情境结束后,你要学会不要为自己在情境中的表现感到愤怒,相反,要对自己在情境中使用应对技巧鼓励、表扬自己。在使

用应激预防的过程中，我们将在以上各个关键期练习使用各种应对技巧。

关于应对技能和策略的信息 最后，咨询者将为求助者提供在那些关键期可加以利用的各种应对技巧和策略的信息。咨询者要强调有效的应对技巧各式各样；求助者或者自己进行选择，或者为自己制定应对技巧。允许求助者选择或制定应对策略在应激预防中是非常重要的。应激预防法包括“直接行为”和“认知”两种应对技巧。直接行为应对策略即是使应对行为来处理应激；而认知应对技巧则通过求助者的应对思想（或自我陈述）来处理应激。尽管某些求助者由于自己的性别和文化而更喜欢某一种应对方式，但应当让求助者明白，两种应对技巧都是重要的。它们具有不同的功能。咨询者可以用这样的解释向求助者提供有关应对技巧作用的信息：

下一步，你将学到大量不同应付方法来准备处理或实际处理应激情境。其中的一些应对技巧将帮助你学习通过行动和行为来应付应激情境；而另一些应对技巧将通过你对情境的解释和思考，来帮助你处理这些应激情境。当然不是所有的策略都是必要的，重要的是你要从中选择你所喜欢的应对策略。

直接行动应对技巧的获得和练习

在应激预防法的这个阶段，求助者学习和练习直接行动应对技巧。咨询者先要讨论和示范可能的行为策略；然后求助者在咨询者的鼓励 and 帮助下，选择其中的一些策略进行练习。最常用的直接行为应对策略有如下几种：

1. 收集关于应激情境的客观、事实性的信息
2. 找出减轻压力的逃避路径或方法
3. 缓和性的应对策略

4. 精神放松

5. 躯体放松

收集信息 收集一个应激情境的客观信息，可帮助求助者更现实地评估情境。问题识别过程对于收集信息是非常有用的（见第九章）。而且，有关情境的信息能减少求助者的疑问，从而间接地减轻应激水平。例如，一个身体疼痛的求助者获得有关疼痛来源和持续时间的信息后，便能减轻应激水平。这种应对方法被广泛用于分娩教程。告诉孕妇分娩时体验到的疼痛实际上是子宫在收缩，并告诉她们有关的分娩时间和阶段、子宫收缩时间和强度，这样孕妇们就不会因为对分娩的误解和缺乏有关身体变化的信息而增加自己的焦虑。

收集有关焦虑和愤怒情境的信息有着同样的作用。例如，用应激预防法帮助求助者控制愤怒时，知道什么人常惹求助者愤怒的信息就会有帮助。求助者还可以收集这样的信息，以帮助自己把激惹看做是一个需要加以解决的任务或问题，而不是一种威胁或个人攻击。

逃避路径的识别 找出逃避路径是帮助求助者在失去控制力之前进行应付的一种方法。逃避路径就是在求助者可能采取失控行动之前，使爆发性情境短路，或降低应激水平。这种应对策略可帮助求助者学会意识到那些可能引起身体或言语激动的线索，并在大打出手之前采取一些预防行动。这与第二十章描述的刺激控制策略很相似。这些逃避或预防路径是一些求助者能做到的简单事情，如，一个被激怒的人可通过数数到60、离开房间或谈论滑稽的事，而避免大打出手。

缓和性的应对策略 Meichenbaum提到，缓和性的应对策略在那些不能改变或不能避免的应激情境中特别有用。如，当求助者面对慢性或无药可救的疾病时，要训练他们学会情绪和缓应对策略（其中包括：采用新的视角，选择性注意转移，适宜的情

感表达，如幽默，放松及情境再构等）。

精神放松 精神放松也能帮助求助者应对压力。这个技术包括注意力转移策略：愤怒的求助者可将注意力集于解决一个问题，或数房间内的地板瓷砖数，或想出一个滑稽的笑话，或想一些积极的事情等。注意力转移策略可用于帮助人们控制疼痛：要使劲将注意力集中在房间中的某个物体上，或重复一句话或一系列数字，而不是将注意力集中在疼痛上。

一些人发现，当他们进行想像或幻想时，精神放松法更易成功。对于喜欢做白日梦的人或有鲜明表象的人来说，想像法是促进精神放松特别有效的方法。例如，为了不去想焦虑或愤怒情感，求助者可以幻想躺在温暖的海滩、躺在帆船上，或吃着喜爱的食物（见第十三章）。为了控制疼痛，可想像不同的事情。如分娩中的妇女可以想像子宫收缩像波浪一样，而不是想着疼痛。

身体放松 身体放松法对于那些产生焦虑和愤怒生理反应的求助者特别有效，如手掌出汗、呼吸急促、心跳、恶心等。身体放松对于控制疼痛也是一种非常有用的应对策略，因为躯体紧张会增加疼痛感。身体放松由肌肉放松或呼吸技术组成。第十七、十八章将更详细地描述这些程序。

求助者首次进行直接行动策略时，咨询者都要向他们解释其目的和步骤。讨论和示范所有可能的直接行动应对策略。可能需要几个疗程的时间。描述和示范完策略后，求助者应选择出某个特殊的方法加以练习。求助者使用直接反应策略的次数依赖于反应的强度、应激的性质和求助者的偏爱。为了能在模拟和实际情境中使用它们，求助者要在咨询者的帮助下练习使用每一种技巧。

认知应对技巧的获得和练习

认知应对技巧的获得和练习与前面描述的认知重建策略非常相似。咨询者首先给求助者示范一些应对思想，然后求助者选择并练习用所选择的应对思想，并因它们来替代消极或自我否定思想。

认知应对的四个阶段 咨询者帮助求助者建立阶段概念，明白情绪反应的本质。在帮助求助者获得认知应对技巧时，咨询者首先要复习应对关键期知识，指出求助者要为每个阶段准备一组相应的应对技巧：为情境的出现做好准备；面对和处理这个情境；应对情境中的关键事件；在情境过后鼓励自己。咨询者可以用类似下面的解释来向求助者描述这四个阶段。

刚才我们曾谈到，愤怒不是一个连续的反应，而是在你感到被激怒或被攻击时才上升到最高点。现在将学习的认知控制法能帮助你控制任何能导致敌意的消极思想，也能帮助你在应激时使用应对思想。使用应对思想有四个重要阶段。首先是你最初怎样解释应激情境，你准备怎样进行反应；第二是实际处理应激情境；第三是应对情境中发生的真正能激怒你的事情；第四是在情境过后，你要学习鼓励自己在应激情境中使用了应对方法。

示范应对思想 在向求助者解释使用认知应对技巧的四个阶段后，咨询者要针对每个阶段示范一些特别有用的应对思想。

Meichenbaum等人对这些应对思想或自我对话做了很好的总结（见表16-3），总结分为四个阶段：为应激情境做准备，面对应激情境，应对应激情境中的关键时刻，自我强化应对思想。咨询者将为应激反应的每一个阶段提出应对陈述的例子。

求助者选择应对思想 在咨询者示范了一些可能的应对思想后，求助者要补充或选择那些适合自己的应对思想。咨询者要鼓

励求助者使用他感到最自然的应对思想。求助者可能会寻找自己在有关的应激情境中曾使用过的应对陈述。在咨询的这个阶段，咨询者要帮助求助者制定一个合适的应对计划。如果求助者的自我陈述太一般化，可能会导致“机械的重复”，失去有效的自我指导功能。合适的应对陈述要与求助者的文化相关联。咨询者可以这样解释求助者参与的重要性：

你参与选择有效的应对思想是非常重要的。我已经给你示范了一些例子，它们中有些应对方法对你可能很适合，你还可以想出其他一些应对方法来。现在我们要做的是，针对每个应激阶段找出那些只适合于你的应对思想来。

求助者练习应对思想 求助者选择出每个阶段使用的应对思想后，咨询者要指导求助者练习这些自我陈述，让他们大声地说出来。出声训练可以帮助求助者熟悉、习惯这些应对思想。然后，求助者按四个阶段的顺序练习应对思想，这个练习可以帮助求助者学会使用应对思想的时机。咨询者可以这样说：

首先，我想让你通过大声地说出应对思想来进行练习，这将帮助你习惯这些应对思想。下一步，让我们按实际情境应用的次序来进行练习。我先演示：先假设一个情境，并使用应对陈述帮助我准备应对这个情境，如“我知道这类情境常会使我心烦，但现在我有一个计划来对付它”，或“即使这个情境很令我恼怒，我也能控制我的愤怒”。下一步，我将假装处在实际情境中，我将这样进行应对，对自己说“保持镇静，记住是在和谁打交道，这是她的风格，不要太过认真”，或“不要有过激反应，放松下来”。

现在这个人的骚扰在继续，我感到更加愤怒。我会想“我能感到自己变得激动不安起来，要保持放松，将注意力集中于放松”，或“这是一个挑战性的情境，我采取怎样的行动才使我以后不会后悔？”现在事情过去了，我终于按捺住没有

反击或报复，因此我将想出一些东西来鼓励自己，如“我做到了”或“我真的保持了冷静”。

现在，你来进行练习。按情境次序用语言来表达你的应对思想。

在问题情境中应用所有的应对技能

应激预防法的下一步是让求助者面对一个紧张的、易激惹或痛苦的环境，并使用直接行动和认知应对技能。在求助者运用应对技巧前，他应在咨询者的帮助下用模拟的情境进行练习。应激预防的这个应用阶段对整个治疗程序的作用很重要，只是简单地让求助者演练应对技巧，而没有机会在应激情境中运用它们，似乎会有改善作用，但对求助者实际应对能力的增长帮助有限。

这个阶段包括针对模拟情境进行示范和演练。例如，一个想控制敌意的求助者将有机会练习应对一系列敌对或易激惹的情境。在应对练习中，求助者要面对一些应激情境，并用某种应对方式来练习应对技巧。换句话说，这个阶段将尽可能做到像真实的情境一样。这种应用练习被认为是为求助者提供一个在应激情境中进行自我示范的机会。通过想像颤抖和失去控制、体验焦虑，然后进行应对，求助者就像在实际生活中一样练习这些思想和感觉。

运用应对技巧的示范 咨询者首先示范当面对应激情境时，求助者应怎样使用刚学会的应对技能。下面的例子显示出咨询者向一个努力控制敌意的求助者进行演示的整个过程：

我想像警察打电话告诉我，我16岁的儿子因为入室抢劫再次被捕。我感到我的身体开始爆热。哦，等一会儿，这是一个应对的唤起信号。我最好考虑用放松方法来保持镇静，准备使用应对思想建设性地处理这个情境。

好，先坐下放松。让肌肉松弛下来，数到10，深呼吸（直接行动应对方法）。现在我马上要去看我的儿子，我将做什

么？我知道痛骂和痛打他没有用，那不解决任何事。因此我要想出另一个方法，让他讲。给他一个改过机会或找出解决的方法（认知应对：为情境作准备）。现在我看见他走进门来。我感到有点说不出话来，我感到拳头在握紧。他开始解释。我想打断他，并揍他一顿。等等（这又是应对信号）。集中数数，慢慢呼吸（直接行动应对）。告诉我自己要保持冷静，让他继续说。现在发怒没有任何帮助（认知应对：面对情境）。现在我正在回想上次他被逮捕的情境，为什么他没有吸取教训？我的儿子不应是惹麻烦的（情绪唤起）。唉！我相当生气，我必须保持自控，特别是现在（应对信号）。放松，肌肉保持放松（直接行动应对）。我可以告诉他我很失望，但我不会发怒、叫喊、打他（认知应对：更激动的感觉）。很好，我正在很好地保持着冷静（认知应对：自我强化）。

求助者在想像和角色扮演练习中使用应对技巧 在咨询者示范之后，求助者将练习直接行动和认知应对技巧。可以用两方法练习：想像法和角色扮演法。我们发现，求助者首次练习应对技巧时，想像问题情境是有效的。这个练习需要反复进行，直到求助者对在想像情境中运用应对技巧感到非常自然。然后，求助者在咨询者的帮助下，用问题情境的角色扮演来练习应对技巧，角色扮演情境要与求助者遇到的情境类似。如，愤怒的求助者要辨认出最容易令其发怒或失去控制的情境和人物。然后求助者想像每个情境（从最易控制的情境开始），并想像使用应对技巧。最后，咨询者扮演某个挑衅者，求助者用角色扮演来练习应对技巧。

在潜在的问题情境中应用所有的应对技能

任何治疗程序不仅要帮助求助者解决当前的问题，还要使她们能建设性地处理潜在的问题。也就是说，适合的治疗策略不仅能解决当前的问题，而且也能预防将来的问题。应激预防法通过

让求助者在其他应激情境中运用新学会的应对策略,从而取得预防效果。这个情境现在不是问题情境,但将来有可能是。如果忽视这个阶段,应激预防法的效果就可能非常短暂。换句话说,如果求助者没有机会把应对技巧运用到当前情境之外的情境中去,他们的应对技巧将不能扩大和超出现在的问题情境。

应用应对技巧到潜在的应激情境,是用同样的方法来完成的。首先解释应对技巧在求助者的生活其他方面作用,然后咨询者进行示范。咨询者可以选择求助者没有遇到过、但需要积极应对的情境,如没有得到工作晋级或提升,面对家庭危机,搬到新地方居住,即将退休,或生重病等。在咨询者示范应用应对技巧后,求助者将练习在这些情境中运用这些技能。也可用想像中或角色扮演来进行练习。一个新的练习方法是转换角色练习,求助者扮演咨询者,咨询者扮演求助者。求助者帮助或训练咨询者使用应对技巧。这将使求助者能更好地掌握应对策略,同时也会提高他们的自我效能(见第二十章)。

家庭作业和复诊

当求助者在会谈中学会使用应激预防后,他就可以在实际生活中使用应对技巧了。但咨询者要告诫求助者,不要期望一开始就能很好地应对所有的问题情境。要鼓励求助者使用日志表记录特殊的情境和使用应对策略的次数。在复诊时使用日记资料可以帮助确定求助者进步的程度。

应激预防是目前使用最广泛的治疗方法之一。要教会求助者使用直接行动和认知应对技巧,并能在当前和潜在问题情境中加以使用。

应激预防法的跨文化应用

本章提出的应激预防法在本质和形式上无疑都是欧美式的,

因此并不是对所有求助者都最适合。在应激概念和应对方法上存在着文化差异。在印度的一些文化群体中，应激不被看做是一个主要的问题，当然也就不是需要“专家”来帮助的问题。相反，应激被看做是生活的一部分。普遍认可对应激进行魔法解释，并请有资格念咒语除鬼魂的人来帮助驱魔。人们寻求各种方法解决问题，如制作象征性祭品献给神、朝拜圣地等。此外，还使用冥想和瑜伽功等自我治疗方法对应激情况。

应激和应激源也存在着文化差异。例如，在美国被诊断为焦虑或应激失常的妇女数量要比男性要高得多。感到被主流文化群体冷落的人，如有色人种、同性恋者、老人和身体及心理残疾者，“更可能体验到以歧视、贫困、耻辱、骚扰等形式出现的应激事件。难民中因为创伤导致的应激综合征也非常普遍。

学习练习活动 46 / 应激预防

1. 下面列出了 12 个直接行动应对技巧的例子。参照例子前面的应对系统，识别出每个例子使用的直接行为应对技巧类型。

代码

信息 (I)

逃避路径 (ER)

社会支持网络 (SSN)

公开讨论 (V)

扩大视野 (PT)

注意力转移 (AD)

意象控制 (IM)

肌肉放松 (MR)

呼吸技术 (B)

例子

1. “当你感到特别紧张时，学习进行缓慢的深呼吸。”
2. “替代头脑中想着的疼痛，试着将注意力集中于地板上的一个污点。”
3. “想像一个非常暖和的晴天，温暖使你全身放松。”
4. “如果真的太多了，就只做第一部分好了，其余的先放一放。”
5. “你可以预期疼痛，但它只有针扎一下那样疼，并不意味着某些事出了差错。”
6. “握紧你的左手，握住并注意这种紧张，现在放松它，去感觉一下它们之间的不同。”
7. “当你在治疗中感到不适时，试着想像一个强壮的、正常的细胞攻击虚弱的、令人烦恼的癌细胞。”
8. “当烦恼变得非常强烈时——倾听音乐或学习墙上的图画。”
9. “如果你谈论它，并表达你的疼痛感，你可能感觉会更好。”
10. “最初或直觉的反应可能使你只看见情境中的某些特征，还有一些积极的方面需要你去注意。”
11. “让你的家庭成员和周围邻居反馈其他的观点是有帮助的。”
12. “对你来说，学习社会技能是重要的。这会帮助你从别人那里得到支持，别人的支持会减轻这种令人讨厌情境的影响。”

II. 下面列出使用认知应对技巧的4个阶段的例子：准备情境的来临，面对和处理情境，对付情境中的关键时刻，对应用进行自我强化。识别出下列每个例子中所表示认知应对法的阶段。答案见学习活动反馈 46。

1. “太棒了，我完成了。”

2. “我需要做什么？”
 3. “不要失去你的冷静，即使现在正是最激动的时候，做一个深呼吸。”
 4. “现在想像你要说什么，而不是考虑别人对你怎样反应。”
 5. “放松，很快就过去了，现在只注意结束这个难过的时刻。”
 6. “你能感觉到吗？这次应对成功了。”
 7. “既然来了，就只考虑情境，而不要想焦虑的事情。”
 8. “这是一个应对信号，要注意你下一步要做的事情。”
-

学习活动反馈 46 / 应激预防

- I.
1. B
 2. AD
 3. IM
 4. ER
 5. I
 6. MR
 7. IM
 8. AD
 9. V
 10. PT
 11. SSN
 12. SSN

如果这个练习对于你还很困难，请复习直接行动应对技巧章节中的内容。

- II.
1. 自我鼓励
 2. 情境准备
 3. 对付关键时刻

4. 面对情境
5. 对付关键时刻
6. 自我鼓励
7. 情境准备
8. 面对情境

如果你不能识别应对技巧的四个阶段，你可以参照表 16-3。

表 16-3 应激预防法中的应对思想

1. 为应激做准备	为激怒做准备	为痛苦的应激做准备
你必须做什么？ 你能制定一个计划来对付这个情境。 考虑你能做些什么，这要比焦虑更有用。 不要消极思想，只要理性思考。 不要着急，着急没有任何用处。 你的焦虑只不过是急于面对这个情境。	这将使我心烦，但我知道怎样对付它。 我必须做什么？ 我能想出一个办法对付它。 如果发现自己变得烦躁，我知道怎样做。 争论不需任何东西。 不要对它太认真。 这是一个易怒的情境，但我相信自己。 是做几个深呼吸放松的时候了。 体验舒适、放松、自在。 这很容易，记住你的幽默感。	你必须做什么？ 你能制定一个计划来对付它。 只想着你能做的。 不要着急，着急没有任何帮助。 你有许多不同的策略。
2. 面对和处理应激	冲击和面对	面对和处理疼痛
使自己做好精神准备，你能对付这个挑战。 一次一步，你能处理这个情境。 不要想着害怕，只想着你必须做的。这就是咨询者说的，你感	保持镇静，继续放松。 只要保持我的冷静，我能自控。 想想你要怎样摆脱它。 你不需要证明自己什	你能对付这挑战。 一次一步，你能处理这个情境。 放松，深呼吸，使用某种策略。 不要想着疼痛，只想着你必须做的。

表 16-3 (续表) 应激预防法中的应对思想

觉到焦虑时,就是使用应对练习的时机。这种紧张是进行应对的信号。 放松,你受自己控制,做一个深呼吸,哦,好的。	还没有变得疯狂。不要做得太过分。我不想让他碰我。寻找积极的方面,不要总往最坏的方面想或匆忙下结论。	这种紧张是进行应对联系的信号。 放松,你是在自我控制中,做一个深呼吸,哦,好的。 这就是咨询者说的你能感觉到的焦虑,这是使用你的应对技巧的时机。
3. 应对惊慌失措感 恐惧来时,就停下来。 注意力放在当前,什么是你必须做的? 不要尝试消灭所有的恐惧,让它处于可控的程度。 它就会过去的。 想想其他的事情吧。 描述一下周围的情况,这使你不去想令人担心的事。	应对愤怒情绪的唤起 我的肌肉紧张起来,这告诉我应当进行放松了。 愤怒是无济于事的。应当深呼吸了 让我们试试合作的方式,也许我们两人都对。 慢慢来,不要着急。 愤怒只会激起更多的愤怒。	应对关键时刻 你现在必须做什么事情。 疼痛可能就会来了,但要控制住它。
4. 自我强化应对 我做到了。 并不像我想像的那样糟。 当你控制它的时候,你就控制了恐惧。 每次做都会取得进步。 对所取得的进步而高兴吧。	反映激怒情绪 试图摆脱掉它,它只会干扰你的工作。 记住要放松,这比愤怒好得多。 不控制的话,结果会更可怕。 我挺过来了,没有发脾气 吸一口气。 不要太过认真。	自我强化应对 很好,你做到了。 你做得非常好。 你知道,你能做到的。

应激预防法示范对话

第一次咨询

在第一次会谈中，咨询者指导Joan练习某些直接行动应对技巧，以帮助她应对对数学课产生的躯体紧张感。练习中将使用想像控制和呼吸技术。

1. 咨询者：你好，Joan。这星期怎么样？

求助者：相当好。你知道，各种方法开始起作用。这星期进行了一次考试，我得了85分，通常只能得70和75分。

咨询者向Joan介绍对付紧张其他的应对技能。

2. 咨询者：这确实非常好。因为上星期你做得很好，我相信我们今天可以练习更多的应对技能，以帮助你减轻紧张感。

求助者：那是什么样的技能呢？

在对话3和4中，咨询者解释和示范直接行动应对技巧。

3. 咨询者：你要学习的一件事是，想像一个使你有非常平静感觉的情境，进行想像的同时，慢慢做深呼吸，就象这样（咨询者示范：闭上眼睛，慢慢地、深深地呼吸）。当我深呼吸时，我想像我正坐在沙发上阅读喜爱的书。但你可以想像与我不同的事，例如，你可以想像努力学习使你获得奖励或奖品；或者想像你正在学会解数学题，以便你能够帮助别人。你明白了吗？

求助者：我明白了。我猜，就是用一种假象的方式来想像与数学课有关的事情。

4. 咨询者：是的。总之是要减轻而不是增加压力。

求助者：我明白了。

在对话5中，咨询者要求Joan找出对平静心情有帮助的意象。

5. 咨询者：你要想像出一些能使自己避免过分紧张的情境。你能花几分钟想出一两个情境吗？

求助者：（停顿）我也许可以假设上数学课是为了做某些令人激动的事情，如一名奥林匹克滑雪运动员。

在对话6和7中，咨询者指导Joan练习这些直接行动应对技巧。

6. 咨询者：很好，我们先用它来进行练习。如果它对你没有帮助，我们还会想出一些别的情境。你现在一面慢慢做深呼吸，一面练习想像刚才的情境。（Joan练习）

7. 咨询者：有什么感觉？

求助者：有点趣味。

在对话8中，咨询者布置家庭作业，要求Joan在下次治疗前进行这些应对技巧的自我引导练习。

8. 咨询者：好。这个星期我希望你能在安静的地方，每天练习2-3次，在日记上记录练习情况，并评估在练习前、后的紧张水平。下个星期我们将检查日记，然后找出在实际生活中应用应对思想的方法。下周见。

第二次咨询

在这次咨询会谈中，咨询者帮助Joan将前面学过的各种治疗策略（应对思想、想像和呼吸放松等）综合起来。特别是让Joan在想像数学课的有关内容或角色扮演数学课的过程中，应用所有这些应对技巧。在问题情境中运用应对技巧是应激预防法的一个部分，它可以帮助求助者将新学会的应对技巧扩展到实际生活情境中。

在对话1和2中，咨询者先评论Joan的直接行动应对技巧家庭作业的完成情况。

1. 咨询者：练习进行得怎么样，Joan？

求助者：这个星期我很忙，有一次考试和两次小测验，但我都得了80多分。我也做了想像和呼吸练习。它们让我花了不少时间来学习。

2. 咨询者：这是正常的。在你真正学会它以前要进行大量的练习。如果你能继续每天的练习，一定会有帮助。练习时你的感觉怎么样？

求助者：我想紧张感比以前792少多了。

咨询者介绍了在练习情境中运用所有应对技巧的必要性，并讲到它的基本原理。

3. 咨询者：很好，随着时间的推移，你会感到更多效果的。到目前为止，我们已经练习过几种方法，如停止自我否定思想、使用想像和深呼吸法，来帮助你应对和控制自己的紧张。现在你要将所有这些方法应用在与数学课有关的应激情境中，这会对你有更大的帮助，使你在数学课上或其他应激情境中进行应对。我们会很快在其他问题情境中进行相同的练习过程，如与你父母相处时能够表达自己的不同意见。你觉得这样安排好吗？

求助者：好。

下一步，咨询者演示（示范）如何在想像练习中使用应对技巧。

4. 咨询者：现在请你想像一些与数学课有关联的情境，并尝试用应对技巧和深呼吸来控制你的紧张。让我演示怎样去做。我正在想像又该是上数学课的时间了。我要全力想像数学课是一节奥林匹克滑雪训练课。我要使用应对思想，比如：数学课会过得很快，我一直做得很好，它是一种挑战。现在我正在上课。我要停止去想我不能做好数学。每次只解决一个数学问题，每次只进行一步演算。呀！老师刚刚叫我，我能感到自己开始变得紧张起来。做一个深呼

吸……我能做好。反正只有一会儿。做得相当好。我觉得当我需要时，我就能够进行应对了。那么，Joan，现在该轮到你试几次了。（Joan在想像中使用不同的应对思想和直接行动。）

在对话5中，咨询者检查Joan通过想像练习运用技巧的反应情况。

5. 咨询者：当你练习想像的情境时，你真的能进入这个情境吗？

求助者：是的。尽管我认为，我需要更努力地进行练习。因为如果这个情境真的发生时，对我来说还是有一定困难的。

角色扮演练习更接近真实情况，下一步就进行角色扮演练习。咨询者将增加情境的应激性，方法是在没事先约定的条件下，突然叫Joan回答问题。

6. 咨询者：是这样的。这种想像练习情境与实际情境的应激性还是有差异的。现在我们做一些角色扮演练习，这可能对你帮助更大。假设我是老师，正在上数学课。我在讲课时会突然叫你回答问题。当叫到你时，你就要使用应对思想，进行深呼吸。（角色扮演练习）

咨询者评估Joan对角色扮演练习的反应，并要Joan评估她在练习中的紧张水平。

7. 咨询者：在这些练习中你感到舒适吗？你能用1至5分来评估你的紧张感吗？1分表示没有紧张，5分则是非常紧张。

求助者：大约是2分。

咨询者鼓励Joan在与数学课有关的情境中运用应对技能。并布置家庭作业和约定复诊时间。

8. 咨询者：我想你已经能够在你需要的时候使用这些应对技

能了。要记住，任何自我否定思想或身体紧张感的出现都是需要进行应对的信号，这时就要使用应对思想、想像和深呼吸技能。我希望你在日记本上记录使用它们的次数，并评估在数学课前、数学课上、数学课后你的紧张程度。

本章总结

再构法是帮助求助者用不同的观点看待问题的有效途径。要想使再构法对求助者有疗效，它对于求助者来说就必须是合理的、可被接受的及有文化意义的。意义再构的一个例子是“健康的抗拒”这一新的观点，它的意思是，求助者的抗拒不再是负面的，它是求助者对压迫的抗拒，表明他们能够为自己和自己的信念而抗争。

应激和应激源在不同的文化群体之间存在着差异。应激预防法及其相应的应激观点主要是欧美文化的模式，它将应激看做是需要“专家”和“咨询者”帮助减轻和控制的问题；而在某些东方文化里，应激被看做是生活的一部分，自我治疗练习（如冥想和瑜伽等）是比他人帮助更有用的应激处理方法。我们将在后面几章描述冥想和瑜伽。

学习评判

第一部分

本章目标一要求你在角色扮演中演示11步再构法中的8个步骤。利用再构会谈检测清单进行评估。

第二部分

目标二要求你用一个个案，描述怎样运用应激预防的五个主要组成。使用下列求助者个案描述回答这五个问题，就象你正在将应激预防应用到这个求助者身上。答案见学习评判反馈。

求助者个案描述：这个求助者是在家庭服务中心的推荐下到

你这里进行咨询的。他失业了，正接受社会救济。他有三个孩子。是第二次结婚，大儿子是前妻的。他来咨询是因为学校告诉他，他的大儿子，一个7年级学生，有几次到学校时，脸部带有明显的伤痕，这个孩子将求助者牵连进去。与他长时间交谈后，求助者显示出对这个孩子没有耐心，有时为教训这个孩子会打他的脸。他知道有时自己做得很过分，但他对这个到了年龄还“无责任感”和“缺乏主动性”的孩子极其厌烦。他说，在那时，他的急躁和愤怒变得非常强烈。

1. 解释应激预防的目的。
2. 介绍有关应激预防的概况。
3. 描述和解释下列直接行动应对技巧：
 - A. 有关情境信息
 - B. 逃避路径
 - C. 注意力转移策略
 - D. 意象控制
 - E. 身体放松
 - F. 缓和的应对策略(扩大视野、寻求社会支持或公开讨论)
4. 解释情绪反应的四个阶段和应对时机，对于四个阶段中的每一个都给出两个认知应对技巧(思想)例子。这四个阶段是：为与孩子争执和辩论的情境做准备；面对这个情境；对付关键的、非常令人愤怒的时刻；对自己的应对行为给予鼓励。
5. 描述你将怎样在会谈中建立练习机会，来帮助求助者在类似令人愤怒的情境中练习运用直接行动和认知应对技巧。

第三部分

目标三要求你在角色扮演中，演示21步应激预防法中的17个步骤。使用应激预防会谈检测清单进行评估。

再构会谈检测清单

给观察者的指导语：确定咨询者是否演示出了清单上的引导语，如果演示了，则在相应的横线上画勾。

项目	引导语举例
I. 再构基本原理	
_____ 1. 咨询者解释再构目的。	“通常当我们考虑一个问题情境时，我们最初或直接的反应可能导致情绪苦恼。例如，我们只注意这个情境的消极特征而忽视另外的细节。将注意力选择性地集中于情境的消极特征上，我们会为那个情境紧张和焦虑。”
_____ 2. 咨询者提供有关再构的情况。	“我们将识别出在你考虑一个问题情境时你注意到的情境特征；我们将寻找在这个情境中，你可能忽视的其他中性和积极的特征。然后，我们将致力于把后者重构到你对问题情境的知觉中。”
_____ 3. 咨询者确认求助者愿意使用策略。	“你想试试吗？”
II. 识别问题情境中求助者的知觉和情感	
_____ 4. 让求助者识别在问题情境中应注意哪些特征类型（某些求助者可使用意象）。	“当你想一个问题情境时，你会注意什么特征？你突然想起的第一件事是什么？”
_____ 5. 让求助者识别在问题情境	“你通常有什么感觉？在这个情境的

中的感觉类型。

角色中你体验到（或正在体验）什么？”

III. 仔细选择问题情境的知觉特征

- 6. 让求助者再次扮演情境（通过角色扮演和想像）、仔细注意被选择的特征（这一步骤需要重复几次）。

“让我们用角色扮演（或意象）演示在情境中的情况。这次我希望你仔细注意情境中我们刚刚识别过的这些方面。要观察你是怎样注意到……的？”

IV. 提出其他的知觉

- 7. 指导求助者识别问题情境中积极或中性的特征。这个新的再构对求助者是合理、可接受的，适合求助者的年龄及性别。

“现在我们来识别问题情境中中性或积极的特征。这些是你忘记或忽略特征。对你来说，提出一种对这个情境的不同考虑方法是不容易的。”

V. 调整问题情境知觉

- 8. 指导求助者通过注意问题情境的中性和积极的特征，来修正知觉（某些求助者使用角色扮演和想像能促进这个程序）（这个步骤需要重复几次）。

“当我们演示这个问题情境时，我希望你通过考虑我们刚识别的中性或积极的特征，改变你在这个情境中的注意点。”

VI. 家庭作业和复诊

- 9. 鼓励求助者练习修正知觉。

“练习对于修正你的知觉是非常重要的，每次在你想到或遇到一个问题情境时，注意这个情境的中性或积极特征。”

- 10. 指导求助者自我监督家庭

“我希望你用日记来记录你练习的次数，也记录你在各种情境前、后的感

作业的完成情况。

觉。”

- 11. 安排复诊（在复诊中，咨询者评价求助者的日记，指出小的知觉替代）。

“两个星期后，把你的日记带给我，然后我们来看看你是怎样做的。”

观察者评论：

应激预防会谈检测清单

给观察者的指导语：确定咨询者是否演示出了清单上的引导语，如果演示了，则在相应的横线上画勾。

项目	引导语举例
I. 基本原理	
—— 1. 解释应激预防的目的。	“应激预防是一种应对焦虑的方法，当你面对那些情境时使你能控制你的反应。”
—— 2. 解释应激预防程序的情况。	“首先，我们试着让你明白你的焦虑感对你的影响，然后我们学习一些应对技巧来帮助你放松躯体，并帮助你使用应对思想来替代自我否定思想，然后你将有机会在我们设置的应激情境中测试你的应对技巧。”
—— 3. 了解求助者的意愿。	“现在你对使用这个程序感觉怎样？”
II. 提供信息	
—— 4. 解释应激情绪反应的本质。	“你可能了解当你感到焦虑时身体的紧张，而且，你可能用一种焦虑的方法来思考——担心这个情境、担心

怎样对付它。躯体 了你的应激反应。”

—— 5. 解释对应激情境可能的反应阶段。

“当你感到焦虑时，你可能倾向于把问题看得很严重。例如，你在期待某一种情境时感到非常急躁，然后你在情境中感到焦虑，特别是当它开始压制你时，当情境结束后，你感到了解脱。”

—— 6. 强调应激预防中学习特殊的应对技巧和求助者参与制定应对策略的重要性。

“我们将学习一些行动应对策略，象身体和肌肉放松、精神放松等。然后你也可以学习一些考虑情境的不同方法，不是所有的应对策略对你都是最好的，因此你要选择你感到最好的一个。”

III. 直接行动技能的获得的练习

—— 7. 咨询者讨论和示范直接行动应对策略（或使用象征示范）：

“首先，我将解释我们说的每一个应对技巧。然后，我来演示当你被激怒时应怎样运用它。”

—— a. 收集有关应激性情境的客观、真实的信息；

“它帮助你获得有关使你激怒和生气情境的信息。让我们找出这样的情境和人，然后看看是否有其他的方法来理解这种情境，例如，你是否把这个情境看做是对你解决问题的能力挑战，而不是人身攻击。”

—— b. 识别缩短路线和逃避路径——选择能降低情境应激的方

“假设你陷入某一情境，你感到将失去控制，在你大打出手前用什么方法来摆脱它或使它减轻？例如，数数到 60，离开房间，等等。”

法:

精神放松

_____ c. 注意力转移;

“控制愤怒的一种方法是分散你的注意力, 将你的注意力从你感到愤怒的这个人身上移开, 如果不得不呆在原来的房间, 则注意房间中非常难注意的物体, 想像有关这个物体的你能想到的所有问题。”

_____ d. 意象处理;

“好, 为避免自己大打出手做努力的另一种方法是使用想像, 想像某些令人平静和非常高兴的事, 如倾听自己喜爱的唱片或在夏日的海滩。”

躯体放松

_____ e. 肌肉放松;

“肌肉放松能帮助你应对无论何时你所感到的应激唤起和脸发烫或身体紧张, 它能帮助你使身体放松, 从而控制你的愤怒。”

_____ f. 呼吸技术;

“呼吸对学习身体放松也是重要的, 有时, 在一种紧张处境下做深而慢的呼吸, 可以使你在说或做你不想做的事前有时间想好对策。”

缓和的应对策略

_____ g. 视野扩大;

“让我们尝试从一个不同的视野来看这个情境——也许这个情境中有一些是我们所忽视的。”

_____ h. 社会支持;

“让我们汇集你能使用的一些人和资源, 作为社会支持系统。”

_____ i. 公开讨论情感。

“花一些时间展露你的情感会有帮

- 8. 求助者选择最有帮助的策略，并在咨询者的帮助下练习每个策略。

助。”

“我们将复习大量可能的方法来帮助你
你的愤怒，以使它不会引起辱骂行为。
我确信你有一些选择，你为什么不选择一些你认为对你最有帮助的方法？我们练习它以便使 你能从它们那里得到一些感觉。”

IV. 认知应对技巧的获得和练习

- 9. 咨询者描述使用认知技巧对付应激性情境的四个阶段。

“你可能记得我们早先讨论过，我们谈到学习在应激性或令人愤怒的情境的关键时期使用应对程序。现在，我们将致力于帮助你在这四个重要时期使用应对思想：为情境做准备，处理情境，在情境中处理关键期，在情境后进行自我鼓励。”

- 10. 对于每个阶段，咨询者示范应对陈述的例子。

“我给你一些在这四个重要时期所使用的应对思想。例如，当我面对一个应激性情境并试图使自己做好精神准备时，这是我想的一些事。”

- 11. 对于每个阶段，求助者选择最自然的应对陈述。

“我给的例子对你来说可能是不自然的，你可以选择或增加你自己的应对陈述”。

- 12. 咨询者指导求助者在每个阶段练习应对陈述。

“有时，因为你不习惯在些关键期将注意力集中于应对思想，开始使用有点不方便。我想你可以通过大声讲你选择的应对思想来得到一些感觉。让我先从为情境做准备练起。”

- 13. 咨询者示范和指导求助者

“好，下次我想让你练习用一个激惹

按四个阶段的顺序练习，
用语言表达应对陈述。

V. 在问题情境中应用应对技巧

—— 14. 使用求助者选择的应对策略和技巧，咨询者示范想像一个应激（或与问题有关）情境时怎样运用这些应对方法。

—— 15. 求助者想像与问题有关的应激性情境练习应对策略。

—— 16. 求助者用角色扮演与问题有关的情境来练习应对策略。（这一步必须重复多次）

VI. 在潜在问题情境应用应对技巧

—— 17. 咨询者示范求助者选择应对策略到潜在的应激性情境中。

—— 18. 求助者练习，运用应对策略到潜在的应激性情境中，通过：

情境中的你能使用的次序大声地用语言表达应对思想。”

“现在当面对一个问题情境时，你能练习使用所有的应对策略。例如，假定我是你，我的上司朝我走过来，由于误传而指责我，这时我在这种情境中应怎样使用应对技巧？”

“好，你为什么不试一下，只想像这个情境——想像每当你失去控制时，这是使用你的应对技巧的信号。”

“我们可以用角色扮演练习。假设我是你的上司，要约见你，你可以使用你的应对技巧来准备这次会谈；然后，在会谈中，当你变得紧张和开始发脾气时，练习你的技巧。”

“现在让我们试试另外一些情境，它们现在不是问题情境，但将来可能会是，这将给你一个机会来看你将怎样运用这些技巧到将来可能会遇到的另外情境中，例如，假定我刚发现我不能得到晋升，而我相信这确实是我应得的。我是这样应对这个情境的。”

“好，现在你试试。”

- | | |
|--|--|
| <p>_____ a. 想像一个潜在的应
激性情境;</p> | <p>“你想像刚知道你将被调到新的地方,你对此很吃惊,想像你将怎样应对。”</p> |
| <p>_____ b. 参与角色扮演练习;</p> | <p>“角色扮演一个情境,我是你的丈夫,并告诉你我刚知道自己病得很重,你要象我们刚才谈的那样练习你的应对技巧。”</p> |
| <p>_____ c. 在角色扮演中,作为教师教授学生在
应激性情境中如何使用应对技巧。</p> | <p>“这次我扮演慢性关节炎患者,感到持续性疼痛。我希望你是我的咨询者,指导我怎样学会使用应对技巧来处理这种慢性不适。”</p> |

VII. 家庭作业和复诊

- | | |
|--|---|
| <p>_____ 19. 咨询者和求助者讨论在实际情境中应用应对策略。</p> | <p>“我相信,现在你已经能够将这些应对技能应用于实际生活场景中。虽然它们不会像你希望得那样很快起作用,但你会越来越能够应对,而不失去控制。”</p> |
| <p>_____ 20. 咨询者指导求助者怎样使用日记,记录在实际情境中使用应激预防的情况。</p> | <p>“每次使用应对技巧,都用日记简略描述你使用它们的情境。”</p> |
| <p>_____ 21. 咨询者安排复诊时间。</p> | <p>“下星期我们再见时要查看你的日记,看你进行得如何。”</p> |

观察者评论: _____

参考文献

- Bedrosian, R. C., & Bozicas, G. D. (1994). *Treating family of origin problems: A cognitive approach*. New York: Guilford.
- Castillo, R. (1997). *Culture and mental illness*. Pacific Grove, CA.: Brooks/Cole.
- Fausel, D. (1995). Stress inoculation training for stepcouples. *Marriage and Family Review*, 21, 137-155.
- Foa, E. B., Rothbaum, B. O., Riggs, D. S., & Murdock, T. B. (1991). Treatment of posttraumatic stress disorder in rape victims: A comparison between cognitive-behavioral procedures and counseling. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 59, 715-723.
- Gendlin, E. T. (1996). *Focusing-oriented psychotherapy: A manual of the experiential method*. New York: Guilford.
- Guterman, J. T. (1992). Disputation and reframing: Contrasting cognitive-change methods. *Journal of Mental Health Counseling*, 14, 440-456.
- Huang, L. N. (1994). An integrative approach to clinical assessment and intervention with Asian-American adolescents. *Journal of Clinical Child Psychology*, 23, 21-31.
- Laungani, P. (1993). Cultural differences in stress and its management. *Stress Medicine*, 9, 37-43.
- Lehrer, P. M., & Woolfolk, R. L. (Eds.). (1993). *Principles and practice of stress management* (2nd ed.). New York: Guilford.
- Leserman, J., Perkins, D., & Evans, D. (1992). Coping with the threat of AIDS: The role of social support. *American Journal of Psychiatry*, 149, 1514-1520.
- Meichenbaum, D. (1993). Stress inoculation training: A 20-year update. In P. M. Lehrer & R. L. Woolfolk (Eds.),

- Principles and practice of stress management* (2nd ed., pp. 373–406). New York: Guilford.
- Meichenbaum, D. (1994). *A clinical handbook: Practical therapist manual for assessing and treating adults with post-traumatic stress disorder*. Waterloo, Ontario: Institute Press.
- Midori-Hanna, S., & Brown, J. (1995). *The practice of family therapy*. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
- Motenko, A. K., & Greenberg, S. (1995). Reframing dependence in old age. *Social Work*, 40, 382–390.
- O'Hanlon, W. H., & Weiner-Davis, M. (1989). *In search of solutions: A new direction in psychotherapy*. New York: Norton.
- Oppenheimer, M. (1992). Alma's bedside ghost: Or the importance of cultural similarity. *Hispanic Journal of Behavioral Sciences*, 14, 496–501.
- Robinson, T., & Ward, J. (1992). "A belief in self far greater than anyone's disbelief": Cultivating resistance among African American female adolescents. In C. Gilligan, A. Rogers, & D. Tolman (Eds.), *Women, girls and psychotherapy: Reframing resistance* (pp. 87–104). Binghamton, NY: Haworth Press.
- Rodriguez, C., & Moore, N. (1995). Perceptions of pregnant/parenting teens: Reframing issues for an integrated approach to pregnancy problems. *Adolescence*, 30, 685–706.
- Ross, M., & Berger, R. (1996). Effects of stress inoculation training on athletes' postsurgical pain and rehabilitation after orthopedic injury. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 64, 406–410.
- Weeks, G., & Treat, S. (1992). *Couples in treatment*. New York: Brunner/Mazel.

学习评判反馈

第一部分

使用再构会谈检测清单评估你的会谈表现。

第二部分

1. 你对这个求助者可以像这样介绍治疗基本原理:

你知道,有时愤怒和急躁情绪控制了你。这个治疗程序能帮助你学会在特别困难的时期如何控制自己。

2. 下面是关于应激预防的概况:

首先,我们将找到一些孩子做的使你心烦的事,当你知道是在这类情境中你恼怒时,你便能学习通过保持你的镇静来控制烦躁;这个程序将帮助你学习保持镇静的不同方法。

3. 信息—参阅应激预防会谈清单中的引导语 7 的 a 项。

逃避路径—参阅引导 7 的 b 项

注意力转移—参阅引导 7 的 c 项

意象控制—参阅引导 7 的 d 项

身体放松—参阅引导 7 的 e、f 项

缓和应对—参阅引导 7 的 g、h、i 项

4. 下面是给求助者解释的例子。

阶段	解释	认知应对
为令人愤怒的情境做准备	在争执或争论之前,你能计划处理方案	“我想对他说什么,以使我的观点被他了解。” “我能告诉他我没有叫嚷。”
面对令人愤怒的情境	当你对他说话时,你想怎样控制自己。	“保持用正常的语气交谈,不要大叫。”“要让他说。不要大声叫嚷,那没有用。”

处理非常令人 愤怒的时刻	如果你感到非常愤怒，你需要想一些能保持冷静的事。	“等一会儿，慢慢来。”“保持自我控制，保持冷静。”
为应对进行自我鼓励	承认你保持了冷静，这是重要的，要给自己鼓励。	“我保持了冷静。”“我能感到我正在变得愤怒，但我能控制它们。”

5. 咨询者利用想像或角色扮演法给求助者提供练习机会，如你扮演孩子的角色。参阅应激预防会谈检测清单中的这类例子（引导语 14、15 和 16）

第三部分

使用应激预防会谈检测清单评估你的角色扮演。

第十七章 冥想与肌肉放松

你感到忧虑吗？有压力吗？

你有紧张性头痛吗？

你有酒精、烟草等依赖吗？

你感到慢性疲劳吗？

你面对挫折时易怒吗？

你在某种情境中和特定时间里血压升高吗？

你的免疫系统功能低下吗？

很多人在生活中都会遇到过上面提到的一个或多个问题。焦虑是求助者中最常见的问题：应激与头痛、消化不良这类生理不适有关，应激也与心脏病、癌症和其他严重疾病有关系，也许这算做“应激综合征”的结果。近些年来出现了大量治疗应激和焦虑的方法。最早的方法是 Jacobson 于 1929 年创立的“顺序放松”法。书店中健康自助法柜台摆放着许多应激管理的书籍。在同一时期，有关应激管理方法优缺点的研究也非常多。

本章将介绍五种应激管理及放松策略。其中三种冥想程序分别是：Kabat-Zinn 的沉思冥想法，Benson 和 Benson 与 Stuart 的放松反应法，Borysenko 和 Borysenko 的仁爱冥想法。另外还有两种肌肉放松训练法。你还将了解到，两类方法相互补充：肌肉放松法（躯体扫描）是冥想法的组成部分，而对不同肌肉群的聚焦（像激光器发出的光）冥想（头脑意识），则可能是肌肉放松训练的组成部分。这五种策略主要应用于与应激有关的认知和生理功能治疗等领域。

本章目标

1. 在给出的9个咨询者反应例子中，要至少能在7个例子中辨别出放松反应的步骤。
2. 在8个咨询者的反应例子中，辨别出哪一个使用了沉思冥想。
3. 向另一个人教授沉思冥想或放松反应法。用录音带录下你的教学过程，并依照章末的会谈检测清单评估自己教学的每一个步骤，或者让一个观察者根据清单评估你的教学。
4. 描述你在一个模拟案例中将如何使用肌肉放松法的七个主要部分。
5. 在角色扮演中为求助者示范13个（共15个）肌肉放松步骤，并依照章末的会谈检测清单评估自己的成绩。
6. 在角色扮演中为求助者应用躯体扫描肌肉放松法。

冥想的过程与应用

咨询者和研究者们以不同方式为冥想做了定义。Fontana 首先描述了冥想是什么和不是什么：“冥想不是进入睡眠状态，不是进入精神恍惚状态，也不是将自己与现实隔离，不是自我封闭，不是行为怪异，变得丧失思想，忘记自己在哪里。冥想是使头脑警觉，是使注意力和精神集中并聚焦，使头脑更好地意识和感觉世界，变得更为人性化，更加了解自己。”Levine 将冥想描述为“走向无穷的方法。冥想进入心灵，医治心灵，它所达到的程度如此之深，如此之广，只有‘心’一词才能加以描述。冥想使我们直接参与我们的生活，而不只是过一种事后回顾的生活”。Dean Ornish 将冥想描述为“集中精神”，“聚焦意识”，“积极关注”和“焦点思维”。禅宗大师 Thich Nhat Hanh 描述冥想中的沉思为“保持自己在现实中的活生生的意识……沉思就像一种奇迹，它在

一瞬间将我们散乱的心灵聚合起来，恢复它的整体性，使我们时刻生活在生命之中”。LeShan说，“我们冥想就是为了发现、揭示、返回我们曾经模模糊糊、无知无觉地拥有过，但又不知在何时、何地遗失了的东西”。“冥想已经浸润了我们的文化。很多美国人都尝试过冥想，其中很多人将它纳入自己繁忙的生活”，也许这种冥想过程帮助人们打破了“始终不变的知觉模式”。“冥想法现在是医学、心理学、教育学和自我发展训练中的标准工具”。

“冥想是引出放松反应的技术之一。从字面最广的意义上讲，它是每个人都熟悉的自然的过程，即将自己的精神聚焦到某个物体或活动上。实际上，这是很多时候每个人都在做的事情。当你使用冥想进行放松时，你把自己的注意力转向内部，集中在一种重复的事情上，如呼吸、一个字词或一段祈祷。这时肉体和精神平静下来，生理和心理静息随之而来。当然，我们知道，心灵通常是非常活跃的，很难加以聚焦。”Joan Borysenko说，“沉思是行动中的冥想，是一种让生命在没有预设限制下展开的‘此时此地’的方法。它意味着你敞开了对此时此刻的意识，意识到此刻所能拥有的。它是对内心世界的思想与感受和对外部世界的行为与知觉进行注意的一种放松状态。”

Patel视冥想为一种“找到一个舒适的姿势——或坐、或躺、或站（尽管坐姿是最常见的）的练习活动：在一个宁静的环境里，调节呼吸，放松躯体，保持不抵抗的心态，专注于一个目标之上。冥想的目标不一定是物质的，它可以是一个想法，一个意象，或一个事件；也可以像大乘佛教的冥想中那样，在心中重复一个词，或一段祈祷语；还可以观察自己的思想、知觉或反应；或者专注于身体产生的节奏（如呼吸）”。Barry Long说，“冥想是构造过程，因为它渐渐地溶解掉你心中虚假的自我”。

最后，Borysenko说：“冥想是使注意力愉快地停留在此时此刻的活动上……为了建立内部意识形态，去见证刚刚过去的内部

对话，你必须要有有一个观察点。如果你乘船去观海潮，但忘记将船锚固定，你将很快被带到大海里去。心灵也同样如此。如果没有将心灵固定在一个地方，它将被思想的急流卷走。你将丧失观察正在发生的事情的能力。进行冥想练习，将使你的身体通过放松反应而平静，使你的心灵通过锚定注意而固定；冥想是自我康复和自我调节的最重要的工具。”我们赞同Benson的观点，即“沉思冥想的整个过程提供了‘心理治疗的入门钥匙’。精神世界的大门从而向巨大的洞察力和创造力敞开，并铺就了摆脱过去的困扰、强迫、冲动或不健康习惯的道路。冥想过程与心理治疗的目标和技术之间的关系清晰可见”。Carrington说，“是冥想体验带来了治疗上的变化，而不是所使用的治疗技术唤起了这种体验”。

Carrington总结了冥想方法能够帮助治疗的主要适应症和困难问题：“紧张、焦虑状态，心理、生理紊乱，慢性疲劳状态，失眠和嗜睡，滥用酒精、药物或烟草，过分自责，慢性情绪抑郁或亚急性反应性抑郁，易怒，低挫折耐受性，强烈的顺从倾向，心理鉴别力缺乏，缺乏自信，分离焦虑，居丧的病态反应，创造力障碍，情感生活的不适当表达，将求助者对治疗者的依赖转为依靠自己（这在心理治疗结束时非常有使用价值）。”Murphy 和 Donovan为冥想对生理和心理的影响做了一份详细的记述。就像表17-1中所列的一样，新近的研究表明冥想有广泛的应用范围。

表 17-1 冥想的有关研究

减低焦虑	血液循环和新陈代谢
抑郁	老年人
高血压	射击手
崩溃预防	呼吸疾病
学校应用	应激
药物滥用	

对不同文化群体求助者应用冥想和放松法

我们只发现少量将冥想和放松应用于不同文化求助者的实例。Ruben 将放松训练作为课堂指导程序的一部分，用于五年级的西班牙裔和黑人学生。放松训练增强了这些学生的自尊感，并减少了他们的辍学率。Ibanez-Ramirez、Delgado-Morales 和 Pulido-Diez 报告说，在治疗中使用放松训练成功地治愈了西班牙裔年轻同性恋者的阳痿病。冥想在中老年身上也有多方面的应用，包括延年益寿、调节呼吸、降低高血压。通常冥想法比放松法对于老年人来说具有更好的效果。

基本冥想

Patel 描述了冥想的七个基本步骤：

1. 冥想的环境应避免噪音、运动、亮光、电话以及其他人的活动。
2. 确保你感觉舒适：房间温暖，穿宽松的衣服，排空膀胱和胃肠，餐后 1 小时内不做练习。
3. 后背挺直，身体放松，眼睛全闭或半闭。
4. 呼吸通过鼻腔向下进入腹腔，确保你的呼吸规则、缓慢、均匀。
5. 注意力集中在一个物体、单词、短语或自己的呼吸上。
6. 对外界引起分心的事情养成被动、放松的态度。
7. 有规律地进行练习。

冥想的三种变式见表 17-2，分别为：(1)沉思冥想；(2)放松反应冥想；(3)仁爱冥想。我们将这三种形式的冥想分别用于：寻求心理解脱的求助者，健美中心的练习者，以及医院的住院患者（辅助治疗措施）。

表 17-2 沉思冥想、放松反应冥想、仁爱冥想的步骤

沉思冥想	放松反应冥想	仁爱冥想
1. 基本原理	1. 基本原理	1. 基本原理
2. 冥想基本态度的引导	2. 关于放松冥想的时间、地点和练习时间长度的引导	2. 呼吸引导
3. 冥想时投入、自律和心量能量的引导	3. 关于冥想词、成语或祈祷语的指导	3. 星光想像引导
4. 冥想准备	4. 冥想姿势、眼睛的引导	4. 为自己祈祷
5. 放松肌肉	5. 放松肌肉引导	5. 将所爱的人引导入想像之中
6. 呼吸引导	6. 呼吸引导	6. 为所爱的人祈祷
7. 心灵漫游引导	7. 关于被动态度的引导	7. 将误解自己的人引导入想像之中
8. 冥想过程引导	8. 关于冥想时间长短的引导	8. 为误解自己的人祈祷
9. 讨论冥想体验	9. 讨论冥想体验	9. 想像广袤星球的引导语
10. 家庭作业	10. 家庭作业	10. 祈祷和平与容纳
		11. 冥想引导
		12. 讨论仁爱冥想
		13. 家庭作业

沉思冥想的步骤

进行Kabat-Zinn的沉思冥想，就像是“乘上了自我发展、自我发现、学习和康复旅程的飞机”。

沉思冥想的基本原理

Jon Kabat-Zinn 提出下述沉思冥想原理：

我们沉浸在一个永恒活动的世界里。我们很少去问谁在做着这些活动，换句话说，我们很少触及存在的世界。回过头来思考存在的世界并不是那样困难，只要我们提醒自己进行沉思，我们就可以做到。片刻的沉思就是片刻的平和与安宁，即使是在运动的间隙也可如此。当你的整个生命被活动驱使着时，正规的冥想练习为你心智的健全和稳定提供庇护所，使你恢复某些平衡和希望。冥想是阻止你只顾往前冲的方法，它使你有时间体察深度放松和愉快安宁的状态，并铭记自己是谁。正规的沉思练习使你在回到活动世界中时具有了力量和自知之明，使你的行为发自你自己的存在。那么至少某种程度的耐性、内心平静、清晰与平衡，就会使你的忙碌和压力减少，事实上它们可能会完全消失……这就是为什么我们每天都要安排专门时间做正规的冥想练习。它是使我们停下来重组我们的心灵和滋养我们存在本质的方式。

沉思冥想是要关注和见证从一个时刻到另一时刻所发生的事情。让求助者选择一个宁静的地方进行冥想，闭上眼睛，集中注意呼吸，允许思想自由地流动大约 10 至 20 分钟。如果思想“溜号”，我们可以通过注意呼吸把它重新拉回来。为了促进和提高冥想练习，参与者要有基本的态度。

沉思冥想练习中基本态度的引导

Kabat-Zinn 描述了七种冥想练习的基本态度：

1. 非判断性 意味着沉思是通过对自身体验进行无偏的见证和观察而实现的。我们习惯于将我们的体验进行分类和评价，因而将我们自己禁锢在无意识的“膝腱反射”或通常没有客观基础的机械反应之中。例如，做练习时，你要考虑所有必须做的事，还可能会想这多么令人厌烦。然而正是这些判断使你不能观察到所发生的事。如果你继续这种

判断性思考，它就会使你远离此时此刻的意识状态。要矫正这种过程，就去注意你自己的呼吸吧。

2. 耐性 意味着我们必须允许事物按自己的时间展现自己。耐性在沉思练习中就意味着，我们不必以每时每刻的活动来填充自己的生命。
3. 初学者的期待 是建立在我们过去的经验或认知结构基础上的，它妨碍了我们观察事物的真相。对于刚开始进行冥想练习的人，重要的是要时时刻刻将自己开放，而不要被自己对下一时刻会发生什么的期待所框住。
4. 信任 要培养你对自己的感觉和直觉的信任。让求助者相信自己的感觉和智慧，而不是怀疑它们。例如，冥想时你的姿势明显不舒服，那么就变换另一种感觉好的姿势。如果你的直觉告诉你这样做，那么就按照直觉告诉你的那样去做，尝试找到符合需要的方式。就是说，要服从和信任身体和感觉告诉你的事情。
5. 无为 意味着沉思冥想是这样一种练习过程，它不想努力获得什么或到达什么地方。要让求助者体验此时此刻，注意和接纳此时此刻所发生的事情。
6. 接纳 意味着不要担心结果。要让求助者只集中注意力和接纳此刻分分秒秒发生的事情。
7. 放任 意味着不附着、不停留在某种思想上。如果某个求助者出现了评判想法，那么就让他放任自己的想法，并观察这种评判想法。

关于投入、自律和心理能量的引导

Kabat-Zinn要求求助者在进行冥想时要投入，就像从事运动训练那样。除去上面的七种态度外，要让求助者对练习非常投入，坚持自律练习，用足够的心理能量去培养出强大的冥想和高度的

沉思。Jon告诉求助者，“你不一定要去喜欢它，只要练习它就行了”。这样经过八个星期的练习，求助者就可以讲练习是否有益了。

冥想的准备

求助者要在每天空出一段整块时间——至少一周六天和连续八周——进行练习。进行沉思冥想练习时，我们认为坚持三个星期的时间是必须的。要让求助者在家里安排一个专门的地方冥想，这个地方应该舒适、不被打扰。建议沉思冥想时的姿势是在椅子或地板上的坐姿。求助者要挺直自己的头、颈、背，这种姿势可以使呼吸毫不费力的流动。如果坐在椅子上，不要靠椅背，让脊椎直立。如果在地板上，就坐在垫子上，使臀部抬高离开地板。某些求助者更喜欢仰卧冥想，感觉更舒适；我们发现某些求助者在躺着冥想时常常睡着了，他们把放松和睡觉联系到了一起，他们失去了意识。经过一段时间（约两周）的冥想以后，这些求助者开始能够维持意识，并减少睡觉的欲望。

放松肌肉的躯体扫描

Kabat-Zinn描述躯体扫描像一个净化人体不同部位的过程。躯体扫描的过程帮助求助者发现自己的身体，并引起精神与肉体的意识（我们将在本章肌肉放松部分再来描述躯体扫描）。

呼吸引导

让求助者观察呼吸的流入和流出（见第十八章）。要求求助者注意进入和排出的空气温度差，并感受空气进出鼻孔的感觉。

心灵漫游的引导

注意力常常被心中流淌的思想急流卷走。要指导求助者每当

这种情况发生时，将自己的注意力放在呼吸上，放任思想流动。Kabat-Zinn告诉求助者，在冥想期间思想的出现并不有害，更不是避之惟恐不及的。重要的是你是否在冥想中意识到了自己的想法和感觉，以及你如何处理它们。“冥想所关心的不是多少思想在那里流动，它更关心的是你在意识中为它开辟了多少空间”。假如求助者被思想、情感、感觉、声音、疼痛或不适感等占据，那么就要指导他们将注意力放回到呼吸上，让分心的事情自然消散。

冥想过程引导

指导求助者闭上眼睛，冥想 10 到 20 分钟。在他们结束冥想时，先平静的坐一会儿，然后运动和伸展一下躯体，放松之后再睁开眼睛。

冥想体验的讨论

讨论和探索求助者对冥想的反应。求助者们可能不太自信，因为他们在对冥想过程做出判断。和他们讨论第一次的冥想体验时，咨询者应当对求助者的体验不做评价。如，假设求助者说他们的多数体验是跟着思想跑，这时就要鼓励他们继续练习冥想，因为每次练习都将有不同的体验，而体验过程才是重要的。

讨论家庭作业

咨询者应指导求助者选择宁静的地方和适当的时间进行冥想，并确定冥想的次数。冥想时要利用先前的沉思冥想体验作为指导。同时，还应告诉求助者不要在餐后一小时内进行冥想；假如冥想是在晚上进行，就应该在就寝数小时前进行。最后，鼓励求助者把沉思意识贯穿于每天的活动之中，如吃饭、坐车、日常工作、与人交往等。主旨是“此时此地”、“此时此刻”。

除了上面讲的呼吸冥想外，Kabat-Zinn还描述了四种其他类

型的沉思冥想:

1. 呼吸和躯体一体的打坐
2. 环境、自然和音乐声中的打坐——不要去听声音，而是聆听此刻所发生的
3. 注意内心思想和感受的打坐——将思想和感受知觉为心灵活动中的事件，注意它们的内容和变化
4. 放任意识的打坐——敞开和接纳进入你意识中的任何事情，来去自由

放松反应冥想的步骤

基本原理

下面是 Benson 和 Stuart 进行冥想治疗时解释原理的实例:

冥想是引导出放松反应的一种技术。从字面最广的意义上讲，它是每个人都熟悉的自然过程，即将精神集中在某个物体或活动上的过程。当你应用冥想进行放松反应时，你将自己的注意力指向内部，聚焦在一个重复的事情上，如呼吸、一个单词或一段祈祷词等。你的身体和心灵开始宁静下来，生理和心理上的平静也随之而来。但是我们也都知道，心灵通常都是非常活跃、难以集中的。

关于时间、地点和练习时间长度的引导

Benson和Stuart建议进行冥想的最佳时段是早餐前的一段时间，因为在一天工作开始前进行冥想，会为这一天提供一个好心情，而这一时间也通常没有杂乱的事情和活动。选定有规律的时间最好，这样可以逐渐形成习惯。进行练习的地方也是非常重要

的，他们建议选择吸引人的、有安全感的地方。所选的地方应当是安静的，能让你摆脱分心的事情或干扰。理想的是每天能够一次练习 10 至 20 分钟，或者一天 2 次。开始时求助者可能难以留出时间进行冥想，并难以保持一段冥想的时间。他们应该试验用不同的方法去体会，以掌握最好的冥想方式。

关于冥想词、短语或祈祷语的引导

聚焦心灵的一种方法就是将注意力与呼吸建立联系。你可以将注意力集中到一个单词、一个短语或一段祈祷语上。你可以从自己的信仰体系中获得聚焦对象。“例如，基督徒可以选择《圣经》的段落。求助者也可以选择一个中性的词，如‘一’、‘和平’或‘爱’等。求助者也可以集中在自己的呼吸上，感觉空气的进入和流出”。

关于姿势和眼睛的引导

任何一种舒适的姿势对于冥想都是合适的，仰面躺着或坐着。我们更喜欢后背挺直的坐姿，坐在稳固的支持物上。要让求助者闭上眼睛，因为闭上眼睛时，他们更容易聚焦、体验此时此刻。

要求求助者放松肌肉

求助者将注意力集中在呼吸上时，咨询者可以迅速审视他的身体，从头到脚或从脚到头。下面将要介绍的任何肌肉放松程序都可用来作为进行冥想练习的前奏曲。

呼吸的引导

指导求助者进行呼吸时，要让他们注意自己腹部的起伏，注意空气进入和排出鼻腔，注意进入鼻腔的微冷空气和排出鼻腔的温暖空气。当呼吸变得平静和规则时，求助者可能会注意到在吸

气结束、呼气开始前有一个细微的停顿。

关于被动态度的引导

Benson 和 Stuart 说冥想与看电影一样：你可以选择在情绪上卷入电影情节，也可以保持与己无关的态度，说“它只不过就是一场电影罢了”。冥想练习使人们去观察或见证自己的思想、情感或躯体感觉等。Mark Epstein 在他的《没有思想者的思想》一书中，将冥想中的注意力描述为“逐渐消失的反应性……将反应的自我从主体的经验中分离出去，这种纯粹的注意力练习使得冥想者返回到一种无条件的开放状态”。这就像观察一列火车：站在那里或坐在那里，每个时刻都不动姿势地盯着一节车厢。你只是在见证或观察，而并没有让心理判断参与其中。当一节车厢飞快地进入你的视野后，你并不追随它，而是开始注意到进入视野的下一节车厢。你要让求助者知道，不要担心冥想是否“恰当”以及如何进行冥想，只要维持一种被动态度，放任自流就可以了；而当判断想法出现时，则应马上将注意力拉回到单词或呼吸上来。

关于冥想时间长短的指导

要求助者进行 10 至 20 分钟的冥想。咨询者和求助者要为求助者进行第一次冥想的时间长短一起进行讨论。我们发现 10 分钟对于第一次冥想可能长了些，但是，我们也发现一些求助者宁愿时间长一些。

冥想体验的讨论

咨询者要掌握求助者对刚刚完成的冥想体验的反应。如：求助者的感觉怎么样？求助者如何处理分心事物？

家庭作业和复诊

咨询者指导求助者每天进行冥想两次或至少一次，要帮助求助者找到一个安静的地方和时间段练习冥想，并提醒求助者：进行有规律的冥想是治疗和康复过程中重要的组成部分。

仁爱冥想的步骤

Borysenko和Borysenko发展出了一种不同类型的冥想方式，被称为“仁爱冥想”，它包含的步骤详见表 17-2。他们的体系以 Dossey 的《治疗语词》一书为基础，该书描述了人际互动医学，作者认为“心灵是个体内部和个体之间进行治疗与康复的因素”。

治疗原理

Borysenko 和 Borysenko 认为进行将慈爱和宁静带给周围人们的冥想，是使问题得以解决的持续可利用的源泉。他们建议用这种方法去冥想你自己和你所爱的人、你对他人的否定态度，以及向你自己和他人敞开心胸。在这样的冥想中，你对星空的想像会为你带来心理、情感和精神上的安宁。

呼吸引导

进行冥想前，要让求助者首先“进行几次自由的呼吸，通过将注意力聚焦在膈式、腹式呼吸，或者天地交融式呼吸上，而使自己平静下来”（下面有解释）。求助者可以遵照天地交融式呼吸的引导进行意识训练。指导语可以用录音带播放，这样求助者就可以在家中进行练习了。

1. 坐好后，使你的脚自然平放在地面上，你的后背挺直而放松……调整一下自己的身体，使它尽可能的舒适……现在可以闭上你的眼睛。

2. 要求求助者进行一次自由呼吸，然后转到腹式呼吸上，感觉和想像当你吸气时，你的腹部在胀满扩大，当你呼气时，腹部放松下去……继续呼吸直到你感觉躯体放松下来……这是很多呼吸方法中的一种。现在我们学习另外一种称为天地交融式呼吸的方法。我们想像呼吸能量来自天空和大地，同时进入我们的心脏。
3. 让我们从呼吸天空的能量开始。感觉和想像太阳的能量悬浮在你头上，无论这是白天还是黑夜……当你吸气时，这股能量贯通你的头顶，进入你的心脏。呼气时，则感到广阔无比，仿佛你的呼吸能达到宇宙的边缘……进行若干次这样的呼吸……
4. 现在我们将呼吸大地的能量。感觉和想像大地的能量就在你的脚下……当你吸气时，能量通过你的脚进入你的心脏，呼气时，感到一种向宇宙的扩张感。尝试进行这样的呼吸1到2分钟，直到你的自我感觉很舒适……
5. 现在睁开眼睛，望一望大自然。一边继续呼吸练习，一边看着大地和蓝天。这种呼吸使你进入此时此刻，并祝福世界和平永存。

星光想像引导

Borysenko 和 Borysenko 提出了如下的星光想像引导语：

想像在你头顶的正前方有一颗闪闪发光的星星，向你倾泻着爱的水流和光辉。让这爱之光进入你的头顶，贯穿全身，揭示出你心灵的纯洁；你的心灵因而扩大、延伸，超越了你自身，最后与神圣之光融合在一起。想像你自己完全被包围在光环之中，为你自己重复这些慈爱祝福吧，将你的爱和问候给予你的独生子吧。

为自己祈祷

求助者可以用下列祈祷语为自己祝福：

愿我宁静，
愿我的心胸保持开阔，
愿我唤醒自己的真实本质之光，
愿我得到治愈，
愿我是所有存在物的康复源泉。

想像所爱的人的引导语

还可以让求助者将自己所爱的人带入想像中：

下面，让一个或若干个你所爱的人进入脑海。尽可能地想像出他们的细节，想像爱之光照耀在他们身上，为他们做通体洗浴，并激发出他们自己内心的光亮。想像这光越来越明亮，融入了神圣的光环，他们整个被包围在光环之中。于是祝福他们。

为所爱的人祈祷

咨询者指导求助者使用下面的祈祷语：

愿你宁静，
愿你的心胸保持开阔，
愿你唤醒自己的真实本质之光，
愿你得到治愈，
愿你是所有存在物的康复源泉。

想像那些误解自己的人的引导语

让注意力转到那些曾误解求助者的人身上，要让求助者这样

去进行想像：

现在请想像一个或若干个曾对你有过不公正行为，而你又准备给予他们宽恕的人。将他们置于爱之光环之中，让这种神圣之光洗刷掉他们身上所有的消极和误解，就像你为自己和自己所爱的人做的一样。

为误解自己的人祈祷

咨询者指导求助者使用下面的祈祷语为误解自己的人祈祷：

愿你宁静，
愿你的心胸保持开阔，
愿你唤醒自己的真实本质之光，
愿你得到治愈，
愿你是所有存在物的康复源泉。

想像广袤星球的引导语

咨询者现在指导求助者想像地球的广袤：

看太空中我们美丽的星球，就像一颗镶嵌在广袤星空的精致宝石。想像地球被爱之光环绕，它的周围有绿色的大地，蓝色的海洋，白色的两极，两条腿和四条腿的生物，鱼在游水，鸟在飞翔。地球是两极对立的王国，白天和黑夜，善良与丑恶，疾病和健康，贫穷与富裕，上和下，男和女。大地之广袤能够包容下所有这一切，为它祈祷吧。

祈祷地球和平与容纳

求助者为地球进行下列祈祷：

愿地球和平宁静，
愿所有的人们敞开心胸对待自己，对待每一个人，
愿所有的人们唤醒他们自己的本质之光，

愿所有的造物受到祝福。

冥想的引导

指导求助者利用上面所讲的想像和祈祷(在咨询者的帮助下)进行冥想。冥想可持续 15 到 20 分钟。

讨论冥想

和求助者讨论他们在第一次冥想中的感受。咨询者应该避免进行评价。如果这种类型的冥想对求助者没有吸引力,咨询者可以建议另一种办法。

家庭作业

要求求助者每天至少进行一次冥想,并且一天中只要需要就进行这样的冥想。提醒求助者要在冥想时选择安静的地方,在饭前或餐后一小时持续冥想 15 到 20 分钟。这种仁爱冥想是开始和结束一天生活很好的方法。

冥想的禁忌症和副作用

Carrington 和 Goleman 对使用冥想提出一些警告,指出它可能对某些求助者不合适。Carrington 发现某些人可能对冥想“高度过敏”,只需要比其他人更短的时间进行冥想。某些人则可能释放出自己无法控制的情绪,因为他们可能很长时间(3到4个小时)都处在冥想之中。例如,处于精神病活跃期的病人,如果冥想时间过长的话,会产生有害的作用。Goleman 指出,一些有精神分裂障碍的求助者如果进行冥想,可能会过度关注内心世界,而与现实世界脱节。“在剧烈的情绪状态下开始冥想,可能会过分激动不安;强迫而冲动的求助者则可能会过分热衷于冥想中新的体验”。

最后,一些服用某种药物的求助者在进行冥想时会增强药物的作用。Carrington建议在下列求助者进行冥想练习时要有人监督,即服用过抗焦虑药、抗抑郁药、抗高血压药、或甲状腺调节药的人。继续冥想练习可能需要减少这些患者的用药量。咨询者应该意识到求助者正在进行什么医疗措施,这些措施与各种心理干预措施的潜在相互影响是什么。对于咨询者来说,重要的是根据求助者的需要和问题制定出具有针对性的冥想治疗方案。

沉思冥想个案范例

在这个实例中,我们记述了如何将沉思冥想法应用于一个49岁的日本裔美国男性求助者的情况。Yoshi,一个空中交通管理员,报告说他希望减轻工作中体验到的压力,他相信减轻压力将有助于溃疡病的康复,并使他能更好地应付工作。除去躯体检查有应激征兆(高血压)外,Yoshi还报告他常担心会在工作中犯错误。

1. 基本原理

首先,我们向Yoshi解释了沉思冥想具有帮助人们缓解工作压力的作用,并告诉他,这种治疗程序曾被用于患有高血压、焦虑症,以及那些常常需要高度戒备的人。向他描述说,这是个将注意力集中在呼吸上的过程,需要安静的地方,练习时要闭上眼睛,放任思想自由流动。如果他的思想过于分心时,他应该聚焦在自己的呼吸上。一般人应用这项技术,通常每天冥想10到20分钟。为了更好地进行冥想练习,练习者必须有一些基本的态度,这是进行冥想练习的基础。最后,我们确定他是自觉自愿地进行冥想练习的,我们还回答了他对这个过程所提的问题。

2. 练习的基本态度

我们向 Yoshi 解释了七种沉思冥想练习态度。不做评价的态度有助于沉思；进行冥想时，我们要做一个自身体验无偏见的见证者和观察者。人们习惯于将经验进行分类，我们应当避免这种习惯。我们不必用活动和行为填充我们生活的每时每刻；进行冥想时要耐心，要让事情按照它自己的时间去展开。冥想的初学者常常期望当他进行冥想时应当怎样做，但是恰恰相反，他不应让基于过去经验的期望影响冥想过程，他应当向每时每刻的经验开放自己。要相信自己的感觉和直觉，进行冥想时没有“对”和“错”之分。沉思冥想只是一个练习过程，它不是要努力去完成某事或到达某地。他所要做的一切就是去体验在此时此刻所发生的事情。要抱有接纳的态度，不要担心结果，要接受事情存在的此时此刻。最后，我们要 Yoshi 放任、不依附任何思想，不要停留在某种思想和情感上；冥想就是观察正在发生的事情，注意避免进行任何判断。

3. 关于投入、自律和精神能量的引导

我们告诉 Yoshi，练习沉思冥想时要像运动员进行训练时一样的投入。Yoshi 懂得他必须坚定地投入，督促自己坚持练习，并产生足够的精神力量，以便更好地进行冥想练习。

4. 冥想的准备

我们要求 Yoshi 每天留出一段时间（一周至少六天）进行冥想。要找一个安静、没有干扰的地方进行冥想。冥想打坐时，后背要挺直。练习冥想八周后便会逐渐适应这个过程。不要在餐后一小时内进行冥想，进行冥想时要穿着舒适的衣服。

5. 躯体扫描到肌肉放松

我们对 Yoshi 进行了躯体扫描，并告诉他对他的不同肌肉群进行扫描是一种过滤净化过程。这会使他的躯体放松下来，使精神 / 肉体的意识回到此时此刻。

6. 呼吸引导

我们要求他深呼吸，并注意吸气、呼气时腹部是如何起伏的，吸进和呼出空气的温度差异，以及空气进出鼻孔时的感觉。

7. 心灵漫游的引导

Yoshi 说他的注意力常被思想的急流卷走。我们告诉他这无关紧要，当它发生时，他只要把注意力重新集中到自己的呼吸上就行，放任思想离开。要意识到冥想期间的思想和感觉。假如他停留在一种思想、情感、躯体感觉、声音、疼痛或不适感上，他就要将注意力转回到呼吸上来，以淡化那些分心的事情。

8. 冥想的引导

我们指导 Yoshi 平静、放松静坐片刻，然后闭上眼睛，集中注意力于自己的呼吸，让空气自然地进出。我们告诉 Yoshi，沉思冥想不是运动，不需要任何努力，不能强迫它。假如有思想、感情或噪音产生分心的事，应允许它们出现，不要试图影响它们；要在观察它们的同时，注意自己的呼吸。我们告诉 Yoshi，每次进行冥想 10 到 20 分钟。时间到了时，要保持坐姿，闭着眼睛片刻，以便慢慢地从冥想中出来，然后运动、伸展一下，最后再慢慢睁开眼睛。

9. 询问刚刚完成的冥想体验

我们向Yoshi询问有关他冥想体验的问题：“你对冥想体验感觉如何？你是怎么处理分心的事情的？现在你的感觉怎样？”

10. 家庭作业

我们要求 Yoshi 每天进行一次冥想，最好在早上进行。要找一个宁静的环境，选择一个专门的时间，进行快速躯体扫描，牢记七种基本态度，以及投入、自律和精神能量。饭后一小时内不要进行冥想。要将冥想效果贯穿于一天之中（见学习练习活动47）。

学习练习活动 47 / 冥想（放松反应和沉思冥想）

I. 教授一个求助者进行沉思冥想或放松反应是一个心理学的教育过程。练习教授指导过程可选择一个同伴进行角色扮演，并根据沉思冥想会谈检测清单的指引来进行练习。如果你们愿意，可变换角色，体验被别人指导的过程。

II. 这个学习活动为你提供了尝试冥想的机会。在一个安静的地方进行20分钟的冥想。不要在餐饭后一小时内或睡前两小时内做这个练习。

1. 选取舒适的坐姿，闭上眼睛。
2. 放松全身，想像将所有的紧张排出体外。
3. 冥想 15 到 20 分钟。
 - a. 放松、自然地通过鼻腔呼吸。
 - b. 呼吸时，想像一个数字或一个单词。随着每一次的吸入和呼出，默默地念（想）你的字词。
 - c. 如果另外的思想出现，不要被它们引开，但也不要强制它们离开。只是放松和聚焦到你的字词或呼吸上。

4. 尝试评估你对冥想体验的反应：
你冥想的感觉怎样？
你冥想后感觉怎样？
什么类型的思想或想像进入了你的头脑？
你应付分心的事物感到困难吗？
 5. 如果可能，进行系统的放松反应练习，每天两次，练习一周。
-

肌肉放松的过程与应用

肌肉放松法通过教会人有意识地去感觉主要肌肉群的紧张和放松，从而达到放松的目的。下面试一下这种感觉：将你利势的手握成拳，将拳头攥紧些，再紧些，然后感觉一下手和前臂的紧张状态，让这种感觉进到手指、手掌和前臂，然后再放松你的手，注意紧张和放松之间的感觉差异。再做一次这个练习，这次闭上你的眼睛。紧紧地握住拳头，意识到手和前臂变得紧张起来，然后放松你的手，让紧张感流走。尝试一次吧。

如过你做了这个练习，你就会注意到手和前臂不能在同一时刻既放松又紧张。换句话说，放松与紧张是互不兼容的。你可能也注意到，你指示手紧张起来，然后放松下来；你所发送的信息出自大脑，迫使手紧张起来，然后又引导它放松。你可以暗示一个肌肉群（如手和前臂）以某种特别的方式进行响应（紧张和放松）。当然这个练习可能太简单了，使你没有注意到其他身体功能的变化。例如，紧张和放松可以影响一个人的血压、心率、呼吸频率，也可影响心理内部过程以及外显行为。“肌肉放松的长远目标是使身体能够即时监督大量的控制信号，从而自动地缓解不需要的紧张”。

放松训练法不是新近产生的，但是它近来在处理求助者各种

各样的问题中成为很受欢迎的技术。Jacobson 发展出一种称为“渐进放松法”的程序。稍后，Wolpe 将肌肉放松法称为焦虑抑制程序，并与他的系统脱敏法一同应用（见第十九章）。Bernstein 和 Borkovec 撰写了一本《渐进放松训练手册》。

肌肉放松法可应用于下列情绪和躯体状态中，如愤怒、哮喘、抑郁、头疼、疱疹、高血压、失眠、胃肠激惹综合征、惊恐、小便失调等（见表 17-3）。而且躯体扫描放松法（肌肉放松的一项技术）也是冥想和瑜伽练习中不可分割的一部分。

肌肉放松的疗效和其他方法的疗效一样，都与这样几个因素有关，即：对求助者问题的评估，求助者本身的特点，治疗者使用放松法的能力和信心。治疗者应注意，在没弄请求助者紧张的原因之前，不要应用放松训练法。咨询者要在问题评估期间对这些原因做一大致的了解（见第八章和第九章）。例如，求助者在工作中体验到紧张，咨询者需要首先处理的也许是求助者的外部境遇（如工作）。假如求助者的紧张来自受到压迫和歧视，外部的境遇则是需要加以改变的目标。Bernstein 和 Borkovec 指出，日常生活造成的紧张和濒临经济危机产生的紧张，两者是不同的。在后一种情况下采用综合治疗策略才是必要的。

表 17-3 肌肉放松的有关研究

愤怒	哮喘
癌症	抑郁
头疼	疱疹
高血压	失眠症
肠激惹综合征	惊恐
进行性肌肉放松	小便失调

肌肉放松的步骤

肌肉放松包括七个步骤：

1. 基本原理
2. 穿戴的要求
3. 创造舒适的环境
4. 咨询者示范放松练习
5. 肌肉放松引导
6. 练习后的评估
7. 家庭作业和复诊

在本章结尾的会谈检测清单中对这七个步骤做了详细的描述。

治疗的基本原理

这里是咨询者解释放松练习目的的一个例子：“假如你有规律地进行放松练习的话，你将变得放松起来。而放松的效果之一就是使你晚上的睡眠更好。”可以这样概括介绍这种方法：“在这个程序中你将学习使自己身体的不同肌肉群变得紧张和放松。通过比较紧张和放松两者之间的差异，会帮助你认识紧张，从而使你能引导自己放松。”

另外，咨询者应该解释肌肉放松是一项技术，学习的过程是渐进的，要有规律地进行练习。咨询者还要说明在放松练习期间可能会出现某些不适感。如产生的话，求助者只需移动一下身体，找一个更舒适的位置就可以了。最后，某些学习放松的求助者可能会体验到一种漂浮不定、温热和沉重的感觉。咨询者应该告知求助者这些可能的感觉。基本原理解释结束时，还应了解求助者是否愿意尝试这个练习过程。

穿戴的要求

要求求助者在练习过程中穿上舒适的衣服，宽松而不会转移注意力。求助者应该戴普通眼镜，而不是隐形眼镜，戴着眼镜闭眼睛是不舒服的。

创造舒适的环境

放松练习的环境应该是安静的，没有干扰声音，如电话铃声、街道嘈杂声、飞机声等。可能的话，使用躺椅。如果没有，也可以用铝制亚麻椅或加衬垫的折叠椅。如果有一组人进行放松训练，可以躺在衬垫和毯子上，头枕在枕头上。求助者仰卧在地板上，腿伸直，手臂放在身旁，手掌向下。

咨询者示范放松练习

在求助者的放松练习开始前，咨询者应该至少简要地做一些肌肉练习示范。咨询者首先从手开始（握紧拳头，然后放松手，伸展手指，紧张和放松另一只手；使手臂和腕关节之间弯曲，然后放松它们；耸起肩部，并放松它们）。咨询者应该告诉求助者，示范的速度要比实际练习时的速度快得多，在示范时咨询者要不时地停下来进行解释，“当我弯臂时，我的二头肌就鼓起来，当我放松时就将手臂垂落到身旁。我注意到紧张和放松两者之间的差异”。用这些注释来引导求助者区别紧张和放松。

肌肉放松引导

在进行完上述各个步骤后，求助者就可以开始放松练习了。咨询者读练习指导说明时的声音应该是对话式的，不要夸张。在指导求助者肌肉紧张和放松时，记住不要让求助者尽可能的紧张，不要因此使肌肉损伤。给予引导语时小心用词，不要使用这样的

措辞，如“尽可能的硬”，或“肌肉松懈或无力”，或“使肌肉紧张到像要折断一样”。在指导紧张和放松肌肉时，有时你还可以补充有关呼吸的引导语，它们能帮助求助者进行放松。

求助者放松训练中使用的肌肉群可以被分为17组、7组或4组，它们列于表17-4。通常，在训练开始的初始阶段，咨询者指导求助者对所有17组肌肉群都进行放松练习。当求助者可以支配17组肌肉群中的任意一组时，便可以简化这一程序，让求助者只对7组肌肉群进行紧张放松练习，之后求助者就可以只用4组主要肌肉了。开始时一定要用17组或7组肌肉群中的一个，这可帮助求助者区别不同身体部分的紧张和放松的感觉，肌肉群数目可以逐渐减少。当求助者获得放松的要点时，4组肌肉群比17组肌肉群少了很多的麻烦！

下面将讲解咨询者如何指导求助者应用17组肌肉群进行放松练习。首先，咨询者指导求助者在躺椅上坐好，或者躺在地板上，用枕垫支撑着头部，手臂放在椅子的扶手上或地板上，手掌向下，尽可能使自己舒服些。然后咨询者引导求助者闭上眼睛。如果在某些场合求助者可能不愿意闭眼睛的话，咨询者可以让他们在训练期间睁开眼睛，不过眼睛要盯住房间中的某个物体或天花板。要让求助者认真倾听你的引导语。对每一组肌肉群先引导求助者感觉紧张，持续5到7秒后，再感觉放松。在两组肌肉群进行练习的间隙，容许求助者有10秒钟的放松。在整个过程中要不断地让求助者比较各组肌肉群，如“你的头皮像你的二头肌那样放松吗？”发送指令时，要逐渐降低声音并放慢发送的速度。通常在训练的初期，每一组肌肉群要做两次。

下面是咨询者在肌肉放松训练中的引导语（见表17-4）：

1. 利势手紧握拳头。“首先考虑你的右臂，特别是你的右手。握起右拳，攥得紧一些。感觉右手和右前臂紧张，再感受以下这些紧张。（暂停）现在松开拳头，放松右手并将它

表 17-4 17 组、7 组 和 4 组肌肉群的放松练习

17 组肌肉群	7 组肌肉群	4 组肌肉群
1. 利势手攥拳	1. 攥拳同时, 将前臂弯	1. 左、右手, 前臂, 二
2. 非利势手攥拳	曲 45 度	头肌
3. 一手或两手手腕弯	2. 换另一只手、手臂进	2. 脸部、颈部肌肉
曲	行练习	3. 胸、肩、背部、腹部
4. 绷紧二头肌	3. 皱前额, 皱眉, 紧闭	肌肉
5. 耸肩	眼睛、嘴唇, 紧压舌	4. 左、右大腿, 小腿, 左
6. 皱前额	头, 嘴角往后拉	右脚
7. 紧闭眼睛	4. 将下巴压向胸前	
8. 压紧舌头	5. 胸、肩、上背部、腹	
9. 紧闭嘴唇	部肌肉	
10. 头向后紧靠椅背	6. 大腿, 小腿, 脚	
11. 用下巴够胸	7. 另一只大腿、小腿、	
12. 向后弯曲腰背	脚	
13. 吸气, 缩紧胸肌		
14. 绷紧腹部肌肉		
15. 收紧臀部肌肉		
16. 伸展双腿		
17. 脚趾朝上指		

放在椅子扶手（或地板）上休息。（暂停）注意紧张和放松两者之间的差异。”（暂停 10 秒）

2. 非利势手紧握拳头。“现在左手做同样的动作。握住左拳，注意到紧张（暂停 5 秒），接着放松，感受紧张和放松之间的差异。”（暂停 10 秒）

3. 一只或两只手腕。咨询者引导求助者同时弯曲两只手腕，

或分别弯曲。如果分开进行，可以从劣势手臂开始。“现在让手腕向后弯曲，你的手背和前臂的肌肉紧张起来。胳膊不动，让手指指向天花板。感受手腕的紧张。现在放松。（暂停）感觉紧张和放松之间的差异。”（暂停10秒）

4. 二头肌。咨询者引导求助者练习两个二头肌或一次一个。假如分开进行，则从劣势胳膊的二头肌开始。引导语为“现在双手握拳，前臂向肩部弯曲，这时你的二头肌变紧。感觉这些肌肉的紧张。（暂停）现在放松，让你的手臂落下，回到身旁。注意紧张和放松之间的差异。”（暂停10秒）
5. 肩部。通常要求求助者耸起双肩，也可能每次只耸一个肩膀。“现在我们向上移动到肩部。耸起你的肩部，向耳部靠拢。感觉和保持肩部的紧张。（暂停）现在让肩部放松。注意比较紧张和放松的感觉。”（暂停10秒）
6. 前额。这个练习和下面的三个练习都是面部肌肉练习。“现在我们来练习如何放松面部肌肉。首先，皱起你的前额和眉头，感觉到眉头上有了皱纹。（暂停）现在放松，前额皱纹松弛下来。”（暂停10秒）
7. 眼睛。这个练习的目的是让求助者能够控制和调节眼部肌肉的运动。“现在紧闭双眼，你能感觉到眼睛周围的紧张吗？（暂停5秒）现在放松那些肌肉。注意紧张和放松之间的差异。”（暂停10秒）
8. 舌头和咀嚼肌。“现在通过咬紧牙关，使你的咀嚼肌紧张起来，并将嘴角向后移动。感觉咀嚼肌的紧张，（暂停5秒）现在放松。你能区别出咀嚼肌紧张和放松的差异吗？”（暂停10秒）。这种练习对于某些带假牙的求助者来说可能是困难的，可选择如下练习：“用你的舌头紧紧顶住口腔的上腭，注意你口腔内部的紧张。（暂停5秒）现在放松口腔和舌头。”（暂停10秒）

9. 紧闭嘴唇。最后一项面部练习包括嘴与下巴的肌肉。“现在紧闭双唇。感觉嘴部周围的紧张，（暂停）现在放松那些肌肉，感受嘴和整个脸部肌肉的放松。（暂停）你的脸像你的二头肌一样放松吗？（在肌肉群之间进行比较）
10. 头。“现在我们移向颈部肌肉。将头紧靠在椅背上。你能感觉到颈部和后背的紧张吗？（暂停）现在让头部休息。注意两者的差异，保持放松。”（暂停）
11. 下颌向胸靠。这个练习仍然是颈部肌肉，主要是颈前部肌肉。“现在继续注意颈部。头向前伸，看看能否将下巴接触到前胸。感觉颈前部肌肉的紧张。现在放松。”（暂停10秒）
12. 背部。做这个练习要小心，不要让求助者感到背部酸痛。“现在注意你的后背。将背向后弯曲，挺出胸和腹部。你能感觉到背部紧张吗？感觉这种紧张。（暂停）现在放松，注意紧张和放松之间的差异。”（暂停10秒）
13. 胸部肌肉。“现在深吸气，充满你的胸腔，憋一会儿。感觉整个胸部和腹部的紧张。（暂停）现在放松，自然地呼出气体。感受放松的感觉。”（暂停10秒）
14. 腹部肌肉。“现在将注意力放在腹部，绷紧腹部肌肉。现在放松腹部肌肉。（暂停10秒）你的腹部是否像后背和胸部那样放松？”（肌肉群之间的比较）
15. 臀部。肌肉群向下移动到臀部。这组肌肉群可不进行，直接做腿部练习。“现在收紧臀部肌肉，向地板（或椅子）上压。感觉它的紧张。现在放松。”（暂停10秒）
16. 腿部。“注意力集中到腿部。伸直双腿。感觉大腿的紧张。（暂停5秒）现在放松。感受大腿的紧张和放松之间的差异。”（暂停10秒）
17. 脚部。“现在注意小腿和脚。将脚尖尽量朝上指，使你的小腿肌肉绷紧，好像有一根线正向上牵拉着你的脚尖。你

能感觉这种牵拉和紧张吗？（暂停）现在放松，让你的腿放松。感觉紧张和放松的差异。”（暂停 10 秒）

每一组肌肉群完成紧张和放松两次以后，咨询者通常要以简要的概括和总结结束放松练习。总结可以这样做，咨询者每提及一组肌肉群，便让求助者放松由于该肌肉群被提及而引起的紧张。例如：

现在，我准备再回顾一次所有肌肉群。当我提及一组肌肉时，你要注意那里是否有任何的紧张。如果存在紧张，那么就集中注意力到那组肌肉上，让它们放松下来。想像将所有的紧张完全排出体外。现在放松脚部、踝部、小腿的肌肉。（暂停）放松大腿的紧张。（暂停 5 秒）放松臀部。（暂停）让躯体下部的肌肉放松。（暂停）放松腹部、腰部和下背部。（暂停）排出上背部、胸部和肩部的紧张。（暂停）放松你的上臂、前臂和手。放松喉部和颈部。（暂停）放松脸部。（暂停）让所有的紧张排出体外。（暂停）现在闭着眼睛，平静地坐着。

治疗者可以通过评估求助者的放松水平（0 到 5 级），或向求助者大声数数来结束练习过程。例如：

现在我希望你想像一个刻有从 0 到 5 数字的尺子，0 代表完全放松，5 是极度紧张。告诉我你现在放松的程度相当于尺子上哪一级刻度。

我将进行数数，从 5 数到 1。当我数到 1 时，请睁开眼睛。5……4……3……2……1，现在睁开眼睛。

练习后的评估

放松训练的疗程完成后，咨询者要询问求助者的体验。可以问“你对这个程序的反应是什么？”“你的感觉怎样？”“当你聚焦在紧张上时，你的反应是什么？”“放松时的反应如何？”或“对比紧张和放松之间差异的感觉如何？”咨询者应该奖励和赞扬求

助者取得的成绩，并建立起一个对练习的积极期待。

人们做放松练习时可能会有几个问题。其中包括：抽筋，笑或谈话过多，阵发性痉挛或局部痉挛，干扰性想法，睡着，个别肌肉群无法放松，有奇怪的感觉，呼吸局促。求助者体验到的肌肉抽筋，可能是因为对某组肌肉过于用力所产生的反应。这时咨询者要引导求助者减少紧张感。如果出现阵发性痉挛或局部抽筋，咨询者要说明这是很普通的，在睡眠中常会出现。笑和谈话过多都出现在群体进行放松练习时，最好的办法是不理睬它们，或者与练习者一起讨论这些行为会使练习分心。

最常见的问题是求助者在放松练习期间睡着了。应告知求助者，不断睡觉是会妨碍学习肌肉放松相关技巧的。要观察求助者全部的练习过程，以便能够确定求助者是否醒着。咨询者要告诉求助者在肌肉放松过程中“保持觉醒”。

如果求助者难以放松某组肌肉，咨询者和求助者就要一起寻找适合于这些肌肉群的练习方法。如果干扰性思想使求助者太容易分心，咨询者可以建议求助者把思想集中到某些较少分心或令人愉快的想法上来，如凝视挂在墙上的画或天花板。针对干扰或分心想法的另一个策略是，让求助者利用作业指向语句或思想（见第十六章）以帮助他们将注意力集中在放松练习上。

另外一些不熟悉的感觉，如飘浮、烦躁、性急等，也都会造成问题。咨询者应该指出这些感觉很普通，不应害怕它们。最后一个问题是某些求助者在紧张某些肌肉时不敢呼吸。咨询者要观察求助者在肌肉放松练习中的呼吸。假如求助者的呼吸局促，咨询者要引导他们自由、放松地进行呼吸。

家庭作业和复诊

肌肉放松的最后一个步骤是布置家庭作业。四五次治疗练习再加上在中间进行两次家庭练习大概足够了。有些治疗者只与求

助者签订了最小程度的合同，因为他们发现，求助者自己在家里根据录音带进行放松训练，间或进行电话咨询，其减低紧张性头疼的效果一样好。无论治疗练习的数量和时间如何，治疗者都要告知求助者，掌握放松法就像学习其他方法和技术一样，需要进行大量的练习。

练习越多，求助者就越能控制自己的紧张、焦虑和应激状态。应鼓励求助者每天练习肌肉放松 15 到 20 分钟，一天两次；练习时要在安静的地方，也没有任何时间压力。练习可以在躺椅或地板（以枕头支撑头部）上进行。

应鼓励求助者在每次练习后记录日志。图 17-1 是一个家庭作业日志样本。在每一次练习前后，要用数字评估自己的反应，“1”为很少或没有紧张，“5”为极度紧张。应安排好家庭作业完成后的复诊时间表。

治疗者可使用多种技术促使求助者按要求进行家庭放松练习作业。一种方法是要求求助者在复诊过程中，示范他在家里是怎样练习颈部和小腿肌肉放松的。咨询者可以随意地选择四五组肌肉，要求求助者进行示范。如果示范正确，就表明求助者在家里确实按要求进行了练习。

肌肉放松的禁忌症和副作用

一般来说肌肉放松练习是良性和愉快的，但对于某些人来说它可能有副作用。例如，那些有焦虑、恐惧障碍，或有过度换气症的求助者就会体验到副作用。那些肌肉和肌腱受到损伤，或慢性肌无力的求助者，要他们进行某些肌肉群的紧张和放松活动是困难的。另外，如果求助者正在服用某些药物，如治疗糖尿病的胰岛素，那么在他们进行肌肉放松练习时，有必要对药量进行调整。这些求助者在进行放松练习前，有必要咨询医生，以了解有关药物的作用。如果求助者有焦虑或恐慌障碍，咨询者要首先选

家庭作业日志						
日期	磁带编号	肌肉群编号	练习序列号	练习地方	紧张程度（1-5级）	
					练习前	练习后

图 17-1 肌肉放松练习日志表

用下一章第一部分介绍的呼吸练习。如果求助者的某个肌肉群有问题，练习时则要避开那个肌肉群或做躯体扫描。Herman 注意到，放松练习对于那些有严重创伤史的求助者是不合适的，因为他们常常需要保持某种程度的警觉，以使自己感到安全。

肌肉放松法的变式

肌肉放松法有几种变式，包括回忆法、计数法、区分放松法，以及躯体扫描法。咨询者可以安排、设计这些变式以帮助求助者获得在实际生活中进行放松的技巧。表 17-4 列出了四组肌肉群练习，它们可以与回忆和计数联合使用。

回忆法

可按表 17-4 中的四组肌肉群放松练习进行回忆练习。咨询者首先要告诉求助者回忆放松练习的基本原理：“无须绷紧肌肉就可以帮助你学会肌肉放松技巧。”让求助者将注意力集中于每个肌肉群（四个肌肉群分别为：手臂，脸和颈部，胸部、肩部、背部和腹部，腿和脚）并放松，然后让求助者回忆在以前放松练习中释放肌肉紧张时的感觉。咨询者可以暗示某个肌肉群还有紧张，求助者应该发送信息给这个肌肉群进行放松，并让紧张“流走”。然后要求求助者回忆肌肉放松时的感觉。通常在第一次练习完了四组肌肉群的紧张与放松程序之后，求助者接着就可以使用回忆的方法。逐渐的，求助者便能利用回忆法进行自我引导的放松练习。回忆法也可以与计数法联合应用。

计数法

计数法的基本原理是帮助求助者进行深度放松。基本原理解释如下：咨询者从“1”到“10”进行数数，每数一个数后，求助者就变得更放松一些。咨询者可以慢慢地说：

1—你变得放松了；2—你手臂变得更加放松；3—感觉到你的脸和颈部变得更为放松；4、5—你的胸和肩开始放松；6—进一步地放松；7—背部和腹部深深地放松；8—更深一层地放松；9—你的腿和脚更深地放松；10—继续放松，你会更加放松。

咨询者可以把计数法和回忆法一起用。求助者应将计数法用于对付真实情境中的紧张感。计数法能够促进放松、减轻紧张，应鼓励求助者在疗程以外去应用它。

区分放松法

区分放松法的作用在于，它可以将治疗中学会的放松练习扩大到实际生活中。区分放松法的目的是帮助求助者认识到，在不同的情境下不同的身体姿势和各种活动需要不同的肌肉群，从而能够区分哪些肌肉在起作用，哪些肌肉作用不大。这样放松训练就有了针对性。表 17-5 举例说明了区分放松法某些可能的水平。

下面是一个应用区分放松法的实例。咨询者让求助者坐在普通的椅子（不是躺椅）上，并辨别出坐着的时候会用到哪些肌肉，没有用到哪些肌肉。如果求助者感到哪些没有用到的肌肉紧张（如脸、腿和腹部肌肉），那么就要引导他放松这些坐着时并不需要的肌肉。咨询者指导求助者使用区分放松法。例如，坐在一个安静的地方，肌肉活动水平很低；而站立时，肌肉活动水平很高。几次练习后，可以给求助者布置家庭作业，让他们进行不同水平的活动：如坐在一个安静的餐厅里，坐在一个嘈杂的餐厅里，站

表 17-5 微分放松程序的标准

境遇	身体位置	活动级别
宁静	坐	低——静止
嘈杂	站	高——日常活动

着排队买票,或走在热闹的购物中心里。进行区分放松练习时,求助者要努力辨别出那些作用不大的肌肉是否存在紧张情况。如果存在紧张,求助者要集中注意力去使它放松下来。

躯体扫描法

对于重建与躯体的联系,躯体扫描法是一个强有力的技术,因为它能同时培养出注意的集中性和灵活性。扫描躯体的目的是感受躯体的每个区域或肌肉群。你能做到在躯体的每个区域上进行呼吸,将气吸入这个区域,又从这个区域呼出。如果求助者感到某个区域紧张,咨询者就要引导求助者把紧张从这个区域呼出,随着气体释放掉。我们这里提供两种躯体扫描方案:第一种方案引导肌肉深度放松,但很少注意呼吸。第二种方案则在整个引导过程中始终注意呼吸。对于那些绷紧肌肉就不能呼吸的人来说,躯体扫描法是非常有益的肌肉放松传统方法的变式。

肌肉深度放松的躯体扫描引导语

1. 闭上眼睛,非常缓慢地吸气,气从膈肌开始运转向上直到胸腔的顶部,然后非常缓慢地呼出。三次缓慢呼吸后,恢复正常的呼吸。轻轻地、有节奏地吸进呼出。不要强制呼吸,不要故意使呼吸减慢。保持自己的呼吸节奏,完全意识到自己的呼吸模式。感觉吸入和呼出空气温度的细微差异,吸入的空气是冷的,而呼出的空气是暖的。

2. 现在你有意识地依次放松躯体的每个部分。放松即没有任何运动,因为即使轻微运动也表示某些肌肉在收缩。注意力集中于你正在放松的部位。

3. 现在注意你的右脚,放松脚趾、脚底、脚背、脚跟;在那里停留片刻后,慢慢向上移动你的注意力,放松你的腿,小腿、膝盖、大腿和臀部。感觉你右腿所有的肌肉、关节和组织都完全放松下来。尽可能地放松自己。保持对右腿深度

放松的感觉。

4. 现在将你的注意力转到左脚，并重复上述过程。

5. 然后集中注意力到你的右手。放松手指、手掌和手腕。慢慢向上移动你的注意力到前臂、肘、上臂、肩。感觉到右臂的每个肌肉、关节和组织都深深地放松了。保持对右臂放松的感觉。

6. 将你的注意力转到你的左手，并重复上述过程。

7. 现在将注意力集中到脊柱的底部，一节接着一节。放松每一节脊骨和脊骨旁的每一块肌肉。放松你的背，首先是下背部，然后中背部，最后上背部。释放背部所有的紧张。让放松变得越来越深。

8. 让颈部肌肉放松。让所有前颈部肌肉放松。让头颅逐渐休息，接着感觉到颈后部肌肉的放松。让放松变得尽可能的深。

9. 放松你的胸部肌肉。你每一次呼气后，就更放松一些。让胸部所有的神经、肌肉和器官完全放松。现在放松你腹部的肌肉。让腹部所有的神经、肌肉和器官完全放松。感觉它们正在放松。

10. 现在注意自己的下巴。让它放松下来。你的嘴唇刚好相触，牙齿分开。放松你的舌头，放松颞骨周围的肌肉，放松眼睛和眼睛周围的肌肉。感觉它们变得放松。你的眼睛变得非常静止。现在放松你的前额，让所有前额的肌肉变得完全放松。你的所有面部肌肉再没有紧张。现在放松你的头皮和头顶上的所有肌肉。

11. 你的身体现在完全放松了。让它处于放松状态。

从放松状态出来时，先做一次深呼吸，感觉到能量进到你的手臂和腿部。慢慢移动你的手臂和腿。睁开眼睛，慢慢坐起来，并伸展身躯，感觉到精神振奋和精力恢复。

身体意识放松引导语

让身体开始完全放松……吸入并感觉气息从脚底流向头顶，就像温暖而缓慢运动的水波。让紧张随着每一次呼吸流出体外。将注意力集中到左手手指上。吸气并感到它贯穿手指，接着又上到左臂；呼出气体，放松手臂……让放松随着每一次呼出而加深。现在注意你的右手指，吸入气息上到手臂，呼出气息并完全放松。

现在将你的注意力转到你的左脚脚趾，吸入气息向上移动到腿的根部，呼出气息时充分放松左腿。现在注意右腿，让气息呈波浪式地流向右腿根部；接着呼出，完全放弃右腿的重累。随着每一次吸气，腿的所有感觉变得更清晰；随着每一次呼气，腿部放松就更加深入。当气息贯穿全身时，倾听气息波浪的声音。

现在将呼吸和注意力向上带进你的臀部和骨盆。吸气时感觉骨盆自然地张开，呼气时骨盆沉入大地休息……随着每一次吸入，感觉气息从骨盆的底部向上逐渐进入腹部；随着每一次呼出，骨盆完全放松。感觉气息波浪向上充满整个腹部。感到腹部的起伏。随着每一次呼气，腹部变得相当柔软。感觉到柔和到达下背部，并将气息带到那里。

让气息和注意力上流进脊骨。每一次吸入，脊骨中就充满了感觉；随着每一次呼出，脊骨充分放松。感到气息贯穿整个背部。吸气，进行感觉；呼气，完全放松。

现在将你的注意力放在腹部的起伏上。让气息向上进入心脏和肺，并随着每一次呼气，放松感越来越深入心脏的中心。

移动气息进入颈部和喉咙。呼气，让所有的紧张释放掉……让气息向上流入头部。吸气便更多地意识到感觉；呼气，放松。放松下巴、眼睛、前额、头的后部，使内耳变得柔软。

感觉整个身体现在被来自脚底和指尖的温暖气息笼罩，并一路向上到达头顶。随着呼吸变得越来越柔软，感觉到宁静和完全放松。感到躯体变得更柔软、更加放松。

现在让气息更强一些，贯穿脚底，并在腹部起伏。气息变得强大时，让躯体的感觉也增强。让身体和气息一起开始轻轻地运动。移动脚趾和手指……让整个躯体开始轻轻地伸长。保持眼睛闭拢，躯体开始轻轻地转到右侧。让每个动作都被清晰地意识到。躯体又回到坐姿。当你就座时，感受到深层的三部分气息，并体验到人体、气息和精神取得了平衡。

肌肉放松训练的对话范例

在这段对话里，咨询者向Joan示范了放松练习，帮助她应付身体上的紧张感。

首先，咨询者给Joan讲解了放松的基本原理，肌肉放松的目的，并为Joan简单概述了有关程序。

1. 咨询者：我们所有人都或多或少地带着某些躯体紧张感，某些肌肉可能好些。在紧张刺激的情况下，某些躯体肌肉甚至会更紧张，尽管你可能并没有意识到。如果你能学会认识肌肉紧张并学会放松肌肉，那么放松状态便能帮助减少紧张、焦虑。我们有意地紧张和放松不同的肌肉群，以帮助你认识什么时候你的身体是紧张的，什么时候你的身体是放松的。最后我们将达到这样的目的，即你能感受到紧张的感觉，并将它们当做信号使自己进行放松。理解了吗？

求助者：理解了。你将告诉我怎么做吗？

其次，咨询者通过注意房间细节和求助者的舒适感，来“建立”轻松气氛。

2. 咨询者：是的。首先我将做给你看，使你能知道如何去做。

在做之前,要让你尽可能感觉到舒适。为了不被灯光分心,我将把灯关掉。如果你戴着隐形眼镜并感到不舒服的话,就把它拿下来,因为放松过程中你要闭着眼睛。我会给你坐一个特制的椅子,因为直背椅在坐一会儿后,就会让人觉得很硬。这也会造成分心。我这里还有一个软坐垫,你可以使用。(拿出特制椅子)

求助者: 嗯。确实舒适。

接下来,咨询者开始为 Joan 示范肌肉放松法。这可以使 Joan 知道怎么做,并减少她的困惑。

3. 咨询者: 现在我将示范如何使肌肉紧张和放松。我先从右臂开始。(紧握右拳。停一会并注意紧张。松开拳头,停一会并注意放松。再示范其他几个肌肉群。)示范对你有启发吗?

求助者: 明白。你不做全身的吗?

咨询者进一步解释关于肌肉放松的知识,并描述 Joan 可能产生的感觉。检查 Joan 是否完全了解了放松练习的过程。

4. 咨询者: 你来做。但每次只做一个肌肉群。当你进行每个肌肉群的紧张和放松时,你全身也会感到放松。现在,你也许不能立刻注意到许多差异——但是你能够做到,到时你甚至可能感觉到你正在漂浮。最重要的事情是让自己尽可能地保持舒适。在我们开始前你还有其他问题吗?

求助者: 我想没有。我想这个过程或许有点像瑜伽。

咨询者继续讲解对 17 组肌肉群进行交替紧张和放松的练习。

5. 咨询者: 是的,它们都是基于相同的思想——使人远离躯体紧张。好,请非常舒适地坐在你的椅子上,我们现在开始。(给 Joan 几分钟,使她坐得更舒适些。然后进行放松引导语。见前面的介绍。)

放松以后,咨询者询问 Joan 在放松期间和之后的感觉。发现

放松过程如何影响求助者是重要的。

6. 咨询者: Joan, 你现在感觉如何?

求助者: 非常放松。

7. 咨询者: 那么比较肌肉紧张和放松状态时的感觉怎样?

求助者: 很容易讲。我猜想某些时候我的身体非常紧张, 但我不去考虑它。

咨询者给 Joan 布置每天的家庭作业。

8. 咨询者: 我前面提到过, 为了使你在需要时能够使用这个方法, 你要进行有规律的练习, 并真正取得实效。录音磁带录有我的引导语, 我希望你按照磁带进行练习, 每天两次。做练习时要找一个安静的地方, 没有其他事情干扰的时间。练习时, 还要坐得舒适些。你还有任何问题吗?

求助者: 没有, 明白了。

咨询者解释如何记日志。

9. 咨询者: 我还希望你使用日志记录练习情况。记下你在什么地方练习, 练习了多长时间, 针对哪些肌肉群, 每次练习前后的紧张等级。记住, “0” 代表完全放松, “5” 代表完全或极度紧张。现在还有任何问题吗?

求助者: 没有。我明白我需要进行练习。

最后, 咨询者安排下一次复诊时间。

10. 咨询者: 是的, 它与学习任何其他技术一样, 不会自动就掌握的。你自己在家里练习两周的时间, 然后再回来见我, 如何?

学习活动 48 / 肌肉放松

肌肉放松练习包括多组肌肉群的交替紧张和放松, 有时与求助者一起练习是困难的。学习肌肉放松最轻松的途径是自己去做

练习。它不仅帮助你学习有关内容，而且也能间接帮助你自己放松。

在这个学习活动中，你将运用肌肉放松程序。你可以自己练习，也可与同伴一起来做。也可以先独自做，然后再与他人一起练习。

自己独自练习

1. 找到一个舒适的姿势，穿宽松的衣服，摘下眼镜或隐形眼镜。
2. 使用书面指导说明或听指导说明磁带来进行练习。先较快地练习一遍，以获得感觉。再慢慢地做，而且不依靠书面指导语。当你练习放松时，体验紧张和放松两者之间的差异。
3. 努力评估你放松以后的反应，使用从0到5（0是完全放松，5是极度紧张）的等级分数，你感觉到的放松程度有多少？是否有任何特殊的肌肉群因收缩而无法交替感受紧张和放松？
4. 一两次肌肉放松练习还收不到任何效果。要在以后几周时间里每天做一两次练习。

和同伴一起练习

一个人是帮助者，另一个是学习放松的人；然后转换角色。

1. 帮助者应该首先介绍和解释肌肉放松的基本原理，以及其他的引导语。
 2. 帮助者可以在肌肉放松中对朗读指导说明，帮助者应给予充足的时间练习每一组肌肉群，并应鼓励学习者注意紧张和放松时的不同感觉。
 3. 完成整个过程后，帮助者应该向学习者询问放松的程度，以及对整个过程的反应。
-

本章总结

在这一章中我们描述了三种冥想策略、一种肌肉放松法和两种躯体扫描法。任何一种冥想策略都可以实际应用。咨询者必须意识到冥想和肌肉放松法对于某些求助者有禁忌症和副作用。肌肉放松策略可以使用17组、7组或4组肌肉群进行练习。所有这些策略都可以单独使用，用以治疗应激反应。另外，肌肉放松法还可以同系统脱敏法、眼动脱敏和再加工法一起使用（见第十九章）。

学习评判

第一部分

本章目标一要求你能够准确辨认出放松反应过程的步骤，在下面的9个咨询者引导语中应至少在7个例子中做出正确的辨认。冥想的八个主要部分是（答案见学习评判反馈）：

1. 基本原理
2. 说明在什么时候、什么地方进行练习，练习多长时间
3. 说明放松时要集中注意力在一个字词、一个短语或一段祈祷语上
4. 呼吸引导
5. 说明练习时的被动态度
6. 冥想10到20分钟
7. 探询冥想体验
8. 家庭作业和练习

引导语

1. “重要的是在家里进行有规律的练习。如果没有规律，每天练习两次通常也是没有作用的。”
2. “在家里找一个舒适的地方进行练习，一个不被打扰、没

有噪音的地方。”

3. “这个程序被应用于高血压患者和有睡眠障碍的人，也可用于当做一般减低压力的过程。”
4. “通过鼻腔呼吸，把注意力放在呼吸上。如能聚焦在字词上，它是非常容易的。”
5. “一定要在安静的时候进行练习。不要在饭后一小时内或睡觉前两小时内做练习。”
6. “持续冥想 10 到 20 分钟。完成后还要安静地坐几分钟。”
7. “你认为做起来容易还是困难？”
8. “有时其他的想像和思想进入了你的头脑，要维持一种被动态度。假如你为其他思想烦恼，不要为它分心，但也不要强制它们离开。只要聚焦到自己的呼吸和词句上。”
9. “选择一个像‘一’这样中性的字，用于集中注意力。”

第二部分

目标二要求你能准确地辨认出沉思冥想的步骤，在下面的 8 个咨询者引导语中，要至少能在 6 个例子中进行准确地辨认。沉思冥想的八个主要步骤如下（答案见学习评判反馈）：

1. 基本原理
2. 说明练习的态度
3. 冥想的准备
4. 关于投入、自律、能量的引导说明
5. 呼吸引导
6. 躯体扫描说明
7. 讨论求助者对第一次冥想的反应
8. 家庭作业和练习

引导语

1. “冥想能够减轻紧张、焦虑、应激反应和头痛等，因而对人们有益。”

2. “冥想进行八周，每天在相同的时间进行一两次。”
3. “允许分心的思想往来，允许出现记忆、想像和思想，不要试图影响它们。”
4. “要以舒服的姿势进行冥想。”
5. “注意从鼻孔吸进和呼出的空气。”
6. “慢慢地退出冥想，闭着眼坐两分钟，慢慢睁开你的眼睛。你感觉如何？”
7. “允许你的呼吸进入你的身体，从头到脚，再进入头顶。”
8. “首先它就像你正在进行训练。”

第三部分

目标三要求你对另一个人讲授冥想的过程，讲授放松反应或者沉思冥想。可以让观察者评估你，或用录音带录下自己的教学过程，并评估自己的表现。

第四部分

目标四要求你描述如何应用肌肉放松程序的七个主要部分。用下列求助者个案和随后的七个问题，阐述你是如何将程序的某一部分应用于这个求助者的。学习评判反馈可用来检查你的回答。

求助者个案描述：这个求助者是个中年男人，他很担心自己的睡眠。他服用过安眠药，但又不愿意依赖药物。

1. 解释使用放松法和冥想法的基本原理，包括目的和概况。
2. 知道进行练习时的适当着装。
3. 列出任何可能影响肌肉放松法的环境因素。
4. 描述你将如何为求助者示范放松练习。
5. 描述你将指导求助者交替进行紧张和放松练习的某些重要的肌肉群。
6. 提供两个探询的实例，用来询问求助者放松后的反应。
7. 你将给求助者布置什么样的家庭作业任务？

第五部分

目标五要求你用角色扮演为求助者示范15个肌肉放松步骤中的13个步骤。请观察者或求助者来评估你的表现。

第六部分

目标六要求你用角色扮演为求助者示范躯体扫描程序。请观察者来评估你的表现，或利用录音带对自己的表现进行评估。

沉思冥想会谈检测清单

指导语：请判断咨询者在会谈中是否使用了下列引导语或问题。在相应的引导语旁边的横线上画上記号。

清单中右侧列出了若干引导语示例。

引导语项目	引导语示例
I. 基本原理	
_____ 1. 咨询者描述沉思冥想的过程。	“我现在教你练习沉思冥想。这种冥想长期以来用于缓解由焦虑引起的疲劳，减低可以增高血压的应激水平，使生活恢复平和。冥想能帮助你更加放松，并有效地应对紧张和应激。它会使你对自己有一种新的意识，获得看待世界和生活的新途径。”
_____ 2. 为求助者介绍过程概况。	“首先我们选择一处安静的地方进行冥想。你要找到一个放松、舒适的姿势，闭上眼睛，集中注意自己的呼吸，并让思想自由地流动。如果思想分神了，可以通过注意呼吸，将它拉回来。冥想练习约10至20分钟。然后，我们一起谈一下冥想的体会。”
_____ 3. 确定求助者使用这一咨询	“你觉得现在进行冥想联系怎么

过程的意愿。

II. 关于沉思冥想基本态度的指导语

——4. 讲述进行沉思冥想的态度。

——5. 告诉求助者要不做任何判断。

——6. 告诉求助者要耐心。

——7. 告诉初学者要敞开心灵，关注每时每刻的体验。

——8. 告诉求助者要相信自己的感觉和直觉。

——9. 告诉求助者不要强求自己。

样？”

“有7种态度，可以帮助你进行冥想练习。”

“第一，最好不进行任何判断。我们倾向于将人物、事物和经验进行分类，并作出判断。但这些判断会使你在冥想时无法观察到心灵的流动。判断会妨碍每时每刻的意识体验。为了避免作判断，要集中注意于呼吸。”

“第二，要有耐心，要让事物按照自己的时间表展开。没有必要将我们生活的分分秒秒都添满忙忙碌碌的活动。”

“第三，初学者常常让过去的经验影响现在的体验。要只对每时每刻的体验敞开心灵，不要让过去的经验进行判断，使你分神。”

“第四，冥想时，要相信自己的感觉和直觉。例如，如果身体告诉你冥想的姿势不舒适时，你就要改变当前的姿势。”

“第五，不要强求自己，沉思冥想是一种练习过程，每个人的练习都会有所不同。不要让自己去获得什么事情，或者达到什么目的。只要关注每时每刻的心灵过程就可以了。”

—— 10. 要具有接纳的态度。

“第六，去观察和接受事情每时每刻或现在的真实面目。”

—— 11. 要放任思想流动。

“第七，放任思想流动，不要附加条件，或者停止在某种思想上。”

III. 关于投入、自律和集中能量的指导语

—— 12. 告诉求助者进行沉思冥想时，要投入、自律和集中能量。

“对于练习，你要很投入；要有足够的自律来产生能量，以使自己能进行冥想，并进入高层次的沉思之中。你不必去喜欢它，只要练习就可以了。8个星期之后，我们就可以检查练习是否有效果了。”

IV. 准备进行冥想的指导语

—— 13. 告诉求助者进行练习的时间、地点和姿势。

“选择特定的时间进行冥想。每周至少练习6天，共练习8个星期。练习的地方要舒适，没有干扰。冥想练习时，直坐在椅子上，或躺在地板上，以后背支持自己的身体。”

V. 身体扫描指导语

—— 14. 指导求助者进行身体扫描。

“让身体完全放松下来。吸气时，感觉气体由脚趾贯通到头顶，像平缓流动的水泼。呼气时，让所有的紧张流出体外。”

VI. 呼吸指导语

—— 15. 指导求助者如何进行呼吸。

“观察自己的呼吸，注意到呼进、呼出时的温度差异，并感受气体在鼻腔中流进、流出的感觉。”

VII. 关于心灵漫游的指导语

—— 16. 告诉求助者如何应对漫游的思想、情感、感觉、疼痛和不适感。

“如果练习中发现自己被某个思想、情感、感觉、声音、疼痛、或不适感干扰,这是很正常的;只要将注意力放到呼吸上就可以了,并随着呼气,让分神的东西自然流出。”

VIII. 沉思冥想指导语

—— 17. 告诉求助者要放松、安静地坐好。可以很快地进行一次身体扫描,以便更好地放松。

“静静地坐一会,放松,注意呼吸。”

—— 18. 要闭上双眼,保持舒适的姿势,并集中注意于呼吸上。

“闭上眼睛,找到一个舒适的姿势,集中注意自己的呼吸。”

—— 19. 要集中于现在时刻,意识和观察心灵的流动,不要被其它事情分神。

“意识、体验每时每刻心灵所发生的。如果某些思想、感觉、疼痛等分流能量,就要把它们呼出去,继续进行体验;而不要被分神的东西支配。”

—— 20. 告诉求助者要进行大约10到20分钟的沉思冥想。

“冥想10至20分钟。我来记时,时间到了,我会告诉你。”

—— 21. 告诉求助者要缓慢地从沉思冥想中恢复出来。

“从冥想状态出来时,要缓缓而出。闭着眼睛坐一会,让时间削去你刚才的体验。慢慢地伸展四肢,睁开眼睛。”

IX. 讨论求助者对沉思冥想的反应

—— 22. 询问求助者沉思冥想时的体验。

“刚才的冥想体验是怎样的?”

“你是如何处理分身的事情的?”

“你对沉思冥想的感受如何?”

X. 布置家庭作业

- _____ 23. 指导求助者每天练习沉思冥想一次。提醒他们做练习前要进行各种准备。

“每天练习冥想一次，每周至少5次。记住，要选择一个没有干扰的安静环境。练习前24小时内，不要喝任何酒精饮料，或者吃非处方药。吃完固体食物或饮用含咖啡因饮料后，要等待1个小时后，才能进行冥想练习。冥想时要关注每时每刻，体验心灵，不要分神。”
- _____ 24. 告诉求助者进行非正式的冥想。

“当你在日常生活中遇到应激情境时，可随时进行非正式的冥想。放松，并集中注意呼吸，要体验内心宁静，不要分神。”

观察者评语: _____

进行放松反应会谈检测清单

指导语：请判断咨询者在会谈中是否使用了下列引导语或问题。在相应的引导语旁边的横线上画上线号。

清单中右侧列出了若干引导语示例。

引导语项目	引导语示例
I. 基本原理	
_____ 1. 咨询者描述沉思冥想的过程。	“放松反应法用于缓解焦虑，降低导致高血压的应激，使人更加松弛。会使人获得一种对自身和外部世界的

_____2. 为求助者介绍过程概况。

全新体察。”

“要先选择一个中心词，然后找到一个舒适的姿势，放松身体，注意自己的呼吸。冥想时要保持一种被动的态度，这种态度会引致放松反应。进行10到20分钟的冥想练习后，我们再来谈论冥想的体验。”

_____3. 确定求助者使用这一咨询过程的意愿。

“你认为可以进行这种放松反应冥想练习吗？”

II. 关于何时、何地以及练习时间长度的指导语

_____4. 要告诉求助者进行放松练习的时间、地点和时间长度。

“做练习的最好时间之一是早饭前，因为这段时间做练习可为整个一天奠定良好的基础；也没有被一天中的生活事件和活动所扰乱。按规定时间做练习，会使放松效果更好，因为这样会养成习惯。练习地点要安静，不被分神事情干扰。每次练习10至20分钟，最好一天练习两次。”

III. 关于中心词、短语和祈祷语的指导语

_____5. 告诉求助者使用中心词、短语或祈祷语基本原理。

“集中思想和精力的主要途径，是将注意集中于自己的呼吸，或者集中于一个词、一个短语、或者祈祷语上。”

_____6. 举出中心词、短语或祈祷语的例子。

“可选择一个中性词或短语，如‘一’、‘和平’、‘仁爱’等；或者‘空气在流进流出’。也可选择与自己信

仰相适合的祈祷语，如基督徒可选择‘主是我的牧羊人’，而穆斯林则可选择‘真主，安拉！’”

VI. 身体姿势和眼睛的指导语

—— 7. 告诉求助者身体姿势和眼睛。

“有几种冥想方式。我来演示一种。先找到一种舒适的坐姿。”

V. 身体扫描

—— 8. 咨询者与求助者一起进行快速身体扫描。

“放松身体所有的肌肉。[缓缓地说]依次放松头、脸、颈、肩、胸、腹、臀、腿和脚。放松全身”。（参见身体扫描部分）

VI. 呼吸指导语

—— 9. 告诉求助者如何进行呼吸。

“通过鼻子呼吸，并意识到自己的呼吸。让空气进入到你的身体，自然而放松地呼吸。随着每次吸气和呼气，在心里重复所选择的词汇。”

VII. 关于被动态度的指导语

—— 10. 指导求助者要保持被动态度。

“态度要宁静而被动。如果出现分神的思想 and 想像，只采用被动态度，不要细想它们。重复默想所选择的词汇、短语或祈祷语。自然地进行呼吸。多次练习后，你就会不分神地考察这些思想和想像，不要将它们驱除出去，而是让它们自然消退。开放自己的心灵，不要尝试去解决问题或思考问题，让它们平缓地流进心灵，然后逐个消退。默念中心词，放松身体。不要为分神思想烦心，回到中心词、短语或祈祷语上来。”

VIII. 指导求助者进行冥想 10 到 20 分钟

- 11. 指导求助者进行 10 到 20 分钟的冥想。 “现在进行 10 至 20 分钟的冥想。你可以睁开眼睛看时间。做完练习后，静坐几分钟，闭着眼睛，不要活动。”

IX. 讨论求助者对放松反应的体验

- 12. 询问求助者冥想时的体验。 “你的冥想体验怎么样？”
“冥想时什么思想和想像流过你的心灵？”
“你怎样处理分神的思想？”
“你对中心词、短语和祈祷语的感受如何？”

X. 布置家庭作业

- 13. 指导求助者每天进行冥想练习。 “一天练习两次放松反应。练习时要找到舒适的姿势；练习地点要安静，避免干扰。吃饭后两小时之内和睡觉前几小时内不要进行练习。”
- 14. 告诉求助者要将放松反应应用于现实生活场景中。 “在日常生活情境中遇到问题时，进行冥想放松练习也是很有帮助作用的。应激时要保持宁静和被动态度，观察自己的呼吸，并进行放松。”

观察者评语： _____

肌肉放松会谈检测清单

指导语：请判断咨询者在会谈中是否使用了下列引导语或问题。在相应的引导语旁边的横线上画上記号。

清单中右侧列出了若干引导语示例。

引导语项目	引导语示例
I. 基本原理	
_____ 1. 咨询者描述沉思冥想的过程。	“肌肉放松能有效地帮助那些患有失眠症、高血压、焦虑和应激紧张的人。它能降低身体的紧张度，使你能控制并驱除干扰日常生活的紧张。”
_____ 2. 为求助者介绍过程概况。	“我会让你绷紧和松弛各部分的肌肉。所有的人都存在身体肌肉紧张的情况，否则我们就不能站、坐和运动，但有时会紧张过度。通过绷紧和松弛练习，你就能意识并比较紧张和放松时的感觉。然后我会训练你对某个肌肉发出放松的指令，这样当你感觉紧张时，就会控制紧张，并放松下来。”
_____ 3. 告诉求助者肌肉放松是一个技巧练习过程。	“肌肉放松是一项技巧练习。如同其它技巧一样，要掌握好它，就要做大量、反复的练习。”
_____ 4. 告诉求助者只要觉得不舒服，就要活动一下身体；并告诉求助者放松练习中可能会有平时不曾有过的	“练习过程中，你躺着或坐着觉得不舒服时，可以活动一下。只要舒服，活动一下是允许的。进行练习过程中，你可能会强烈的感觉，但它们

感觉。

的产生是正常的。你对我的介绍有什么问题吗？如果没有，你愿意进行这项放松练习吗？”

II. 求助者衣着的指导语

_____ 5. 告诉求助者进行放松练习时的衣着。

“练习时要穿着舒适的衣服。”

“不要带隐形眼镜。”

III. 关于舒适环境的指导语

_____ 6. 练习环境要安静，有椅垫的座椅，或者地板上放有枕头。

“练习时，请坐在这张躺椅上，很舒服。”

IV. 示范练习

_____ 7. 咨询者先要示范放松某些肌肉群。

“我将示范某些练习部分。首先，握紧右拳头，使右手和右前臂紧张起来，然后放开拳头。”

V. 肌肉放松练习的指导语

_____ 8. 咨询者以谈话的语调讲述练习指导语，并与求助者一起练习。

_____ 9. 告诉求助者保持舒服的姿势，闭上眼睛，聆听指导语。

“现在，尽量坐得舒服些，闭上眼睛，听我讲的话。我会让你意识到身体中的某种特殊感觉，然后减低这些感觉，并增加放松感觉。”

_____ 10. 指导求助者依次紧张、放松17组肌肉群（最初练习时，每组肌肉要做两次）。并偶尔比较不同肌肉群。进行比较：

_____ a. 利手握拳

“首先握紧右拳，感觉右手和右前臂

的紧张。[停一会] 现在放开拳头，将右臂放在扶手上放松。[停一会] 感觉紧张和放松之间的差别。”[停约10秒钟]。

_____ b. 非利手握拳

“左手做同样的事情。体察紧张和放松间的不同感觉。”

_____ c. 一个或两个手腕

“现在向后弯曲手腕，并将手指指向天花板，感觉手背和前臂上的紧张。现在放松双臂。[停一会] 体验紧张和放松间的不同。”[10秒停顿]。

_____ d. 一个或两个手臂二头肌

“握紧双拳，向肩部弯曲手臂，并绷紧二头肌。[停一会] 现在放松。[停一会] 体验紧张和放松间的不同感受。”[10秒停顿]。

_____ e. 肩膀

“现在向耳部耸起双肩，感觉双肩的紧张。放松双肩，并对比紧张和放松间的感觉。[10秒停顿] 你感觉肩像手臂一样放松吗？”

_____ f. 前额

“现在练习脸部的各种肌肉。先皱起眉头，[停一会] 再舒展眉头。”[10秒钟停顿]。

_____ g. 眼睛

“紧紧地闭上双眼，你能感到眼周围的紧张吗？[5秒停顿] 现在放松眼部肌肉，并体验紧张和放松间的不同。”

_____ h. 舌头、咬肌

“紧咬牙关，并将嘴角向后拉。[5秒停顿] 松弛咬肌。你能区分出咬肌紧张和放松的不同吗？”

_____ i. 嘴唇

“紧闭双唇，感觉嘴唇周围的紧张感。[停一会] 放松唇部肌肉，并体验紧张和放松间的不同。”

_____ j. 头后仰

“现在练习颈部肌肉。将头紧靠椅背，你能感觉颈部和上背部的紧张吗？然后让头部放松下来。注意它们间的不同。”[停一会]

_____ k. 下巴贴胸

“将下巴贴近胸部，感觉到颈前部肌肉的紧张。现在放松下来。”[停一会]

_____ l. 后背

“现在注意后背肌肉。拱起后背，挺起胸部和腹部。你能感觉后背的紧张吗？[停一会]现在放松下来。体验紧张和放松间的不同。”

_____ m. 胸肌

“深吸气，坚持一会。感觉胸部和腹部的紧张。[停一会] 自然呼气，并放松。你的胸部同背部一样放松了吗？”[10秒停顿]

_____ n. 腹肌

“绷紧腹部肌肉，并保持一会。放松腹部肌肉。”

_____ o. 臀部肌肉

“提起臀部肌肉，然后放松。”[停顿10秒钟]

_____ p. 腿

“伸直双腿，感觉大腿肌肉的紧张。[5秒钟停顿] 然后放松。体验紧张和放松间的不同感觉。”

_____ q. 脚趾

“现在将注意力放在小腿和脚部肌肉。将脚趾指向头部，使腿部肌肉紧张起来，就像有一根线将脚趾提起

—— 11. 告诉求助者放松所有肌肉群。

来一样。[5 秒钟停顿] 现在放松腿部肌肉。体察腿部肌肉紧张和放松间的区分。”[10 秒钟停顿]

“现在再重新练习一遍全部肌肉。当我提到某个肌肉群时，你要注意那里是否存在紧张感；如果有的话，就集中注意那组肌肉，并使它们放松下来。想像紧张从身体中排除出去。放松脚部、脚踝和小腿的肌肉。[停一会] 放松腿部、臀部肌肉。[停一会] 放松腹部、胸部和背部的肌肉。[停一会] 将紧张从胸部、肩部排除出去。[停一会] 放松上臂、前臂和手部肌肉。[停一会] 放松颈部和喉咙的肌肉。[停一会] 放松面部肌肉。[停一会] 让全身肌肉放松下来。[停一会] 现在闭上眼睛，静静地坐一会。”

—— 12. 练习后询问求助者放松水平。

“现在你想像一个 5 点量表，‘0’代表完全放松，‘5’代表极度紧张。告诉我你现在处于这个量表的哪个位置？”

VI. 训练后的评估

—— 13. 询问求助者第一轮放松练习的感受；如果求助者练习过程中有问题，就要与他一起讨论。

“你的感觉如何？”

“你对整个过程的反应怎样？”

“考虑一下我们刚刚做的，其中哪些肌肉群有问题？”

“紧张时，你的反应怎样？放松时，你的反应如何？”

“对比肌肉紧张和放松状态时，你的感觉是怎样的？”

VII. 家庭作业和复诊

—— 14. 布置家庭作业，并要求求助者完成放松练习的家庭日志。

“放松训练，就象其它任何技能一样，需要进行大量练习。每天练习15到20分钟。在安静的地方，坐在躺椅上，或着躺在安置枕头的地板上进行练习。练习时不要有任何压力，不要在放学、下班或吃饭前进行练习。避免任何干扰，如电话等。完成家庭日志，每做完一次练习，就要做记录。还有什么问题吗？”

—— 15. 安排复诊日期

“你能在接下来的两个星期，继续做放松练习；然后，两个星期后再来进行咨询？”

会谈中遇到的问题

参考文献

- Alexander, C. N., Robinson, P., Orme-Johnson, D., & Schneider, R. H. (1994). The effects of transcendental meditation compared to other methods of relaxation and meditation in reducing risk factors, morbidity, and mortality. *Homeostasis in Health and Disease*, 35, 243–263.
- Arena, J., Bruno, G., Hannah, S., & Meador, K. (1995). A comparison of frontal electromyographic biofeedback

- training, trapezius electromyographic biofeedback training, and progressive muscle relaxation therapy in the treatment of tension headache. *Headache*, 35, 411–419.
- Bankart, C. P. (1997). *Talking cures: A history of Western and Eastern psychotherapies*. Pacific Grove, Ca.: Brooks/Cole.
- Benson, H., & Stuart, E. M. (1992). *The wellness book: The comprehensive guide to maintaining health and treating stress-related illness*. New York: Birch Lane Press.
- Bernstein, D. A., & Carlson, C. R. (1993). Progressive relaxation: Abbreviated methods. In P. M. Lehrer & R. L. Woolfolk (Eds.), *Principles and practice of stress management* (2nd ed., pp. 53–87). New York: Guilford.
- Borysenko, J. (1997). *Meditation for inner guidance and self-healing*. (Audio tape). Niles, IL: Nightingale Conant.
- Borysenko, J., & Borysenko, M. (1994). *The power of the mind to heal*. Carson, CA: Hay House.
- Broota, A., Varma, R. & Singh, A. (1995). Role of relaxation in hypertension. *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*, 21, 29–36.
- Carlson, C. R., & Hoyle, R. H. (1993). Efficacy of abbreviated progressive muscle relaxation training: A quantitative review of behavioral medicine research. *Journal of Counseling and Clinical Psychology*, 61, 1059–1067.
- Carrington, P. (1993). Modern forms of meditation. In P. M. Lehrer & R. L. Woolfolk (Eds.), *Principles and practice of stress management* (2nd ed., pp. 139–168). New York: Guilford.
- Epstein, M. (1995). *Thoughts without a thinker*. New York: Basic Books.
- Fontana, D. (1991). *The elements of meditation*. New York: Element.
- Hanh, T. N. (1991). *Peace is every step*. New York: Bantam.
- Ibanez-Ramirez, M., Delgado-Morales, F., & Pulido-Diez, J.

- (1989). Secondary situational impotence in case of homosexuality. *Analisis y Modificacion de Conducta*, 15, 297-304.
- Johanson, G., & Kurtz, R. (1991). *Grace unfolding: Psychotherapy in the spirit of Tao-te Ching*. New York: Bell Tower.
- Kabat-Zinn, J. (1990). *Full catastrophe living*. New York: Dell.
- Kabat-Zinn, J. (1994). *Wherever you go, there you are*. New York: Hyperion.
- Kabat-Zinn, J. (1995). *Mindfulness meditation*. (Audio tape). Niles, IL: Nightingale Conant.
- Lehrer, P. M., & Woolfolk, R. L. (Eds.). (1993). *Principles and practice of stress management* (2nd ed.). New York: Guilford.
- Levine, S. (1991). *Guided meditations, explorations and healings*. New York: Anchor.
- Long, B. (1995). *Meditation* (rev. ed.). London: Barry Long Books.
- Murphy, M., & Donovan, S. (Eds.). (1997). *The physical and psychological effects of meditation* (2nd ed.). Sausalito, CA: Institute of Noetic Sciences.
- Simpkins, C. A., & Simpkins, A. M. (1996). *Principles of meditation*. Boston: Charles E. Tuttle.
- Teasdale, J., Segal, Z., Williams, J. & Mark, G. (1995). How does cognitive therapy prevent depressive relapse and why should attentional control (mindfulness) training help? *Behaviour Research and Therapy*, 33, 25-39.
- Weil, A. (1995). *Spontaneous healing*. New York: Ballantine.
- Weil, A. (1997). *8 weeks to optimum health*. New York: Knopf.

学习评判反馈

第一部分

1. 家庭作业和练习
2. 指导关于在何处进行练习
3. 基本原理——告诉求助者如何进行练习
4. 呼吸引导
5. 家庭作业——告诉求助者如何完成练习
6. 指导求助者进行冥想 10 到 20 分钟
7. 探索冥想的体验——评估求助者的反应
8. 关于被动态度的指导
9. 关于聚焦字词或短语的指导

第二部分

1. 基本原理——原因
2. 家庭作业——何时进行练习
3. 关于态度的引导
4. 有关冥想姿势的准备
5. 呼吸引导
6. 讨论对冥想的反应
7. 躯体扫描
8. 有关自律和投入引导

第三部分

使用放松反应会谈检测细则或沉思冥想会谈检测清单来评估你的教学。

第四部分

1. 基本原理:
 - a. 目的: “如果你有规律地练习这个程序, 它就能帮助

你变得放松；放松有益于你，能帮助你睡得更好。”

- b. 概况：“这个程序包括学习紧张和放松你身体的不同肌肉群。通过做这些，你能比较放松和紧张两者之间的差异。这将帮助你认识紧张，从而你能命令自己放松。”

- 2. 关于服装的指导：“你不需要任何事物转移你的注意力，要穿舒适宽松的衣服训练。你可以取下你的眼镜或隐形眼镜。”

- 3. 环境因素：

- a. 安静的屋子，并放置椅子
- b. 不要有明显的分心事物或被打断

- 4. 练习示范：“让我来指导你将正确地做什么。仔细地观察我的右臂。我将紧握我的拳头并绷紧我的前臂，像我这样做，学习紧张。现在我将放松，像这样（手变得柔软），让所有的紧张排出手臂、手和手指。”

- 5. 程序应用的肌肉群包括：

- a. 拳头
- b. 手腕
- c. 二头肌
- d. 肩部
- e. 面部肌肉——前额，眼，口，唇
- f. 头，下颌，颈部肌肉
- g. 背部
- h. 胸部
- i. 腹部
- j. 腿和脚

- 6. 若干可能的探询：

- a. “在从0到100的刻度尺中，0代表非常放松，100代

表非常紧张，你现在的感觉是几分？”

- b. “对于你刚刚所做的，你整体的反应是什么？”
- c. “肌肉紧张和放松之间的对比是怎样的？”
- d. “你做时感觉容易还是困难？”

7. 家庭作业指导应该包括

- a. 每天练习两次
- b. 在一个安静的地方进行练习
- c. 使用椅子、地板或枕头来支撑

第五部分

使用肌肉放松法会谈检测清单来评估你的表现。

第六部分

在角色扮演中使用躯体扫描方法。

第十八章 呼吸练习和 HATHA 瑜伽

一个16岁的男孩由于不能保持清醒，并经常感觉疲倦而无法适应学校生活。他的父母对此感到难以理解，因为他每天的睡眠时间都在八小时以上。

一个29岁的电脑程序编制员时常有下背部的疼痛感。她说经常要在电脑前持续工作很长时间，并感到总是处于巨大的压力之下。她感到烦躁并经常失眠。

一个曾服药成瘾的人说，自从他康复以来，他常常担心如果自己不能找到一项有积极意义的工作就会旧病复发。

一个老年人反映他时常感到头晕眼花，浑身颤栗。而对他进行的身体检查并未发现任何可以解释这些症状的身体异常。

一个大约在六个月前遭到强奸的妇女说，她感到身体有一种极度的不适感。

一名心理卫生中心的咨询员说，他时常感到六神无主，不知所措。他感到压力巨大，但不知道该如何应付。他是一个单身父亲，十分忙碌，他认为自己没有时间去做他应该做的事。

以上各种病情都可以通过本章所介绍的两种干预疗法而得到解决。多年来，健康专家一直把躯体和心理当做两个独立的系统来对待。我们现在正在改变我们关于健康和治疗的原有思维方式，例如：

- * 每一种疾病并不只有一个病因。疾病和健康一样，是由人的心理、躯体、精神以及外界环境等多种因素综合决定的。
- * 治疗方法不是惟一的。没有哪种单一的治疗方法能解决所

有的问题。

- * 我们不应把治疗的效果完全归于外部环境或治疗方法本身。治疗效果的大小归根结底取决于我们自身,诸如躯体、心理和精神等各方面因素。
- * 医疗专业人员不能回答有关健康和疾病的所有问题。有些问题只有我们自己才能找到答案。

精神免疫学领域的研究提供了一种从生物化学角度阐述身心关系的方法。人的心理状态会影响人的生理功能。近十五年来,越来越多的研究证据表明心理和躯体之间有着密切的联系,而这种联系对我们身心的健康产生着影响。思维、情感、想像及生物化学机制之间的交互作用,是通过一个活性神经肽细胞——天然的转换躯体和心理之间信息的化学物质来实现的。Candace Pert 对这方面做了深入研究,他发现人体的一切活动都是通过负载信息的分子来调控的。在这些研究成果的基础上,出现了有别于传统方法的保健治疗方法,它们受到了心理卫生保健专业人员的重视,并被视为是对传统医学方法和心理健康干预措施的补充。这些补充手段在以前被认为是异乎寻常和奇怪的,而现在则为许多咨询者和保健机构所熟悉。Dacher 认为,所有这些手段“都可以拿来自己去做,而不需要别人为我们做”。这一整套自我调节和强化心理与躯体相互联系的训练课程,包括冥想、瑜伽、呼吸练习、太极、合气道、想像、书法、记日记等。这些都是 Bankart 所说的“东方心理疗法”。总的来说,它们具有这样一些特点:

1. 将躯体健康、良好的精神状态、人际意识和情绪稳定结合为完整的统一体;
2. 扩展了意识的范畴;
3. 在相对安静的状态下完成上述过程。

在本章我们将介绍两种有效的心理/躯体训练,即呼吸练习和 Hatha 瑜伽功。一旦咨询者体验到呼吸练习和修习 Hatha 瑜

伽功的益处，他就会发现自己会变得更具有意识、更平和、更能集中注意力于自己与求助者的关系以及生活中的其他方面。呼吸练习和瑜伽可以作为单独的治疗方法使用，也可以与其他治疗方法结合使用。

许多传统心理治疗都着眼于处理求助者的情感、认知和行为。众多的西方学派所做的仅限于考察“我们的头脑”，而没有对它与躯体的关系做进一步考虑。事实上，很多求助者都可以从本章所介绍的呼吸练习及瑜伽中受益。在呼吸练习和瑜伽练习的每一部分，我们都会列出能从这些练习中受益的求助者类型。如果咨询者觉得某位求助者能从心、身结合治疗中受益，就可以指导他做呼吸练习。如果求助者对呼吸练习感兴趣或反应良好，还可以介绍他去找专业瑜伽治疗师，因为膈膜式呼吸是Hatha 瑜伽不可缺少的组成部分。从我们的经验来看，大多数求助者都能从呼吸练习或 Hatha 瑜伽中获益，尤其是那些精神压力过大的人。

本章目标

1. 能根据指导有意识地调节自己的呼吸强度和节奏。最好在做练习以前用录音带录下指导语。
2. 能较详尽地说出 12 个膈式呼吸步骤中的 10 个。你可以用录音带录下指导语，以提高练习时的注意力。
3. 能说出 11 个交替鼻孔呼吸步骤中的 9 个（录下指导语）。
4. 能分别说出 13 个瑜伽准备姿势中的 9 个，及 14 个 Hatha 瑜伽姿势中的十一个。你可以把这些作用写下来，或进行录音。
5. 能说出做呼吸练习时所要注意的六项规则中的四项。同样，你可以把这些规则写在表中，或录下它们。
6. 能描述七个能量中心中的六个所处的体内位置，及其所包含的潜在情感与认知表现。书面记录或进行录音。

呼吸练习的过程与用途

Andrew Weil 认为,“如果说呼吸是体内的精神运动,那么练习呼吸活动就是一种精神活动的练习方式”。这里呼吸是对生命力的调控,它是心理、躯体和精神整体中的一部分,因此生命力的呼吸不仅仅是指一般的呼吸活动或气体交换。Patel 说,“当一个人获得对事物的创造性见解时,我们称之为灵感……一个人的生命力越强,那他的活力也越强,心理活动和意识就越灵敏”。我们吸入的氧气对新陈代谢非常重要,没有氧气我们就无法进行能量消耗;我们需要氧气为躯体提供营养,进行躯体修复和再生,而“呼吸练习”可以使我们有意识地控制和分配躯体内的生命力。

“呼吸是联系生命与意识的桥梁。躯体与思维通过呼吸有机地结合在一起……呼吸是联系躯体和心灵的桥梁,使躯体和心灵结为一个统一的整体。呼吸与心灵和躯体都有密切的联系,而且它也是使两者紧密结合、和谐共处的工具。对于呼吸紊乱及其对心理/躯体机能影响方面的研究,Fried 和 Patel 分别做了简略的概述。Fried 把呼吸练习引入针对呼吸异常、应激应付、心理疾病躯体化等的治疗,如紧张、焦虑、疲劳症候群、恐怖症、抑郁症、紧张性头痛、高血压、雷诺氏症、磨牙癖、哮喘病、胃炎、低血糖、心律不齐、糖尿病和恐高症等。

呼吸和应激的生理学

了解一些呼吸的生理学有助于解释呼吸失常后,在心理/躯体方面发生的改变。呼吸的功能是为机体细胞提供氧气(吸气),并排出二氧化碳(呼气)。吸气时,外界空气被吸入肺。图 18-1 显示了呼吸系统的图解:气管,心脏,主动脉,肺和支气管,两个放大图分别是:支气管和成串的放大的肺泡,一串有毛细血管的肺泡。心脏和肺一起参与工作。心脏把富含氧气的血液从肺泵

出，通过主动脉输送到身体的各个部位。二氧化碳含量高而含氧少的血液被泵到肺进行气体交换。肺内空气中的一些氧气进入血液，同时血液中的二氧化碳进入肺腔并被排出体外。氧气和二氧化碳在被称为肺泡的细支气管中进行交换。肺泡与运送血液的毛细血管有直接的联系（见图18-1）。气管和毛细血管壁既薄又湿。

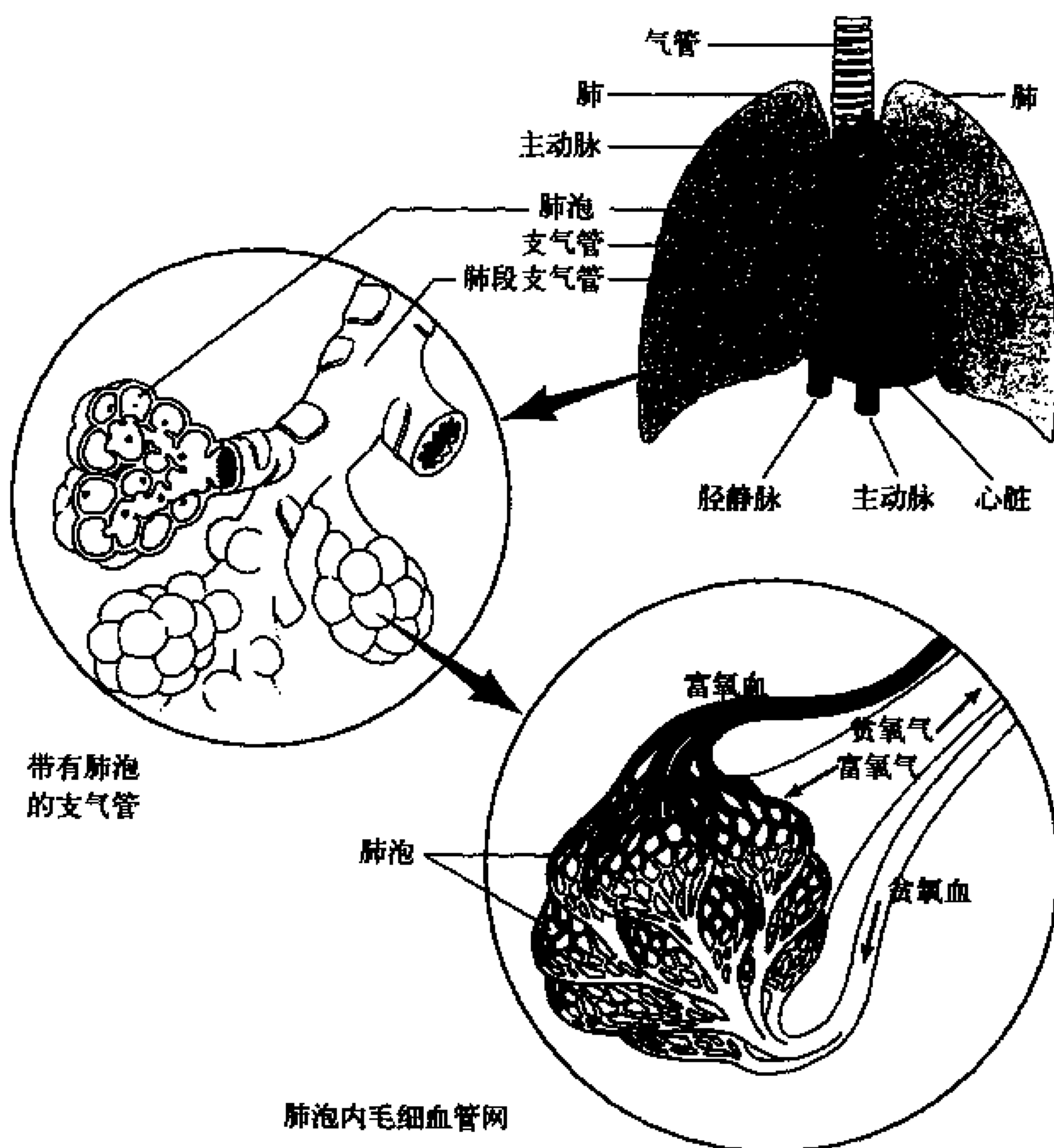


图 18-1 呼吸系统示意图

氧分子透过膜溶入毛细血管的血液中。在肺泡里，血红蛋白获得氧气，血浆则把二氧化碳释放到空气中。

新陈代谢活动给机体提供氧，这一过程通过血液循环系统或氧气输送系统来完成。当代谢需要量增加时，一个自动平衡调节机制有助于“消除能引起慢性低氧的生理副产物的作用”。Fried把低氧（氧量不足）与缺氧（无氧）区别开来。换气过度可表现出类似低氧的迹象，表现为连续应激反应极端状态。根据Fried的理论，过度换气表明血中碳酸过少或肺泡内的二氧化碳不足。“血碳酸过少损伤所有器官系统，包括肌肉、心肌组织和神经。尤其是血液和动脉……血碳酸过少，会引起大脑和外周动脉的过度收缩，减少流向身体末端和大脑的血流量”。应激的最重要症状之一就是过度换气，或表现为呼吸紊乱和血碳酸过少。表18-1列出了应激患者报告的各种与过度换气症候群相同的症状。正如表18-1所示，呼吸紊乱影响情绪，并会导致心理、生理功能的失调。

表 18-1 应激失常者报告的症状与过度换气症候群相同

-
- 紧张（一种“紧张的感觉”，肌肉疼痛）
 - 易怒，对挫折耐受性低
 - 焦虑（忧虑，警戒性增高）
 - 呼吸困难（无力屏息，令人窒息的感觉，频繁叹气，胸部起伏，咽喉异物感）
 - 劳累、疲倦
 - 失眠
 - 心动异常（心脏剧烈跳动，感到脉搏加快，胸部沉重的感觉，且伴有弥散性疼痛）
 - 抑郁，坐立不安，紧张不安
 - 头晕，颤栗
 - 四肢发冷，并不时有刺痛感
 - 注意力不集中
 - 浮肿
-

膈式呼吸（或称腹式呼吸），而不是胸式呼吸（又称浅呼吸），负责平衡交感神经和副交感神经系统。这两个系统支配着内脏和血管的活动，影响心律、血压、不自主呼吸和消化等生理功能。交感神经系统（SNS）激活应激反应和不规则呼吸，SNS 对自我保护极为重要，不规则呼吸是应激反应的一个正常部分。SNS 对危险状态做出反应。副交感神经系统（PNS）则产生松弛反应，引起深度的腹式呼吸。PNS 执行保持机体平衡的功能。

呼吸方式影响躯体和心理的状态，这种影响通过人的生理、心理、情绪和精神的变化反映出来。应激状态下产生的胸式呼吸、或习得的呼吸模式会导致生理和心理失衡，或引起心理与躯体整个系统的失衡。因为在呼吸与心理之间存在着循环往复的关系，因而膈式或腹式呼吸能够帮助精神放松。

呼吸练习的步骤

请用一点时间先来回答下面的问题：

当你进行深呼吸的时候，你的胸部会鼓起吗？

你感到你的胸部或胃部有不舒服的感觉吗？

你的呼吸更多的是在胸部进行吗？

你的呼吸很浅吗？

你经常感到没有获得充分的呼吸吗？

你经常在下半时感到轻度或较严重的头痛吗？

你是否有时感到肋骨有疼痛感，或感到刺痛，以至于想要屏住呼吸？

你的肌肉经常处于紧张状态，或者一碰就疼吗？

你是否经常叹气？

你是否经常感到透不过气来？

你是否容易疲劳或睡醒后仍感疲倦？

在平静时或休息后，你的呼吸每分钟超过 15 次吗？

如果求助者对上述任何一个问题的回答都是“是”，那么他就是表18-2中所列的五类人，他将通过呼吸练习获得改善。你可以与求助者讨论呼吸练习是否会对他目前的问题有所帮助。

表18-2列出了五种呼吸意识指向和五种呼吸练习方式，即膈式呼吸、间断呼吸、单鼻孔呼吸、交替鼻孔呼吸和 Kapalabhati 呼吸（净化式呼吸）。有意识地练习五种呼吸中的任何一种都会获得以下一项或多项好处：减轻压力和消除紧张，积蓄能量和提高忍耐力，控制情绪，预防和治愈生理疾病，缓解疼痛，有利于生长发育，促使精力集中和提高体育成绩，促进心理精神的转型。

教授呼吸意识或五种呼吸练习时，应考虑求助者的年龄、性别、阶层和种族。还要考虑求助者是否有某些医学和躯体的禁忌症，以致不宜进行呼吸练习。如果咨询者或求助者对此有任何疑问，则要与专门的保健医生协商，在得到求助者可以进行呼吸练习的许可之后，再开始练习。也可以参阅本章后面的“膈式呼吸的禁忌症和负作用”一节。

呼吸意识

呼吸状态的意识（表18-2第一列）是用来帮助一个人清楚地觉察和意识到自己的呼吸状况。这一状态意识过程有五个步骤：

1. 要求求助者保持舒适的躺姿（在一张长沙发椅上或其他任何感到舒服的地方），分开双腿，两脚向两边自然伸开；一只手臂弯曲放在上衣腹部的纽扣处，另一只手臂自然放松在身体一侧。
2. 指导求助者缓慢地通过鼻孔呼吸，并仔细去体察和感受。在吸气和呼气的同时，要感觉到腹部的涨落运动。
3. 指导求助者保持深而慢的呼吸，并保持放松状态。
4. 在躺着呼吸几分钟以后，指示求助者坐直。把一只手放在肚脐下，把另一只手放在胸前。

表 18-2 呼吸意识的指向和五种呼吸练习方式

呼吸意识	膈式呼吸	间断呼吸	单鼻孔呼吸	交替鼻孔呼吸	净式呼吸
1. 采取一个舒适的姿势躺下，把一只手放在腹部的纽扣上。双腿分开，两脚放松向两侧伸开。把另一只手臂放于体侧，保持放松。	1. 基本原理——用途及优点。 2. 采取一个舒适的姿势躺下，如躺在一张卧椅上。通过鼻孔呼吸。仅留意你的呼吸。 3. 弯曲手臂，把大拇指轻轻放在肋弓下缘，另一只手和手指与身体垂直放置。想像膈肌的运动。当你吸气时，膈肌的肌肉纤维收缩并被往下拉。当你呼气	1. 基本原理——用途及优点。 2. 吸气时，身体坐直，慢慢吸气，并保持放松。 3. 呼出一小部分气体，然后暂停。 4. 继续保持每次吸气和呼气后暂停约一秒钟。 5. 呼气时，呼出后再吸入一点。按暂停、吸入、再暂停的顺序反复进行。暂停时间	1. 基本原理——用途及优点。 2. 采取一个舒适的坐姿，并保持身体坐直。如果你是坐在地板上，把双腿交叉，并在屁股下垫一个软垫。 3. 做呼吸手形。用呼吸手形堵住右鼻孔。 5. 用左鼻孔将气体全部呼出，数四下后吸气，再数八下后呼气。 6. 反复做五次。	1. 基本原理——用途及优点。 2. 坐直并保持脊柱直立。把一只手轻轻握成拳状。 3. 伸直大拇指、无名指和小手指，把中间的另两个手指合拢在手掌内。把拳头放在鼻子前。 4. 用两个鼻孔吸气。用大拇指堵住右鼻孔，缓慢地从左鼻孔把气呼出，用深呼吸。	1. 基本原理——用途及优点。 2. 做这项练习时坐直身体，或弯腰站着。把手放在膝盖上方，保持放松，轻轻地呼吸。 3. 在吸气时，放松腹部肌肉，鼓腹部，想像膈肌正在下降。做深呼吸。 4. 呼气时用力拉紧腹部的肌肉，就像有人打或压了你的
2. 轻而缓慢地呼吸。通过鼻孔呼吸，逐渐体会并感受你的腹部的运动。注意呼吸和吸气时腹部的运动。					
3. 保持通过鼻孔					

(待续)

- 呼吸。通过鼻孔进行缓慢的深呼吸，保持放松。
4. 身体坐直，把一只手放在腹部（腹部纽扣处），另一只手放在胸部上侧。
5. 注意当你吸气和呼气时两手的运动，哪只手运动更明显？
6. 做家庭作业，练习。
- 时，膈肌纤维被上拉，这时空气从肺内排出，膈肌变成了球面状。
4. 用双手摹仿这些运动。当吸气时把你的手指向外伸直；当呼气时，弯曲手指使之形成球面状。
5. 身体坐直，闭上眼睛；想像腹部像潮水般地起伏，膈肌上下运动。
6. 做家庭作业，练习。
- 约一秒钟，间隔时间与吸气时相同。
6. 呼吸练习结束时先暂停一下，然后恢复正常呼吸。
7. 做家庭作业。
7. 堵住左鼻孔，做同样的练习。
8. 反复做五次。
9. 做家庭作业。
5. 现在从左鼻孔吸气，用最末两个手指（无名指和小拇指）通过右鼻孔把气呼出。
6. 在你逐渐对用鼻孔呼吸习惯以后，可通过默默数数使你的呼气时间相当于吸气时间的两倍。
7. 刚开始练习时做三分钟，然后逐步增加到六分钟或更长。练习的同时在脑中想像呼吸运动的情形。
8. 做家庭作业和练习。
- 腹部一样。注意这时你的膈肌会很快上移并形成球面状；空气从你的肺急速喷出。
5. 以做15次快速呼吸为一个周期。做2-3个周期。
6. 做家庭作业和练习。

5. 让求助者注意两手在吸气和呼气中的运动,并且判断哪一只手活动更明显。如果放在胸部的手的运动比另一只手更明显,这可能意味着这个求助者更多的是采用胸式呼吸而非膈式呼吸。这类呼吸较膈式呼吸或腹式呼吸程度要浅。

对一部分求助者来说,在给他们讲解有关膈式呼吸及其练习基本原理以前,上述这些练习可帮助他们获得呼吸意识。我们发现对一部分求助者来说,呼吸意识的练习有助于提高和促进膈式呼吸练习。对其他求助者来说,咨询者可以不需要经过呼吸意识练习,而直接从呼吸原理开始进行膈式呼吸练习。

如何观察求助者的呼吸

表 18-3 显示了呼吸的五个维度。(1)咨询者可观察求助者呼吸的部位,胸式呼吸还是腹式呼吸,胸式呼吸显示出问题,而腹式呼吸则表示放松。(2)引导求助者意识到呼吸的深度,浅式呼吸显示出问题,深呼吸则表示放松。(3)测定呼吸的频率,呼吸快显示出问题,频率慢则表示放松。(4)观察求助者是否有屏息或急促呼气现象,这显示出问题。(5)咨询者还可观察求助者吸气是否短促,这也显示出问题。对于任何显示问题的呼吸,咨询者可以让求助者去做表 18-2 所列的相应练习。

获得求助者的同意

咨询者应向求助者恰当地介绍呼吸练习,以保护求助者的权利和幸福。治疗者应获得求助者的同意,即表示愿意接受这些练习。咨询者可为求助者提供以下信息,以争取获得赞同:

1. 对呼吸练习过程和所包括的相关活动进行描述;
2. 解释呼吸练习的基本原理、用途,以及潜在的作用;
3. 描述治疗者的角色;
4. 描述求助者的角色;

表 18-3 如何观察求助者的呼吸

呼吸的维度	不正确的呼吸方式	放松呼吸	相互作用的标准
呼吸的部位	胸	腹	只有通过观察
呼吸的深度	浅	深	有觉察
呼吸的频率	快	慢	教授或使用表 18-2 中列出的一种呼吸练习, 以减轻呼吸中的问题
呼 气	屏息或急促	缓慢呼出	教授或使用表 18-2 列出的一种呼吸练习, 以减轻呼吸中的问题
			教授或使用表 18-2 列出的一种呼吸练习, 以减轻呼吸中的问题
吸 气	浅而多变的	深而平静	教授或使用表 18-2 列出的一种呼吸练习, 以减轻呼吸中的问题
			教授或使用表 18-2 列出的一种呼吸练习, 以减轻呼吸中的问题

注: 上述方法对咨询者和求助者都适用

5. 描述可能出现的危险或不适反应;
6. 描述预期效果;
7. 预计练习所需要的时间;
8. 回答求助者提出的关于呼吸练习的问题;
9. 告诉求助者他拥有随时中止练习的权利;
10. 对求助者的各种反应做出总结和澄清。

利用上述条目设计一个协议书,请求助者同意后在上面签字,表明他已经接受上述条款。

呼吸练习的基本原理和概况

对呼吸练习的基本原理和概况可做如下解释:

很多人呼吸不够深沉。学会用膈式或腹式呼吸能增加吸氧量。这种呼吸方法充分利用了肺的容量,使你可获得比正常浅呼吸多七倍的氧气量。而且,在一天当中的任何时候你都可以练习——不管是在排队等候时,还是当你的车子遇到交通堵塞的时候。所增加的氧气量对你的身体和心理都有益。呼吸练习可以使副交感神经兴奋,并起松弛作用(见第十七章),而且使神经系统趋于平静。开始时,你可能会有一些轻微的不适和头晕,但这种副作用很少出现。而你得到的好处是很多的,包括以下几个方面:减轻压力,缓解紧张,充沛精力和忍耐力,有助于情绪的控制,预防和治疗身体疾病,帮助止痛,有助于延缓衰老,集中精力,提高身体素质。在学习和使用呼吸练习中还没有发现存在什么危险,尽管对一些求助者来说,可能会有一些后面提到的禁忌症。如果你出现极为异常的疼痛或不适反应,我们将立即停止练习。练习过程包括训练腹式呼吸或膈式呼吸。我们还可以探讨其他对你有帮助的呼吸练习。你可以进行一周的呼吸练习。如果你每天练习一次,将花大约五六分钟时间。如果每天两次,时间也

加倍。而且，当你处于应激状态，需要休息或恢复体力和精神时，可练习做深呼吸。你可以接受一个疗程的呼吸练习训练。然后进行一周的练习。需要的话，可打电话给我。练习能帮助你把深呼吸结合到你日常的生活和应激环境中。你觉得这样如何？

膈式呼吸

通常在进行膈式呼吸时，要准备好示意图，如图18-2。这个图能很好地解释为什么膈式呼吸也称为腹式呼吸。因为随着吸气与呼气的进行，腹部交替外突和内收。如图18-2所示，膈肌位于肺的下部，它是一块宽的、扇形的肌肉，它把胸腔及其内容物与腹腔及其内容物隔离开来。如果求助者的呼吸太浅，膈式呼吸能帮助他获得更深的呼吸。你可根据下列步骤进行教学指导：

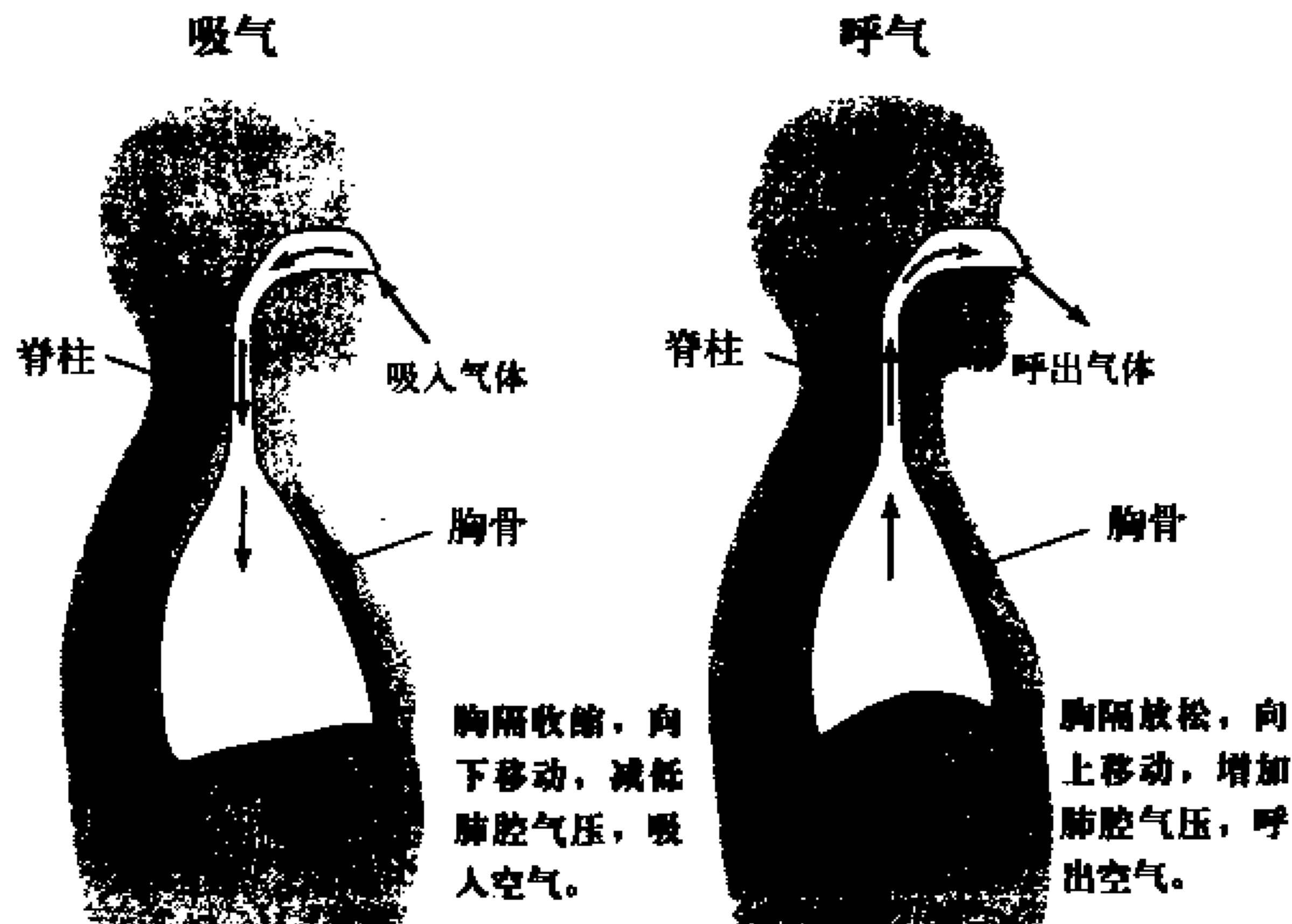


图18-2 胸腔下部的胸膈运动

1. 咨询者向求助者介绍基本原理时可对求助者说：“请注意，在你每次开始呼吸时，你的胃上升，肋骨向外扩展。如果你的呼吸太浅，膈式呼吸能帮助你获得更深的呼吸。”你可用上页所说的事例向求助者阐述呼吸练习的基本原理。当人吸气时，膈肌纤维收缩并向腹部下拉，如图 18-2 左图所示。右图则显示当呼气时，膈肌呈球面状。我们使用示意图，是因为它可以让求助者在膈肌训练开始时想像膈肌的运动。膈肌训练包括六个步骤，如表 18-2（第二列）所示。在练习过程中，腹部在吸气时往外突，呼气时往内收，所以这个练习也称为腹式呼吸。
2. 咨询者指导求助者保持一个舒适的躺姿，并通过鼻孔呼吸。两腿舒适地分开，两足放松向外分开。
3. 让求助者弯曲肘部，把大拇指轻轻地放在肋骨下缘；两手手指相对，并使掌面与身体保持垂直。然后想像吸气时的膈肌，膈肌纤维收缩并往下拉。呼气时想像空气从肺中呼出，同时膈肌上移，形成球面状。“当你吸气时，把你的腹部向外鼓，当你呼气时让你的腹部向内收。始终保持用一种平稳的方式通过鼻孔呼吸。刚开始练习时，注意吸气和呼气时手的升落，这对你是很有帮助的。吸气时注意，你的手上升，同时腹部鼓起；呼气时注意，腹部向后压（使腹部往脊柱靠拢），同时手下移。记住，膈肌是一块肌肉，可以像其他肌肉一样的得到锻炼和强化。”
4. 指示求助者用手模拟膈肌的运动。大拇指贴放在肋骨的下缘，手指微微交错。当吸气时，交错的手指平放模拟膈肌的上拉（见图 18-3，左图）。在呼气时，使手指弯曲形成球面状，模拟空气从肺中排出时膈肌向下拉的运动。在吸气时，膈肌纤维收缩并往下拉，膈肌的球面弯曲度变小乃至几乎放平。膈肌下降并压迫胃、肝脏等，起到了类似轻



图 18-3 呼吸时胸膈的运动

微按摩的作用，并可以促进这些器官的活动。“当你呼气时，肌肉收缩，膈肌变成球面状并向上推向肺部。想像你的膈肌在每次吸气和呼气时，对负责消化和排泄等的内脏器官做揉捏等按摩，使血液流入内脏，然后再挤出。这种呼吸的方法充分利用了你的肺容量”。

5. 指导求助者坐直身体、闭上双眼，在呼气和吸气时想像膈肌的位置，同时体验腹部如潮水般的起落。
6. 要求求助者把膈式呼吸作为家庭作业，每日至少练习两次。要找一个安静的地方来练习，以保证不被打扰。鼓励求助者在处于应激状态和恢复精力、体力时使用膈式或腹式呼吸。这种呼吸的方法可使你的肺容量得到充分利用。使你能吸入比正常的浅呼吸多七倍的氧气量。鼓励求助者在一天中随时使用膈式呼吸。

Bill(作者之一)经常用这种呼吸练习来协调膈式呼吸与身体的细微运动，并以此作为瑜伽练习的准备工作。指导求助者仰卧、膝部弯曲、两足放平、两臂放在身侧。(注意：对那些有身体缺陷

的求助者或性攻击的受害者，你不应使用躺着的练习方式，而应采用前述的坐姿方式。) 呼气时微微抬起臀部，使腰部着地。吸气时则微微弓起腰部，使求助者在腰与地面之间能塞进一个手指头，同时臀部着地。慢慢重复这些动作，保持放松，提醒求助者在想像膈肌活动时做这些动作。

间断呼吸

1. 咨询者介绍这种呼吸练习的原理，使求助者学会如何进行缓慢地呼吸，并体验他们在呼吸的短暂间隔的感受。
2. 指导求助者采取一个舒适的坐姿，保持上身坐直，开始缓慢地呼吸，并放松；
3. 在呼气时，指示求助者呼出一部分后暂停；
4. 继续呼出另一部分，然后暂停大约一秒，如此重复直到肺内气体全部呼出。
5. 在吸气过程中，要求求助者每次吸入一部分。在吸气过程中同样连续使用暂停。吸气时保持相同的间隔时间。
6. 在呼吸练习结束时先暂停一下，然后恢复正常的呼吸。要让求助者重复多次这样的练习，并选择尽可能舒适的交替暂停顺序，我们每次重复四次是有帮助的。记住对希望减慢他们的呼吸速度的求助者来说，这是一个候选的呼吸练习。如果求助者感到进行这项练习没有获益，单鼻孔呼吸或交替鼻孔呼吸或许是一种更为合适的选择。
7. 如果求助者希望在家里进行这项练习，要求他每天练习两次，并注意调节吸气和呼气的频率。

单鼻孔呼吸

单鼻孔呼吸(表18-2第四列)是进行呼吸控制和交替鼻孔呼吸的一种有效的预备训练方式。

1. 咨询者介绍单鼻孔呼吸的原理,指出这项练习是为交替鼻孔呼吸做准备。
2. 求助者采取一个舒适的坐姿,挺直背部。如果他双腿交叉坐在地上,可在屁股下垫一个软垫,同样要求保持背脊挺直。
3. 指导求助者做一个手形,大拇指、无名指和小拇指伸出,合拢另外两个手指(见图18-4)。
4. 求助者以该手形堵住右鼻孔。
5. 要求求助者通过左鼻孔把气完全呼出。然后吸气时数到4,呼气时数到8。
6. 要求求助者重复做5次。
7. 指导求助者堵上左鼻孔,通过右鼻孔把气完全呼出。然后吸气时数到4,呼气时数到8。
8. 指示求助者重复做5次。
9. 指示求助者练习一周。



图 18-4 呼吸练习手形

交替鼻孔呼吸

1. 对于交替鼻孔呼吸的原理，咨询者可以这样解释：这种呼吸练习能平衡心理和躯体，使身体放松，逐渐提高精神活力和注意力，使神经得到松弛。此外，交替鼻孔呼吸的好处还在于它能增进食欲、促进消化，并能帮助获得充足的睡眠。大脑的两个半球通过一束密集的纤维相联结。右半球被认为是控制感觉、情绪、意象和直觉的，左半球则负责处理逻辑、数学、言语和线性思维等功能。左鼻孔与大脑的右侧相连，右鼻孔则与大脑的左侧相连。大脑的两个半球的交替工作降低了呼吸练习可能带来的疲惫感。
2. 指导求助者采取一个舒适的坐姿，保持上身挺直。
3. 指导求助者做一个手形，放在鼻子边。然后伸直大拇指、无名指和小拇指，合拢中间的两个手指（见图 18-4）。
4. 让求助者用两个鼻孔吸入空气，然后用大拇指堵住右鼻孔，再缓慢、深深地把气从左鼻孔呼出。
5. 指示求助者用左鼻孔吸气，再用另外两个手指（无名指和小拇指）堵住左鼻孔，再通过右鼻孔把气呼出。
6. 在求助者已习惯了交替鼻孔呼吸练习后，进一步要求他控制呼气过程的时间，使其为吸气时间的两倍。
7. 指示求助者反复做交替鼻孔呼吸练习，从三分钟开始，然后逐步增加到六分钟以致更长。
8. 最后要求求助者在家每天练习一次，要求求助者把想像膈肌运动贯穿于这个练习之中。

对这个呼吸练习的更高要求是，通过左鼻孔吸气数到 4，然后停住；堵住两个鼻孔数到 16，再通过右鼻孔呼气数到 8；通过右鼻孔吸气数到 4，停下，堵住两个鼻孔数到 16，再通过左鼻孔呼气数到 8。

Kapalabhati 式呼吸（净化式呼吸）

1. 咨询者指出这种更先进的呼吸练习的原理：它为心理 / 躯体提供“净化”的结果。它的好处是能对腹部器官起到反复按摩的作用，增强腹肌的力量，使腹腔内的所有器官得到活动。这项练习的最大好处是它能使整个神经系统得到松弛。还能通过增加脑部的血流量来为大脑补充氧。大脑血液的增加能促进注意力的集中，改善记忆力，促进思维。然而，咨询者应注意：有高血压、心脏病、癫痫、耳眼疾病或疝气的患者不宜做这项练习。月经期和怀孕期的妇女也不宜做这项练习。

该项练习的动作要领如下：保持舒适的坐姿（你也可以站着练习），挺直背部。手臂和手放松，闭上双眼，放松上、下腭。然后缓慢、平稳地吸气，如果没有不适感就尽可能深地吸气。迅速呼气，并收紧腹部。然后自然地像平常一样地吸气。重复“轻快呼气（腹部收紧），自然吸气”，快速连续做几次。Kapalabhati 或呼吸的另一种解释是它包含了短促的、强有力的呼气过程，以及紧随着的被动的吸气过程。呼气过程是一个积极主动的过程，而吸气过程仅仅是使前者得以发生的被动过程。最后恢复休息时的正常呼吸。这可以作为后面训练的指导性练习。

2. 指导求助者坐着做这项练习，挺直背部，也可以采取两膝微曲、上身自腰部向前弯、两手放在膝盖上侧的站立姿势。你还可以站着做这项练习。指导求助者保持放松，轻轻地呼吸。
3. 在吸气过程中，指示求助者放松腹部肌肉，让腹部鼓起，同时想像膈肌的运动。要求求助者深吸气，但不要强行吸气。

4. 要求求助者在呼气过程中用力拉紧腹部肌肉,就像肚子被使劲打压进去。告诉求助者注意这时膈肌会很快向上移动形成球面状,同时空气被从肺里呼出。指示求助者保持一个较为舒适的呼气 and 吸气速度。
5. 指示求助者重复吸气/呼气过程,15到20次为一个阶段,每次做2至3个阶段。要求求助者在做练习时想像膈肌运动。
6. 如果求助者觉得这个练习有帮助,就可以布置家庭作业,建议他在何时、何处和每隔多长时间进行练习。

膈式呼吸的禁忌症和副反应

膈式/腹式深呼吸并非对任何人都适用。例如,某些做这项练习的人可能会出现抽筋。Fried 给求助者提出以下建议:

如果练习带来疼痛或不舒适感,就立即停止练习;如果出现某些身体疾病,或有对治疗安全性有影响的伤痛,则不要做任何练习。有关事项如下:

1. 肌肉以及其他组织和器官的畸变或创伤。如肌肉扭伤或撕裂、斜颈、骨折或刚做完外科手术后不久。
2. 任何会引起代谢酸中毒的情况,如糖尿病、肾脏疾病、心脏病、严重低血糖等。
3. 低血压及相关情况,如晕厥。在这种情况下做腹式深呼吸可能会引起血压的严重降低。
4. 胰岛素依赖型糖尿病。如果你是一位胰岛素依赖型糖尿病患者,没有医生的许可和他对你做的最新胰岛素需求量调查,你不应该做这项和其他任何的放松式深呼吸练习。

怀孕期的求助者也不宜做呼吸练习。吸烟者做这项练习会很危险, Hendricks 不允许吸烟者在戒烟以前做呼吸练习。

膈式呼吸范例：

在这个示范个案中，一位名叫 Yoshi 的 49 岁的日裔美国人（一位空中交通管制员）接受了膈式呼吸练习。

1. 基本原理

首先，我们向 Yoshi 解释，学会膈式或腹式呼吸能增加氧气吸入量；这种呼吸的方法可以充分利用肺的容量，并且使他能吸入比正常的浅呼吸多达七倍的氧气量。我们还告诉他膈式呼吸的益处包括减轻压力和消除紧张、促进精力的集中。我们介绍原理的同时，还告诉他练习膈式呼吸的步骤。我们确定 Yoshi 愿尝试做膈式呼吸的意愿，并回答了他提出的有关步骤的问题。

2. 展示膈肌的图解和有关姿势的指导

我们向 Yoshi 展示了吸气和呼气时膈肌位置的图解（图 18-2）。让 Yoshi 选择一个舒适的姿势，通过鼻孔呼吸。要求他把一只手放在腹部纽扣处，另一只手放在肋骨下方。我们要求他通过鼻孔呼吸，注意他的呼吸活动（在空气通过鼻孔时），同时在呼气 and 吸气时观察手的变化。我们向 Yoshi 询问手的运动情况，比如两只手的运动是一样的，还是其中的一只手比另一只手更明显？如果是一只手的运动更明显，那么，是放在肋弓上的手还是放在腹部的手？我们向他解释，如果是膈式呼吸，放在腹部的手在呼气 and 吸气时的运动会比放在肋弓下缘的手的运动更明显。我们要求 Yoshi 放松并注意他的呼吸活动。

3. 想像膈肌运动和手的放置

我们要求 Yoshi 弯曲手臂，把他的大拇指轻轻地放在肋骨的下缘（如图 18-3）。指示 Yoshi 把两手的其他手指放在与身体垂

直的位置，想像膈肌的运动（如图 18-2）。在他吸气时，提醒他这时膈肌纤维正在收缩并往下拉。在他呼气时，告诉他这时的膈肌往上升并形成球面状，同时空气从肺内排出。

4. 用手模拟膈肌运动

指导 Yoshi 用手模拟膈肌的运动。我们告诉他在吸气时，把手指向外伸直放平；而在呼气时，弯曲手指使之形成球面状。要求他这样呼吸几次，在轻柔、放松地呼吸的同时，用手模拟膈肌的运动。

5. 坐着进行膈式呼吸

指导 Yoshi 坐直身体，背部挺直，闭上眼睛，把手放在膝上或他感到舒适的地方。要求他想像他的腹部正像潮水般地起伏，在这种放松的状态下呼吸两分钟。

6. 家庭作业和实际场景练习

指示 Yoshi 练习膈式呼吸每日两次，每次五分钟。一次在早晨起床后，另一次在傍晚或天黑前。要求 Yoshi 寻找一个安静的、没有干扰的地方练习。指示 Yoshi 在练习时，或在应激状态应用腹式呼吸时，想像膈肌的运动。

交替鼻孔呼吸示范

我们选用同一个求助者，Yoshi，来介绍如何做交替鼻孔呼吸。

1. 基本原理

我们向他解释交替鼻孔呼吸的目的和有关交替鼻孔呼吸的概况。这种呼吸练习能平衡心理和躯体，使身体放松，提高思维灵

活性和精神集中性，使神经系统得到休息。此外，交替鼻孔呼吸还能增进食欲、促进消化、获得充足的睡眠，并净化神经系统。“你用手闭住一个鼻孔，交替通过每个鼻孔呼吸，感觉如何？你有什么问题吗？”

2. 姿势和平静的呼吸

让 Yoshi 保持舒适的坐姿，挺直背部。告诉他如果双腿交叉坐在地上，最好在屁股下垫一个软垫。

3. 交替鼻孔呼吸的手形

指示 Yoshi 用利势手轻轻握拳。“伸出大拇指、无名指和小拇指，中间的两个手指合拢在手掌”（见图 18-4），“把拳头放在鼻子前。”

4. 右鼻孔

指示 Yoshi 通过两个鼻孔吸气，然后堵住右鼻孔，保证右鼻孔完全堵住。告诉他慢慢地从左鼻孔呼气，用深呼吸。

5. 交替鼻孔

对 Yoshi 说，“现在，从左鼻孔吸气，然后堵住左鼻孔，再通过右鼻孔将气呼出”。指示 Yoshi 继续做交替鼻孔呼吸。

6. 呼气过程两倍于吸气过程

在 Yoshi 习惯了交替鼻孔呼吸以后，指示他掌握好呼气过程的时间，呼气过程应是吸气过程的两倍。

7. 有关呼吸练习时间长短的指示

指示 Yoshi 首次做交替鼻孔呼吸的时间大约为三分钟，以后

逐渐增加到六分钟乃至更长。要求他在练习时想像呼吸的过程。

8. 家庭作业和练习。

指示 Yoshi 在合适的时间和没有干扰的安静环境中进行练习，每天做两次交替鼻孔呼吸。如果可能的话，指示 Yoshi 在压力情境下需要振作涣散的精神时，可使用交替鼻孔呼吸。

通过 Yoshi 一周或两周的膈式或交替鼻孔呼吸练习，咨询者和 Yoshi 期望可以产生如下几种效果。针对 Yoshi 所提出的问题，他可能会体验到更小的压力、更多的能量和耐受力、精神更集中；在工作以外的生活中，他可能会感受到更平静、精神更灵活、精力更旺盛和更少疲劳感。所有这些精神状态都归功于氧气吸入量的增加，这比他进行膈式和交替呼吸练习以前所吸入的氧气多七倍。与以前他的浅呼吸、没有充分利用肺容量的时候相比，有更多的氧气被分配到身体的各个部位。

学习练习活动 49/ 呼吸练习

本章的重点在于调节躯体和心理状态策略。在这个学习活动中你将进行呼吸练习，使你有意识地体验到呼吸活动，有利于你向他人教授呼吸练习。

1. 进行呼吸意识练习，以及本章介绍的五种呼吸练习方法。试做几天，你将会逐步熟悉这些方法，并感受到它们的好处。
2. 做两周的膈式呼吸和交替鼻孔呼吸。选择一个固定的时间和一个安静的地方。注意在日常的真正应激情况下使用膈式呼吸。除了固定的练习时间以外，在你需要振奋一下自己时，也可以使用交替鼻孔呼吸。
3. 在做两周的膈式呼吸和交替鼻孔呼吸期间，坚持记录每

次练习的经历和感受,以及做完呼吸练习后身体的整个能量状态以及放松水平,并记下在什么情况下你使用了膈式呼吸或交替鼻孔呼吸。

Hatha 瑜伽功的过程与益处

我们介绍Hatha瑜伽的目的在于:(1)提醒读者注意Hatha瑜伽的潜在益处,这样你可以向瑜伽治疗师请教,哪些求助者能从这项身体运动中获益;(2)为你提供一项自行减轻压力的方法。对精神健康咨询者来说,练习瑜伽是一种放松,它是一种减轻、消除潜在工作压力的极为有效的方法。

瑜伽不是一种健身术、健美操或常规的增氧健身法。它也不是一种宗教。它是一种转变意识的心理/躯体治疗术。早在五千年以前,瑜伽就已经作为一种培养意识和自觉状态的精神/躯体的完整系统而出现。现在,瑜伽作为一种减轻压力、健身、心理和躯体保健、增强意识的有效工具,已经为西方医学和健康咨询者所接受。瑜伽一词的原义是统一。在这个复杂、混沌的世界里,瑜伽把我们每个人的方方面面统一起来,使我们与自己真实的内心世界深处相联系。瑜伽有很多种练习方法,尽管方法各不相同,但都是为了达到一个共同的目的。在美国最为流行的瑜伽训练是Hatha功。Iyengar指出,Hatha瑜伽中“Ha”是“太阳”的意思,意指我们身体内部的“太阳”,或灵魂。“tha”的意思是月亮,或指意识。Hatha揭示了相对的两极,如太阳——月亮、男性——女性、肯定——否定,及阴——阳之间的平衡。Iyengar说,太阳是永远也不会消失的,而月亮则每个月都会逐渐消失,然后又逐渐恢复。我们身体内部的太阳(灵魂)始终存在,永远不会消失,我们的精神和意识正是从这“太阳”获得能量。而意识则会有波动、调节、情绪变化、兴盛与衰退,就像月亮各个阶段的变化。通

过练习瑜伽能使身体和意识相互融合,并使意识的能量变得平和。“瑜伽使人达到躯体、心理和灵魂三者的和谐,实现身体方面、社会方面和精神方面的统一”。瑜伽是一项“统合训练”——能带来内与外的统一,身心的协调和快乐。瑜伽探讨意识生存的规律,它同样探讨生活的规律。

在上一章里,我们已经介绍了肌肉放松疗法和冥想疗法,它们都可以结合到 Hatha 瑜伽练习中。有意识的呼吸也是瑜伽的一个重要组成部分。瑜伽结合身体姿势和呼吸练习(呼吸的调节)以达到躯体、心理和灵魂的统一。瑜伽的动作姿势能按压、伸展和弯曲脊椎,锻炼肌肉和关节,主要是利用地心引力来伸展、挤压肌肉和身体的内脏器官。因为做这些姿势时结合了呼吸运动,其相互作用的结果是加速血液循环,促进了消化,刺激了内分泌系统和神经系统。Hatha 瑜伽的练习通过复杂的身体姿势练习来排出体内的毒素,达到强健身心的效果。它也是冥想的一种准备练习。身体姿势的练习是运动中进行冥想的一种方式,能使心灵平静,达到身体放松,而又保持注意力集中的状态。21 世纪混乱的生存状态给人们实现真实的自我制造了巨大的障碍,而瑜伽能除掉这些障碍。

Ward 认为,瑜伽练习是重要的,但并非仅仅有瑜伽练习就足够了。练习瑜伽需要献身性、连续性、积极性,以及对自己的健康有一个基本责任心的态度。瑜伽练习中的自我效能感很重要(见第二十章)。瑜伽练习中的身体姿势对练习效果影响很大,认清这些姿势所起的心理暗示作用将有助于练习效果更持久。在做这些姿势时,观察和处理心理变化过程能提高觉醒意识和理解力。当身心更好地结合起来时,你将拥有更强的领悟力和洞察力,而心理本身能通过注意力转移和重新调整心理与意识状态来实现自我治疗。

练习瑜伽的告诫

呼吸练习和瑜伽的目的是为了使身心达到平衡。每个人都可以练习瑜伽，无论是年轻人，还是中老年人。给求助者制定治疗计划前，要让求助者先与自己的医师协商。你还可以给求助者提供几个对瑜伽熟悉的治疗师的姓名。

对心理咨询者来说，瑜伽是一种对保持自己身心平衡、减轻压力的极为有效的治疗手段。你可以在做瑜伽时，想像从每个瑜伽姿势中获得的益处。你可以根据你自己的节奏来练习本章中介绍的瑜伽姿势。尽管如此，我们还是建议，开始练习时必须要有瑜伽治疗师的指导。

练习的地方、衣着和练习时间

我们可以在室内练习瑜伽。选择一个宽大（至少64平方英尺）、没有堆放家具和物品、并有适宜的温度和良好通风条件的地方进行练习。如果没有地毯，可用小毛毯或不会扎手的席子来替代。练习瑜伽的地方应保持安静，不受外界环境干扰。枕头可以在做呼吸练习和瑜伽姿势时充当软垫来使用。小毛毯也可用来做放松及海绵姿势。

瑜伽练习者应穿舒适的、不妨碍做大幅度动作的服装。宽松的T恤衫、圆领长袖运动衫、高领绒衣、宽松的长运动裤、高领长袖紧身衣或短衣服都是很好的选择。练习瑜伽时不宜穿鞋，它们妨碍练习活动并会把你和地板、地毯“隔绝”开来，并使你不能在地上转圈。最好赤裸双脚，如果觉得冷，可以穿上袜子。

每天留出一段没有干扰的时间来做瑜伽练习。选定每天的一个固定时间做练习。有人喜欢在清晨练习，作为一天中的良好开端；有些人在午休时间做瑜伽练习；而另外的人则喜欢在晚餐前做瑜伽练习，不要在餐后两小时内练习。晚间做练习有助于减轻

白天的紧张。

用一个到一个半小时的时间做瑜伽练习。这看来是段比较长的时间，但这段时间和精力的付出是非常值得的。在你很忙时，可以选择较短的练习。我们赞同 Jon Kabat-Zinn 的信条，“你不必喜欢它，只要去做就行了”。六到八周以后，你将会感受到练习的好处。

瑜伽与你

我们认为，如果你打算帮助求助者进行瑜伽练习、呼吸练习和冥想治疗，你必须首先亲自做这项练习，而且每天都做。如果你能从瑜伽练习中感受到益处，在你向求助者推荐专业瑜伽治疗师时，会更具说服力和感染力。如果你决定自己做 Hatha 瑜伽练习，最好在一个合格的瑜伽老师的监督下进行，他能在你做呼吸练习和瑜伽练习时为你做指导和演示。最好是按瑜伽治疗师的训练方式来做练习。Bill 就是在 Joseph LePage 的指导下进行训练，后者是瑜伽集中治疗法的创始人。

正如 Ward 所建议的，进行瑜伽练习需要全身心的投入，需要坚持不懈，还需要积极热情的态度和对健康的强烈责任心。在开始做瑜伽姿势以前，仔细回想一遍姿势要领，并确定你的承受能力。进程可能是缓慢的，保持你自己的速度，并且在做姿势时保持身体放松。在做姿势时，注意你的身体并有意识地做呼吸。伴随呼吸练习的瑜伽姿势，能促使你的所有能量流遍身体的七个能量中心。记住，你没有资格教求助者做瑜伽练习，但你自己可以通过瑜伽练习切身感受到瑜伽的益处。

身体的七个能量中心

对身体能量中心的描述能促进你对身体机制的了解，了解哪些求助者能从合格的瑜伽治疗师那里获得好的治疗效果。瑜伽治

疗师把能量中心理论结合到 Hatha 瑜伽的练习中。在传统的瑜伽理论里,有七个能量中心,称之为 Chakras,意思是神经的中心。这些神经中心的位置与脊髓上不同高度上的点一致。根据瑜伽理论,这些能量中心产生能量场。表 18-4 在第一列中列出了能量中心的数目、名称及其心理特征;第二列是能量中心在身体上的具体部位;第三列描述了每个能量中心所包含的身体部位和器官;第四列和第五列对每个能量中心的能量平衡流动对心理、情感的影响,以及能量中心的能量不平衡流动心理、情感和生理影响做了介绍;在最后一列中,根据瑜伽的理论,指出了对消除能量流动阻碍的有效姿势。

对七个能量中心的概述有助于理解能量系统的活动机制。根据瑜伽的传统理论,第一个能量中心与安全感和稳定性相关。它与个人所属的群体(包括家庭、地区、国家、地域和文化)的行为活动有关。最原始的恐惧感和不安全感被认为是由这个能量中心引起的。如果我们对自己充满自信,没有对社会或外部环境的依赖感,没有基于外界事物的强烈的安全归属感,那么我们会感到平静、安全、平衡和踏实。第二个能量中心是我们身体的、性的能量产生根源。它从耻骨周围扩大到骶骨或腰部区域(腹的下部或中间部分)。在这个中心里,能量的堵塞或不平衡流动会导致挫折感、责备、愧疚、嫉妒、性依赖以及对人或物的过分依赖。在这种情况下,人体产生的能量被这些不健康的情绪和作用所消耗。

第三个能量中心位于胸骨底部与肚脐眼之间的肚脐周围区域。它与太阳神经丛的分布相一致。这个能量中心与个人能力、动机或主动性、决断力、良好的人格和自我控制有关。能量在第三个中心的不平衡流动或阻塞会产生无力感、贪婪、侵犯行为、抑郁、优柔寡断和人格分裂。第四个能量中心位于心脏区域,包括肺和膈肌。这个中心与爱心、同情心、接受性、满足感、宽容、期望和信任感有关。能量在这个中心的不平衡流动会导致情感封闭、迟钝、消极、

表 18-4 能量中心及其部位和功能

能量中心	身体部位及 相关表现	身体相应部 分及器官	能量的平衡流动对 心理、情感的影响	能量的不平衡 流动对心理、情感 和生理的影响	姿势范例
第一中心 背部脊椎底部 安全感 安全感	背部脊椎底部	脊椎骨的最底端 (尾骨), 包括大 肠、直肠、男性 生殖器官、前列 腺、肾脏、肾上 腺、腿、脚、骨 头 tou 和免疫系 统	稳定性安全感, 情绪 和生理的支持, 信 任, 归属感、意识 和知觉	自我中心、自我沉迷, 缺乏 安全感, 情绪不稳定, 郁郁 寡欢, 恐惧、焦虑, 失落感, 感到缺乏清醒意识	树姿 前弯式 压腿式
第二中心 耻骨到骶骨 (脊 椎最下端的骨头) 区域 性欲、创造力、能量 积蓄	耻骨到骶骨 (脊 椎最下端的骨头) 区域 性欲、创造力、能量 积蓄	耻骨到骶骨 (脊 椎最下端的骨 头) 区域。包括女 性生殖器官、肾 脏、膀胱、髓部区 域、循环系统	感觉和情感的能 量中心, 忍耐力、自信、 幸福感、人际关系中 的道德感和荣誉感, 自主性	受挫感—责备和自责, 怀 疑, 过分依赖, 焦虑、恐 惧、性冷淡 子宫、膀胱和肾脏疾病, 下背部疼	三角式 眼镜蛇式 前弯式
第三中心 肚脐区域——胸 骨底部到肚脐眼	肚脐区域——胸 骨底部到肚脐眼	胰腺、小肠、消 化系统, 这个区	个人能力、自我动机 (主动性)、决断力,	无力感、贪婪、侵犯行为, 发怒、抑制、内疚、优柔	弓形准备动作

(待续)

化和社会沟通	之间的范围，太阳神经丛。	胃、肝脏、脾脏、胆囊，脊椎中段，神经系统	良好的人格（自信、尊重和自尊）、好的自我评价、良好的自我控制力	寡断，恐惧感，人格分裂，对批评过于敏感，胃的问题、消化不良、胃及十二指肠溃疡、肝病、肾上腺机能失调、胰腺炎、关节炎
第四中心	心脏部位 打开心扉， 同情心	心脏和循环系统、胸腺、膈肌、肋骨（胸）、肺	同情心、接受性、满足感、宽容、希望、信任	情感封闭、消极、怨恨、孤独、发怒，以自我为中心、缺乏同情心、不信任感 气喘、过敏、肺病、心脏疾病—充血性心力衰竭、心肌梗塞、二尖瓣脱出、高血压、上背部的不适感、细支气管的问题、肺部疾病
第五中心	咽喉底部 意志，更高 层次的交流 和相互作用	咽喉、气管、颈、食管、脊椎、甲状腺、甲状旁腺、口、肩、手臂、手	交际、表达能力、个人创造力，灵感，良好的决断能力	优柔寡断、感情和认知意识缺乏、表达障碍、迟钝、偏执、个人创造能力低下、依赖性强、药物滥用或毒瘾问题 咽喉疼、颌关节疾病、硬

(待续)

		脖子、感冒、言语混乱、听觉障碍、气喘、牙颌问题、咽炎、腺体肿大，甲状腺问题，手、手臂、肩的问题，上背部的不舒适感		半蝉姿势 全蝉姿势 半肩倒立姿势 脊椎半扭转姿势	
第六中心	眉心 视觉化、想像直 觉	松果腺区域、大 脑、神经系统、 眼、耳、鼻	智商和情商，感悟 力、想像力、创造力， 洞察力，知识经验的 开放程度，独立性， 现实性和信任感，自 我调节和评价，充分 的情感体验	海绵式 倒 V 字式	
第七中心	头的顶部。 超意识的最高状态 二重现实的 洞察力	头顶部或颅骨的 顶部，中枢神经 系统，大脑的上 部（大脑皮层）， 脑垂体	无私、信任人生历程 的能力，认清大局的 能力，归属感、道德 价值观、勇气。充沛 的精力，开明，意识 和知觉	抑郁、受限制、封闭心理、 心理变态倾向，焦虑、情 感疏远、慌乱、厌烦、冷 漠、学习和领悟能力低下 瘫痪、遗传机制紊乱、多 重硬化症、肌萎缩性脊髓 侧索硬化、阿尔采莫氏 病、骨质疏松	

孤独、自我中心、不信任感、悲观、缺乏同情心、郁郁寡欢。

第五个能量中心位于咽喉的底部，它与言语表达、意志力及创造力有关。这个区域的能量障碍会导致依赖感和药瘾问题、情感和思维意识缺乏、缺少决断能力。第六个能量中心与思维、想像力、直觉、理解力有关。这个能量中心位于眉心处。能量在这个中心的不平衡流动会导致注意力不能集中、学习能力下降、冷漠、缺乏想像力、反应迟钝。最后一个能量中心位于头或颅骨的顶部。这个能量系统和人的整体性、人与外界的相容性、现实洞察力及高水平的意识有关。这个能量中心周围的阻碍或不平衡会导致抑郁、受限制、封闭心理、焦虑、情感疏远、慌乱、厌烦、冷淡及学习与领悟能力的低下。

能量中心里能量的不平衡流动或阻塞与第二章中介绍的发展和依赖问题有关。瑜伽治疗师可通过了解求助者的日常生活类型来制定治疗方案。例如，求助者可能报告他们整天都在伏案工作、处理消息和做出决定，很少有时间进行体育锻炼。另外，瑜伽治疗师还可向求助者询问他们所关心的方面位于哪个能量中心周围，然后通过定位估计出他们感到不舒服（能量阻塞）的部位。这样瑜伽治疗师可以在常规的瑜伽姿势练习外，让求助者重点练习与堵塞的能量中心有关的瑜伽姿势。

很多咨询指导和心理治疗都是针对求助者的认知、情感和行为方面问题提供帮助，但求助者并不常有机会用自己的身体来配合治疗。而瑜伽治疗则对多种类型的求助者提供了完整的心理／躯体调整的方法。如：

- * 关节炎、癌症、慢性肺病、慢性疼痛、冠动脉疾病、疲劳
肠胃疾病、头痛、高血压、失眠患者
- * 缺乏自尊心的青少年
- * 生活在疗养所或生活扶助机构，或属于健康俱乐部的老年人

- * 药物滥用者或有毒瘾的人
- * 焦虑或恐惧症患者
- * 有精神创伤的人
- * 因为以从事脑力劳动为主, 缺少体育锻炼或身体运动而感到有压力的人
- * 曾经受到伤害和正遭受心理 / 情感折磨的人
- * 因为压力和持续烦躁而感到不平衡的心理卫生专业人员

Hatha 瑜伽的一个重要方面是加强心理躯体的联系。七个能量中心的冥想以及瑜伽姿势的练习促进了心理和躯体的联系。除了在第十七章中所介绍的冥想疗法以外, 我们下面介绍的冥想法是瑜伽治疗师用来把能量中心结合到瑜伽练习中去的方法。

闭上眼睛, 保持一个舒适的躺姿。做两次深呼吸, 放松身体, 用膈式呼吸。注意你的每一个能量中心。把注意力集中于第一个能量中心, 体验你自己与你的生命在身体的脊椎尾部这个区域达到融合, 通过呼吸把能量注入这个区域…体验你呼吸的能量进入了这个区域, 感受这个区域提供的安全感。在集中注意力于第二个能量中心时, 思考你的能力和控制力、性和创造力, 把注意力集中于耻骨、尾骶骨区域。体验能量并感受能量的品质, 放松地呼吸…把注意力集中于第三个能量中心…胸骨底部到肚脐之间的区域。思考你自身和你与社会的沟通。体验这个能量中心所提供的能量。注意第四个能量中心, 心脏区域, 体验这个能量中心带来的爱心、同情心和感应的能量, 如果感到能量不足或能量的品质不够完善的时候, 让呼吸的能量充实这个能量中心。把你的注意转移到咽喉的底部, 体验这个能量中心所提供的能量的数量和品质, 想像自己与他人的关系是在更高的境界中进行的, 想像你通过相互作用把积极的能量和思想传送给他人。把你的注意力转移到你的眉毛之间的区域, 这里产生你的领悟力、

智慧…如果你觉得被打乱了，把能量注入这个中心，需要它给你领悟和智慧。在你头顶部的第七个能量中心集中注意力于统一性；让能量来排除未完成的事物，为灵魂意识吸入能量。好，暂停一下…回顾每个能量中心。如果你觉得哪一个能量中心需要更多的能量，把你的注意力转移到这一个中心…有意识地呼吸，把优质的能量注入这个能量中心…体验你身体的相应部位所增加的能量活动。体验你全身所有能量中心的平衡和畅通。

这个冥想疗法可以与 Hatha 瑜伽姿势同时进行，也可以在做海绵姿势时使用。

Hatha 瑜伽的步骤

引入瑜伽首先是给求助者提供它的基本原理和概况。咨询者指导求助者如何做腹式呼吸或膈式呼吸，然后，在做特定的姿势时提供呼吸的原则。在姿势结束时，咨询者要指导求助者进行躯体扫描（见第十七章中的最后一节）；Hatha 瑜伽疗程结束于冥想（见第十七章中的第一部分）。

瑜伽原理

Benson 和 Stuart 对 Hatha 瑜伽原理做了如下说明：“Hatha 瑜伽给人提供了一种发展身体意识和产生放松反应的方法。Hatha 瑜伽很少受个人身体条件的约束。瑜伽练习除了一些明显的益处以外，还能帮助你健美体态、减轻肌肉的紧张，并养成对身体更敏锐的控制力。此外，在你每日坚持练习瑜伽后，它能使你的心理和肌肉组织保持一个‘休息状态’”。

Ornish 说：“瑜伽不仅仅是伸展肢体和呼吸的技能，Hatha 瑜伽的最终目的是，使对立的力量重新平衡，并体验均衡、平静，以及平衡双方背后的整合性。对我们大多数人来说，我们肌肉的

二重性——收缩和放松——是不平衡的，因为我们的肌肉是经常处于收缩和紧张状态的。体验内心的宁静和治疗的第一个步骤是使身体安静下来并放松。”

Kabat-Zinn 提出以下观点：“有很多理由可以说明瑜伽是一种很好的锻炼方式。从轻柔开始，它将对任何不同的身体状况都有益，而且，如果固定练习的话，它还能防止废用性萎缩……瑜伽还是一种全身的适应性运动，它增强了整个身体的力量和灵活性……也许，对瑜伽来说，最显著的事是在你做了以后，你所感受到的能量的增加……”

另一个有关 Hatha 瑜伽的简单的原理和观点是：“瑜伽是一个自我整合的过程，是一个心理获得平静的过程。瑜伽是一门灵魂的科学，是一项可使你从无序的循环中摆脱出来的技术。瑜伽加强、促进了冥想的过程。你做运动或姿势，但没有哪种姿势是绝对正确的。你不必用他人的标准来评估你的姿势，而要用你的觉察和意识。所谓的正确就是你在多大程度上体验到现实性、活力和整体性。除了一块铺了席子或地毯的地板和需穿舒适的服装之外，练习瑜伽不需要特殊的装备。你必须学着做膈式呼吸或腹式呼吸，也必须学做准备姿势，然后再学做 10 到 14 个瑜伽姿势。而且，你可以用躯体扫描和冥想技术。你觉得如何？还有什么问题吗？”

运动中的呼吸活动

瑜伽咨询者应当教会求助者做腹式呼吸或其他呼吸技术。Miller 为运动中的呼吸活动制定了几条一般性的准则：

1. 身体在呼气时轻柔地向前稍弯；
2. 吸气时，身体轻柔地向后仰；
3. 呼气时做转身运动更容易；
4. 吸气时做胸部和胸腔扩张的动作；

5. 呼气时做胸部和腹部区域压缩的动作;
6. 一般在姿势练习中, 要求呼气的比吸气时间要长1到1.5倍。

在身体运动和呼吸活动之间存在着相互作用。初练 Hatha 瑜伽的人, 在做姿势时常会有屏息现象。一般说来, 屏息的原则是, 在身体做伸展的动作时可出现吸气后屏息; 呼气后的屏息行为可以在身体的伸展动作或固定姿势时出现。正如 Miller 所建议的, 咨询者还应指导求助者在呼气时, 想像呼吸活动正沿着脊椎从尾骨向头顶移动; 吸气时则相反, 想像呼吸从头顶向脊椎的底部下降。最后要指导求助者与呼吸协同地进行所有这些运动, 呼气时做收腹、身体前曲或扭转身体的动作, 想像那些呼吸运动与躯体运动相协调; 吸气的同时做伸展、后仰或扩张身体的动作, 想像这些动作及与之相应的吸气活动。

准备动作

图18-5介绍了一套练习瑜伽姿势的准备动作, 准备动作使身心变得柔和, 为后面的姿势练习做准备。图18-5的13个动作中的每一个都结合了脊椎的不同运动, 以达到平衡感和加强心理与躯体之间的联系的效果。指示求助者从做4到6个动作开始, 要求尽量平缓地做这些动作。

这13个姿势从祈祷式开始(合十礼), 按顺时针方向依次做, 后仰站立式、前弯式、前弓式、斜平式、倒V字式、俯卧撑式、眼镜蛇式, 再做倒V字式, 重复前弓式、前弯式、后仰站立式, 最后是山式。

每个准备动作的图解、指导语及其益处见表18-5中列出。指导求助者想像进入每个姿势前的运动, 并想像伴随这些动作变化时的呼吸运动, 提醒求助者回忆前面介绍的呼吸活动的动作要领。准备动作里的姿势是预备动作, 其目的是热身。整套动作必须连

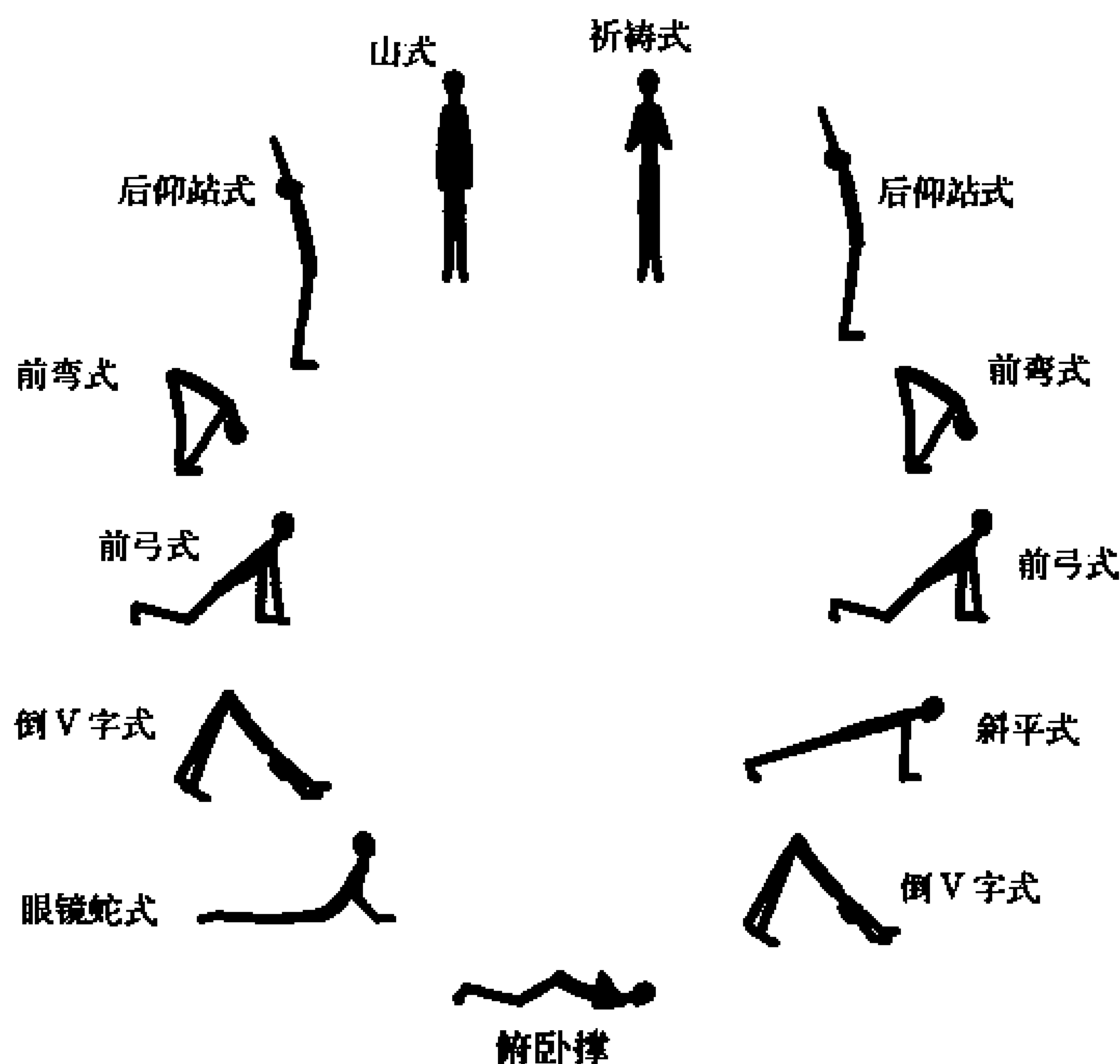


图 18-5 预备姿势

续完成。此后，使保持每个姿势的持续时间更长一些，以充分体验到每个动作的按摩、渗透和舒展效果。

Hatha 瑜伽姿势

表 18-6 列出了每一个瑜伽姿势的指导语、作用和姿势图解。14 种姿势包括：三角形姿势（手可触地）；左右两侧的半月形姿势；树形姿势（一只脚贴在另一条腿的小腿上或大腿内侧）；眼镜蛇姿势；压腿姿势；脊椎半扭转姿势（双侧进行）；前弯曲姿势；半肩倒立姿势；胎儿姿势；皮匠姿势；弓形姿势；半蝉姿势；全蝉姿势；最后是海绵姿势。

表 18-5 准备动作的姿势及其作用

	姿势动作要领	作用	
1		祈祷式——站直身体，两脚分开与肩齐宽，两臂肘部弯曲，双手合放胸前，头放正。集中注意力于呼吸。	发展腿部的力量以及骨盆、下背部的灵活性。
2		后仰站立式——吸气并从两侧把双臂举过头顶。头部抬起向上注视双手。身体后仰，后仰幅度以感觉舒适为宜。	舒展胸部，并能刺激神经系统，增强活力。
3		前弯式——使头部置于两臂之间向前弯腰；保持背部挺直。把手放在脚上，或触及踝部，或悬垂双手。低下头部。	能使神经系统保持平静，使心灵安静。如果踝腱绷得过紧，或有下背部不适感，可以选择两脚分得更开的、变化了的前弯式。
4		前弓式——右脚往后退一大步，膝部贴地，手指或手掌平放在地毯或地板上。左脚在两手之间，左膝贴着左胸。眼睛往上看。	有利于增强下背部和腿部的力量和灵活性。
5		斜平式——左腿后移，脚趾顶地，双臂伸直。使头与身体保持在一条直线上。	增强肩膀、手臂和脚的力量。

(待续)

6



倒 V 字式——双脚向双手移近，抬高臀部使之形成一个三角形。伸展背脊时，从臀部起沿背部保持一条直线，脚跟尽量往下压使腿伸直，双臂靠在耳边，眼睛向后看着脚。

伸展脊柱和肩。通过伸展和收缩踝旁腱、胫、小腿肌肉和四头肌来加强膝部力量。被认为是最有效的健身姿势之一。

7



俯卧撑式——俯下身体，使膝部、胸、下巴或额部触及地面，抬高髋部，手掌垫在肩下，掌心朝下。

使下背部、腹部和髋部得到锻炼。

8



眼镜蛇式——髋部贴地，向后收紧头、颈和胸部，微微弯曲肘部并往内收，使体重集中在背上，脚趾平放在地上。

锻炼背部肌肉、脊椎和头部，舒展胸部，能减轻背痛、便秘，促进空气吸入。

9



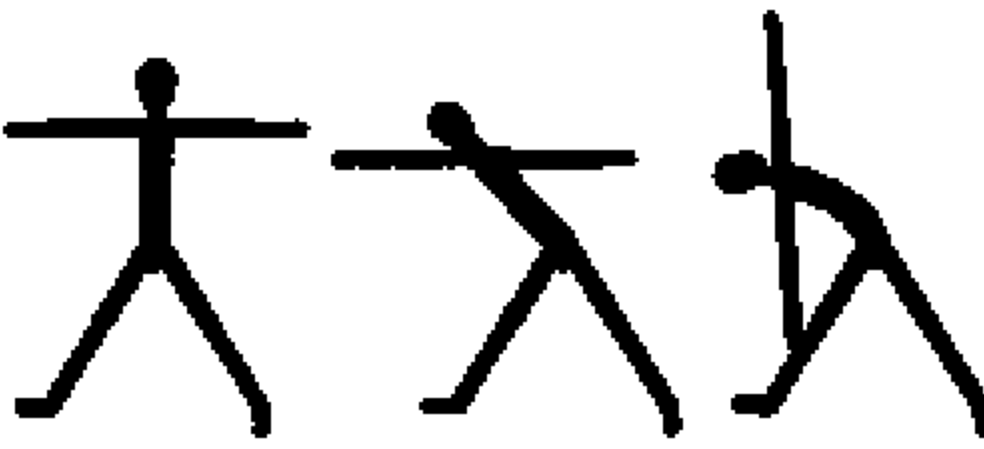
倒 V 字式——脚趾顶地，抬高臀部使身体形成一个三角形。把整个身体往上、往后推，形成一个倒 V 形姿势。脚跟下压，使腿伸直，从臀部起沿背、肩、手臂保持在一条直线上，头部朝后看着脚。确定你的腿由于脚后跟下压而已经伸直。两脚平行放置，相距 8 到 12 英寸，与你的髋骨在一条直线上；两手以同样的距离放置，与

同第六个姿势。

(待续)

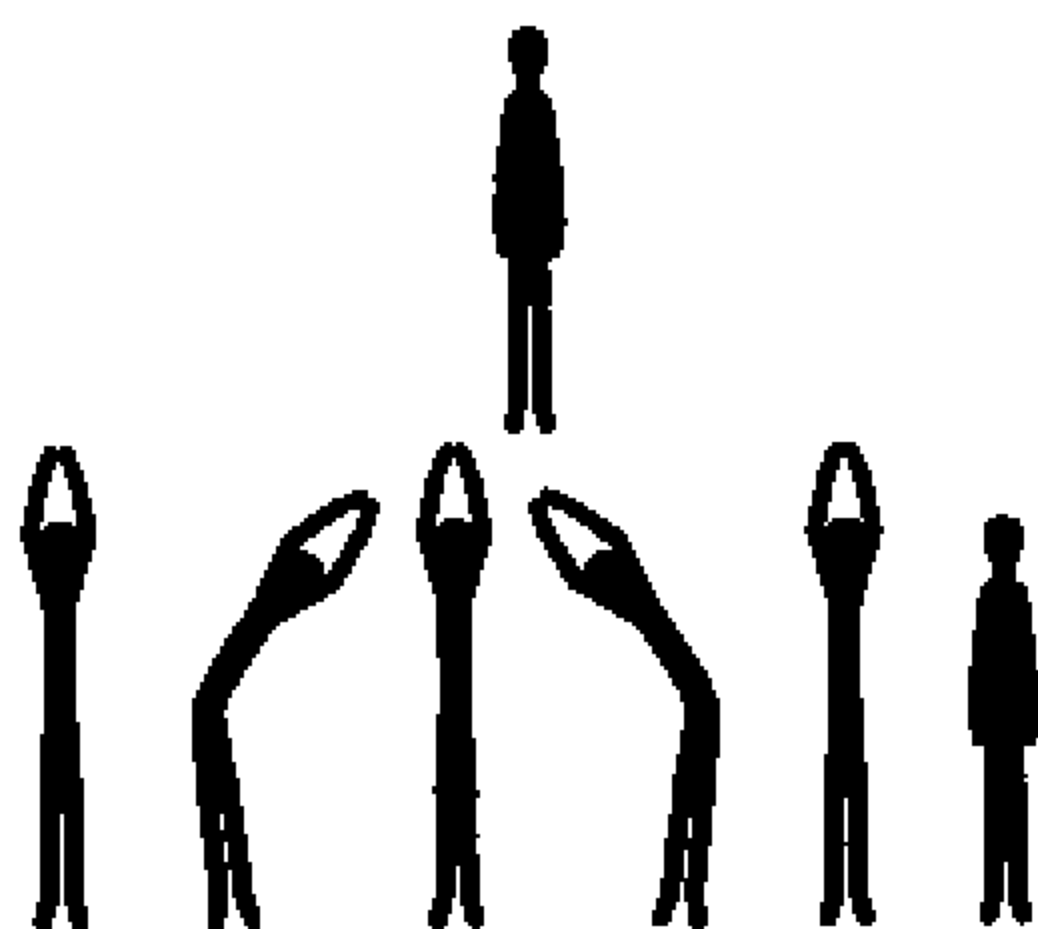
		肩平齐,手掌平放、手指分开。眼睛看着肚脐。	
10		前弓式——保持前一个姿势动作,右脚前移至双手之间,膝对着右肩,左膝放在地上。	同第四个姿势。
11		前弯式——把左脚也移到两手之间,膝部伸直,头靠向膝部。	同第三个姿势。
12		后仰站立式——自腰部仰身——保持背直——形成直立姿势。吸气并从体侧把手臂举过头顶,身体后仰,眼看双手。后仰幅度以感到舒适为宜。	同第二个姿势。
13		山式——从两侧放低双臂,站直身体,两腿分开与肩同宽。闭上眼睛并集中注意力于呼吸。	发展腿部的力量以及下背部与髋的灵活性。

表 18-6 Hatha 瑜伽姿势

姿势图解	姿势的指导语和作用
三角形姿势 	姿势指导: 保持站立姿势, 张开双脚, 右脚脚面与身体所在平面成90度角, 左脚脚面与身体所在平面成45度角, 左脚弓与右脚跟保持在同一直线上; 伸开手臂使之与地面平行; 两个脚踝位于手腕的正下方, 如, 左脚踝在左手腕的正下方。在呼气时, 右臂向右腿方向滑落, 同时左臂向上举起; 向右侧弯腰; 转头向上看着你的左手。保持这个姿势约 30 秒

(待续)

半月姿势



钟。你可以逐渐把这个时间延长到一分钟。每一侧做两次。

作用：在三角形姿势中，身体一侧的腹腔得到伸展，按摩了肝、结肠、胃、脾和肾；还按摩了背部肌肉和膈肌。

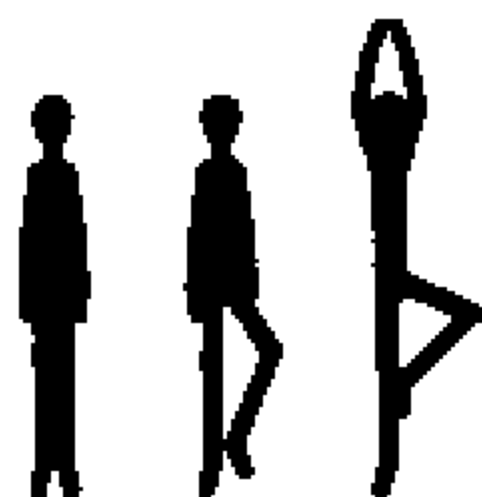
姿势指导：先取山式，两脚并拢，手臂放在身体两侧；先花两分钟时间用膈式呼吸使心理和身体放松下来。收缩股四头肌，收紧臀部；往上向内收紧腹部。眼睛向前平视并注视前方某一点。再做一次深呼吸，使你的意识遍布全身。开始做这个姿势。吸气，把手臂从两侧举过头顶；在头顶上方两手合拢，十指交叉叠放在一起，手和手指处在与身体平面之上的位置；呼气并将身体向右侧弯曲。尽可能拉长左侧肋弓下缘，体验身体左侧外弯部分的紧张感觉。吸气时回复到原来的位置。再吸入一口气，向左侧弯曲身体，体验上述的感觉后再回复到中心的位置。你可以做两个或更多的回合，在每一个回合中身体两侧各做一次。也可以闭上眼睛，想像身体的运动和呼吸活动。

作用：半月形姿势使脊椎得到侧弯活动；手臂上举动作能锻炼肩关节的灵活性，它还能增强手臂、躯干和腹部肌肉组织的力量；半月姿势对肾、肝、脾和消化系统功能的改善也有帮助。

树形姿势

姿势指导：取山形式，两眼平视并注视前方某一点；把另一条腿轻轻地抬起，

(待续)



把体重移到站立的腿上，保持这个姿势呼吸三次。然后单腿站立，弯曲另一条腿的膝部，脚底贴在站立腿的小腿上或大腿内侧。吸气，并把双臂举过头顶。可以保持两手合拢，十指交叉叠放在一起的姿势。保持这个姿势约30秒钟左右，别忘了呼吸活动。然后换身体另一侧再做。每一侧做二到四次。

作用：树形姿势能增强双腿的力量；促进注意力的集中；增加身体平衡能力和呼吸能力。

眼镜蛇姿势



姿势指导：俯卧，胸部和下颌着地，把手放在肩下，手指朝前。呼气时，保持髋部固着在地面，脚尖着地，手指或手掌放在肩下。现在呼气，胸部抬离地面，头部跟着抬起。慢慢呼气并尽量伸展整个脊椎。注意不要靠手的力量向上撑，而是用你的脊椎和下背部的力量来完成仰动作。逐渐地使胸部上升，一节接一节地弓起椎骨。头轻轻地后仰。保持这个姿势同时做呼吸。好，放松，并缓慢地放下胸部，接着下巴着地；头部一侧贴地。把手从肩底抽出，放在身体的两侧。体验放松的感觉，并仔细想身体体验到的感觉。重复这个姿势。

作用：这个姿势使背部肌肉、脊椎和头部的神经得到锻炼；扩展了胸部，并能减轻背痛和便秘。

压腿姿势

姿势指导：仰卧，手臂上举过顶。双手一起握紧，同时保持手臂举在头顶上。

(待续)



现在，放下手臂，弯曲右腿，右脚底对着左腿大腿的内上侧，脚跟内压。手臂上举，双手握紧，弯腰使身体折向左腿的上方。双手抓住两腿尽可能地往下压。可能的话，最好能做到双手握住大脚趾。脸朝下向膝部靠拢，保持腿部伸直。如果做不到，可以稍微弯曲膝部。然后起来，双手握紧，上身尽可能直地坐起。换另一条腿再做这个动作。每一条腿做二到三次。头部靠膝的姿势保持约 10 秒钟。

作用：这个姿势能增强体质，提高身体的能量水平。

前弓姿势



姿势指导：仰卧，手臂举过头顶，用心想像身体的运动和呼吸活动。现在双手一起握紧，呼气的同时坐起。坐起时，尽量保持背部挺直，双臂仍举在头的上方。然后身体弯向腿的上方，尽可能地往下弯。试着用手抓大脚趾，最好能做到把脸贴在膝盖上。同样尽量不要使膝部弯曲，如果无法做到，可以稍微弯曲膝部。试着用这个姿势来放松，而不要有紧张感。这个姿势做三到五次，每次大约保持 10 秒钟。

作用：这个姿势几乎伸展和锻炼了所有身体后部的肌肉，增强了腹部内脏器官的功能。

半肩倒立姿势

姿势指导：这是一个倒立的健身姿势。首先，仰卧，两手掌心朝下放在身体的两侧。呼气时，两腿抬高使之与身体成

(待续)



90度角；膝部尽量伸直，弯曲腰部。手掌用力把双腿轻轻地摆到头的上方，用手撑住背部。把手掌的底部放在髌部靠后位置，手指放在髌侧。上臂贴地平放，前臂折起与地垂直。用手臂支撑骨盆，两肘部在背下相互靠近，使胸部尽量靠近下巴（如果这样做感到不太舒适，可以用一块小软垫或折叠的席子垫在肩下，使头部能放在地板上）。注意弯曲腿部，使脚在头的正上方或越过正上方。保持这个姿势尽可能长的时间，时间以感到舒适为宜。

作用：半肩倒立姿势能增强甲状腺的机能，调节新陈代谢和促进血液循环。

半蝉姿势



姿势指导：面朝下俯卧，把手塞到身体底下，双肘靠拢，使手掌能贴在大腿的上方。伸直腿，足尖触地。记住，在我向你做姿势指导和你自己做这项运动时，用心想像自己的姿势。好，慢慢抬高右腿，保持腕关节放在髌骨处。保持右腿抬起，做两次呼吸。然后慢慢放下右腿，再呼吸两次后抬高左腿。每条腿这样做两次，每次抬腿时间大约10秒钟。

作用：半蝉姿势和全蝉姿势能使背部、髌部和腹部得到锻炼，促进交感神经系统和肝脏的功能。

全蝉姿势



姿势指导：起始式与半蝉姿势相同，不过，这一次不是抬高一条腿，而是两条腿同时抬高。全蝉姿势比半蝉姿势相对

（待续）

要求更高一些。

作用：与半蝉姿势相同。

弓形姿势



姿势指导：俯卧，下巴或额部着地，弯曲膝部并用手抓住足踝部；在做这些动作时想像自己的姿势。吸气时，抬高头，胸和大腿抬高，弓起背部，仅腹部着地，保持手臂伸直。要求稍低一些的话，可以不抬高胸部或抬高胸部而让大腿仍然着地。做这个姿势三到六次，每次保持这个姿势大约 10 秒钟，在以后的练习中，逐渐延长到一分钟。

作用：除了与眼镜蛇姿势和半蝉、全蝉姿势相同的作用以外，还有减少腹部脂肪和增强胰腺功能的作用。它还能减轻慢性便秘，增强肝、肾、脾、胃和肠的功能。能增强背部和大腿的力量，锻炼脊柱，增强身体和活力。

脊椎半扭转姿势



姿势指导：保持坐姿。抬膝靠胸，脚底朝下；把右脚放在左腿的外侧——膝部或小腿的外侧。右手放在臀后地上，手指朝远离身体的方向。左臂放在右膝的外侧，眼睛从右肩上方注视远方。呼气时，把脊椎往右扭转。保持这个姿势做两次呼吸，然后在吸气中放松。以同一姿势向另一侧扭转。保持 30 秒钟，逐渐延长到三分钟。

作用：这个姿势有利于增强肝、脾、肾和肾上腺的功能；增强交感神经系统的机能；增强背部的深层和表层肌肉的力量。

(待续)

胎儿姿势



姿势指导: 取跪姿, 用手和膝支撑身体。手离开地面, 上身后挺坐在脚上, 想像自己的姿势。呼气时, 前额着地, 手臂朝后放在身体的两侧或向前伸直。轻轻地做呼吸。记住, 这是一个放松的、休息的姿势。

作用: 这个姿势增强了背部、髋关节、膝和踝的灵活性。这是一个非常有效的休息姿势。它能平衡植物神经系统和促进消化作用; 它还有助于缓解头痛和胃疼。这是一个平静、放松的姿势。

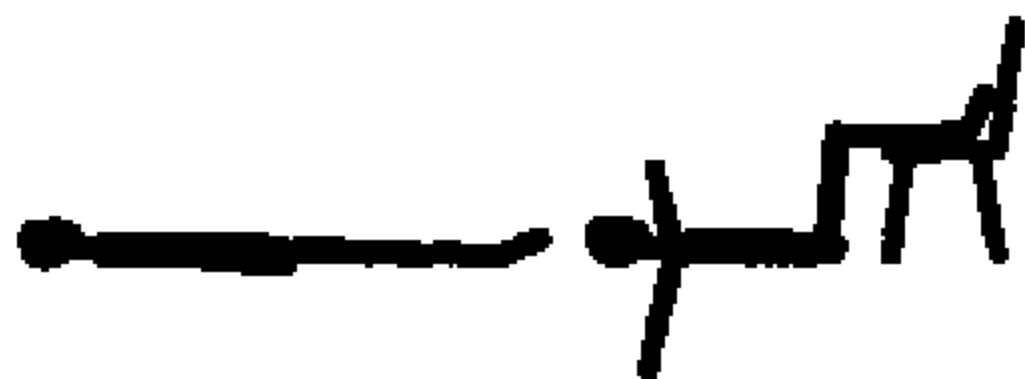
皮匠姿势



姿势指导: 坐在地上, 挺直背部, 膝部弯曲, 两脚并在一起。呼气时使大腿外撇, 同时身体向上向前伸展, 与地面保持倾斜。皮匠姿势是最古老的瑜伽姿势之一。

作用: 做大腿在髋关节处的外转有助于改善关节的僵直和不灵活。这是瑜伽的基础姿势之一。

海绵姿势



姿势指导: 仰卧, 双腿伸直, 脚转向两边, 手臂和手放在身体的两侧, 但不要贴到身体上, 掌心朝上。注意使背部尽量放平。腰部稍稍抬高一些, 形成一个小拱形。呼吸并体验腹部如潮水般的上升和下落。这个姿势的一种变化是, 把脚和小腿搁在椅子上, 使大腿与身体垂直, 而坐骨或尾骨则平放在地上, 两臂和双手往外伸直。

作用: 海绵姿势促进觉醒和带来放松。将注意力集中于呼吸活动。在这个姿势中, 我们必须进行躯体的审视和冥想。

同意做 Hatha 瑜伽练习

如果把求助者委托给一位瑜伽治疗师，你应该为求助者起草一份他同意与治疗师配合的协议书。该协议书与前面提到的同意做呼吸练习的协议相类似。瑜伽治疗师可以选用你提供的文件或他已准备好的协议书文件。这是为了保护求助者的权益起见。

Hatha 瑜伽范例

在这个范例中，我们介绍瑜伽治疗师是如何用 Hatha 瑜伽来为 Yoshi 减轻他的心理压力的。先介绍 Hatha 瑜伽的基本原理，确定 Yoshi 的保健医生已经同意他参加瑜伽练习。然后指导 Yoshi 做准备动作。告诉他在做姿势时有关的呼吸活动，指导他做表 18-6 中所介绍的 14 瑜伽姿势和躯体扫描检查，指导求助者使用前面介绍的冥想技术，最后布置有关家庭练习。

1. 基本原理

瑜伽治疗师给 Yoshi 解释有关的原理：很多理由表明瑜伽是一种有效的练习方式，对任何身体状况水平的人都适用，并且，有规律的练习能防止废用性萎缩。瑜伽还是一项全身适应性运动，除了能减轻压力和帮助治疗溃疡外，它还能增强你全身的力量和灵活性。这种练习极大地促进了身体内部的运动，通过伸展肢体渗透、强化肌肉和内脏，它所带来的治疗效果大大超过了一般身体锻炼的效果。渗透是指细胞在富含氧气的血液中得到营养的补给。瑜伽使心理和躯体紧密地结合在一起。

瑜伽治疗师确认 Yoshi 愿意进行瑜伽练习后，回答了他所提出的问题。另外，瑜伽治疗师还要确证 Yoshi 的医生已经同意他来进行瑜伽练习。

2. 13 个准备动作和衣着的建议

给 Yoshi 示范 13 个准备动作姿势（见图 18-5）。Yoshi 从祈祷式开始，按顺时针方向继续直至山式。在 Yoshi 的练习中，向他指出每一个姿势的动作要领及其作用。告诉他在练习时不要穿鞋，要穿舒适的衣服。

3. 介绍做准备动作和 Hatha 瑜伽姿势时的呼吸活动

在 Yoshi 做准备动作和 Hatha 瑜伽姿势练习时，给他提出呼吸的原则。瑜伽治疗师可以这样说：“身体在前弯时流畅地呼气，吸气时身体做后仰动作，呼气时做扭身动作。”提醒 Yoshi 不必现在就记住所有这些，在做每一个姿势时，咨询者会指导他做相关的呼吸活动。呼吸活动的指导语是这样的：吸气时做扩胸的动作；呼气时胸部和腹部往内收。一般地，呼气的的时间大约比吸气的时间长 1 到 1.5 倍。在 Yoshi 开始做每个姿势后，提醒他吸气动作和呼气动作。在开始做姿势练习后，告诉他要柔和地呼吸，用他平常的速度吸气和呼气。

4. 每个准备动作的作用及想像的指导

告诉 Yoshi 准备动作的目的是热身，为随后的姿势练习做准备。告诉他要缓慢开始，在两个姿势之间不要中断，连续地完成准备动作。指示 Yoshi 在他做这些姿势时，用“心”来想像每个姿势和他的呼吸活动。从祈祷式开始，把表 18-5 所列的每个姿势的指导语告诉 Yoshi（详见表 18-5）。

要 Yoshi 在进行家庭练习时先做三轮准备动作，然后逐渐增加到十轮，但不要勉强。“这套动作的作用是热身。如果你能迅速完成这套动作，你将会感到身心敏捷、精力充沛。在缓慢的速度下做完这套动作，能使你的身心趋于平静”。

5. 关于 Hatha 瑜伽动作姿势、作用、呼吸活动和想像的指导

告诉 Yoshi 表 18-6 所示的 Hatha 瑜伽各个姿势的作用。要求他注意运动中的呼吸规则，并在他做每个姿势时用心想像这些姿势。还要告诉他，“有些姿势做起来有一定难度，但重要的是去做这些动作，而不要想着去完成什么”。

对每个姿势的指导语详见表 18-6。

6. 躯体扫描指导语

在 Yoshi 做海绵姿势时，瑜伽咨询者应提醒他进行躯体扫描。一般情况下，求助者可以用 Patel 提出的“深部肌肉的放松法”或 LePage 提出的“身体意识放松法”。这两种躯体扫描法的指导语都已经在第十七章中介绍过。

7. 冥想的指导语

躯体扫描之后，指示 Yoshi 做冥想练习。一般情况下，第十七章中所描述的三个冥想步骤都可使用。可以选择求助者和瑜伽治疗师感觉最适合的一种来使用。

8. 家庭作业

指示 Yoshi 选择一个练习瑜伽的地方，这个地方应当有足够大的空间，并且没有分散注意力的杂物。所选择的地方应有良好的通风条件和适宜的温度。做瑜伽姿势时要穿舒适的衣服，不要穿鞋子。每天选择固定的时间段来练习，而且不要随便中断瑜伽的练习。提醒他在做每个瑜伽姿势时，都应注意自己的呼吸活动，并想像每一个特定动作的身体姿势。如果 Yoshi 想做一个瑜伽练习的记录，他可以用在第二十章中所介绍的方式来记录，以此作

为瑜伽准备动作和姿势练习的自我检测。

通过瑜伽治疗师的指导练习，可使 Yoshi 从多方面获益。针对他的具体问题，瑜伽练习应能使他体验到更多的精神放松。经过 Hatha 瑜伽练习，他的溃疡引起的不适也会有所减轻，甚至能痊愈。另外，这些姿势、呼吸活动及与 Hatha 瑜伽相关的冥想还会使 Yoshi 产生对生命和生活更深刻的见解。他体内的能量中心里将获得更多的能量。并增强他的心血管、内分泌和免疫系统的功能，增强躯体和精神的力量和灵活性。今后他会感到更加精力充沛、充满活力。

学习练习活动 50 / 准备动作和 Hatha 瑜伽

如果你有什么顾虑或正在进行治疗，在开始练习以前请与你的医生协商。（注意：如果你不能做这些姿势，你可以仅仅想像做每个准备动作和 Hatha 瑜伽的姿势，同时回顾各个姿势对人体的作用）。选择一个不受干扰的地点和时间，以及足够大的房间来做这些练习。穿舒适的衣服，不要穿鞋子和短袜。另外，如果可能的话，可在专业瑜伽治疗师的指导下做这些姿势，保证每个姿势的得正确。

你也许会发现，用磁带录下每个姿势的指导语会很有帮助。做准备动作时，在两个姿势之间不要有太多的停顿，因为你是要预热身体。然后做 Hatha 瑜伽姿势，并注意保持身体的舒适。对每个姿势来说，在练习过程中仔细检查自己的姿势，并进行想像，这比快速做完所有姿势更重要。你也许更愿意从五到七个姿势开始，然后把这个数目逐渐增加，以进行更多的练习。在你做这些姿势时，别忘了呼吸活动。另外，在你做每个姿势时，还要想像姿势，并且思考它们的作用。试着制定一个瑜伽练习的日常计划表，坚持练习四到六周，以获得最佳的效果。建立一个练习日志，

简要记录每次练习的情况。参考第二十章中所介绍的准备动作和 Hatha 瑜伽姿势的自我调节图也许会有所帮助。

本章总结

我们在本章叙述了有意识觉察自己呼吸深度的方法，并介绍了五种呼吸练习：膈式呼吸，间断呼吸，单鼻孔呼吸，交替鼻孔呼吸和净化式呼吸。我们还介绍了 13 种瑜伽热身姿势和 14 种 Hatha 瑜伽姿势。我们介绍 Hatha 瑜伽的目的是：1) 提高读者对躯体治疗有效性的认识，并了解能从瑜伽治疗师那里获益的求助者类型；2) 提供一些做咨询者应具备的基本知识，包括：做特定姿势过程中的呼吸指导，关于七个能量中心的介绍及瑜伽治疗师如何利用对这些能量中心的描述，单独使用或结合瑜伽姿势的冥想练习，做 Hatha 瑜伽必不可少的呼吸练习、冥想和躯体扫描的使用，以及一小部分人做呼吸练习和瑜伽姿势时的禁忌症和不良反应。

如果你要指导他人进行一种或更多的呼吸练习，要先获得求助者的同意。如果求助者有问题，怀疑瑜伽姿势是否适合自己，就要求求助者与自己的保健医生协商。咨询者不能指导求助者进行瑜伽练习，而只能把求助者委托给专业瑜伽治疗师。但在此之前，你可以给求助者提供一份由瑜伽治疗师起草的协议书。还有，在开始练习瑜伽之前，你应让求助者与医生协商确定。而且，在你把每个求助者介绍给瑜伽治疗师以前，应了解他是否有呼吸练习或瑜伽练习的禁忌症。

本章中所介绍的干预措施，以前曾被认为是新奇古怪而无法接受，而今已普遍为许多精神和生理卫生的从业者当做治疗的补充手段。这里介绍的呼吸练习和瑜伽姿势能加强自我调节、提高意识和加强身心联系。本章介绍的两种方法可以作为前面介绍的

各种疗法的补充，也可与将在下章中叙述的系统脱敏疗法和眼动脱敏疗法一起使用。

学习评判

第一部分

本章目标之一是要你通过使用表18-2第一列中所示的呼吸意识练习，来评估你自己的呼吸活动。看看你是否能够凭记忆做这项练习。用表18-2来确定你是否能做出所有的步骤。

第二部分

目标之二是要你示范膈式呼吸的步骤。用本章结尾的检测清单来评估你的成绩。

第三部分

目标之三是要你示范交替鼻孔呼吸的步骤。用本章结尾的检测清单来评估你的成绩。

第四部分

目标之四要求你描述各个瑜伽准备姿势和Hatha瑜伽姿势的作用。看你是否能画出每个姿势的草图。用本章结尾处的检测清单评估你对姿势作用的叙述。用表18-5和表18-6来检查你想像瑜伽准备姿势和Hatha瑜伽姿势的准确性。

第五部分

目标之五要求你描述在身体运动时的呼吸规则。用本章的内容来检查你的答案。

第六部分

目标之六要求你描述每一个能量中心的位置，以及与其相关的一个情感、认知属性。用表18-4来检验你的答案。

膈式呼吸检测清单

I. 基本原理

- _____ 1. 如果你有疑虑,请在开始练习之前与你的保健医生协商确定。
- _____ 2. 思考腹式呼吸的目的和益处。

II. 舒适的位置(长沙发椅)

- _____ 3. 保持舒适的躺姿,这样能体验和感受到腹部的运动。
- _____ 4. 通过你的鼻孔呼吸,注意你的呼吸活动。
- _____ 5. 在你吸气时,注意感受空气的凉度,而在呼气时注意感受空气暖和了多少。

III. 手的位置;想像膈肌的运动,并用手模拟膈肌的运动

- _____ 6. 弯曲手臂,把大拇指放在肋弓的下缘,其余的手指与身体垂直放置。
- _____ 7. 想像膈肌的运动。在你吸气时,膈肌收缩并往下拉;当你呼气时,膈肌上抬,同时空气排出体外。
- _____ 8. 用你的手指模拟膈肌的运动。在吸气时,手指往外伸直,呼气时弯曲手指并形成球面状。

IV. 膈式呼吸

- _____ 9. 不加手势运动继续做膈式呼吸,把手放在大腿上或身体的两侧。
- _____ 10. 在你做膈式呼吸时,想像膈肌的运动,腹部象潮水般的起伏。

V. 坚持每日练习并在应激状态下使用

- _____ 11. 选择一周中每日练习的时间和地点。
- _____ 12. 当你处在应激状态下时做膈式呼吸。

交替鼻孔呼吸检测清单

I. 基本原理

- _____ 1. 回顾交替鼻孔呼吸的目的和益处。如果你对做这项练习有疑

虑，与你的保健医生协商确定。

_____ 2. 简略回顾整个练习过程。

II. 位置和呼吸活动

_____ 3. 选择一个舒适的坐姿，保持背部挺直。

_____ 4. 平静地做膈式呼吸。

III. 手形

_____ 5. 用利势手轻轻握拳，伸出大拇指、无名指和小拇指，另两个手指留在手掌里。

IV. 用手形堵住右鼻孔

_____ 6. 把手形放在鼻子前，通过两个鼻孔吸气，然后用手形堵住右鼻孔。确定鼻孔已经完全堵住，缓慢地通过左鼻孔呼气。

V. 交替鼻孔

_____ 7. 从左鼻孔吸气，然后用手形堵住左鼻孔，从右鼻孔中呼出。继续做交替鼻孔呼吸。

VI. 呼气 / 吸气比例

_____ 8. 在你适应了交替鼻孔呼吸以后，试着使你的呼气时间是吸气时间的两倍。

VII. 呼吸练习的时间和想像

_____ 9. 交替鼻孔呼吸三到四分钟。

_____ 10. 在你呼吸的时候想像这项活动。

VIII. 每日练习

_____ 11. 确定练习的时间和安静而不受干扰的地点。把交替鼻孔呼吸当做从应激状态下恢复放松状态的方法来使用。如果有可能，写下你每日练习的感受。

Hatha 瑜伽检测清单

I. 基本原理

_____ 1. 给出几个你练习瑜伽的目的。你已从你的保健医生那里得到

了对你做瑜伽练习的许可。

- _____ 2. 瑜伽的四个部分：预备活动、呼吸活动、做并想像这些姿势和冥想。

II. 衣着、地点和时间

- _____ 3. 穿舒适的衣服。
- _____ 4. 选择一个不受干扰的地点。
- _____ 5. 选定每天练习瑜伽的固定时间。

III. 做姿势过程中的呼吸活动

- _____ 6. 在做前弓动作时呼气。
- _____ 7. 在做后仰动作时吸气。
- _____ 8. 在做转身动作时呼气。
- _____ 9. 在做扩胸动作时吸气。
- _____ 10. 在做压缩胸部和腹部的动作时呼气。
- _____ 11. 通常，在姿势练习过程中，呼气过程的时间比吸气过程的时间长 1 到 1.5 倍。

IV. 准备姿势及其作用（按呼吸活动和想像的指导做这些姿势）

- _____ 12. 祈祷式：起手式。
- _____ 13. 后仰站立式：伸展胸部；刺激神经系统。
- _____ 14. 前弯式：松弛神经系统；使心灵平静。
- _____ 15. 前弓式：增强下背部和腿的力量和灵活性。
- _____ 16. 斜平式：增强肩、臂和腿的力量。
- _____ 17. 倒 V 字式：使人精力充沛；伸展脊椎和肩膀。
- _____ 18. 俯卧撑式：使下背部、腹部和骨盆区域得到锻炼。
- _____ 19. 眼镜蛇式：锻炼背部肌肉、脊椎和头部神经；伸展胸部。
- _____ 20. 倒 V 字式：见 17。
- _____ 21. 前弓式：见 15。
- _____ 22. 前弯式：见 14。
- _____ 23. 后仰站立式：见 13。

_____ 24. 山式：结束式。

V. Hatha 瑜伽姿势和作用（按呼吸活动和想像的指导做这些姿势）

_____ 25. 三角形姿势——使身体一侧的腹腔得到伸展，按摩了肝、结肠、胃、脾和肾；还按摩了肋间肌和膈肌。

_____ 26. 半月形姿势——半月形姿势为脊椎提供了侧弯动作；手臂举过头顶的动作能锻炼肩关节的灵活性；它能增强手臂、躯干和腹部肌肉组织的力量；有利于改善肾、肝、脾和消化系统的功能。

_____ 27. 树形姿势——增强双腿的力量；促进注意力的集中；增加身体平衡能力和呼吸能力。

_____ 28. 眼镜蛇姿势——使背部肌肉、脊椎和头部的神经得到锻炼；扩展了胸部，并能减轻背痛和便秘。

_____ 29. 压腿姿势——增强体质，提高身体的能量水平。

_____ 30. 前弯曲姿势——几乎伸展和锻炼了所有身体后部的肌肉，增强了腹部内脏器官的功能。

_____ 31. 半肩倒立姿势——增强甲状腺的机能；调节新陈代谢和促进血液循环。

_____ 32. 半蝉姿势——使背部、髋部和腹部得到锻炼，促进交感神经系统和肝脏的功能。

_____ 33. 全蝉姿势——与半蝉姿势相同。

_____ 34. 弓形姿势——减少腹部脂肪和增强胰腺功能；它还能减轻慢性便秘，增强肝、肾、脾、胃和肠的功能；能增强背部和大腿的力量，锻炼脊椎，增强身体活力。

_____ 35. 脊椎半扭转姿势——增强肝、脾、肾和肾上腺的功能；增强交感神经系统的机能；增强背部的深层和表层肌肉的力量。

_____ 36. 胎儿姿势——增强了背部、髋关节、膝和踝的灵活性；这是一个非常有效的休息姿势，它能平衡植物神经系统和促进消化作用；它还有助于缓解头痛和胃疼，是一个平静、放松的姿势。

- _____ 37. 皮匠姿势——伸展并放松大腿和髋关节。
- _____ 38. 海绵姿势——促进觉醒并带来放松，将注意力集中于呼吸活动。

VI. 躯体扫描

- _____ 39. 用在第十七章中介绍的两种指导中的一种来审视躯体。

VII. 冥想

- _____ 40. 用在第十七章中介绍的三种冥想中的任何一种，或本章中介绍的能量中心冥想。

VII. 每日练习

- _____ 41. 制定一个每日练习 Hatha 瑜伽的计划，包括呼吸指导细则、准备动作、每个姿势的想像、躯体审视和冥想。你可以使用在第二十章中介绍的图表。
-

参考文献

- Baxter, K. (1994). *Pain release*. (Videotape). Lenox, Ma.: Kripalu Center.
- Bell, L., & Seyfer, E. (1982). *Gentle yoga*. Berkeley, CA: Celestial Arts.
- Birch, B. B. (1995). *Power yoga*. New York: Fireside.
- Brennan, B. A. (1987). *Hands of light: A guide to healing through the human energy field*. New York: Bantam.
- Christensen, A. (1987). *The American Yoga Association beginner's manual*. New York: Fireside.
- Cohen, K. (1997). *Healthy breathing*. (Audio tape). Boulder, CO: Sounds True.
- Dacher, E. S. (1996). *Whole healing*. New York: Dutton.
- Farhi, D. (1996). *The breathing book*. New York: Holt.
- Fried, R. (1990). *The breathing connection*. New York: Plenum.
- Fried, R. (1993). The role of respiration in stress and stress

- control: Toward a theory of stress as a hypoxic phenomenon. In P. M. Lehrer & R. L. Woolfolk (Eds.), *Principles and practice of stress management* (2nd ed., pp. 301–331). New York: Guilford.
- Feuerstein, G., & Bodian, S. (Eds.). (1993). *Living yoga*. New York: Jeremy P. Tarcher/Perigee Books.
- Goleman, D., & Gurin, J. (1993). *Mind/body medicine*. New York: Consumer Report Books.
- Hendricks, G. (1995). *Conscious breathing*. New York: Bantam.
- Iyengar, B. K. S. (1988). *The tree of yoga*. Boston: Shambhala.
- Joy, W. B. (1979). *Joy's way*. New York: Tarcher/Putnam.
- Karagulia, S., & Kunz, D. (1989). *The chakras and the human energy field*. London: Quest Books.
- Kent, H. (1993). *Yoga made easy*. Allentown, PA: The People's Medical Society.
- Kroner, H., Hebing, G., Van-Rijn-Kalkmann, U., & Frenzel, A. (1995). The management of chronic tinnitus: Comparison of a cognitive-behavioral group training with yoga. *Journal of Psychosomatic Research*, 39, 153–165.
- Lidell, L., Rabinovitch, N., & Rabinovitch, G. (1983). *The Sivananda companion to yoga*. New York: Fireside.
- Monro, R., Ghosh, A. K., & Kalish, D. (1989). *Yoga research bibliography: Scientific studies on yoga and meditation*. Cambridge, England: Yoga Biomedical Trust.
- Myss, C. (1996a). *Energy anatomy: The science of personal power, spirituality, and health*. Audio tapes. Boulder, CO: Sounds True Audio.
- Myss, C. (1996b). *Anatomy of the spirit: The seven stages of power and healing*. New York: Harmony Books.
- Patel, C. (1993). Yoga-based therapy. In P. M. Lehrer & R. L. Woolfolk (Eds.), *Principles and practice of stress man-*

- agement* (2nd ed., pp. 89–137). New York: Guilford.
- Pierce, M. D., & Pierce, M. G. (1996). *Yoga for your life*. Portland, OR: Rudra Press.
- Radha, S. S. (1987). *Hatha yoga*. Spokane, WA: Timeless Books.
- Rama, S., Ballentine, R., & Ajaya, S. (1974). *Yoga and psychotherapy*. Honesdale, PA: The Himalayan International Institute of Yoga Science and Philosophy.
- Steward, M. (1994). *Yoga over 50*. New York: Fireside.
- Steward, M., & Philips, K. (1992). *Yoga for children*. New York: Simon & Schuster.
- Telles, S., Nagarathna, R., & Nagendra, H. R. (1995). Improvement in visual perception following yoga training. *Journal of Indian Psychology*, 13, 30–32.
- Ward, S. W. (1994). *Yoga for the young at heart*. Santa Barbara, CA: CAPRA Press.
- Weller, S. (1995). *Yoga therapy*. London: Thorsons.
- Zi, N. (1994). *The art of breathing*. Glendale, CA: Vivi.

第十九章 系统脱敏

请看下面的案例：

一个中学生，他能够很好地完成家庭作业和自学任务。然而，只要一参加测验，他的大脑就僵住了。有时在考试前一天，他会因为紧张而想到逃学。考试时，过分的焦虑导致许多知识都回忆不起来了，结果他的考试成绩总是很低。

这个案例所描绘的是人对某一情境形成焦虑反应的情形。按照 Bandura 的定义，焦虑是一种持续、习得的不适反应，来源于那些要求人们产生强烈情绪反应的外界刺激。案例中的这个学生对于没有明显外在危险的情境感到害怕（也称为“恐怖症”），而且他在一定程度上试图避开他所害怕的毫无危险的情境（也称“恐惧反应”），这些都是焦虑的表现。患有恐怖症的人一般会寻求治疗或咨询。

相反，下面讲的是人避免对某一情境产生焦虑反应的两个案例：

一个孩子，由于先前与水打交道的经验而不敢学习游泳。于是，孩子的父母或教练采用逐渐引导的办法。首先，带孩子到泳池参观，让他用手和脚在池边戏水，再进到齐膝的水里，等等。孩子学习游泳的每一种方法都伴随以一种愉快的体验——与父母一起在水中、玩玩具或打水仗。

某人曾遭遇过严重车祸。复原以后，坐在车里就害怕。治疗时，先让他从坐车走一小段路开始，而且常常要有朋友的陪同，或者在车中欣赏令人愉快的音乐。

在这两个例子中，情境得到了控制，也就是说，情境不再能引发持续的焦虑反应，而且主人公也不再力图躲避特定的情境。

为什么？你能否从这些情境中找到一些共同的东西，而正是这些共同的东西使案例中的主人公免于治疗吗？请再回忆一下上面的两个案例。你是否注意到在每个案例中，都有某种刺激或情感抵制了害怕或焦虑的产生？在孩子游泳的时候，父母用令人愉快的活动使孩子享有乐趣；害怕坐车的那个人有朋友陪同或者聆听美妙的音乐。而且，这两个主人公逐渐学会了适应曾经使他们恐怖的情境。这种方法的每一步都呈现出较前一步更大或更强烈的情境刺激。

简言之，这些步骤反映出了系统脱敏疗法治疗中的一些过程。系统脱敏疗法是一种广泛应用于焦虑治疗的方法。Wolpe 提出：

系统脱敏疗法是各种治疗神经性焦虑症的方法之一，是一种渐进式的方法……先引导求助者进行肌肉放松，从而达到抑制焦虑的生理状态。然后给求助者一个引起焦虑的微弱的刺激，持续几秒钟。刺激重复多次，就会逐渐失去引起焦虑的作用。接下来以类似的方式给患者施以逐渐增大的刺激。

本章目标

1. 在给出的四个刺激等级中，至少能指出其中三个刺激等级的类型（一般型、特殊型）。
2. 在给出的求助者案例中，至少能够识别并描述出系统脱敏疗法 11 个步骤中的 9 个步骤：
 - a. 介绍系统脱敏疗法的基本原理
 - b. 说明系统脱敏疗法的概况
 - c. 识别出引发求助者情绪的情境
 - d. 选择适合求助者的刺激等级类型
 - e. 选择适合求助者的刺激项目排序方法
 - f. 选择适当的去条件反射反应
 - g. 选择想像评估方法

- h. 选择场景呈现的方法
 - i. 场景呈现过程中求助者发出信号的方法
 - j. 书面记录场景呈现过程
 - k. 给出一个脱敏疗法自我练习的实例
3. 通过角色扮演的会谈练习，能够表现系统脱敏疗法 28 个步骤中的 22 个步骤。

使用脱敏疗法的各种报告

早在 1958 年，Wolpe 就已大量使用系统脱敏疗法。1961 年，他发表了系统脱敏疗法在几个案例中的成功经验，并于 1967 年为 Lazarus 的治疗案例所证实。自 1963 年 Lang 和 Lazovik 进行了首次系统脱敏疗法控制实验以来，系统脱敏疗法作为一种治疗方法便成为许多实证研究和案例报道的主题。

首先，脱敏疗法被用来治疗各种恐怖症，也用于治疗发言焦虑，数学焦虑，饮食限制，考试焦虑等。同时，它也被用于治疗强迫症。此外，系统脱敏疗法被越来越多地应用于行为医学——比如在实施痛苦的治疗之前，让患者进行脱敏性准备（见表 19-1）。脱敏疗法最近还被应用于创伤后应激失调者（PTSD），并采用了称为眼动脱敏及再加工的新方法（在介绍脱敏疗法的种类时，我们将

表 19-1 系统脱敏的应用

焦虑	
节食焦虑	数学焦虑
发言焦虑	考试焦虑
有创性医疗的心理准备	强迫症
恐惧症	
儿童恐惧症	幽闭恐怖症
惊恐与广场恐怖症	恐高症

详细介绍 EMDR)。最近的几项研究对脱敏疗法和其他几种治疗方法进行了比较。Schneider对脱敏疗法和社会技能训练进行了比较,他分别对41名在学校里常有攻击行为的儿童进行两种方法的训练,结果发现,在学校的环境没有任何变化的情况下,两组儿童的合作行为都有增加,同时攻击行为减少。Schneider和Nevid在治疗大学生的数学焦虑时,比较了脱敏疗法和应激预防训练法(SIT)。与控制组比较,两种治疗方法都是有效的,明显降低了焦虑评价水平。Menzies和Clarke在消除3岁到8岁儿童对水的恐惧的研究中,对比了间接性脱敏疗法和现场脱敏疗法,结果发现,现场脱敏疗法比间接脱敏疗法的效果更好。

当然不能只要求助者一感到“焦虑”,就一律使用脱敏疗法。在有些案例中,焦虑可能是别的问题造成的。比如,一个经常在截止日期前赶工作的人,可能会感到焦急。使用脱敏疗法只能使他对拖拉工作可能造成的结果不再紧张,变得麻木不仁。很显然,帮助求助者改变拖拉行为才是合理的方法。这再次说明在选择和实施咨询策略之前,全面地进行问题评估是很有必要的(第八章和第九章)。

一般而言,脱敏疗法是治疗恐怖症的首选方法,尤其适合于求助者有能力控制情境或完成任务,但是由于焦虑而逃避这种情境或不能很好完成任务的情况。比如在本章开始部分所讲的例子中,那个中学生有能力做得很好,而且掌握了足够的技能,但是由于他对考试的焦虑反应,使他不能在考试中取得和能力相当的成绩。相反,如果一个人由于能力缺陷而躲避某情境,使用脱敏疗法就不合适,也不会有效果。读者可能记得第十二章讲到,示范法对于能力缺陷引起的问题很有效。对于怀有各种恐惧或一般弥散性焦虑的人而言,改变认知是更好的方法(第十五章和第十六章),也可以使用包括脱敏疗法在内的综合方法。另外,有些焦虑症可能是由于求助者不恰当的自我描述造成的,这种情况下,

认知重建法或应激预防法（第十六章）等是首选的治疗方法，但也可以结合脱敏疗法来进行治疗。Van Hout、Emmelkamp 和 Scholing 在治疗 8 个患有恐怖症和广场恐怖症的成人时，评估了现场脱敏治疗过程中消极自我评价所产生的影响。其中 4 个人的症状有很大改善，另外 4 个人则几乎未见改善。结果表明，这两组成人在治疗的开始、中间及结尾阶段，进行消极自我评价的频率有很大差别。这些研究者认为，从治疗角度讲，脱敏治疗应该一直持续到求助者在主观上及生理上的焦虑状态得到缓解，而且消极的自我评价减少到零为止。如果求助者的焦虑对象是非特异化的，或者说总在变化着，则不应使用脱敏疗法。生物反馈、冥想和肌肉放松法有时是十分有效的辅助方法。

同时还应该注意到，脱敏疗法也可以用来治疗与焦虑无关的心理问题。Marquis, Morgan 和 Piaget 指出，脱敏疗法可以用来处理类似愤怒和失落感等的情感问题。

系统脱敏疗法的跨文化应用

到目前为止，脱敏疗法在各种人群的应用还很有限。传统的脱敏疗法在处理日本大学生的考试恐怖和发言焦虑当中有着成功经验。脱敏疗法还被用来治疗一个 42 岁拉丁妇女的多种恐怖综合征。眼动脱敏和再加工法还被用来治疗一个 68 岁美国二战老兵和几个曾是越战老兵的非裔美国人的应激后失常。

所有这些例子都报告了脱敏疗法的有效性。然而请注意，虽然焦虑大体上是一种普遍现象，但是“先于许多情感状态发生的特定社会事件，以及对这些社会事件所做的各种反应，在某些方面却是具有文化特定性的”。作为一个例子，Kleinknecht 等人（1994）区分了西方国家所说的社交恐怖症和日本所谓的社交恐怖（这种反应在中国和韩国也有报导）。西方的定义可以参考 DSM-IV 中的描述：恐怖症始于儿童期或青春期，男女的患病率相同；

当人认为自己会面临尴尬时就产生焦虑。而对日本人来说,男性比女性更容易患社交恐怖症;如果一个人认为自己的行为将使他人尴尬或触怒他人,就会产生焦虑。这种差异反应了西方文化和亚洲一些国家文化中价值观的不同。西方文化关注独立性和个人主义(狭路相逢勇者胜),而亚洲一些国家的文化则注重相互依赖和集体主义(出头的椽子先烂)。正像 Kleinknecht 等人观察到的那样,不同国家文化价值观之间的差异,影响了求助者表达焦虑的方式以及主要关心症状的哪些方面,也影响了治疗者应着重于哪些认知和行为的模式。那些不了解这些文化差异的治疗者将抓不住与焦虑症有关的主要问题,而专注于次要的方面。焦虑的其他跨文化差异在第十六章已有介绍。

脱敏疗法的解释

虽然脱敏疗法已经有了事实经验的支持,但对于它的现状仍存在着大量争论。脱敏疗法对于恐惧和神经症行为的疗效已经得到了广泛认可。争论的焦点在于脱敏疗法是如何发生作用和怎样发生作用的,或者说脱敏疗法中哪些具体程序导致了好的疗效。Cornnor-Greene发现了某些非特异性的因素,如治疗者和求助者达成的共识以及求助者对改善症状的期望等,似乎都对脱敏疗法的疗效起作用。但Ford宣称,有相反的证据显示,求助者的期望对于长期的疗效并不是可靠的预测指标。

我们将简单总结一下脱敏疗法的两种理论,这将有利于读者了解在脱敏疗法中产生作用的两个理念:去条件反射和消退作用。

脱敏是通过交互抑制完成的

Wolpe解释了脱敏疗法是如何通过交互抑制的原理来起作用的。在交互抑制中,恐惧等反应被一种更强的、不相容的反应或活动所抑制。换句话说,如果在引起恐惧的情境出现时,有一种

不相容的、更强的反应同时发生，就会出现脱敏过程，于是原来的情境就不再能引起恐惧反应了。交互抑制作用是以经典条件反射理论为基础的。按照交互抑制的原理，要使脱敏疗法起作用需经过以下三个过程：

1. 必须呈现一个强烈的抗焦虑反应或者说去条件反射反应。一般这种对抗性的抑制反应是深度的肌肉放松。虽然其他的反应（比如进食、断言、性行为）也可以使用，但Wolpe认为肌肉放松是最好的方法。
2. 向求助者呈现一系列形成等级的、引发焦虑的刺激。要求底部刺激强度很弱，顶部刺激强度很强，呈金字塔形。
3. 刺激情境与对抗或去条件反射反应（放松）之间必须形成联对。当求助者达到一种极深的放松状态后，去想像厌恶刺激（整个刺激系列中的一项），这时两者的联对便产生了。当焦虑（或其他需要抑制的情感）产生时，求助者要停止想像。再进一步放松之后，可将同一刺激重复几次。

近些年，交互抑制原理的某些部分受到了挑战，交互抑制的作用机制存在着一些疑点。Kazdin和Wilcoxon发现，有些研究证明脱敏疗法并不依赖于肌肉放松、引起焦虑刺激的等级化安排或厌恶刺激与放松之间的联对。这些研究结果使一些人不再将交互抑制作为脱敏疗法的原理。

脱敏是通过消退作用完成的

Lomont提出用消退作用来解释脱敏过程，也就是说，由于引起焦虑的刺激在呈现时没有得到强化从而导致了焦虑的消退。这一理论是以操作性条件反射为理论基础的。Wolpe同意对脱敏疗法机制的解释应该引入消退这一操作化的定义，因为消退能在脱敏疗法中起到一定作用。同样，Wilson和Davison争辩说，由于脱敏疗法大大降低了焦虑水平，从而使人能够逐渐接近原来害怕

的刺激，而恐惧也随之消退了。图19-1表示出了系统脱敏疗法的七个主要部分。在本章的结尾部分，系统脱敏法的会谈检测清单提供了与每个部分相联系的具体步骤。

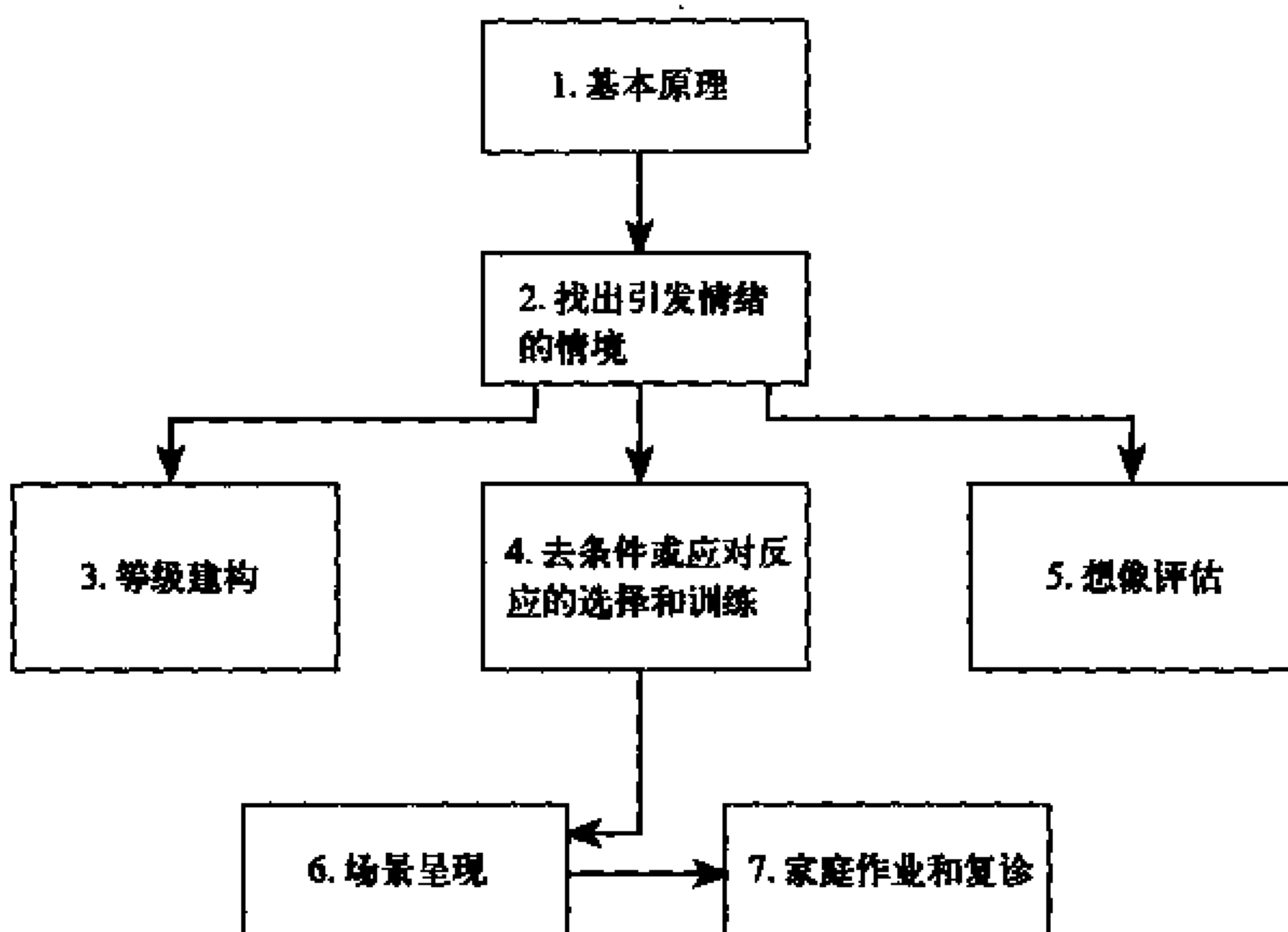


图 19-1 系统脱敏法的组成部分

脱敏疗法的组成部分

治疗原理

将脱敏疗法的目的和概况告诉求助者是很重要的，因为这可以让求助者了解脱敏疗法的原理。而且，如果求助者对脱敏疗法了解得非常清楚，并产生积极的期望，将会提高脱敏疗法的疗效。

去条件反射的基本原理和概况 按照去条件反射模式，咨询

者应向求助者清楚解释治疗原理，即求助者的恐惧（及其它条件反射形成的情绪）是如何通过脱敏疗法消除的；介绍治疗程序时，要强调以下三点，即用一个不含焦虑的反应来取代由条件反射形成的情绪，呈现的刺激系列是由能引起情绪反应的情境项目构成的，这些项目将与不含焦虑的反应（比如放松）之间构成各种联对。

示范对话：脱敏疗法的原理

这里为读者提供了一个咨询者解释治疗原理的例子。假设Joan对数学课感到害怕并逃避，咨询者可以这样向Joan解释脱敏疗法将如何帮助她解除烦恼：

Joan，我们已经谈了你在上数学课之前和课上感到非常紧张不安，有时你甚至想逃课。但你认识到你并不是一直对数学课感到紧张，你对数学课的这种感觉是逐渐形成的。有一个叫做脱敏疗法的治疗程序可以帮助你化紧张为轻松，最终，上数学课对你来说将不再是令人紧张的事。这个方法已经成功地帮助许多人消除了对某一情境的恐惧。

在脱敏治疗中，你将学习如何放松。你放松了以后，我会让你想像上数学课的一些事情——从不太有压力的情况开始，逐渐接触更大的压力。当我们不断这样进行时，轻松将取代焦虑，数学课将不再会令你感到紧张、害怕。你还有什么不明白的吗？

识别引发情绪的情境

如果咨询者和求助者已经对问题有了清楚的界定，他们就能对引起焦虑（或其他情绪）的情境有了一定了解。但是他们必须找出最重要的情境——在该情境下，求助者应当感到更为焦虑或不安。这往往不是很容易就能完成的工作，因为第一印象常常是错误的。Wolpe提供过一个例子，最初看来求助者是社交性恐怖，

然而实际上求助者是害怕被拒绝和批评。在另一个例子中,治疗者出乎意料地发现,原以为与能力欠缺有关的焦虑,实际上是由于害怕身体受到创伤。因此,Goldfried和Davison建议,咨询者要提醒自己和求助者,对不同对象进行脱敏的结果是会不同的。

应该针对每个求助者寻找出特定的焦虑产生情境。Marquis、Ferguson和Taylor观察到,即使求助者表现出相同类型的害怕或恐怖,但引起恐怖的特殊环境可能是非常不同的。

咨询者至少可以用三种方法来识别已经过去的以及现在存在的焦虑产生情境,这三种方法是:会谈评估,求助者的自我监测,自我报告问卷测评。

会谈评估 这里所讲会谈评估与第八章和第九章介绍的问题评估相类似。咨询者要引导求助者找出引发情绪的特殊情境。比如,求助者是否在所有的社交场合都感到不安,还是只有在有陌生人在场的情况才如此?求助者的反应是否随在场人数的多少而不同?是否因有人陪同和独自一人而不同?求助者是否因有同性在场或异性在场而更加焦虑?会谈中得到的信息能帮助咨询者揭示求助者在某些社交场合感受到的焦虑。

求助者的自我监测 咨询者可以让求助者记日记,即时记录一星期中引起焦虑的情境,这样可以得到更多的信息。求助者可以观察并记录,做什么事时、与何人在一起时或在什么地方时,产生了焦虑等情绪。求助者可以用一个从1(低)到10(高)的量表,或者0(没有焦虑)到100(恐慌)的量表,来评价在该情境中感受到的焦虑水平。

自我报告问卷 有的咨询者发现通过让求助者完成一个或多个自我报告问卷,可以得到更多有关产生焦虑情绪的特定情境信息。使用比较多的有Wolpe和Lang的恐惧量表(FSS),其中包括87项可能引起恐惧或不愉快情绪的事件。FSS量表可以在Wolpe的教科书的附录C中找到。在Wolpe的教科书中,还可以

找到 Willoughby 问卷，该问卷列出了人际情境下的各种焦虑反应。

示范对话：识别引起情绪反应的情境

咨询者：Joan，我们谈到数学课的一些情境时你感到焦虑不安。能具体谈一下吗？

求助者：嗯，上课前，只要想到不得不去上课就会使我烦躁。有时晚上会感到不安——做作业时不明显，考前复习时则很明显。

咨询者：好。你能列举出在数学课的哪些情境下感到焦虑吗？

求助者：嗯，考试时总会紧张。有时当我遇到了难题，不得不请教老师时，也会紧张。当然，还有老师叫到我的时候，或者叫我到黑板前演算的时候，我也会紧张。

咨询者：很好。我记得你说从前对自由发言也感到焦虑。

求助者：是的，也害怕。

咨询者：然而这些情境在其他课上并不使你紧张不安，是吗？

求助者：是的。而且事实上，我在数学课上的感觉从没有像最近一年这样坏过。我想部分的原因是由于临近毕业带来的压力。我的老师让我不知所措，上课的第一天我就被他弄得惊慌失措。而且我总是对数字有一种恐慌。

咨询者：看来你的恐惧一部分是针对你的老师，而还可能有一部分是由于希望得到较好的毕业成绩。

求助者：是的。虽然我知道我的成绩不会太差。

咨询者：好。你认识到，虽然不喜欢数学而且又为之担心，但你还是会以较好的成绩毕业。

求助者：不会比 C 等差。

咨询者：我希望这星期你能做一件事情。你能否列一个清单，说明发生了哪些关于数学和数学课的事情使你感到紧张不

安？写下有可能使你焦虑的、有关数学和数学课的所有事情。

求助者：好的。

咨询者：另外，早些时候你说过，有时与父母相处也会有这种感觉。所以在你改变了对数学课的焦虑感受之后，我们还将考虑你与父母相处的情境对你的影响。

建构刺激等级

等级由一系列引起求助者焦虑或其他情绪反应逐渐升级的环境刺激组成。建构一个适当的刺激等级需要多次咨询会谈做基础，因为这要涉及许多因素。这些因素包括刺激类型的选择、刺激的数量（单个还是复合的）、等级项目和控制项目的认定，以及把刺激项目进行排序，并确定项目之间的距离（见学习练习活动51）。

等级的种类 弄清楚引起焦虑的情境刺激之后，咨询者就要选择所要使用的刺激等级类型，然后把情境刺激安排到这种等级上。Wolpe区别了一般和特殊的等级类型。前者是单纬度的，并随恐惧对象的距离或时间逐步增加。许多单纯的恐怖症可以用一般的等级类型处理。另一方面，特殊的刺激等级是非常个人化的，因为它建立在求助者过去所形成的条件反射基础上。究竟采用哪种类型的等级要取决于求助者的问题性质。一般类型等级的各个项目是时间或距离纬度上的刺激，比如，距离某人的房子的距离，或者是考试前的时间。在这两个例子中，求助者的焦虑随害怕事物的接近而变化。如果某人非常害怕离开自己的房子，那么离开房子越远焦虑就越强烈。而害怕考试的人则会随着时间的临近而越来越焦虑。

这里是针对一个考试焦虑的求助者使用的一般等级的例子。你会注意到各个项目是按时间来安排的：

1. 你的教授在上课的第一天宣布一个月后将进行第一次考

试。你知道这一个月会很快过去的。

2. 考试前一个星期，你坐在教室里，教授提醒大家考试的日期。你意识到你还有许多东西要在这一个星期里学习。
3. 你坐在教室里，教授说考试将在下一次上课时——两天以后——进行。你意识到还有许多书没读。
4. 考试前一天，你在图书馆学习。你不知道自己掌握的知识是否像班上其他同学那样多。
5. 考试的前一天晚上，你在自己的屋子里学习。你想到这次考试成绩占期末成绩的三分之一这一事实。
6. 考前的深夜，你复习完了功课，上床睡觉。你躺在床上在头脑中回忆所学的内容。
7. 考试这天清晨，你一起床，头脑中就闪过“今天考试”这一念头。你想知道昨天晚上和以前记住的东西在考试时还能回忆起多少来。
8. 考试前1小时，你最后再翻一翻自己的笔记。你开始有一点头晕——甚至有点儿恶心。你想要是自己还有更多的时间复习多好啊。
9. 课前十五分钟，你走向教室。此时你意识到这次考试是多么重要，你希望自己不要交白卷。
10. 你走进教学楼，停下来喝一杯水，然后走进教室。你向周围看一看，发现大家都在笑。你认为他们很自信，而且他们比你准备得好。
11. 教授来得晚了一点儿。你坐在那儿等老师来发卷，你猜想考试的内容会是什么。
12. 教授已经发下了考卷。你得到了自己的卷子。你的第一个念头是题量太大，你怀疑自己能否将考卷做完。
13. 你开始做考卷的第一部分，有一些问题你没有把握。你花了些时间考虑，继而发现周围的人都在刷刷地写。你跳过

那些题目向下答题。

14. 你看了看表，时间过去一半，只剩下25分钟了，你觉得自己第一部分耽误的时间太多了。你想到如果答不完卷子你会得多少分。
15. 你尽量快地继续答考卷，偶尔会担心时间不够用。你瞟一下手表，只剩下五分钟了，你还有许多题没做。
16. 考试时间到了，你还有些题目空着。你再次因为这次的成绩占期末成绩的三分之一而担心。

特殊类型的刺激等级更注重与求助者个人焦虑有关的具体问题。比如，Wolpe描述了几个求助者担心自己或他人患有疾病的案例。“他人的病”刺激项目包括生理残疾、流血的样子、车祸、穿白衣服的护士等等。“自己的病”项目则包括头部发紧、脚底冒冷汗、手上多汗、头晕、呼吸急促等。这些项目是为每个求助者建构的，与他们各自特有的恐惧或担心相关联。咨询者和求助者必须一起建构出刺激等级——这些项目按先后次序排列，包含逐渐加大恐惧感的刺激项目。以下提供了一个特异刺激等级的例子：

“他人的病”的等级

1. 两条腿都残废的孩子
2. 走得很慢的男人——由于心脏虚弱而呼吸急促
3. 操纵电梯的盲人
4. 一条腿残废的孩子
5. 驼背的人
6. 痛苦呻吟的人
7. 一只脚畸形的人
8. 一只手臂的人
9. 一条腿的人
10. 由于流感等无生命危险的疾病而发高烧的人

等级的数量 咨询者使用一种还是几种刺激等级，还取决于

求助者的具体问题和他的倾向，以及咨询者本人的倾向。有些咨询者认为针对不同的主题或同一主题的不同要求，可以建构各自独立的刺激等级。使用多维刺激等级可减少混乱，但建构和呈现多维等级需要更多的时间。一般而言，一个脱敏疗程中最多可以使用四种不同的刺激等级。

等级项目的确定 咨询者必须想出获得等级项目的方法。求助者在这个过程中的作用非常重要。咨询者一般通过会谈，或通过给求助者布置任务来让他帮助确定等级项目。会谈时，咨询者可以询问求助者引起他情绪反应的特殊场景。在询问的同时不能进行放松训练，因为求助者在被要求确定项目的同时，又经过一段时间的深度放松，会使自身的反应发生变化。

如果会谈中求助者在回答问题时存在困难，可以把项目识别作为任务布置给他。咨询者可以给他一叠空白索引卡片，要他在一个星期里找出等级项目，并分别写在每张卡片上。对于那些能在会谈中很好地回答问题的人，让他们完成家庭任务对治疗也是有帮助的。在这一星期里，求助者有时间把以前治疗程序中所没有的项目添加进去。

咨询者应该不断地探索并找出新的等级项目，直到项目的数量足可以代表厌恶情境的全部，也可以代表不同程度的情绪反应。刺激等级通常应包括 10 到 20 个项目，但偶尔也会多一些或少一些。Goldfried、Davison 和 Marquis 等所提出了建构等级项目时所使用的标准：

1. 有些项目应该代表求助者可以控制的情境(不需要别人的鼓励)。
2. 项目必须具体而详尽，项目描述得越详细，越能帮助求助者获得清楚而生动的视觉想像。例如，一个项目说：“你最好的朋友与你看法不同”，这样的描述太过一般化了。更具体一些的项目应是：“你最好的朋友对你男友的评价很

不好，并且说你和他一起外出约会很愚蠢。”

3. 各项目应该能够反映求助者已经面临或即将面临的实际情况。如果项目含有对话，所用语言应该与求助者的言语相一致。
4. 所选择的项目要能反映引起求助者恐惧（或其他情绪）的情境的广阔范围。
5. 各项目要能反映各种程度的情绪，从低强度到高强度。

等级项目找出来之后，咨询者和求助者可以接下来找出几个控制项目。

控制项目的确定 控制项目包括一个放松的或中性的场景，求助者对它应该不会产生任何情绪反应。它要安排在刺激等级的底部，代表零等级或“没有焦虑”的等级。控制项目的例子有“想像一个有颜色的物体”、“想像你自己坐在太阳下，天空蓝蓝的”、“想像你望着一片黄色的水仙花花圃”。控制项目常用来检验求助者对一个不会引起焦虑的事物产生视觉想像的能力，同时也给求助者一个放松的、愉快的场景去想像，从而提高放松的水平。当等级项目和控制项目都确定后，求助者可以按照情绪反应渐高的顺序来安排这些项目。

等级项目的排序和分隔 咨询者和求助者要共同努力，来寻找一种排列等级项目的顺序。通常，求助者在排序过程中扮演着重角色，但咨询者要确保项目之间有合理的距离。等级项目要按着引起的困难、压力和情绪渐增的顺序排列。控制项目置于刺激等级的底部，每一个带来更大困难、引起更大焦虑的等级项目，要放在刺激等级的更高的位置上。位于刺激等级顶部的项目对于求助者而言是最具压力、最令人焦虑的项目。

求助者在排序之前，咨询者要告诉他刺激项目是如何安排的。还要说明这种安排的目的，以便求助者能充分理解花费时间排序的必要性。咨询者要指出脱敏是逐渐进行的，刺激等级安排的作

用在于找出带来低压力的项目,以使求助者先针对这个项目接受脱敏治疗,然后针对带来稍高压力的项目进行脱敏治疗。求助者要学会面对或应付恐惧的情境,就要先从较容易控制的情境开始,逐渐扩展到更困难的情境。咨询者须强调,在求助者学会应付较小压力的情境之前,不会让他学习应付压力非常大的情境。这一点可以解除某些过于焦虑的求助者的顾虑,在他看来,脱敏疗法本身可能就是极可怕的一件事情。

sud 量表用来量化刺激等级中的各个项目。“sud”代表主观干扰的单位。可以这样向求助者解释 sud 单位:“设想一下你所能想像出的最严重焦虑,并用 100 做标记。然后,想像一下绝对的平静——也就是说根本没有焦虑的状态,标记它为 0。这样就有了一个焦虑量表。在任何醒着的时刻,你都位于这个量表上的一点。你认为现在你处在哪一点上?”。

于是,求助者在排列等级项目时,给每个项目赋予一个值,用来代表该刺激所带来的焦虑的大小。如果求助者并不感到很焦虑,就可能赋予它 10、15 或者 20 个 suds;中等强度的焦虑可能标记为 35、40、45 或 50 suds;而 85、90、95、100 suds 则表示该情境使求助者非常焦虑。

当等级项目按 sud 的大小排列在刺激等级上以后,咨询者要检查一下,确保没有两个项目的距离超过 10 suds;刺激等级顶部的项目距离不超过 5 suds。如果有的距离过大(超过 10 suds 或 5 suds),咨询者和求助者应当追加插入项目,填充到量表中去。如果有过多的项目围绕着同一个刺激水平,尤其是在刺激等级底部的位置,就要把部分项目删除掉。有了 sud 系统,就能很容易地确定项目之间的差距是否过大或过小。其次, sud 量表的使用,为求助者提供了一个对放松和紧张程度进行区分和标定的方法。通常,这个标定系统在放松训练和情境呈现中也是有用的。

虽然以上我们所描述的刺激等级建构,主要是针对个人的问

题,但这种方法也同样适用于群体求助者。对某些求助者而言,标准的刺激等级能够像个人化的刺激等级一样奏效。

甚至用机器来执行脱敏疗法都是可能的。Lang、Melamed & Hart发表了用两台录音机治疗蛇恐怖的案例。他们用一台录音机呈现等级项目,用另一台播放放松项目。其他人也描述过用录音装置代替咨询者参与的方法。当患者过于焦虑以至于咨询者亦会令他无法放松时,使用录音机尤其有效。近来还有人在电脑上使用“真实的情况”呈现刺激等级。

学习练习活动 51/ 建构刺激等级

这个学习活动使你有机会练习建构刺激等级。你可以自己做这个练习,也可以与他人一起练习。

第一部分 一般的刺激等级

想出一个令你恐惧并躲避的情境,它在时间上的逐步临近使你的恐惧也随之增加;或你越接近情境中恐惧的物体,你就越害怕。就像越临近考试,焦虑也越高。现在辨认出这个情境中的一些特征。

如,你一个人时和与他人相处时,临近期中和期末考试时,面对小组和一大群人要你发言时,你的焦虑是怎样变化的。这些情境中的项目可以成为刺激项目,另外令你愉快的项目可以成为控制项目。将所有的项目写在卡片上,并为它们赋予suds值。在刺激等级的底部放置控制项目,往上分别排列引起焦虑的刺激项目。注意项目之间的sud值不能超过10分。

第二部分 特殊的刺激等级

想出一个你会感到痛苦、不愉快的情境,如丢失贵重物品、失去工作和朋友等。将它们列在卡片上,并为它们赋予sud值。注意刺激项目之间的sud值不能超过10分。

示范对话：使用 SUD 量表建构刺激等级

咨询者：你好，Joan。你把列好的清单带来了，非常好。因为今天我们将写出一个所谓的“刺激等级”，类似于楼梯和梯子的结构。对你而言，刺激等级紧扣数学焦虑这一主题，由引起你焦虑的各种与数学课有关的情境组成。我们将把这些情境写下来，然后你把每一项目安排在主观干扰单位(sud)量表上。主观干扰单位数是用来描述你焦虑程度的数字。数字越大，你感到的焦虑就越大。设想最糟糕的焦虑，并把它定为100，然后想一想你完全平静的感觉，也就是一点儿也不紧张的情形，并把它定为0。于是就得到了一个主观干扰单位量表。只要是你醒着的时候，你所感到的焦虑总是介于0和100之间。现在，让我们一起看一看你带来的清单中的项目，并为它们赋值。弄清楚了吗？

求助者：清楚了。事实上，这一个星期我列清单时已经做了部分工作，是吗？

咨询者：是这样。我们下一步的工作，是推敲一下你所列的清单。一方面添加些目前还缺乏的情境刺激，另一方面，使每个项目的表述具体而清楚。我们还可以再加进一些细节的东西，使每个项目与现实的情况更为接近。现在，让我们来看看你的清单。

1. 在英语课上想到数学课。
2. 在上数学课的路上。
3. 在家中做数学作业。
4. 在家中进行数学考前复习。
5. 数学课上，老师发数学试卷。
6. 数学课上，答考卷。
7. 数学课上，老师让我回答问题。

8. 数学课上，在黑板前遇到了困难。
9. 数学课上，在自己的位子上做数学题，有些题不会做。
10. 请老师帮忙。
11. 就某问题发言。
12. 考试或作业得了低分。
13. 老师告诉我，我可能考试不及格或几乎通不过。
14. 做与数学有关的东西，甚至是在课外，比如将一系列数字加起来。
15. 与某人谈论数学。

咨询者：看来你做得很努力，写下了给你带来压力的与数学有关的情境。现在让我们再来看一下它们并添加一些细节。对于这些项目，你能否更具体地描述一下这些情境？当你感到焦虑时，具体发生了什么？比如，英语课上你想到了什么，才使你焦虑不安？

求助者：好，我明白你的意思。

咨询者：那么，让我们看一看这些项目，同时你告诉我其中的细节。我会把它们记下来。（当各个项目补充得比较具体之后，把它们记下来。咨询者要检查这些项目是否符合以下这些必要的标准：各个项目具体、明确，表达了过去、现在、将来可能引发焦虑的场景，能够代表宽广的情境刺激范围，并体现出不同的焦虑水平，部分项目是求助者可以控制的。）

咨询者：还有哪些有关数学的东西可能会给你带来压力？

求助者：现在看来没有什么了。我这张清单上的有些事情从没发生过，但像老师告诉我考试可能不及格这样的事，我会感到非常紧张的。

咨询者：你完全领会了。现在能不能想像一下与数学无关的，能

带给你轻松和愉快的某些事情——比如滑下一个雪坡、躺在海滩上？

求助者：嗯。在篝火前烤棉花糖怎么样？

咨询者：很好。接下来我可能让你通过想像一个愉快的场景而放松自己，你就可以想像这样的场景了。

求助者：好的。

咨询者：我想让你看一看我们所列的这个清单，并给每个项目确定一个主观干扰值。我们可以从清单底部愉快的篝火情境开始，主观干扰值定为0，然后再给其他项目确定主观干扰值。

求助者：好的。那么下一个要确定的情境将是使我稍稍有点焦虑的事情了。对吗？我可以选择在家里解简单的题目，主观干扰值应该是10。

咨询者：非常好。你已经掌握了要领。下一个刺激等级上的项目应该是什么？

求助者：应该是我想到要去上数学课而感到有点儿紧张，所以我选择在英语课上想到下一节要上数学课。我把它定为20。

咨询者：好的，下一步呢？

求助者：走在上数学课的路上，走进教室之后请老师看我的作业。这使我的不安增加了一些，我把它定为30。

咨询者：你做得非常好，就这样做下去。你看下一个应该是什么情况呢？

求助者：对我的朋友说起快考试了，我担心会通不过，大约是35大小的主观干扰。再下一个情况是我看到一大堆数字，必须算一下总数是否正确。主观干扰值是40左右。

咨询者：好的。下一个呢？

求助者：数学课上，我在自己的位子上遇到了解不出的习题，此时的主观干扰值应该是50。下一个情境应该是数学课上向

老师请教，大约是60。

咨询者：我们大约给一半的项目赋了值，让我们接着做下去吧。

（一直继续到把所有16个项目赋值完毕。）好了，你已经把所有的项目都赋了值。我们要确保两个项目之间的距离不会过大，之后才可以使用这个刺激等级。如果有必要，我们可以将项目稍加移动，或者重新给各个项目赋值。现在我逐一拿出这些卡片，让我们来看一看结果怎样。从刺激等级的底部开始。

卡片1 (sud 0)：在一个凉爽的夜晚，和朋友坐在篝火旁一边唱歌一边烤棉花糖。[控制项目]

卡片2 (sud 10)：在自己的屋子里，做平时的数学作业，作业相当简单。

卡片3 (sud 20)：距离下英语课还有十分钟，想到下节课就是数学课了。不知道有什么办法可以躲起来，自己会不会被叫到。

卡片4 (sud 30)：与几个同学一起走过走廊去上数学课。走进教室时看到老师正在批改作业，不知自己做得怎么样。

卡片5 (sud 35)：一个女朋友打来电话，谈起即将进行的数学考试——我想到自己不知能否通过。

卡片6 (sud 40)：看到一大堆数字，比如购物付款单，不得不检查一下总数是否正确。

卡片7 (sud 50)：数学课上，坐在自己的位子那儿做习题，遇到了麻烦，可能没有时间解出来了。

卡片8 (sud 60)：在自己的位子上做习题，遇到了两道题不会做，不得不请教老师。他试图帮助我，我很沉默。

卡片9 (sud 65)：在一个重大考试前，在自己的屋子里复习功课。我不知道自己能否通过。

卡片10 (sud 75)：在数学课上考试，有几道题我不知从何下手。

卡片 11 (sud 80): 等待考试分数或作业成绩, 担心自己的成绩会很低。

卡片 12 (sud 85): 数学课上, 老师提问, 我举起了手, 但不知自己的答案是否正确。

卡片 13 (sud 90): 数学课上, 等待一个重大考试。猜想考题会是什么, 自己能否回忆起以往的知识。

卡片 14 (sud 95): 数学课上, 老师忽然叫我的名字, 并让我回答问题。我感到毫无准备。

卡片 15 (sud 98): 数学课上, 老师叫我到黑板上去做习题。我努力在全班同学面前做出这道题, 我陷入了深深的思索。

卡片 16 (sud 100): 放学后, 老师喊我参加一个面谈。老师告诉我, 事情很棘手, 我很可能通不过考试。

咨询者: 好的。现在每一个项目都显示着压力逐渐增高的情境。你看这其中有没有跨度过大的项目? ——比如突然从一个压力很小的情境过渡到了一个压力很大的情境?

求助者 (再看一看列出的单子): 不, 没有跨度过大的地方

咨询者: 好, 那么我们的治疗将依据清单的顺序。当然, 这也是试探性的。以后, 如果我们觉得有必要, 我们也许会添加某些项目, 或者把这些项目的顺序调整一下。

去条件反射反应的选择与训练

按照交互性抑制和去条件反射的原理, 脱敏过程若要发生, 求助者必须以一种抑制 (或去条件反射) 的方式对焦虑或其他情绪进行反应。咨询者要选择一种焦虑的替代物或与焦虑不相容的反应, 并训练求助者学会这种反应方式。

选择反应 咨询者首要的任务是为求助者选择一种适当的去条件反射作为反应方式。一般而言, 脱敏疗法中使用的对抗焦虑的反应是深度的肌肉放松。肌肉放松有某些优点。Levin 和 Gross 发现,

放松可以增强想像的生动性。而且,你可能还记得第十七章曾讲到已经证明肌肉放松可以减轻焦虑,对它的控制也比较容易。Wolpe选择肌肉放松,是由于它不需要指导求助者进行任何动作活动。肌肉放松既容易学习,又易于在会谈中教授,也适于求助者日常自己练习。当然,偶尔也有求助者难以学会。另外,肌肉放松也不适于在现场脱敏疗法中使用,因为在现场脱敏中,求助者经历实际的情境刺激,而不是通过情境想像。

当肌肉放松不能作为去条件反射的反应时,咨询者可以在没有放松的条件下或寻找一个替换反应,来实施脱敏疗法。在有些案例中,求助者没有通过放松就达到了脱敏疗法的目的。然而,如果求助者的焦虑十分严重,在没有放松的条件下让他去应对焦虑是十分危险的。

如果放松不适合求助者的情况,则可以采用引导想像法(第十三章)、冥想法(第十七章)以及应激预防法(第十六章)替代。这些方法在会谈中也比较实用并易于教会。比如咨询者选择使用引导想像法,求助者就可以在脱敏过程中集中想像令人愉快的场景。如果选择冥想法,求助者则可以集中注意力于自己的呼吸,并记下呼吸次数。如果用应激预防法,求助者可以低声或在心里默默地做些应对的话。

向求助者解释去条件反射反应 求助者需要在会谈时以及在家中,花大量的时间学习去条件反射反应。通常如果求助者懂得如何以及为什么学习这种反应,那么他们所花费的时间将会是更加值得的。

要向求助者解释,所学习的反应行为是用来产生去条件反射;通过提供一种焦虑和其他情绪的替代物,脱敏疗法能够帮助求助者摆脱焦虑。因为这种习得的替代反应行为与焦虑相对抗,可以降低他的焦虑水平,使他不再逃避引发焦虑的情境。

反应的训练 咨询者要提供训练,以帮助求助者学会脱敏疗

法过程中使用的去条件反应。肌肉放松和其他反应至少需要几次会谈的时间才能完成。这种反应的训练可以与刺激等级建构同时进行,可以用一半的会谈时间学习反应,一半的时间用来建构刺激等级。但要记住,确定等级项目不能与放松同时进行。咨询者可以按照认知重建会谈的做法(第十五章),训练求助者学会对抗性言语陈述;用会谈检测清单介绍的引导想像法(第十三章)、肌肉放松法、冥想法(第十七章)来训练求助者进行想像、放松和冥想。

每次训练前后,咨询者应该让求助者评价感受到的压力水平。此时又要借用“主观干扰单位量表”了。求助者要把所感受到的焦虑用0~100的量表值来评价。去条件反射反应的训练一般要持续到求助者能够识别不同的焦虑水平并且能够放松下来时,其放松值(若按照100主观干扰单位量表)应小于或等于10分。如果经过持续的训练后,求助者仍不能轻松地掌握一种去条件反射反应,那么就应选择另外一种去条件反射反应进行训练。

求助者在咨询者的指导下开始去条件反射反应练习后,就要给他安排每天自我训练。求助者进行充分的练习是实际治疗的一个前提,另一个前提是求助者的想像能力。

示范对话：条件反射反应的选择和训练

咨询者: Joan, 可能你还记得我对你解释脱敏疗法时, 提到了用另外的东西来替换焦虑反应, 比如放松。今天我想做的是教你一种放松的方法, 怎么样?

求助者: 好哇。是不是有点儿像瑜伽术?

咨询者: 跟瑜伽相差很远, 但效果和瑜伽差不多, 你可以通过练习学会。这是一种身体放松的过程。要你学会使身体不同部位的肌肉群变得紧张或松弛。最终, 当你身体的某一部位一紧张, 你就能马上意识到, 并向自己发出放松的信号。

求助者: 那么, 我在脱敏疗法过程中如何使用放松法呢?

咨询者：你学会放松之后，我会让你想像刺激等级上的项目——但只是在你放松了之后。你在头脑中想像你感到有压力的事情，你坚持这样想，过一段时间，刺激情境对你而言将越来越不再能够引起焦虑。

求助者：我想这种方法对我有意义。放松会使情境对我的压力减小。

咨询者：是的，很有用——这就是我认为花时间学习放松的很重要的原因。现在，Joan，我们来做下面的事情。每次放松前后，你要告诉我你当时紧张或放松的程度。你可以用从0到100的数字来评价——0代表完全放松，100代表非常紧张或焦虑。你现在的感觉是多少？用量表值来表示。

求助者：嗯，不是完全放松，但也说不上紧张，大概30吧。

咨询者：很好，你想不想现在就进行一次放松训练？

求助者：当然想。（把谈话之后的有关肌肉放松训练的过程清单交给Joan。作为补充，本章最后将给出一个呈现情境的模拟对话。）

想像评估

一般脱敏疗法过程的实施在很大程度上依赖于求助者的想像。脱敏疗法中的再学习——去条件反射，是求助者通过将刺激项目加以活生生的想像而取得的。当然，这里有一个假设：想像的情境与真实的情境是等价的，在想像中形成的学习可以泛化到真实情境中去。Mahoney注意到，论证这些假设有效性的证据存在着很大的差异。但无论如何，只要使用脱敏疗法，求助者的想像能力就是非常关键的因素。

给予求助者的解释 咨询者可以向求助者解释，当 he 想像刺激等级上的项目时，就要像身临其境一样。想像中令人惧怕的情境与实际的情境非常类似。如果求助者在想像中不再感到焦虑，

那么当回到真实生活中时，他的焦虑也会减低。咨询者可以提示，由于人们对运用想像力的反应不同，想像多种情境加以练习效果会更好。

求助者想像力的评估 求助者形成清晰、生动的想像的能力是可以测量的。可以使用练习（控制）情境法，也可以使用第十三章讲到的问卷法。通常，测量求助者在脱敏疗法中的想像能力要选择两个时间，即求助者努力放松自己时和求助者并没有努力放松时。按照 Wolpe 的观点，放松条件下的想像评估有两个目的：首先，使咨询者了解求助者产生缓解焦虑的想像的能力。其次，也可从中发现一些因素，它们可能抑制求助者的想像能力。比如，一个担心会失去自我控制的求助者，可能在想像控制项目时有困难。在每次想像之后，咨询者可以要求求助者大声描述想像情境中的细节。对那些难以形成想像的求助者，咨询者要改用一种不利用想像的方法，比如模拟参与或现场脱敏疗法。

有效想像的标准 在脱敏疗法实施过程中，求助者对想像的运用在很大程度上决定着脱敏的成败。不能形成想像的求助者，将不能使用通过想像呈现的刺激等级。根据对求助者进行想像评估的结果，咨询者将判断他的想像能力是否达到了有效想像的标准。以下四条标准由 Marquis 等人提供：

1. 求助者必须能将一个场景想像得比较具体，有足够的细节，并有触觉、听觉、味觉和视觉的参与。
2. 以一个参与者的身份，而不是旁观者的身份去想像。
3. 求助者可以按照指示开始或结束一个想像。
4. 求助者要能够按照指示保持对某一特定场景的想像，不发生场景漂移或改换。

如果在想像评估过程中遇到了这样或那样的困难，咨询者可以决定：继续使用想像并提供想像训练，或者加入一个对话或练习剧本；也可以用另外的方式来呈现刺激等级（幻灯、角色扮演

或实际的体验)；或者终止脱敏疗法，改用其他的治疗方法。一旦求助者可以报告出符合大多数标准的清楚、生动的想像，咨询者就可以向他呈现刺激等级的项目了。

示范对话：想像评估

以下的评估应在两个时间进行：一是在Joan经过一段放松疗程之后，一是在Joan没有努力进行放松时。

咨询者：Joan，我将让你想像为你建构的刺激等级上的项目。人们对想像的驾驭情况是不同的。因此我们应该看一看你对想像驾驭的能力。请你坐好，闭上眼睛并放松。现在想像一个冬天雪地的场景。把你自己也想像进去，正在做着什么。（停顿）现在，你能清楚地描述一下你的想像吗？

求助者：好。天很冷，但阳光明媚。地上的雪有一尺厚，我和两个朋友坐在雪橇上，从一个高高的山丘上飞快地往下滑。到了山丘下，我们的雪橇翻倒了，我们滚落在雪地上。真冷啊。

咨询者：看来你能想像冷的感觉，你还记得有什么颜色吗？

求助者：山丘当然是白色的，天是蓝色的。阳光令人眩目。我穿着红色的滑雪衫。

咨询者：好的，很好。让我们再做另外一个练习。我说出一个场景，你要说出当时的细节。力争在我说出来之后马上得到一个清晰的想像。而当我说“停止想像”的时候，尽力把它从你的头脑中抹去。好，这个情境是：温暖、明媚的日子，微风习习。你正在晶莹的水面上划船。好——现在开始想像。（停顿）好，Joan，停止想像，你能说出你的想像吗？（Joan开始描述）。我说完之后，你是在多长时间内得到的这个清晰的想像？

求助者：不长，大概一两秒。

咨询者：听到我说停止时，你能从头脑中将它抹去吗？

求助者：用了些时间，大约几秒钟，把它抹去了。

咨询者：你是否一直想像自己在船上，换句话说，你发现自己的想像漂移之后又重现了吗？

求助者：不，所有的时间我都在船上。

咨询者：现在再想像一个情境怎么样？

求助者：很有意思。我不认为想像是个难事。

咨询者：是的，看起来你做得很容易。让我们接着来。

Joan的想像达到了前面提到的四条标准：想像具体，自己参与其中，可以容易地开启和关闭，能够保持场景不变。

等级场景的呈现和示意方法

在对求助者进行了去条件反射反应训练，并评估了他的想像能力之后，就该向他呈现刺激等级上的刺激项目了。每一次呈现都与去条件反射反应相配合，从而使求助者的焦虑被去条件反射化，或者说降低。向求助者呈现场景刺激的方法有很多种，Wolpe的方法如下：引导求助者想像咨询者给出的场景，并告诉他，当想像变得清晰时，请举起食指。让求助者维持想像约5到7秒钟，然后说“停止想像”。然后咨询者问求助者，想像中的焦虑水平是多少，咨询者可以问“场景的想像给你带来的主观干扰值是多少？”

在Wolpe介绍的这个示意方法中，求助者伸出一个指头（食指）告诉咨询者，他的想像是清晰的。其他示意方法可见Marquis等人的介绍。

场景呈现的形式 场景的呈现要遵循相当标准的形式。在每个场景呈现之前，都要先进行指定的去条件反射反应训练。其主旨是使刺激等级项目的呈现和去条件反射反应（或对抗性反应）同时出现。比如，咨询者告诉求助者，这一疗程的第一部分先进

行放松，然后想像刺激等级上的一个项目。也就是说，每个脱敏疗法过程都以一个短暂的肌肉放松、冥想或有指导的想像作为开始。此时求助者的放松程度要等于或低于10个单位的主观干扰值。然后，咨询者再呈现刺激项目。

这时，咨询者开始向求助者描述一个等级刺激项目，并指导他去想像该刺激场景。第一个疗程要从刺激等级的第一个（带来最小焦虑的）项目开始，以后的项目呈现都要从前一次成功地完成了的项目开始。这样做有助于求助者从前一个疗程顺利地过渡到下一个疗程，也有助于检查求助者学习效果的保持情况。同时还能避免焦虑反应自发的反弹。有时在两个疗程之间，焦虑反应的确会反复，所以从前一次成功完成的项目开始，正是检查焦虑是否重复出现的途径。

呈现刺激项目时，咨询者要进行描述，并要求求助者进行想像。通常项目呈现时间为5到7秒钟，然后让求助者停止想像。呈现刺激和进行想像的时间要有所变化，理由如下：首先，如果求助者表现出正在经历着巨大的焦虑，咨询者就要终止他的想像。如果想像某一场景会使他的焦虑水平显著上升，咨询者就应将想像时间限定在2秒之内。Wolpe指出，开始时场景刺激时间一般要短一些，以后可以适当长一些。

如果对一个场景的想像达到了指定时间，而求助者没有报告说感到紧张，咨询者就可以让他停止想像，放松片刻。此时的放松相当于两次场景呈现之间的喘息之机。这时咨询者可以用一些描述性的语句，比如“放松你全身的肌肉”，或使用控制项目，来指导求助者进行放松。等级项目呈现之间没有规定的停顿时间，一般10到30秒就足够了，但有些人需要2到3分钟。这里建议咨询者，利用这段时间检查一下求助者想像的主观干扰值。

如果求助者在想像场景时体验到了焦虑，咨询者要指导他重新再做一次，并检验焦虑的水平。一般要使一个场景不再引发焦

虑需要重复呈现3到4次。Wolpe指出：有时要把焦虑减少到完全没有，需要重复呈现场景10次之多。每个场景项目所引发的焦虑要在减少到0之后，才能进行下一个项目的呈现。

如果一个项目重复呈现3次以后还会引发焦虑，说明可能存在问题，或需要调整。因为持续的焦虑可能意味着建构的刺激等级或求助者的想像有问题。此时咨询者可以采取三种做法来减轻焦虑：加入一个较轻的刺激项目；让求助者把想像时间缩短；检查求助者的想像，看一看他的想像是否出现了漂移。

在刺激呈现的全过程中，咨询者要谨慎地使用标准的引导语。无论是求助者给咨询者发信号，还是用主观干扰值来报告他的焦虑，标准化的引导语都是很重要的。Rimm和Masters通过观察发现，咨询者无意间的一句话，如“好的”，可能会强化求助者不要发出焦虑的信号。由于报告了焦虑不会得到强化，求助者常常希望使咨询者高兴，而尽量不报告有焦虑。

每一个场景呈现的时段都应以一个不再引发焦虑的项目结束，或者以一个低主观干扰值的项目结束。有时咨询者需要返回到刺激等级中一个较低的项目上去，从而以一个不再引发焦虑的项目结束此一时段。虽然有的求助者可以配合很长时间，尤其是在完成最初的几个时段后，但系统脱敏疗法的一个疗程应该在15到20分钟内结束。在限制的时间内，可以给求助者呈现出十个场景项目；而在治疗的后期，有些求助者可以在一次疗程中接受30分钟以上的治疗。如果求助者显得疲劳了，应马上停止这个疗程。脱敏疗法需要求助者全身心的投入，因此咨询者要将治疗时间控制在他能集中注意力的时间以内。

选择记录方法 脱敏疗法同样要求咨询者集中注意力。想一想咨询者在一个疗程中要做的事情吧：要为一个求助者呈现4到5次想像场景刺激，要使用一个甚至更多的刺激等级，而每个这样的等级包含多达10到20个刺激项目！因而，咨询者要记录并能回忆

出大量信息。许多咨询者是用手写的方式记录的。情境呈现期间有许多记录疗效的办法，这里介绍两种方法。这些方法只是作为建议，你可能会在自己的咨询中发现更适合自己的方法。

Marquis 等人用“脱敏疗法记录单”来记录刺激等级的项目数，以及与每个项目相关的焦虑或主观干扰值。图 19-2 是他们所使用的记录单和记录下来的案例。

日期	项目等	焦虑	项目之间	评语、观察、
治疗所用	级数量	sud 值	的时间	特殊治疗
全部时间		+ 或 -		
1997 年 7 月 14 日	4	+8 -15	60 秒	
45 分钟		+20 +30	60 秒	
			30 秒	
			60 秒	

图 19-2 脱敏疗法记录单

Goldfried 和 Davison 使用一种 3×5 的索引卡记录对每一个等级项目的描述和项目号。在项目描述的下面留有一个空白，用来记录每个项目持续的时间，以及该项目是否引起了求助者的焦虑。图 19-3 给出了一个例子，在这个例子中，数字代表求助者想像该项目刺激使用的时间（以秒记）。“+”代表没有引起焦虑或主观干扰值较低，“-”代表产生了焦虑或主观干扰值较高。注意：在结束这一项目呈现时，有连续两个想像没有报告焦虑（+5 和 +7）。

项目编号 6 日期: 1997.7.14 项目描述 你正走向教室,想着即将面对着的考试, 脑子里很乱,甚至怀疑自己是否正确地 掌握了知识。 +5 -7 +5 +7

图 19.3 索引卡片

示范对话：场景呈现

咨询者: Joan, 今天的放松练习之后,我们将开始进行与你的刺激等级有关的工作。我来介绍一下过程。你要先进行放松,然后,我会让你想像刺激等级中最低的那个项目——即令人愉快的那一项。之后,我再给你描述下一项,你来想像。我会教你一种方法,以便让我知道你是否感到了焦虑。如果你感到焦虑,我会告诉你停止想像,并进行放松。在我给你下一个项目之前,你将有一段时间用来放松。我说得清楚吗?

求助者: 清楚。

咨询者: 另外,在想像进行的任何时候,如果你感到焦虑或不安,请举起食指,向我示意。想像过程结束时,你还要告诉我想像中焦虑的主观干扰值。

求助者：好吧。

咨询者：为了确信你理解了我的话，请你告诉我在治疗过程的这一部分，你要做些什么事情？

求助者：放松之后，你会让我想像刺激等级底部的项目。如果我感到焦虑，我就要举起食指。这时你便会要我停止想像，并进行放松。我还要告诉你我感到焦虑的程度。

咨询者：很好。即使想像进行一段时间后，你没有举手示意，我也会让你停下来，放松一下。准备好了吗？

求助者：是的。

咨询者：好，首先我们进行放松。让自己坐得舒服些，闭上眼睛，放松……紧张开始从你的身体中流出……听到“放松”这个词，你的胳膊变得软弱无力……现在让你的脸部放松……使你脸上和脖子上的肌肉松弛下来……当我说到每一个肌肉群时，就对自己说“放松”，使所有的紧张都化解掉……Joan，如果你想到一个令人愉快的情况，你会更加放松……想像一下，冬天的晚上你坐在篝火旁……与好朋友相伴，唱着歌，烤棉花糖（第一个项目，也就是控制项目。给Joan30秒的时间想像）。现在请你想像一下你在自己房间的桌边做作业，题目非常简单，你已经很习惯回家后做作业了（第二个等级项目。咨询者用跑表记录持续时间，让她想像5到7秒钟后，观察她是否举手示意感到紧张。Joan没有反应，说明她对这个项目没有感到紧张）。好的，请停止想像，并把它从你的头脑中抹去。集中注意力于放松（停顿10到30秒）。现在请你再次想像你在自己房间的桌边做作业，题目非常简单，你已经很习惯于回家后做作业了（第二个项目的第二次呈现，咨询者让这个情境再次持续5到7秒，并观察Joan是否举起手指示意感到紧张。Joan没有反应，说明她在想像时没有感到紧张）。好

的，现在把这个场景从你的头脑中抹去，并使自己放松。让你的所有肌肉都得到放松（停顿10到30秒钟。由于这个项目相继两次呈现都没引起焦虑反应，咨询者可以进行第三个项目了）。现在请你想像自己坐在英语课堂上，还有十分钟就下课了。你想到了数学课，不知道会发生什么，比如被提问到（呈现第三个项目。咨询者让这个项目的想像持续5到7秒钟，用跑表记时，并观察Joan是否举起手指示意紧张。这一次，在6秒钟时，Joan举起了手指，说明她在想像中感到紧张）。Joan，现在你的感觉的主观干扰值是多少？

求助者：我感到大约是20。

咨询者：好的，现在把它从你的头脑中抹去……放松，让轻松像水一样遍布你的全身……再次想像你坐在篝火旁（停顿10到30秒）。现在请你再次想像自己坐在英语课堂上，快要下课了。你想到了数学课不知道会不会被提问（第三个项目的第二次呈现。咨询者让这个情境再次被持续5到7秒，并观察Joan是否举起手指示意紧张。Joan没有反应，说明她在想像时没有感到紧张）。好的，现在把这个场景从你的头脑中抹去，并使自己放松，集中精力放松好（停顿10到30秒）。再次想像你坐在英语课上，还有几分钟就下课了。你想到了数学课不知道是否会被提问（第三个项目的第三次呈现，咨询者让这个情境再次被持续5到7秒，并观察Joan是否举起手指示意感到紧张。Joan没有反应，说明她在想像时没有感到紧张）。由于这个项目的最后两次呈现没有引起焦虑反应，咨询者可以进行第四个项目了。好，Joan，停止想像这个场景。开始想像篝火……放松（变换等级项目之前可以进行一个控制项目。大约10到30秒钟后呈现下一个场景或终止这个时段）。

如果上一个时段是以第三个项目结束的,那么下一个时段就要以第三个项目开始。其他的项目也以这种方式呈现。如果Joan在连续三次呈现一个项目时都表现出紧张,那么刺激等级就需要调整。(见学习练习活动52)

学习练习活动 52/ 刺激场景呈现

这个学习活动将帮助你熟悉刺激场景呈现程序。你可以自己单独进行,也可以与他人一同进行。

1. 选择一个刺激等级。
 2. 先让自己放松。
 3. 如果你的伙伴扮演求助者角色,你可以告诉他感到焦虑后,举手示意。
 4. 呈现刺激等级中最下面的刺激项目,如果没有引起焦虑,则再次放松,然后在10到30秒后再次呈现刚才的项目。只有当一个项目连续两次没有引起焦虑后,才可以接着呈现上面一个等级的刺激项目。
 5. 记录每个项目呈现的次数、时间长短,以及是否引起焦虑。如果引起焦虑,一定要记录它所相对应的sud值。
-

家庭作业及复诊

自我练习对于成功的脱敏疗法治疗而言,是必不可少的!可以让求助者每天练习选定的放松过程、想像前一时段使用过的场景项目、接触真实情境等。

家庭作业的布置 大多数咨询者要求求助者每天练习一到两遍脱敏中所使用的放松方法。在治疗的早期阶段,训练求助者掌握去条件反射反应的同时,尤其要重视其自我练习。另外,放松

时段结束之后，咨询者可以安排求助者练习前一个时段涉及到的想像场景。录音磁带或计算机模拟的“视觉现实”可以帮助求助者自我练习。此后可以进行逐步地加入真实情境的自我练习。随着脱敏疗法的进行，要鼓励求助者参与到与等级项目相应的真实生活情境中去。这对促进求助者把在治疗中取得的进步泛化到引起焦虑的真实情境中去是至关重要的。然而让求助者去应对在治疗中没有出现过的相关的真实情境，则是有风险的。

家庭作业日志和复诊 求助者要在记录单上记录所有自我练习任务完成的情况。当所有的脱敏疗法治疗时段结束之后，可以追加治疗时段，或进一步安排会面和联系。

示范对话：家庭作业和复诊

咨询者：Joan，你已经成功地通过了刺激等级上的所有项目。我希望你按照我们已经做过的那样，自己去做一些练习。

求助者：好的。具体怎么做呢？

咨询者：我为你选择了一个项目，它大致属于中等强度的刺激等级项目。上星期你回忆它时还有些害怕，这个星期你就不再紧张了。这个项目是你在课上主动发言。

求助者：我应该怎样练习呢？

咨询者：我会把这个项目以及它前面的两个项目录在磁带上，每天你放松完之后，我希望你能借助磁带复习一下这三个项目。如果你做得很顺利，下一个星期我们将讨论你能否真的在课上的发言更主动一些。

求助者：没有问题。

咨询者：还有一件事，每当你使用磁带练习时，都要在日记上记录。同时记下练习前后你的主观干扰值。下个星期我再询问你的情况。

图19-4概括了系统脱敏疗法的所有程序步骤。可以帮你回顾

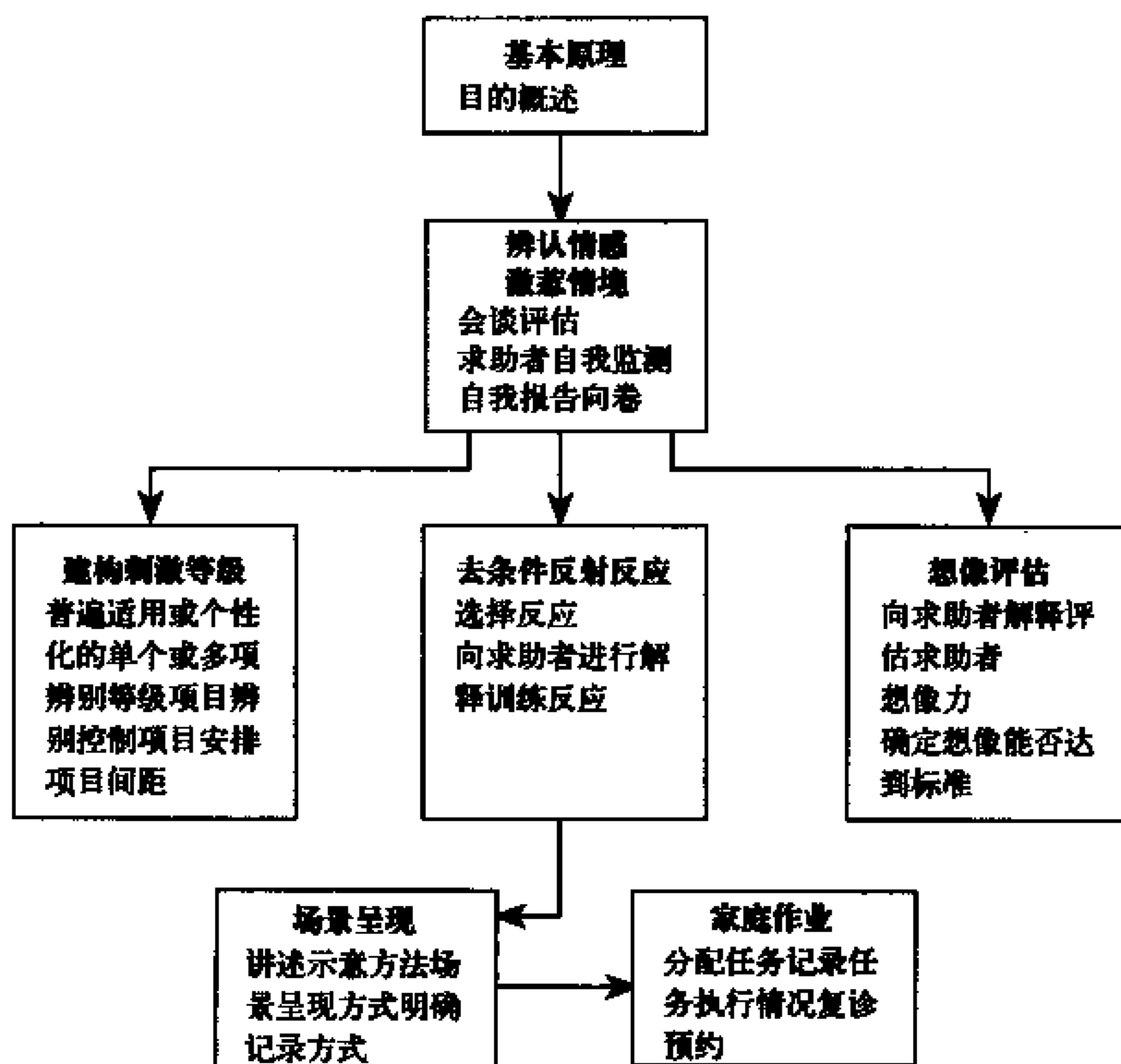


图 19-4 系统脱敏法的组成部分的扩展

一下这种治疗策略的方方面面。

脱敏疗法过程中的问题

虽然脱敏疗法可以说是一种非常有效的治疗方法，但偶尔也有一些问题可能使它很难或不可能实施。有时，我们可以减轻这些问题的影响，甚至化解它们，但有些时候咨询者则需要转而采用其他策略。

Wolpe指出了成功实施脱敏疗法的三大障碍，包括放松困难、

等级建构不当、想像能力欠缺。如果求助者不能将主观干扰值降低为10以下，那么放松所起的作用就不够。按照 Wolpe 的看法，在系统脱敏疗法之前使用某些药物效果很好，一种替代办法是通过催眠使求助者放松。另一个影响脱敏疗法实施的因素与使用的刺激等级有关。有时，由于咨询者和求助者没有对等级建构给予足够重视，未能抓住关键问题，刺激等级便不能很好地反映问题所在。如果是这种情况，就要考虑重新建构刺激等级。最后一个原因，求助者可能无法形成治疗所要求的足够生动的想像。那么，咨询者就要和求助者共同努力，将等级上各个项目描述得更加具体生动。还有一个可能是，项目引发的焦虑过于强烈，以至于求助者不能在想像中坚持下去。这时，就要在这一项目前加入另外一些项目。

使用其他形式的脱敏疗法对求助者也会有所帮助。以下将介绍另外两种脱敏疗法。

系统脱敏疗法的变式： 现场脱敏、眼动脱敏和再加工法

本章所讲的脱敏疗法是一种传统的程序，要经历几个时段的治疗，让求助者通过想像个性化的等级项目来实现。这里，将介绍脱敏疗法的两个变式：现场脱敏，眼动脱敏和再加工法。如果想得到更多的信息，读者可以读一读本章末尾所推荐的材料。

现场脱敏疗法

在现场脱敏疗法当中，求助者接受的刺激等级项目由现实生活中的情境构成。他所面对的是一系列逐渐升级的真实情境，而不是想像。这种变式方法的使用条件是：求助者对想像的控制存在困难，或者想像的情境不能使他产生焦虑，或者真实情境刺激对他更为有效。如果求助者可以置身于所害怕的情境，那么就应

选择真实的情境刺激，而不是想像场景刺激，因为真实情境见效更快，也更易于泛化。咨询者有时要陪同求助者应对所害怕的情境。现场脱敏疗法类似于参与模拟（第十二章），求助者在咨询者的帮助下完成逐渐升级的一系列困难任务。现场脱敏疗法在治疗儿童的声音恐怖和蜘蛛恐怖中都有成功经验。现场脱敏疗法还能成功地治疗成年男性有他人在旁边时不能小便的毛病、成人的突然恐慌，成人包括幽闭恐怖症的各种恐怖症，以及气球恐怖。最近，现场脱敏疗法还被用来治疗成年女性的浅层阴道痉挛。

现场脱敏治疗中主要的困难，在于对去条件反射反应进行控制。有时，求助者刚刚参与某一活动就达到很深的放松状态是很难的。McGrath、Tsui、Humphries和Yule报告了对一个九岁小姑娘实施现场脱敏疗法的情况，其中使用了对话聊天和玩治病游戏，以帮助她形成去条件反射反应。用去条件反射反应降低求助者在危急情境下的焦虑，并不总是必需的。仅仅暴露在真实刺激中，就常常可以带来对焦虑相当的缓解，尤其是当暴露程度逐步升级，而且有咨询者帮助引导的时候。Nelissen等人提出，在现场暴露中，那些与焦虑中的不合理成份相对抗的信息越多，便越容易被求助者利用，从而导致了环境中所惧怕的刺激越来越少。

眼动脱敏疗法和再加工

最近十年来，一种叫做眼动脱敏和再加工法（EMDR）的治疗方法在美国、欧洲、加拿大和澳大利亚等地被广泛使用。这项技术是由Francine Shapiro发展起来的，用来帮助求助者治疗创伤性记忆。EMDR适用于那些经历过单纯性创伤事件或多重创伤的求助者，也可用来治疗经历过车祸或烧伤的人、吸毒者，以及焦虑、抑郁、悲痛、恐怖等症状，犯罪和性侵犯的受害者。

Greenwald总结了过去的研究，其结论表明，围绕EMDR有效性的各种争论均与EMDR的实施方式有关：（1）有些咨询者接

受了EMDR规范而有指导的训练,另外一些咨询者则没有接受这种训练,两类咨询者对信息的掌握存在着很大的差别,因而他们的治疗效果差别也很大;(2)要使EMDR疗法使用得当,接受有指导的训练是必要条件;(3)即使如此,受过EMDR训练的人,也并不能保证严格按照EMDR的大纲执行。另外,Greenwald报告了令人鼓舞的研究证据,指出EMDR对于治疗创伤后应激的确有效。

加速信息加工模式 眼动脱敏和再加工法(EMDR)是Shapiro称做加速信息加工(AIP)模式中的一种特定操作方法,这一模式还包括其他一些方法。AIP模式假设有一个信息加工的神经平衡装置,当人具有这种神经平衡装置时,便会用适当的联想加工信息,并将经验整合成积极的情感和认知图式。比如,一个少年可能由于父母的在场,而在同伴面前感到不安。他开始可能被这种体验所困扰,但后来他克服了不安,并能在将来用这种信息指导自己的行为。这里,少年将由一件小事得到的信息整合起来,经过一段时间成为一种积极的图式,最后形成了一个神经平衡状态。

但是那些经历过严重创伤的人的情形如何呢?按照Shapiro的AIP理论,创伤事件似乎在人的信息加工神经系统中建立起了一种“不平衡”或者“阻塞”。这种阻断可能是由心理神经内分泌系统的改变(比如神经递质和肾上腺素等)引起的。创伤事件中获得的信息在神经系统中处于混乱状态,与事件相关的想像、声音、情感、认知、生理感觉等都被搅乱了。Shapiro提出假说,认为EMDR中的眼球运动启动了一种生理机制,从而激活了“不平衡”或“受阻塞”的信息加工系统。她提出当人想起创伤事件时,就在“意识与存储创伤信息的脑部位”建立起连接。她推测眼球运动使信息加工系统恢复了平衡,或者说移走了其中的阻塞。如果信息加工系统继续失衡和受到阻塞,人就会表现出不良的反应

模式。AIP 模式认为由创伤事件引起的心理神经内分泌混乱制造出了“冷冻的信息（以发生时的形式存储）”，它以混乱、初始和特定的形式，孤立地存储于它的神经网络中。当人被阻滞于一个不平衡的信息加工系统中时，再学习或整合新的信息是很困难的。按照 Shapiro 的观点，通过“刺激求助者固有的自我治愈过程”，神经系统的不平衡、混乱加工、不能正常工作的组织就能得到解决。

眼球运动 在 EMDR 治疗中，治疗师伸出食指和中指，用拇指压在无名指和小指上，手掌朝着求助者，并停留在距离其面部 12 到 14 英寸的地方。然后，治疗者将手指从求助者视野的最左侧，平移到最右侧，要求求助者的视线跟随手指运动。求助者和治疗者用距离、速度和手指的高度几个指标，评价求助者眼球运动的平稳程度。眼球运动除了左—右方向外，治疗者还可以引入垂直、环形、对角方向的眼球运动。据报告，求助者要想使认知材料的加工达到新的适应水平，需要经过二十四套眼球运动。对某些求助者来讲，这种治疗还需要更多的运动。每次在加工完成之后，治疗者都要问求助者“发生了什么？”或“你体会到了什么？”如果求助者表现出了较高的适应性，眼球运动就继续以相同的方向、速度和距离进行下一套运动。如果一套眼动练习之后，求助者没有什么进步，那么改变手指运动方向或许能提高求助者的适应程度。然而，除了方向之外，还有许多其他的干预措施用以帮助取得全面的疗效。EMDR 疗法中不仅仅只包括眼球运动。

在眼动再加工开始的时候，治疗者引导求助者回忆创伤事件各方面的信息，并在眼动的同时，把它们保持在意识当中。这一过程可能会引发记忆系统中的其他联系。当每个新的经验从求助者的记忆中被引导出来时，治疗者都要指导他进行一套眼动练习。新经验包括新的记忆、念头、想像、情感、任务和感觉。彼此连

接的渠道构成了求助者的记忆网络，并与创伤事件的结果相互存储、联系起来。其中不能正常工作的那些记忆是静态地连接在一起的，它们不能形成新的、有效的连接，因此神经物质处于混乱的状态；围绕这些不工作的物质，就难以形成新的学习和记忆。AIP 模式的主要思想，同时也是 EMDR 方法的特殊之处，就在于找到这些不能正常工作的信息，并对它们进行再加工，通过将那些受阻塞的记忆网络与健康网络联系起来，从而促进产生适应性的联结。

帮助求助者识别联想渠道中的特定目标，就会帮助他们接近那些不能正常工作的、受阻塞的记忆网络。训练有素的 EMDR 治疗者报告说，治疗的结果使求助者消极的想像、情感、认知和感觉逐渐化解，并被积极的想像、情感、认知所取代。求助者眼动练习的结果加速信息加工转化了不能正常工作的信息，当失衡的信息加工系统中的阻塞物被去除后，信息就可以被调整、整合成为一个能发挥作用的、积极的情感和认知图式。

Shapiro 发现除了眼球运动，还有其他刺激可以激活不能正常工作的信息加工系统。拍手、听觉复述也可以帮助求助者激活对混乱记忆的加工。拍手治疗中，求助者的手放在膝上，手心朝上；然后咨询者轻拍他的手掌，以类似眼球运动的速度交换拍打他的左右手。在使用听觉线索的治疗中，咨询者交替在求助者左右耳边出声地捻动手指，交替的速度也大体和眼球运动的速度相当。

EMDR 方法的八个阶段 EMDR 方法结合了本书前面介绍的治疗和干预过程的许多方面。

1. **求助者的简历。**这是首先需要了解的，以便决定 EMDR 是否适合这个求助者，因为 EMDR 激活寻找和加工不能正常工作的信息的过程，会给求助者带来困扰。如果求助者能够加以应付的话，治疗者就要从他讲述简历的过程中，找到将要进行再加工的“目标材料”。第一步骤包括：倾

听及动作反应；概念化并定义求助者的问题；识别、定义及评价预期目标。

2. **准备工作。**包括：与求助者建立咨惠关系；向求助者介绍EMDR理论；测试他眼球运动的平稳水平；营建一个求助者感到安全的环境，能够进行情感性想像。这一步骤需要：具有自我意识的咨询者；能建立有效咨惠关系，并增强这种关系的各种变量和因素；引导求助者练习想像的干预措施。
3. **评估。**包括评价想像的主观干扰量表值、消极与积极的认知、认知的有效性、与创伤事件相联的身体感觉等。治疗者将帮助求助者建立对创伤事件的积极认知，并依据认知效度量表（VOC）评价其积极的认知。这一步骤包括：概念化及定义求助者的问题；认知重建；检查求助者的身体感觉。
4. **脱敏疗法。**使用眼球运动或其他适当的干预措施，帮助求助者对自己消极和积极的情绪形成顿悟和再认模式，并用主观干扰量表进行评价。本章提到了这一步骤的主要特点。
5. **安置。**这一阶段要用积极认知来取代消极的认知图式，并增强替代的强度。本书第二十章——利用积极的认知来建立自我效能（信心）——可以作为这一阶段的补充。
6. **躯体扫描。**当求助者想像创伤事件，并体验积极的认知图式时，他（她）会扫描自己的身体，而且几乎不会感到任何紧张，这时躯体扫描步骤就算基本完成（见第十五章及本章所讲的脱敏疗法）。
7. **结束。**这个步骤包括五部分：建立自我效能感；想像一个安全的环境；学习治疗后的学习材料；记录任何使自己感到混乱的事件；以及使用放松、冥想和想像。本书前面所

提到的引导想像、自我监测、冥想、肌肉放松、呼吸练习和瑜伽功等，都可以在这个步骤中有选择地加以利用。

8. **再评估。**最后一个步骤要用到 SUD 和 VOC 量表，评价：
(1) 那些过去或现在令人混乱的人与事；(2) 任何可预测的、可能导致不能正常工作的记忆材料的人、事件或情境；
(3) 治疗结束后的追加练习及保持效果。在 EMDR 的最后这一阶段，可以使用本书讲过的如下方法和干预手段：
概念化，定义求助者的问题，建立治疗目标，脱敏，认知重建，自我监控，结果评估。

在有些案例中，治疗者可以在第一次治疗或者一个半小时的时间内，就通过前七个阶段。

眼动脱敏和再加工法 (EMDR) 综合了非常广泛的治疗干预手段，使得这种方法显得复杂，但卓有成效。只有那些接受了临床训练和指导的人才能使用这种方法进行治疗。如果没有经过正规的训练和指导，对任何求助者——尤其是对那些经受过某种创伤的求助者——使用 EMDR 方法都是不道德的。我们再次提醒你，如果没有接受过训练有素、临床经验丰富的治疗者的训练和指导，你就不能使用 EMDR 方法。

本章总结

系统脱敏疗法是最早用来治疗焦虑症的行为疗法。近一个时期以来，验证系统脱敏疗法有效性的研究较少，这可能是由于到 1970 年为止，反复的研究已经显示了脱敏疗法的有效性。虽然脱敏疗法实施起来比较费时，但它对于治疗焦虑和某些恐怖症却是有显著效果的方法。在实践中，许多治疗者发现，可以将脱敏疗法与其他方法结合起来使用，这有助于减轻求助者的焦虑，并使他们学会应付焦虑源情境的方法。在脱敏疗法的过程中，结合使用其他多种方法来治疗焦虑和恐惧，而且在治疗结束之后还继续

使用的话，将使求助者获得最大的收益。

用脱敏疗法治疗恐怖和焦虑，在不同人群中的应用还不十分广泛。请注意，虽然焦虑大体上说是一种普遍现象，但它特定的表现方式及致病的因素常常有很大的文化特殊性。

Shapiro发展出了最新的脱敏疗法变式，并在她的近作中加以总结，这种方法就是眼动脱敏和再加工法或 EMDR。这种方法使用有节奏的眼球运动，治疗求助者的创伤应激和记忆。有关 EMDR 应用的报道，最多的是对创伤后应激失调者进行治疗。

学习评判

第一部分

本章目标一指出，你应能够准确地从四个刺激等级中识别出三个等级。仔细阅读下列四个等级，判断它是一般的还是特殊的刺激等级。答案见后面的学习评判反馈。

刺激等级 1（恐高症）

1. 你正走在人行道上，这是一个非常平坦的街道。
2. 人行道上，你随着地势向上走。走到街尽头的时候，你回头后望，发现你已经爬上了一个小丘。
3. 你爬上一个架在二楼窗口的梯子。
4. 你驾驶着一辆小汽车，车窗外的道路盘旋上升。
5. 你驾驶着一辆小汽车，向外望时你发现你正行进在山脊上。
6. 你向着灯塔顶爬去。爬到一半时，你向下一望，发现你已经爬了很高了。
7. 你沿着梯子，爬向三层楼房的房顶。
8. 你爬上了灯塔，并向下张望。
9. 你驾驶着一辆小汽车，行进在山崖的边缘。
10. 你身处高山极顶，向周围的峡谷望去。

刺激等级 2（害怕被拒绝）

1. 在街上，你向一个陌生人打招呼，他没听见。
2. 你走进一个百货店，向一个营业员询问，遭到抢白。
3. 你请一个陌生人给你换一下钱，受到了奚落。
4. 你向偶然遇到的一个熟人借一本书，被拒绝。
5. 你约一个朋友吃晚饭，他由于很忙不能前往。
6. 你申请加入一个社交俱乐部而未能如愿。
7. 你在争取一个工作。你与另一个人参加了被应聘接见。结果录用了他，而你落选了。
8. 你与最好的朋友产生了争执。她突然离开了，你好久没有她的消息。
9. 你与爱人有了争执，她说宁愿自己一个人呆着，也不愿与你在一起。
10. 你的爱人说她不再爱你。

刺激等级 3（失去亲密关系）

1. 你记得在一个温暖的、繁星满天的夜晚，你向你所爱的人求婚。她答应了，你欣喜若狂。
2. 婚后，你们乘着大篷车去旅行，晚上就住在帐篷里。
3. 海滩上，你们两人踏浪奔跑，共度美好时光。
4. 你和爱人共进晚餐。
5. 你们因为花钱的事争吵起来。她希望储蓄起来，你希望花点钱买宿营的设备。
6. 你们由于孩子的事争吵。她希望你在旅行时将孩子带在身边，你则希望暂时找个保姆。
7. 你们开始分开吃饭，为了避开回家吃饭你工作得很晚。
8. 她完全沉浸在社交中，你全部心思扑在工作上。周末你们不在一起过。
9. 你们开始讨论两人的关系以及各自分开的活动。你开始睡

沙发。

10. 你们去找律师办理离婚的事。

刺激等级 4（惧怕发言）

1. 老师偶然提到每次课后将叫学生发言。
2. 老师传过来一个发言签名单。你签上了自己的名字。
3. 你与同学就这种发言发表见解，你不知该说什么。
4. 你去图书馆为发言寻找材料，找到的不多。
5. 你的一些同学开始发言了，你很赞赏他们的表现，不知自己的发言会是什么样。
6. 离你发言还有一个星期了，你花费许多时间做准备。
7. 发言的前一天晚上，你认真地复习笔记。
8. 发言的前一天晚上，你躺在床上想着发言的事。
9. 第二天早晨，你醒来，意识到今天要发言了。吃早饭的时候，你的胃口很差。
10. 你走向将要发言的那间教室。一个同学走过来说：“嗨，我记得今天该你了。”
11. 你坐在将要发言的那间教室里，老师随时都可能叫到你，你反复思考着自己发言的主旨。

第二部分

目标二要求你在一个案例中，从11步的脱敏疗法过程中至少识别出9个步骤，并加以描述。请仔细阅读下面的案例，然后指出其中的11个步骤并说明。

求助者是当地一所小学的五年级学生，男孩。今年，这个男孩的妹妹进了同一所学校的一年级。几个星期以后，这个名叫Ricky的求助者开始向家长和老师抱怨这所学校了。他一到学校就感到恶心，于是他的父母来学校把他接回家。经过检查，医生找不到他有什么毛病。然而，Ricky依然或者在学校感到恶心，或者早晨起床就感到恶心。周末的时候，他就会轻一些。他说他恨

这所学校，它使他感到胃里恶心却不得不去学校。偶尔，他会在早晨呕吐。父母说送 Ricky 上学越来越难了。假设你将用脱敏疗法来解决 Ricky 的紧张和逃避上学的问题，指出你将如何按照下面的11个步骤实施对 Ricky 的治疗。注意你所使用的语言应该是一个10岁的孩子能够理解的。

1. 脱敏疗法的基本原理。
2. 大概地描述一下脱敏疗法。
3. 帮助 Ricky 找出学校中引起焦虑的情境。
4. 选择应该对 Ricky 使用的刺激等级的类型。
5. 向 Ricky 介绍将用来安排等级项目的主观干扰评价法。
6. 选择 Ricky 能学会的、合适的去条件反射反应。
7. 选择衡量 Ricky 想像能力的方法。
8. 你将对 Ricky 使用的场景呈现方法。
9. 场景呈现中 Ricky 能够使用的发出信号的方法。
10. 等级呈现的记录方法。
11. 举例说明你怎样安排 Ricky 去做与脱敏疗法相联系自我练习。

答案见后面的学习评判反馈。

第三部分

目标三要求你与角色扮演的求助者一起，至少演示28步系统脱敏疗法中的22个步骤。要想包括脱敏疗法所有重要的步骤，可以通过几个角色扮演会谈来完成，根据系统脱敏疗法会谈检测清单来进行评估。

系统脱敏疗法会谈检测清单

给观察者的指导语：以下列出的是系统脱敏疗法的一些过程步骤，检查咨询者是否在实施过程中使用过了，清单的右栏列出了较好的例子。

项 目	咨询者指导的例子
I. 基本原理	
_____ 1. 咨询者向求助者讲解脱敏疗法的原理，说明它是如何起作用的。	“这个治疗过程是基于这样的观念：人们可以学会用适当的、期望的反应，比如轻松、安宁来取代某一情境下的害怕（或其他形成条件反射的情感）” “你说在某些情境下你会感到害怕（或其他情绪）。这个治疗将教会你一些方法去应付这些情境，使它们不再令你紧张。”
_____ 2. 咨询者大体介绍一下脱敏疗法的过程。	“我们主要做三件事——第一，教你学会放松；第二，找出你感到焦虑的情境，列在清单上；最后，让你在处于深度放松时想像这些情境，从较低焦虑的情境过渡到较高焦虑的情境。 “首先，你要学习如何放松和如何告知我你的紧张程度，这样你就可以让我知道你放松的情况了。然后我们将找到引起你不同程度焦虑的情境，从引起最少不舒服的情境开始，帮你来练习用放松对付压力。”
_____ 3. 咨询者察看求助者是否愿意接受这种治疗。	“你现在做好准备试一试这种疗法了吗？”

II. 识别引发焦虑的情境

—— 4. 咨询者介绍以下识别引发焦虑情境的方法中的一种:

—— a. 通过问题诱导进行会谈评估;

“你发现何时感到非常……”

“这种情况发生时你在什么地方?”

“当你感到……的时候你通常在做什么?”

“什么类型的情境引发你这样的情绪?”

—— b. 求助者的自我监测;

“我希望你这个星期追踪记录带给你这种情绪的情境。在日记上记录地点、正在做的事情、与什么人相处以及情绪的强度。”

—— c. 自陈量表。

“我们可以用这种方法详细了解哪些情境使你感到压力——由你来填写这个问卷, 答案没有对错之分, 只要写出在每个情境中你通常的感觉和反应。”

—— 5. 咨询者继续探寻引发焦虑的情境, 直到求助者识别出某些特定情境。

“让我们继续这种探讨。刚才你说到在某种人当中会感到紧张和不安。你能说一说是哪种人和他们的特征吗?”

“好的, 就是说当有权力评价你或批评你的人——比如老板或教师——在你身边时, 你总是感到非常焦虑。”

III. 等级构建

—— 6. 咨询者选择刺激等级的类

“现在, 我们将这些引发焦虑的情境

- 型:
- _____ a. 一般类型;
- _____ b. 特殊类型;
- _____ 7. 咨询者决定要使用的刺激等级的个数:
- _____ a. 单一等级;
- _____ b. 多重等级。
- _____ 8. 咨询者通过一种或较多的方法引入等级项目的识别:
- _____ a. 会谈时的提问(当求助者未放松时);
- _____ b. 求助者填写记录卡(自我练习)。
- 列出一个清单, 填写一些细节并把它们排一下序, 从引发最低焦虑的情境开始, 到引发最高焦虑的情境结束。”
- “因为随着演讲的临近, 你越来越焦虑, 我们将按照接近演讲的时间顺序安排这些情境。”
- “我们将按照人们批评你的方式的不同来安排这些项目——是谁、关于什么等等。”
- “我们将把所有不同的引发焦虑的情境编写入一个清单中。”
- “因为你对几类情境感到焦虑, 所以我们会把与批评有关的情境写入一个清单, 把与社交事件有关的情境写入一个清单。”
- “我希望写下一些能描述引发焦虑的情境的项目, 包括大量细节。”
- “给我描绘一下你母亲说什么时让你感到很不安? 她怎么说? 除了你母亲, 还有谁的批评令你感到很糟? 哪些方面的批评你最敏感?”
- “这星期我希望你在这个清单上填写一些条目, 我会给你一些空白的卡片, 每当你想起别的与批评有关的

使你焦虑或不安的项目时，就把它记在卡片上。”

—— 9. 咨询者要继续寻找合适的等级项目，直到这些项目能够符合以下的标准：

—— a. 其中的部分项目如果发生在实际场景中，求助者是可以控制的(不需要别人的鼓励)；

“你能否想出一些项目，不需要别人，你自己就可以让这些情境发生？”

—— b. 项目具体而明确；

“嗯，仅仅说你对于社交感到焦虑还有些含糊，请举出些细节，说明在哪些社交场合中你感到相当轻松，在哪些社交场合中你感到格外紧张。”

—— c. 项目要能够反映过去、现在或将来那些已经和可能引起求助者的情感反应的事件；

“想出一些项目代表着过去或当前使你焦虑的事情——也包括将来你可能遇到的会使你焦虑的事情。”

—— d. 项目代表了可能引发情绪反应的广大的情境范围；

“你能否找到一些项目，它们代表着引发情绪反应的不同类型的情境？”

—— e. 项目能代表引起不同水平的情绪反应的情境。

“让我们看一看这些项目是否会使你产生不同程度的紧张。现在得到的这些项目不会使你非常紧张，再找出一些引发更多焦虑以致使你感到痛苦的项目怎么样？”

—— 10. 咨询者要求求助者找出几个控制项目(中性的、非情感唤起的)。

“有时想像一下与引发焦虑无关的场景是有帮助的。你能否想像一些使你感到快乐和轻松的场景并描述出

—— 11. 咨询者解释按照引发情绪水平逐渐增高的顺序排列和间隔项目的原因。

—— 12. 咨询者让求助者通过主观干扰值的方法排列等级项目；向求助者介绍这种方法：

—— a. 主观干扰量表。

—— 13. 如果需要，咨询者可以通过删增项目使刺激等级代表一个相当的范围。

IV. 去条件反射反应的选择和训练

—— 14. 咨询者选择适当的去条件反射反应，用以去除已形

来？”

“虽然你将这些项目按照从引发最低的焦虑到引发最高的焦虑的顺序排列起来会花掉一些时间，但这样做了之后我们就可以得到一个逐渐增高的刺激等级，我们就可以更有条理地呈现项目，而不至于一下子用了—个非常有压力的项目。”

“现在我希望你用以下这个方法—来安排等级项目。”

“请借助一个从 0 到 100 的量表来安排这些项目，0 代表完全的放松，100 代表非常痛苦。如果某个项目一点也不会使你紧张，就—把它的值定为 0；如果只是有一点点紧张可以定为 15 或 20；你感到非常紧张的项目就给它赋一个高一点儿的值。”

“你看，在刺激等级的底部有过多的项目，因此可以去掉一些。相反，在等级顶部附近又只有三个项目，这说明这里的间隔过大了。你能否想出一个情境，它引发的焦虑介于这两者之间？我们可以把它填在这里。”

成条件反射的焦虑(或其他
形成条件反射的情绪):

- a. 深度肌肉放松; (对照性的肌肉紧张和放松)
 - b. 有指导的想像; (在想像中引发愉快的场景)
 - c. 冥想; (集中注意力于呼吸或计数)
 - d. 对抗性思考或陈述。 (专注于与自我挫败不相容的应对性的、积极的思想)
- 15. 咨询者向求助者说明脱敏疗法中去条件反射反应的目的及作用。
- “这个反应相当于焦虑的替代物。学习起来会花费一些时间,但它可以帮助你降低焦虑水平,使你能够正视而不是逃避害怕的情境。”
- “这种训练可以帮助你觉察紧张的发生,你可以用它作为去除紧张的信号。”
- 16. 咨询者训练求助者进行去条件反射反应,并建议求助者每天坚持这种反应。
- “我们会花几个会谈的时段来学习这种反应,之后你就能够把它作为一种放松的途径。你的放松对于治疗而言至关重要。在以后几周里,你在这儿练习完了之后,还要在家里每天练习两次,每练习一次都会使你放松起来更加容易。”
- 17. 咨询者在每次练习之前和之后都让求助者评价焦虑的水平或唤起程度。
- “利用一个从0到100的量表,其中0代表完全的放松状态,100代表强烈的焦虑。你认为现在你的焦虑值是多少?”
- 18. 咨询者继续对求助者进行训练,直到他可以分辨不同水平的焦虑,并表现出
- “让我们继续练习,直到你感到这种练习的确有助于你达到放松状态。”

低于10(0到100量表)的非
焦虑反应。

V. 想像力评估

—— 19. 说明脱敏疗法当中想像的
作用。

“在这个治疗当中，我会让你身临其境地想像刺激等级上的每一个项目。我们的经验表明，想像一个情境的作用和实际去经历的效果非常近似。你对想像中的不愉快情境产生的脱敏可以很容易地迁移到真实情境中去。”

—— 20. 通过以下方法检查求助者
想像的生动性：

“让我们来看一下你的想像能力怎么样，这对治疗很有用。”

—— a. 在求助者处于放松状态
时呈现控制项目；

“现在你很放松。想像一下在一个温暖的日子里，你坐在阳光下的情境。晴朗的天空万里无云，草木青翠，阳光洒在身上暖洋洋的。”

—— b. 当求助者没处在放松状态时，呈现等级项目；

“好的，想像一下你在一个聚会上，没有一个熟人——想像你和其他的人——屋子很大。”

—— c. 让求助者描述a与b激起的
想像。

“能否描述一下你想像到了什么？有哪些颜色？听到了什么？闻到了什么？”

—— 21. 在求助者的协助下，确定
求助者的想像能力是否达到了以下的标准，从而决定是否将脱敏疗法进行下去：

—— a. 求助者的想像具体，带

“你能把这个场景想像得很清楚吗？”

- 有细节;
- b. 求助者能以参加者的身份想像;
- c. 求助者能够按照提示自如地开始和结束想像;
- d. 求助者可以控制住想像, 而不会发生漂移和再现;
- e. 求助者没有别的困难。

你还记得哪些细节?”

“当你想像的时候, 你能否感到你身在其中, 而不只是一个旁观者, 就象是看着别人在做事情一样?”

“我向你说出一个场景之后多久你就可以想像出来? 我说‘停止’之后多久你就可以停止想像?”

“你是否曾经不能专注于某个情境, 想像开始开小差?”

“你想像的过程中, 你是否把想像的内容换成了别的情境?”

“你发现有别的什么影响了你的想像了吗?”

VI. 等级场景呈现

- 22. 介绍场景呈现的方法。
- 23. 检查求助者的焦虑水平, 让求助者保持想像5到7秒钟, 然后说“停止”来终止想像。
- 24. 在场景呈现的每个时段中:
 - a. 先进行肌肉放松或其他过程, 使求助者达到场景呈现前的放松水平;
 - b. 从最初的等级项目(引

“我将把刺激等级上的一个项目呈现给你, 你要尽力把它想像清楚。我会观察你在想像中是否对我发出焦虑的信号。”

“想像这个场景使你的主观干扰值增加了多少?”

“放松你全身的肌肉, 同时你的整个身体变得越来越沉——体会紧张从你的全身抽走了——放松你手部和胳膊的肌肉……”

“在第一个时段里, 我将呈现等级底

发最小焦虑的)开始呈现,在前一个项目成功呈现之后再进行下一个项目;

—— c. 描述等级项目让求助者想像5到7秒钟:

—— (1) 如果求助者想像时没有示意焦虑,让他停止想像,并放松10到30秒

—— (2) 如果求助者在想像之中或之后表现出了紧张,让他评价主观干扰值并抹掉这一想像,休息10到30秒。之后,咨询者再次呈现相同的项目5到7秒,观察求助者是否伸出手指示意感到紧张。

—— d. 10到30秒的停顿之后,将项目再次呈现;

—— e. 在新项目呈现之前,保证前一个项目至少成功

部的项目作为开始。”

“今天——作为巩固——我们从上星期结束了的那个等级项目开始。”

“想像你坐在教室里,等待考卷发到你,不知道自己还能记起多少知识。”(数5到7秒)

“现在停止想像,休息一会儿。想像你坐在温暖的阳光里,头顶上是蔚蓝的晴空。”

“你感到主观干扰值是多少?”

“现在请你想像相同的事情。集中注意力使自己保持很放松的状态,然后想像你坐在教室里,等待考卷发到你,心里想自己能记起多少知识。”

“我将再次呈现这个场景。请放松,然后想像……”

呈现(没有焦虑)两次(顶端的刺激还要求多些);

—— f. 如果一个场景呈现三次以后还会引发焦虑, 要调整刺激等级或求助者的视觉想像过程;

—— g. 呈现场景要使用标准的引导语, 避免只对没有焦虑的反应给予强化;

—— h. 以一个成功的项目(至少连续两次不产生焦虑)结束每一项目呈现时段;

—— i. 每个时段的结束:

—— (1) 场景呈现 15 到 20 分钟之后

—— (2) 求助者表现出疲劳或注意力分散时

—— 25. 使用书面方法记录求助者在刺激等级上的进展。

VII. 自我练习和追加练习

—— 26. 布置与脱敏进展相应的自我练习任务:

—— a. 每日练习所选择的放松;

“让我们来看一看使什么阻碍了治疗。你是否觉察到在想像着以场景时想像漂移到别的东西上去了, 然后又重现了? 你能否想出一个压力稍微轻一点的情境加在这里?”

“好的, 看来这个场景不再使你感到压力了, 现在请放松一会儿。”

“你感到在从 0 到 100 的量表上, 现在的焦虑是多少? 20? 好, 放松一会儿, 然后我再把这个场景呈现一次。”

“好的, 既然你连续两次报告主观干扰值是 5, 那么今天我就在这个项目上结束吧。”

“今天我们已经做了相当的工作。现在放松一会儿, 然后结束今天的治疗。”

“在治疗的过程中, 我将记录每个项目进行了几次以及你每次的主观干扰值。”

“这个星期希望你在家中每天练习这一内容。”

“在安静的地方, 每天练习两次这个

- | | |
|--------------------------------|---|
| | 放松过程。” |
| —— b. 前一次会谈中完成了的想像项目; | “这个磁带上记录着本星期我们使用过的三个场景。下一个星期,你在家中做过放松之后,练习想像这几个场景。” |
| —— c. 在现实生活中应付与成功完成的项目相对应的情境。 | “现在你已经具备了独自参加聚会的能力。在我们的刺激等级上,你已经可以毫无压力的想像这件事了。” |
| —— 27. 指导求助者在日记上记录每天自我练习的完成情况。 | “每当你进行了一次自我练习后,就把它记录在你的日记上。” |
| —— 28. 安排追加练习或联系。 | “两星期之后与我联系,告诉我你的进展情况。” |

观察者评语:

参考文献

- Acierno, K., Tremont, G., Last, C., & Montgomery, D. (1994). Tripartite assessment of the efficacy of eye-movement desensitization in a multi-phobic patient. *Journal of Anxiety Disorders*, 8, 259-276.
- Edinger, J., & Radtke, R. (1993). Use of *in vivo* desensitization to treat a patient's claustrophobic response to nasal CPAP. *Sleep*, 16, 678-680.
- Foss, D., & Hadfield, O. (1993). A successful clinic for the

- reduction of mathematics anxiety among college students. *College Student Journal*, 27, 157–165.
- Greenwald, R. (1996). The information gap in the EMDR controversy. *Professional Psychology: Research and Practice*, 27, 67–72.
- Guglielmi, S., Cox, D., & Spyker, D. (1994). Behavioral treatment of phobic avoidance in multiple chemical sensitivity. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 25, 197–209.
- Kamimura, E., & SaSaki, Y. (1991). Fear and anxiety reduction in systematic desensitization and imaging strategies: A comparison of response and stimulus oriented imaging. *Japanese Journal of Behavior Therapy*, 17, 29–38.
- King, N. (1993). Simple and social phobias. *Advances in Clinical Child Psychology*, 15, 305–341.
- Hoffman, S., Herzog-Bronsky, R., & Zim, S. (1994). Dialectical psychotherapy of phobias: A case study. *International Journal of Short Term Psychotherapy*, 9, 229–233.
- Horne, D., Vatmanidis, P., & Careri, A. (1994). Preparing patients for invasive medical and surgical procedures: II. Using psychological interventions with adults and children. *Behavioral Medicine*, 20, 15–21.
- Menzies, R., & Clarke, J. (1993). A comparison of *in vivo* and vicarious exposure in the treatment of childhood water phobia. *Behavior Research and Therapy*, 31, 9–15.
- Morris, R. J. (1991). Fear reduction methods. In F. H. Kanfer & A. P. Goldstein (Eds.), *Helping people change* (4th ed., pp. 161–201). New York: Pergamon Press.
- Pitre, A., & Nicki, R. (1994). Desensitization of dietary restraint anxiety and its relationship to weight loss. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 25, 153–154.
- Schneider, W., & Nevid, J. (1993). Overcoming math anxiety: A comparison of stress inoculation training and

- systematic desensitization. *Journal of College Student Development*, 34, 283–288.
- Shapiro, F. (1995). *Eye movement desensitization and reprocessing: Basic principles, protocols and procedures*. New York: Guilford.
- Silver, S. M., Brooks, A., & Obenchain, J. (1995). Treatment of Vietnam war veterans with PTSD: A comparison of eye movement desensitization and reprocessing, bio-feedback, and relaxation training. *Journal of Traumatic Stress*, 8, 337–342.
- Strumpf, J., & Fodor, I. (1993). The treatment of test anxiety in elementary school-age children: Review and recommendations. *Child and Family Behavior Therapy*, 15, 19–42.
- Thomas, R., & Gafner, G. (1993). PTSD in an elderly male: Treatment with eye movement desensitization and reprocessing (EMDR). *Clinical Gerontologist*, 14, 57–59.
- VanHout, W., Emmelkamp, P., & Scholing, A. (1994). The role of negative self-statements during exposure *in vivo*: A process study of eight panic disorder patients with agoraphobia. *Behavior Modification*, 18, 389–410.
- Vaughan, K., Armstrong, M. S., Gold, R., O'Connor, N., Jenneke, W., & Tarrier, N. (1994). A trial of eye movement desensitization compared to image habituation training and applied muscle relaxation in post-traumatic stress disorder. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 25, 283–291.
- Wilson, S. A., Becker, L. A., & Tinker, R. H. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) treatment for psychologically traumatized individuals. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 63, 928–937.
- Wolpe, J. (1990). *The practice of behavior therapy* (4th ed.). New York: Pergamon Press.

学习评判反馈

第一部分

1. 一般的。项目是按照距离地面升高的高度安排的。
2. 特殊的。项目是围绕拒绝的主题来安排的。
3. 特殊的。项目是按照一对夫妇从愉快到不愉快的顺序安排的。
4. 一般的。项目是按照时间安排的，情境越接近，恐惧越强。

第二部分

下面给出对脱敏疗法11个步骤的一种描述，请对比一下与你的回答是否相似。

1. 基本原理——“Ricky，现在似乎去学校对你来说很困难，甚至一想到学校你就恶心。我看学校有些方面使你不安，让我们来一起寻找一下是什么使你很厌烦。我会帮助你变得能去上学，而且不再为上学感到恶心。这样你就可以去上学了，而且感觉很舒服。你觉得怎么样？”
2. 治疗概况——“有几件事情需要我们一起做。首先，我们谈一谈使你不安的关于学校的事情。我将让你想像这些事，用来代替你实际做这些事时的不安。然后我教给你一个保持平静、不再恶心的方法。我们将在这间屋子里练习很长时间。但很快你就可以回到课堂上，感觉很平静，并表现出众。”
3. 找出焦虑情境的方法——
 - a. 会谈中加以引导，比如“Ricky，你在学校里做什么时感到恶心？是什么关于学校的东西使你愿意呆在家里？在学校时发生了什么事情使你觉得厌烦？何时你

对学校的感觉最为不安？”

- b. 通过求助者的自我监测：“Ricky, 你能把你在学校的有关情况记录下来给我吗？每当你为学校感到不安时，请记下发生了什么事，或者当你正在想什么时感到了不安或恶心。”
4. 刺激等级的类型：使用特殊等级，应该由与学校有关的焦虑源情境组成。除了焦虑源情境组成的等级之外，还可以建立另一个特殊刺激等级来减轻他的妒忌。逃避学校可能暗示着 Ricky 害怕妹妹夺取父母的宠爱。
5. 排序方法：主观干扰评价法可以对 Ricky 使用。咨询者需要多用一些时间向他解释。这种方法并举例说明，可以举出主观干扰值是 90 和 10 的例子。
6. 去条件反射反应：肌肉放松可以很容易的用在 Ricky 这么大的孩子身上，只要告诉他（通过示范）不同的肌肉群以及如何收缩和放松肌肉。
7. 想像评估的方法：让 Ricky 给你讲述他的白日梦以及他喜欢做的一些事情，放松训练之前和之后让他想像或者装做做这些事。然后，让他描述想像中的细节。孩子常常比成人有更为生动、更具描述性的想像力。
8. 场景呈现：告诉 Ricky 想像咨询者提出的场景，并用举起食指的方法示意这个场景在他的头脑中非常清晰。咨询者要让他将想像保持 5 到 7 秒钟，用“停止这个场景”来结束。接下来，咨询者让他用主观干扰值来表示焦虑的大小，咨询者可以提问“想像这个场景使你的主观干扰值上升了多少？”
9. 示意方法：咨询者应该告诉 Ricky 通行举起一个手指来表示他清楚地想像出了这个场景。
10. 记录方法：最容易的方法莫过于在刺激等级卡上记录每个

项目呈现的次数、时间，以及 Ricky 方法呈现之时、之后是否报告感到“紧张”。记录方法如下：

项目号_____日期_____

项目的呈现

+5 -7 +5 +7

这个项目呈现了四次；数字代表呈现时间；“+”表示没有引起焦虑，“-”表示紧张。

11. 可以布置这样的自我练习：

- a. 引发焦虑的一系列情境
- b. 肌肉放松的练习
- c. 会谈中提到的项目的练习
- d. 自我暴露于某些与学校有关的真实情境中

第三部分

可以由你自己或一个观察者按照以下的系统脱敏疗法会谈检测清单来评价你进行的脱敏疗法。

第二十章 自我管理策略：自我监测、刺激控制、自我奖赏、自我偶像和自我效能

咨询者要在治疗过程中帮助求助者，使他们逐渐对自己的行为承担越来越大的责任；而求助者则要在治疗以外的时间，完成大部分的治疗和康复工作。大多数精神健康工作者一致认为：治疗的主要目标是协助求助者，使他们成为能够掌握自己命运、独立地生活的人。

对自我管理的定义至今还未达成共识，这其中部分原因在于术语使用的混乱。比如，自我改变的方法被称为自我控制、自我调整，或自我管理。我们更喜欢“自我管理”一词，因为“自我管理”暗示着使用某种技巧来指导和掌握人生，同时这个词也避免了“控制”、“调整”所隐含的抑制和压抑等含义。不论用哪个词，人们对自我管理所包含的过程看法是一致的。Bandura指出，社会认知理论认为人类行为是由正在进行着的自我影响过程激发和调整的。自我管理主要有下述四项基本功能：（1）对行为及其构成和效果进行自我监测；（2）对行为的评价；（3）情感性的自我反应；（4）自我效能。由于自我效能感深深影响着人们的思想、情感、动机和行为，所以自我效能在个人能动性训练中处于核心地位。在治疗中，自我效能对于帮助求助者达到治疗目标、增强信心以及提高执行自我管理策略的能力都很重要。咨患之间由于治疗而建立起来的联盟非常重要，它可以激发求助者成为“一个合作的观察者、报告者和自我改变的执行者”。改变行为常常具有挑战性，而又常常令人不愉快。如果让求助者参与制定治疗计划和制定治疗目标，他们将会愿意执行治疗方案，并有可能达到更

令人满意的治疗效果。最后，正像 Kanfer 和 Gaelick-Buys 提出的那样，客观情境常常是无法改变的，所以求助者必须学会应对技能，以便应付这些不变的外界情境。

自我管理策略可使求助者出现以下转变：（1）在完成各项任务和进行人际交流时，以及在认知和情绪等方面，会表现出更为有效的行为；（2）改变对问题情境和对别人的认知和态度；（3）改变或学会对付引起压力的处境。本章介绍了以下四种自我管理策略：

自我监测——对自己的特定行为（思想、感情、行为）进行观察和记录。这些行为涉及自己以及自己与环境之间的相互作用。

刺激控制——事先安排好那些可能会增加或减少目标行为的刺激和线索。

自我奖赏——在自己做出所期望的反应之后，给予自己一个积极的刺激。

自我偶像——把自己作为一个榜样人物，观察自己用理想的方式进行目标行为。

这四种策略都可视为自我管理，因为在每个过程中，求助者都要以自我引导的方式进行自我监测、自我改变、自我奖赏、自我模仿，并获得自信（自我效能），以便在进行某个特别任务的同时达到改变自己行为的目标。自我效能训练是咨询者尽力使求助者产生自信的过程。我们将在本章后面介绍自我效能训练。正像前面各章反复强调的那样，所有这些干预策略都无法避免求助者个人经历、性别、年龄、文化背景、民族以及当时所处的环境等变量的影响。

除了以上这四种自我管理方法外，求助者完全可以用自我引导的方式进行任何治疗策略。比如，求助者在没有咨询者帮助的情况下，可以借助放松训练的录音磁带进行放松训练，从而缓解

焦虑。事实上，求助者的自我管理对于每一个成功的治疗案例而言，都是必不可少的。在本书介绍的各种治疗策略实施方案中，已经隐含了自我管理的许多因素，它们主要在以下四个方面表现出来：

1. 会谈中的求助者自我引导练习。
2. 真实情境中（如完成家庭作业）的求助者自我引导练习。
3. 家庭作业中求助者对目标行为完成情况的自我观察和记录。
4. 成功完成咨询步骤和家庭作业后，求助者对自己进行的言语或物质奖赏。

本章目标

1. 根据给出的案例，向求助者指出如何使用自我监测和刺激控制法。
2. 向另一个人教授如何实施自我监测的自我改变策略。
3. 根据给定的案例，说出对于该求助者使用的文化相关的自我管理方法。
4. 向另一个人教授如何使用自我奖赏、刺激控制、自我监测和自我偶像方法。

自我管理策略的临床应用

临床上已经广泛使用了自我管理策略，涉及的健康问题包括：艾滋病、关节炎、气喘病、心脏病、囊肿纤维化、糖尿病、癫痫、头痛以及个人的健康维护等。应用自我管理策略的心理问题有：孤独症、情绪失常、行为失常、食欲过盛、抑郁症、青春期情感混乱以及失眠症等。自我管理模式还可以和社会支持结合起来使用，用来缓解求助者的悲痛，帮助他们戒毒和戒酒，弥补发育能力缺陷，并改善落后学生的课堂行为等。自我效能量表可用于自

自我管理，用该量表的分数预测求助者的自我管理行为。

自我管理在跨文化咨询中的应用

自我管理策略已经在各种人群中使用，如行为医学、HIV 教育和预防计划中的求助者。Jacob、Penn、Kulik 和 Spieth 研究了自我管理与正性强化的效果。他们请非裔美国妇女报告在为期九个月的时间里进行乳房自我检查的履行率，发现自我管理和正性强化策略都能促使这些妇女坚持进行自我检查，尤其是那些一开始就被指定为“检查者”的妇女。

Roberson 以那些被诊断为患有慢性疾病，并生活在乡村的成年非裔美国人为对象，研究了自我管理策略和坚持性的关系。她发现这些病人和医生对坚持性持有不同观念，而且双方的治疗目的也不相同。病人认为坚持治疗意味着明显的康复，并得到易于操作、可行而有效的治疗。他们用于对付疾病的自我管理策略与自己的生活风格、信念模式、个人特点相互协调。他们相信这种自我管理对治疗和康复都有效果。Roberson 指出，治疗者不应过多地指责求助者没有坚持治疗，而应鼓励和促进求助者以自己的努力应付疾病，使他们生活得更好。

在一个相关的研究中，Haire-Joshu、Fisher、Munro 和 Wedner 比较了两组病人对自我管理疗法的态度。这些病人都是非裔美国成年人，都患有哮喘病。不过一组病人在急救中心接受治疗，而另一组病人则住在强调自我管理策略的私人诊所。与第二组学习过预防哮喘自我管理技巧的病人相比，急救中心的病人更愿意进行自我管理治疗，并避免或延后他人的帮助。Rao 和 Kramer 发现在婴儿患有镰刀细胞病的非裔美国母亲中，自我控制是她们减轻或应对压力的一个重要方面。

还有研究发现，自我管理是减低同性恋男性感染 HIV 训练计划中的重要课程。在一个新近的研究中，数百名非裔美国青年接

受了八个星期预防HIV风险的自我管理疗法训练。研究比较了分别只进行教材讲授或技能训练与综合进行教材讲授和技能训练的效果,结果发现综合使用两种方法的青年人比另一组青年人降低了感染率,性行为的冲动性也得到了更大的控制。

上述研究中的参与者都是非裔美国人。他们使用自我管理策略时可能有一些与他们自己的价值观、信念及行为模式相适应的东西。如在认知重建一章,我们提到一些非裔美国妇女报告说学会了在生活中自强自立的普遍原则。这些价值观、信念以及行为模式和那种认为治疗应改善行为而不仅仅是“谈话”和自我探讨的观念,正好与使用自我管理策略的理念相契合。自我管理似乎可以纳入体现各种文化特点的干预措施中,因而对具有不同文化背景的求助者都行之有效。特别需要指出的是,自我管理是一种“现时性”的策略,它处理“现时”的问题,注重“问题的具体解决结果”。自我管理也会吸引那些不喜欢传统的精神健康服务、或对之感到不舒服的少数民族求助者。因为自我管理疗法是由求助者自我引导的,主要在咨询疗程之外进行。

然而并不能认为自我管理作为干预措施适合于来自任何文化群体的求助者。McCafferty提出,在不同的文化和不同的社会中,自我调控过程是有差异的。而自我管理中所涉及的许多概念都植根于欧洲文化。Casas宣称自我管理的“一些基本概念可能与少数民族的生活经验不一致,特别是由于种族主义、歧视、贫穷生活的影响,人们可能产生了一种与自我调控方法相反的认知模式(比如外控源、责任推卸、习得性无助)”。我们在第十一章讨论了制定治疗计划中的各种观点,并提到Sue和Sue的四象限文化身份模式理论,这四个象限从内控过渡到外控,从内在责任过渡到外在责任。这样,控制源和责任的内外归因可能就是影响自我管理是否适合于某些妇女和少数民族求助者的中介因素。St. Lawrence进行了一项创造性的研究,要求非裔美国男女青年回答下列有关

问题，如艾滋病知识、避孕套使用态度、艾滋病病毒传染性、避孕措施偏爱及控制源。内控越高的人使用避孕套的可能性就越大，其中女孩的比例要高于男孩。除去这两个中介因素外，研究者还发现对自己文化的认同感，对美国文化的趋同和同化程度也都是重要的中介变量，它们对少数民族求助者使用自我管理策略都产生着影响。

表 20-1 自我管理研究领域举例

艾滋病	酗酒
愤怒	关节炎
哮喘	孤独症
行为障碍	贪食症
心脏病	课堂行为
膀胱纤维瘤	抑郁症
生长性无能	糖尿病
情绪不稳定青少年	癫痫症
自我描画	头痛
健康自我维护	海洛因吸食
失眠症	心境
疼痛	小儿麻痹症
自我管理量表	社会支持
自我效能	

对不同文化背景的求助者使用 自我管理治疗的指导原则

我们建议使用如下的指导原则进行跨文化自我管理治疗：

1. 在评估自我管理策略是否有时，要考虑求助者的生活风

格、信仰、行为模式及个人价值观等因素。例如，若求助者的认知风格是对事件的发展过程感兴趣，那么对其使用自我监测策略便是适当的；若求助者没有这方面兴趣的话，使用自我监测策略便是浪费时间。

2. 干预策略要与求助者的文化相配合。有些求助者的成长过程使他们变得十分保守，他们不愿意将自我监测资料公之于众。而另外一些求助者则缺乏自律，难以为了自我监测而坚持做某事，如到有吸烟椅子的地方进行戒烟。求助者的成长经历不同，接受自我奖赏观念的程度也不同，因此奖赏也必须根据求助者的性别和文化进行调整。
3. 要了解求助者的世界观（见第十一章），并据此来判断自我管理的适用性。对于那些来自强调外源控制和外部责任文化的求助者，自我管理是没有作用的。
4. 要根据求助者进行咨询治疗的目的和他们的生活环境来判断自我管理策略的适用性。如果求助者生活艰难，环境压抑，并存在着种族主义、种族歧视和种族压迫，那么自我管理策略就不太可能发挥作用。假设你是一个收入很低的妇女，没有任何社会支持和社会联系，并常常遭受同居男人的打骂。而这时咨询者告诉你要进行某种自我管理治疗，这当然是很难想像的事情！

有效自我管理策略的特征

如果能很好地计划和执行自我管理策略，它就会表现出一些在咨询者主导的治疗过程中不甚明显的特征。第一，它可以增加求助者对环境的控制感，减少对咨询者和其他人的依赖；增强的控制感会促使求助者采取行动。第二，自我管理策略非常实用，既不需要花费很多，又可以随时进行。第三，它对求助者来说很适用。有时求助者会拒绝进行“咨询者主导的治疗”（如戒烟或减

肥),但他们可能会同意使用自我管理治疗方法。对于那些不信任咨询治疗的求助者来说,自我管理方法具有特别的优势。事实上,一项研究表明,那些从来没有接受过咨询的人比起那些有过咨询经验的求助者,更愿意使用自我管理策略。最后,自我管理策略还可使学习效果进一步扩大,从会谈咨询扩大到实际生活,从问题情境扩大到一般情境。正是这些优点促使研究者和咨询者不断使用和探索自我管理策略,研究其有效成份和成功的疗效。虽然还有很多问题,但我们仍然可以指出在进行有效的自我管理治疗时,下面几个因素很重要:

1. 各种策略的组合,有些着重于行为的前提,有些则着重于行为的后果。
2. 在一段时间里坚持使用这些策略。
3. 求助者的自我评价,设立目标和自我效能感的情况。
4. 使用内隐的、言语的以及实物的自我管理方法。
5. 外部环境的支持程度。

策略组合

通常组合策略要比单个策略更有用。在一项控制体重的研究中, Mahoney、Moura和Wade发现使用自我奖赏会显著地加强自我监测和对刺激物的控制。而且,同时使用自我奖赏和自我惩罚策略的求助者要比只用一种策略的求助者,体重减轻的效果更明显。Greiner和Karoly也发现同时使用自我监测、自我奖赏和制定计划策略的学生,学习成绩提高得更快,而只使用一种策略的学生效果则没有那么明显。Mitchell和White发现患者头痛频率下降的程度与他们同时使用自我管理策略的数量直接相关。Perri和Rihards, Heffernan和Richards的研究表明,自我控制成功者使用的策略数量更多,坚持的时间更长;而自我控制不太成功者则相反(成功者是指将目标行为增加或减少至少50%,并

将这种改变至少持续几个月时间的人)。使用综合自我管理策略的问题领域有：减低体重，人际关系技巧训练，焦虑，成瘾障碍，抑郁，失眠症，学习问题。另外，在长期控制肥胖的治疗过程中，自我强化、刺激控制和自我监测都是维持治疗继续进行的重要策略。

坚持应用策略

持续而有规律地使用这些策略对于自我管理治疗的成功是非常重要的。自我管理治疗不成功常常不是因为这个策略无效，而是因为没有持续地使用这个策略。自我控制成功者较之不成功者更经常和更持久地使用这些策略。如果自我管理的努力不持续一段时间的话，它的效力也许太弱会因为而无法产生任何变化。

自我评价、设定目标和自我效能

自我评价、设定目标和自我效能是自我管理方法中的重要组成部分。证据表明，自我选择的严格标准（目标）对于操作有正面的影响。自我效能或对设定目标能力的自信水平也起着重要的作用。自我控制成功者通常为自己设定较高的目标或标准，但是标准必须是现实的、能够达到的，否则自我强化就不可能发生。

自我强化

自我强化，无论是内隐的，还是言语的或实物的，都是自我管理方法的重要组成部分。能够在心里表扬自己并注意到积极改变的迹象，与自我改变有着密切联系。相反，自我批评（内隐和言语的）则阻碍变化。实物自我奖赏（如金钱）可能比自我监测和自我惩罚更有作用。自我强化还必须与求助者的性别和文化相关联。

环境支持

某种程度的外部支持对于自我管理策略产生疗效是必要的。例如，公开自己的监测资料和他人的帮助都提供了社会强化，而社会强化有助于自我改变。自我控制成功者说他们得到了比别人更多的积极反馈，为了维持自我改变的效果，就必须有社会和物质的支持。

为求助者设计自我管理方案的步骤

下面我们介绍自我管理方法的步骤，并将刚刚介绍完的有效自我管理特征加入进去一起讨论。只要在自我治疗中用到刺激控制、自我监测或自我奖赏策略，下述的步骤就是适用的。图 20-1 总结了各个步骤，左侧所列即为自我管理方法的特征。

第一步和第二步包括设定目标 and 自我评价。求助者在步骤 1 中要确认出目标行为以及原因和后果，并将它们记录下来。求助者还要收集基线数据，并据此监测行为的变化。如果问题评估（第九章）中没有收集这方面的数据，这时就要加以补充。求助者在步骤 2 中要具体明确地定义目标行为、改变条件和改变程度。第十章曾提到，行为、条件和改变程度是治疗目标的三个组成部分。而确定目标是自我管理策略的重要步骤，因为设立目标对求助者来说有着动机作用。

第三步和第四步用来帮助求助者选择出自管理策略的组合。咨询者要向求助者解释清楚所有的策略（步骤 3），并强调求助者选择出的策略应当包括两类，一部分策略要与行为原因发生联系，而其他的策略则要用于操作和管理行为结果。求助者最终要自己决定应当选用哪些自我管理策略（步骤 4），求助者自己选择策略是自我管理和自我引导方法中很重要的一步。

第五至第九步涉及各种具体操作，用以增强求助者的投入，

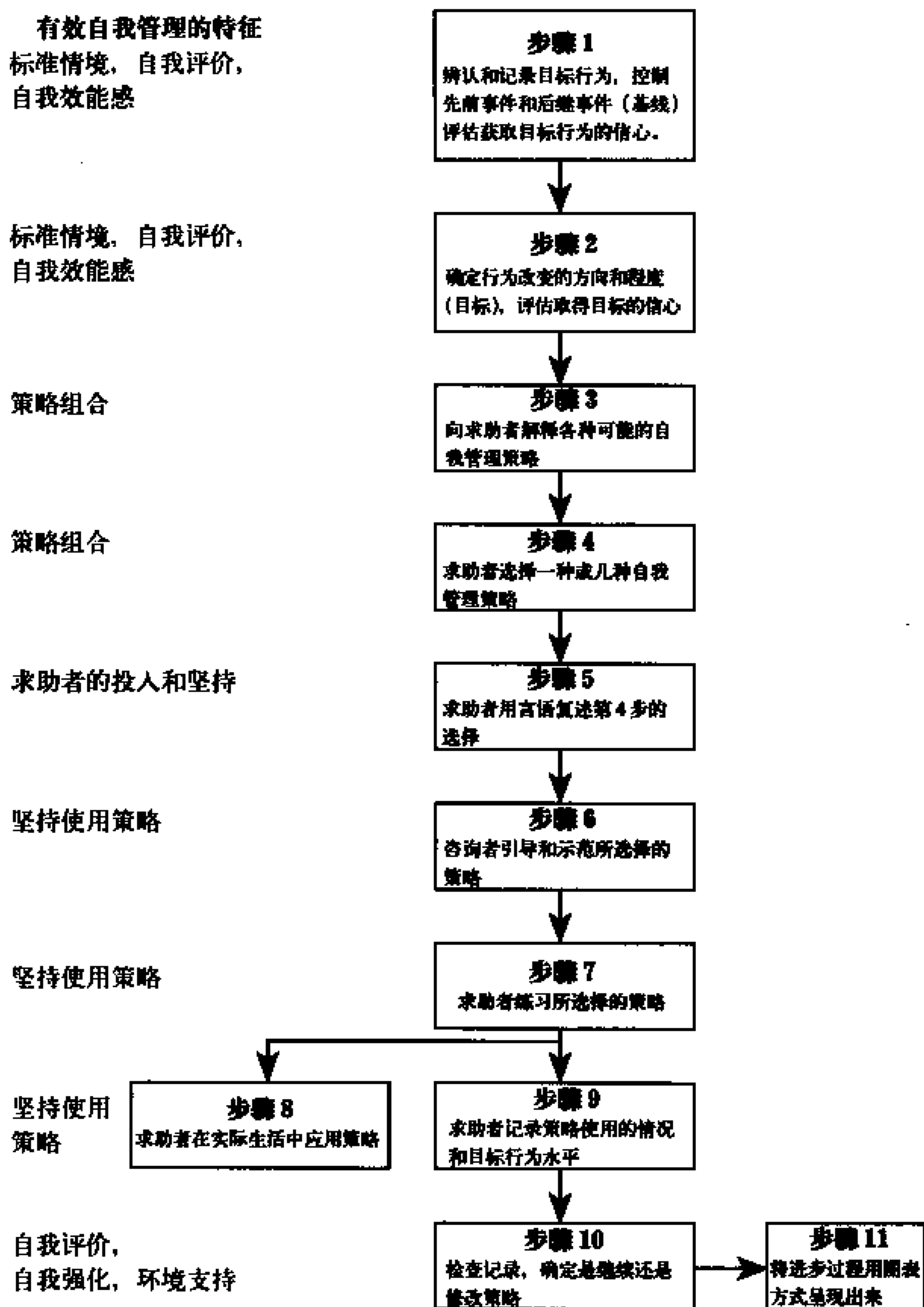


图 20-1 有效自我管理方法的建立

鼓励求助者坚持较长时间运用策略组合。首先，求助者要明确行为要有多大程度的改变，以及为了达到行为改变的目标需要采取哪些具体行动（步骤5）。其次，咨询者要告诉求助者如何实施所选择的策略（步骤6）（咨询者可参照本章后面所列的指导原则）。清晰的引导语和咨询者的示范将使求助者能够更准确有效地实施自我管理策略。如果求助者能够有机会在咨询者的辅导下预演全过程的话，则他们进行自我治疗的效果就会更好（步骤7）。最后，求助者实际应用自我引导策略（步骤8），并记录下策略使用的频率和目标行为改变的程度（步骤9）。自我管理的疗效在某种程度上也有赖于求助者做记录的情况。

第十步和第十一步包括自我评价、自我强化和环境支持等。求助者可利用在前几步收集的数据来评价行为改变的情况（步骤10）。评价结果可显示出哪些策略进行得顺利，哪些策略需要进行调整。表明有进步的评价结果也是进行自我强化的一个时机。将每一个进步制图并张贴出来（步骤11），会增强自我强化的效果，并能得到周围环境的各种支持，这样就能使行为改变长久地保持下去。

下面将描述如何用自我监测方法记录目标行为。进行问题评估和设立治疗目标时需要行为记录进行自我改变策略时也需要行为记录。我们将具体讨论如何应用自我监测方法促使行为发生改变。

自我监测的目的、使用 and 过程

自我监测的目的

在第九章我们将自我监测定义为观察、记录自己的行为及自己与周围环境交互作用的过程。自我监测是进行问题评估时非常有用的手段，因为观察资料能够证实或改变求助者关于问题行为的口头报告。我们建议求助者要在指定的时间内观察并记录日常行为，主要是问题行为及其前因后果。Thoresen 和

Mahoney 宣称,自我监测是任何自我改变过程的首要步骤。求助者必须能够发现在实施自我改变策略之前所发生的行为,这就像咨询者必须在进行治疗前先了解求助者的情况一样。自我监测也可以利用第九章提供的行为日志记录表。如果在问题评估时已经进行了有关的行为观察记录,那么在自我管理治疗时则无须再做自我监测。

自我监测对于评价治疗目标和治疗结果也十分有用。治疗前和治疗进行中,求助者“自我监测的主要功用在于进行评估和采集资料”。近些年来,咨询者和研究者们注意到,自我观察本身就能产生行为改变。收集自己行为资料的过程可以对被观察的行为产生影响。现在我们知道自我监测不仅有助于收集资料,而且能够促进求助者行为的改变。所以如果能够很好地安排和执行自我监测策略,它本身就是一种自我管理治疗方法。

临床使用自我监测

许多研究和临床报告都将自我监测作为主要的治疗策略进行过探讨。如下列自我监测法的研究领域,包括:学业成绩,职业升迁,课堂行为,跨文化适应,健康冒险行为。其他领域还有免疫系统、心境、问题解决、失眠、减轻体重等。

影响自我监测反应性的因素

第九章曾谈到自我监测有两个应关注的问题,一个是自我记录的可靠性,另一个是自我监测的反应性。评价目标行为时自我记录的可靠性即准确性很重要,但将自我监测作为一种行为改变策略使用时,资料的准确性就不那么关键了。从咨询的角度来讲,自我监测的反应性就很适合行为改变策略。例如, Kanfer 和 Gaelick-Buys 提到过,一对夫妻曾用自我监测法观察他们自己的争论行为。后来他们报告说,每当监测仪(录音机)打开时,他

们就会停止争论。

反应性在资料收集过程中是个问题,但在使用自我监测治疗策略时它却是有益的。这时要尽量扩大自我监测中的反应性,至少要达到行为改变的目标。

有许多因素影响自我监测的反应性,总结这些因素发现:当求助者能够持续监测少量的、具体而积极的目标行为时,当所提供的反馈信息、目标或标准十分清楚时,或者当监测行为十分突出并且与目标行为在时间上十分接近时,自我监测最有可能导致积极的行为变化。

Nelson 总结出八个有关变量,影响着自我监测反应性的发生、强度和方向:

1. 动机。有兴趣改变被监测行为的求助者更有可能表现出反应性。
2. 目标行为的重要性。求助者看重的行为会提高自我监测的效果,相反的行为会减少其效果,而中性行为则没有效果。
3. 目标行为的类型。被监测行为的性质会影响自我监测对行为改变的效果。
4. 标准(目标)设定、强化和反馈。如果在进行自我监测的同时有明确的目标和反馈信息,其反应性就会增加。
5. 自我监测的时间。自我记录的时间会影响反应性,目标反应前、后进行监测的效果是不同的。
6. 自我监测的工具。使用可见的记录装置能比隐蔽的装置产生更多的反应性。
7. 被监测目标反应的数量。被监测行为的数量越多,反应性越低。
8. 自我监测持续性。持续的监测要比断续的监测能够导致更大的行为改变。

另外对下面三种因素对自我监测的反应性亦有影响:

1. 求助者的特点。求助者的智力和躯体能力与反应性有很大的关系。
2. 求助者的期望值。求助者对行为的改变抱有期望，求助者的期望与治疗对求助者的“要求”很难截然区分开来。
3. 求助者行为改变技巧。求助者与行为改变有关的知识和技能会影响反应性。如，成瘾行为的反应性受到求助者关于禁食和戒烟等简单知识的影响。这些一般性指导的效果随求助者的性别、阶层、民族、种族的不同而有所不同。

表 20-2 自我监测研究领域举例

学业进步	学业困难儿童
学习统计课的态度	孤独症
血糖监测	职业变迁
课堂行为	跨文化研究
心脏病高危行为	血液酒精度的监测
情绪表达线索	毛发营养摄取
免疫系统	肠染与应激
婚姻紧张关系中的先前事件和后继事件	心境状态
惊恐发作	疼痛知觉
察觉躯体运动	学前儿童

自我监测的步骤

自我监测至少包括六个步骤：介绍治疗原理，区分反应，记录反应，将反应做图，展示改变进程资料，分析资料。以下将对这几步的实施一一做介绍，并用表 20-3 做一总结。请记住，这些步骤都是相互联系的，每一步都是自我监测取得成效不可或缺的。同时，每

表 20-3 自我监测的步骤

1. 基本原理	A. 目的 B. 概况
2. 区分反应	A. 选择监测目标反应 1. 反应类别 2. 反应重要性 3. 反应数目
3. 记录反应	A. 记录时间 1. 行为前记录降低反应; 行为后记录增加反应 2. 及时记录 3. 不存在竞争反应时记录 B. 记录方法 1. 记数 2. 时间长度 a. 连续记录 b. 取样记录 C. 记录设备 1. 可携带的 2. 可接近的 3. 经济的 4. 在某种程度上引人注意的
4. 将反应制图	A. 将记录反应每天的总数制成图表
5. 展示资料	A. 环境支持图示
6. 分析资料	A. 准确解释资料 B. 自我评价和自我强化

一步都要考虑求助者的性别和文化。

治疗原理

首先，咨询者要向求助者解释自我监测方法的原理，使求助者在开始治疗之前了解自我监测要进行哪些内容以及这些内容对他有何帮助。以下是Benson和Stuart进行原理解释的一个例子：

自我监测的目的在于使你增加对自己睡眠情况的了解。研究表明坚持进行自我监测对失眠症患者颇有益处。一个星期内，每天早晨都要记录前一天晚上上床的时间，大约用了多少分钟睡着；如果在夜间醒来，醒了多少分钟才又睡着；睡眠时间一共多少小时；早晨起床的时间。同时用量表做出如下评定：早晨是否感到得到了良好休息，前晚入睡的困难程度，睡眠质量，前晚入睡时的身体紧张程度、大脑兴奋程度，以及前一天的工作效率等。这种日志会帮助我们评价你的睡眠状况和纠正睡眠中存在的问题。你认为这种方法怎么样？

区分反应

求助者要使用自我监测法，首先就要对自己的反应进行观察或做出区分。比如正在对咬指甲的习惯进行监测的求助者，必须能够区分咬指甲行为和其他行为。如果能够辨认某种行为是否出现，这就做到了区分反应；这种行为可能是外显的（如咬指甲），也可能是内隐的（如积极的自我观念）。Thoresen和Mahoney指出，区分行为反应可以被看做是自我监测法中的“意识”层面。

区分反应包括帮助求助者识别要监测“什么”，这个决定通常需要咨询者的帮助。被监测的反应类型会影响自我监测的治疗效果，比如，每天记录体重和热量摄入量的病人比只记录体重的求助者可能会减掉更多的体重。McFall指出，现在还不清楚为什么有些目标反应似乎比其他反应更容易进行自我监测，因此对被监

测的目标反应的选择仍然只是从实际考虑出发的。Mahoney也指出这样的情况，即对某类反应的自我监测会削弱治疗的效果，比如，让有自杀倾向的人监测自己的抑郁观念。

自我监测的效果还会随目标反应的重要性而变化。任何被监控的行为都有积极和消极两个方面。在有些情境中，某个方面会比另一方面对自我监测的影响更重要。

遗憾的是，几乎很少有指导资料告诉我们自我监测时应当选择什么样的反应，或其重要性如何等。因为行为本身的价值影响到自我监测的反应性，因而这可以作为一个指导原则，即应让求助者监测那些他们非常想要加以改变的行为。一般来讲，应当鼓励求助者只监测一个反应，特别是在刚开始进行监控时。如果求助者监测一个行为没有困难，就可以慢慢增加监控对象的数目。

记录反应

求助者学会了对反应进行观察、区分后，咨询者就可以告诉他们如何进行行为记录。大多数求助者很可能从来没有系统记录过自己的行为，而系统记录对自我监测法的成功至关重要，因此求助者必须了解做记录的重要性和具体方法。求助者需要知道何时记录、如何记录以及记录工具的使用等情况，记录的时间、方法和工具都会影响自我监测的效果。

自我监测的时间：何时记录 记录时间是指求助者在什么时刻实际对目标行为进行记录。记录可以在行为之前，也可在行为之后进行。在行为前监测中，求助者要记录行为的意图和动机；在行为后监测中，求助者要记录目标行为的完整过程。Kazdin指出，自我监测的效果依赖于监测发生在反应链的哪一点上。Kanfer 和 Gaelick-Buys总结说，现有的资料不足以说明究竟是行为前还是行为后监测能取得更好效果。Nelson指出，自我监测时间的选择在一定程度上要看求助者做记录时是否还有其他引起注意的行为反应。

另一个影响自我监测时间选择的因素是反应和记录之间的时间长短，许多人认为延迟记录会削弱监测的效果。

我们建议如下四条原则，用以指导咨询者和求助者决定何时进行记录。第一，如果求助者想要用自我监测法减少某种行为，那么行为前记录会更有效，因为记录似乎可以使反应链提前中断。例如，当你刚刚产生吸烟和吃零食的念头时，你就进行记录，这样的行为前监测法便可以减少吸烟行为。行为前监测可能较行为后监测能导致更多的行为改变。如果求助者是想增加某种行为，那么行为后监测可能更为有效，因为记录可能会使求助者意识到所期望的行为还太少。第三，行为发生后马上记录可能是最有效的。简单的原则是当有了吸烟念头后马上记录，或者在你暗暗对自己进行赞扬之后立即记录下来，不要等到 15 或 20 分钟之后再记录，那样记录的影响就失去了。第四，让求助者在进行自我记录时，不要为环境影响或其他行为反应而分心。如果可能，要训练求助者在行为现场中马上记录，而不要在每天晚上依靠记忆记录一天的行为。

自我监测方法：如何记录 咨询者要告诉求助者记录目标行为的具体方法。McFall 指出记录方法有许多种变式：

有的记录是非正规、非结构化的，如让求助者记录下与心境变化有关的心理事件；有的记录方法则是很正规、结构化的，如让求助者按时间抽样安排次序填写情绪评价问卷量表。记录方法可以非常简单，比如让求助者追踪记录在给定的时间内吸了多少支香烟；也可以很复杂、费时，比如不只问吸了多少支烟，还要问吸烟的时间、地点、环境以及点燃每支烟时伴随的情感反应等。记录可以是很客观的，比如记录每天摄入的热量；也可以是非常主观的，比如记录每天有多少次成功抗拒了吃甜食的诱惑。

Ciminero 等人指出，记录方法应该是“易于操作的，必须能

获得目标行为的样本,必须对目标行为的变化很敏感”。对于那些不能做“监测”或那些认为“追踪记录”没有什么价值的求助者来说,要尽量采用非正式、非结构化的记录方法。

第十章关于治疗结果评估部分我们曾讲到:使用连续记录或时间取样记录方法都可以记录行为的频率、持续性、强度几个指标。具体选择哪一种方法主要取决于目标行为的类型和发生频率。要记录目标反应的次数可以选择频率指标。当目标反应间断发生时,频率指标对监测反应是非常有用的。比如,求助者可以记录渴望吸烟的次数或者暗自表扬自己、抱怨自己的次数。

其他种类的目标反应用持续性做指标,就更为准确和更容易记录。只要求助者想要记录行为反应的量或者长度,就可以使用持续性指标。Ciminero 等人建议,只要目标反应是连续的行为,使用持续性指标就是适合的。例如,求助者可用持续性指标来记录读书的时间或练习竞技运动的时间,求助者也可用它来记录“愉快情绪”持续的时间。

有时求助者可能要用频率和持续性指标记录两种不同的反应。比如,求助者用频率记录想吸烟的次数,用持续性指标记录吸烟的时间。Watson和Tharp提出,当用频率可以清楚地记录离散行为时就用频率指标,当行为持续较长时间时就用持续性指标。需要时,求助者还可以记录反应的强度。如,记录愉快、焦虑和抑郁情绪的程度。

自我监测方法 有许多自我监测方法可以记录目标反应的频率、持续性、严重性以及相关影响因素。监测方法必须适合求助者的问题和本人的具体情况。图20-2列出了四个自我监测方法实例。图中第一个例子说明了如何记录与情绪问题有关的思想过程。求助者要根据7个内容类别分别记录与情绪和思想有关的内、外事件。第二个例子讲述了如何分7天记录瑜伽功的各种练习姿势。求助者可以核对每天所做的练习,并用量表评价每日练习时的体会。

例 1: 思想记录表

1. 情境 谁? 什么? 何时? 何地?	2. 情绪 a. 体验? b. 评价情绪(0-100%)。	3. 自发的思想和想像 a. 你产生体验时头脑中在想什么? 别的思想和想像呢? b. 圈上激烈的思想。	4. 激烈思想的表现	5. 与激烈思想无关的表现	6. 替换的 / 与之抗衡的思想 a. 写出一种与之抗衡的思想。 b. 评估信念程度(0-100%)。	7. 评价现在的情绪,再评第二栏中的情绪,以及出现的其他情绪(0 - 100%)。

图 20-2 4 例自我监测记录表(待续)

例 2: 瑜伽练习

	1 祈祷式	2 后仰船式	3 树式	4 战士式	5 勇士式	6 侧V字式	7 前屈膝式	8 侧卧托式	9 侧V字式	10 战士式	11 侧角式	12 后仰膝式	13 山式
星期一													
星期二													
星期三													
星期四													
星期五													
星期六													
星期日													
自我监测评语:													

图 20-2(续 1) 4 例自我监测记录表

(待续)

例 2 (续): 瑜伽练习

1 肩式	2 牛面式	3 树形	4 眼镜蛇式	5 牛膝式	6 合掌式	7 弓步	8 作桥牛膝式	9 加腹式	10 前弓曲式	11 半卧倒心式	12 敬礼式	13 鹰抓式	14 海豚式
星期一													
星期二													
星期三													
星期四													
星期五													
星期六													
星期日													
自我监测评语:													

图 20-2(续 2) 4 例自我监测记录表

例 3: 夫妇交流的内容和质量

在“内容”栏中记录交流类别，选出最能代表交流质量的等级

时间	交流内容	非常愉快	愉快	中性	不愉快	很不愉快
6:30 A. M.		++	+	0	-	--
7:00		++	+	0	-	--
7:30		++	+	0	-	--
8:00		++	+	0	-	--

图 20-2(续 3) 4 例自我监测记录表

第三个例子是在婚姻咨询中，夫妇双方采用自我监测法观察双方交流内容和质量的方法，两人分别记录与配偶交流的内容（比如一起就餐、讨论家庭开支、讨论双方的工作、去看电影等）。第四个例子提供的方法可用来自我记录焦虑反应。每种方法都可采用各种不同的监测设备。

自我监测的设备 求助者报告说自我监测最令人感兴趣的地方在于用来记录的设备或仪器。仪器设备可使记录显得系统而准确。设备有许多种：如可以用纸笔记录的卡片、日志清单、日记等；很受欢迎的设备是戴在手腕上的计数器。如果同时要记录多种行为，求助者可以带多个计数器。录音带、录影带、牙签或塑料辅币等都可以作为记录使用的材料。Watson和Tharp报告了使用硬币做计数器的经验：求助者在一个口袋里装上硬币，每当目标行为出现一次，就从其中拿出一个硬币放到另一个口袋里。儿童可以用贴星星的办法来记录频率。采用持续性指标记录行为可用钟、手表和计时器等。

咨询者和求助者要共同选择记录设备，帮助求助者选择记录设备有几个实用的标准：设备要便于携带、易于得到，这样当行为出现时就可以取到它们；设备要容易使用、花费不多；设备要显眼突出，它们的作用是要提醒求助者进行自我监测，然而如果设备太过显眼，可能会分散那些对求助者自我监测给予奖赏或惩罚的人的注意力，从而降低他们的作用；最后，所选设备应能提供累积频率的资料，这样求助者就可以统计每天目标行为发生的总数。

当求助者学会了对记录时机的把握，并选好了记录方法与设备之后，他就应练习使用记录系统了。常常由于求助者对记录过程了解得不清楚，而造成自我监测的中断，对记录过程进行演练可以使求助者正确地进行记录。通常求助者的自我监测时间应进行三到四周，因为在一到二周时间内，自我监测不会表现出明显

的效果。

将行为反应改变情况制成图表

求助者记录下来的数据要转换成图表,一方面容易长期保存,一方面有利于求助者直观地总结变化的进程,还可以为求助者提供一种自我强化的机会,而自我强化又会促进自我监测。记录数据图可以以天为单位用单线条图形表示。比如,某求助者记录了每天渴望吸香烟的次数,就可以画成图20-3的形式。另一个求助者则可将自己每天用于学习的时间制成类似的图表,其纵坐标用时间表示,如15分钟、30分钟、45分钟、1小时等。

咨询者应当用口头或书面的指示教会求助者如何制图,还要帮助求助者解释和分析图形趋势。如果使用自我监测法是要增加某种行为,图形中的线条应当是逐渐上升的;相反,如果想要降低某类行为,则线条应是逐渐下降的。

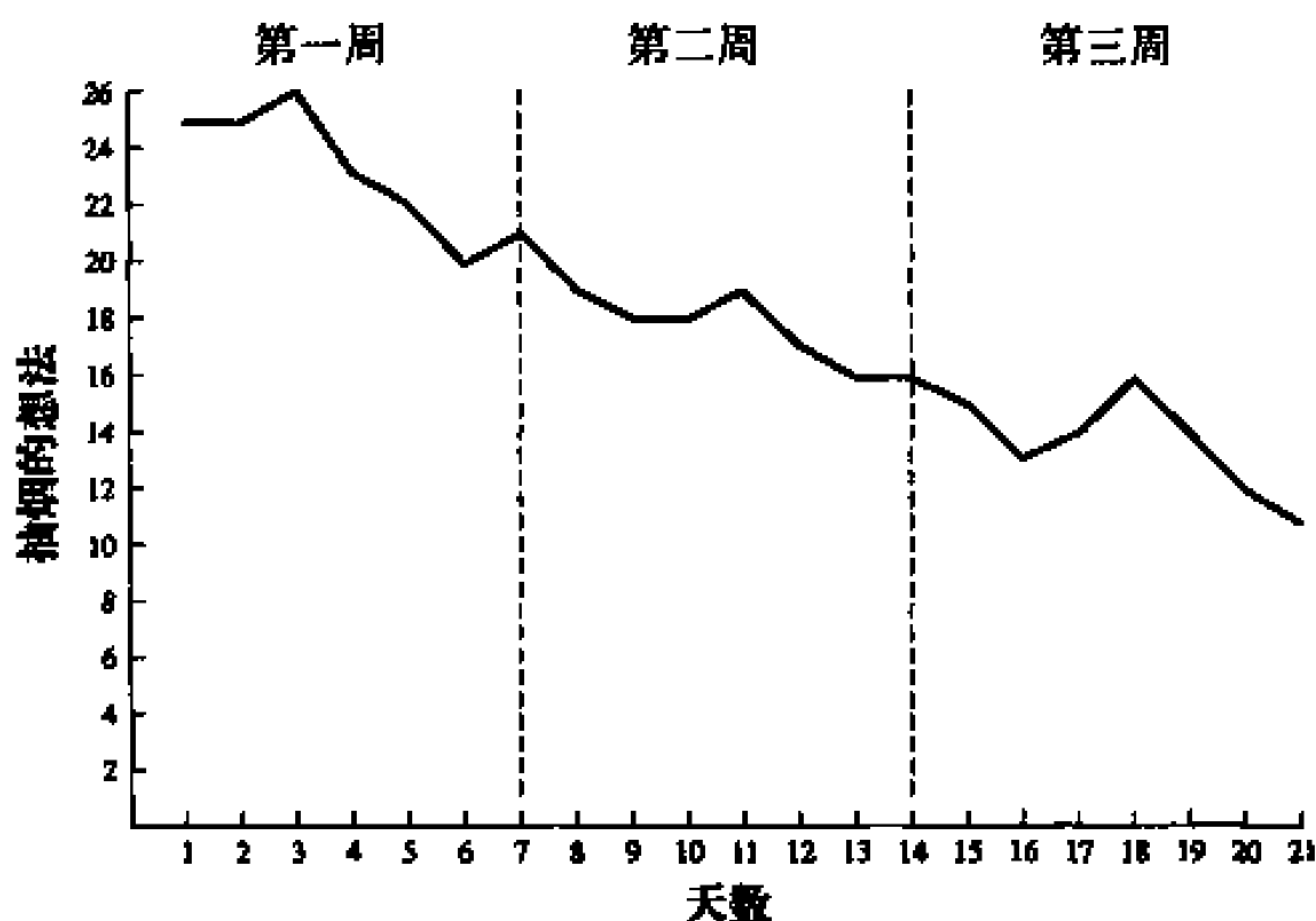


图 20-3 自我监测图表

展示资料

图表制成后，求助者有权决定是否将它展示出来。如果展示这一图表，那么就会促进环境强化效果，而环境强化则是有效自我管理治疗过程中的必要组成部分。通常公开展示图表后会增加自我监测的效果。当然有些求助者出于保密和害羞的原因不愿意将自己的情况公之于众，这也是完全可以理解的。

资料分析

如果不对求助者的记录资料进行回顾和分析，求助者可能很快就会忘了画图表的意义，而仅仅把它当做是画直线的简单练习！有证据表明，得到反馈的求助者在行为上的改变程度要大于没有获得反馈的人。因此，自我监测结果的记录和图表应当成为明确向求助者提供了解自己行为或业绩的途径。求助者应该在每周一次的会谈时间里，与咨询者共同回顾和分析自己的情况。会谈中咨询者帮助求助者将自己的情况与理想目标和标准相比较；求助者则用这些资料进展情况进行自我评价，并判断自己是否达到了希望的水平。咨询者可以帮助求助者正确地解释记录结果。Thoresen和Mahoney观察到：“对图表资料不恰当的解释会严重影响自我控制的疗效”。

自我监测方法的范例

第十章讲述的女学生Joan的目标之一，是增加她有能力学好数学的积极念头（同时减低相关的消极念头）。这一目标很适合通过自我管理策略来达到，原因如下：首先目标行为是内隐行为（积极的观念），只有Joan自己能觉察到。其次，目标的另一面（消极观念）则是长期形成的行为习惯，而大多数消极观念都发生在咨询会谈之外。要改变这种观念模式，Joan就需要这样一种治疗

策略，一是自己可以进行，二是只要需要随时可以应用。

以下描述自我监测法是如何帮助 Joan 达到上述目的的。

1. 治疗原理：咨询者要向 Joan 解释进行自我监测的原因。要强调这种方法她自己就能进行，而且可针对自己的内隐行为，在现实生活可随时加以使用。
2. 认识、区分行为反应：咨询者要帮助 Joan 明确界定目标反应。如目标行为可以这样界定：“任何时候我想到做数学题，我都会成功地加以解决。”咨询者还可以为这个定义举出一些例子，如“哇，今天的数学作业做得真不赖！”或者“我把今天的练习做完了！”要鼓励 Joan 也来举一些例子。因为 Joan 是要增加这个反应行为，所以要用积极语调举出目标反应的例子。
3. 记录反应行为：要告诉 Joan 记录反应的时间，具体方法和设备。因为 Joan 是要通过自我监测来增加某种行为，她应该使用行为后监测法。应当在目标观念出现之后，立即进行记录。因为 Joan 对目标观念产生的次数感兴趣，所以可以采用频率指标；记录卡片或腕上计数器可用作记录设备。要告诉 Joan 自我检测要连续进行四周时间。
4. 制图表：每周做完自我监测后，Joan 都要将每天反应发生的总数用线条画在图中，如图 20-4 所示。Joan 的图形是逐渐上升的。如果自我监测确实对目标反应有促进作用，那么在以后的几周里，图形线条应该表现出更大的上升。
5. 展示资料：Joan 也许会将自己的图表张贴在某个地方，如她自己的房间里。当然，这需要由她自己决定。
6. 分析资料：与咨询者会谈时，Joan 应将每周自我监测的记录带给咨询者。咨询者为她提供反馈，并帮助她准确地解释这些资料。Joan 也可以将结果和自己做目标做比较，从而对进展情况做出自我评价。

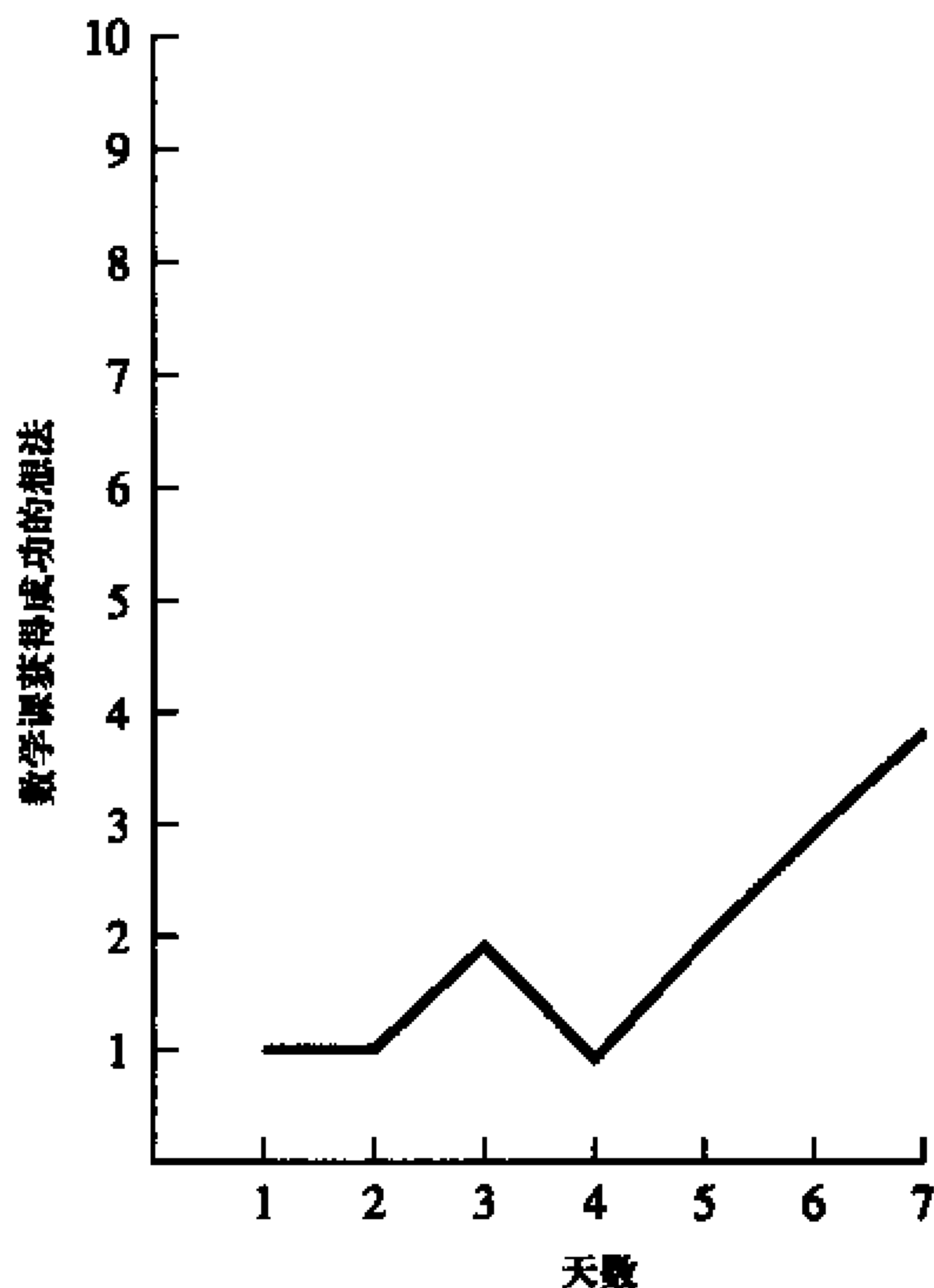


图 20-4 自我监测的简单直线图

学习练习活动 53/ 自我监测

这个学习活动将帮助你自已实施自我监测，以下是为你设计的自我监测计划：

1. 识别目标反应

- a. 确定一个你想改变的目标行为，并挑选该行为的正面进行监控——这取决于你更看重哪一方面以及你想增加还是减少该行为。

- b. 写下该行为的定义，你的界定是否清晰？
- c. 你能否举出该行为的例子？如果有困难，可以紧扣你所下的定义来举例——也可以对照举出该行为正面和反面的例子。

2. 记录目标反应

- a. 选择记录时机，注意以下原则：
 - (1) 若想减少不希望出现的行为，则采用行为前监测法；
 - (2) 若想增加该行为，则采用行为后监测法；
 - (3) 马上记录——不要拖延；
 - (4) 只有当没有其他竞争性反应时才记录，写下你选择的记录时机。
 - b. 选择记录方法（频率持续性等），注意：
 - (1) 频率指标适用于反应行为间断性发生的情况；
 - (2) 持续性或潜伏性指标适用于反应行为持续一段时间的情况；
 - (3) 强度指标用来说明反应的严重程度。
 - c. 选择用来记录的设备，注意这些设备应该是：
 - (1) 携带方便；
 - (2) 容易找到；
 - (3) 经济；
 - (4) 令人感兴趣。
 - d. 做好以上选择之后，实施自我监测至少一周（最好两周），然后开始第 3、4、5 步。
3. 制图表：将每天监控的资料画成单线图表。
4. 展示资料：选择一个（你感觉舒服的）地方展示自己的情况图表。
5. 分析资料：将自己现有的水平与所提出的目标水平进行对比，看看行为出现了哪些改变。
-

刺激控制

Kanfer 和 Gaelick-Buys 将刺激控制定义为预先安排好的环境条件, 它会使某些目标行为出现的可能性降到最低程度。刺激控制法要对影响某些行为的外部线索或先前事件(环境条件)进行重新安排或调整。第八章讨论的行为ABC模式曾提出过, 行为常常是由某些先前事件所导引, 并由后继事件所维持的, 而且先前事件和后继事件可以是外在的, 也可以是内隐的。比如, 先前事件可以是情境、情绪和认知, 也可以是言语或内心独白。

刺激控制法的临床应用

刺激控制法已经被广泛应用于许多领域, 表20-4列举了其中的一些研究。这些领域包括贪食症、儿童和青春期肥胖症、对盆腔检查的焦虑, 还有排便训练、讲课行为训练和改变抗拒行为等。如果研究的数量可作为一个重要性指标的话, 则刺激控制法主要用于治疗失眠症。

先前事件如何控制行为反应

如果先前事件的出现使某种行为得到强化, 那么先前事件对该行为就有了控制作用。由于先前事件成为某种反应的刺激条件, 所以可以把它看做是“刺激控制”。一旦先前事件成为反应行为的

表 20-4 刺激控制研究领域举例

贪食症	讲课行为
健身	失眠症
自然情境中的训练	拒绝行为
肥胖	骨盆检查
如厕训练	写作

刺激控制，它的出现导致某种行为的可能性就变得非常高。例如，大多数人看到红灯时，会自动地进行减速、刹车反应。红灯就是控制停车行为的刺激。通常先前事件的这种控制作用是很有益处的，如它能使我们做到红灯停、绿灯行。

问题行为中不恰当的刺激控制

求助者的问题行为可能与不适当的刺激控制有关。肥胖者的贪吃行为与环境中的许多刺激线索相联系。他们不仅在餐桌上吃东西，而且在做饭、看电视、走过冰箱、路过饮食店时都会不停地吃，这些行为会很快导致肥胖。其他的问题行为也大多与环境线索有关，尤其是“过量”问题，如吸食烟草等。因此，使用刺激控制法的首要目标就是减少与过分行爲（如进食、吸烟）有关的环境线索。

还有一些问题行为似乎是由于刺激线索过少所致。肥胖者有时为了减肥，吃得非常少（所谓厌食症），因而使身心健康都受到损害，对他们来说，环境中太缺乏能让他们进食的线索。缺乏身体锻炼也是环境线索过少的一个例子。因此在这些案例中使用刺激控制的首要目标就是创建或增加能引发目标行为的线索数量。

概括地说，自我管理中的刺激控制法包括：减少与不良行为相联系的先前事件数量，同时增加与适应行为相联系的先前事件数量。表 20-5 列出了刺激控制的基本原理和一些具体例子。

利用刺激控制减少目标行为

为了降低某行为的发生率，应该减少与该行为相联系的先前事件出现率，或重新安排、改变它们出现的时间和地点。当将不良习惯行为与其先前事件分离开来（改变它或消除它）时，它就会被终止。重新安排线索会使目标行为难以执行，从而令人不愿再做该种行为。如把某人吸烟时坐的椅子搬到一个不方便的地方

(如地下室), 每当他想吸烟时将不得不走到地下室去。也可以将线索安排的控制权掌握在另外一个人手中, 比如你可以将烟盒交给某个朋友, 并要求这个朋友同意帮助你减少吸烟次数, 当你吸烟时不给予强化或进行某种惩罚。

刺激控制之所以能减少某种行为, 是因为它打断了求助者习得的某种模式或次序——由一个或多个先前事件引出不良行为。这种习得次序也可以称为事件链。问题行为常常是由一长串事件链所引发的。例如, 吸烟行为是由许多行为依次构成的。某人吸烟之前, 要走到售烟机跟前, 把钱投进去, 取出一盒烟, 并从中拿出一支, 然后点燃它。

这个事件链可以用三种方式来打断: 中断事件链, 改变事件链, 或制造停顿。这几种方法都涉及到事先安排或改变行为发生的时间。可以通过及早发现并中断事件链上早期的环节或扰乱各事件发生的先后顺序来阻断行为的发生。比如吸烟的人可以不带售烟机需要的零钱; 或者, 如果吸烟者一般在某个特定时间吸烟, 就可以重新安排这段时间的活动。有人在感到无聊、紧张或无事可做时就会开始吸烟, 那么他们就可以在这种时候去做另一件事, 比如无聊时就给朋友打电话, 紧张时就放松一下, 手上没事做时可以织毛衣、玩扑克等。最后, 可以有意地将事件链停顿下来, 以便减少某种自动化的行为。Watson和Tharp指出, 停止这类自动行为的方法之一就是在对线索进行反应之前停顿一段时间。当抽烟者遇到应激线索想吸烟时, 就要故意在实际点烟之前停顿10分钟。停顿时间可以逐渐地加长。Watson和Tharp发现停顿方法对于纠正“成瘾行为”有很大帮助作用, 而且2分钟的停顿时间已经足够让吸烟欲望消退了。有时, 也可以通过内部对话告诫自己治疗的目的以及不吸烟的好处, 以加强停顿过程的效果。停顿本身就会成为行为的一种新的先前事件。

通过刺激控制法来增加行为

刺激控制法也可以用来增加求助者所需要的行为。如表20-5所示,一个人若想增加某种反应行为的发生率,他就要增加或预先安排好先前事件线索。要努力找出目标行为的先前事件线索,并将注意力集中于该目标行为;必须避免任何分心的行为反应。当刺激在某一情境中逐渐地控制了目标行为后,求助者再将目标行为扩大到另外一种情境中。这一刺激泛化过程意味着,在一个情境中习得的行为可以迁移到另一个不同的、相近的情境中去。请别人时刻提醒自己或用内部对白的方式都可以促进新的先前事件的出现。增加目标反应发生的地点和时间,也可以使目标反应随之增加。

例如,假设你正在为一个希望增加自己每天的锻炼量的求助者咨询。首先,要为他建立起更多的引发肌肉和躯体活动的线索,如,让他坐着时或等红灯时都进行肌肉紧张练习;也可以将锻炼时间安排在早晨或晚上,让他在专门的小垫子上进行运动。求助者应该寻找这些先前事件线索,并在该情境中进行运动时集中注意力。不要再做其他的活动,以免打断目标行为。求助者可以将锻炼活动逐渐扩展到新的相近情境中去,如坐在地板上或在会议开始前做肌肉紧张锻炼。可以用提示卡片的方法促进锻炼——在墙上张贴锻炼图表,把图表放在口袋或皮夹中随身携带,亦可展示锻炼清单。

刺激控制法在治疗失眠症方面很有作用。比如可以这样指示求助者:(1)只有在感到困时才上床躺下;(2)在床上不要读书、看电视、吃东西——床只是睡眠和性行为的场所;(3)如果躺下10到20分钟之后还未睡着,起来活动一下,直到有睡意时再回到床上——如果必要,整夜都坚持这样做;(4)床前放置闹钟,每天清晨定时起床,不论晚上睡得怎样;(5)白天不要睡觉。

表 20-5 刺激控制的原则和例子

改变原则	例 子
减少行为: 减少与该行为相关的线索事件。 1. 事先安排或改变与行为发生地点相联系的线索 a. 事先安排事件, 使该行为难以发生 b. 事先安排事件, 使求助者受控于他人 2. 改变先前事件与目标行为之间的时间链。 a. 中断这种时间链 b. 改变这种时间链 c. 在两者之间制造停顿	将令人增重的食物放在高处难以够到的地方。 请朋友或家人只给你清淡的食物, 而不给你会导致肥胖的食品。 只在吃饱了的时候才买食物或烹调食物。 当你想去吃快餐时(或走向冰箱、糖果机时)用一种与食物无关的活动取代它。 添加食物或快餐之前, 拖延一段预定好的时间。
增加行为: 增加或事先安排与目标反应相联系的线索。 1. 有意寻找促使目标行为发生的线索 2. 在该线索情境中专注于目标行为 3. 逐渐将目标行为扩展到其他情境中去 4. 通过别人或自己设置的提醒自己的事物促使有益的线索发生	在一间只有书桌的房间学习, 想学习的时候就这儿。 在此房间中专注于学习, 一旦分神就离开, 不要把学习与其他活动, 如听录音、谈话等混淆。 当你能在这个房间里控制自己的行为后, 可以把目标行为扩展到其他房间或地点。 请同屋的人在你说话或分心时提醒你离开课桌。在课桌上贴一清单或用自我指导语来提醒自己保持良好的学习习惯。

Kanfer 和 Gaelick-Buys 指出, 刺激控制法的一个优点是求助者只需要很少的步骤就可以引起环境线索的改变, 从而影响目标行为。Mahoney 和 Thoresen 经过观察指出, 使用刺激控制法对于求助者行为的长期自我改变还是不够的, 除非同时还配合其他能对影响目标行为的后继事件进行自我管理的方法。

学习练习活动 54/ 刺激控制

本章的重点是自我管理, 所以学习活动的设计将有助于你自己运用这些策略! 这个学习活动的目的是帮助你借助刺激控制减少一种行为。

1. 选择一种你想摆脱或减少的行为。如吸烟、进食、咬指甲等外显的行为, 也可以是内隐的行为, 如关于自己的消极观念, 想到食物的美味或烟草的口味等。
2. 从表 20-5 减少目标行为的刺激控制方法中选择一两种。记住, 要减少与该行为有关的线索或先前事件的数目, 途径是改变目标行为发生的时间和场所。
3. 每天实施刺激控制, 坚持两星期。
4. 在这两星期当中, 对目标反应进行自我监测。记录你所采用的自我监测的类别及实施情况, 用频率或持续性表示目标行为的多少。
5. 两个星期快要结束时, 回顾记录的资料。问一问自己, 是否坚持使用了所选择的方法? 如果没有, 是什么原因使你没有坚持下来? 如果你坚持得很好, 你是否达到了逐渐减少目标行为的目的? 在实施刺激控制时你遇到了哪些困难? 你体会到什么可以帮助你指导求助者实施刺激控制。

刺激控制治疗法范例

这个例子将说明如何将刺激控制法作为方法之一，来帮助Joan达到她自己的目标——增强有关自己数学能力的积极观念。用刺激控制法来增加某种行为的原则是，增加与该行为相连的线索事件：

1. 至少建立一个线索，让Joan把它当做积极观念的先前事件。我们建议她在手表上贴一块胶带之类的东西作为这样的线索。
2. 列出关于数学的积极观念清单，将它们写在随身携带的空白卡片上。
3. 要求Joan每次看表时都要想起或读一下写在某张卡片上的积极观念。要让她尽可能多找机会看手表，然后再将注意力集中于那些积极观念上。
4. 当Joan能够在看手表时自动地想到某个积极观念时，就可以用同样的方式建立起别的先前事件了。比如，她可以在自己的数学书上贴一个笑脸图案。每当她拿出数学书看到笑脸时，她就要将注意力集中于另一个积极观念上。
5. 她可以使用提醒物作为积极观念的刺激控制线索。比如，她可以在镜子或衣橱门上贴上积极观念清单。Joan也可以请朋友或同学在讨论有关数学或数学课的话题时，提醒自己注意积极观念。

自我奖赏的过程和应用

自我监测和刺激控制法对于许多人维持目标行为是足够有效的。然而对于某些人，比如低自尊、抑郁、情绪反应强烈、环境作用强烈、低自我效能感的人来说，自我监控法在校正他们的行为上并不总是有效果。在这中情况下，用自我奖赏法可以帮助求

助者管理和加强自我引导行为。不仅外部的后继事件，而且自己引导的后继事件也同样能够对行为产生控制作用。

按照 Bandura 的看法，自我强化，也就是自我奖赏，需要几个必须的条件：

1. 求助者本人(而非他人)为自己确定行为反应和强化标准。
2. 求助者本人(而非他人)能够控制奖赏的出现。
3. 求助者本人(而非他人)要能对自己实施强化和奖赏。

自我奖赏包括自我裁决和自我管理两个部分。这种区分在自我强化研究和应用中常常被忽视。Nelson、Hayes、Spong、Jarrett 和 Mcknight 提出自我强化之所以有效，首先在于它具有引起环境中的后继事件的刺激属性。

自我奖赏法是用来增强和增加目标反应。自我强化过程被认为与外在强化具有同等的效果。换句话说，自我的或外在的强化发生于目标反应之后，往往能维持或增加这种反应未来出现的可能性。自我奖赏优于外在奖赏的好处在于，求助者可以独立地运用和实施这一策略。

自我奖赏分为两类，正强化和负强化。在正强化中，求助者在某一特定的行为之后给自己一个积极的刺激。正强化的例子如当你完成了一项长期而艰难的任务之后表扬自己；当你在练习了一定量的钢琴之后，给自己买一张音乐光盘；或者在做完每天的练习之后，想像自己在最喜欢的地点休息。负强化是在目标反应之后去除掉消极刺激，比如，在完成了目标反应之后，从墙上摘下一幅不完美的图片或图表。

我们把自我奖赏作为一种治疗方法进行讨论，但仅限于正强化，原因有几方面：首先证明负强化有效的研究还很少；其次，按照定义，负强化涉及令人厌恶的活动，诸如将板油放在冰箱里或者在墙上挂一幅难看的图画，都会令人不快，许多人不愿意使用令人厌恶的治疗方法；再次，我们建议咨询者不要使用这种令人

厌恶的方法是因为它会使求助者终止咨询。

自我奖赏的应用

自我奖赏法曾用于治疗：发育性障碍；学习困难学生的学习；治疗11岁女孩对感染艾滋病以及其他疾病的恐惧。还有研究报告了自我奖赏法对于促进减肥、提高学习技巧、提高约会技巧、提高抑郁病人的活动水平都有效果。有的研究还探讨了影响自我奖赏效果的中介变量，如Enzle、Roggeveen和Look发现，使用自我奖赏法时，如果行为评定标准非常清晰的话，会促进求助者的内在动机；相反如果标准模糊，内部动机就会减弱。类似的研究表明，外部激励的孩子（3到6岁）在严厉或宽松的要求情况下，为自己的行为设定更高的标准，其自我奖赏时间安排更缺乏变化；而内在激励的孩子则更现实，自我强化时间的安排也更灵活。观察发现，有自我失败感或抑郁情绪的人进行自我强化的频率比较低。Rokke和Kozak发现抑郁的人自我评价和自我奖赏的水平低；当自我评价得到控制时，与正常人相比，他们自我强化的程度还是较低。最后，Field和Steinhardt报告说，在大学生关于体育锻炼和促进健康行为的看法上，外控制点上的低分数与正性自我强化高频率相关。

临床上自我强化的效果也可能来自于某种外在因素，包括求助者先前受强化的经历、求助者的目标设置、求助者自我监测的角色、别人监督求助者、所处环境的外在一致性，以及给予求助者的指导语等。在自我奖赏治疗中，这些外在因素究竟起着多大的作用依然不很清楚。但是，咨询者应该承认并尽力利用这些因素来加强自我奖赏方法的临床效果。

自我奖赏疗法的组成

自我奖赏疗法包括由求助者计划适当的自我奖赏，以及在何

种条件下使用这种奖赏。自我奖赏主要包括四个部分：（1）选择一个合适的自我奖赏物；（2）给予奖赏物；（3）奖赏的时机；（4）计划如何将自我改变维持下去。

下面的列表总结了这四部分的大体情况。虽然它们是分开讨论的，但切记它们自我奖赏程序中有机整体的一部分。

1. 选择适当的奖赏物
 - a. 可实际获得的奖赏
 - b. 个人化的奖赏
 - c. 使用若干个奖赏
 - d. 使用不同类型的奖赏（言语符号、物质、想像、现时或潜在的）
 - e. 使用有一定力度的奖赏
 - f. 使用不会伤害他人的奖赏
 - g. 使用与目标行为相配合的奖赏
 - h. 使用与求助者的文化、性别、年龄和阶层相符合的奖赏
2. 给予奖赏物
 - a. 对目标反应进行自我监测
 - b. 确定做什么和做到什么程度才能得到奖赏
 - c. 对不同水平的目标反应进行强化要做到“量少多奖”
3. 自我奖赏的时机
 - a. 应在行为之后而不是之前给予奖赏
 - b. 行为后马上给予奖赏
 - c. 奖赏应该针对行为，而非针对承诺
4. 如何保持自我改变
 - a. （如果需要）可请他人帮助提供奖赏物
 - b. 与咨询者共同总结自己的改变进程

选择适当的奖赏物

为了帮助求助者有效地运用自我奖赏法，必须花时间选择适合求助者和目标行为的奖赏物。选择过程可能会花费很多时间，但自我奖赏的效果在某种程度上取决于是否存在对于求助者有强化作用的事件。咨询者要帮助求助者进行选择，但这一工作应主要由求助者本人完成。

奖赏的形式多种多样，可以是言语／符号的、物质的、想像的等。言语／符号形式的奖赏就是进行自我表扬，如对自己说“我做很出色”，这类奖赏对于惯于自我挑剔的求助者十分有效。物质奖赏应是有形的，如看电影、买东西等，或者是可以获取这些强化物的分数。想像奖赏可以是内心浮动的一个令人愉快并带来美好情感的场景或情境，如想像自己减掉许多体重后成为苗条的人，或者想像你在湖面上自由滑水的情境。

自我奖赏也可以分为当前的和潜在的。当前奖赏是指每天都会发生的令人愉快的事件，如进食、与朋友谈话、读报纸等。潜在奖赏是指不经常出现、希望未来能够出现的新奇事件，如度假、买一件奢侈的商品（你非常喜爱却很少为自己买的物品，不一定很昂贵）、进行一项奢侈活动——你很少做的事情等，都是一种潜在强化。比如对于一个工作很忙的人来讲，休息可能就是一种奢侈的活动，一种潜在的强化物。

求助者进行选择时要考虑各种奖赏物是否能够实现。我们认为设计很好的自我奖赏程序应该包含多种类型的奖赏，应鼓励求助者既选择言语的也选择物质的奖赏。仅靠物质性奖赏可能不能发挥积极自我评价所应有的重要作用，而且，有批评指出物质性奖赏被用得过多过滥。想像性奖赏可能不及物质性和言语奖赏那样有效，但当其他类奖赏无法实施时，想像奖赏就可取而代之成为。

求助者还应考虑既选用当前奖赏，又结合潜在奖赏。使用当前奖赏最便捷的方法是，观察现在每天所思所做的事件中哪些具有强化作用，然后将它们重新安排以使之发挥强化作用。但求助者使用当前奖赏时，有可能引入剥夺和自我否定成份，如打扫厨房后可以阅读报纸这样的自我奖赏，有可能使求助者将读报纸不再看成是愉快的事情。Thoresen 和 Mahoney 指出，这种自我否定对自我奖赏策略是一种不利因素，有些人对自己改变或自我引导行为中任何令人厌恶的部分不能做出良好反应。本书作者之一一直在“滥用”自我奖赏的原则：在反应之前（而不是之后）给予强化（如在打扫厨房之前读报），这样就可避免引入自我否定带来的厌恶感。

咨询者可用多种方法帮助求助者识别和选择多种自我强化物。一种办法是采用口头报告，相互讨论自我奖赏治疗活动和强化物种类。求助者还可以通过现场观察来识别奖赏物，要指导求助者观察并列出的那些能维持行为的后继事件。最后，求助者还可以通过回答偏好与强化问卷来找到奖赏物。偏好问卷可以帮助求助者识别自己爱好和喜爱的活动。下面是 Watson 和 Tharp 推荐的一个偏好问卷：

1. 什么将成为你达到目标的奖赏物？
2. 你希望得到自己或他人什么样的赞扬？
3. 你希望得到什么样的东西？
4. 你主要对什么感兴趣？
5. 你的爱好是什么？
6. 你喜欢与什么人相处？
7. 你喜欢与这些人一起做什么？
8. 你娱乐时做什么？
9. 你以什么方式放松？
10. 你要全力避免的东西是什么？

11. 什么使你感觉良好?
12. 对你来说什么东西能算是好礼物?
13. 对你来说什么东西是重要的?
14. 如果得到 20 元、50 元或 100 元, 你将买什么?
15. 每星期中, 你把钱花在什么上面?
16. 每天你会做些什么 (不要忽略那些显然易见、普通的事情)?
17. 你是否经常用某些行为来取代目标行为?
18. 你会为失掉什么东西而愤恨?
19. 每天所做的事情当中你最不愿意放弃的是什么?
20. 你最喜欢的白日梦和幻想是什么?
21. 你所能想像的最令人放松的场景是什么?

求助者可以用纸笔或讨论的方式完成上面的偏好调查。那些识别强化事件有困难的求助者, 可以通过回答更正式的强化问卷而获得帮助, 如 Cautela 编制的强化调查表和儿童强化调查表。也可通过让求助者做家庭作业来识别出各种可能的言语和想像强化物, 如记录一星期内每天所想到的积极念头, 以及正面的后继事件, 还可列出所有喜欢的白日梦主题或愉快的想像情境。

有时求助者可能会由于难以找出适当的强化物而感到沮丧。Watson 和 Tharp 注意到: 行为消耗强化物 (如吸烟和进食) 的人、行为受到间断强化的人, 以及逃避行为受到负强化的人, 都难以找到有强化作用的后继事件。抑郁的人寻找强化事件也有困难。在以上这些情况下, 咨询者和求助者可以做出几种选择来克服选择强化物的困难。

如果缺乏时间或金钱, 求助者可以用想像奖赏代替物质奖赏。在目标反应之后进行愉快场景想像被 Cautela 称为“内隐的正强化”(CPR)。在 CPR 过程中, 求助者在想像中完成目标行为, 然后接着想像一个强化场景。只有在其他方法都不能使用的情况下,

咨询者才考虑使用想像强化法。

另一个选择是以求助者的日常活动作为自我强化物。某些临床案例中使用接电话或阅读来信等日常活动作为自我奖赏（事实上，这些活动更像提示线索而不是强化物）。如果用发生频率很高的活动作为强化物，那么它应是令人喜欢的活动，或至少是一种中性活动。Watson和Tharp指出，不应把求助者不喜欢的高频率活动当作自我奖赏事件，因为负面高频率活动与其说是强化物不如说是惩罚。

为抑郁的求助者选择强化物一般较困难，因为许多事情都失去了应有的强化作用。因此先要提高某些事件的强化作用，然后才能把它作为自我奖赏事件。Anton、Dunbar和Friedman介绍了一种“期待训练”程序，用以提高抑郁者对事物的积极期待。训练中求助者要找出几件令其愉快的活动，并做好活动计划安排，然后针对每项活动写出三个积极期待的句子，最后在想像中进行这些活动，并联想有关的积极期待的句子。下面就是针对某项活动的三个积极预期的句子：

活动计划：在湖边度过一个下午。

活动日期：星期二，如果星期二下雨就改在星期三。

我将尽情享受：坐在沙滩上读书的乐趣。

我将尽情享受：热天里游泳的乐趣。

我将尽情享受：清新的空气。

不存在对所有人都具有强化作用的观念、事件或想像情境。一个人的强化事件与另一个人往往有很大差别。使用自我奖赏方法有一点很重要，那就是帮助求助者选择出对他们自己有效的强化物，强化事件不是为咨询者、朋友或配偶选择的。Kanfer和Gaelick-Buys指出，重要的是要考虑求助者的经历，以及他们的性别、文化、年龄和阶层。

咨询者可以参考以下指导原则来帮助求助者寻找有效的自我

奖赏物:

1. 使奖赏物针对求助者个人。
2. 目标行为发生后, 奖赏物应能方便地得到。
3. 交替使用多种奖赏物, 以防止厌烦(奖赏物重复呈现会丧失原有的强化作用)。
4. 应选择不同类型的奖赏(言语/符号的、物质的、想像的潜在的)。
5. 奖赏强度应是足够的, 但又不能强到使人不愿只是偶尔得到它。
6. 奖赏不能对他人构成惩罚。Watson 和 Tharp 指出, 如果奖赏涉及到他人, 要征求他人的同意方能实施。
7. 奖赏应与目标反应相协调。例如, 对减轻体重的人来说, 可以用穿新衣做奖赏, 或者用对减肥后的健美体形的想像做奖赏; 但如果选用美食作为奖赏则是不合适的。
8. 奖赏应与求助者的文化、年龄、性别、阶层、种族和民族相联。

给予自我奖赏

实施自我奖赏方法的第二部分工作是, 要选择给予自我奖赏的条件和方式。首先, 求助者必须在掌握一些基本情况后, 才能实施自我奖赏; 自我监测是首要的一步。

其次, 求助者要确定在何种明确的情况下给予奖赏。换句话说, 求助者必须讲清楚游戏规则, 要在弄清楚奖赏什么和奖赏多少之后才能给予奖赏。通常求助者对出现的微小进步及时给予奖赏是很有效的自我奖赏方法, 而等待目标行为完全出现后才给予奖赏就会造成强化的延迟。

最后, 求助者要确定各种反应达到不同水平时, 要给予何种奖赏和奖赏多少。求助者要针对反应的程度来选择奖赏的种类和

强度。通常将强化细分为较小的单位，并频繁进行自我奖赏的做法更为有效。可以用辅币或记分的办法进行频繁的小单位强化，当辅币或分数积累到一定数目之后就可以换取更大的强化物。

自我奖赏的时机

咨询者还要指导求助者确定自我奖赏的时机——何时应给予奖赏。这里有三条基本原则：

1. 应在特定的反应之后给予奖赏，而不是反应之前。
2. 反应之后及时给予奖赏，延迟奖赏会使奖赏无效。
3. 应在实际的反应之后给予奖赏，不应奖赏行为的承诺。

自我改变的维持

自我奖赏像其他自我改变策略一样，需要环境的支持才能将行为变化长期地维持下去。自我奖赏策略的最后一步工作，就是帮助求助者计划如何维持行为变化。首先，咨询者可以允许求助者将他人引进治疗过程，可由他人实施强化。有证据表明，有些人在自我奖赏过程开始时得到他人的奖赏，会取得更好的效果。其次，求助者应该与咨询者共同总结在实施自我奖赏过程中收集到的资料。总结会谈使咨询者有机会对求助者进行再次强化，同时也可帮助求助者对自我奖赏方案做必要的修改。如果治疗者能起到强化者作用的话，那么他对求助者的期望和表扬将增加自我奖赏方法的总体效果。

使用奖赏的注意事项

对于将奖赏作为一种激励和传递信息的方式，存在着许多争议。把奖赏，尤其是物质的奖赏，作为一种激励的做法受到批评，理由是有形的奖赏被滥用、误用，常常会挫伤而不是鼓励求助者。

作为一种治疗技术，自我奖赏不应不加区分地应用于任何人。

在提出建议之前，咨询者应仔细考察求助者，包括他以前接受强化的经历，以及他所期望的变化。如果求助者的文化认为自我奖赏是不应该和不谦虚的，那么自我奖赏策略就不适合该求助者。如果咨询者和求助者决定使用自我奖赏策略，下面的两点警告则需要加以注意。首先，不能过于依赖物质性奖赏。在借助外在奖赏作为激励之前，治疗者要想办法增加求助者对完成目标行为的内在满足感。其次，咨询者在治疗过程中的作用仅限于介绍治疗方法以及对病人给予鼓励。应该由求助者来选择奖赏物，确定给予奖赏的标准和时机。如果目标行为和其他奖赏物是由求助者之外的某人确定的，那么确切地说这个治疗程序就不能称之为自我改变疗法。

自我奖赏策略范例

这个例子将说明如何使用自我奖赏法来帮助Joan，培养她对于自己数学能力的积极观念。

1. 选择奖赏：首先，咨询者要帮助Joan选择出适当的奖赏物。咨询者应鼓励Joan想一些自我表扬的话（如“我做对了”、“我对数学的态度正在发生改变”）。Joan可以就她每天产生的积极观念为自己打分。分数累积到一定数额就可以换取物质性奖赏，包括现时奖赏（比如从事所喜欢的日常活动）和潜在奖赏（比如购买渴望已久的东西）。以上都是些建议，Joan应该对实际的选择负责。咨询者可以建议Joan通过自我观察或回答偏好调查问卷来选择奖赏种类。咨询者应检查Joan选择出的奖赏是否可以达到，是否便于操作。为了避免厌烦，可以选择多种奖赏方式。咨询者还要考虑奖赏物是否有效，是否与Joan的目标相协调，是否切合Joan的情况同时又不伤害他人。
2. 奖赏的给予：咨询者应帮助Joan确定给予奖赏的准则。

Joan 可以决定每当她产生一个积极的想法就给自己计一分，这样就可以对微小的进步进行强化。如果分数达到了事先规定的标准，比如每天得五分，Joan 就可以给自己一个现时的奖赏，比如看电视或去朋友家拜访。如果达到每周应得到的总分数，Joan 就可以给自己一个有力的奖赏，比如看一场电影或购物。如果 Joan 的行为超过了预定的水平，她就可以给自己额外的奖赏。

3. 奖赏时机：咨询者要让 Joan 在产生积极的想法“之后”，或得到了预定的总分数“之后”，给自己以奖赏。要强调给予奖赏应在目标行为出现之后，而不是承诺之后。同时，咨询者要鼓励 Joan 在达到每天或每周的目标之后尽可能及时地对自己进行奖赏。
4. 自我改变的维持：咨询者可以帮助 Joan 寻找维持自我改变的方法。一种方法是每隔一段时间，就由求助者和咨询者共同总结治疗取得的成果；Joan 还可以找位朋友来帮助她，她们将共同分享看电视、购物等奖赏，这位朋友也可以对 Joan 的进步给予表扬。

学习练习活动 55 / 自我奖赏

本学习活动旨在帮助读者实施自我奖赏治疗。

1. 选择一种你想要增强的目标行为，写下你要达到的目标（要增强的行为、希望增强的程度，以及行为出现的情境）。
2. 选择几种奖赏方法并写下来，奖赏的形式可以是言语 / 符号的、物质的（现时的和潜在的）、想像的。所选择的奖赏要符合以下标准：
 - a. 适合于你自己
 - b. 能够得到，并且便于操作

- c. 多种奖赏
 - d. 包括不同类型的奖赏
 - e. 奖赏有效力
 - f. 不能惩罚别人
 - g. 奖赏要与期望的目标相协调
 - h. 奖赏应符合你的性别和文化特点
3. 计划如何给予奖赏: 采用哪种强化方式? 需要多大强度的强化? 目标行为要达到何种程度?
 4. 打算何时实施自我奖赏?
 5. 如何借助他人的帮助?
 6. 实施一段时间的自我奖赏程序之后, 你的目标反应增强了吗? 达到了什么程度?
 7. 你认为应如何向不同群体的求助者推荐自我奖赏方法?
-

自我偶像法

自我偶像疗法就是求助者将本人作为偶像。本章我们讲到的自我偶像疗法是由Hosford首先采用的。在Hosford和devisser的治疗程序中, 是求助者将自己看做偶像, 以所期望的方式从事目标行为。求助者可以用录音带进行练习, 做得好可以得到奖赏, 出现错误就被纠正。这种治疗程序中不仅包含模仿, 也包括练习和反馈。

为什么让求助者作为偶像? 资料显示偶像的特征, 如威望、地位、年龄、性别及民族等对求助者都有不同的影响。对于某些人而言, 观察另一个人(即使与求助者在各方面都非常相似)可能会产生消极反应。而如果看到、听到自己出现在电影上或录音带中, 有些人则会给予以更多的注意。例如, 当我们在摄像机或录音机前做事时, 我们必须承认我们都愿意表现得更好。

几项研究对自我偶像疗法作用于不同群体的效果进行了调查。Winfrey 和 Weeks 曾经用自我偶像法对 11 个 8 到 13 岁的体操女运动员进行改进平衡木技术的训练。两个用自我偶像法指导 6 岁聋儿的案例取得了成功。Woltersdorf 用录像机记录了自我偶像疗法对 4 个 9 到 10 岁注意力多动症儿童 (ADHD) 的治疗过程, 治疗提高了他们的数学成绩, 同时减少了他们烦躁、分心和多语的症状。Walker 和 Clement 使用自我偶像法和应激预防训练对 6 个一二年级的多动症男孩进行治疗。还有人用此种方法训练 4 位母亲更直接了当地对自己 4 到 7 岁的孩子提出要求, 并根据孩子的顺从程度提出表扬。同时采用认知—行为疗法、放松训练法和自我偶像法对 68 名六到八年级的患有抑郁症的学生进行治疗, 结果使他们减轻了抑郁症状, 并建立了自尊。一项荷兰的研究讨论了自我偶像法在减轻一个患白血病的 12 岁男孩应激状态中所起的作用。Johnson 用自我偶像法对一群实习咨询者 (22 岁到 50 岁) 进行训练, 结果显示他们比对照组体验到较少的生理和心理焦虑, 能更全神贯注于他们正在做的事情。采用录像形式的自我偶像法对于帮助提高残疾儿童的学习技能十分有效。

所要模仿的行为应该与求助者的年龄、性别、文化相符合。从 Hosford 和 deVisser 的自我偶像疗法中, 可以总结出实施过程的五个步骤 (这五个步骤在本章后面的自我偶像疗法检测清单中有进一步说明):

1. 基本原理
2. 将期望的行为记录在磁带上
3. 编辑磁带
4. 播放编辑后的磁带
5. 自我练习: 求助者进行自我观察和实践练习

治疗原理

咨患双方共同确定了问题行为及目标行为之后，咨询者就可向求助者说明使用自我偶像法的原理：

我们将要进行治疗基于这样原理：人们可以通过观察他人在各种情境中的行为，学习新习惯或新技能（原因）。其方法是观察他人的行为，或者观看他人做事的录像。我们所要做的稍有不同，你要观察的对象是你自己而不是其他人。我们将把你从事目标行为的过程进行录像（或录音），这样你可以看见（或听见）你自己是如何做事的。然后，你将按照你所看见（听见）的行为模式进行练习，我将对你的练习结果进行反馈。我想观看自己的行为会帮助你更好地获得目标行为。（总结）你觉得这种疗法怎么样（求助者的意愿）？

当然，以上只是可以采用的方式之一。咨询者还可以补充一点，“看见自己做这些事情将会增强你的信心”。这句话强调了自我偶像疗法的认知成份；通过把自己当做偶像，求助者可以看见自己在曾经唤起焦虑的情境中进行应对的情况。

记录所期望的行为

首先将期望的目标行为以音像的形式记录下来。比如，某人可能需要学会以下自我肯定技巧，如以坚定、强烈的声调表达自己观点的技巧，同时不要出现错误，不要有时间延误（在对方发言之后五秒钟内进行发言）。在这个例子中，咨询者和求助者应从声调发音开始练习，记录求助者以坚定、洪亮的声音向别人表达观点的情况。磁带要保证足够长，从而求助者可以听见自己在与他人对话中坚定的话语；咨询者可能要在录音上花费大量时间才能使求助者达到他的理想目标。

咨询者有时可以教会求助者在现实生活中记录他们自己的行

为。如要求口吃的人在一星期中某些指定的时间里，用录音机录下他与别人交往的过程。我们建议那些与异性交往不自信的人也采用这种记录方式。现场记录的优点在于，可以获得求助者在现实生活情境中的行为方式样本。然而，如果求助者在目标行为上的基线水平很低，就不宜采用现场记录的方法。无论录制磁带是在现实生活中，还是在会谈过程中，通常要反复录制多次才能得到所期望的行为。

磁带的编辑

咨询者接下来要对磁带进行编辑，以便使求助者听到或看到的磁带只含有适宜（理想）的行为，使求助者看到的是正面的、积极的自我形象。这就像是锄掉花园里的蒲公英，只剩下水仙花。在我们所举的例子中，磁带中只应留下他以坚定的语调表达自己观点的部分；在治疗口吃的案例中，应该把口吃的部分删掉，留下比较流利的对话部分。

展示编辑好的磁带

磁带编辑好之后，就可以展示给求助者了。首先，要告诉求助者观察磁带中的哪些段落。在对口吃者的训练中，咨询者可以说，“请听磁带，注意在这段对话中你能够流利地与人交谈”，或者“请注意你在向对方传达观点时，你要用眼睛注视着他”。

指导语之后放磁带。如果磁带较长，可以在某些地方停下来，并观察求助者的反应。此时或磁带放到头时，咨询者要鼓励求助者做出期望的行为，或对其给予积极的反馈，这一点至关重要。

磁带放完之后，求助者应对目标行为进行练习。咨询者要在旁边加以指导，奖赏进步，指出不足。自我偶像法的这一步能否奏效，取决于练习和反馈。

自我练习：求助者的自我观察和练习

如果求助者在业余时间可以对照磁带进行练习，那么自我偶像法会取得很好的疗效。咨询者可以指导求助者每天对照磁带进行自我练习，求助者要公开地或不公开地练习目标行为，也可以在没有任何对照的情况下练习。逐渐地求助者要在现实生活中做出期望的行为反应。求助者还要自行在清单上记录对目标行为达到期望水平的评价及次数。另外，咨询者还要安排求助者在自我练习之后再追加一些练习。以下的清单给出自我偶像疗法的实施步骤。

自我偶像疗法步骤检测清单

基本原理

- _____ 1. 说明基本原理
- _____ 2. 关于本疗法的概述
- _____ 3. 了解求助者是否愿意采用本疗法

录制期望的行为方式

- _____ 4. 将期望的行为细分
- _____ 5. 指导求助者成功地完成细分后的每一部分行为
- _____ 6. 求助者借助咨询者或磁带得到反馈
- _____ 7. 在音像带上录制期望的行为，可以在会谈中或现实中录制。反复录制，直到得到一个完整的、期望的行为样本

磁带的编辑

- _____ 8. 咨询者对磁带进行编辑，从而得到一个清晰的期望行为样本

编辑后磁带的展示

- _____ 9. 告诉求助者要注意磁带中的哪些东西
- _____ 10. 播放磁带，让求助者观察
- _____ 11. 对求助者在磁带上的表现给予积极反馈
- _____ 12. 要求求助者练习目标行为；奖赏成功，指出不足

自我练习：求助者的自我观察和练习

- _____ 13. 要求求助者每天观察或听磁带上的理想行为样本，并坚持一段时间
- _____ 14. 咨询者提供由求助者掌握的某种激励方法，比如一些卡片
- _____ 15. 要求求助者在清单上记录练习中目标行为的水平和练习次数
- _____ 16. 咨询者在会谈结束后，检查求助者自我练习的情况并给予鼓励，可以当面进行，也可以通过电话完成

学习练习活动 56 / 自我偶像法

你可能还记得 Weare 夫人和 Freddie 的案例吧。Weare 夫人希望 Freddie 早晨能自己为上学做好准备而不再需要她的帮助。她想找一个合适的方式告诉 Freddie：她将不再帮助他穿衣，不再在公共汽车到达前三分钟提醒他。Weare 夫人担心 Freddie 会撅嘴或不同意，担心不能实施她的计划，或者在向 Freddie 表达时不够坚定。

你如何通过以下五个步骤帮助 Weare 夫人达到她的目的？
(答案见学习活动反馈 56)

1. 向 Freddie 清楚说明自己的主张
 2. 以坚定的声音说
 3. 说话时眼睛注视着 Freddie
 4. 避免声音变小，避免屈服
-

自我偶像法范例

以下咨询者和 Joan 的对话可以帮助读者掌握自我偶像疗法的步骤。对话的目的仍然是为了帮助 Joan 达到第十章曾提到的咨询目的：增加她对自己数学能力的信心。

咨询疗程一

在对话1中，咨询者向Joan说明自我偶像疗法的基本原理。咨询者不仅要说清基本原理，还要了解求助者是否愿意接受这一疗法。

1. 咨询者：我们过去讨论过你在数学课上几乎从不主动回答问题或发表见解。你说在数学课上发言时感到窘迫，而且毫无信心。我们将试着采用自我偶像法来帮助你改善这一状况。这个方法很有意思，在实施中你还会用到录音机。这样你就可以听一听你自己是如何回答问题的。这将帮助你像你所希望的那样行事，同时增强你的信心。你觉得试一试怎么样？

求助者：嗯，我从前很少在磁带上听到自己的声音。我想可以试一下。

在对话2中，咨询者向求助者说明如何使用录音机，并花一点时间与求助者共同操作一下，以免录音设备干扰自我偶像法的进行。

2. 咨询者：习惯于在治疗中使用录音机需要一些时间，因此我们先来熟悉一下录音机在治疗中的使用。我们现在就开始（Joan和咨询者大约用了15分钟进行录音和播放）。

在对话3中，咨询者总体介绍自我偶像法的步骤。

3. 咨询者：看起来你已经不再受录音机的干扰了。我现在告诉你治疗中将涉及哪些步骤，使你心中有数。我们先找出你希望自己能主动发言的行为方式，然后按照这种方式进行练习；我们同时将练习过程录下音。然后我会边放录音，边给你反馈。从你的练习中挑出做得很好的一次，保留在磁带上作为行为样本。这样你就可以把磁带和录音机带回家，每天听着磁带进行练习。我说清楚了吗？

求助者：很清楚。我想磁带可以让我知道自己发言的情况。
在对话4中，咨询者强调自我偶像法的认知特点或应对功能。

4. 咨询者：很对。磁带会常常提醒你，你能够做得比你自己认为的还要好。这就是为什么磁带会对你有帮助。

求助者：我可以理解这一点。刚刚才听了一会儿录音，就增强了我的信心。我的声音并不像我过去想得那样让人觉得不舒服。

在这个案例中，求助者在数学课上的言语参与包括三项行为。这里先对其中一个行为，即主动发言进行咨询帮助。另外两个行为将在以后处理。在对话5中，咨询者指导Joan练习这一行为。

5. 咨询者：好。现在让我们讨论一下你如何才能平静而自信地主动发言。现在你想到的是什麼？

求助者：我几乎从来没有在课上主动发言。我总是等老师叫到我时才发言。并不是我不会，事实上大多数时候我都知道答案。我想我只差举起手并说出答案。比如当老师说“谁知道这道题的答案”时，我要做的就是举起手，说出答案，比如25或者40等。我不知道为什么我没有这样做。可能是因为我担心自己会显得傻傻的，或者我的声音听起来很可笑。

在下一段对话中，咨询者使用澄清反应以确定Joan对于主动发言的担心。

6. 咨询者：这么说来，你更担心的是你发言的方式而不是发言的内容。

求助者：我想是的。

在对话7中，咨询者就主动发言的方式对Joan加以指导，并开始首次练习。

7. 咨询者：好，让我们试一下。我来扮演老师，你举手回答问题。你要尽量使语气坚定，使我听起来毫不费力。或许

讲话前先做一次深呼吸。可以吗？（咨询者打开录音机，用老师的口气问）谁知道答案？（像老师那样环视四周，停顿，Joan 举起手）Joan？

求助者（用相当响的声音说）：25。

学习活动反馈 56

1. 治疗原理

首先你应该向Weare女士解释自我偶像法是如何帮助她解决问题的（原理），并要说明治疗中包括哪些内容（概述），然后问Weare女士对这种疗法的看法（求助者的意愿）。

2. 记录期望出现的行为

Weare女士在与Freddie谈话时有四件事情要做，咨询者要依次对这几件事进行指导，当Weare女士有时能做出期望的行为时就可以开始录音或录像了（记录说话时眼睛的注视运作就必须录像）。因为Weare女士还不能在Freddie面前这样做，所以不宜录制现场情境，而只是录制咨询时的情境。咨询者可以扮演Freddie。最后把四件事都录制完全。

3. 编辑磁带

录制好磁带后，咨询者就要着手编辑，删除做得不理想的部分。比如，Weare女士目光移开的部分就应该删掉。只保留下来那些目光坦然注视着对方的部分。最后，磁带上就完全是Weare女士期望做到的那些行为了。

4. 展示编辑后的磁带

磁带编辑好之后，就可以用来帮助Weare女士练习了。咨询者要指出Weare女士应注意什么，并对正确的行为给予正面反馈。然后Weare女士把磁带倒回来，并对照练习，

同时得到咨询者的正面反馈。

5. 自我练习：求助者自我观察和练习。

当 Weare 女士能在咨询者的指导下做出期望的行为以后，她就可以对照磁带自己练习了。她可以先自行练习，然后公开地——面对 Freddie 练习，这时练习可以脱离磁带。最后，咨询者还要追踪调查 Weare 女士是否已达到了预期的目的。

第一轮尝试之后，咨询者在对话 8、9、10 中针对 Joan 练习的目标行为给反馈。

8. 咨询者：好，先到这儿。你感觉怎么样？

求助者：嗯，事实上并不太难。我做了一个深呼吸。

9. 咨询者：你的声音相当清晰，要是把声音放大一些就好了。

现在让我们来听一下录音（放录音）。

10. 咨询者：你认为你听到的声音怎么样？

求助者：还可以。我的意思是我的声音并不那么可笑。

在对话 11 中，咨询者再次为 Joan 录音。这次的录音将被编辑成样本。

11. 咨询者：一点儿不可笑，而且声音响亮。现在让我们反复

练习几次。深呼吸一下，坚定地发言（练习并录音）。

在对话 12 中，咨询者说明磁带编辑过程。编辑好的磁带将在下一个咨询疗程中使用。

12. 咨询者：进行反馈练习之前，我先要编辑处理一下录音带。

今天就到这儿吧，到下星期我们见面时我会把磁带整理好。简单地说，我编辑磁带的目的是使你得到清晰而坚定的声音样本（咨询者应抹掉那些听不清、刺耳的声音，保留那些坚定、响亮、音调适中的声音）。

咨询疗程二

一个简短的预备过程之后, 咨询者指导Joan去听编辑后的声音样本。

1. 咨询者: Joan, 你的录音已经编辑好了。我现在放一遍录音。在这个过程中希望你注意体会你在回答问题时的声音是多么清晰、镇定(放录音)。

2. 咨询者: 你感觉如何?

求助者: 你说得很对。我的声音不可笑, 至少在磁带上的声音听起来不愚蠢。

在对话3中, 咨询者为Joan的行为进行正面强化。

3. 咨询者: 从你的声音判断, 你对答案很自信。你的声音很容易让人听清楚。

求助者: 但是我在课堂上也能像这样发言吗?

在对话4中, 咨询者告诉Joan如何使用磁带练习家庭作业。家庭作业要规定Joan做什么和做多少。

4. 咨询者: 我们下一步就要解决这一问题。同时我希望你在这一星期里按照磁带进行练习。你能否每天拿出固定的时间来听磁带, 就像今天这样? 听完之后, 再对照练习。想像老师提问了, 然后你举起手, 做个深呼吸, 镇定地说出答案。现在你知道如何使用录音样本吗?

求助者: 知道了。就是每天听一遍录音, 然后对照着进行练习。

在对话5中, 咨询者要求Joan用日志的方式记录每天的练习情况。

5. 咨询者: 希望你在日志上记录每次练习的情况。同时, 用5级量表评价你进行练习前后的舒适程度。

求助者: 我想这做起来并不难。

在对话6中, 咨询者鼓励Joan对自己的进步进行自我强化, 并安排下一周的复诊。

6. 咨询者: 你所做的日志可以帮助你看到自己的进步。如果在练习中出现了进步, 你就对自己给以表扬。下个星期我们将讨论你是如何取得进步的, 并看看你能不能在课堂上也有类似的进步。

下一步将是在课堂上录制Joan主动发言的样本。首先应在Joan不感到紧张的课上录音, 然后再在数学课上录音。这一步最大的难题是, 不使Joan因同学们在场而感到窘迫, 同时又能录到Joan的发言样本。

自我效能

Bandura、Adams和Beyer描述自我效能是一种对行为改变起调节作用的认知过程, 是人们相信自己具有控制生活事件能力的一种信念。换句话说, 自我效能是指人们认为自己具有完成某项任务的技能。当我们觉得自己能够成功地做成某事, 或者我们认为自己能够达到目标时, 我们的自尊感就提高了, 自我效能感水平也会很高。乐观和希望导致高自我效能感, 而无助和绝望则使自我效能感降低。高自我效能和低自我效能这两种极端情况都是可以通过学习而获得或改善的。与自我效能相近的概念有自我力量感、自我期望、自信、自我授权、乐观、充满希望和热情。

过去几年里出现了大量有关自我效能的研究, 表20-6列举了其中的一些研究。这些研究大致可分为成就和绩效、职业决策、健康关注、药物滥用、离婚、运动成绩、练习、法律诉讼、恐慌、问题解决、康复、预防衰竭、安全及害羞等问题领域。

有这样几方面因素可对自我效能等人格概念产生影响。Bandura指出四个基本因素: (1) 实际绩效; (2) 心身状态; (3) 环境体验; (4) 作为治疗开始的言语移入。言语移入是指咨询者

表 20-6 有关自我效能的研究领域

堕胎	艾滋病
酗酒	帮助受过袭击的妇女
生育控制	乳房自我检查
癌症	心血管疾病
职业	婴儿生产
法律诉讼	决策
牙齿保健	糖尿病
节食与婚姻互动	离婚与孩子的自我效能
癫痫症	练习活动
体育训练	头痛
健康	获得工作
学习活动	父母行为自我效能
数学学习自我效能	心肌梗塞
吸食鸦片	骨关节炎
痛疼	父母教养行为
问题解决	康复
药物滥用	安全
害羞	吸烟
医学院学生	受精神创伤的青少年

有意增强求助者完成特定任务的信心或自我效能预期的过程。咨询者可以通过谈论求助者过去完成类似工作时的成功，来为求助者移入积极的自我效能感。而如果求助者没有从事过类似的任务，咨询者就要与他讨论过去的成功经验，以帮助他树立自信心。

实际绩效

人们做事的方式有着巨大差异。自我效能高的人能很快地从失败中恢复过来。尽管有失败的可能，他们仍然受到激励，充满精力，甘愿冒险。处于另一种极端的人则会陷入习得性无助状态，他们满怀抑郁，痛苦地跋涉，他们没有活力，对自己消极暗示，敏感而脆弱，最后导致悲观失望。遇到失败的时候，他们就会说：“这是我的错”，“我总是把事情弄糟”，“这再次证明我不能做好任何事情”，或者“这将毁了我的一生”。这种面对失败的习得行为会导致悲观的、灾难式的感情和思考方式。

大多数人介于以上这两种人之间。自我效能感作为一个主要的因素，决定了人们是否会完成某项任务，如果做某事他们会付出多大的努力，遇到困难时他们会坚持工作多久。例如，经常在互联网上寻找特定网页的人，会认为自己是有能力做到的，即使没能成功登录某一站点，他们仍会对自己的能力相当自信，也会继续坚持长时间的搜寻；但如果让同一批人去编软件，他们就会逃避。有时人们觉得自己有能力做好某项工作，但由于缺少刺激而不去做。同样还有些人由于不熟悉某项工作，而不现实地期待自己能够成功。比如，对于同样的工作，有人过分自信，有人却心里发虚。总之，如果我们要培养自己的能力，我们就要提高和加强自我效能、自信心、自尊、承担风险的意愿及完成某项工作的能力。

心身状况与自我效能

自我效能会影响到我们的情感、思想、知觉、动机和生物化学过程。在心身信息加工系统内部存在着一种链索反应和相互作用。我们身体中的任何过程都是由信使分子(messenger molecules)控制的，其中大部分是肽分子。有足够的科学证据表明，信息分子

(information molecules)、肽分子和受体是情感的生物化学粒子。这些信使分子或神经肽会影响自我效能。比如,一个具有高自信、高自尊的人比低自信的人更倾向于尝试困难的工作;面对困难时能够调动更多的能量,坚持更长时间;遇到失败时不会责备自己。这种人具有控制感,一个假说认为:这些人大脑中的内生性镇静剂(内啡肽)分泌得多,内啡肽高分泌量与人的自信有关。内啡肽有镇痛作用,它分布到全身各处,可以减轻人对疼痛的敏感。

相反,没有控制感的人自我效能水平也低,他们会力图避免困难工作,为达到目标所做的努力不够。他们安于个人不适的现状,常进行消极的自我对话,很少努力去工作,需要很长时间才能从失败中恢复过来,他们极易受应激和抑郁的影响。那些感到无力自我控制、低自我效能感的人可能会引致大量儿茶酚胺或应激激素的分泌。自我效能感、自信心以及生物化学反应性的差异程度来源和家庭、环境和文化背景。

环境的影响

人的自我效能受到认知、情感、行为、关系、环境和文化等多种因素的影响。人在家庭、文化和环境的影响下形成自我效能,自我效能又作用于人的认知发展和认知活动。Bandura 提出自我效能感对四种主要的发展过程具有巨大影响,它们是认知发展、动机发展、情感发展和知觉选择过程。比如,Bandura 指出自我效能感在四种不同水平上影响着学生的学习:(1)学生对于调节自己学习以及掌握学习内容的效能感,决定了他们的动机水平和最终的学习成绩;(2)教师激励和促进学生学习自我效能感的能力,影响着他们为学生创造一个怎样的学习环境,也影响着学生进步的程度;(3)教师集体对自己团体的效能感将显著地影响学校的教学水平;(4)通过改变教师的集体效能感,将更能突出学生在学校成就水平中的作用。这四种水平的自我效能感都会受到

求助者世界观的影响。

自我效能是治疗的前提

求助者对治疗结果的预期建立在自我效能感基础之上。这种预期能够影响认知过程。求助者首先必须获得自我效能感（信心），才能成功地进行与治疗相关的技能练习。Bandura曾经证实，一个人的自我效能感与他最终达到的绩效水平之间存在着密切联系，自我效能感是强烈影响治疗成功与否的心理前提。笔者相信，如果咨询者能够最大限度地提高求助者的自我效能感和对治疗的预期，那么求助者对治疗的每一步都会充满信心，从而潜移默化地提高治疗的效果。Rosenthal和Steffek指出，“当病人开始尝试或坚持他们最初的逃避活动时，所有心理治疗——不管它们使用的是什么方法——都必须首先提高患者的自我效能感”。

自我效能感强度的评估涉及第十章提到的治疗目标的确认。可以为求助者提供一系列特定的目标行为或治疗结果目标，然后请他们判断哪些行为目标可以达到，以及做出这一判断时的信心有多大。评估量表通常由0（不确定）到100（确定）。比如，Ozer和Bandura曾对45名妇女自愿者进行训练，帮助她们有效地应付可能遭遇的性攻击。这些妇女训练前都减少了参与文化、教育和社会活动的次数，因为她们认为不能（缺乏自我效能）应付独自外出会遇到的潜在危险。对她们自我效能训练的评估是从以下几个方面进行的：（1）自卫能力，即测量自己能对暴力进行还击的效能感；（2）增加休闲活动的的能力，通过测量恢复夜间外出参与休闲活动的自然轻松感；（3）人际交往的效能感，即测量在各种场合对遇到的性威胁和性骚扰进行有力反击的能力；（4）控制困扰性认知的能力，即测量克服对可能遇到性攻击强迫性思想的能力；（5）其他的一些测量，如对可能被攻击的观念、易受攻击性、风险性以及恐惧感等。因为每种治疗都要达到特定目标，所以它

们的疗效大部分要依赖于求助者的自我效能感。求助者的年龄、性别、社会地位、文化与民族背景都会影响他们完成特殊任务时的自我效能感。

自我效能感在跨文化治疗中的应用

自我效能感越来越被认为是进行跨文化治疗中的因素,涉及的领域包括风险预防和风险降低、学习成绩、工作绩效等(表20-7)。在预防和风险降低方面,自我效能感对于预防HIV感染、吸毒以及心血管疾病很有成效。

关于自我效能感的许多研究考察了降低HIV感染行为,涉及的研究对象包括非裔美国男性、拉美男性以及同性恋者和双性恋者。研究发现,在吸食可卡因的异性恋非裔美国男性中,自我效能感越强,使用避孕套的比率越高;而在被监禁的非裔美国男性青年人中,自我效能感越强,防止HIV感染的预防行为越多。Rotheram-Borus、Rosario、Reid和Koopman在一个对136名非裔美国及拉美男性青少年同性恋、双性恋者的追踪研究中,考察了自我效能感和其他预测指标与有感染HIV风险性活动的关系。对这些活动模式变化的评估分别当时和3个月、6个月和12个月时进行。活动有五种方式:有保护措施,有所改进,故态萌发,反复无常,没有保护措施。结果发现,有保护或有改的风险性活动与低水平焦虑和抑郁及高水平自我效能相关。

自我效能感是预防同性恋、双性恋者感染HIV计划中的重要

表 20-7 自我效能多元文化应用举例

艾滋病预防	预防毒品
心脏病预防	学业成绩和职业选择
工作业绩	前列腺癌症
练习活动	腰部障碍与无法工作

组成部分。自我效能理论和健康信念模式日益被应用于HIV感染的预防工作。Cochran和Mays讨论了将这些模式应用于预防非裔美国人感染它HIV有关的疾病时存在着潜在问题,他们注意到这些理论强调个人的重要性,强调行为的直接控制,却忽视了种族主义和贫穷等外在的因素,而这些因素在HIV高感染率的美国黑人社区中尤其不可忽视。他们认为应用这些模式时,不考虑黑人社区中特定的问题会使人抓不住要害。其他人也讨论了在非裔美国人社区进行艾滋病预防教育,以调动受教育的所有意愿的重要性。这样的预防工作要满足以下三个假设:

1. 在行为改变中,环境起着关键作用;
2. 在非裔美国人中,男性和女性对社区风气恶化程度的体验和感受是不同的;
3. 住在城市的非裔美国人,正试图努力了解他们每天都要接触的生态与社会环境的威胁。

Gasch和他的助手们提出了一个艾滋病教育的模式,该模式对非裔美国男性强调了社会责任感,对非裔美国女性则强调了关系性自我效能感。

一项对757名七年级学生(他们中有非裔,也有西班牙裔,家庭收入都很低)的研究结果发现,自我效能感可以作为吸食大麻或吸毒意向的预测指标。来自成人、朋友和角色对吸食大麻的宽容度也可以作为预测吸食大麻的指标。缺乏自我效能感以及低水平的学业成绩与这些青年吸食毒品的意向相关。在另一项对117名非裔美国成年人注射毒品的研究也发现,自我效能感与吸毒存在着关联。特别是自我效能感是预测注射针头是否消毒的十个预测变量之一。十个变量中自我效能、对效度的预期和年龄是最有效的三个预测变量。Van-Hasselt、Hersen、Null和Ammerman(1993)对毒品预防进行了研究,他们指出在家庭中进行各种促进自我效能感、成就需要及自尊发展的活动,可以使非裔儿童较少接触毒品。

Winkleby、Flora 和 Kraemer 将自我效能感作为因素之一，研究它们与心血管风险指数（RFSS）的关系。被试者是 411 名成人，他们来自于不同的种族、民族，并都接受过为期六年的减轻心脏病风险教育。发生积极改变比例最高的一组被试者全都超过 55 岁，他们发病风险最高，接受的医疗措施最多，血压和胆固醇水平也最高。相反，积极变化比例最低的一组被试者受过很少教育，健康知识不多，自我效能感水平也很低。

自我效能感也是影响学业成绩的重要因素。Bryan 和 Bryan 发现自我效能感和积极情感与初、高中学习困难学生的成绩有关。有研究表明墨西哥和拉美裔大学生的自我效能感——即他们认为自己能顺利完成大学学业的信心程度——是决定他们适应大学生活的重要因素。

Bandura 的自我效能模式也被应用于职业选择过程。Morrow、Gore 和 Campbell 调查了自我效能感对于男、女同性恋的职业发展模式的影响。对学生择业兴趣的研究表明，少数民族学生（主要是西班牙裔和美国土著学生，来自于农场家庭）的职业兴趣、职业的吸引力、自我效能预期（相信自己能够成功地从事某项职业），都可用来预测他们的择业意愿。

Lauver 和 Jones 的研究对象是 800 多名高中生（西班牙后裔、美国土著人和白人学生），他们发现了择业自我效能的民族差异，其中美国土著学生对 18 种职业中的 7 个表现出很低的职业效能感。

性别也是影响择业效能感的一个因素。Church 等人发现西班牙裔及美国土著高中男、女学生，都更希望选择自身性别占优势的工作，而女学生不愿选择男性占优势的职业的倾向更为明显。这一发现似乎表明学生对非传统职业的胜任预期与低自我效能感有关。Lauver 和 Jones 对来自农村的西班牙裔、美国土著人、白人高中生的研究发现，在对同性别或跨性别职业的兴趣和自我效能感上都存在性别差异，男生更不愿意考虑那些跨性别的职业。

跨文化咨询中应用自我效能策略的指导原则

从跨文化的观点出发，我们不能单一地使用增强自我效能感的策略。正像 Cochran 和 Mays 指出的那样，自我效能感模式强调了个人主义以及对行为选择的直接控制。这反映了高度内控和高度内在责任感的世界观。强调集体主义和整体性的民族的求助者对这一模式有可能会感到不舒服，而处在被压迫、种族主义和贫穷条件中的人们将同样也难以接受此模式。如果将提高自我效能感的办法在特定的环境中与其他方法配合使用，则不失为帮助妇女及有色人种求助者的有力工具，因为这不仅增强了他们的自我效能感，而且培育了群体和文化意识，减少了自我指责。这种综合的方法的确有效，因为它不仅强调个人内在的自信心，而且也强调外在的社会背景因素。

自我效能的范例

在第十章我们介绍了 Joan 的目标。第一个目标（举手提问和提出合理要求）有四个次目标：（1）降低由于在数学课上发言失败或被父母拒绝而引发的焦虑；（2）在数学课或其他竞争情境中增加“女孩是有能力的”这类自我对白的次数，从一星期内少于两次到一星期有四五次，坚持两个星期；（3）将每星期上数学课的次数从每星期二三次增加到四五次；（4）在数学课上和与父母交流时，增加言语参与和积极举手的次数，从没有到每星期三四次。言语参与是指在课上向老师提问、回答老师问题，主动回答问题或发表观点、到黑板前进行演算等活动。

咨询者可以分别测量 Joan 对上述每个目标行为的自我效能感（信心），用 0 代表没有信心，100 代表非常有信心。要求 Joan 据此进行口头判断。也可以设计一个量表，让 Joan 用笔划出她对每个目标抱有信心的程度。下面将为 Joan 的所有目标给出测量量表。

目标一（对数学课）:

降低数学课引发的焦虑（从 70 到 50）的信心

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

不确定

完全确定

目标一（对父母）:

降低害怕被父母拒绝而产生焦虑（从 70 到 50）的信心

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

不确定

完全确定

目标二（对数学课）:

在数学课上进行积极言语或观点（“女孩是有能力的”）的次数增加到每星期四五次的信心

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

不确定

完全确定

目标二（对其他情境）:

在其他竞争性场合中进行积极言语或观念（“女孩是有能力的”）的次数增加到每星期四五次的信心

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

不确定

完全确定

目标三:

把每星期上数学课的次数增加到四五次的信心

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

不确定

完全确定

目标四（对数学课）:

在数学课上提问的信心:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

不确定

完全确定

在数学课上回答问题的信心:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

不确定	完全确定										
在数学课上主动举手回答问题的信心:											
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
不确定	完全确定										
在数学课上走到黑板前演算的信心											
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
不确定	完全确定										
目标四（对父母）:											
向父母发出询问的信心											
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
不确定	完全确定										
回答父母问题的信心:											
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
不确定	完全确定										

这里列出了七种不同的行为,行为很具体。随着Joan的进步,她在自我效能上的得分将会提高。

学习练习活动 57/ 自我效能感

在本练习中,你要评价一下自己的自我效能感。

1. 回顾第十章,选择你想要达到的某些目标,并且要把总目标细分成次目标。
2. 写下你的总目标以及次目标。这些目标要符合第十章提出的条件。
3. 制定量表(0到100)测量你对达到目标行为、观念或情感以及各个次目标的自我效能感(信心)。包括在多种情境下与每个人交往的自我效能感。
4. 在每个量表上划出代表你的自我效能感的数字。

5. 在练习的过程中,可以借助自我效能量表对你的信心增长情况进行自我监测。
-

本章总结

自我管理是求助者自己引导行为改变的过程,其中可能应用一种或数种治疗策略。自我监测策略为求助者提供了这样一个方法,使他能够更好地了解自己的外在行为和思想、感情等内在反应;它还可以提供影响这些行为的社会和环境的有关信息。刺激控制策略则要对目标行为的先前事件,或增加、减少行为的线索(行为的环境条件)进行重新安排。自我奖赏策略是在求助者自己做了某项特定行为之后,对自己进行正面积极刺激。自我偶像法则是求助者通过将自己作为偶像,从而获得所期望行为的方法。自我效能感即自信感,它调节着求助者的行为改变。这四种策略方法之所以被称为自我管理,是因为它们都以自我引导的方式,由求助者自己引发、调整和控制行为的先前事件和后继事件,从而产生所期望的行为改变。增强求助者对自我管理治疗的投入和责任感,可以采用下面几种方法:在治疗过程的后期引进自我管理策略,评估求助者寻求行为改变的动机强度,营造帮助求助者自我管理的社会支持系统,在求助者自我治疗过程中要保持与他们的接触。本书谈到的自我管理策略以及所有其他干预策略,都受到求助者自我效能这种认知过程的影响。

自我管理干预策略被用于各种文化群体的求助者,主要集中在这样两个领域:行为医学,以及预防艾滋病病毒感染和使用毒品的教育。自我管理不一定适合所有的少数民族求助者,但对于那些注重自我独立价值观,希望干预措施能在一定时间内完成,能够解决现存问题的少数民族求助者,自我管理策略也是可用的。根据求助者文化与社会环境的不同,他们自我调节的过程也是不同的,多数

自我管理策略背后的观念都是欧洲中心主义的,特别是内在控制和内在责任感的观念更是如此。这两个变量以及求助者的文化认同、文化适应和文化同化的状况都会影响自我管理治疗方法的适用性。我们同意 Gutierrez 提出的观点,他认为对不同群体求助者使用自我管理策略,不仅要增加他们的自我效能感,而且也要培养他们的群体和文化意识,并减少他们进行自责和贬低的倾向。

全书最后的提示

在结束本书全部章节之前,我们要留给读者三点意见。首先,作为一个咨询治疗者,你一定要谨慎而现实地为自己和自己的职业设定好一个范围。要知道你能为求助者做些什么,哪些是你做不到的。提供有效帮助的关键是要知道何时应该退出治疗关系,并让求助者自己承担起责任。你为他们做的越多,他们为自己做的就越少。最近,“同情疲劳症”引起咨询业界的关注,它是指职业咨询者没能设立好自己的界限,为求助者过多操心,从而引起生理和心理疲惫。对咨询者来说,“照顾好自己”是一条重要原则。

其次,查看一下你对自己和对求助者的期望。咨询者常常会发现他们对行为改变的期望与求助者有很大出入,尤其是当求助者不情愿进行咨询,或对咨询持悲观态度的时候。在这样的情况下,与其说咨询者在力求满足求助者的需要,帮助他们解决问题,不如说咨询者在满足自己对改变和成功的需要。这样的咨询者就会与求助者(的根本利益)发生冲突,从而失去了治疗同盟。要认识到对所有人来说,进行改变都是困难的,尤其是改变那些长期形成了的行为习惯。还要记住,求助者抵制改变的行为常常具有正面意义,因为它们具有自我保护功能。

第三,最重要的是要因人而异。本书所介绍的方法和策略只提供了方法学的指导,它们效果的好坏依赖于咨询者的创造性和直觉。求助者之间存在着极大的差异,不仅表现在文化和性别方

面,而且表现在外在与内在的行为模式、生活经历和成长历史,以及所处的社会政治环境等方面。本书中我们提到了各种各样的求助者人群,有男人、女人、年轻人、老年人、同性恋者、学习困难者、残疾人,以及来自各种民族的求助者等。但绝不能因为某个求助者属于某群体,就将该群体的分类标签戴到个体求助者头上。因人而易的咨询者,把每个求助者都看成独特的人,是否选用某种治疗方法要根据它对该求助者的效果而定。

学习评判

第一部分

本章目标一要求你针对以下案例,描述自我监测和刺激控制的方法。

案例描述

求助者, Maria, 一个30多岁的波多黎哥妇女,与丈夫分居十五年之后终于双双来到美国团聚。重聚一年以来,她感到颤抖和虚弱。她担心丈夫会英年早逝,留下自己孤独一人。她没有早期的失落或遭抛弃的经历,但从移居以来她感到了失落。她依赖于丈夫 Juan, 完全没有了自我。她笃信宗教,经常因自己的状况而祈祷。

她希望咨询者能帮助她对颤抖和虚弱的感觉有所控制。你能否用自我监测和刺激控制的方法帮助她减少这种感觉?根据她的文化背景等情况你将注意哪些问题?答案见学习评判反馈。

第二部分

目标二是要求你教别人如何进行自我监测。在教的过程中,要遵循表20-3提出的六个步骤:讲清原理,区分反应,自我记录,将资料制成图表,结果展示和资料分析(见学习评判反馈)。

第三部分

目标三是要求你对于特定的案例。指导求助者如何使用适合于他的文化背景的自我管理程序(自我效能、自我偶像、自我监

测、自我奖赏和刺激控制)

案例

求助者, Thad, 是一个非裔美国男青年, 最近发现自己是同性恋者。Thad向你诉说了他的同性恋倾向。他去过一些同性恋者常去的酒吧, 并参加过他们的一些活动, 你向他介绍了自我监测和自我奖赏的过程, Thad对此很感兴趣, 并且愿意每周与男性同伴至少外出一次。

你将如何从自我监测、自我奖赏、自我偶像、刺激控制和自我效能中选择合适的策略并运用到这个特定的求助者身上? (答案见后面的学习评判反馈)

第四部分

目标四要求你教别人如何使用自我奖赏、自我监测、自我控制和自我偶像等方法, 你可以参考自我监测步骤、刺激控制原则、自我奖赏的各个组成部分以及自我偶像法的步骤。

参考文献

Self-Management

- Cole, C. L. (1992). Self-management interventions in the schools. *School Psychology Review*, 21, 188–192.
- Lazarus, B. D. (1993). Self-management and achievement of students with behavior disorders. *Psychology in the Schools*, 30, 67–74.
- Marks, I. M. (1994). Behavior therapy as an aid to self-care. *Current Directions in Psychological Science*, 3, 19–22.
- Parcel, G. S., Swank, P. R., Mariotto, M. J., & Bartholomew, L. K. (1994). Self-management of cystic fibrosis: A structural model for educational and behavioral variables. *Social Science and Medicine*, 38, 1307–1315.
- Rokke, P. D., & Kozak, C. D. (1989). Self-control deficits in

- depression. A process investigation. *Cognitive Therapy and Research*, 13, 609–621.
- Smith, L. L., Smith, J. N., & Beckner, B. M. (1994). An anger-management workshop for women inmates. *Families in Society*, 75, 172–175.
- Taal, E., Riemsma, R. P., Brus, H. L., & Seydel, E. R. (1993). Group education for patients with rheumatoid arthritis. Special Issue: Psychosocial aspects of rheumatic diseases. *Patient Education and Counseling*, 20, 177–187.
- Watson, D. L., & Tharp, R. G. (1997). *Self-directed behavior* (7th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
- Williams, R. L., Moore, C. A., Pettibone, T. J., & Thomas, S. P. (1992). Construction and validation of a brief self-report scale of self-management practices. *Journal of Research in Personality*, 26, 216–234.

Self-Monitoring

- Fox, M., & Deyer, D. (1995). Stressful job demands and worker health: An investigation of the effects of self-monitoring. *Journal of Applied Social Psychology*, 25, 1973–1995.
- Goodwin, R., & Soon, A. P. Y. (1994). Self-monitoring and relationship adjustment: A cross-cultural analysis. *Journal of Social Psychology*, 134, 35–39.
- Halford, W. K., Gravestock, F. M., Lowe, R., & Scheldt, S. (1992). Toward a behavioral ecology of stressful marital interactions. *Behavioral Assessment*, 14, 199–217.
- Harris, K. R., Graham, S., Reid, R., & McElroy, K. (1994). Self-monitoring of attention versus self-monitoring of performance: Replication and cross-task comparison studies. *Learning Disability Quarterly*, 17, 121–139.
- Madsen, J., Sallis, J. F., Rupp, J. W., & Senn, K. L. (1993). Relationship between self-monitoring of diet and exercise change and subsequent risk factor changes in children and

adults. *Patient Education and Counseling*, 21, 61–69.

McDougall, D., & Brady, M. (1995). Using audio-cued self-monitoring for students with severe behavior disorders. *Journal of Educational Research*, 88, 309–317.

Reynolds, M., & Salkovskis, P. M. (1992). Comparison of positive and negative intrusive thoughts and experimental investigation of the differential effects of mood. *Behaviour Research and Therapy*, 30, 273–281.

Stimulus Control

Estabrooks, P., Courneya, K., & Nigg, C. (1996). Effects of a stimulus control intervention on attendance at a university fitness center. *Behavior Modification*, 20, 202–215.

Haddock, C. K., Shadish, W. R., Klesges, R. C., & Stein, R. J. (1994). Treatments for childhood and adolescent obesity. *Annals of Behavioral Medicine*, 16, 235–244.

Jacobs, G. D., Benson, H., & Friedman, R. (1993). Home-based central nervous system assessment of a multifactor behavioral intervention for chronic sleep-onset insomnia. *Behavior Therapy*, 24, 159–174.

Jacobs, G. D., Rosenberg, P. A., Friedman, R., & Matheson, J. (1993). Multifactor behavioral treatment of chronic sleep-onset insomnia using stimulus control and the relaxation response: A preliminary study. *Behavior Modification*, 17, 498–509.

Stromer, R., MacKay, H., Howell, S., & McVay, A. (1996). Teaching computer-based spelling to individuals with developmental and hearing disabilities. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 29, 25–42.

Taylor, S., Cipani, E., & Clardy, A. (1994). A stimulus control technique for improving the efficacy of an established toilet training program. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 25, 155–160.

- Williams, J. G., Park, L. I., & Kline, J. (1992). Reducing distress associated with pelvic examinations: A stimulus control intervention. *Women and Health, 18*, 41–53.

Self-Reward

- Eisenberger, R., & Cameron, J. (1996). Detrimental effects of reward: Reality or myth? *American Psychologist, 51*, 1153–1166.
- Enzle, M. E., Roggeveen, J. P., & Look, S. C. (1991). Self-versus other- reward administration and intrinsic motivation. *Journal of Experimental Social Psychology, 27*, 468–479.
- Field, L. K. & Steinhardt, M. A. (1992). The relationship of internally directed behavior to self-reinforcement, self-esteem, and expectancy values for exercise. *American Journal of Health Promotion, 7*, 21–27.
- Kanfer, F. H., & Gaelick-Buys, L. (1991). Self-management methods. In F. H. Kanfer & A. P. Goldstein (Ed.). *Helping people change* (4th ed., pp. 305–360). New York: Pergamon Press.
- Schill, T., & Kramer, J. (1991). Self-defeating personality, self-reinforcement, and depression. *Psychological Reports, 69*, 137–138.

Self-as-a-Model

- Dowrick, P., & Raeburn, J. (1995). Self-modeling: Rapid skill training for children with physical disabilities. *Journal of Developmental and Physical Disabilities, 7*, 25–37.
- Houlihan, P., Miltenberger, R., Trench, B., & Larson, M. (1995). A videotaped peer self-modeling program to increase community involvement. *Child and Family*

Behavior Therapy, 17, 1–11.

Meharg, S. S., & Lipsker, L. E. (1991). Parent training using videotape self-modeling. *Child and Family Behavior Therapy*, 13, 1–27.

Winfrey, M. L., & Weeks, D. L. (1993). Effects of self-modeling on self-efficacy and balance beam performance. *Perceptual and Motor Skills*, 77, 907–913.

Woltersdorf, M. A. (1992). Videotape self-modeling in the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder. *Child and Family Behavior Therapy*, 14, 53–73.

Self-Efficacy

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84, 191–215.

Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. *American Psychologist*, 37, 122–147.

Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. *American Psychologist*, 44, 1175–1185.

Bandura, A., Taylor, C. B., Williams, S. L., Mefford, I. N., & Barchas, J. D. (1985). Catecholamine secretion as function of perceived coping self-efficacy. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 53, 406–415.

Friedman, L. C., Nelson, D. V., Webb, J. A., & Hoffman, L. P. (1994). Dispositional optimism, self-efficacy, and health beliefs as predictors of breast self-examination. *American Journal of Preventive Medicine*, 10, 130–135.

Luzzo, D. A. (1995). The relative contributions of self-efficacy and locus of control to the prediction of career maturity. *Journal of College Student Development*, 36, 61–66.

Mancoske, R. J., Standifer, D., & Cauley, C. (1994). The effectiveness of brief counseling services for battered women. *Research on Social Work Practice*, 4, 53–63.

- Ozer, R. L., & Bandura, A. (1990). Mechanisms governing empowerment effects: A self-efficacy analysis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58, 472–486.
- Rodgers, W., & Brawley, L. (1996). The influence of outcome expectancy and self-efficacy on the behavioral intentions of novice exercisers. *Journal of Applied Social Psychology*, 26, 618–634.
- Ryan, N., Solberg, V., & Brown, S. (1996). Family dysfunction, parental attachment, and career search self-efficacy among community college students. *Journal of Counseling Psychology*, 43, 84–89.

Self-Management and Diverse Groups of Clients

- Belgrave, F., Randolph, S., Carter, C., & Braithwaite, N. (1993). The impact of knowledge, norms, and self-efficacy on intentions to engage in AIDS-preventive behaviors among young incarcerated African American males. *Journal of Black Psychology*, 19, 155–168.
- Carr, S., & Punzo, R. (1993). The effects of self-monitoring of academic accuracy and productivity on the performance of students with behavioral disorders. *Behavioral Disorders*, 18, 241–250.
- Church, A., Teresa, J., Rosebrook, R., & Szendre, D. (1992). Self-efficacy for careers and occupational consideration in minority high school equivalency students. *Journal of Counseling Psychology*, 39, 498–508.
- Cochran, S., & Mays, V. (1993). Applying social psychological models to predicting HIV-related sexual risk behaviors among African Americans. *Journal of Black Psychology*, 19, 142–154.
- Epstein, J., Botvin, G., Diaz, T., & Toth, V. (1995). Social and personal factors in marijuana use and intentions to use drugs among inner city minority youth. *Journal of*

- Developmental and Behavioral Pediatrics*, 16, 14–20.
- Gutierrez, L. (1990). Working with women of color: An empowerment perspective. *Social Work*, 35, 149–153.
- Jacob, T., Penn, N., Kulik, J., & Spieth, L. (1992). Effects of cognitive style and maintenance strategies of breast self-examination (BSE) practice by African American women. *Journal of Behavioral Medicine*, 15, 589–609.
- Lackner, J., Carosella, A., & Feuerstein, M. (1996). Pain expectancies, pain, and functional self-efficacy expectancies as determinants of disability in patients with chronic low back disorders. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 64, 212–220.
- McAuley, E., Shaffer, S., & Rudolph, D. (1995). Affective responses to acute exercise in elderly impaired males: The moderating effects of self-efficacy and age. *International Journal of Aging and Human Development*, 41, 13–27.
- McCafferty, S. (1992). The use of private speech by adult second language learners: A cross-cultural study. *Modern Language Journal*, 76, 179–189.
- Malow, R., Corrigan, S., Cunningham, S., & West, J. (1993). Psychosocial factors associated with condom use among African American drug abusers in treatment. *AIDS Education and Prevention*, 5, 244–253.
- Martin, D. (1993). Coping with AIDS-risk reduction efforts among gay men. *AIDS Education and Prevention*, 5, 104–120.
- Roberson, M. (1992). The meaning of compliance: Patient perspectives. *Qualitative Health Research*, 2, 7–26.
- Rotheram-Borus, M. J., Rosario, M., Reid, H., & Koopman, C. (1995). Predicting patterns of sexual acts among homosexual and bisexual youths. *American Journal of Psychiatry*, 152, 588–595.
- St. Lawrence, J. (1993). African American adolescents'

knowledge, health-related attitudes, sexual behavior, and contraceptive decisions: Implications for the prevention of adolescent HIV infection. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 61, 104–112.

Solberg, V., O'Brien, K., Villareal, P., & Kennel, R. (1993). Self-efficacy and Hispanic college students: Validation of the College Self-Efficacy Instrument. *Hispanic Journal of Behavioral Sciences*, 15, 80–95.

Van-Hasselt, V., Hersen, M., Null, J., & Ammerman, R. (1993). Drug abuse prevention for high risk African American children and their families: A review and model program. *Addictive Behaviors*, 18, 213–234.

Winkleby, M., Flora, J., & Kraemer, H. (1994). A community-based heart disease intervention: Predictors of change. *American Journal of Public Health*, 84, 767–772.

学习评判反馈

第一部分

自我监测

1. 讲解治疗原理时, 你应强调这种方法可以帮助求助者了解她颤抖和虚弱的有关情况, 也能对其进行调整。要告诉她在今后的几个星期里记录现实生活中颤抖和虚弱的情况。你要使你的解释适合于她的文化价值观。
2. 反应区分训练包括选择, 定义将要监测的反应, 咨询者可以提供该行为的一些例子, 并鼓励求助者也想出一些来。你尤其要帮助求助者记录诸如感到虚弱等行为的性质和内容。
3. 记录的时机: 因为求助者是在用自我监测法减少不想有的行为, 她应在行为前监测: 每当她感到虚弱时就记录下来。

记录方法：应指导求助者使用频数法，记录她感到虚弱的次数。如果她不能区分这种感觉是何时开始、何时结束的，她可以使用时间取样法，比如，她可以把一天分成相等的时间段，然后记录“全或无”。如果在某段时间间隔里这种观念产生了，就记“是”，如果没发生，就记“否”。或者，她可以在每段时间间隔里评价这类行为发生的大致频率，比如0代表“从未发生”，1代表“偶尔发生”，2代表“经常发生”，3代表“很频繁”。

记录工具：对这一个案例可以使用多种方法，她可以在记录卡上记录，也可以在日记上记录。

4. 可成简单图表。横轴代表日期，纵轴代表行为发生的频率。
5. 这个求助者可能不愿公开地展示这些资料，因此她可以把它们放在钱包或背包中；
6. 可以通过咨惠共同讨论的方式分析资料，也可以由求助者将自己现在的情况与基线水平或目标水平（期望的行为改变）进行比较。后一种方法需要进行自我评价，或许还需加入自我强化过程。

刺激控制

可以告诉她，刺激控制是另一种帮助她控制颤抖和虚弱的方法。途径是限制这种感觉只在特定的场所和时间发生，这样它便不能随时发生了。你可以建议她挑选一个“担心地点”或“担心椅子”，在特定的时间她才能进去担心和发抖，而一旦离开这个地点或椅子，她便不能再担心了。

除了以上两种自我管理干预法，了解以下情况也是有益的：她因移居而产生的失落感和不安全感，她为了适应美国文化做了哪些努力，以及她感受到的两种文化间的冲击程度。

第二部分

对照表 20-3 进行指导，同时检验求助者的自我监测情况。

第三部分

首先要确定所采用的自我管理 with Thad 的信念、价值观、世界观、生活风格相适应的程度，假定 Thad 接受了自我管理，而且更倾向于内在的控制点和责任归因，你就可以做下一步工作了（但是，分析是否还有其他外在的社会因素使他感到不安，也是很重要的）。你可以首先评价并增强他的自我效能感，即 Thad 对自己以及对他与其他男人接触的信心。注意本例中，Thad 的自我效能感受到男同性恋者和非裔美国人双重身份的影响。我们预期在 Thad 使用多种自我管理方法的过程中，他的自我效能感会逐渐提高。

实施自我偶像法时，要录制 Thad 与其他男性进行社会接触的录像带或录音带。

自我奖赏是在他与男性有了社会接触或与男性外出时进行。

1. 言语性的奖赏可以是自我表扬或者是关于自己行为的积极观念，比如：

“我做到了！请他外出了！”

“我完全做到了自己想做的事。”

“噢！我和 × × × 度过了一段多么美好的时光。”

2. 物质性的奖赏可以选择 Thad 喜欢的事物、事件。比如看电视、听音乐、运动。既可以使用现时奖赏，也可以使用潜在的奖赏。当然以上这些例子只是具有可能性，还要由 Thad 决定什么具有强化作用。

想像的奖赏可以是与外出有关的令人愉悦的场景：

想像自己荡舟湖中

想像自己在足球场上驰骋

想像自己与同伴看电影

想像自己与同伴躺在温暖的海滩上

Thad 可以设法增加线索性的事件，从而促进他与男性的交

往，这就是刺激控制的应用。比如，他可以在感到很舒服的场所或时机与男性交往，慢慢地，他可以把与人交往的场合扩展到别的地点。

第四部分

利用以下的指导：自我监测的步骤，刺激控制的原则，自我奖赏的各种方法，自我偶像的内容。

中国轻工业出版社心理学类和教育类图书目录

(一) 心理学丛书——心理咨询与治疗系列

- | | | | |
|---------------------|-----|----|-------------|
| 1. 心理咨询与心理治疗 (美) | 石 林 | 等译 | 定价: 26.00 元 |
| 2. 理智胜过情感 (美) | 张忆家 | 译 | 定价: 15.00 元 |
| 3. 直言相告 | | | |
| ——儿童精神健康与调节 (美) | 汤宜朗 | 等译 | 定价: 18.00 元 |
| 4. 压抑的女性 | | | |
| ——女性抑郁与心理调节 (美) | 朱怀江 | 等译 | 定价: 14.00 元 |
| 5. 夫妻心理治疗与辅导指南 (美) | 贾树华 | 等译 | 定价: 50.00 元 |
| 6. 心理咨询师的问诊策略 (美) | 张建新 | 等译 | 定价: 68.00 元 |
| 7. 危机干预策略 (美) | 肖水源 | 等译 | 定价: 50.00 元 |
| 8. 心理咨询与治疗理论及案例 (美) | 胡佩诚 | 等译 | 定价: 50.00 元 |
| 9. 行为矫正的原理与方法 (美) | 胡佩诚 | 等译 | 定价: 50.00 元 |
| 10. 团体咨询的策略与方法 (美) | 李筱鹏 | 等译 | 定价: 50.00 元 |

(二) 心理学丛书——心理学导读系列

- | | | | |
|--------------------|-----|----|-------------|
| 1. 心理学导论 (美) | 郑 钢 | 等译 | 估价: 65.00 元 |
| 2. 健康心理学 (美) | 胡佩诚 | 等译 | 估价: 50.00 元 |
| 3. 人格心理学 (美) | 陈会昌 | 等译 | 估价: 50.00 元 |
| 4. 认知心理学 (美) | 黄希庭 | 等译 | 定价: 50.00 元 |
| 5. 犯罪心理学 (美) | 刘邦惠 | 等译 | 估价: 40.00 元 |
| 6. 压力与健康 (美) | 石 林 | 等译 | 定价: 40.00 元 |
| 7. 三种心理学 | | | |
| ——弗洛伊德、斯金纳和 | | | |
| 罗杰斯的心理学理论 (美) | 石 林 | 等译 | 定价: 13.00 元 |
| 8. 弗兰克尔: 意义与人生 (美) | 常晓玲 | 等译 | 定价: 18.00 元 |
| 9. 现代英汉心理学词汇 | 张厚粲 | 等编 | 定价: 18.00 元 |

* 本目录定价如有错误或变动, 以实际出书定价为准。

欲购上述图书者, 请将书款及邮挂费 (书款的10%) 寄至北京东长安街6号 (邮编: 100740) 中国轻工业出版社责任编辑朱玲, 款到即发书。(若需要量大, 可有折扣优惠)

电话: (010) 65262933, 65288410 传真: (010) 65288410

FTF

优秀的心理咨询师需要具备健全的人格、丰富的知识和娴熟的技巧。本书为每一位渴望成功、追求卓越的心理咨询师提供专业指导，使其迅速成长为一名出色的专业人士。

阅读本书，你将学到

- 面对求助者，如何进行有效沟通，成功地建立咨询关系。
- 如何将所学习的专业知识转化为进行有效咨询的能力。
- 如何运用倾听、评估和干预技能，成功地进行心理治疗。

认真阅读本书且能身体力行者，必能迅速成长为一名优秀的心理咨询师！

• **Sherry Cormier**，美国西弗吉尼亚州立大学心理学教授、执业心理咨询师专家，具有丰富的教学及其实践经验。

• **Pat Cormier**，美国西弗吉尼亚州立大学心理学教授，美国心理学协会授权举办的心理咨询师培训中心主任，在行为治疗方面具有丰富的临床经验。

ISBN 7-5019-2715-6



9 787501 927159 >

ISBN 7-5019-2715-6 > 111

定价：48.00元（上、下册）